ЛОР-справочник

Разборы клинических рекомендаций

51 рекомендаций Минздрава РФ · сборка от 24.10.2026 · каждый пункт сверен с текстом КР

Оглавление

Абсцесс, фурункул и карбункул носа

J34.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Аллергический ринит

J30.1, J30.2, J30.3, J30.4

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации
6. Контроль лечения
7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
8. Источник и актуальность

Аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа

K07.0, K07.1, K07.4, Q18

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Болезнь Меньера

H81.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Воспалительные заболевания челюстей у детей

K10.2, M86

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Врождённая цитомегаловирусная инфекция

P35.1

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей

K21, K21.0, K21.9

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин

J31.1, J35.1, J35.2, J35.3, J35.8

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Грибковый отит

B37.8, B44.8, B49, H60.8, H62.2, H66.3

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Деформация перегородки носа

J34.2

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация

3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Доброкачественные остео- и хондрогенные опухоли носа и пазух

D14.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Инородное тело в пищеварительном тракте

T18

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Кисты челюстно-лицевой области и шеи

K04.8, K09, K11.6, L72.0, Q18.0, Q18.1, Q18.2, Q18.8

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Коклюш у детей

A37

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Краниальные мононейропатии у взрослых

B02.2, G44.0, G50.0, G50.1, G50.8, G50.9, G51.0, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G51.9, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, G53.0, G90.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Круп, эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани
J05.0, J05.1, J38.4, J38.6

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Мастоидит
H70

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Множественные переломы мозгового и лицевого черепа
S02.0, S02.1, S02.4, S02.6, S02.7, S02.8, S02.9, S07

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Наружные отиты
H60.0, H60.1, H60.2, H60.3, H60.4, H60.5, H60.8, H60.9, H61.0, H61.8, H61.9, H62.0, H62.1, H62.3, H62.4, H62.8

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Наружный отит у детей
H60.0, H60.1, H60.2, H60.3, H60.5, H60.8, H60.9, H61.0, H61.8, H61.9, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H62.8

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Нейросенсорная тугоухость у взрослых
H90.3, H90.4, H90.5, H91.1, H91.2, H91.8

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение и реабилитация
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Нейросенсорная тугоухость у детей
H90.3, H90.4, H90.5

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Носовое кровотечение
R04.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

ОРВИ у детей
B34.0, B34.2, J00, J04.1, J06.0, J06.8, J06.9, J39.9

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых
B34.0, B34.2, B34.9, B97.0, B97.4, J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J20, J21, J22

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Острый ларингит
J04.0, J04.2

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Острый синусит

J01

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Показания к госпитализации. Осложнения
6. Источник и актуальность

Острый тонзиллит и фарингит

J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения
6. Источник и актуальность

Отит средний острый

H65.0, H65.1, H66.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Отосклероз

H80

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Медицинская реабилитация. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Паратонзиллярный абсцесс

J36, J39.0, J39.1

1. Основные положения

2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения
6. Источник и актуальность

Парезы и параличи гортани

J38.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Первичные иммунодефициты с недостаточностью синтеза антител

D80.0, D80.1, D80.2, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D80.9, D83.0, D83.1, D83.2, D83.8, D83.9

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Перелом верхней челюсти

S02.4

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Полипозный риносинусит

J33.0, J33.1, J33.8, J33.9

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Потеря слуха, вызванная шумом

H83.3, Z57.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика

4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

РСВ-инфекция у детей

B97.4, J00, J02.8, J04.1, J04.2, J06.0, J20.5, J21.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Рак гортани

C32, D38.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Рак носоглотки

C11

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Рак носоглотки у детей

C11

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Рак полости носа и придаточных пазух

C30, C31

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

6. Источник и актуальность

Расщелина верхней губы и нёба

Q35, Q36, Q37

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Саркоидоз

D86.0, D86.1, D86.2, D86.3, D86.8, D86.9

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Травма гортани

R04.1, S10.0, S10.1, S11.0

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Травма носа

S00.3, S01.2, S02.2

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Травма уха

S00.4, S01.3, S09.2

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Химический ожог пищевода

T28.5, T28.6, T28.7

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Хронический ринит

J30.0, J31.0, J34.3

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Хронический синусит

J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J34.1

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Хронический средний отит

H65.2, H65.3, H65.4, H66.1, H66.2, H66.3, H72.0, H90.0, H90.1, H90.2, H90.6, H90.7, H90.8

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Хронический тонзиллит

J31.2, J35.0, J35.8, J35.9

1. Основные положения
2. Клиническая картина и классификация
3. Диагностика
4. Лечение
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации
6. Источник и актуальность

Клинические рекомендации

Абсцесс, фурункул и карбункул носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.0** — Абсцесс, фурункул и карбункул носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/956_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Лечение по стадиям:
  1. стадия инфильтрации: консервативное лечение;
  2. абсцедирование и карбункул: вскрытие и дренирование гнойника без прекращения консервативной терапии.
- При фурункуле, карбункуле и абсцессе носа во всех случаях необходима системная антибактериальная терапия, направленная на санацию очага инфекции и профилактику осложнений.
- При каждом осмотре исключают признаки внутричерепных осложнений:
  1. синдром системной воспалительной реакции;
  2. неврологическая симптоматика;
  3. офтальмологическая симптоматика;
  4. тромбоз угловой вены и кавернозного синуса.
- Признаки возможного тромбоза кавернозного синуса:
  1. лихорадка;
  2. головная боль;
  3. хемоз;
  4. экзофтальм;
  5. поражение III, IV, V и VI пар черепных нервов.

  В этом случае необходима компьютерная томография (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.
- Госпитализация:
  1. дети: во всех случаях, в круглосуточный оториноларингологический стационар;
  2. взрослые в стадии инфильтрации могут лечиться амбулаторно.
- Массаж области носа и выдавливание содержимого фурункула противопоказаны.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. фурункул носа: острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и сальной железы на кончике или крыльях носа, в преддверии носа или в области дна носа у верхней губы;
2. карбункул носа: гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желёз с распространением вглубь и по поверхности, с обширными некрозами кожи и подкожной клетчатки;
3. абсцесс носа (абсцедирующий фурункул): скопление гноя при острой инфекции с деструкцией тканей в очаге, часто с перифокальным отёком.

2.2 Этиология

Возбудители

1. ведущий: золотистый стафилококк; резервуар инфекции: бессимптомные носители;
2. стрептококки, прежде всего бета-гемолитический стрептококк группы А.

Способствуют инфицированию фолликула

1. микротравмы кожи носа и преддверия;
2. загрязнение кожи техническими маслами и пылью при несоблюдении гигиены;
3. переохлаждение, перегревание, стресс;
4. нарушение секреторной функции кожи;
5. у детей: привычка ковырять в носу и чрезмерное сморкание.

Фурункул носа нередко является проявлением фурункулёза, то есть образования множественных фурункулов на фоне вторичного иммунодефицита при эндокринных заболеваниях, прежде всего при сахарном диабете, а также при гиповитаминозе, нарушениях питания и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

2.3 Патогенез

Опасный треугольник: средняя зона лица, ограниченная линиями, соединяющими назион с углами рта.

Венозный отток в кавернозный синус

1. угловые вены;
2. вены орбиты;
3. крыловидное сплетение.

Вены этой системы лишены клапанов: инфекция с кожи лица, носа и околоносовых пазух распространяется гематогенно в глазницу, далее в кавернозный синус и на головной мозг.

В кавернозном синусе

1. внутренняя сонная артерия;
2. III, IV и VI пары черепных нервов;
3. первая и вторая ветви тройничного нерва;
4. к синусу прилежат гипофиз и клиновидная пазуха.

Этими анатомическими особенностями обусловлена тяжесть внутричерепных осложнений.

При снижении сопротивляемости организма и высокой вирулентности возбудителя возможна генерализация процесса: стафилококки распространяются в окружающие ткани или проникают в кровоток с развитием сепсиса. В зоне инфильтрата развивается тромбоз мелких вен, и увеличение воспалительного очага повышает угрозу распространения тромбоза.

2.4 Классификация

Стадии

1. I стадия: инфильтрация;
2. II стадия: абсцедирование.

2.5 Клиническая картина

Жалобы

1. боль в области носа;
2. головная боль;
3. слабость, снижение работоспособности;
4. повышение температуры тела до субфебрильных значений.

В общем анализе крови возможны сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Фурункул может локализоваться на кончике носа, в преддверии носа, вблизи перегородки носа или в области дна носа.

Стадия инфильтрации

1. постепенно нарастающая гиперемия кожи над фурункулом;
2. локальная боль, усиливающаяся при мимических движениях и жевании;
3. нарастающая инфильтрация мягких тканей;
4. вокруг первичного очага некротическая ткань, формируется стержень фурункула;
5. на внутренней поверхности входа в нос болезненный конусовидный инфильтрат.

При благополучном течении происходит отторжение некротического стержня с выделением небольшого количества гноя, инфильтрат уменьшается, болевой синдром регрессирует, температура тела нормализуется, общее состояние улучшается.

Стадия абсцедирования

1. зона некроза увеличивается;
2. кожа над инфильтратом истончается;
3. появляется флюктуация, формируется абсцесс.

Карбункул и абсцесс носа

1. тяжёлое общее состояние, фебрильная лихорадка;
2. ощущение распирания и выраженная пульсирующая боль;
3. несколько плотных инфильтратов, сливающихся в единый увеличивающийся очаг;
4. обширная полость с гнойно-некротическим содержимым;
5. несколько отверстий на коже, из которых выделяются гной и некротизированные кровянистые массы.

У детей заболевание протекает тяжелее вследствие выраженного интоксикационного синдрома (головная боль, слабость, вялость, лихорадка). Местные изменения могут развиваться стремительнее, а обширный отёк и гиперемия верхней губы или щёчной области могут маскировать фурункул под заболевание челюстно-лицевой области.

2.6 Анамнез

В анамнезе возможны указания на переохлаждение и косметические процедуры в области наружного носа и его преддверия.

3. Диагностика

Диагноз устанавливают по трём критериям.

Жалобы

1. выраженная боль в области очага, усиливающаяся при прикосновении;
2. головная боль, недомогание;
3. повышение температуры тела.

Данные осмотра

1. гиперемия, отёк и инфильтрация мягких тканей наружного носа, преддверия носа и носо-лицевой области;
2. резкая болезненность при пальпации.

Передняя риноскопия

1. в преддверии носа у волосяного фолликула гиперемия кожи, инфильтрат и гнойный стержень в центре.

3.1 Осмотр и передняя риноскопия

Показания

1. каждый пациент с подозрением на фурункул носа: первичный осмотр оториноларинголога, врача общей практики или педиатра.

Динамика при передней риноскопии

1. начало: остиофолликулит преддверия носа, гиперемия и уплотнение в устье волосяного фолликула;
2. в течение **1–2 суток**: отёк, инфильтрация и гиперемия кожи входа в нос (стадия инфильтрации);
3. затем кожа истончается, ткани в очаге гнойно-некротически расплавляются с образованием детрита.

Наружный осмотр

1. гиперемия, отёк и болезненность в области преддверия и кончика носа;
2. прикосновение к носу и риноскопия болезненны;
3. кожа преддверия может быть покрыта толстыми жёлтыми корками;
4. при выраженном воспалении отёк распространяется на щёчную область и верхнюю губу.

Показания

1. все пациенты: основной метод инструментальной диагностики, уточнение локализации фурункула.

3.2 Признаки внутричерепных осложнений (оценивают при каждом осмотре)

При каждом осмотре необходимо оценивать наличие симптомов внутричерепных осложнений, которые объединяются в три синдрома: инфекционный, неврологический и офтальмологический.

Инфекционный синдром (синдром системной воспалительной реакции)

1. температура тела **38 °C и выше** или **36 °C и ниже**;
2. частота сердечных сокращений **90 в минуту и более**;
3. частота дыхания **более 20 в минуту**;
4. лейкоциты более 12×10^9/л или менее 4×10^9/л либо незрелых форм более 10%;
5. прокальцитонин в плазме **0,5 нг/мл и выше**.

Неврологический синдром

1. интенсивная головная боль;
2. тошнота и рвота, не связанные с приёмом пищи;
3. несистемное головокружение;
4. менингеальный синдром: светобоязнь, звукобоязнь, гиперестезия кожи, ригидность затылочных мышц; симптомы Кернига и Брудзинского, скуловой симптом Бехтерева, симптом Менделя;
5. при прогрессировании оглушение, психомоторное возбуждение, судорожный синдром.

Офтальмологический синдром

1. отёк век на стороне поражения;
2. хемоз;
3. экзофтальм;
4. болезненные тромбированные вены при пальпации век;
5. при офтальмоскопии признаки внутричерепной гипертензии.

Тромбоз угловой вены

1. резкая болезненность при пальпации;
2. интенсивная головная боль;
3. отёк лица на стороне поражения;
4. угловая вена пальпируется в виде плотного болезненного тяжа.

Тромбоз кавернозного синуса

1. на начальном этапе выраженный цианоз слизистой оболочки губ, кожи лба и носа;
2. нарастающий отёк верхней губы и щеки на стороне поражения с распространением на височную и лобную области, веки и противоположную половину лица;
3. нарушение функции глазодвигательного, блокового, отводящего и тройничного нервов вплоть до полного выпадения.

3.3 Компьютерная томография головного мозга с контрастированием

Показания

1. подозрение на тромбоз кавернозного синуса: КТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.

О возможном тромбозе кавернозного синуса свидетельствуют фебрильная лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и признаки поражения III, IV, V и VI пар черепных нервов.

3.4 Консультации специалистов

Показания

1. осложнённое течение: первичные консультации офтальмолога и невролога.

При распространении воспалительного процесса на область лица целесообразна консультация челюстно-лицевого хирурга.

Алгоритм ведения пациента (приложение Б) при внутричерепных осложнениях предусматривает консультации нейрохирурга, офтальмолога и челюстно-лицевого хирурга.

> Состав консультантов при осложнениях в разных разделах рекомендации не совпадает: в разделе 2.5 и в критериях качества указаны невролог и офтальмолог, в алгоритме (приложение Б) указаны нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

3.5 Общий анализ крови

Показания

1. все пациенты на любой стадии: оценка общего состояния и выраженности воспаления.

3.6 Биохимический анализ крови

Показания

1. выявление сахарного диабета, нарушений углеводного обмена и других состояний, способствующих развитию фурункула и утяжеляющих его течение.

1. сахарный диабет неблагоприятно влияет на частоту развития, течение и прогноз фурункула;
2. повышен уровень глюкозы: направить к эндокринологу для коррекции гликемии, выявления сахарного диабета и назначения лечебного питания;
3. изменения билирубина, креатинина, мочевины, активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ): нарушение функции печени и почек.

3.7 Коагулограмма

Показания

1. осложнённое течение;
2. сопутствующие заболевания.

3.8 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого

Посев гнойного отделяемого на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. абсцедирующий фурункул;
2. карбункул;
3. абсцесс носа.

Материал забирают из раны после вскрытия, без контакта с окружающими тканями, до начала антибактериальной терапии.

---

4. Лечение

1. метод лечения определяется стадией и характером проявлений, в том числе наличием карбункула или абсцесса;
2. при неосложнённом течении лечение преимущественно консервативное: местное и парентеральное;
3. лечение комплексное: элиминация возбудителя, купирование интоксикации, восстановление обмена веществ, повышение защитных сил организма.

По алгоритму ведения пациента (приложение Б):

1. стадия инфильтрации: консервативное лечение;
2. стадия абсцедирования: хирургическое лечение в сочетании с консервативным;
3. стадия разрешения: консультация физиотерапевта;
4. рецидив: консультации эндокринолога и аллерголога-иммунолога.

4.1 Стадия инфильтрации: консервативное лечение

Для подавления инфекции и воспаления у всех пациентов с фурункулом носа местно применяют антисептики.

1. в первые часы после появления инфильтрата: повторное смазывание пустулы 5% спиртовым раствором йода;
2. выраженное действие: четвертичные аммониевые соединения (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний), препараты йода, хлоргексидин; допустимы у взрослых и детей;
3. повидон-йод разрешён детям **старше 28 дней**;
4. кратность обработки по выраженности воспаления, обрабатывают до разрешения инфекционного процесса;
5. в стадии инфильтрации кожу вокруг очага бережно обрабатывают 70% этанолом.

При фурункуле и карбункуле носа для санации очага местно используют мази с антибиотиками широкого спектра действия.

Мупироцин, мазь

1. взрослые: 2–3 раза в день, 5–7 дней;
2. дети с рождения: 2–3 раза в день, не более 10 дней.

Фузидовая кислота

1. взрослые: мазь или крем на кожу над фурункулом до 3–4 раз в день, 7–14 дней;
2. дети с рождения: крем 3–4 раза в день, 7–14 дней.

Диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол, мазь: противомикробное и противовоспалительное действие

1. взрослые и дети с одного года: один раз в день до очищения раны от гнойно-некротических масс.

Для купирования воспаления и болевого синдрома при отсутствии противопоказаний рекомендуется противовоспалительная и обезболивающая терапия.

НПВП и другие анальгетики-антипиретики в монотерапии или в комбинации; выраженный эффект даёт сочетание НПВП с парацетамолом.

Метамизол натрия купирует болевой синдром у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде.

НПВП у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев;
2. кетопрофен: с 15 лет;
3. кетопрофен, гранулы для приготовления раствора внутрь: с 6 лет.

В амбулаторной практике от назначения метамизола натрия детям следует воздержаться; в стационаре препарат применяется только при отсутствии других анальгетиков, разрешённых к применению у детей, в связи с риском серьёзных нежелательных явлений.

Анальгетическая терапия у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	0,5–1 г внутривенно, инфузия в течение 15 минут	6 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 «мл» внутримышечно (так в таблице рекомендации; по смыслу 75 мг)	12 ч	150 мг	2 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кеторолак	30 мг внутривенно или внутримышечно	8 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> Разовая доза диклофенака в таблице 1 указана как «75 мл в/м»; исходя из смысла и суточного максимума 150 мг, речь идёт о 75 мг.

Анальгетическая терапия у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия в течение 15 минут: менее 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; более 50 кг — 1000 мг	4 ч	Менее 10 кг — менее 30 мг/кг; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; более 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	С 12 лет — 0,5–1 г; 6–12 лет — 240–480 мг; 1–6 лет — 120–240 мг; от 3 месяцев до года — 72–120 мг	6 ч	С 12 лет — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг	С 12 лет — 3 суток, до 12 лет — 5–7 суток
Парацетамол в ректальных суппозиториях	10–14 лет — 500 мг; 5–9 лет — 250 мг; 1–4 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50–100 мг	4–6 ч	Менее 60 мг/кг	До 5 суток
Ибупрофен внутрь	Старше 6 лет — 200–400 мг; 4–6 лет — 150 мг; 1–3 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50 мг	8 ч	12–17 лет — 1 г; 6–12 лет — 800 мг; 4–6 лет — 450 мг; 1–3 года — 300 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 3–6 месяцев — 150 мг	4 суток
Ибупрофен в ректальных суппозиториях	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	8 ч (3–9 месяцев), 6 ч (9–24 месяца)	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	Не более 3 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кетопрофен	С 15 лет — 100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	Не более 2 суток
Кетопрофен в гранулах для раствора внутрь	Старше 6 лет — 40 мг	8 ч	120 мг	Не более 2 суток
Метамизол натрия внутримышечно	13–14 лет — 0,8–1,8 мл (400–900 мг); 10–12 лет — 0,5–1,0 мл (250–500 мг); 7–9 лет — 0,4–1,0 мл (200–500 мг); 4–6 лет — 0,3–0,8 мл (150–400 мг); 1–3 года — 0,2–0,5 мл; 3–11 месяцев — 0,1–0,2 мл (50–100 мг)	8–12 ч	С 15 лет — 2 г; 8–14 лет — 900 мг; 4–7 лет — 600 мг; 2–3 года — 300 мг	1–5 суток

> В строке метамизола натрия таблицы 2 для детей 1–3 лет указано «0,2–0,5 мл (100–2500 мг)». При концентрации 500 мг в 1 мл, как и в соседних строках, 0,5 мл соответствуют 250 мг, следовательно, значение «2500» является опечаткой. Возраст «79 лет» в той же строке следует читать как 7–9 лет.

4.2 Системная антибактериальная терапия (все пациенты)

Всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа для санации очага инфекции и предупреждения осложнений проводят системную антибактериальную терапию.

Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь

1. взрослые и дети старше 12 лет или массой более 40 кг: 1000 мг (875/125) 2 раза в сутки, 7 дней;
2. дети от 3 месяцев до 12 лет массой менее 40 кг: суспензия (400 мг амоксициллина + 57 мг клавулановой кислоты в 5 мл), 20 мг/кг в сутки;
3. новорождённые и дети до 3 месяцев: 30 мг/кг (по амоксициллину) 2 раза в день, 7–14 дней.

Цефдиторен

1. с 12 лет: 200 мг каждые 12 часов, 10 дней.

Тяжёлое или рецидивирующее течение, непереносимость бета-лактамных антибиотиков, пациенты с 18 лет:

1. левофлоксацин: 750 мг один раз в сутки, 7–14 дней;
2. моксифлоксацин: 400 мг один раз в сутки, 7 дней.

Цефазолин: препарат первой линии для парентерального введения

1. взрослые: 0,5 г внутривенно или внутримышечно 2 раза в день;
2. дети от месяца до 18 лет: 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения;
3. длительность: 7–10 дней.

Цефтриаксон, один раз в сутки

1. взрослые и дети старше 12 лет или массой более 50 кг: 1–2 г;
2. новорождённые до 14 дней: 20–50 мг/кг, не более 50 мг/кг;
3. дети от 15 дней до 12 лет: 20–80 мг/кг;
4. длительность: 7–10 дней.

Ампициллин + сульбактам внутримышечно или внутривенно (капельно 60–80 капель в минуту или струйно медленно в течение 3–5 минут)

1. взрослые: 3–12 г в сутки в 3–4 введения в зависимости от тяжести инфекции;
2. дети: 150 мг/кг в сутки в 3–4 введения;
3. недоношенные и дети первой недели жизни: 75 мг/кг в сутки в 2 введения;
4. длительность: 5–14 дней.

Амоксициллин + клавулановая кислота внутривенно

1. взрослые и дети старше 12 лет: 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки;
2. дети до 3 месяцев и массой менее 4 кг: 25/5 мг/кг каждые 8 часов, только медленной инфузией в течение 30–40 минут;
3. дети от 3 месяцев до 12 лет: 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов в зависимости от тяжести инфекции;
4. длительность: 5–14 дней.

Клиндамицин при аллергии на бета-лактамные антибиотики

1. взрослые: парентерально 0,6–2,7 г в сутки в несколько введений;
2. дети 3–18 лет: 20–40 мг/кг в сутки в 3–4 равных приёма;
3. длительность: 7–10 дней.

Детям **младше 3 лет** противопоказан.

Парентеральные антибактериальные препараты

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Цефазолин	Взрослым 0,5 г; детям старше месяца 10–20 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям старше месяца 100 мг/кг	7–10 дней
Цефтриаксон	Взрослым 1–2 г; новорождённым до 14 дней 20–50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	1 раз в сутки	Взрослым 4 г, детям 2 г	7–10 дней
Ампициллин + сульбактам	Взрослым 1–2 г; детям старше месяца 50 мг/кг; новорождённым до 14 дней 75 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	Взрослым и детям старше месяца 3 раза, новорождённым 2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям 150 мг/кг	5–14 дней внутримышечно (или 5–7 дней внутривенно, затем внутримышечно до 14 дней)
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослым и детям старше 12 лет 1 г внутривенно; до 12 лет 25 мг/кг внутривенно	Взрослым и детям старше 3 месяцев 3 раза, детям до 3 месяцев 2–3 раза в сутки	Взрослым и детям старше 12 лет 6 г, до 12 лет 50–75 мг/кг	5–14 дней

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Клиндамицин	Взрослым «0,2–0,9 мг» (так в таблице; внутримышечно не более 0,6 г, внутривенно не более 1,2 г на одно введение); детям 3–18 лет 5–10 мг/кг внутримышечно или внутривенно	3–4 раза в сутки	Взрослым 4,8 г, детям 40 мг/кг	7–10 дней

> Данные раздела 3.1 и таблицы 3 не совпадают. Цефазолин детям: в тексте 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в таблице 10–20 мг/кг 2 раза в сутки. Ампициллин с сульбактамом: в тексте взрослым до 12 г в сутки, в таблице максимальная доза 6 г; новорождённым в тексте 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в таблице 75 мг/кг на введение 2 раза в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 25 мг/кг каждые 6–8 часов (до 100 мг/кг в сутки), в таблице максимальная доза 50–75 мг/кг в сутки. Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице указана в миллиграммах («0,2–0,9 мг»), хотя, исходя из смысла и текста (0,6–2,7 г в сутки), речь идёт о граммах.

4.3 Стадия абсцедирования, карбункул, абсцесс: хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению:

1. стадия абсцедирования;
2. карбункул носа.

При осложнённом течении абсцесс или карбункул носа вскрывают, чтобы эвакуировать гной и обеспечить дренирование.

Вмешательство возможно как под местной анестезией, так и под общим обезболиванием. Забор материала из раны для бактериологического исследования обязателен.

4.4 Осложнённое течение: антикоагулянтная терапия

Осложнённое течение фурункула, карбункула или абсцесса носа во всех случаях требует профилактики тромбозов антикоагулянтами прямого или непрямого действия.

Доза подбирается под контролем показателей свёртывающей системы крови.

4.5 Стадия разрешения

В стадии разрешения для ускорения выздоровления показана консультация физиотерапевта.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Рецидивирующее течение

При рецидивирующих фурункулах носа рекомендована консультация эндокринолога (у детей детского эндокринолога) для выявления причины рецидивов.

В ряде случаев целесообразна также консультация аллерголога-иммунолога.

Для профилактики рецидивов при рецидивирующем течении фурункула носа применяют бактериофаги.

Местное применение бактериофагов в комплексном лечении оправдано при устойчивости выделенных штаммов к антибиотикам, при наличии в анамнезе более двух курсов антибактериальной терапии, при непереносимости антибиотиков и при рецидивирующем течении.

5.2 Профилактика

Основа профилактики

1. личная гигиена: мытьё рук до и после еды, после туалета, поездок в транспорте и посещения общественных мест;
2. гигиена труда, средства защиты при работе в условиях запылённости и загрязнения;
3. запрет прикосновений к коже лица грязными руками, массажа болезненных участков, выдавливания фурункула и самолечения;
4. при сахарном диабете и других заболеваниях соблюдение диеты и своевременный приём препаратов;
5. обучение гигиеническим навыкам в семье, детском саду и школе.

Пациенту разъясняют

1. осторожность при косметическом уходе за лицом, включая чистку лица и бритьё;
2. при гнойничке на коже носа или верхней губы массаж и выдавливание категорически противопоказаны;
3. при отёке или гиперемии в области фурункула обращаться в оториноларингологический стационар.

Родителям

1. контролировать чистоту рук ребёнка;
2. обучать правильному туалету носа;
3. не допускать ковыряния в носу.

5.3 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. дети: установленный диагноз абсцесса, фурункула или карбункула носа (круглосуточный оториноларингологический стационар).

Взрослые в стадии инфильтрации могут лечиться у оториноларинголога амбулаторно. В большинстве случаев пациентов ведёт оториноларинголог в хирургическом стационаре.

Тактика при сопутствующих заболеваниях и рецидивирующих фурункулах в КР не указана.

> В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена и тактика их ведения не указана; по контексту, по-видимому, подразумевается госпитализация. Кроме того, в информации для пациента (приложение В) при отёке или гиперемии в области фурункула всем пациентам рекомендуется обращаться в оториноларингологический стационар, хотя гиперемия и отёк отмечаются уже в стадии инфильтрации, при которой взрослые, согласно разделу 6, могут получать лечение амбулаторно.

Пациента выписывают при:

1. разрешении абсцесса, фурункула или карбункула;
2. отсутствии осложнений;
3. удовлетворительном общем состоянии;
4. нормализации температуры тела.

При неосложнённом течении прогноз благоприятный. У пациентов с первичным или вторичным иммунодефицитом и с сахарным диабетом следует ожидать более тяжёлого течения и высокого риска осложнений.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Абсцесс. Фурункул носа. Карбункул носа»

Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	`956_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 разовая доза диклофенака указана как «75 мл».
- В таблице 2 для метамизола натрия у детей 1–3 лет указано «100–2500 мг» (объёму 0,2–0,5 мл соответствуют 100–250 мг), а возраст «79 лет» означает 7–9 лет.
- Дозы антибактериальных препаратов в тексте раздела 3.1 и в таблице 3 не совпадают: доза цефазолина у детей, максимальная доза ампициллина с сульбактамом у взрослых и его доза у новорождённых, суточная доза амоксициллина с клавулановой кислотой у детей.
- Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице 3 указана как «0,2–0,9 мг» вместо граммов; в тексте фраза «противопоказан детям в возрасте старше до 3-х лет» искажена (по контексту имеется в виду возраст младше 3 лет).
- Состав консультантов при внутричерепных осложнениях в разделе 2.5 и в критериях качества (невролог, офтальмолог) не совпадает с алгоритмом в приложении Б (нейрохирург, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург).
- В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена; рекомендация из приложения В обращаться в стационар при любом отёке или гиперемии расходится с возможностью амбулаторного лечения взрослых в стадии инфильтрации.
- Показания к хирургическому лечению сформулированы по-разному: в разделе 3.2 указаны абсцедирование и карбункул, в тезисе-рекомендации указано осложнённое течение, в критериях качества указана стадия абсцедирования.

Клинические рекомендации

Аллергический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.1** — Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений **J30.2** — Другие сезонные аллергические риниты **J30.3** — Другие аллергические риниты **J30.4** — Аллергический ринит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 11.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз аллергического ринита:

  Обязательные критерии

  1. **не менее двух** из четырёх симптомов, беспокоящих ежедневно **не менее часа**: заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу;
  2. связь симптомов с аллергеном;
  3. положительные результаты аллергологического обследования.
- Лечение ступенчатое:
  1. первая ступень: один препарат: антигистаминный внутрь или интраназально, кромоглициевая кислота или монтелукаст;
  2. вторая ступень: один препарат, предпочтительно интраназальный глюкокортикостероид;
  3. третья ступень: интраназальный глюкокортикостероид и один или два препарата первой ступени;
  4. четвёртая ступень: омализумаб, решение о котором принимает только специалист.
- Интраназальные глюкокортикостероиды превосходят по эффективности антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту, особенно при выраженной заложенности носа.
- Сосудосуживающие препараты допустимы только при обострении с выраженной заложенностью носа и только коротким курсом, **3–7 дней**.
- Контроль симптомов оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и **через 2–4 недели** лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Аллергический ринит является IgE-опосредованным воспалительным заболеванием слизистой оболочки носа, развивающимся под действием аллергенов. Для него характерны **не менее двух** симптомов, проявляющихся ежедневно **в течение часа и более**:

1. заложенность носа;
2. ринорея;
3. чихание;
4. зуд в полости носа.

2.2 Классификация

По этиологическому фактору

1. сезонный;
2. круглогодичный (бытовой);
3. профессиональный.

По течению

1. интермиттирующий: симптомы беспокоят **менее 4 дней в неделю** или **менее 4 недель в году**;
2. персистирующий: симптомы сохраняются **более 4 дней в неделю** и **более 4 недель в году**.

По тяжести

1. лёгкое течение: симптомы не нарушают сон и повседневную активность;
2. среднетяжёлое течение: симптомы препятствуют работе, учёбе, занятиям спортом и нарушают сон;
3. тяжёлое течение: без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать.

Кроме того, выделяют периоды обострения и ремиссии.

В формулировке диагноза указываются аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельной формой является локальный аллергический ринит. Для него характерны типичные симптомы с чёткой связью с аллергеном при отрицательных результатах кожных проб и исследования специфических IgE в крови. Определение специфических IgE в носовом секрете в России не проводится, назальные провокационные тесты положительны.

2.3 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. заложенность носа с дыханием через рот, сопением, храпом и изменением голоса;
2. водянистые выделения из носа;
3. чихание, нередко приступообразное, чаще в утренние часы;
4. зуд, реже жжение в носу, в ряде случаев зуд нёба и глотки;
5. на поздних стадиях снижение обоняния.

Характерен «аллергический салют» (потирание кончика носа ладонью), вследствие которого формируется поперечная носовая складка.

У каждого пациента с подозрением на аллергический ринит подробно собирают жалобы и анамнез.

Ведущие симптомы

1. круглогодичная форма: заложенность носа со слизистыми выделениями;
2. сезонная форма: приступы чихания, зуд и ринорея.

Уточняют

1. связь симптомов с аллергеном;
2. аллергические заболевания у пациента и его кровных родственников.

Обильные выделения и нарушение проходимости слуховых труб могут сопровождаться раздражением и отёком кожи над верхней губой и в области крыльев носа, носовыми кровотечениями после сморкания, болью в горле и покашливанием, болью и треском в ушах при глотании, снижением слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром, представляющий собой перекрёстную непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Его проявления варьируют от зуда в полости рта до анафилаксии.

2.4 Физикальное обследование

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей, общий осмотр и аускультацию для выявления бронхиальной астмы, конъюнктивита и атопического дерматита.

Характерные признаки

1. затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот;
2. тёмные круги под глазами;
3. мацерация кожи над верхней губой;
4. отёчность лица.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии

1. характерные жалобы: **не менее двух** симптомов из четырёх, ежедневно **не менее часа**;
2. данные анамнеза о связи с аллергеном или о других аллергических заболеваниях;
3. положительные результаты аллергологического обследования.

Задачи оториноларинголога

1. риноскопия и эндоскопическое исследование;
2. дифференциальная диагностика;
3. выявление осложнений и анатомических нарушений;
4. определение показаний к хирургическому лечению.

Задачи аллерголога-иммунолога

1. кожные и провокационные тесты и оценка их результатов;
2. исключение бронхиальной астмы;
3. решение вопроса об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

3.2 Передняя риноскопия

Показания

1. все пациенты.

Диагностические признаки

1. отёк носовых раковин;
2. обильный водянистый секрет;
3. слизистая оболочка ярко-красная в период обострения сезонного ринита;
4. слизистая оболочка цианотичная или серая при круглогодичном рините, в ряде случаев пятнистая («мраморная», симптом Воячека);
5. полипы.

3.3 Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки и околоносовых пазух

Показания

1. неэффективность стандартной терапии;
2. осложнённое течение ринита.

Проба с сосудосуживающим средством позволяет оценить обратимость назальной обструкции.

3.4 Кожные пробы

Prick-тесты или скарификационные пробы при отсутствии противопоказаний.

Показания

1. подтверждение аллергической природы ринита;
2. выявление причинно-значимых аллергенов;
3. решение вопроса об АСИТ.

Пробы проводят в аллергологическом кабинете.

На результат влияют

1. возраст **младше 5 и старше 60 лет**;
2. приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов;
3. дермографизм: ложноположительный результат;
4. недавно перенесённая острая аллергическая реакция: ложноотрицательный результат.

3.5 Специфические IgE в сыворотке крови

Показания

1. кожные пробы противопоказаны или невозможны;
2. результат кожных проб сомнителен;
3. результат кожных проб расходится с данными анамнеза.

Диагностические признаки

При использовании метода ImmunoCAP результат считается положительным при значении **более 0,70 kU/l**.

3.6 Общий IgE

Для диагностики аллергического ринита исследование общего IgE нецелесообразно, поскольку не несёт необходимой диагностической информации.

Показания

1. только перед назначением омализумаба (**с 12 лет**, при тяжёлом течении): по уровню общего IgE рассчитывают дозу препарата.

3.7 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. выраженные симптомы в период обострения;
2. подготовка к АСИТ.

Диагностические признаки

1. содержание эозинофилов;
2. лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево служит поводом для поиска инфекции, прежде всего острого риносинусита.

3.8 Цитологическое исследование смывов из полости носа

Показания

1. выраженные симптомы в период обострения.

Диагностические признаки

1. эозинофилия носового секрета **10% и более**.

3.9 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. симптомы риносинусита: гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, повышение температуры тела;
2. лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево.

3.10 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания

1. неэффективность лечения;
2. выраженная и длительная назальная обструкция;
3. стойкая аносмия;
4. отрицательные результаты аллергологического обследования, прежде всего при подозрении на полипозный риносинусит.

3.11 Спирометрия с бронхолитиком

Показания

1. кашель, свистящее дыхание, одышка;
2. подготовка к АСИТ: выявление скрытого бронхоспазма.

3.12 Электрокардиография

Показания

1. подготовка к инъекционной АСИТ.

3.13 Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит дифференцируют

1. с инфекционным ринитом;
2. с аномалиями внутриносовых структур;
3. с аденоидами у детей;
4. с полипозным риносинуситом;
5. с эозинофильным ринитом;
6. с лекарственным ринитом: на фоне приёма нестероидных противовоспалительных препаратов, альфа- и бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, резерпина, длительного применения деконгестантов;
7. с гормональным ринитом: беременность, пубертатный период, менструальный цикл, приём контрацептивов, акромегалия, гипотиреоз;
8. с профессиональным ринитом;
9. с атрофическим ринитом пожилых;
10. с пищевым и алкогольным ринитом;
11. с идиопатическим ринитом;
12. с первичной цилиарной дискинезией и муковисцидозом.

---

4. Лечение

Целью лечения является полный контроль симптомов. При продолжающемся контакте с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями достижимо лишь уменьшение выраженности симптомов.

4.1 Ступенчатая терапия

На любой ступени:

1. исключение контакта с аллергеном;
2. хирургическое лечение сопутствующей патологии при наличии показаний;
3. рассмотрение вопроса об АСИТ.

1. Первая ступень. Один препарат: антигистаминный препарат без седативного эффекта внутрь, антигистаминный препарат интраназально, кромоглициевая кислота интраназально или монтелукаст.
2. Вторая ступень. Один препарат, предпочтительно интраназальный глюкокортикостероид; возможно назначение антигистаминного препарата внутрь или интраназально либо монтелукаста.
3. Третья ступень. Интраназальный глюкокортикостероид в сочетании с одним или несколькими препаратами: антигистаминным препаратом внутрь или интраназально, монтелукастом.
4. Четвёртая ступень. Омализумаб при тяжёлом течении, **с 12 лет**. Назначается только специалистом.

Препараты скорой помощи на любой ступени: сосудосуживающие препараты коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Перед переходом на ступень выше следует повторно оценить правильность диагноза, приверженность лечению, наличие сопутствующих заболеваний и анатомических аномалий.

4.2 Системные антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты без седативного эффекта рекомендованы всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность носа. Цетиризин в высоких дозах чаще других препаратов вызывает сонливость.

Назначение седативных антигистаминных препаратов первого поколения не рекомендуется, поскольку они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к развитию апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	Взрослым и детям с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 2,5 мг, детям 1–5 лет — 1,25 мг, детям 6–12 месяцев — 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–12 лет при массе тела до 30 кг — 5 мг, более 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки, детям 1–2 лет — 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз в сутки.
Эбастин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10–20 мг 1 раз в сутки. Имеется лекарственная форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	Взрослым и детям старше 12 лет — 20 мг 1 раз в сутки.

4.3 Интраназальные глюкокортикостероиды

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение, особенно при выраженной заложенности носа.

По эффективности превосходят антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту, уменьшают и глазные симптомы.

Нежелательные явления

1. сухость слизистой оболочки;
2. носовые кровотечения;
3. редко перфорация носовой перегородки.

Пациента обучают правильной технике введения спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза; при необходимости до 4 доз. Детям 2–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза. Детям 2–12 лет — 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза. Детям 4–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, для поддерживающей терапии — 200 мкг в сутки. Не более 3 месяцев.
Беклометазон	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки (максимальная доза); для поддерживающей терапии — 1 доза 2 раза в сутки.

4.4 Интраназальные антигистаминные и комбинированные препараты

Интраназальные антигистаминные препараты быстро, в течение 30 минут, уменьшают выраженность симптомов. Их применяют в монотерапии или в сочетании с другими препаратами; возможна сухость слизистой оболочки носа.

При необходимости одновременного интраназального применения антигистаминного препарата и глюкокортикостероида целесообразно назначение одного комбинированного спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки, с 12 лет при необходимости 2 дозы. Не более 6 месяцев.
Левокабастин	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза. При отсутствии эффекта в течение 3 дней препарат отменяется.
Азеластин и флутиказон	Взрослым и детям старше 12 лет — 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	Взрослым с 18 лет — 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки, курс 2 недели.
Мометазон и олопатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина). Детям 6–11 лет только при сезонном рините — 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

4.5 Монелукаст и кромоглициевая кислота

Монелукаст может назначаться при любой степени тяжести, в монотерапии или в сочетании с другими препаратами, однако по эффективности он уступает интраназальным глюкокортикостероидам.

При сопутствующей бронхиальной астме монелукаст позволяет контролировать оба заболевания. Курс лечения **от 1 до 3 месяцев и более**; согласно инструкции, ограничений по длительности применения нет.

При необходимости назначения и антигистаминного препарата внутрь, и монелукаста возможно применение комбинированной таблетки левоцетиризина с монелукастом.

Кромоглициевую кислоту интраназально используют при лёгком течении. Препарат безопасен, однако по эффективности уступает антигистаминным препаратам, монелукасту и интраназальным глюкокортикостероидам.

Препарат	Доза
Монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 10 мг 1 раз в сутки, детям 6–15 лет — 5 мг, детям 2–6 лет — 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	Взрослым и детям старше 5 лет — 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз. После достижения эффекта возможно применение только при контакте с аллергеном. Курс 4 недели.

4.6 Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью носа сосудосуживающие препараты применяют коротким курсом, **3–7 дней**.

Длительное применение не рекомендуется: **после 10 дней** развиваются привыкание, отёк слизистой оболочки и медикаментозный ринит.

При необходимости интраназального применения и антигистаминного, и сосудосуживающего препарата возможно назначение комбинации диметиндена с фенилэфрином, не более 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки. Детям 1–6 лет — 1–2 капли 0,025%, детям от 5 недель до года — 1–2 капли 0,01%, до 4 недель — 1 капля 0,01% 2–3 раза в сутки. Курс 3–4 дня.
Ксилометазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки, детям 2–6 лет — 1 доза 0,05% 1–2 раза в сутки. Не более 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки. Детям 1–6 лет — только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

4.7 Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или неэффективности третьей ступени возможно назначение короткого курса глюкокортикоидов внутрь.

1. терапия четвёртой линии или средство лечения тяжёлого обострения;
2. введение растворов и депо-форм глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо: риск тяжёлых осложнений вплоть до слепоты;
3. доза преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирается индивидуально;
4. преднизолон в таблетках противопоказан детям **до 3 лет**.

Назначение депо-форм глюкокортикоидов не рекомендуется в связи с быстрым развитием побочных эффектов, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Назначение омализумаба рассматривается **с 12 лет** при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении в случае неэффективности третьей ступени.

Препарат вводится подкожно каждые 2 или 4 недели в дозе от 75 до 600 мг в соответствии с таблицей дозирования. При сезонном рините введение начинается не менее чем за неделю до начала пыления и продолжается до его окончания.

4.8 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам рекомендуется по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение контакта облегчает течение заболевания и снижает потребность в лекарственных препаратах.

Рекомендуется применение изотонических солевых растворов для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением интраназального глюкокортикостероида полость носа целесообразно промыть: это улучшает контакт препарата со слизистой оболочкой и снижает частоту сухости и носовых кровотечений.

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия

Проведение АСИТ рассматривается у всех пациентов в период ремиссии, в том числе медикаментозной. Метод уменьшает выраженность симптомов и потребность в лекарственных препаратах, предупреждает развитие бронхиальной астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяются аллергологом-иммунологом, которым и назначается АСИТ.

4.10 Хирургическое лечение

К хирургическому лечению прибегают только при сопутствующей патологии; показания определяются оториноларингологом по данным эндоскопического и рентгенологического исследования. Плановые операции в сезон пыления причинно-значимых аллергенов не выполняют.

4.11 Нетрадиционные методы

Гомеопатия, фитотерапия, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапия не рекомендуются в связи с отсутствием доказательств их эффективности.

Иглоукалывание может рассматриваться в составе комплексной терапии.

---

5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации

5.1 Возрастные ограничения

Интраназальные глюкокортикостероиды у детей

1. мометазон, флутиказона фуроат: с 2 лет;
2. флутиказона пропионат: с 4 лет;
3. беклометазон, будесонид: с 6 лет.

Антигистаминные препараты у детей

1. цетиризин, дезлоратадин: с 6 месяцев;
2. лоратадин: с 2 лет;
3. первого поколения (хлоропирамин, диметинден): с 1 месяца.

По достижении ребёнком соответствующего возраста предпочтение отдают препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст у детей

1. 4 мг: с 2 лет;
2. 5 мг: с 6 лет.

Согласно инструкциям к препаратам, АСИТ возможна **с 5 лет**.

Детям интраназальные глюкокортикостероиды применяют в минимальной эффективной дозе; при длительном применении необходим контроль роста.

Предпочтительно ограничить применение препаратов с высокой биодоступностью: будесонида (30–40%) и беклометазона (40–50%). Биодоступность дексаметазона превышает 80%, что следует учитывать, поскольку он входит в состав многих комбинированных капель.

5.2 Беременность и лактация

У беременных необходимо учитывать возможность ринита беременных, который характеризуется заложенностью носа без признаков инфекции и аллергии и полностью регрессирует **в течение 2 недель** после родов. Выявленная сенсибилизация свидетельствует в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и лактации не выполняют; для аллергологического обследования исследуется уровень специфических IgE в сыворотке крови.

Предпочтение отдаётся элиминационным мероприятиям и промыванию полости носа. К лекарственной терапии переходят при их недостаточной эффективности с учётом рисков для матери и ребёнка.

Для лоратадина, цетиризина и будесонида доказательства риска для человека отсутствуют (категория B по классификации Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, FDA).

В первом триместре назначения лекарственных препаратов по возможности следует избегать, за исключением случаев жизненной необходимости.

В период лактации предпочтительно ограничиться местными средствами с минимальной биодоступностью, поскольку все системные препараты проникают в грудное молоко.

---

6. Контроль лечения

Контроль симптомов оценивается по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и **через 2–4 недели** лечения. Методика оценки приведена ниже.

Визуальная аналоговая шкала представляет собой линию длиной 10 см, на которой пациент отмечает выраженность беспокоящих его симптомов. При отметке от 0 до 50 мм ринит считается контролируемым, при отметке 50 мм и более неконтролируемым.

Подростки и взрослые, ВАШ 5 см и более (ринит не контролируется): схема

1. антигистаминные препараты **на 2–4 недели**;
2. контроль достигнут: лечение по потребности, рассмотреть АСИТ;
3. контроля нет: добавить интраназальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё **на 2–4 недели**;
4. контроль не достигнут и в этом случае: пересмотреть диагноз, искать сопутствующую патологию, рассмотреть АСИТ и хирургическое лечение.

Ринит контролируемый, если за последние 4 недели

1. симптомы отсутствовали;
2. не нарушались сон и дневная активность;
3. результат теста «дыхание с закрытым ртом» нормальный.

Любое отклонение, в том числе учащение потребности в препаратах скорой помощи, означает потерю контроля; возможен переход на ступень выше.

Для проведения теста пациенту предлагается закрыть рот и в течение 30 секунд дышать только носом.

При ведении дневника симптомов (шкала TNSS, суммарная оценка назальных симптомов) пациент ежедневно оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов; суммарный балл составляет от 0 до 12. Врач рассчитывает среднее значение за 7 дней. Дневник ведётся в период обострения и для оценки эффективности АСИТ.

Отдельно оценивается медикаментозная нагрузка: приём только антигистаминных препаратов соответствует 1 баллу, интраназальных глюкокортикостероидов 2 баллам, системных глюкокортикоидов 3 баллам.

---

7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Каждому пациенту или его представителям следует разъяснить суть заболевания, составить индивидуальный план лечения и обучить навыкам самостоятельного контроля заболевания.

Пациенты подлежат диспансерному наблюдению у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые **не реже одного раза в год**, дети **не реже двух раз в год**. Наблюдение осуществляется пожизненно или до достижения стойкой ремиссии длительностью **3 года и более**.

АСИТ применяется и для вторичной профилактики: она позволяет предупредить развитие бронхиальной астмы, утяжеление течения ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации рекомендуется ограничить употребление перекрёстно реагирующих продуктов и растительных лекарственных средств.

Лечение, как правило, амбулаторное.

Показания к госпитализации

1. крайне тяжёлое или осложнённое течение;
2. у детей тяжёлое обострение с выраженной заложенностью носа;
3. плановое проведение ускоренного курса АСИТ.

Критерии выписки

1. достижение контроля над симптомами;
2. завершение курса АСИТ.

---

8. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года
Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

8.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная как «22.4 мкг»; эти значения следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», тогда как в оригинальном названии указано «untreated patients», то есть пациенты, не получавшие лечения.

Клинические рекомендации

Аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K07.0** — Основные аномалии размеров челюстей **K07.1** — Аномалии челюстно-черепных соотношений **K07.4** — Аномалия прикуса неуточненная **Q18** — Другие врожденные аномалии [пороки развития] лица и шеи
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.12.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/779_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Зубочелюстная аномалия (деформация) — диспропорция развития челюстей с функциональными и эстетическими нарушениями; может затрагивать челюсти, скуловые кости, структуры носа и другие кости лицевого черепа.
- Всем пациентам — консультация оториноларинголога. При нарушении носового дыхания — оценка ЛОР-органов и функции внешнего дыхания (передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия), по показаниям — хирургическая коррекция внутренних структур носа.
- Обязательны КТ лицевого черепа (КЛКТ или МСКТ) и МРТ височно-нижнечелюстного сустава.
- Скелетные аномалии лечат хирургически (ортогнатические операции) вместе с ортодонтом: подготовка до операции и коррекция после.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Термины

Термины

Термин	Определение
Аномалия	врождённое отклонение от нормы или общей закономерности
Деформация	изменение размеров, формы и конфигурации кости от внешних или внутренних факторов
Окклюзия	вид смыкания зубных рядов
Прикус	соотношение челюстей в положении центральной окклюзии
Дистальная окклюзия	нижний зубной ряд смещён назад относительно верхнего, резцовая дизокклюзия, нарушение соотношения боковых зубов в сагиттальном направлении
Мезиальная окклюзия	нижняя челюсть смещена вперёд относительно верхней
Вертикальная резцовая дизокклюзия	нет окклюзионных контактов между резцами
Ортогнатическая хирургия	нормализация формы, размеров, положения и соотношения челюстей; включает и приёмы для профилактики нарушения носового дыхания
Гениопластика	остеотомия подбородочного отдела нижней челюсти для изменения контуров подбородка, по эстетическим показаниям

2.2 Причины

Возникают при

1. наследственной предрасположенности и генетических заболеваниях;
2. врождённых аномалиях челюстно-лицевой области: расщелины губы, альвеолярного отростка и нёба, гемифациальная микросомия, синдромы Робена и Гольденхара;
3. нарушениях развития височно-нижнечелюстных суставов;
4. травмах челюстей с поражением зон роста;
5. рахите, нарушениях обмена кальция, эндокринопатиях.

Менее значимые причины

1. нарушение носового дыхания;
2. макроглоссия;
3. неправильное грудное вскармливание;
4. осложнения кариеса, недостаточная жевательная нагрузка.

2.3 Классификация

Рабочая классификация скелетных зубочелюстных аномалий

1. **по типу окклюзии**: по сагиттали — дистальная или мезиальная окклюзия; по трансверсали — перекрёстная окклюзия; по вертикали во фронтальном участке — вертикальная резцовая дизокклюзия;
2. **по межчелюстному соотношению**: II скелетный класс (дистальный прикус), III скелетный класс (мезиальный прикус), сужение челюсти (перекрёстная окклюзия);
3. **по симметричности**: симметричная, асимметричная.

У взрослых клиническая картина сложнее, чем у детей: к аномалии присоединяются потеря зубов, деформация зубных рядов и челюстей, функциональная перегрузка пародонта, нарушения окклюзии.

---

3. Диагностика

Диагноз — по анамнезу, клинической оценке, моделям зубных рядов, антропометрическому анализу и лучевым исследованиям: ОПТГ, ТРГ, КЛКТ или МСКТ, МРТ.

Обследование включает

1. анамнез;
2. местный и стоматологический статус;
3. рентгенологическое обследование;
4. соматический статус;
5. психоневрологический статус при нелабильной психике;
6. состояние ЛОР-органов при нарушении дыхания: функция внешнего дыхания, передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия.

3.1 Жалобы и анамнез

Выяснить жалобы на

1. изменение конфигурации челюстей или лица, асимметрию челюстей и лица;
2. частичную потерю зубов;
3. затруднение движений нижней челюсти и жевания;
4. хруст, щелчки, боль в височно-нижнечелюстных суставах;
5. нарушение носового дыхания;
6. реже — дефект речи.

3.2 Осмотр и антропометрия

Начать с оценки симметрии лицевого скелета и черепа, определения прикуса и антропометрических измерений лица.

Видимая деформация, асимметрия лица, нарушение окклюзии и межчелюстных соотношений — первичное звено обследования. Антропометрия объективно оценивает выраженность аномалии, гипсовые модели зубных рядов — прикус.

3.3 Лабораторные исследования перед операцией

При подготовке к операции — лабораторные исследования, чтобы исключить сопутствующие заболевания.

3.4 КТ лицевого черепа

Всем — КТ лицевого отдела черепа (КЛКТ или МСКТ), с трёхмерной реконструкцией или без неё; шаг или толщина среза **не более 0,5 мм**. Без КЛКТ или МСКТ диагностика невозможна.

3.5 МРТ височно-нижнечелюстного сустава

Всем — МРТ височно-нижнечелюстного сустава: целостность и положение суставного диска.

3.6 Консультации специалистов

Оториноларинголог — всем: оценивает состояние ЛОР-органов и предупреждает осложнения с их стороны.

Ортодонт — всем: хирургическое лечение всегда сопровождается ортодонтической подготовкой и коррекцией после операции.

Генетик — всем: выявить синдром или нарушение костного метаболизма.

Анестезиолог-реаниматолог — перед операцией: операции травматичны, возможна значительная кровопотеря и гемотрансфузия.

Стоматолог-терапевт — перед операцией: подготовка зубов.

Стоматолог-ортопед — всем: дефекты зубных рядов, окклюзионные соотношения.

---

4. Лечение

Рекомендованный метод лечения скелетных зубочелюстных аномалий — хирургический.

Противопоказание — тяжёлые заболевания в стадии декомпенсации; после их лечения операция возможна.

Пациентам **младше 18 лет** операцию согласуют с ортодонтом, с учётом окончания роста — для профилактики рецидива.

4.1 Общие принципы

Единого метода нет: объём операции планируют индивидуально по типу и выраженности аномалии, этнической принадлежности и возрасту. Цель — устранить аномалию и создать условия для нормальной работы зубочелюстной системы; оценивают весь лицевой скелет.

Перед операцией — планирование объёма и методик вмешательства.

Перед операцией — специализированные программы для расчёта перемещения челюстей и изменения мягких тканей лица.

Во время ортогнатической операции — жёсткая фиксация титановыми пластинами и винтами: стабильный результат, меньше рецидивов.

Ортодонтическая подготовка до операции и коррекция после.

В некоторых случаях — метод «surgery first», без предоперационной ортодонтической подготовки.

4.2 III класс: избыточный рост нижней челюсти

Двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) — уменьшить её размеры.

Большой подбородочный отдел — редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.3 III класс: недоразвитие верхней челюсти

Остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная.

Большой подбородочный отдел — редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.4 III класс: избыток нижней и недоразвитие верхней челюсти

Операции

1. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная, — увеличить верхнюю челюсть;
2. двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) — уменьшить нижнюю;
3. при большом подбородочном отделе — редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.5 II класс: избыток верхней и недоразвитие нижней челюсти

Операции

1. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная, — уменьшить верхнюю челюсть;
2. двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) — увеличить нижнюю;
3. остеотомия подбородочного отдела — по эстетическим показаниям.

Выраженная «десневая улыбка» — ротация верхней челюсти против часовой стрелки.

4.6 II класс: недоразвитие нижней челюсти

Двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) — увеличить её размеры.

Остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I.

Малый подбородочный отдел — увеличивающая гениопластика по эстетическим показаниям.

4.7 Сужение верхней челюсти, перекрёстная окклюзия

Тактика

1. оценить возраст и степень сращения нёбного шва;
2. вместе с ортодонтом решить, возможно ли ортодонтическое расширение;
3. при сращённом шве или невозможности расширения — остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I и по срединному нёбному шву с дистракционным аппаратом; величину расширения определяет ортодонт.

4.8 Вертикальная резцовая дизокклюзия

Операции

1. сегментарная остеотомия верхней челюсти с ротацией фронтального фрагмента из 4 или 6 зубов — профилактика рецидива;
2. ортодонтическая подготовка: промежутки (тремы) между зубами в местах остеотомии, чтобы не повредить корни;
3. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, BSSO, остеотомия подбородочного отдела.

4.9 Асимметричные аномалии

Тактика

1. по КЛКТ или МСКТ в специализированной программе оценить возможную послеоперационную деформацию;
2. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, BSSO, остеотомия подбородочного отдела по эстетическим показаниям; при симметричном положении одной из челюстей — одночелюстная операция.

Остаточная асимметрия после перемещения челюстей — краевая резекция или аугментация.

4.10 Иное лечение

Нарушение носового дыхания — по показаниям хирургическая коррекция внутренних структур носа.

Патология височно-нижнечелюстного сустава — артроцентез, артролаваж, диагностическая артроскопия.

Оценить показания к липосакции, липофилингу, платизмопластике, ботулинотерапии и другим методам пластической хирургии — для улучшения эстетики.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Ортогнатические операции — в круглосуточном стационаре, планово, челюстно-лицевыми хирургами.

Плановая госпитализация

1. нужна ортогнатическая операция или ортодонтическая коррекция амбулаторно невозможна;
2. диагностические или лечебные манипуляции нельзя выполнить амбулаторно.

Выписка

1. нет показаний к дальнейшему лечению в стационаре;
2. перевод в другое учреждение;
3. требование пациента или законного представителя;
4. нарушение предписаний, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих.

5.2 Реабилитация

После операции — реабилитация до полного социального и физического восстановления.

Команда: челюстно-лицевой хирург, ортодонт, анестезиолог-реаниматолог; при необходимости — невролог, офтальмолог, оториноларинголог, генетик, логопед. Специфической реабилитации нет.

5.3 Профилактика и диспансерное наблюдение

При симптомах аномалии костей черепа и лица — консультация челюстно-лицевого хирурга. Специфической профилактики нет: рациональное ведение беременности, при выявлении — обследование у ортодонта.

После операции — осмотры челюстно-лицевого хирурга и ортодонта **не реже раза в 6 месяцев**.

Подозрение на рецидив, вторичную деформацию, ухудшение местного, неврологического или офтальмологического статуса — КТ черепа, МРТ головного мозга, ЭЭГ и другие исследования по клинической картине.

На исход влияют отрицательно

1. инфекционные осложнения;
2. несоблюдение местной контактной криотерапии;
3. плохая гигиена полости рта;
4. нарушение диеты и ограничения жевания;
5. несоблюдение ношения межчелюстной эластической тяги;
6. несоблюдение лечебной физкультуры;
7. пропуск контрольных осмотров и других рекомендаций врача.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Врожденные и приобретенные аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 29.12.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2026 года
Код в рубрикаторе	779_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Рекомендации для взрослых, но в разделе 3 есть указание об операциях у пациентов младше 18 лет — с согласованием с ортодонтом.
- Текст PDF — скан с ошибками распознавания (Le Fort I, BSSO); цитаты журнала сверки приведены по распознанному тексту.

Клинические рекомендации

Болезнь Меньера

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H81.0** — Болезнь Меньера
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/18_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Достоверная болезнь Меньера:
  1. **не менее двух** спонтанных приступов головокружения длительностью **от 20 минут до 12 часов**;
  2. сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа;
  3. флюктуирующие слуховые симптомы: слух, шум, ощущение полноты в ухе;
  4. отсутствие других причин.
- Обследование всех пациентов:
  1. тональная пороговая аудиометрия: степень тугоухости;
  2. импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия): исключение патологии среднего уха.
- Купирование приступа:
  1. атропин или платифиллин подкожно;
  2. антигистаминные: дименгидринат, дифенгидрамин;
  3. бензодиазепины: лоразепам, диазепам.

  Не более **3 суток**; из-за тошноты и рвоты предпочтительно парентеральное введение.
- Межприступный период: бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки **2–3 месяца и более** после перенесённого приступа и при повторении приступов **чаще одного раза в 3 месяца**.
- Хирургическое лечение при неэффективности консервативного **в течение 6–12 месяцев**:
  1. первый этап: слухосохраняющие вмешательства;
  2. второй этап или социально незначимый слух: деструктивные вмешательства.
- Компьютерная томография (КТ) височных костей и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов:
  1. исключение новообразований, прежде всего акустической шванномы при односторонней сенсоневральной тугоухости.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Болезнь Меньера (БМ) является заболеванием внутреннего уха, которое характеризуется повторяющимися приступами системного головокружения, а также шумом в ушах и сенсоневральной тугоухостью.

2.2 Классификация

Формы по классификации AAO-HNS

1. несомненная;
2. достоверная;
3. вероятная;
4. возможная.

Варианты начала

1. кохлеарная форма: сначала слуховые расстройства, затем вестибулярные;
2. классический вариант: слуховые и вестибулярные нарушения одновременно, уже первый приступ сопровождается снижением слуха и шумом;
3. вестибулярная форма (реже): сначала приступы головокружения, слуховые расстройства позже.

По данным ряда авторов, флюктуация слуха в сочетании с головокружением наблюдается у 82,7% пациентов, без головокружения у 17,3%; по другим данным, заболевание начинается с изолированной кохлеарной симптоматики у 54,4% пациентов, с классической картины у 45,6%.

2.3 Клиническая картина

Триада

1. приступы системного головокружения;
2. шум в ухе;
3. тугоухость.

Приступ

1. развивается внезапно, в любое время, на фоне полного здоровья, ничем не провоцируется;
2. иногда предшествует аура: появление или усиление заложенности и шума в поражённом ухе;
3. всегда сопровождается вегетативными проявлениями, прежде всего тошнотой и рвотой;
4. длится несколько часов (**чаще 4–6**) и проходит самостоятельно, без препаратов;
5. шум в ухе односторонний, чаще низко- или среднечастотный, усиливается перед приступом и во время него.

Тугоухость

1. как правило, односторонняя и флюктуирующая;
2. скалярная (ложная сенсоневральная): горизонтальный или восходящий тип кривой с костно-воздушным интервалом **5–10 дБ** на низких или средних частотах;
3. пороги восприятия ультразвука в норме, латерализация ультразвука в сторону хуже слышащего уха.

2.4 Стадии заболевания

Первая стадия (начальная)

1. приступы редкие: **1–2 раза в год** или раз в 2–3 года, в среднем 1–3 часа, с тошнотой и рвотой;
2. шум, заложенность, распирание в ухе до или во время приступа, но не постоянно;
3. флюктуация слуха: ухудшение перед приступом и последующее улучшение; у некоторых пациентов слух резко улучшается сразу после приступа и снижается до прежнего уровня в течение суток.

Вторая стадия (разгар)

1. типичные приступы с интенсивным системным головокружением и выраженными вегетативными проявлениями;
2. частота: от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю или ежедневно;
3. постоянный шум в ухе, усиливающийся во время приступа;
4. ежедневная заложенность и дискомфорт в ухе;
5. слух снижается от приступа к приступу.

Третья стадия (затухающая)

1. типичные приступы урежаются или прекращаются;
2. постоянная шаткость и неустойчивость;
3. выраженное снижение слуха на поражённое ухо, часто вовлекается второе ухо;
4. возможны отолитовые кризы Тумаркина: внезапные падения вследствие резкого смещения отолитовых рецепторов, опасные травмами.

> Длительность приступа в тексте рекомендации указана неодинаково: в общем описании клинической картины она составляет несколько часов (чаще 4–6), для первой стадии в среднем 1–3 часа, в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.

2.5 Степень тяжести

Степени тяжести (частота и длительность приступов, трудоспособность)

1. тяжёлая: приступы ежедневные или еженедельные, по несколько часов, со всем комплексом статокинетических и вегетативных расстройств; трудоспособность утрачена;
2. средняя: приступы еженедельные или ежемесячные, по несколько часов, статокинетические расстройства умеренные, вегетативные выражены; трудоспособность утрачивается во время приступа и на несколько часов после;
3. лёгкая: приступы непродолжительные, ремиссии месяцы и годы.

2.6 Жалобы

Жалобы

1. приступы нарастающей глухоты;
2. шум в ушах;
3. периодическая потеря равновесия;
4. головокружение;
5. тошнота вплоть до рвоты.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают по критериям:

1. AAO-HNS (1972, 1985, 1995);
2. 2015 года, согласованным Обществом Барани, Европейской академией отологии и нейроотологии (EAONO), комитетом по равновесию AAO-HNS и Корейским обществом равновесия.

3.1 Диагностические критерии

Форма	Критерии
Несомненная	1. гистологически подтверждённый эндолимфатический гидропс; 2. не менее двух приступов головокружения от 20 минут до 12 часов; 3. сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; 4. флюктуирующие слуховые симптомы: слух, шум, ощущение полноты в ухе.
Достоверная	1. не менее двух спонтанных приступов головокружения от 20 минут до 12 часов; 2. сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; 3. флюктуирующие слуховые симптомы; 4. отсутствие других причин.

Форма	Критерии
Вероятная	1. не менее одного приступа головокружения; 2. сенсоневральная тугоухость, подтверждённая хотя бы однократной аудиометрией; 3. шум или заложенность в поражённом ухе; 4. отсутствие других причин.
Возможная	1. приступы головокружения без подтверждённого снижения слуха либо стойкая или непостоянная сенсоневральная тугоухость с нарушением равновесия без явных приступов; 2. отсутствие других причин.

3.2 Осмотр и вестибулярные пробы

Комплексное общеклиническое обследование с участием терапевта и невролога.

Объём

1. акуметрия: шёпотная и разговорная речь, камертональные пробы Вебера, Ринне и Федериче;
2. оценка спонтанного нистагма;
3. тест импульсного поворота головы (Хальмаги–Кертойза);
4. статокоординаторные и статокинетические пробы: поза Ромберга, проба Фишера–Барре, ходьба по прямой и фланговая походка, проба на диадохокинез;
5. позиционные пробы: Дикса–Холлпайка, roll-тест Пагнини–Макклюра.

3.3 Общий и биохимический анализы крови

Показания

1. дифференциальная диагностика: общий (клинический) и биохимический общетерапевтический анализы крови.

3.4 Тональная аудиометрия и импедансометрия

Показания

1. все пациенты: тональная пороговая аудиометрия, степень тугоухости.

Показания

1. все пациенты: тимпанометрия и акустическая рефлексометрия, исключение патологии среднего уха.

3.5 Подтверждение гидропса лабиринта

Показания к подтверждению гидропса лабиринта

1. клинические признаки вероятной болезни Меньера;
2. неэффективность консервативной терапии.

Методы (по отдельности или в сочетании)

1. пороги чувствительности к ультразвуку и его латерализация;
2. электрокохлеография (ЭКоГ);
3. дегидратационный тест.

3.6 Отоакустическая эмиссия и КСВП

Показания к отоакустической эмиссии и коротколатентным слуховым вызванным потенциалам (КСВП)

1. противопоказания к МРТ головного мозга (например, металлические конструкции);
2. сомнительные результаты тональной аудиометрии: подозрение на аггравацию или симуляцию.

Диагностические признаки на аудиограмме

1. скалярная (ложная сенсоневральная) тугоухость: горизонтальный или восходящий тип кривой с костно-воздушным интервалом **5–10 дБ** на низких или средних частотах;
2. пороги восприятия ультразвука в норме, латерализация ультразвука в сторону хуже слышащего уха;
3. возможно снижение амплитуды пиков спонтанной отоакустической эмиссии.

При ретрокохлеарном уровне поражения отмечается повышение порогов акустического рефлекса относительно нормальных порогов слышимости.

Критериями ретрокохлеарной дисфункции по данным КСВП являются отсутствие всех пиков с I по V, которое трудно объяснить потерей слуха; отсутствие всех пиков, следующих за I или III; удлинение межпикового интервала I–V более 4,4 мс; снижение отношения амплитуд V/I менее 0,5, особенно в сочетании с другими изменениями. Диагностическое значение имеет также патологически большая межауральная разница параметров, особенно межпиковых интервалов, если её трудно объяснить односторонней или асимметричной тугоухостью периферического уровня.

Универсального метода выявления гидропса лабиринта не существует. Для подтверждения диагноза необходим широкий спектр исследований с оценкой результатов в динамике, при этом результаты в значительной степени зависят от стадии заболевания.

3.7 Вестибулярные исследования

Показания

1. диагноз невозможно установить по клиническим данным;
2. планирование хирургического лечения.

Межприступный период

1. спонтанной вестибулярной симптоматики нет;
2. статическое и динамическое равновесие в норме, в том числе по постурографии (стабилографии);
3. при вестибулометрии угнетение вестибулярной функции, больше на стороне поражения.

Приступ: периферический вестибулярный синдром

1. системное головокружение;
2. тошнота, рвота;
3. нарушение равновесия;
4. горизонтальный вестибулярный нистагм.

Показания к видеонистагмографии (ВНГ)

1. дифференциальная диагностика;
2. планирование хирургического лечения.

Запись калорической или вращательной пробы, видеоимпульсного и других тестов.

3.8 Лучевые методы исследования

КТ височных костей и МРТ головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов, в том числе с контрастированием.

Цель: исключить

1. новообразования, при односторонней сенсоневральной тугоухости прежде всего акустическую шванному;
2. демиелинизирующий процесс;
3. нейроваскулярный конфликт;
4. приобретённые и врождённые структурные изменения височных костей.

3.9 Дифференциальная диагностика

Диагноз	Отличительные признаки
Болезнь Меньера	Приступы системного головокружения, сопровождающиеся снижением слуха, ощущением распирания и шумом в ухе, тошнотой и рвотой
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)	Кратковременные приступы системного головокружения, возникающие при изменении положения тела
Вестибулярный нейронит	Резко выраженное вращательное головокружение, расстройство равновесия, тошнота и рвота на фоне вирусной инфекции
Перилимфатическая фистула	Головокружение различной степени выраженности и нарушения слуха вплоть до глухоты после травмы уха или на фоне хронического отита; симптомы провоцируются изменением давления или громкими звуками
Инфаркт лабиринта	Острое системное головокружение, часто в сочетании с острой односторонней глухотой и шумом в ухе
Аутоиммунные заболевания внутреннего уха	Прогрессирующее головокружение преимущественно вестибулярного характера с двусторонним снижением слуха и другими признаками аутоиммунного заболевания
Вестибулярная мигрень	Мигренозная головная боль при части приступов головокружения

---

4. Лечение

Лечение включает три направления: медикаментозное купирование приступа головокружения, медикаментозную профилактику в межприступном периоде и хирургическое лечение.

4.1 Купирование приступа

1. #Атропин или #платифиллин подкожно: блокируют афферентную импульсацию от раздражённого лабиринта. Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции.
2. Дименгидринат или дифенгидрамин.

   Препараты относятся к Н1-антигистаминным средствам, проникают через гематоэнцефалический барьер и действуют как вестибулярные блокаторы центрального действия. Их используют в первые сутки приступа, максимально **до 3 суток**.
3. #Лоразепам или #диазепам в первые сутки, **максимально до 3 суток**.

   Ввиду тошноты и рвоты во время приступа предпочтительно парентеральное введение препаратов; по мере купирования симптомов возможен переход на таблетированные формы.

Препарат	Доза
#Атропин	1 мл 0,1% раствора подкожно
#Платифиллин	2 мл 0,2% раствора подкожно
Дименгидринат	50–100 мг 2–3 раза в сутки
Дифенгидрамин	25–50 мг внутрь 3–4 раза в сутки; внутримышечно — #дифенгидрамин 10–50 мг
#Лоразепам	1 мг, возможно сублингвальное применение
#Диазепам	10 мг внутримышечно

4.2 Межприступный период

Бетагистин по 24 мг 2 раза в сутки (48 мг в сутки), курс **2–3 месяца и более**.

Показания

1. после перенесённого приступа головокружения;
2. межприступный период **менее 3 месяцев**.

Бетагистин улучшает кровообращение в сосудистой полоске внутреннего уха, снижает возбудимость нейронов вестибулярных ядер и ускоряет восстановление вестибулярной функции, в том числе за счёт активации центральной вестибулярной компенсации.

Курсами: диуретики (калийсберегающие, тиазидные и другие) или ингибиторы карбоангидразы, оптимально ацетазоламид.

Пример схемы ацетазоламида из рекомендации

1. 1–3-й день: по 1 таблетке 2 раза в день (утром и днём);
2. 7–9-й и 13–15-й дни: по 1 таблетке утром.

Курс подбирают индивидуально.

Петлевые диуретики не применяются ввиду возможного ототоксического действия. При длительном приёме ацетазоламида следует контролировать уровень электролитов крови и при необходимости восполнять их.

Диетотерапия всем пациентам:

1. поваренная соль **до 2 г в сутки**;
2. исключение глутамата натрия;
3. сбалансированное питание для нормализации водно-солевого обмена.

Потребление соли и готовых продуктов следует максимально ограничить, алкоголь, кофеин и никотин исключить, жидкость потреблять умеренно.

Плановая инфузионная дегидратационная терапия: в первые 2 года заболевания **каждые 6–12 месяцев**, затем **каждые 2–3 года**. Конкретные препараты в рекомендации не указаны.

4.3 Хирургическое лечение

Показание: неэффективность консервативной терапии **в течение 6–12 месяцев**.

Первый этап: слухосохраняющие вмешательства (I и II стадии)

1. хордоплексустомия;
2. интратимпанальное введение глюкокортикоидов;
3. обнажение (дренирование) эндолимфатического мешка;
4. селективная лазеродеструкция ампулярного рецептора горизонтального полукружного канала.

Второй этап: деструктивные вмешательства

1. интратимпанальное введение гентамицина;
2. лазеродеструкция лабиринта;
3. вестибулярная нейроэктомия.

Показания: неэффективность слухосохраняющей операции или социально незначимый слух.

4.4 Медицинская реабилитация

1. нарушение равновесия в межприступном периоде на третьей стадии: лечебная физкультура;
2. двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость со средними порогами в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе **выше 31 дБ**: слухопротезирование.

При развитии соматоформных расстройств на фоне хронической вестибулярной дисфункции показана психолого-социальная реабилитация.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Диспансерное наблюдение с **ежегодным** осмотром: эффективность терапии, слуховая и вестибулярная функция.

К мерам профилактики рекомендация относит формирование здорового образа жизни, раннее выявление воспалительных заболеваний ЛОР-органов, особенно у детей, и предупреждение рецидивов хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов посредством диспансерного наблюдения.

Рекомендации пациенту

1. избегать резких перепадов давления в среднем ухе: подводное плавание, резкое сморкание, авиаперелёты;
2. ограничить углеводы, солёные, острые и жирные мясные продукты; ежедневно продукты, богатые калием (печёный картофель, творог, курага);
3. исключить алкоголь, курение, кофеин, продукты с консервантами, особенно с глутаматом натрия;
4. избегать переутомления, работы на высоте и с движущимися предметами.

5.1 Организация медицинской помощи

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-оториноларингологом в амбулаторных условиях.

Показания к госпитализации в оториноларингологическое отделение

1. тяжёлое состояние пациента;
2. тяжёлое течение: госпитализация бригадой скорой помощи напрямую в специализированное отделение, минуя амбулаторное звено.

Критерии выписки

1. прекращение или урежение приступов головокружения;
2. улучшение или стабилизация порогов слуха.

На течение и исход заболевания влияют его длительность и тяжесть, сопутствующая патология, возраст пациента, наличие и характер осложнений.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Болезнь Меньера»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «пересмотр не позднее 2026 года»; в приложении А2 — обновление каждые 3 года
Код в рубрикаторе	18_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность приступа указана неодинаково: в описании клинической картины «чаще 4-6 ч.», для первой стадии «в среднем от 1 до 3 часов», в диагностических критериях от 20 минут до 12 часов.
- Схема применения ацетазоламида приведена в таблетках, без указания дозы в миллиграммах.
- Для плановой инфузионной дегидратационной терапии (раздел 6) не названы препараты и не указаны УУР и УДД; уровни не указаны также для рекомендаций по хирургическому лечению и диспансерному наблюдению.

Клинические рекомендации

Воспалительные заболевания челюстей у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K10.2** — Воспалительные заболевания челюстей **M86** — Остеомиелит
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/997_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Хронический остеомиелит челюсти — гнойное деструктивное или пролиферативное воспаление кости **более 4 недель** с образованием секвестров или без тенденции к выздоровлению. Различают первично-хронический (негнойный), вторично-хронический (гнойный) остеомиелит и продуктивный периостит.
- При остеомиелите верхней челюсти, осложнённом верхнечелюстным синуситом или секвестрацией стенок пазухи, секвестрэктомию выполняют по типу радикальной операции на верхнечелюстной пазухе (по Колдуэллу — Люку).
- Первично-хронический остеомиелит диагностируют по 2 большим или 1 большому и 3 малым критериям; для исключения сарком и фиброзно-костных поражений показана биопсия.
- Вторично-хронический остеомиелит лечат хирургически: секвестрэктомия или резекция челюсти после формирования и полного отграничения секвестра; антибиотики — по результатам посева.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Остеомиелит — воспалительное состояние костной ткани различной природы, которое начинается с медуллярной полости, быстро распространяется по системе гаверсовых каналов, вовлекая в воспаление надкостницу и прилегающие мягкие ткани.

Периостит — воспалительное заболевание, вовлекающее надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из одонтогенного или неодонтогенного очага.

Секвестр — отграниченный воспалительно-некротический очаг костной ткани, располагающийся более или менее свободно и не подвергающийся аутолизу.

Зубоальвеолярный сегмент — условная единица объёма альвеолярной части челюсти для оценки распространённости воспаления; верхняя граница сегментов верхней челюсти — дно полости носа и верхнечелюстных пазух.

Симптом Венсана — снижение чувствительности кожи над поражённым участком и (или) нижней губы.

1. **первично-хронический остеомиелит (негнойный)** — фиброзно-костное продуктивное заболевание без выявленного триггера: без гноя, свищей и секвестров, с упорно-рецидивирующим течением и избыточным образованием кости
2. **вторично-хронический остеомиелит** — гнойное деструктивное или пролиферативное воспаление **более 4 недель**, связанное с одонтогенной инфекцией, инородными телами, травмой, пороком развития кости или системными заболеваниями
3. **хронический периостит челюсти** — хронический одонтогенный процесс с надкостницей, который может выходить за пределы пародонта одного зубоальвеолярного сегмента
4. **хронический рецидивирующий мультифокальный остеомиелит** — неинфекционное многоочаговое литическое поражение костей; у взрослых — синдром SAPHO (синовит, акне, пустулёз, гиперостоз, остеит)

2.2 Этиология и эпидемиология

Первично-хронический остеомиелит — небактериальное воспаление неизвестной этиологии, связанное с аутоиммунными заболеваниями; преобладает генетическая теория, посевы, как правило, стерильны. Вторично-хронический связан с одонтогенной инфекцией, травмой, инородными телами; 65–75% флоры — неспорообразующие анаэробы. Продуктивный периостит чаще осложняет хронический периодонтит (74,6%) в области первого моляра.

Хронические негнойные формы встречаются с частотой 1–2 на 1 000 000; первично-хронический остеомиелит у девочек в 4 раза чаще, средний возраст 9–10,8 года. Продуктивный периостит чаще у мальчиков, дебют в 8,8–11 лет. Чаще поражается нижняя челюсть.

2.3 Классификация

1. **по течению** — первично-хронический (ювенильный продуктивный; синдром-ассоциированный — SAPHO, синдром Маджида, DIRA, PAPA); вторично-хронический (одонтогенный; неодонтогенный — неонатальный, травматический, от инородного тела, при мальформации сосудов); продуктивный периостит (простой, оссифицирующий — остеомиелит Гарре, посттравматический)
2. **по этиологии** — гнойный (специфический — туберкулёзный, актиномикозный; неспецифический — бактериальный, грибковый); негнойный (остеорадионекроз, медикаментозный, аутоиммунный)
3. **по локализации** — верхняя или нижняя челюсть; локальный (зубоальвеолярный сегмент, альвеолярная часть, базис, ветвь) или распространённый (тотальный, субтотальный)

Острый остеомиелит отличается от хронического длительностью **менее 4 недель** от появления симптомов.

2.4 Клиническая картина

Первично-хронический остеомиелит течёт с обострениями (от нескольких дней до недель) и ремиссиями (месяцы — годы); при поражении челюсти чаще у девочек, единичный очаг, дебют около 10 лет (4–14 лет).

Симптомы при поражении нижней челюсти

1. боль, часто усиливающаяся ночью, с лихорадкой или без;
2. ограничение открывания рта, отёк;
3. регионарная лимфаденопатия;
4. парестезия над очагом и (или) нижней губы.

Гноя, свищей и секвестров нет — это отличает его от острого и вторично-хронического остеомиелита. При тяжёлом течении исключают злокачественные новообразования, прежде всего острый лимфобластный лейкоз.

Около 25% пациентов имеют кожные (псориаз, ладонно-подошвенный пустулёз, акне) и кишечные заболевания (болезнь Крона, язвенный колит); при поражении челюсти, ключицы, грудины возможны бессимптомные очаги в скелете.

Вторично-хронический остеомиелит характеризуется гноем, свищами и секвестрами, течёт с обострениями.

Местные проявления

1. свищевые ходы до кости с гноем или грануляциями;
2. абсцессы и флегмоны при обострении;
3. ограничение открывания рта при поражении угла и ветви нижней челюсти;
4. подвижность зубов в очаге.

Продуктивный периостит — одностороннее безболезненное плотное утолщение задних двух третей нижней челюсти с умеренной асимметрией лица, без признаков воспаления кожи и слизистой; толщина нароста до 2–3 см. Иногда возможны свищ и лимфаденопатия.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита

Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита

Большие критерии	Малые критерии
рентгенологически подтверждённые остеолитические и остеосклеротические очаги	хорошее общее состояние и нормальная лейкоцитарная формула
множественные очаги поражения	СОЭ и С-реактивный белок незначительно повышены
псориаз или ладонно-подошвенный пустулёз	длительность заболевания более 6 месяцев
стерильная биопсия с признаками воспаления и (или) фиброза, склероза	гиперостоз
—	связь с другими аутоиммунными заболеваниями; аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания у родственников I и II линии

Для постановки диагноза необходимы 2 больших или 1 большой и 3 малых критерия.

3.2 Жалобы и анамнез

Сбор жалоб и анамнеза проводит челюстно-лицевой хирург или стоматолог-хирург.

Основные жалобы

1. боль в зубе или челюсти, иррадиация по ветвям тройничного нерва;
2. подвижность зубов, отёк мягких тканей;
3. парестезия нижней губы и подбородка;
4. ограничение открывания рта, боль при глотании, жевании, движениях языка;
5. свищи, деформация челюстей;
6. симптомы интоксикации.

Уточняют связь с заболеванием или удалением зуба, переохлаждением, простудой, перенапряжением; динамику и проведённое лечение.

3.3 Осмотр полости рта и челюстно-лицевой области

Оценка общего состояния: визуальный осмотр, термометрия, пальпация костной системы, осмотр полости рта и челюстно-лицевой области при обострении.

Клиническая оценка мягких тканей, регионарных лимфоузлов и полости рта: пальпация, перкуссия, степень открывания рта и подвижности нижней челюсти. Определяется изменение конфигурации лица за счёт инфильтрации и периостального утолщения; кожа над утолщением не изменена.

3.4 Биопсия

Биопсия из очага — для дифференциальной диагностики с фиброзно-костными поражениями и остеосаркомами: на ранних этапах их клиника сходна с хроническим остеомиелитом.

Патологоанатомическое исследование материала, полученного при операции, — дифференциальная диагностика с невоспалительными поражениями и специфическим воспалением.

3.5 Анализы крови и посев

Общий анализ крови — оценка выраженности воспаления. При обострении вторично-хронического остеомиелита — лейкоцитоз более $10 \cdot 10^9$/л, нейтрофилы до 70–80%; СОЭ до 40 мм/ч при гиперергии или в норме при гипоергии.

С-реактивный белок — динамика воспаления и необходимость коррекции терапии; при хронических формах повышение умеренное и неспецифичное.

Всем с подозрением на воспалительное заболевание челюсти — посев гноя, отделяемого свищей и ран с определением чувствительности; материал биопсии и вскрытия абсцесса обязательно направляют на посев.

3.6 Компьютерная томография челюстно-лицевой области

КТ — для определения распространённости и типа процесса и планирования лечения, в том числе при обострении.

1. **первично-хронический** — на ранней стадии изменений может не быть; позже — смешанная картина склероза и остеолиза, периостальная реакция, «кость на кости»; секвестры крайне редки
2. **вторично-хронический** — очаги деструкции с секвестрами и участками остеосклероза; секвестр отграничивается **на 4–6-й неделе** на верхней челюсти и **на 6–8-й неделе** на нижней
3. **продуктивный периостит** — слоистые периостальные наслоения по типу «луковой шелухи» над компактной костью в области причинного зуба

3.7 УЗИ мягких тканей и лимфоузлов шеи

УЗИ мягких тканей, костей челюстно-лицевой области и лимфоузлов шеи — оценка гнойного процесса, дифференциальная диагностика с абсцессами, артритами и опухолями.

---

4. Лечение

Основные компоненты лечения

1. хирургическое лечение: санация очага, удаление причинного зуба, вскрытие и дренирование абсцесса;
2. противомикробная терапия — общая и местная;
3. патогенетическое и симптоматическое лечение.

1. **первая линия при первично-хроническом остеомиелите** — санация полости рта, НПВП
2. **вторая линия** — плоскостная резекция очага; антибиотики; системные глюкокортикоиды, бисфосфонаты, ингибиторы ФНО-альфа или интерлейкинов

4.1 Антибактериальная терапия

При выявлении инфекционной причины — рациональная антибактериальная терапия по результатам посева; шаблонное применение недопустимо. При первично-хроническом остеомиелите антибиотики неэффективны.

При обострении вторично-хронического остеомиелита антибиотик широкого спектра начинают эмпирически с первых часов в стационаре, эффект оценивают **через 2–3 дня**, затем корректируют по посеву. Типичная длительность — **5–10 дней**.

Критерии достаточности антибактериальной терапии

1. стойкая нормализация температуры;
2. положительная динамика основных симптомов;
3. нет признаков системной воспалительной реакции;
4. нормализация лейкоцитов, формулы, СОЭ, СРБ;
5. отрицательная гемокультура;
6. нормализация функции ЖКТ.

Нет ответа на адекватную терапию **за 1–3 дня** — дополнительное обследование (УЗИ, КТ, посевы) для поиска осложнений и вторичного очага.

При отягощённом соматическом статусе продолжительность увеличивают; при S. aureus или P. aeruginosa с бактериемией — **не менее 14 суток**.

4.2 Другая консервативная терапия

При обострении — дезинтоксикационная инфузионная терапия сбалансированными растворами.

Гипербарическая оксигенация — только как вспомогательный метод: высокая частота рецидивов и опасные осложнения.

При хроническом небактериальном остеомиелите — НПВП для купирования боли (эффективны у 40–80% детей): #метамизол натрия, парацетамол, ибупрофен, #кетопрофен.

При первично-хроническом остеомиелите — системные глюкокортикоиды после неудачи НПВП, при рецидивирующем или тяжёлом течении.

1. преднизолон — 2 мг/кг в сутки внутрь **1 неделю** с последующим снижением дозы на 25% каждые 5 дней.

Для стойкой ремиссии хронического остеомиелита — препараты, влияющие на минерализацию кости (бисфосфонаты).

1. #памидроновая кислота — 1 мг/кг (максимум 60 мг) ежемесячно или 1 мг/кг 3 дня подряд каждые 3 месяца.

4.3 Хирургическое лечение

Принципы хирургического лечения

1. вскрытие гнойного очага и удаление причинного зуба;
2. выбор обезболивания совместно с анестезиологом;
3. кратчайший доступ к очагу с наименьшим риском повреждения сосудов и нервов и лучшим оттоком.

При первично-хроническом остеомиелите — биопсия кости в объёме декортикации очага: улучшает доступ препаратов в очаг.

При продуктивном периостите — устранение источника инфекции (удаление или лечение зуба, вскрытие абсцесса) или травмы; иссечение изменённой надкостницы и избыточной кости.

При обострении — вскрытие поднадкостничного абсцесса внутриротовым доступом (периостотомия); при флегмоне или свище — вскрытие и дренирование наружным доступом.

При вторично-хроническом остеомиелите — секвестрэктомия или резекция челюсти в пределах неизменённой кости; проводится только после формирования секвестральной полости и полного отграничения секвестра.

На верхней челюсти используют внутриротовой доступ. При осложнении верхнечелюстным синуситом или секвестрации стенок пазухи секвестрэктомию выполняют по типу радикальной операции на верхнечелюстной пазухе (по Колдуэллу — Люку).

Дренирование гнойного очага (дренаж Пенроуза, силиконовые дренажи) и местное лечение раны по фазам: в I фазе — антисептики (хлоргексидин, #повидон-йод), во II — средства, стимулирующие репарацию.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. обострение при суб- или декомпенсированных сопутствующих заболеваниях, гиперергическом течении, опухолях, иммунодефиците;
2. невозможность операции под местной анестезией (поведение ребёнка, сопутствующая патология, аллергия на анестетики);
3. отсутствие стоматолога-хирурга.

Плановая госпитализация

1. хронический остеомиелит со сформированным секвестром;
2. затяжное, торпидное или прогрессирующее течение с длительным формированием секвестров.

Выписка — при неосложнённом раннем послеоперационном периоде, удовлетворительном состоянии, контролируемой боли и возможности продолжить антибиотики амбулаторно под наблюдением челюстно-лицевого хирурга.

5.2 Профилактика и реабилитация

Основа профилактики — санация полости рта. Стоматолог-терапевт и стоматолог-хирург — не реже 1 раза в год, профессиональная гигиена — не реже 1 раза в 6 месяцев; при осложнённом кариесе — своевременное эндодонтическое лечение.

Физиотерапия (электрофорез, ультразвук, парафин) — после адекватного хирургического лечения; ЛФК в ремиссии.

Факторы риска рецидива

1. возраст **6–12 лет** (смешанный прикус);
2. лейкоцитоз более $15 \cdot 10^9$/л и температура выше 39 °C при поступлении;
3. MRSA-инфекция (риск выше в 4 раза);
4. предшествующее введение антибиотиков;
5. диабет.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Воспалительные заболевания челюстей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	997_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.

Клинические рекомендации

Врождённая цитомегаловирусная инфекция

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**P35.1** — Врожденная цитомегаловирусная инфекция
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.07.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии «Российское общество неонатологов»; Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/260_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Врождённая цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) — заболевание, развившееся при антенатальной передаче цитомегаловируса (ЦМВ) от матери к плоду; одна из причин нейросенсорной тугоухости, слепоты, ДЦП и задержки развития.
- Доказательство антенатального заражения — ДНК ЦМВ в любом биоматериале (слюна, мазок из ротоглотки, моча, кровь) **в первые 3 недели жизни**; антитела IgG у новорождённого диагноз не подтверждают.
- Каждому ребёнку с любой формой врождённой ЦМВИ, независимо от аудиологического скрининга, показано исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов **до 3 месяцев жизни**.
- Отрицательный результат скрининга слуха методом отоакустической эмиссии — показание к обследованию новорождённого на ЦМВИ.
- Среднетяжёлая и тяжёлая форма: #валганцикловир 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь **6 месяцев**; изолированное снижение слуха — тот же препарат **6 недель**, начать как можно раньше.
- Сурдолог-оториноларинголог наблюдает всех детей с врождённой ЦМВИ: **каждые 3 месяца на первом году**, **каждые 6 месяцев до 3 лет**, затем **ежегодно до 18 лет**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Врождённая цитомегаловирусная инфекция — инфекционное заболевание, развившееся в результате антенатальной передачи возбудителя от матери к плоду при первичном заражении беременной, реактивации ранее приобретённой инфекции во время беременности или заражении серопозитивной беременной другим штаммом цитомегаловируса.

Цитомегаловирусная инфекция — распространённая вирусная инфекция, вызываемая цитомегаловирусом (Human Cytomegalovirus), с проявлениями от бессимптомного течения до тяжёлых генерализованных форм с поражением внутренних органов и ЦНС (при иммунодефиците и внутриутробном поражении плода).

2.2 Этиология и патогенез

Возбудитель — герпесвирус человека 5 типа. При первичном заражении беременной транзиторная виремия ведёт к поражению плаценты и передаче вируса плоду; вирус реплицируется в эндотелии и поражает почки, печень, миокард, головной мозг. Тяжесть поражения тем выше, чем меньше гестационный возраст при заражении.

Частота симптоматической формы и отдалённых последствий, в том числе нейросенсорной тугоухости, не зависит от того, было ли заражение беременной первичным или вторичным (реактивация, суперинфекция новым штаммом).

Врождённая ЦМВИ встречается у 0,5–2,5% живорождённых (в среднем около 1%). Клинические формы составляют 10–70%, из них у 20–60% детей развиваются тяжёлые необратимые последствия (нарушения слуха, эпилепсия, задержка развития, атрофия зрительного нерва). При субклинической форме (30–90% инфицированных) отдалённые последствия развиваются у 10–20%.

Вероятность передачи вируса плоду при первичном заражении растёт с 30% в I триместре до 72% в III, но наиболее тяжёлые поражения возникают при заражении в I триместре. При реактивации передача составляет около 1,5–2%, при повторном заражении — до 20%; вторичная инфекция обусловливает 50–80% всех случаев внутриутробного инфицирования.

2.3 Классификация

Формы врождённой ЦМВИ

1. клиническая: среднетяжёлая и тяжёлая;
2. клиническая: лёгкая;
3. клиническая: изолированное снижение слуха;
4. субклиническая;
5. осложнения.

Среднетяжёлая и тяжёлая форма

1. множественные проявления: тромбоцитопения, петехии, гепато- и спленомегалия, малый размер к сроку гестации, гепатит;
2. менингоэнцефалит, в том числе судороги;
3. хориоретинит;
4. микроцефалия;
5. характерные изменения головного мозга при НСГ, КТ или МРТ: кальцификаты, перивентрикулярные кисты, вентрикулодилатация, аномалии белого вещества, атрофия коры, гипоплазия мозжечка, лентикулостриарная васкулопатия.

Лёгкая форма — 1–2 изолированных клинически незначимых или транзиторных проявления: невыраженная гепатомегалия, однократное снижение тромбоцитов или повышение АЛТ.

Изолированное снижение слуха — клинических и лабораторных признаков заболевания нет, кроме снижения слуха **на 20 дБ и более**. У детей, не прошедших скрининг слуха методом отоакустической эмиссии, необходим дифференциальный диагноз между врождённой ЦМВИ и другими причинами тугоухости.

Субклиническая форма — ЦМВ в крови, моче или слюне при отсутствии клинически значимых признаков заболевания и изменений при обследовании.

«Поздние» проявления у 10–20% детей в первые 3–6 месяцев

1. задержка психомоторного развития;
2. нейросенсорная тугоухость;
3. хориоретинит.

Дети с субклинической формой требуют динамического наблюдения.

2.4 Клиническая картина

Клинические проявления

1. малый размер для гестационного срока, микроцефалия (менее 10-го перцентиля);
2. петехии, пурпура, сыпь по типу «черничного кекса»;
3. ЦМВ-ассоциированная желтуха с первых суток, дольше физиологической;
4. гепатомегалия, спленомегалия;
5. неврологические симптомы вплоть до комы, судороги;
6. нейросенсорная тугоухость, вплоть до глухоты, одно- или двусторонняя;
7. хориоретинит, ретинальные кровоизлияния, атрофия зрительного нерва, катаракта, косоглазие.

Лабораторные и инструментальные изменения

1. анемия, тромбоцитопения (менее 100 000 кл/мкл), лейкопения, нейтропения (менее 1000 кл/мкл);
2. повышение трансаминаз, конъюгированная гипербилирубинемия;
3. белок и плеоцитоз в ликворе, ДНК ЦМВ в ликворе;
4. кальцификаты (чаще перивентрикулярные), кисты, вентрикулодилатация, лентикулостриарная васкулопатия при НСГ и КТ; МРТ лучше выявляет нарушения миграции нейронов и задержку миелинизации.

Снижение слуха вплоть до глухоты может прогрессировать несколько лет: около 40% нарушений слуха формируется после неонатального периода у детей с нормальным скринингом. Мониторинг слуха продолжают **до школьного возраста**, в том числе при субклинической форме.

Тугоухость при врождённой ЦМВИ сопровождается поражением вестибулярного аппарата (до 92,3%), нередко прогрессирующим. При латентной форме нарушения вестибулярной функции выявляются почти у половины детей младшего школьного возраста; изолированные нарушения равновесия при сохранном слухе значительно недооцениваются.

При клинически выраженной форме отдалённые последствия: задержка психомоторного развития (50%), нейросенсорная глухота (50%) или двустороннее снижение слуха (37%), нарушение восприятия речи при сохранном слухе (27%), нарушения зрения (22–58%). При субклинической форме значительное ухудшение слуха развивается в 5–23% случаев.

Летальность при тяжёлой форме достигает 5–7%. При микроцефалии инвалидность развивается более чем в 50% случаев.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз с указанием формы устанавливается на основании

1. анамнеза матери;
2. клинических проявлений при физикальном обследовании;
3. лабораторных исследований;
4. инструментальных исследований.

Доказательство антенатального заражения — ДНК ЦМВ в любом биоматериале **в первые 3 недели жизни**. Клиническая форма устанавливается при характерных признаках, этиология которых подтверждена ПЦР; субклиническая — при ДНК ЦМВ без характерных признаков.

Диагноз не может быть установлен по антителам IgG к ЦМВ у новорождённого; убедительных данных о значимости авидности IgG нет.

Показания к обследованию новорождённого на ЦМВИ

1. гепатоспленомегалия, петехии, пурпура, сыпь по типу «черничного кекса», затяжная желтуха, микроцефалия;
2. судороги неясной этиологии;
3. тромбоцитопения неясной этиологии, конъюгированная гипербилирубинемия, затяжная желтуха с повышением трансаминаз;
4. кальцификаты, вентрикуломегалия и другие изменения при нейровизуализации;
5. хориоретинит, врождённая катаракта;
6. отрицательный результат скрининга слуха методом отоакустической эмиссии;
7. признаки инфекции при антенатальном УЗИ или МРТ плода;
8. сероконверсия или симптомы, характерные для ЦМВИ, у матери во время беременности;
9. недоношенность **менее 32 недель** или масса тела **менее 1500 г**.

3.2 Жалобы и анамнез

Подозрение на ЦМВИ или подтверждённая ЦМВИ у матери во время беременности (в том числе ОРВИ-подобное заболевание или лихорадка неустановленной этиологии) — показание к обследованию новорождённого.

Признаки внутриутробной инфекции при УЗИ или МРТ плода — показание к обследованию новорождённого. Специфичные УЗ-признаки: кальцификаты в головном мозге, вентрикуломегалия, микроцефалия, гепатоспленомегалия.

Всем недоношенным с гестационным возрастом **32 недели и менее** или массой тела при рождении **1500 г и менее** показано обследование на ЦМВИ для последующей дифференциальной диагностики с постнатальной инфекцией.

Признаки ЦМВ-поражения плаценты или антигены ЦМВ при исследовании последа — показание к обследованию новорождённого.

Лабораторные и (или) инструментальные признаки, характерные для ЦМВИ, — показание к обследованию на ЦМВИ.

3.3 Визуальный осмотр

Новорождённому с подозрением на врождённую ЦМВИ показан осмотр; клинические признаки врождённой инфекции — показание к обследованию на ЦМВИ.

Чаще всего встречается микроцефалия — прогностический признак неблагоприятного неврологического исхода. Обследуют детей с малым размером к сроку гестации в сочетании с микроцефалией, а не всех с малым размером к сроку гестации.

При клинических признаках врождённой инфекции новорождённому назначают обследование на ЦМВИ.

3.4 ПЦР на ДНК цитомегаловируса

Основной метод: количественное определение ДНК ЦМВ методом ПЦР в слюне, мазке со слизистой оболочки ротоглотки, моче, крови **в первые 3 недели жизни**; при недоступности количественного — качественное.

После 3 недель жизни интранатальное или раннее постнатальное заражение исключить нельзя. Наиболее информативны слюна (мазок из ротоглотки) и моча. При грудном вскармливании слюну берут **через 90 минут после кормления**, положительный результат подтверждают ПЦР мочи.

Чувствительность ПЦР мочи 98,8–100% при специфичности 99,1%; соскоба со слизистой оболочки полости рта — 93–100% при низкой положительной прогностической значимости (49–73%).

При противовирусной терапии количественная ПЦР крови выполняется в начале лечения и **каждые 2–4 недели**. Отсутствие снижения вирусной нагрузки может указывать на резистентность штамма или иммунодефицит.

Рутинное определение ДНК ЦМВ в ликворе не рекомендуется: отрицательный результат не исключает поражения ЦНС.

3.5 Антитела IgM к цитомегаловирусу

При недоступности ПЦР и в сомнительных случаях определяют IgM к ЦМВ в крови (ИФА или ХЛИА). Возможны ложноотрицательные и ложноположительные результаты; кровь берут до введения иммуноглобулинов.

3.6 Общий анализ крови

При подозрении на ЦМВИ — общий анализ крови с лейкоцитарной формулой: анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения.

При противовирусной терапии — контроль общего анализа крови **еженедельно первые 6 недель**, на 8-й неделе, далее **ежемесячно** весь курс; при терапии колониестимулирующими факторами — ежедневно до нейтрофилов более 1000 кл/мкл.

3.7 Биохимический анализ крови

При подозрении на ЦМВИ и органные поражения (гепатит, острое повреждение почек) определяют АЛТ, АСТ, свободный и связанный билирубин, креатинин, мочевину.

При противовирусной терапии — биохимический анализ с натрием и калием **ежемесячно** для своевременной коррекции дозы.

3.8 Общий анализ мочи

Ребёнку с врождённой ЦМВИ показан общий анализ мочи: возможна протеинурия с тубулоинтерстициальным поражением почек.

3.9 Исследование слуха методом отоакустической эмиссии

Показания: подозрение на врождённую ЦМВИ, подтверждённая ЦМВИ, антенатальные изменения головного мозга при УЗИ или МРТ — для выявления нейросенсорной тугоухости.

Глубоко недоношенным детям исследование проводят после достижения постконцептуального возраста **34 недели**.

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы

Ребёнку с любой формой врождённой ЦМВИ, независимо от результатов аудиологического скрининга, исследование коротколатентных вызванных потенциалов проводится **до 3 месяцев жизни** для выявления отсроченных нарушений слуха.

3.11 Нейросонография

Показания: подозрение на врождённую ЦМВИ, подтверждённая ЦМВИ, антенатальные изменения головного мозга — выявление поражения ЦНС.

3.12 Магнитно-резонансная томография головного мозга

Показания: подтверждённая врождённая ЦМВИ с неврологическими нарушениями и изменениями головного мозга при НСГ — уточнение объёма и характера поражения ЦНС. МРТ чувствительнее КТ.

3.13 Исследования внутренних органов

При подозрении на органное поражение — УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников, эхокардиография, рентгенография лёгких, обзорная рентгенография брюшной полости в зависимости от вовлечённых органов.

3.14 Консультации специалистов

Новорождённому с подтверждённой ЦМВИ показана консультация офтальмолога; глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели.

Новорождённому с подтверждённой ЦМВИ показана консультация невролога; глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели.

При нежелательных реакциях на противовирусную терапию — консультация клинического фармаколога; при тяжёлой нейтропении — гематолога.

---

4. Лечение

Этиотропное лечение проводится #ганцикловиром и #валганцикловиром (применение вне инструкции). Из-за высокой токсичности их назначают по жизненным показаниям при тяжёлом или среднетяжёлом течении после информированного согласия родителей.

#Валганцикловир менее токсичен и является препаратом выбора. В России он зарегистрирован только в таблетках, суспензия не зарегистрирована. #Ганцикловир применяют при отсутствии энтерального питания или жизнеугрожающем течении.

Отрицательная ПЦР не является целью терапии в остром периоде. Продление или прекращение лечения решает консилиум; при рецидиве после отмены терапию возобновляют.

Препараты миелотоксичны (тяжёлая нейтропения, тромбоцитопения); в эксперименте выявлены канцерогенный эффект и токсическое воздействие на гонады.

4.1 Среднетяжёлая и тяжёлая форма

Противовирусная терапия начинается как можно раньше после установления диагноза для снижения неблагоприятных неврологических исходов, включая нейросенсорную тугоухость.

1. #валганцикловир — 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь, **6 месяцев**;
2. #ганцикловир (нет энтерального питания или жизнеугрожающее течение) — 6 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно, по возможности не более **6 недель**.

При нейтропении **менее 500 кл/мкл** препарат временно отменяют на несколько дней или снижают дозу вдвое; на #ганцикловире можно перейти на #валганцикловир. При тромбоцитопении **менее $25 \cdot 10^9$/л** на фоне #ганцикловира препарат временно отменяют.

При клинических формах, требующих противовирусной терапии, дополнительно назначают иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный.

1. иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный — 1 мл/кг внутривенно каждые 48 часов до исчезновения клинических симптомов (описаны курсы до 6 введений).

4.2 Изолированное снижение слуха

Новорождённому с изолированным снижением слуха показан #валганцикловир 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь **6 недель** для улучшения слуха; лечение начинают как можно раньше.

Улучшение слуха показано при начале терапии **в первые 3 месяца**; при позднем начале улучшения не получено.

В рандомизированном исследовании терапию начинали в возрасте от 1 месяца до 4 лет (медиана 18,7 месяца), курс 6 недель; слух не улучшился.

4.3 Лёгкая и субклиническая формы

При лёгкой форме противовирусная терапия рутинно не рекомендуется; возможна в индивидуальном порядке по решению консилиума и с согласия родителей.

При субклинической форме противовирусная терапия рутинно не рекомендуется: обоснованных данных нет.

4.4 Сопутствующая терапия

Тяжёлая нейтропения (менее 500 кл/мкл), не купирующаяся временной отменой противовирусного препарата, — филграстим после консультации гематолога.

1. филграстим — 5 мкг/кг в сутки подкожно или внутривенно, при неэффективности до 10 мкг/кг в сутки; как правило, 1–3 дня до нейтрофилов 1000 кл/мкл и более.

Тромбоцитопения без кровотечения — менее 25 000 кл/мкл у новорождённых и менее 20 000 кл/мкл у детей **старше 1 месяца** — показание к трансфузии лейкоредуцированного концентрата тромбоцитов 10–15 мл/кг.

Патогенетическая и симптоматическая терапия — по ведущим синдромам: гемостатическая, противосудорожная, седативная, кардиотоническая, инфузионная.

Вскармливание материнским молоком при любой форме врождённой ЦМВИ не прекращают.

Медицинская реабилитация проводится по органным поражениям: невролог, сурдолог-оториноларинголог, офтальмолог.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Всем детям с любой формой врождённой ЦМВИ показано наблюдение сурдолога-оториноларинголога для контроля функции слуха.

Частота осмотров сурдолога

1. **каждые 3 месяца** на первом году жизни;
2. **каждые 6 месяцев** до 3 лет;
3. **ежегодно** до 18 лет.

Инфекционист: контроль терапии, её побочных эффектов, отсроченных поражений — **не реже 1 раза в 2–3 месяца** на первом году, далее по показаниям.

Офтальмолог — оценка зрения и отдалённых последствий.

Частота осмотров офтальмолога

1. недоношенные с риском ретинопатии — не реже 1 раза в 2 недели **до 6 месяцев**;
2. доношенные и поздние недоношенные без риска ретинопатии — 1 раз в месяц **до 6 месяцев**;
3. после 6 месяцев — 1 раз в 3 месяца **до 1 года**, 2 раза в год **до 3 лет**, затем ежегодно **до 18 лет**.

Страбизм, нистагм, атрофия зрительного нерва, корковое нарушение зрения, реактивация хориоретинита развиваются в течение всего детства, при субклинической форме — вплоть до 17 лет.

Невролог — **ежегодно до 7 лет** или чаще.

Частота осмотров невролога

1. субклиническая и лёгкая формы — в 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев;
2. среднетяжёлая и тяжёлая форма с поражением ЦНС — ежемесячно **до 3 месяцев**, затем 1 раз в 3 месяца **до 1,5 лет**, далее 1 раз в 6 месяцев **до 7 лет**.

Профилактика у беременных — по клиническим рекомендациям «Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) у взрослых».

5.2 Организация медицинской помощи

Новорождённого с подозрением на клиническую форму переводят из акушерского стационара в профильное отделение (патологии новорождённых, реанимации). Лечение клинической формы начинается в стационаре и продолжается амбулаторно пероральным препаратом при стабильном состоянии.

Если ребёнок не переведён на второй этап выхаживания или не прошёл скрининг слуха методом отоакустической эмиссии, в выписке указывают необходимость обследования и наблюдения для исключения субклинической формы, в том числе изолированного снижения слуха; верификация проводится амбулаторно педиатром и инфекционистом.

Показания к выписке

1. стабильное удовлетворительное состояние;
2. стабилизация лабораторных показателей;
3. отсутствие противопоказаний к выписке.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Врожденная цитомегаловирусная инфекция»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 08.07.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2029 года
Код в рубрикаторе	`260_3` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество неонатологов; Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.

Клинические рекомендации

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K21** — Гастроэзофагеальный рефлюкс **K21.0** — Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом **K21.9** — Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 30.09.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Союз педиатров России; Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"; Национальная ассоциация детских реабилитологов; Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/402_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — состояние, при котором заброс содержимого желудка в пищевод вызывает беспокоящие симптомы и (или) осложнения.
- Оториноларингологические проявления ГЭРБ: першение и охриплость голоса, гипертрофия аденоидов (после исключения персистирующих вирусных инфекций и аллергического ринита), рецидивирующие отиты; у детей старшего возраста также ночной храп и утренний кашель.
- Диагноз устанавливается только при стойкой «пищеводной» симптоматике или чёткой связи симптомов с эпизодами рефлюкса после исключения альтернативных диагнозов.
- Грудным детям с неосложнённым рефлюксом лекарства рутинно не назначаются: симптомы, как правило, исчезают самостоятельно **после 6 месяцев**. Сначала применяют терапию положением, затем антирефлюксные смеси.
- Детям **старше 1 года** с пищеводными проявлениями препаратами выбора являются ингибиторы протонного насоса курсом **4–8 недель**.
- Отсутствие ремиссии за **4–8 недель** терапии ингибиторами протонного насоса или жизнеугрожающие осложнения — показание к фундопликации по Ниссену.
- Неотложная госпитализация показана при повторяющихся эпизодах апноэ и обильном кровотечении из эрозий или язв пищевода.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) — непроизвольный ретроградный заброс желудочного либо желудочно-кишечного содержимого в пищевод.

У детей старшего возраста ГЭРБ понимается шире: хроническое рецидивирующее заболевание с нарушением моторно-эвакуаторной функции верхних отделов ЖКТ, регулярным забросом содержимого в пищевод, пищеводными и внепищеводными симптомами, повреждением слизистой оболочки дистального отдела пищевода вплоть до эрозивно-язвенного эзофагита и цилиндроклеточной метаплазии. У детей раннего возраста ведущее значение имеет морфофункциональная незрелость.

2.2 Этиология и патогенез

Непосредственной причиной ГЭРБ является гастроэзофагеальный рефлюкс. Заболевание развивается при нарушении равновесия между факторами агрессии (гиперсекреция соляной кислоты, лизолецитин, желчные кислоты, панкреатический сок при дуоденогастральном рефлюксе, некоторые лекарства и продукты) и факторами защиты (антирефлюксная функция кардии, резистентность слизистой оболочки, клиренс пищевода, своевременная эвакуация из желудка).

У подростков распространённость ГЭРБ составляет 12,4–18,8%. У детей с неврологическими нарушениями, хроническими заболеваниями лёгких (в том числе муковисцидозом), ожирением и после операций по поводу пороков развития пищевода ГЭРБ выявляется более чем в 70% случаев.

2.3 Классификация

1. **неэрозивная (НЭРБ)** — без видимых эрозий слизистой оболочки пищевода, включая эндоскопически негативную форму; около 60% случаев
2. **эрозивная (эрозивный эзофагит)** — с эрозиями слизистой оболочки пищевода; около 35% случаев; указывается стадия A–D по Лос-Анджелесской классификации

Внепищеводные проявления

1. бронхолёгочные;
2. оториноларингологические;
3. кардиологические;
4. стоматологические.

Осложнения

1. язва пищевода, кровотечение, перфорация;
2. стриктура или стеноз пищевода;
3. постгеморрагическая анемия;
4. пищевод Барретта.

Лос-Анджелесская классификация эрозивного рефлюкс-эзофагита (1994)

Стадия	Эндоскопические критерии
A	одно или более повреждений слизистой оболочки, каждое не более 5 мм в длину
B	хотя бы один дефект более 5 мм в длину, не распространяющийся между вершинами соседних складок
C	хотя бы один дефект, распространяющийся между вершинами соседних складок, но не циркулярный (менее 75% окружности пищевода)
D	дефект, занимающий не менее 75% окружности пищевода

Лос-Анджелесская классификация не содержит критериев неэрозивных изменений слизистой оболочки, поэтому врач-эндоскопист описывает признаки минимально выраженного или неэрозивного рефлюкс-эзофагита в протоколе отдельно.

2.4 Клиническая картина

Пищеводные симптомы

1. **изжога** — ключевая жалоба подростков, у детей дошкольного и младшего школьного возраста может отсутствовать;
2. **регургитация** — пассивное продвижение желудочного содержимого в нижнюю часть глотки, полость рта и за её пределы; усиливается лёжа и при наклоне туловища;
3. **отрыжка** воздухом, кислым, горьким; отрыжку кислым пациенты нередко принимают за изжогу.

Боль и нарушение глотания

1. **боль за грудиной, одинофагия** — у детей встречается относительно редко;
2. **дисфагия** — ощущение препятствия прохождению пищи; после любой пищи более характерна для эзофагита, после жидкой — для функциональных нарушений, после твёрдой нередко указывает на органическую патологию (опухоль, стриктура, стеноз);
3. **парадоксальная дисфагия** (симптом Лихтенштерна) — твёрдая пища проходит лучше жидкой.

Ком в горле (globus pharyngeus) — ощущение кома в горле, не связанное с глотанием. Возникает из-за отражённых болей при эзофагите, дискоординации мышц пищевода, крикофарингеальной гипертензии или прямого раздражения рефлюксатом слизистой оболочки гортани.

Внепищеводные симптомы

1. длительный хронический кашель, ночные приступы кашля и (или) удушья после обильной еды;
2. рецидивирующий бронхит, пневмония;
3. апноэ у детей раннего возраста;
4. периодическое першение и охриплость голоса;
5. гипертрофия аденоидов — при исключении хронических персистирующих вирусных инфекций и аллергического ринита;
6. рецидивирующие отиты;
7. нарушения ритма и проводимости сердца;
8. эрозии эмали зубов.

Изолированно, без основных жалоб, внепищеводные проявления встречаются редко. Иногда ГЭРБ выявляется только при эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), выполненной по поводу патологии желудка и двенадцатиперстной кишки.

Дети раннего возраста

1. рецидивирующие рвоты, срыгивания;
2. снижение массы тела;
3. рвота фонтаном, рвота с примесью крови или желчи;
4. респираторные нарушения вплоть до апноэ и синдрома внезапной смерти.

Частота срыгиваний снижается с 50–66% в первом полугодии до 5–10% к концу первого года жизни.

Степень тяжести срыгиваний у детей первого года жизни

Степень тяжести	Срыгивания
лёгкое течение	до 3–5 срыгиваний в день, объёмом 2,5–5,0 (единица измерения в КР не указана)
среднетяжёлое течение	в половине кормлений или чаще, до 1/2 объёма съеденной пищи
тяжёлое течение	более чем в половине кормлений, объём более 1/2 кормления и (или) отставание в физическом развитии

Патологический рефлюкс у детей первого года жизни встречается с частотой 8–11%. Среди причин выделяют натальную травму шейного отдела позвоночника, аллергию к белкам коровьего молока, лактазную недостаточность, скользящую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, нарушение вегетативной регуляции, недоношенность.

У детей первого года жизни и раннего возраста судить о наличии и выраженности эзофагита только по клиническим проявлениям невозможно.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. жалоб с учётом выраженности симптомов: у детей раннего возраста субъективные симптомы ненадёжны, большинство симптомов неспецифичны;
2. анамнеза: заболевания, при которых ГЭРБ встречается чаще, ранее установленный диагноз ГЭРБ;
3. инструментальных данных при необходимости: рентгеноскопия пищевода с контрастированием, ЭГДС, pH-метрия, pH-импедансометрия, манометрия.

Диагноз ГЭРБ устанавливается только при стойкой клинической («пищеводной») симптоматике или при чёткой связи симптомов с эпизодами рефлюкса и исключении альтернативных диагнозов.

ГЭРБ считается рефрактерной при отсутствии убедительной клинической и эндоскопической ремиссии в течение **4–8 недель** терапии стандартной дозой ингибиторов протонного насоса.

3.2 Жалобы и анамнез

Симптомы у детей первого года жизни и раннего возраста

1. персистирующие срыгивания, рвоты;
2. повышенное беспокойство, плач, усиливающиеся во время кормления;
3. снижение аппетита, отказ от еды, затруднения при глотании;
4. в тяжёлых случаях — плохие прибавки массы тела;
5. персистирующий кашель, стридор, в тяжёлых случаях — апноэ и аспирационная пневмония;
6. персистирующая икота.

Симптомы у детей старшего возраста

1. персистирующие рвоты;
2. изжога, дисфагия, отрыжка, боль за грудиной;
3. кислый, горький или другой неприятный привкус во рту;
4. ночной храп как проявление синдрома обструктивного апноэ сна;
5. утренний кашель, осиплость голоса;
6. поражение зубной эмали.

Специфических симптомов ГЭРБ нет, поэтому для дифференциальной диагностики оценивают симптомы тревоги.

Симптомы тревоги

1. рвота с примесью желчи, ночная или упорная рвота;
2. стойкая дисфагия;
3. увеличение живота в объёме;
4. гематемезис;
5. лихорадка;
6. патологические изменения при осмотре со стороны ЖКТ, дыхательной, сердечно-сосудистой или нервной системы;
7. потеря массы тела, отставание в физическом развитии;
8. нарушение психомоторного развития;
9. рецидивирующие бронхиты, пневмонии.

Если диагноз ГЭРБ не подтверждён, по алгоритму КР проводится диагностический поиск в рамках других заболеваний с консультациями оториноларинголога и пульмонолога; при осложнениях показана консультация детского хирурга.

3.3 Визуальный осмотр, пальпация, аускультация

Ребёнку с клиническими признаками ГЭРБ показан стандартный полный осмотр: визуальный осмотр, пальпация, аускультация. Патогномоничных для ГЭРБ физикальных симптомов нет.

3.4 Общий (клинический) анализ крови

При рвоте и плохой прибавке массы тела выполняется общий развёрнутый анализ крови: исключение инфекционной природы симптомов и анемии.

Анемия носит железодефицитный характер: гипохромная, микро- или нормоцитарная, норморегенераторная; уровень железа и ферритина снижен, железосвязывающая способность сыворотки повышена.

3.5 Кислотно-основное состояние и электролиты крови

При рвоте и плохой прибавке массы тела определяют pH и буферные основания крови, натрий, калий и хлориды: контроль водно-электролитного состояния и исключение ацетонемического синдрома.

3.6 Исследование кала на скрытую кровь

Детям **до 1 года** с рвотой и плохой прибавкой массы тела показано исследование кала на скрытую кровь, желательно иммунохимическим методом: в этом возрасте подобные жалобы нередко обусловлены аллергией к белкам коровьего молока.

3.7 Ультразвуковое исследование пищевода с водно-сифонной пробой

Показание: подозрение на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы; после УЗИ выполняется рентгеноскопия желудка.

Нормальный диаметр пищевода у детей 7–10 мм. При диаметре **более 13 мм** (во время глотка **15 мм и более**) заключение о скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы становится практически достоверным.

Для диагностики самой ГЭРБ УЗИ Европейским обществом детских гастроэнтерологов не рекомендуется: чувствительность около 95%, специфичность 11%.

3.8 Эзофагогастродуоденоскопия

ЭГДС проводится детям с подозрением на ГЭРБ для диагностики и дифференциальной диагностики; обязательна при симптомах тревоги.

Исследование позволяет

1. выявить врождённые аномалии верхних отделов ЖКТ (атрезии, стенозы, «короткий пищевод»);
2. диагностировать эрозивный рефлюкс-эзофагит;
3. выявить осложнения: пептический стеноз, язвы пищевода, пищевод Барретта;
4. исключить эозинофильный и инфекционный эзофагит, воспалительные заболевания кишечника;
5. выявить грыжу пищеводного отверстия диафрагмы;
6. выявить опухоли и проконтролировать пищевод после операций.

Эрозивные дефекты слизистой оболочки (без уточнения размера) при наличии симптомов подтверждают диагноз; тяжесть оценивают по Лос-Анджелесской классификации.

Нормальная эндоскопическая картина ГЭРБ не исключает. Лечение ингибиторами протонного насоса до ЭГДС переводит эрозивную форму в неэрозивную и снижает чувствительность исследования.

Признаки минимально выраженного рефлюкс-эзофагита (фиксируются в протоколе)

1. спрямление, уплотнение, мелкие треугольные выпячивания и сегментарные подъёмы Z-линии менее 10 мм;
2. гиперемия и мельчайшие эрозии в зоне пищеводно-желудочного соединения;
3. реактивная гиперплазия кардиального эпителия с гиперпластическими полипами или без них;
4. линейное утолщение слизистой оболочки по верхушкам складок нижней трети пищевода (белесые полосы).

При технической возможности используют осмотр в узком спектре света.

Детям ЭГДС, по возможности, проводится под общей анестезией или глубокой седацией.

Биопсия пищевода с гистологическим исследованием проводится для дифференциальной диагностики (эозинофильный эзофагит, болезнь Крона, инфекционный эзофагит) и своевременного выявления пищевода Барретта.

Берут не менее двух биоптатов (лучше четыре) на **2 см и более выше Z-линии**. Микроскопические изменения ГЭРБ не подтверждают и не исключают, поэтому рутинная биопсия для диагностики ГЭРБ нецелесообразна.

Пищевод Барретта диагностируется по эндоскопическому и гистологическому критериям. Сегмент метаплазии описывают по Пражским критериям C&M; при подозрении используют формулировку «подозрение на цилиндроклеточную метаплазию пищевода» с указанием протяжённости и берут множественные биоптаты. Группа риска поздней диагностики — дети с тяжёлой патологией опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью (ДЦП).

Выполняется четырёхквадрантная биопсия через каждый 1 см циркулярного сегмента метаплазии, больше биоптатов — у проксимального края «языков пламени». При обнаружении цилиндрического эпителия устанавливается диагноз пищевода Барретта независимо от наличия кишечной метаплазии и длины сегмента.

3.9 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

Показания: рефрактерное течение (нет ремиссии за **4–8 недель** терапии) и подозрение на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы по данным ЭГДС; цель — дифференциальная диагностика и выявление анатомических аномалий.

У детей первого года жизни показанием является повторяющаяся рвота давностью **более 3 суток**, если нет симптомов, определённо указывающих на механическую или функциональную непроходимость.

Исследование выполняется натощак, перед очередным кормлением. Объём бария сульфата соответствует разовому кормлению: детям **до 3 месяцев** 40–80 мл, старше — 60–200 мл; более 200 мл давать нецелесообразно.

Водно-сифонная проба (питьё воды лёжа) положительна при забросе бария из желудка в пищевод. У младенцев проба с компрессией живота положительна при двух и более эпизодах заброса за 30 секунд. При отрицательном результате осматривают в положении Тренделенбурга; нагрузочная проба с густым барием оценивает моторику пищевода и работу сфинктеров.

3.10 Внутрипищеводная pH-метрия

Показания (при возможности): подозрение на неэрозивную или рефрактерную ГЭРБ, выраженные и (или) стойкие внепищеводные симптомы. Метод регистрирует только кислые рефлюксы.

1. один из электродов устанавливают на 5 см выше кардии;
2. нормативы T. R. DeMeester применимы у детей **старше 12 лет**, у детей до года — нормативы J. Boix-Ochoa;
3. нормальный индекс рефлюкса (доля времени с pH < 4) при кислотном рефлюксе — 4,45%;
4. метод доступен не везде: ребёнка направляют в специализированный стационар или консультативный центр.

Нормальные показатели суточной pH-метрии по T. R. DeMeester

Показатель	Норма
время с pH < 4, общее	4,5%
время с pH < 4, стоя	8,4%
время с pH < 4, лёжа	3,5%

Показатель	Норма
число эпизодов рефлюкса	46,9
число эпизодов рефлюкса длительнее 5 минут	3,5
самый длинный эпизод с pH < 4	20 минут

Нормальные показатели суточной pH-метрии у детей до 1 года по J. Boix-Ochoa

Показатель	Среднее значение	Верхняя граница нормы
общее время с pH < 4	1,9 ± 1,6%	5,0%
число эпизодов рефлюкса	10,6 ± 8,8	27,0
число эпизодов длительнее 5 минут	1,7 ± 1,2	5,8
самый длинный эпизод, минуты	8,1 ± 7,2	22,5

3.11 Суточная pH-импедансометрия

Показания (при возможности)

1. рефрактерная ГЭРБ;
2. неэрозивная ГЭРБ;
3. выраженные внепищеводные симптомы.

Исследование позволяет

1. уточнить характер рефлюкса: кислотный, щелочной, смешанный;
2. связать симптомы (кашель, боль за грудиной) с эпизодами рефлюкса;
3. выявить детей со свистящим дыханием и другими респираторными симптомами, у которых рефлюкс является отягощающим фактором.

Метод выявляет и некислотный рефлюкс, определяет высоту заброса и риск аспирации. Щелочной и смешанный рефлюкс выявляются не менее чем у половины детей; норм для щелочного рефлюкса нет, сам факт заброса дуоденального содержимого в пищевод патологичен.

3.12 Пищеводная манометрия

Показания (селективно): отсутствие ремиссии за **4–8 недель** стандартной терапии, подозрение на нарушение моторики пищевода, предстоящая антирефлюксная операция.

Нижние границы нормы нижнего пищеводного сфинктера: давление 6 мм рт. ст., длина 2 см, внутрибрюшной сегмент 1 см. Исследование сложно провести у детей младше 15 лет.

3.13 Дифференциальная диагностика

1. **заболевания пищевода** — острый и хронический эзофагит, язва, стеноз, дивертикулы, опухоли пищевода, склеродермия, сидеропения
2. **заболевания нервной и мышечной систем** — эзофагоспазм, атония пищевода, ахалазия кардии
3. **сдавление пищевода соседними органами** — опухоли и кисты средостения, инородные тела, задний медиастинит, плевропульмональный фиброз, митральный порок, аневризма и праволежащая аорта, аномалии сосудов, увеличение щитовидной железы
4. **другие причины** — лекарственное воздействие, психические заболевания

---

4. Лечение

Тактика у детей с ГЭРБ

1. стартовое лечение ингибиторами протонного насоса около **8 недель**;
2. наблюдение после отмены препарата;
3. при возвращении симптомов — рентгеноконтрастное и при необходимости другие инструментальные исследования;
4. при отсутствии эффекта — рассмотреть хирургическое лечение (лечение, наблюдение и оценка результатов занимают в среднем около **1 года**).

Терапия комплексная, ступенчатая: нормализация образа жизни, режима дня и питания; медикаментозная терапия (моторика пищевода и желудка, кислотообразование, восстановление слизистой оболочки); хирургическое лечение.

4.1 Лечение детей первого года жизни и раннего возраста

Первый шаг — терапия положением: при кормлении ребёнка держат под углом **45–60°**, ночью головной конец кроватки приподнимают на **10–15 см**. Перекармливание недопустимо.

При неэффективности терапии положением назначают антирефлюксные молочные смеси с загустителями: они уменьшают частоту рефлюкса.

Варианты назначения антирефлюксной смеси

1. в начале каждого кормления адаптированной смесью — 1/2–1/4 объёма кормления;
2. 1–3 раза в день в объёме кормления, в остальные кормления — адаптированная смесь;
3. в полном суточном объёме, длительность индивидуально.

При отсутствии эффекта и плохих прибавках массы тела применяют смесь на основе глубокого гидролиза белка или аминокислотную. Отсутствие улучшения за **2 недели** свидетельствует о неэффективности, и ребёнка возвращают на прежнюю смесь. При положительном эффекте смесь продолжают **до 12 месяцев, но не менее 6 месяцев**.

Смеси с неперевариваемыми полисахаридами (камедь рожкового дерева) лечебные и назначаются врачом: объём подбирают (1/2, 1/3 или 1/4 суточного рациона), длительность — по клинике, до 2–3 месяцев; здоровым детям без срыгиваний не рекомендуются. Вместе с терапией положением эффективны в 90–95% случаев.

Грудным детям с неосложнённым рефлюксом медикаментозная терапия рутинно не рекомендуется: в большинстве случаев симптомы исчезают самостоятельно **после 6 месяцев**.

Ингибиторы протонного насоса показаны детям **старше 1 года** с выраженными симптомами (беспокойство, отказ от кормления, плохая прибавка массы тела) и эзофагитом средней и тяжёлой степени при неэффективности немедикаментозного лечения. Дозы — по инструкции.

4.2 Немедикаментозное лечение детей старшего возраста

Всем детям и подросткам с ГЭРБ рекомендуется изменение образа жизни.

Рекомендации по изменению образа жизни

1. спать с головным концом кровати, приподнятым не менее чем на 15 см;
2. снизить содержание жира и объём пищи, повысить содержание белка, избегать раздражающих продуктов (цитрусовые соки, томаты, кофе, чай, шоколад, мята, лук, чеснок);
3. снизить массу тела при ожирении;
4. не есть перед сном, не лежать после еды;
5. избегать тесной одежды и тугих поясов;
6. избегать глубоких наклонов, длительного пребывания в согнутом положении, подъёма тяжестей более 8–10 кг, упражнений с напряжением мышц брюшного пресса;
7. избегать седативных, снотворных средств, транквилизаторов, антагонистов кальция, теофиллина, холинолитиков;
8. прекратить курение.

Жиры снижают давление нижнего пищеводного сфинктера, белки повышают; кофе, чай, шоколад, мята, алкоголь и курение снижают давление сфинктера.

ГЭРБ, как правило, сочетается с гастритом, гастродуоденитом, заболеваниями желчевыводящих путей, поджелудочной железы и кишечника, поэтому базисной диетой являются столы 1, 5, 4. Изголовье поднимают брусками высотой до 15 см под ножки кровати, а не подушками; сон на левом боку уменьшает частоту рефлюкса. Слабоминерализованные щелочные воды принимают в тёплом дегазированном виде за 30–40 минут до еды в течение 4 недель.

4.3 Медикаментозное лечение детей старшего возраста

Детям старше года с пищеводными проявлениями ГЭРБ препаратами выбора являются ингибиторы протонного насоса: омепразол, эзомепразол, #рабепразол — курсом **4–8 недель**, при подтверждённом эзофагите дольше.

1. омепразол — детям **старше 2 лет** 1–4 мг/кг в сутки, максимально 40 мг (в КР одновременно указано «в два приёма» и «1 раз в сутки»);
2. эзомепразол — детям **старше 1 года** 0,5 мг/кг в 1–2 приёма, максимально 40 мг 1–2 раза в сутки;
3. рабепразол — **с 12 лет** до 20 мг в сутки.

При приёме **более 8 недель** учитывают повышение риска метаболических, инфекционных и пищевых расстройств. По эффективности ингибиторы протонного насоса превосходят блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов.

Детям **старше 6 лет** вместе с ингибиторами протонного насоса рекомендуется средство для создания желудочно-пищеводного барьера: натрия гиалуронат и хондроитина сульфат на биоадгезивном носителе полоксамере 407.

Сочетание эффективнее монотерапии ингибиторами протонного насоса в устранении пищеводных и внепищеводных симптомов и эпителизации эрозий.

По 1 пакетику (10 мл) после еды и на ночь; эффективность доказана при применении **4–5 недель**.

При сочетании пищеводных и внепищеводных симптомов внепищеводные симптомы полностью исчезли у 70,5% детей; доля принимавших антациды снизилась с 34,4 до 4,9%.

При невозможности приёма ингибиторов протонного насоса или противопоказаниях селективно применяют #фамотидин 1 мг/кг в сутки курсом **4–8 недель** при эрозивном эзофагите у детей **старше 3 лет**.

Применяется с осторожностью: эффективность ниже, фармакотерапевтический профиль неблагоприятен, высок риск тахифилаксии.

Для быстрого купирования изжоги в комплексной терапии назначают антациды, преимущественно в виде геля или суспензии. Длительно для лечения ГЭРБ не применяются.

1. алюминия фосфат;
2. алгелдрат + магния гидроксид — **с 10 лет**;
3. натрия алгинат + натрия гидрокарбонат + кальция карбонат — **с 12 лет**.

Синтетические антихолинергические средства и прокинетики применяются селективно: при сопутствующей задержке эвакуации из желудка и (или) запоре; наибольший эффект — при сочетании ГЭРБ с функциональной диспепсией.

1. тримебутин — **3–5 лет**: 25 мг 3 раза в сутки;
2. тримебутин — **6–12 лет**: 50 мг 3 раза в сутки;
3. тримебутин — **12 лет и старше**: 100–200 мг 3 раза в сутки;
4. итоприд — **с 16 лет**.

4.4 Противорецидивное лечение

В период стойкой клинико-морфологической ремиссии ингибиторы протонного насоса, блокаторы H2-гистаминовых рецепторов, прокинетики и антациды не рекомендуются.

Для профилактики рецидивов селективно проводятся реабилитационные мероприятия: бальнеолечение, физиотерапия.

ГЭРБ часто протекает на фоне хронического гастродуоденита и колонизации Helicobacter pylori, поэтому в наблюдение включают обследование и ведение по клиническим рекомендациям о патологии желудка и двенадцатиперстной кишки.

Физкультура: при неполной клинико-эндоскопической ремиссии — подготовительная группа, при полной — основная.

4.5 Хирургическое лечение

Показания к фундопликации (лапароскопической, по Ниссену)

1. рефрактерность к медикаментозной терапии: нет ремиссии за **4–8 недель** стандартной дозы ингибиторов протонного насоса;
2. необходимость постоянной фармакотерапии для контроля симптомов;
3. стриктура пищевода, пищевод Барретта;
4. жизнеугрожающие осложнения: эпизоды апноэ, рецидивирующая аспирация, реактивные заболевания дыхательных путей, неврологические нарушения, задержка физического развития;
5. тяжёлое основное заболевание (неврологическое, муковисцидоз) со значимым риском осложнений ГЭРБ.

Перед операцией исключают причины симптомов, не связанные с ГЭРБ; оперируют только детей с чётко доказанной хронической или рецидивирующей ГЭРБ, взвесив риск и пользу.

Риски фундопликации: вздутие живота, раннее насыщение, дисфагия, позывы на рвоту, демпинг-синдром, аспирация из-за застоя в пищеводе, несостоятельность манжеты с повторной операцией.

Лапароскопическая фундопликация по Ниссену является золотым стандартом и в значительной степени заменила открытую операцию: меньше травматичность и пребывание в стационаре. Робот-ассистированная операция безопасна, но существенных преимуществ не даёт.

Наименьший успех антирефлюксная хирургия даёт при внепищеводных симптомах, включая аспирационную пневмонию, у детей с неврологическими нарушениями.

4.6 Иное лечение

Детям с ГЭРБ и неврологическими нарушениями, проблемами с кормлением, недостаточным набором массы тела селективно проводится кормление через гастростому — для предотвращения осложнений и улучшения нутритивного статуса.

При тяжёлой ГЭРБ и высоком риске аспирации (тяжёлые неврологические нарушения), синдроме короткой кишки с тяжёлой ГЭРБ или дисморикой, когда пероральное и желудочное питание неэффективны, альтернативой фундопликации и гастростоме является кормление через назоеюнальный зонд.

4.7 Медицинская реабилитация

Коррекция образа жизни с обучением позиционированию

1. исключается положение лёжа на спине после еды;
2. сон на левом боку: на правом боку рефлюкс усиливается;
3. после еды допустимо жевание резинки без сахара;
4. исключают кофеин, газированные напитки, шоколад, цитрусовые, томаты, острую и жирную пищу, жирные молочные продукты.

Для улучшения глотания и уменьшения дисфагии селективно назначается лечебная физкультура по методике Р. Шейкер.

Лёжа на спине без подушки поднять голову (смотреть на пальцы ног), не отрывая плеч, удерживать 1 минуту, опустить; повторить ещё 2 раза с отдыхом по 1 минуте. Затем 30 раз поднять и опустить голову.

Для уменьшения дисфагии и изжоги селективно проводится санаторно-курортное лечение: питьевые минеральные воды, терренкуры, климатотерапия.

Возможно применение физиотерапии: синусоидальные модулированные токи, электросон, СВЧ-терапия, структурно-резонансная электромагнитотерапия, низкочастотная магнитотерапия.

Противопоказания к физическим факторам

1. тяжёлая ГЭРБ, осложнённая стриктурами, язвами, кровотечением из вен пищевода;
2. грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, подлежащая операции;
3. пищевод Барретта;
4. доброкачественная или злокачественная опухоль;
5. общие противопоказания к физической терапии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Как правило, лечение в круглосуточном стационаре не требуется, за исключением осложнённого течения и показаний к операции. Для диагностики, коррекции терапии и реабилитации целесообразен дневной стационар.

Показания к неотложной госпитализации

1. повторяющиеся эпизоды апноэ;
2. обильное кровотечение из эрозий или язв пищевода.

Показания к срочной консультации детского хирурга

1. дисфагия;
2. потеря массы тела;
3. гематемезис;
4. рецидивирующая рвота.

Дети с ГЭРБ наблюдаются педиатром или врачом общей практики и гастроэнтерологом. Осложнённое течение (стриктуры, кровотечения, пищевод Барретта) ведётся совместно с детским хирургом; при подозрении на малигнизацию ребёнка с пищеводом Барретта направляют к детскому онкологу.

5.2 Диспансерное наблюдение

Осмотры педиатра и (или) гастроэнтеролога — **не реже 2 раз в год в течение 3 лет** с момента последнего обращения.

Частота ЭГДС

1. эндоскопически негативная форма и рефлюкс-эзофагит I степени — при обострении;
2. рефлюкс-эзофагит II–III степени — **1 раз в год** и при обострении;
3. рефлюкс-эзофагит IV степени (язва, пищевод Барретта) — **1 раз в 6 месяцев** на первом году, затем **1 раз в год** при клинической ремиссии.

5.3 Профилактика

1. борьба с лишним весом;
2. ограничение продуктов, повышающих внутрибрюшное давление (газированные напитки, бобовые) и усиливающих рефлюкс (кофе, шоколад, жирная и острая пища);
3. ограничение продуктов с кислотостимулирующим действием (мучные изделия, цитрусовые, специи, жареное, редька, редис);
4. еда небольшими порциями, медленно, без разговоров;
5. подъём тяжестей не более 8–10 кг;
6. изголовье кровати приподнято на 10–15 см;
7. ограничение лекарств, расслабляющих пищеводный сфинктер;
8. не принимать горизонтальное положение **2–3 часа** после еды;
9. разъяснение вреда табачного дыма и алкоголя.

ГЭРБ не является противопоказанием к вакцинации вакцинами любого типа.

5.4 Осложнения и прогноз

Грозные осложнения ГЭРБ — пептическая стриктура пищевода при рубцевании язв, пищевод Барретта (предраковое состояние; у детей с эзофагитом 6,2–13%) и постгеморрагическая анемия при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы или эрозивно-язвенном поражении.

У большинства детей прогноз благоприятный. При пищеводе Барретта сохраняется вероятность аденокарциномы или плоскоклеточного рака; неблагоприятные признаки — метаплазия на протяжении 8 см и более и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 30.09.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2028 года
Код в рубрикаторе	`402_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Российская ассоциация детских хирургов; Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов; Национальная ассоциация детских реабилитологов; Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Доза омепразола: в одной фразе указано «до 40 мг в два приема» и «1 раз в сутки» (раздел 3.1.2).
- Обобщённый показатель DeMeester «в норме не должен превышать значений» — пороговое число в тексте пропущено (раздел 2.4).
- Частота ЭГДС при диспансерном наблюдении задана по степеням рефлюкс-эзофагита I–IV, а классификацией в разделе 1.5 служит Лос-Анджелесская (стадии A–D); соответствие степеней и стадий не приведено (раздел 5.2).
- Объём срыгиваний при лёгком течении («объемом 2,5-5,0») приведён без единицы измерения (раздел 1.6).

Клинические рекомендации

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.1** — Хронический назофарингит **J35.1** — Гипертрофия миндалин **J35.2** — Гипертрофия аденоидов **J35.3** — Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/662_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин само по себе не является патологией. Показанием к обследованию служат жалобы, клинические проявления или сопутствующее заболевание, на течение которого могут влиять аденоиды и нёбные миндалины.
- Диагноз:
  1. гипертрофия нёбных миндалин: жалобы, анамнез, фарингоскопия с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин;
  2. гипертрофия аденоидов: дополнительно инструментальное подтверждение: эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография (КТ).
- Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей не проводится.
- Тактика:
  1. есть показания: операция в плановом порядке;
  2. нет показаний или есть абсолютные противопоказания: динамическое наблюдение оториноларинголога.
- Консервативное лечение детям с гипертрофией аденоидов: только при признаках аденоидита. У детей **младше 7–9 лет** без осложнений и значимого влияния на качество жизни аденоидит не считается патологией: наблюдение.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. гипертрофия аденоидов: увеличение глоточной миндалины со стойким затруднением носового дыхания и (или) осложнениями: обструктивные нарушения сна, экссудативный средний отит, деформация лицевого скелета;
2. гипертрофия нёбных миндалин: увеличение одной или обеих нёбных миндалин; бессимптомно или с храпом, остановками дыхания во сне, нарушениями глотания и артикуляции, деформацией лицевого скелета.

Аденоидит: реактивные воспалительные изменения глоточной миндалины как органа местного иммунитета в ответ на антигены, попадающие на слизистую носа и глотки. У детей **младше 7–9 лет** без значимого влияния на качество жизни и без осложнений (например, средних отитов) аденоидит не считается патологией.

Острый синусит считается рецидивирующим при 4 и более эпизодах за последний год. Острый средний отит считается рецидивирующим при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

2.2 Этиология

1. наиболее вероятные причины: вирусная инфекция, генетическая предрасположенность, факторы окружающей среды;
2. роль бактериальной инфекции, гастроэзофагеального рефлюкса и аллергии дискутабельна;
3. как правило, действует несколько факторов одновременно.

Особое внимание уделяется вирусу герпеса IV типа: герпетическая инфекция является одной из частых причин выраженной гипертрофии глоточной миндалины со стойкой обструкцией носоглотки.

2.3 Классификация

Классификация А. Г. Лихачёва: какую часть сошника прикрывает ткань глоточной миндалины.

1. I степень: не более верхней трети сошника;
2. II степень: от 1/3 до 2/3;
3. III степень: более 2/3.

Классификация Б. С. Преображенского: расстояние от вертикали через середину язычка до края передней (нёбно-язычной) дужки делят на три части.

1. I степень: миндалина занимает треть расстояния;
2. II степень: две трети;
3. III степень: миндалины достигают язычка и соприкасаются.

2.4 Клиническая картина

Жалобы и симптомы чаще всего отмечаются при гипертрофии III степени. При I и II степени пациенты, как правило, хотя и не всегда, жалоб не предъявляют.

Гипертрофия нёбных миндалин

1. храп: постоянный, часто не зависит от положения тела во сне (в отличие от храпа при воспалении);
2. в ряде случаев признаки синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): дневная сонливость, снижение успеваемости;
3. значительно реже изменения прикуса и лёгкая дисфония.

Гипертрофия аденоидов

1. нарушения дыхания во сне;
2. стойкое затруднение носового дыхания: постоянно открытый рот, гипоназальность (закрытая гнусавость), сухость во рту;
3. снижение слуха при экссудативном среднем отите, повторные острые средние отиты;
4. даже при II степени после простуды заложенность, постназальный затёк и кашель **до нескольких недель**;
5. у школьников частые, в том числе рецидивирующие, острые синуситы.

Аденоидит

1. основная жалоба: кашель, как правило продуктивный, ночной и утренний (постназальный затёк);
2. может развиваться и при небольших размерах глоточной миндалины;
3. при гипертрофии аденоидов II–III степени одновременно заложенность носа и кашель.

Реактивные изменения глоточной миндалины после простуды или на фоне аллергического ринита у детей **младше 7–9 лет** физиологичны, если:

1. нет осложнений (средних отитов, острого синусита);
2. кашель или затруднение носового дыхания не нарушают сон и дневную активность.

Симптомы не патогномоничны.

Дифференцируют с

1. острым и хроническим риносинуситом;
2. аллергическим, вазомоторным и гипертрофическим ринитом;
3. искривлением перегородки носа;
4. инородными телами и новообразованиями полости носа и носоглотки.

Гипертрофия аденоидов часто сопутствует острому и хроническому синуситу и аллергическому риниту.

Клиническая картина у взрослых не отличается от таковой у детей.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. длительность заболевания и с чем связано начало;
2. динамику жалоб и их влияние на сон и дневную активность;
3. проводившееся лечение, его эффект и нежелательные явления;
4. сохраняются ли симптомы вне эпизодов ОРВИ и как выражены сейчас по сравнению с прошлым;
5. сопутствующие, прежде всего аллергические, заболевания: наблюдение, лечение, планируемые операции;
6. перенесённые операции и манипуляции в полости носа, включая назотрахеальную интубацию и назальные зонды.

---

3. Диагностика

Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин не является патологией.

Обследование оправдано при

1. жалобах;
2. клинических проявлениях;
3. сопутствующем заболевании, на которое могут влиять аденоидит, гипертрофия аденоидов или нёбных миндалин.

1. гипертрофия нёбных миндалин: жалобы, анамнез, физикальное обследование с фарингоскопией и обязательной оценкой нижнего полюса миндалин;
2. гипертрофия аденоидов: дополнительно эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или КТ.

3.1 Осмотр

Показания

1. каждый пациент: осмотр оториноларинголога (амбулаторно и при госпитализации).

Пальцевое исследование носоглотки детям в амбулаторной практике не проводят: результаты крайне субъективны, процедура неприятна и может травмировать структуры глотки.

Лабораторные исследования для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин не применяют; их используют лишь для диагностики сопутствующих заболеваний.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. симптомы, характерные для гипертрофии аденоидов.

Метод первого выбора, в том числе для контроля после операции.

1. предпочтителен гибкий эндоскоп с сохранением изображения (фото или видео);
2. метод первого выбора для дифференциальной диагностики и оценки носоглотки после операции, в том числе в отдалённые сроки;
3. ригидный эндоскоп дети, особенно дошкольники, переносят хуже;
4. осмотр без сохранения изображения значительно менее объективен при последующих консультациях.

3.3 Рентгенография носоглотки

Показания

1. симптомы, характерные для гипертрофии аденоидов: оценка размеров глоточной миндалины (боковая проекция).

Метод является недорогим, доступным и безболезненным. К недостаткам относятся небольшая лучевая нагрузка, необходимость правильной укладки с открытым ртом и невозможность дифференцировать аденоиды от других объёмных образований носоглотки; результат не всегда соответствует выраженности симптомов. После аденотомии рентгенография малоинформативна, поскольку не позволяет отличить аденоиды от компенсаторной гипертрофии трубных валиков и оценить рубцовые изменения.

3.4 Компьютерная томография

Показания к КТ верхних дыхательных путей и шеи

1. сложные случаи: дифференциальная диагностика гипертрофии аденоидов с другой патологией носа со сходными симптомами;
2. одновременная диагностика нескольких заболеваний.

3.5 Тимпанометрия

Показания

1. гипертрофия аденоидов: объективная оценка среднего уха.

3.6 Исследования, которые не показаны

Мазки из глотки на микрофлору для диагностики гипертрофии миндалин не показаны: условно-патогенные бактерии есть и у здоровых, рост или его отсутствие не говорит о риске и прогнозе.

3.7 Консультации специалистов

Консультация аллерголога-иммунолога

1. клинические и анамнестические признаки аллергического ринита;
2. атопическая бронхиальная астма;
3. атопический дерматит.

В первую очередь при

1. глазных симптомах, повторяющемся чихании и зуде в носу;
2. ринологических симптомах, связанных с цветением, животными или другими ситуациями;
3. повторных приступах кашля, свистящего или затруднённого дыхания, стеснения в груди, особенно ночью и рано утром;
4. атопическом дерматите, крапивнице и других аллергических заболеваниях кожи;
5. рецидивирующих острых средних отитах или риносинуситах.

Консультация специалиста по расстройствам сна

1. признаки повторяющихся обструктивных нарушений сна.

Консультация ортодонта

1. врождённые или приобретённые изменения челюстно-лицевой области.

Консультация инфекциониста

1. подозрение на персистирующую вирусную, прежде всего герпесвирусную, инфекцию.

Показание: хотя бы один признак, сохраняющийся **3 месяца и более**:

1. увеличение лимфатических узлов в 3 группах и более (не менее 3 узлов в каждой);
2. увеличение печени и (или) селезёнки;
3. абсолютное число нейтрофилов ниже возрастной нормы и (или) общее число нейтрофилов ниже 5×10^9/л.

Оториноларинголог оценивает симптомы, решение о лабораторном поиске вирусов принимает инфекционист.

---

4. Лечение

4.1 Тактика

1. есть показания: хирургическое лечение в плановом порядке;
2. нет показаний или есть абсолютные противопоказания: динамическое наблюдение оториноларинголога;
3. хроническая или врождённая сопутствующая патология: операция только по согласованию с профильным специалистом.

Абсолютные противопоказания к операции

1. шок;
2. острая стадия инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения;
3. поздние стадии тяжёлых инфекционных и онкологических заболеваний;
4. тяжёлое, крайне тяжёлое или терминальное состояние из-за сопутствующих заболеваний.

Относительные противопоказания

1. неконтролируемое или плохо контролируемое течение сопутствующей соматической патологии;
2. аномалии строения носа, резко повышающие риск серьёзных интраоперационных осложнений.

Консервативное лечение оправдано только при клинических и анамнестических признаках воспаления глоточной миндалины (аденоидита) или нёбных миндалин (тонзиллита) при наличии соответствующих жалоб или осложнений.

4.2 Аденотомия

Аденотомия: восстановление проходимости носоглотки при отсутствии противопоказаний.

Показания к аденотомии у детей

1. частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна: храп, в ряде случаев дневная сонливость и вялость;
2. экссудативный средний отит **3 месяца**, резистентный к консервативному лечению и подтверждённый тимпанометрией;
3. рецидивирующие острые средние отиты или острые синуситы (**3 эпизода и более за 6 месяцев** или **4 и более за 12 месяцев**) после исключения других причин, прежде всего иммунодефицита, и при неэффективности медикаментозной профилактики;
4. хронический синусит с выраженными симптомами или частыми обострениями при неэффективности **1–2 курсов** консервативного лечения;
5. стойкое затруднение носового дыхания без других причин, ухудшающее качество жизни или ведущее к деформации лицевого скелета (цефалометрия, заключение ортодонта или челюстно-лицевого хирурга);
6. заключение других специалистов об аденотомии как этапе лечения сопутствующего заболевания (например, перед кардиохирургическим вмешательством).

Ориентир при объективной оценке нарушений сна: индекс апноэ-гипопноэ.

1. **5–15**: среднетяжёлая форма;
2. **более 15**: тяжёлая форма.

Детям аденотомию предпочтительно выполнять под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

4.3 Тонзиллотомия, сочетанная операция, тонзиллэктомия у взрослых

Тонзиллотомия детям с гипертрофией нёбных миндалин: уменьшение размеров миндалин.

Показание

1. частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, в ряде случаев дневная сонливость и вялость); ориентир: индекс апноэ-гипопноэ, как при аденотомии.

При одновременном наличии у ребёнка показаний и к тонзиллотомии, и к тонзиллэктомии предпочтение отдаётся тонзиллэктомии. Тонзиллотомию предпочтительно проводить под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Сочетанная гипертрофия аденоидов и нёбных миндалин: аденотомия с тонзиллотомией по показаниям к аденотомии.

Такое вмешательство проводится только под общим обезболиванием с обязательным визуальным контролем операционного поля; в раннем послеоперационном периоде пациент находится под наблюдением в ЛОР-отделении стационара.

Взрослые с гипертрофией нёбных миндалин и синдромом обструктивного апноэ сна: тонзиллэктомия при отсутствии противопоказаний.

> Для рекомендации о тонзиллэктомии у взрослых не указаны ни уровень убедительности рекомендаций, ни уровень достоверности доказательств. Кроме того, в разделах о госпитализации, послеоперационном обезболивании и реабилитации речь идёт только об аденотомии и тонзиллотомии, тонзиллэктомия у взрослых не упоминается.

4.4 Консервативное лечение аденоидита

Консервативное лечение детей с гипертрофией аденоидов: только при признаках аденоидита.

Признаки аденоидита

1. продуктивный кашель вследствие постназального затёка;
2. выделения из носа;
3. периодическое затруднение носового дыхания.

У детей **младше 7–9 лет** без значимого влияния на сон, приём пищи и дневную активность и без осложнений (например, средних отитов): наблюдение.

1. Промывание (орошение) полости носа всем пациентам с аденоидитом.
    1. 1–2 раза в день изотоническими или гипертоническими (1,5–3%) солевыми растворами на основе морской воды;
    2. облегчает туалет полости носа, уменьшает симптомы, улучшает условия для местных препаратов;
    3. детям дошкольного возраста промывание большими объёмами не рекомендуется: высокий риск средних отитов.
2. Местные антибактериальные препараты по специальным показаниям.

    Показания

    1. слизисто-гнойные выделения из носа и по задней стенке глотки в течение всего дня;
    2. отсутствие улучшения **за 7–10 дней** противовоспалительной терапии.

    Препараты (курс до 7 дней)

    1. назальный спрей фрамицетина;
    2. дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин: детям **старше 2,5 года**;
    3. тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат: раствор для ингаляций.

    Введение в полость носа растворов антибиотиков, предназначенных для парентерального, внутриконъюнктивального или ушного применения, не рекомендуется: они не предназначены для полости носа и могут нарушать мукоцилиарный транспорт.
3. Карбоцистеин и другие мукорегулирующие препараты пациентам **старше 2 лет**.
    1. карбоцистеин в форме сиропа, в том числе карбоцистеина лизина моногидрат, курсом **от 1 до 3 месяцев**;
    2. уменьшает постназальный затёк и повышает вероятность разрешения сопутствующего экссудативного среднего отита;
    3. при монотерапии отличие от выжидательной тактики заметно лишь к 2–3-й неделе;
    4. другие муколитики, в том числе местные, одновременно не назначают: усиливают затёк.
4. #Мометазон назальный спрей по 50 мкг в каждый носовой ход 1 раз в сутки, **1–3 месяца**: детям **старше 2 лет** при сопутствующем аллергическом рините.

    Ни гипертрофия аденоидов, ни аденоидит, ни назофарингит не зарегистрированы в России в качестве показания ни для одного топического глюкокортикостероида; пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

Не рекомендуются

Масла, в первую очередь масло туи, при гипертрофии аденоидов и аденоидите не применяются: их эффективность не доказана, а в полости носа они угнетают функцию ресничек мерцательного эпителия, нарушают эвакуацию секрета и повышают риск бактериальной инфекции.

Ежедневное промывание полости носа растворами антисептиков не рекомендуется: эффективность не доказана, нарушается мукоцилиарный транспорт, возможны местные дисбиотические изменения.

4.5 Послеоперационное обезболивание

После аденотомии и (или) тонзиллотомии: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол.

Показания к обезболиванию

1. жалобы на боль;
2. отказ от еды и питья;
3. повторная рвота и тошнота.

Препарат	Доза у детей
Ибупрофен	8–10 мг/кг на приём, не более 30 мг/кг в сутки, внутрь в лекарственной форме, соответствующей возрасту (таблетки, покрытые оболочкой, — с 6 лет); детям младшего возраста — ректальные суппозитории.
Кетопрофен	С 6 лет — гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь (кетопрофена лизиновая соль), 40 мг на приём до 3 раз в день.
Парацетамол	10–15 мг/кг на приём, не более 60 мг/кг в сутки, в любой лекарственной форме, соответствующей возрасту. При невозможности приёма внутрь и отсутствии суппозиториев — парентерально 15 мг/кг на введение.

4.6 Послеоперационное ведение

Осмотр оториноларинголога после аденотомии и (или) тонзиллотомии: перед выпиской и амбулаторно **через 7–14 дней** после выписки.

Охранительный режим **5–7 дней** после операции.

1. ограничение контактов: не посещать детский коллектив и людные места;
2. ограничение физической нагрузки;
3. исключение перегревания, особенно головы и шеи, в том числе горячей пищи и питья.

Дисфония **более месяца** после операции: направление к логопеду-дефектологу.

Симптомы обструктивных нарушений сна **более 6–8 недель** после операции: направление к специалисту по расстройствам сна.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Специфическая профилактика гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин отсутствует. Поскольку важную роль играют респираторные вирусы, следует соблюдать общие правила профилактики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Ряд лекарственных препаратов может применяться для плановой и экстренной профилактики аденоидита у детей.

Детям **старше 1 года** из групп риска по респираторным инфекциям рекомендованы стандартизированные растительные препараты для приёма внутрь из группы прочих антисептиков для профилактики эпизодов ОРВИ, а также для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующих эпизодов аденоидита.

К ним относятся препараты, содержащие корень алтея, цветки ромашки, хвощ, листья грецкого ореха, тысячелистник, кору дуба и одуванчик лекарственный. Они назначаются также для лечения аденоидита при появлении симптомов ОРВИ в качестве монотерапии или в комплексе.

Детям **старше 3 лет** при появлении симптомов острого назофарингита применяют комбинированный препарат лизоцим + пиридоксин для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующего аденоидита.

Детям из групп риска по респираторным инфекциям: лизаты бактерий для сокращения длительности и тяжести эпизодов аденоидита и осложнений.

Плановая профилактика курсами по инструкции **2–3 раза в год**, пероральные и местные формы.

Для профилактики аденоидитов и их осложнений у детей может рассматриваться применение местных пробиотиков на основе бактерий нормальной микрофлоры глотки.

Обратиться к врачу, если после простуды **2 недели и более** сохраняются:

1. заложенность носа;
2. храп;
3. снижение слуха;
4. кашель (при исключённой патологии нижних дыхательных путей).

5.2 Показания к госпитализации и выписке

Показание к госпитализации

1. плановая аденотомия и (или) тонзиллотомия при наличии показаний и отсутствии противопоказаний.

Аденоидит лечат амбулаторно или в консультативно-диагностическом отделении.

Выписка после операции

1. удовлетворительное общее состояние;
2. отсутствие осложнений.

5.3 Факторы, влияющие на исход лечения

Влияют на исход операции

1. хронические соматические заболевания: возможно обострение в раннем послеоперационном периоде;
2. аллергический ринит: выше вероятность неполного регресса назальных симптомов (передней и задней ринореи, в меньшей степени заложенности);
3. ожирение: выше вероятность сохранения обструктивных нарушений сна;
4. гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: выше вероятность сохранения назальных симптомов и риск инфекционных осложнений.

При гипертрофии нёбных миндалин медикаментозное лечение аденоидита крайне малоэффективно в отношении обструктивных нарушений сна.

При наличии у ребёнка сопутствующего заболевания, способного повлиять на результат операции, врач должен проинформировать об этом пациента или родителей до операции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	662_2 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Рекомендация о тонзиллэктомии взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и СОАС дана без уровня убедительности рекомендаций и уровня достоверности доказательств, а в разделах о госпитализации, обезболивании и реабилитации упоминаются только аденотомия и тонзиллотомия.
- Для хронического аденоидита в разделе 1.4 предложены два кода: J31.1 («как возможный вариант кодирования») и J35.8 («например, аденоидит»).
- В комментарии к ибупрофену фраза о суппозиториях оборвана («ректальные суппозитории (у детей младше) 2 лет»), поэтому возрастная граница неоднозначна.

Клинические рекомендации

Грибковый отит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B37.8** — Кандидоз других локализаций **B44.8** — Другие виды аспергиллеза **B49** — Микоз неуточненный **H60.8** — Другие наружные отиты **H62.2** — Наружный отит при микозах **H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/304_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Отомикоз: грибковое поражение кожи ушной раковины, наружного слухового прохода, барабанной перепонки, барабанной полости или послеоперационной полости среднего уха. Основные возбудители — плесневые грибы Aspergillus и дрожжеподобные Candida. Течение хроническое, рецидивирующее.
- Диагноз ставят только после выявления возбудителя: микроскопия и посев отделяемого из уха на грибы. Однократный отрицательный результат микоз не исключает.
- Лечение: тщательный туалет уха врачом и местные противогрибковые аппликации, при среднем отите и микозе послеоперационной полости — также противогрибковые препараты внутрь. Критерий излечения: клиническое выздоровление в течение месяца и отрицательное микологическое исследование.
- Госпитализация:
  1. осложнённый грибковый средний отит;
  2. лабиринтит;
  3. невозможность ежедневного туалета уха;
  4. нет эффекта амбулаторного лечения наружного грибкового отита **за 5–7 дней**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение и формы

1. грибковый наружный отит: плесневые или дрожжеподобные грибы на коже ушной раковины, стенках наружного слухового прохода, барабанной перепонке;
2. грибковый мирингит: плесневые грибы на барабанной перепонке;
3. грибковый средний отит: плесневые и дрожжеподобные грибы в барабанной полости;
4. микоз послеоперационной полости среднего уха.

Синоним: отомикоз (ОМ).

Классификация

1. по локализации: наружный грибковый отит, грибковый мирингит, грибковый средний отит, грибковый средний послеоперационный отит;
2. по возбудителю: плесневой, дрожжеподобный, смешанный;
3. по течению: хронический.

2.2 Возбудители и предрасполагающие факторы

1. Aspergillus: 65% случаев;
2. Candida: 30%;
3. Penicillium, Mucor, Alternaria, Geotrichum, Cladosporium и другие: до 5%;
4. сочетание Aspergillus и Candida: 15%.

Все возбудители условно-патогенные: болезнь развивается при предрасполагающих факторах.

Виды: Aspergillus niger, fumigatus, oryzae, flavus и другие; Candida albicans, tropicalis, krusei, glabrata, parapsilosis и другие; Penicillium notatum и другие.

Предрасполагающие факторы

1. травма кожи при чрезмерной гигиене слухового прохода с удалением защитной серы;
2. сахарный диабет: глюкоза в ушной сере повышается уже на ранних стадиях;
3. соматические заболевания, нарушение обмена веществ, гиповитаминоз;
4. длительная системная и местная антибиотикотерапия, кортикостероиды;
5. иммунодепрессанты, лучевая терапия.

Микоз послеоперационной полости

1. длительное воспаление в полости с повреждением эпителия;
2. травма уха, в том числе операционная;
3. попадание нестерильной воды;
4. влажность, запылённость, производственный контакт с антибиотиками.

Для грибкового отита характерно рецидивирующее течение.

2.3 Жалобы и анамнез

Наружный грибковый отит

1. жидкие выделения (кандидоз);
2. корочки и пробки в слуховом проходе (аспергиллёз);
3. зуд, боль, заложенность уха;
4. в острой стадии иногда головная боль, лихорадка, болезненность раковины, заушной области и слухового прохода.

Слух не снижен или снижен незначительно по кондуктивному типу.

Грибковый средний отит

1. снижение слуха;
2. выделения из уха;
3. периодический зуд;
4. возможны головокружения.

Течение длительное; обострения — выраженная боль, зуд, заложенность, выделения, головная боль, головокружение.

В анамнезе уточняют

1. начало и течение болезни, частоту и характер обострений;
2. прежние отиты и микозы другой локализации;
3. прежнее лечение и его эффект;
4. лечение антибиотиками, кортикостероидами, иммунодепрессантами: длительность и интенсивность;
5. производственные и бытовые условия, аллергологический анамнез.

Для отомикоза характерны учащение обострений и слабый эффект стандартного лечения.

2.4 Картина по возбудителю

Возбудитель	Картина
Дрожжеподобные (Candida)	1. в процесс может вовлекаться кожа раковины и околоушной области; 2. гиперемия, инфильтрация и мацерация кожи слухового прохода, гиперемия барабанной перепонки; 3. при среднем отите утолщение слизистой, густое мутное отделяемое; нарушение эпителизации послеоперационной полости; 4. беловатое, менее густое отделяемое; на раковине эрозии, легко снимающиеся беловатые налёты; возможен хондроперихондрит.

Возбудитель	Картина
Aspergillus	1. казеозно-некротические массы; 2. инфильтрация сильнее в костном отделе, возможен мирингит; 3. беловато-серые наложения с чёрными вкраплениями: «молотый перец», «промокшая газета»; 4. Aspergillus glaucus: зеленоватое отделяемое.
Penicillium	1. желтоватое отделяемое, иногда как сера, по всему слуховому проходу; 2. инфильтрация кожи, сухие корочки и плёнки.
Geotrichum capitatum	1. выраженная инфильтрация кожи, мирингит; 2. плотные «замазкообразные» серовато-жёлтые массы по всему слуховому проходу.

3. Диагностика

Диагноз основан на комплексе: жалобы, анамнез, физикальное, лабораторное и инструментальное обследование.

3.1 Отомикроскопия

Показания

1. все пациенты: осмотр наружного слухового прохода, барабанной перепонки, барабанной полости и послеоперационной полости под микроскопом, отоскопом или торцевым эндоскопом.

Общий признак всех форм

1. окрашенное отделяемое в слуховом проходе и (или) среднем ухе.

Диагноз «отомикоз» ставят только после выявления возбудителя.

Осмотр с увеличивающей оптикой: отоскоп, микроскоп, торцевой эндоскоп.

Форма	Отоскопические признаки
Кандидоз наружного слухового прохода	1. умеренное сужение просвета, сильнее в хрящевом отделе; 2. барабанная перепонка гиперемирована; 3. отделяемое жидкое, беловатое, творожистое; 4. процесс часто переходит на кожу раковины.
Аспергиллёз	1. сужение за счёт инфильтрации, сильнее в костном отделе; 2. барабанная перепонка почти всегда инфильтрирована, утолщена, без опознавательных контуров; иногда грануляции; 3. обильное отделяемое разных оттенков серого, иногда с чёрными точками, холестеатомо- или сероподобное, как промокшая газета.
Пенициллиоз	1. процесс в хрящевом отделе, умеренная инфильтрация без полного закрытия прохода; 2. барабанная перепонка гиперемирована, иногда эрозирована или выпячена — ложное впечатление перфорации; 3. отделяемое оттенков жёлтого, как сера, по всему проходу, с сухими корочками и плёнками.

Форма	Отоскопические признаки
Грибковый средний отит	1. специфическое отделяемое, цвет и консистенция по виду гриба; 2. часто сопутствует наружный отит; 3. барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, перфорации разного размера; 4. слизистая барабанной полости гиперемирована, инфильтрирована, иногда грануляции.
Микоз послеоперационной полости	1. эпителизации нет или она резко замедлена; 2. стенки прохода гиперемированы, неравномерно инфильтрированы; 3. неотимпанальная полость заполнена отделяемым, как при отомикозе другой локализации; 4. мелкие кровоточащие грануляции.

3.2 Микологическое исследование отделяемого из уха

Показания

1. все пациенты: микроскопия отделяемого на дрожжевые и мицелиальные грибы, посев на дрожжевые и на мицелиальные грибы.

При хроническом отите обязательно, если

1. частые обострения (**1 раз в 2 месяца**);
2. противовоспалительная антибактериальная терапия неэффективна;
3. характерная отоскопическая картина микоза.

После лечения — контрольные исследования.

1. материал берут аттиковым зондом или ложкой Фолькмана из глубоких отделов слухового прохода под контролем микроскопа, отоскопа или эндоскопа;
2. помещают между двумя обезжиренными стерильными стёклами, микроскопия при увеличении ×100, ×200, ×400;
3. микроскопия — самый информативный метод, надёжно определяет возбудителя;
4. критерий микоза при посеве: титр грибов **не менее 10^4 КОЕ/мл**.

Повторное исследование: однократный отрицательный результат не исключает грибковое заболевание, а единичный рост грибов в посеве не всегда означает микоз. Решающее значение — у микологических методов, не у отоскопии.

3.3 Анализы крови

Показания

1. затяжное и рецидивирующее течение: поиск сопутствующих и фоновых заболеваний.

Исследования

1. общий (клинический) анализ крови;
2. биохимия: глюкоза, общий белок, АСТ, АЛТ, креатинин;
3. антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2;
4. антитела к бледной трепонеме;
5. HBsAg (гепатит B), антиген вируса гепатита C.

Поражение уха на фоне системных, в том числе инфекционных, заболеваний: консультация соответствующего специалиста и дообследование.

4. Лечение

Всем пациентам лечение начинают с элиминации возбудителя: противогрибковая терапия и тщательный туалет слухового прохода, барабанной или послеоперационной полости. Учитывают прежние эпизоды микоза и местные противогрибковые препараты.

Местную терапию начинают, не дожидаясь результатов посева.

Схема лечения отомикоза

Локализация	Дрожжеподобные грибы	Плесневые грибы
Наружное ухо, местно	нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор	нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор
Среднее ухо, местно	нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор	нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор
Среднее ухо, внутрь	#флуконазол, капсулы	#итраконазол, капсулы
Послеоперационная полость, местно	нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор	нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор
Послеоперационная полость, внутрь	флуконазол, капсулы	итраконазол, капсулы, или #тербинафин, таблетки (с 3 лет)

4.1 Наружный грибковый отит

Кандидозный: 1% раствор #клотримазола + 1% раствор #нафтифина, аппликации.

1. по 5–10 минут 2 раза в сутки, **14 дней**;
2. затем ещё **14 дней** после стихания клинических признаков и (или) до 3-кратного отрицательного анализа.

Возможны также миконазол, натамицин, #эконазол.

Плесневые грибы: #хлорнитрофенол + 1% раствор #нафтифина, аппликации на кожу слухового прохода.

1. по 5–10 минут 2 раза в день, **10–14 дней**;
2. затем ещё **14 дней** после стихания клинических признаков и (или) до 3-кратного отрицательного анализа.

Грибково-бактериальная ассоциация: комбинированные ушные капли #хлорамфеникол + беклометазон + клотримазол + лидокаин.

1. по 4–5 капель 3–4 раза в день, **10 дней**; детям **с 6 лет**.

4.2 Грибковый средний отит и микоз послеоперационной полости

Candida: кроме местного лечения — противогрибковый препарат внутрь, #флуконазол в возрастной дозе.

Плесневые грибы: итраконазол или тербинафин внутрь; местная терапия как при наружном грибковом отите.

Дозы противогрибковых препаратов системного действия

1. #флуконазол: внутрь 50–100 мг 1 раз в сутки, **14 дней**;
2. #итраконазол: внутрь 200 мг 1 раз в сутки, **10–14 дней**;
3. #тербинафин: внутрь 250 мг в сутки, **16 дней**.

Критерий эффективности: полное клиническое излечение **в течение месяца**, подтверждённое клинической картиной и отрицательным микологическим исследованием.

1. нафтифин: фунгистатичен к Candida, фунгициден к плесневым грибам, есть противовоспалительный эффект, долго держит концентрацию в коже;
2. хлорнитрофенол: противогрибковое и антибактериальное действие, в высоких концентрациях активен и против Proteus и синегнойной палочки;
3. клотримазол: высокоспецифичен к Candida, преимущественно фунгистатичен.

4.3 Туалет уха

Показания

1. все пациенты: тщательная очистка уха от отделяемого перед местной терапией.

Только врач: аттиковым зондом и (или) ушным зондом с ватой, смоченной противогрибковым препаратом, или вакуум-экстрактором. Даже небольшое количество грибковых масс заметно удлиняет лечение.

Особенности

1. наружный отит: особенно передненижний отдел слухового прохода;
2. средний отит: полностью удалить массы из области перфораций; при больших перфорациях промывание барабанной полости 0,01% раствором бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония;
3. послеоперационный микоз: очищают всю неотимпанальную полость, особенно задний отдел за шпорой.

Препарат вводят в ухо на турунде: спиртсодержащие капли раздражают слуховой проход, а при среднем отите вызывают резкую боль, отёк слизистой, усугубление мукозита и грануляции. Турунда удлиняет действие препарата.

4.4 Хирургическое лечение

Показания

1. полипы, грануляции: до медикаментозной терапии удаление или туширование 10% раствором нитрата серебра.

После туширования обязательна обработка местным противогрибковым препаратом, например нафтифином или хлорнитрофенолом.

Физиотерапия не рекомендуется. Ограничить пыль, газы, повышенную влажность; решающее значение — не допускать попадания воды в ухо.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. осложнённые формы грибкового среднего отита;
2. лабиринтит;
3. невозможность ежедневного адекватного туалета слухового прохода;
4. неэффективность адекватной амбулаторной терапии наружного грибкового отита **в течение 5–7 дней**.

Первичную помощь оказывают врачи общей практики и оториноларингологи первичного звена. Медицинская реабилитация не проводится.

5.2 Диспансерное наблюдение и профилактика

Показания

1. все пациенты с грибковым отитом: осмотр оториноларинголога **1 раз в 3 месяца**, при благоприятном течении **1 раз в полгода**, **2 года**.

Профилактика

1. правильный туалет слухового прохода и ушной раковины;
2. коррекция гликемии;
3. общеукрепляющая терапия.

Профилактика рецидивов

1. наблюдение **6 месяцев**;
2. курс профилактического лечения;
3. раз в неделю **4–6 недель** смазывание кожи слухового прохода нафтифином или хлорнитрофенолом.

Повторные посевы из уха — до микробиологического подтверждения элиминации возбудителя.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Грибковый отит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	`304_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Деформация перегородки носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.2** — Смещенная носовая перегородка
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.05.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/913_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Деформация перегородки носа: смещение перегородки от средней линии с нарушением носового дыхания. Главная жалоба — стойкое одно- или двустороннее затруднение носового дыхания.
- Диагноз: жалобы, передняя риноскопия, эндоскопия полости носа; перед операцией — рентгенография или КТ околоносовых пазух, детям и подросткам — КТ обязательно.
- Лечение хирургическое: септопластика, в том числе эндоскопическая. У детей — щадящая техника из-за ростковых зон; детей **младше 12 лет** оперируют в учреждениях третьего уровня.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Деформация перегородки носа: анатомическое изменение строения и положения перегородки относительно средней линии, вызывающее нарушение носового дыхания. Синонимы: девиация, искривление перегородки носа.

2.2 Этиология

1. без травмы: дисбаланс развития до рождения, при прохождении родовых путей, в периоды активного роста — костно-хрящевой остов перегородки растёт быстрее свода и дна полости носа;
2. травма: вид деформации зависит от вида и механизма травмы;
3. у детей преимущественно нетравматическая.

2.3 Классификация

Рекомендуемая унифицированная классификация:

1. С-образная девиация;
2. S-образное искривление;
3. гребень;
4. вывих четырёхугольного хряща;
5. утолщение («бугор»).

Известны также классификации Cottle, Mladina, А. С. Лопатина и Г. З. Пискунова.

2.4 Клиническая картина

Перегородка смещена от средней линии, изменена её форма. Основной симптом — одно- или двустороннее затруднение носового дыхания.

Возможные сопутствующие симптомы

1. гипо- или аносмия;
2. храп, апноэ сна;
3. ксеростомия, сухость слизистой носа;
4. деформация наружного носа;
5. рецидивирующие носовые кровотечения;
6. рецидивирующие риносинуситы;
7. стекание слизи по задней стенке глотки;
8. закрытая гнусавость;
9. рецидивирующая головная боль по типу головной боли напряжения.

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. жалобы на стойкое одно- или двустороннее нарушение носового дыхания;
2. передняя риноскопия: девиация и смещение перегородки, изменение внутриносовой анатомии, субтотальная или тотальная назальная обструкция;
3. эндоскопия полости носа, рентгенография или КТ околоносовых пазух: деформация перегородки и других внутриносовых структур.

У детей без сформированной речи затруднение носового дыхания оценивают со слов родителей или опекуна.

3.1 Передняя риноскопия

Показания

1. все пациенты с затруднением носового дыхания: первичный осмотр оториноларинголога.

Оценивают

1. перегородку и её положение;
2. нижние и средние носовые раковины;
3. состояние слизистой оболочки.

Лабораторные и иные исследования для первичной диагностики не показаны.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. все пациенты при наличии оборудования: локализация деформации, изменения других внутриносовых структур, состояние носоглотки.

3.3 Рентгенография или КТ околоносовых пазух

Показания

1. деформация перегородки: анатомия пазух, планирование операции, сопутствующая патология — хронический синусит, новообразования, инородные тела.

Детям и подросткам перед операцией — КТ околоносовых пазух обязательно.

4. Лечение

4.1 Хирургическое лечение

Показания

1. деформация перегородки при наличии показаний и без противопоказаний: септопластика или пластика перегородки с эндоскопической поддержкой — восстановление носового дыхания.

Дети и подростки

1. щадящий подход: минимальная резекция, бережность в проекции сфенодорсальной и сфеноостевой ростковых зон;
2. избыточная резекция в передних отделах и повреждение ростковых зон ведут к деформации наружного носа и средней трети лица;
3. интраоперационно — эндоскопическая или микроскопическая визуализация;
4. детей **младше 12 лет** оперируют в учреждениях третьего уровня.

Риносептопластика, в том числе эндоскопическая, совместно с пластическим хирургом

1. выраженная деформация перегородки и костей носа;
2. выраженное каудальное искривление;
3. деформация в верхних отделах перегородки;
4. высокий риск неудовлетворительного результата или неполной коррекции при септопластике.

4.2 После операции

Всем: отсасывание слизи из носа — очищение от фибрина, слизи и крови, профилактика синехий.

По индивидуальным показаниям: септальные шины для профилактики синехий.

Кратковременно — препараты для улучшения носового дыхания: ксилометазолин, фенилэфрин, оксиметазолин, в том числе в комбинациях; дозы по инструкции.

Всем — орошение носа солевыми растворами или стерильной морской водой для удаления фибрина и отделяемого; по показаниям возможны другие препараты.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к плановой госпитализации

1. стойкое затруднение носового дыхания из-за деформации перегородки, подтверждённой риноскопией или эндоскопией и рентгенографией или КТ.

Показания у детей

1. стойкое одно- или двустороннее затруднение дыхания и (или) апноэ сна, не связанные с другими причинами, со слов родителей;
2. деформация подтверждена эндоскопией и КТ;
3. детей **младше 12 лет** оперируют в учреждениях третьего уровня.

Выписка

1. нет гнойного воспаления в полости носа;
2. нет местных и системных осложнений.

5.2 Наблюдение и профилактика

Конкретных рекомендаций о наблюдении нет; по клиническому опыту — плановые осмотры **в течение первого года** после операции. Медицинская реабилитация не показана.

Профилактика у детей: социальные меры против травматизма (безопасный досуг, дорожное движение), разъяснение родителям в детских учреждениях — в том числе о сопутствующих заболеваниях и своевременной операции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Деформация перегородки носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.05.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее мая 2028 года
Код в рубрикаторе	913_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Доброкачественные остео- и хондрогенные опухоли носа и пазух

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D14.0** — Среднего уха, полости носа и придаточных пазух
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/756_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Остеома, остеобластома, фиброзная дисплазия, аневризматическая костная киста, оссифицирующая фиброма, гигантоклеточная опухоль, хондрома и другие костные и хрящевые опухоли носа и околоносовых пазух. Чаще всего — остеома лобной пазухи.
- Стойкий или прогрессирующий на фоне лечения односторонний воспалительный процесс в носу и пазухах — всегда повод исключить опухоль: КТ носа и пазух, при необходимости биопсия.
- Диагноз — по жалобам, анамнезу, осмотру, эндоскопии полости носа и КТ носа и околоносовых пазух.
- Лечение хирургическое. При небольшой бессимптомной остеоме — наблюдение; после операции — КТ через **3–6 месяцев**, затем через год и более.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Опухоли

Опухоль	Определение
Остеома	медленно растущая (0,44–6,0 мм в год) опухоль из костной ткани; случаев малигнизации не описано
Остеобластома	редкая опухоль из костной ткани, продуцирующая ретикуло-фиброзные перекладины, окружённые крупными остеобластами
Фиброзная дисплазия	опухолевидное поражение: разрушение костной ткани с деформацией и заполнением костномозгового канала фиброзной тканью
Аневризматическая костная киста	редкое заболевание кости с локальным деструктивным и экспансивным ростом
Оссифицирующая фиброма	опухоль из кальцификатов, цемента, костной и фиброзной ткани; ювенильная форма течёт агрессивнее
Гигантоклеточная опухоль (остеокластома)	редкое новообразование кости с локально-агрессивным, деструктивным ростом
Хондрома	истинная опухоль из хрящевой ткани, развивается от 3 месяцев до 10 лет
Хондромиксоидная фиброма	редкая опухоль из веретеновидных или звёздчатых клеток в миксоидной или хондроидной строме
Хондробластома	редкая опухоль из хондробластов
Носовая хондромезенхимальная гамартома	опухоль из веретенообразных клеток, хрящевой ткани и геморрагических кист

2.2 Этиология

Причины окончательно не установлены. Возможные факторы риска — нарушение эмбриогенеза, инфекция, травма; при фиброзной дисплазии основную роль играет мутация гена GNAS1.

2.3 Классификация

Общепринятой классификации нет; классификации отдельных опухолей рабочие и учитываются при планировании лечения.

Рабочие классификации

1. остеома по строению: компактная, губчатая, смешанная;
2. остеобластома по скорости роста: латентная, активная, агрессивная;
3. фиброзная дисплазия: монооссальная (70–85%) и полиоссальная (15–30%);
4. аневризматическая костная киста, фазы: остеолиз, отграничение, восстановление;
5. хондрома: энхондрома (внутри кости) и экхондрома (на поверхности кости).

2.4 Клиническая картина

Жалобы появляются с ростом опухоли — при давлении на стенки пазух и распространении на соседние области; небольшие опухоли бессимптомны и бывают случайной находкой при КТ.

Частые жалобы

1. головная боль в носо-лицевой области, в проекции пазухи;
2. заложенность носа, аносмия — при обтурации соустья, вторичном синусите, мукоцеле;
3. рецидивирующие носовые кровотечения — при аневризматической костной кисте;
4. асимметрия и безболезненный отёк лица — при фиброзной дисплазии.

Распространение на орбиту и в полость черепа

1. деформация носоглазничной области, проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия;
2. слезотечение — при сдавлении носослёзного канала;
3. снижение зрения — при сдавлении зрительного нерва;
4. общемозговые и очаговые симптомы, менингит, абсцесс мозга — при интракраниальном распространении.

---

3. Диагностика

Диагноз — по жалобам, анамнезу, физикальным данным, эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки и КТ носа и околоносовых пазух. Симптомы неспецифичны и в начале минимальны; остеома бессимптомна в 4–10% случаев и случайно выявляется при КТ у 1–3% обследованных.

3.1 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. сроки, последовательность и динамику жалоб;
2. прежние травмы и заболевания носа и пазух, их лечение и эффект;
3. результаты прежних обследований: анализы, КТ, МРТ, биопсия, протоколы операций;
4. похожие жалобы у близких родственников.

3.2 Осмотр

Общий осмотр, пальпация и перкуссия носо-лицевой области, пальпация подчелюстных, подподбородочных и глубоких шейных лимфоузлов. Для доброкачественных опухолей изменения регионарных лимфоузлов не характерны.

3.3 Передняя риноскопия и видеориноскопия

Всем — передняя риноскопия: преддверие, передние отделы полости носа, раковины, перегородка, отделяемое; новообразование в передних отделах.

Всем — видеориноскопия риноскопом или фиброскопом; первичный осмотр — без подготовки и анестезии.

3.4 Компьютерная томография носа и околоносовых пазух

При подозрении на опухоль — КТ от твёрдого нёба до верхней границы лобной пазухи, срез **2 мм**: локализация, распространённость, размеры, структура, кальцификация, ремоделирование кости.

Остеома на КТ

1. компактная: округлое плотное почти бесструктурное образование;
2. губчатая: грубо-трабекулярная структура;
3. смешанная: зона 300–600 ед. Н губчатого строения и зона более 800 ед. Н компактного вещества.

Фиброзная дисплазия на КТ — однородная ткань «матового стекла» плотностью около 300–450 ед. Н, не инкапсулирована; кистозная форма — с участками более низкой плотности.

Остеобластома на КТ — сочетание плотной кости и участков затемнения.

Хондрома на КТ — образование гетерогенной плотности с чёткими границами и очагами минерализации.

Остеохондрома на КТ — костное вещество неоднородной плотности в центре, ткань хрящевой плотности по периферии.

МРТ и консультации челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога, нейрохирурга — обязательно при

1. изменениях зубочелюстной системы: смещение, расшатывание, выпадение зубов, деформация;
2. глазных симптомах: проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия, слезотечение;
3. менингеальных и очаговых неврологических симптомах.

3.5 Биопсия

По показаниям — биопсия и патологоанатомическое исследование с иммуногистохимией: отличить доброкачественную опухоль от злокачественной. Обычно прицельная биопсия под эндоскопом на границе опухоли со здоровой тканью; при небольшой опухоли — эксцизионная.

---

4. Лечение

Хирургическое лечение эндоназальным, наружным или комбинированным доступом; при большой распространённости — транспалатинный доступ, боковая ринотомия, краниофациальная резекция, midfacial degloving. Навигация повышает эффективность и безопасность.

4.1 Остеома

Эндоназальный (эндоскопический), наружный или комбинированный доступ — по размерам и месту прикрепления. Наружный доступ травматичнее: эстетический дефект, парестезии, прозопалгия.

Небольшая бессимптомная остеома — выжидательная тактика; по некоторым данным, оперируют остеому, занимающую **более 50%** объёма пазухи. Рецидивы редки, через **5–8 лет**.

Классификация остеом лобной пазухи по A. G. Chiu, 2005

Степень	Остеома лобной пазухи
1	прикреплена сзади-снизу, медиальнее плоскости бумажной пластинки; переднезадний размер меньше 75% лобного кармана

Степень	Остеома лобной пазухи
2	то же расположение, переднезадний размер больше 75% лобного кармана
3	прикреплена спереди или сверху и (или) выходит латеральнее плоскости бумажной пластинки
4	полностью обтурирует лобную пазуху

Эндоскопическое удаление

1. предпочтительно при остеомах 1 и 2 степени, описано и успешное удаление 3 и 4 степени;
2. не показано при остеоме на передней и нижней стенке латеральных отделов лобной пазухи;
3. интраорбитальное и интракраниальное распространение — не абсолютное противопоказание.

4.2 Другие опухоли

Лечение по виду опухоли

Опухоль	Лечение
Остеобластома	хирургическое удаление; радикальное — обычно полное излечение, без рецидивов 5–15 лет; у детей рецидивы до 32%
Фиброзная дисплазия	выжидательная тактика с наблюдением и КТ — возможен регресс; операция — при выраженной деформации и ограниченном процессе; бифосфонаты — профилактика переломов и боли (риск остеонекроза челюсти)
Аневризматическая костная киста	хирургическое удаление: от пункции до кюретажа и резекции; до операции — эмболизация питающих сосудов; рецидивы 10–30%
Оссифицирующая фиброма	раннее и полное удаление; ювенильная форма рецидивирует до 30%, риск сохраняется до 18 лет — длительное наблюдение
Гигантоклеточная опухоль	хирургическое удаление; длительное наблюдение; если радикальная операция невозможна — лучевая терапия
Хондрома	хирургическое удаление (риск малигнизации): эндоскопически, при распространении в пазуху и орбиту — по Денкеру
Хондромиксоидная фиброма	хирургически: кюретаж эффективен в 80%; предпочтительна широкая эксцизия
Хондробластома	радикальное иссечение; после одного кюретажа рецидивы до 55%

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация

1. доброкачественная остео- или хондрогенная опухоль носа и пазух без противопоказаний к плановой операции.

Выписка

1. нет осложнений, удовлетворительное общее состояние.

5.2 Реабилитация и наблюдение

После удаления опухоли — охранительный режим **10–14 дней и более**.

Специфической профилактики нет. После операции — динамическое наблюдение: КТ **через 3–6 месяцев**, затем **через 1 год и более** — по виду опухоли, локализации и радикальности операции.

Прогноз зависит от гистологии, локализации и распространённости. Радикальное удаление обычно излечивает, но из-за рецидивов и возможной малигнизации нужно наблюдение.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Доброкачественные остеогенные и хондрогенные опухоли носа и околоносовых пазух»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 04.03.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее марта 2026 года
Код в рубрикаторе	756_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В критериях оценки качества уровни доказательности (КТ — УУР А, УДД 1; операция — А, 4; охранительный режим — В, 2) не совпадают с уровнями этих рекомендаций в тексте (С, 4–5).

Клинические рекомендации

Инородное тело в пищеварительном тракте

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T18** — Инородное тело в пищеварительном тракте
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов" ; Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/710_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Инородное тело — любой объект, проглоченный, введённый в просвет пищеварительного тракта или образовавшийся в нём, который не может служить пищей. Большинство (80–90%) выходит самостоятельно; эндоскопия нужна в 10–20%, операция — менее чем в 1%.
- При поступлении — осмотр оториноларинголога (исключить инородное тело полости рта и глотки) и хирурга (признаки перфорации и других осложнений).
- Диагноз — инородное тело, найденное при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо при операции.
- Батарейка, остроконечный предмет или полная обструкция в пищеводе — эндоскопия **экстренно: лучше в течение 2 часов, не позднее 6**; прочие инородные тела пищевода, в том числе магниты, — **срочно, в течение 24 часов**.
- Батарейки и магниты консервативно не ведут; контейнеры с наркотиками эндоскопически не удаляют.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Инородное тело пищеварительного тракта — объект органического, неорганического или искусственного происхождения, случайно или намеренно проглоченный, введённый в просвет пищеварительного тракта или образовавшийся в организме, который по составу и (или) расположению не может служить пищей.

Условно инородные тела — пища, желчные камни, паразиты, становящиеся инородным телом при определённых обстоятельствах: вклинение пищевого комка в зону сужения пищевода, миграция желчного камня в просвет кишки, конгломерат паразитов.

Инородные тела по воздействию на стенку

Вид	Определение
Инертные	без выраженного патологического воздействия на стенку: монеты, мелкие игрушки, клипсы, стеклянные и металлические шарики
Механически активные	механическое повреждение стенки: иголки, булавки, саморезы, проволока
Физически активные	выраженное физическое, компрессионное воздействие: магниты
Химически активные	химические и термические ожоги вплоть до перфорации: дисковые батарейки таблеточного типа
С комбинированным воздействием	механическое (обтурация, компрессия) и химическое воздействие: безоары, силикагелевые шарики

Признак Турнера — ощущение инородного тела в гортаноглотке или пищеводе даже после его прохождения в желудок.

2.2 Этиология

У детей чаще, чем у взрослых; пик — от 6 месяцев до 6 лет. Самые частые у детей — монеты: через пищевод самостоятельно проходят у 30–60%. Застрявшая в пищеводе дисковая батарейка — угрожающее жизни состояние (трахеопищеводный и трахеоаортальный свищ, медиастинит, абсцесс шеи). Взрослые глотают инородные тела случайно или намеренно (психические заболевания, заключённые), «курьеры» — контейнеры с наркотиками; бывают ятрогенные инородные тела (видеокапсулы, стенты, зубные протезы).

2.3 Классификация

1. **по происхождению** — истинные (проглоченные умышленно, случайно, незаметно; введённые через задний проход; оставленные при вмешательствах; попавшие при травме) и условно инородные тела (вклиненный пищевой комок; желчные камни, безоары, каловые камни; живые инородные тела)
2. **по локализации** — пищевод — 68,4%, желудок — 18,9%, тонкая кишка — 7,1%, толстая — 3%, прямая — 2,6%

1. **по количеству** — единичные, множественные
2. **по динамике** — мигрирующие, свободнолежащие, фиксированные
3. **по величине** — мелкие — **до 2–2,5 см в диаметре или до 5 см в длину**; средние — 2,5–5 см или до 10 см; крупные — более 5 см или более 10 см
4. **по воздействию** — инертные; потенциально агрессивные (контейнеры с наркотиками, хрупкие предметы); агрессивные — химически (батарейки), физически (магниты, ртуть), механически активные (остроконечные), комбинированные (безоары, силикагель)

Рентгеноконтрастность инородных тел

Контрастность	Инородные тела
рентгеноконтрастные, хорошо видны на снимке	истинные рентгенопозитивные инородные тела непищевого происхождения, мясные кости
малоконтрастные и рентгенонегативные, как правило, не видны	пищевой комок, рыбьи и куриные кости, дерево, пластик, стекло, тонкие металлические предметы

Классификация Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии

Тип	Примеры
тупые	монета, пуговица, игрушка; батарейки, магниты
остроконечные	игла, зубочистка, кость, булавка, осколки стекла; фрагмент зубного протеза, лезвие
длинные	мягкие (струна, верёвка), твёрдые (зубная щётка, столовый прибор, отвёртка, ручка)
пищевые комки	с костями или без
другие	контейнеры с запрещёнными веществами

2.4 Клиническая картина

У детей зона глоточно-пищеводного перехода уже и длиннее, поэтому инородное тело чаще застревает в шейном отделе пищевода. Непищевые инородные тела составляют 75–90%, чаще возникает респираторный синдром.

Проявления у детей

1. кашель, одышка, свистящее дыхание, ложный круп;
2. гиперсаливация, слюнотечение, поперхивание, рвота;
3. дисфагия, одинофагия, отказ от еды, ощущение комка в горле.

У части детей симптомов нет до развития осложнений.

Инородное тело пищевода у взрослых (выраженная картина у 50–68%)

1. боль по ходу пищевода, в яремной ямке, затылке, спине, эпигастрии;
2. слюнотечение, невозможность проглотить твёрдую и жидкую пищу, дисфагия, срыгивание;
3. одышка; вынужденное положение при инородном теле в виде «якоря».

Вторичные проявления

1. лихорадка, обезвоживание, запах изо рта;
2. осиплость голоса;
3. инфильтрация мягких тканей шеи, подкожная эмфизема, пневмоторакс.

10% инородных тел пищевода бессимптомны; «мнимые» инородные тела — 10–15%.

Инородные тела желудка и ДПК проявляются слабо — только крупные, длинные и острые; пролежень и перфорация дают перитонеальные симптомы или забрюшинный инфильтрат. Крупные инородные тела прямой кишки — тенезмы, боль в промежности, кровь в стуле. Отсутствие симптомов не повод отказаться от обследования.

---

3. Диагностика

Диагноз — обнаружение инородного тела при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо при операции. На догоспитальном этапе и при поступлении основание — анамнез и осмотр.

3.1 Жалобы и анамнез

Тщательная оценка жалоб и детальный анамнез.

Выяснить

1. что проглочено (на снимке монета похожа на дисковую батарейку);
2. сколько прошло времени, когда последний раз ел и пил;
3. пытался ли пациент сам извлечь или «протолкнуть» инородное тело (сухой хлеб);
4. были ли попытки эндоскопического удаления;
5. были ли такие эпизоды; эозинофильный эзофагит, ГЭРБ, рубцовая стриктура, ахалазия;
6. у детей — стенозы, ожоги, операции на пищеводе: дисфагия, слюнотечение, отказ от еды, апноэ при кормлении — показание к эзофагоскопии.

Гиперсаливация и невозможность глотать жидкость — признаки полной непроходимости пищевода; удушье, стридор, одышка — аспирация или сдавление трахеи.

3.2 Осмотр

При поступлении

1. оториноларинголог — подтвердить или исключить инородное тело в полости рта и глотке;
2. хирург — признаки перфорации пищевода (подкожная эмфизема, отёк, инфильтрат шеи), осложнения со стороны желудка и кишечника;
3. аускультация лёгких — хрипы, аспирация;
4. подозрение на инородное тело прямой кишки — пальцевое исследование.

Лихорадка и тахикардия — настораживают в отношении осложнения; при длительно стоящем инородном теле пищевода и отсутствии торакального отделения — перевод в профильный стационар или вызов специалиста.

3.3 Анализы крови

При поступлении

1. общий анализ крови;
2. биохимия: глюкоза, мочевина, креатинин, амилаза, билирубин, АЛТ, АСТ.

По показаниям

1. калий, натрий, тромбоциты;
2. АЧТВ, МНО, фибринолитическая активность;
3. группа крови и резус-фактор.

3.4 Рентгенография

Подозрение на рентгеноконтрастное инородное тело или характер инородного тела неизвестен — неотложная рентгенография мягких тканей шеи, органов грудной клетки и брюшной полости.

Сначала прямая проекция; ложноотрицательных результатов **до 47%**, поэтому при отрицательном результате — боковая. Шейный отдел пищевода — снимок шеи в боковой и прямой проекции с приподнятой головой.

Дети с подозрением на проглатывание инородного тела, даже без симптомов, — неотложная рентгенография шеи, грудной клетки и брюшной полости, таза в 2 проекциях по показаниям.

Застрявший пищевой комок без костей и без признаков осложнений — обзорная рентгенография, как правило, **не рекомендуется**: ложноотрицательных результатов до 87%.

3.5 Рентгеноскопия с контрастом

Подозрение на обтурацию или перфорацию пищевода, рентгенонегативное инородное тело, сомнения в локализации — рентгеноскопия глотки и пищевода с водорастворимым йодсодержащим контрастом; не должна задерживать эндоскопию.

Контраст — малыми порциями. При нарушении глотания (инородное тело на уровне глоточно-пищеводного перехода, неврологические заболевания) йодсодержащий контраст **не применяют**: аспирация и отёк лёгких.

Бария сульфат **не рекомендуется**: риск аспирации, затрудняет последующую эндоскопию.

3.6 КТ

Клиника перфорации пищевода, флегмоны шеи, медиастинита и других осложнений — КТ органов грудной и брюшной полости.

Рыбьи кости — частые инородные тела у взрослых, застревают в верхней части пищевода; чувствительность рентгенографии **32%**, КТ — **90–100%**. У детей КТ — при рентгенонегативных инородных телах. Свободный газ под диафрагмой при перфорации инородным телом — ненадёжный признак.

3.7 Эндоскопия

До эндоскопии — анализ клинической картины и данных лучевых исследований: выбор обезболивания, эндоскопа, инструментов.

Всем с подозрением на инородное тело верхних отделов — ЭГДС, в том числе при отрицательном рентгенологическом результате; это и первый этап лечебного вмешательства. У детей инородное тело пищевода удаляют **менее чем через 24 часа**.

Подозрение на инородное тело прямой или сигмовидной кишки — ректороманоскопия.

3.8 Дифференциальная диагностика

Похожая картина бывает при

1. кандидозном, рефлюкс- и эозинофильном эзофагите;
2. ахалазии кардии;
3. после инсульта, в дебюте рассеянного склероза, БАС, миастении;
4. опухоли пищевода;
5. истерии и других заболеваниях нервной системы.

Интенсивная боль за грудиной — исключить острый коронарный синдром; инородное тело желудка и кишки — заболевания с картиной острого живота.

---

4. Лечение

4.1 Сроки эндоскопии

Сроки эндоскопического вмешательства: экстренно — лучше в течение 2 часов, не позднее 6; срочно — в течение 24 часов; отсроченно — в течение 72 часов

Инородное тело	Пищевод	Желудок, тонкая кишка
батарейка	экстренно	срочно
магнит	срочно	срочно
остроконечное	экстренно	срочно
тупое, менее 2–2,5 см	срочно	отсроченно
тупое, 2–2,5–5 см	срочно	отсроченно
большое, более 5–6 см	срочно	срочно
пищевой комок	экстренно (срочно — без симптомов и полной обструкции)	—

4.2 Консервативное ведение

Наблюдение без извлечения — если инородное тело не в пищеводе, симптомов нет, оно тупое, инертное и небольшое (**до 2–2,5 см в диаметре или 5 см в длину**).

После пищевода большинство инородных тел проходит ЖКТ за **4–6 дней**, редко — до 4 недель; через привратник не проходят предметы более 2–2,5 см, через изгиб ДПК — длиннее 5–6 см. Без симптомов при инородном теле желудка меньше этих размеров возможно амбулаторное наблюдение: пациента предупреждают о симптомах перфорации и непроходимости.

Наблюдение за небольшим тупым рентгеноконтрастным инородным телом — периодический рентгенологический контроль, без симптомов — еженедельно; не вышло из желудка **за 3–4 недели** — эндоскопическое удаление.

Контейнеры с наркотиками без симптомов — пристальное наблюдение в стационаре, лаваж кишечника, рентгенологический контроль; эндоскопически не удаляют.

Безоар желудка — сначала 5–10% раствор пищевой соды или напитки с ортофосфорной кислотой: размягчают растительные безоары; продолжать между сеансами эндоскопии.

Консервативное ведение противопоказано

1. магниты и батарейки;
2. остроконечные инородные тела;
3. безоары, силикагелевые шарики;
4. любые длительно стоящие инородные тела пищевода.

Магнит удаляют, даже если на снимке он один.

4.3 Эндоскопическое лечение

Перед удалением — анализ анамнеза, клиники, лучевых данных и эндоскопической картины: выбор обезболивания, эндоскопа, инструментов.

Экстренно (лучше в течение 2 часов, не позднее 6) — полная обструкция пищевода, остроконечные предметы и батарейки в пищеводе; **срочно (в течение 24 часов)** — остальные инородные тела пищевода, в том числе магниты.

Остроконечные предметы перфорируют до 35% случаев. Дисковая батарейка быстро повреждает пищевод: электрический ожог, утечка щелочи, пролежень. Цилиндрическая батарейка у ребёнка в пищеводе — экстренно. Риск тяжёлых осложнений при инородном теле в пищеводе **более 24 часов** выше в 14,1 раза.

Желудок и проксимальная ДПК: у детей с симптомами остроконечные, крупные инородные тела, магниты и батарейки — **экстренно (в первые 2 часа)**; у взрослых и у детей без симптомов (магниты) — **срочно (24 часа)**.

Дисковые батарейки у детей — независимо от симптомов, размера и количества — удаляют **лучше в течение 12 часов, не позднее 24**: после 12 часов риск осложнений выше в 4,5 раза. Инородные тела более 2–2,5 см — в течение 24–48 часов; тупое небольшое, не покинувшее желудок за 3–4 недели (лучше не более 1 недели), — эндоскопически.

Крупные инородные тела прямой кишки — экстренное удаление, особенно у детей: под наркозом после девульсии ануса, зажимами Кохера.

Удаление — под общим обезболиванием; у детей — только под наркозом с интубацией трахеи (или внутривенно с сохранением спонтанного дыхания, глубокая седация). У взрослых нетравмоопасные инородные тела — под внутривенной анестезией или седацией, при невозможности — под местной анестезией.

Метод выбора — гибкая видеоэндоскопия: успех более 95%, осложнения 0–5%. Ригидная эзофагоскопия — только при инородном теле в верхней трети пищевода, которое не удаётся извлечь гибким эндоскопом, при перфорации в операционной перед дренированием средостения или если гибкой эндоскопии нет.

Длительно стоящее инородное тело или прежние безуспешные попытки — в операционной с инсуффляцией углекислого газа. Раскрытую булавку проводят в желудок, разворачивают и извлекают; острый конец направляют дистально; длинный предмет захватывают за кончик.

Остроконечные инородные тела — защитные устройства: дистальный колпачок, конус, тубус (дистальнее пищевода — 45–60 см).

Специальные инструменты по типу инородного тела: щипцы «зуб крысы», «зуб аллигатора», полипэктомические петли, корзины, сетчатые ловушки; биопсийные щипцы не рекомендуются.

Инструменты для извлечения у взрослых

Тип	Инструменты
тупые	щипцы-ретракторы, захваты, полипэктомические петли, корзинки, сетчатые ловушки
остроконечные	щипцы-ретракторы, петли, корзинки, сетчатые ловушки; прозрачный колпачок, латексный конус
длинные	полипэктомические петли, корзинки
пищевые комки	щипцы-ретракторы, захваты, петли, корзинки, сетчатые ловушки

Пищевой комок — осторожно низвести в желудок; не удаётся — извлечь целиком или по частям. При значительном сопротивлении проталкивание прекращают.

Эндоскопическое удаление контейнера с наркотиками **не рекомендуется**: разрыв ведёт к тяжёлой интоксикации и смерти.

Перфорация с флегмоной, медиастинитом, перитонитом — изолированное эндоскопическое удаление противопоказано; возможно в операционной во время хирургического вмешательства.

Прекратить попытки при неостанавливаемом кровотечении и если дальнейшие попытки под наркозом увеличивают риск повреждения стенки (рыболовный крючок, проволока «егоза»).

После извлечения — обязательно осмотреть место фиксации и путь извлечения, оценить повреждение стенки.

«Свежая» перфорация пищевода (**до 6 часов**) — эндоскопическое клипирование, с инсуффляцией углекислого газа.

После вклинения пищевого комка или задержки тупого инородного тела — обследовать место задержки: стриктура, эозинофильный эзофагит, ахалазия, опухоль.

Патология пищевода — более чем у 75% пациентов с вклинением пищевого комка: стриктуры (более 50%), эозинофильный эзофагит (около 40%). При подозрении на эозинофильный эзофагит — биопсия из трёх третей пищевода. Стриктуры и кольца Шацкого можно расширить сразу; при повреждении слизистой — ингибиторы протонного насоса и дилатация через 2–4 недели.

4.4 После удаления

Значительное повреждение слизистой или глубокое ранение острым предметом — рентгеноскопия с водорастворимым контрастом: исключить перфорацию; поздняя перфорация от пролежня — **на 2–5-е сутки**.

Травма стенки пищевода с отёком, а инородное тело не найдено — после противовоспалительной терапии повторить рентгеноскопию с контрастом и эзофагоскопию, особенно если проглочена рыбья кость.

Выраженный отёк слизистой пищевода — щадящая диета **3–4 дня** (жидкая, прохладная пища), ибупрофен или парацетамол; возможны масляные растворы бета-каротина, облепиховое масло, гиалуроновая кислота, ИПП.

Воспаление, изъязвления, трещины прямой кишки — НПВП в суппозиториях.

Значительное повреждение слизистой или ушитая перфорация — короткий курс антибиотиков (цефалоспорины, пенициллины); даже без перфорации — наблюдение в стационаре **2–3 дня**.

Операция по поводу перфорации, флегмоны, медиастинита, перитонита — антибиотики широкого спектра внутривенно как можно раньше, предпочтительно резервные (карбапенемы).

4.5 Препараты

Препараты до и после вмешательства

Препарат	Применение
ибупрофен	дети до 6 лет — по возрасту и массе, не более 30 мг/кг в сутки, интервал 6–8 ч: 3–6 мес — по 50 мг 3 раза (до 150 мг); 6–12 мес — по 50 мг 3–4 раза (до 200 мг); 1–3 года — по 100 мг 3 раза (до 300 мг); 4–6 лет — по 150 мг 3 раза (до 450 мг); взрослые и дети старше 6 лет — 200–400 мг 3–4 раза; максимум в сутки: 6–12 лет — 800 мг, 12–17 лет — 1000 мг, взрослые — 1200 мг
кетопрофен	старше 15 лет: в/м 100 мг 1–2 раза в сутки; в/в 100–200 мг в 100–150 мл 0,9% натрия хлорида, только в стационаре
парацетамол	более 50 кг — 1 г до 4 раз в сутки; 10–50 кг — 15 мг/кг до 4 раз; до 10 кг — 7,5 мг/кг до 4 раз; противопоказан новорождённым
цефазолин, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон	профилактика хирургической инфекции, дозы по инструкции; цефотаксим в/м противопоказан до 2,5 лет, цефтриаксон — недоношенным до 41 недели
оксациллин; амоксициллин + клавулановая кислота	по инструкции; амоксициллин + клавулановая кислота противопоказан до 2 лет

4.6 Хирургическое лечение

Показания к операции

1. инородное тело не удалось извлечь эндоскопически;
2. длительно стоящее в тонкой кишке, не извлекаемое при энтероскопии;
3. перфорация с флегмоной, медиастинитом, перитонитом;
4. тонкокишечная непроходимость;
5. кровотечение, не останавливаемое эндоскопически.

Опасное инородное тело за связкой Трейца, не продвигающееся **3 дня**, — рассмотреть операцию; видеокапсула — задержка в тонкой кишке **более 2 недель**.

Контейнеры с наркотиками — операция при подозрении на нарушение упаковки, отсутствии продвижения, кишечной непроходимости.

Объём операции — по локализации и осложнениям. Перфорация пищевода **более 6 часов**, как правило, уже с медиастинитом.

Операция при перфорации пищевода

1. торакотомия, медиастинотомия;
2. удаление инородного тела, ушивание пищевода;
3. дренирование средостения и плевральной полости.

Перфорация прямой кишки на всю толщину — защитная колостома.

Диаметр пищевода по возрасту

Возраст	Диаметр пищевода
новорождённый	5–6 мм
6 месяцев	8–9 мм
1 год	12 мм
3–6 лет	13–15 мм
15 лет	18–19 мм
взрослый	20–22 мм

Эндоскопы для верхних отделов у детей

Масса ребёнка	Эндоскоп, мм	Канал, мм
новорождённые и младенцы до 10 кг	4,9–5,9	2,0–2,2
от 10 кг	7,8–9,2	2,2–2,8
более 25 кг — стандартные взрослые эндоскопы	9,2–9,9 и более	2,8–3,7

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация помощи и госпитализация

Подозрение на инородное тело пищевода в поликлинике — обзорная рентгенограмма шейного отдела пищевода и направление в стационар с оториноларингологом и эндоскопической службой.

Нельзя

1. вызывать рвоту и «проталкивать» инородное тело жёсткой пищей;
2. промывать пищевод и желудок на дому.

Все пациенты — в многопрофильный стационар с круглосуточной эндоскопией; аспирация, перитонит, кишечная непроходимость — в ОРИТ.

Тупое инертное инородное тело до 2–2,5 см без симптомов — амбулаторно. После успешного удаления без осложнений и без серьёзного повреждения стенки — выписка сразу.

Госпитализация для наблюдения

1. технически сложное извлечение;
2. несколько предметов, остроконечные, батарейки, магниты, предметы более 5–6 см;
3. обширное повреждение слизистой;
4. травма пищевода 3–5 степени;
5. травма стенки без найденного инородного тела; патология пищевода, имитировавшая инородное тело.

Не извлечённые острые предметы — ежедневные снимки; батарейки за ДПК — каждые 3–4 дня.

Травмы пищевода (видоизменённая классификация Bassett, 1980)

Степень	Эндоскопическая картина
1	отёк и гиперемия слизистой, обилие слизи (катаральный эзофагит)
2	одиночные царапины, повреждены только верхние слои слизистой
3	значительный отёк, мелкие подслизистые кровоизлияния, скудное кровотечение — повреждена вся толща слизистой
4	слизистая разрушена на значительном протяжении, большие подслизистые гематомы, фибрин, контактная кровоточивость
5	глубокие слепые ранения со слизистой на подслизистый слой, отслойка слизистой 1–2 см, пролежень — повреждён внутренний мышечный слой
6	перфорация, глубокое непроникающее ранение с обильным кровотечением

5.2 Реабилитация и профилактика

После осложнений и операций — реабилитация по осложнению и виду операции; после самостоятельного отхождения или неосложнённого эндоскопического удаления специальная реабилитация, как правило, не нужна.

Разъяснять родителям недопустимость оставлять детей без присмотра.

Трихобезоар — наблюдение психиатра и (или) невролога; ЭГДС **каждые 6–12 месяцев в течение 2–3 лет**.

Лечение заболевания пищевода, вызвавшего вклинение пищевого комка: стриктура, эозинофильный эзофагит, опухоль.

Исход во многом определяет состояние пищевода: опухоли, ахалазия, дивертикулы, ожоговые стриктуры, эзофагит, врождённая патология — тактика индивидуально.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Инородное тело в пищеварительном тракте»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 17.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	`710_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация детских хирургов; Российское общество хирургов; Российское общество рентгенологов и радиологов; Эндоскопическое общество

	«РЭндО»
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.

Клинические рекомендации

Кисты челюстно-лицевой области и шеи

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K04.8** — Корневая киста **K09** — Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках **K11.6** — Мукоцеле слюнной железы **L72.0** — Эпидермальная киста **Q18.0** — Пазуха, фистула и киста жаберной щели **Q18.1** — Преаурикулярная пазуха и киста **Q18.2** — Другие пороки развития жаберной щели **Q18.8** — Другие уточненные пороки развития лица и шеи
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.07.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/931_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Киста — полость с оболочкой из соединительнотканного слоя и эпителиальной выстилки, заполненная жидким или полужидким содержимым. Растёт за счёт давления содержимого: кость рассасывается, челюсть деформируется.
- Консультация оториноларинголога — при кисте верхней челюсти, растущей в полость носа или верхнечелюстную пазуху, и при кисте шеи со свищом в глотку или к корню языка. При кисте мягких тканей шеи осмотр оториноларинголога исключает ларингоцеле.
- Диагноз — кистозная полость в кости или мягких тканях по осмотру и лучевым исследованиям. Окончательный диагноз — гистологический.
- Лечение хирургическое: оболочку кисты удаляют в пределах здоровых тканей.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Киста — опухолевидное образование: полость, оболочка которой состоит из наружного соединительнотканного слоя и внутреннего, выстланного преимущественно многослойным плоским эпителием. Содержимое — серозная жидкость, гной, коллоиды и кристаллы холестерина.

Продукты эпителиальной выстилки и воспаление повышают давление в полости кисты; кислая среда от гипоксии активирует остеокласты, лизис кости преобладает над её образованием — киста растёт, челюсть деформируется.

2.2 Классификация кист челюстей

Клинико-морфологическая классификация (1975)

1. **Эпителиальные одонтогенные** — первичная (примордиальная кератокиста), киста прорезывания, парадентальная (периодонтальная), десневая, зубосодержащая, фолликулярная, корневая (радикулярная)
2. **Эпителиальные неодонтогенные** — киста резцового канала (носонёбного протока), глобуломаксиллярная (фиссуральная), носогубная (носоальвеолярная, преддверия полости рта), холестеатома
3. **Неэпителиальные** — костные кисты: аневризматическая, травматическая, геморрагическая

Клиническая классификация А. К. Иорданишвили (2000)

1. околозубные: околокорневые, резидуальные, околокоронковые (фолликулярные, кисты прорезывания), ретромолярные (парадентальные);
2. первичная киста (кератокиста);
3. киста носонёбного канала;
4. холестеатомы челюстей;
5. травматические;
6. аневризмальная костная киста;
7. шаровидно-верхнечелюстная киста;
8. носогубная (носоальвеолярная, внекостная).

2.3 Классификация кист мягких тканей

Врождённые

1. аномалии эмбриогенеза: срединные и боковые кисты шеи, кисты околоушной области и корня языка, кисты подъязычной слюнной железы;
2. пороки развития эктодермы: дермоидные и эпидермоидные кисты.

Приобретённые

1. ретенционные кисты сальных желёз (атеромы);
2. травматические;
3. кисты слюнных желёз.

Кисты жаберной щели по Bailey (1929) в модификации Proctor (1955)

Тип	Расположение боковой кисты шеи
I	поверхностно, вдоль передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы, под подкожной мышцей шеи; не соприкасается с влагалищем сосудисто-нервного пучка
II	самый частый: кпереди от грудино-ключично-сосцевидной мышцы и кзади от поднижнечелюстной железы, прилежит латерально к влагалищу сосудисто-нервного пучка
III	между внутренней и наружной сонными артериями, латеральнее боковой стенки глотки
IV	глубже влагалища сосудисто-нервного пучка, в окологлоточном пространстве; открывается в глотку, может распространяться к основанию черепа

2.4 Происхождение кист шеи и околоушной области

Кисты шеи и околоушной области

Киста	Происхождение
Срединная киста шеи	незаращение щитоязычного протока; связана с подъязычной костью и слепым отверстием корня языка, в стенке бывает ткань щитовидной железы
Боковая киста шеи	второй глоточный карман между наружной и внутренней сонными артериями, внутреннее устье — в области нёбной миндалины; лежит на сосудисто-нервном пучке, чаще на уровне бифуркации общей сонной артерии
Киста околоушной области	порок развития первой жаберной щели; латеральнее ствола лицевого нерва, связана с наружным слуховым проходом на границе хрящевого и костного отделов
Киста корня языка	аномалия щитоязычного протока; большая киста перед надгортанником мешает есть и дышать, нагноившаяся похожа на абсцесс корня языка
Лимфоэпителиальная киста	из остатков эпителия в лимфоидной ткани; из второй жаберной дуги — шейная лимфоэпителиальная киста (киста жаберной щели)

2.5 Клиническая картина

Киста челюсти

1. вне обострения симптомов может не быть, иногда — свищ на коже или слизистой;
2. большая киста деформирует челюсть: асимметрия лица, выбухание в полости рта;
3. при пальпации — «пергаментный хруст» или флюктуация;
4. большая киста смещает прорезывающиеся зубы, может привести к перелому нижней челюсти.

Нагноившаяся киста — асимметрия лица от отёка, гиперемия кожи; перкуссия «причинного» зуба обычно болезненна. При нагноении фолликулярной кисты у ретенированного восьмого зуба нижней челюсти бывает затруднено открывание рта.

Срединная киста — по средней линии шеи между слепым отверстием языка и перешейком щитовидной железы. Растёт медленно, безболезненная, гладкая, упругоэластическая; **при глотании смещается только вверх** вслед за подъязычной костью. Кожа над ней не изменена.

Боковая киста — впереди кивательной мышцы на уровне угла нижней челюсти, чаще в юношеском возрасте; округлая, эластическая, смещаемая.

1. **Дермоидная киста** — под языком и в языке, под мышцами дна полости рта, у корня носа, у углов орбиты, в надбровной области; мягкая, с кожей не спаяна
2. **Киста больших слюнных желёз** — безболезненная мягкоэластическая припухлость в околоушно-жевательной или поднижнечелюстной области; из протока — неизменённая слюна
3. **Ранула** — округлое синюшно-прозрачное безболезненное образование подъязычной области; может опорожняться в рот и наполняться снова
4. **Киста малой слюнной железы** — округлое полупрозрачное, иногда голубоватое образование над слизистой, подвижное, безболезненное

При нагноении кисты мягких тканей бывают затруднены глотание, дыхание, движения языка, болезненны повороты головы; возможен свищ с отделяемым.

---

3. Диагностика

Диагноз кисты — кистозная полость в кости или мягких тканях, выявленная при осмотре и инструментальном обследовании, и исключение сходной патологии.

3.1 Жалобы и анамнез

Киста челюсти — выяснить жалобы на

1. вздутие альвеолярного отростка, асимметрию лица;
2. боль, отёк, припухлость тканей;
3. затруднение носового дыхания;
4. снижение чувствительности кожи нижней губы.

В начале киста бессимптомна.

В анамнезе выясняют

1. травму зуба;
2. степень разрушения зубов кариесом;
3. качество эндодонтического лечения;
4. ретенированные зубы.

Киста от центральных резцов верхней челюсти, растущая в нижний носовой ход, даёт постоянную заложенность носа; сдавление носослёзного канала — одностороннее слезотечение.

Нагноившаяся киста челюсти — те же жалобы, плюс повышение температуры тела и озноб. Нагноение кисты, врастающей в верхнечелюстную пазуху, — боль в верхней челюсти и одностороннее отделяемое из носа.

Срединная киста шеи — боль при глотании, болезненность в области языка, ощущение инородного тела при глотании, припухлость в передней области шеи.

Боковая киста шеи — асимметрия шеи, припухлость (иногда болезненная) в верхней трети боковой области шеи, односторонняя боль при глотании.

Дермоидная киста мягких тканей — асимметрия лица и шеи, образование, эстетический дефект, нарушение подвижности языка, глотания, речи.

Нагноившаяся киста мягких тканей лица и шеи — жалобы на

1. боль;
2. асимметрию лица или шеи;
3. отёк, припухлость;
4. затруднение дыхания;
5. повышение температуры тела, озноб.

При воспалении срединной, боковой и дермоидной кисты возможна дисфагия с расстройством речи.

3.2 Осмотр и пальпация

Помимо общего осмотра — наружный осмотр лица и шеи, осмотр полости рта, поверхностная и глубокая пальпация регионарных лимфатических узлов.

Киста челюсти: сглаженность или выбухание переходной складки преддверия рта или нёба; затем «пергаментный хруст» (симптом Рунге — Дюпюитрена), а когда в кости появляется «окно», — флюктуация.

Дермоидная киста дна полости рта: эластичная или тестоватая, гладкая, с чёткими границами; прикреплённая к подъязычной кости — полушаровидное выпячивание в подподбородочной области. Дермоидные кисты околоушной области лежат глубоко, под стволом лицевого нерва или его ветвями.

3.3 Зондирование и перкуссия зубов

Киста челюсти — зондирование, перкуссия и оценка подвижности зубов.

3.4 Риноскопия

Киста носонёбного канала или киста верхней челюсти, растущая в полость носа, при затруднении носового дыхания — риноскопия: определить объём операции и исключить патологию полости носа.

Киста, растущая к нижней стенке грушевидного отверстия, при риноскопии — выпячивание на дне полости носа («валик Гербера»).

3.5 Лучевые исследования

Киста челюсти — рентгенография

1. прицельная внутриротовая контактная;
2. ортопантомография;
3. панорамная рентгенография нижней челюсти;
4. рентгенография придаточных пазух носа;
5. рентгенография нижней челюсти в прямой и боковой проекциях.

Прицельного внутриротового снимка достаточно при околокорневой кисте **не более 7–10 мм**. При кисте **более 11 мм**, у премоляров и моляров нижней челюсти и при наложении анатомических образований — ортопантомография, панорамный снимок, рентгенография пазух.

Если прицельного снимка недостаточно — панорамная рентгенография нижней челюсти, конусно-лучевая томография или КТ челюстно-лицевой области: размеры и топография кисты, состояние слизистой и стенок верхнечелюстной пазухи и полости носа.

Большая киста челюсти — спиральная КТ придаточных пазух носа или КТ челюстно-лицевой области.

Киста мягких тканей лица и шеи — УЗИ мягких тканей и цитологическое исследование материала тонкоигольной аспирационной биопсии: содержимое, размеры, топография.

Если УЗИ недостаточно информативно — МРТ мягких тканей или КТ челюстно-лицевой области.

3.6 Осмотр оториноларинголога

Киста мягких тканей лица и шеи — осмотр оториноларинголога, чтобы исключить ларингоцеле.

3.7 Патологоанатомическое исследование

Всем пациентам — патологоанатомическое исследование операционного материала, чтобы исключить злокачественное образование. Окончательный диагноз — по плановому гистологическому исследованию.

3.8 Дифференциальная диагностика

Кисты челюстей — с амелобластомой, гемангиомой, миеломой, эозинофильной гранулёмой, центральной гигантоклеточной гранулёмой, гигантоклеточной опухолью, фиброзной дисплазией, мягкой одонтомой, хондромой, остеомой, кистой Стафне, саркомой, метастазами карциномы. Помогают КТ, ангиография, сцинтиграфия, цитология пунктата, биопсия.

Кисты околоушной области — с кистами и опухолями околоушной слюнной железы и боковыми кистами шеи; помогают МРТ и цитология пунктата.

Дермоидные и эпидермоидные кисты — с

1. туберкулёзом лимфатических узлов (при первичной форме лёгкие могут быть не поражены);
2. лимфо- и ретикулосаркомой — быстрый рост, множественное поражение узлов;
3. опухолями кроветворной системы;
4. аденолимфомой слюнных желёз — в пунктате клетки опухоли;
5. боковыми и срединными кистами шеи — пунктат дермоидной кисты атеромоподобный, с холестерином;
6. абсцедирующим лимфаденитом;
7. атеромой — дермоидная киста с кожей не спаяна.

Боковые и срединные кисты — с

1. хроническим лимфаденитом шеи;
2. дермоидными кистами;
3. опухолями слюнных желёз (сиалография, МРТ, КТ);
4. каротидной хемодектомой (МР- или КТ-ангиография);
5. метастазами, бранхиогенным раком, лимфо- и ретикулосаркомой, гемангиомой, лимфангиомой;
6. боковые свищи — со свищами после нагноения лимфатических узлов.

Атерому отличают от эпидермоидной кисты, липомы, фибромы, лимфаденита, фурункула, ретенционной кисты по точечной втянутости кожи над протоком железы и спаянности кожи с оболочкой кисты.

---

4. Лечение

Основной метод — хирургический: оболочку кисты удаляют в пределах здоровых тканей.

4.1 Подготовка зубов

Зубы, вызвавшие корневую кисту, — пломбирование корневых каналов и резекция верхушек корней.

Канал пломбируют до операции, до уровня резекции верхушки, **не менее чем на 2/3 длины**.

Зубы, прилежащие к кисте, без реакции на ток при электроодонтометрии, — пломбирование корневых каналов.

Электроодонтометрия, мкА

1. **2–8** — интактный зуб
2. **9–14** — кариес
3. **15–24** — глубокий кариес
4. **25–44** — пульпит
5. **45–80 или нет реакции** — периодонтит

4.2 Кисты челюстей

Перед операцией

1. подписанное согласие пациента;
2. нет хронических заболеваний в стадии декомпенсации и тяжёлых органных дисфункций;
3. выбор метода анестезии, по показаниям — консультация анестезиолога-реаниматолога.

Нагноившаяся киста челюсти — вскрытие и дренирование (цистотомия).

Цистэктомия — полное удаление оболочки кисты; выполняют, если оболочку можно удалить без опасности повредить соседние зубы, сосудисто-нервные пучки, стенки верхнечелюстной пазухи и полости носа. Дефект можно заместить остеопластическими материалами.

Костная пластика — методика по величине дефекта

1. **1/4** — НКР с коллагеновой мембраной, одномоментная имплантация
2. **2/4** — НКР с коллагеновой мембраной, нерезорбируемой мембраной
3. **3/4** — НКР с нерезорбируемой мембраной, титановой сеткой
4. **4/4** — НКР с нерезорбируемой мембраной, титановой сеткой, костные блоки (инлэй, онлэй), дистанционный остеогенез, «Graftless solutions»

НКР — направленная костная регенерация. Классификация остеопластических материалов — в PDF КР, раздел 3.2.

Цистостомия — соустье между полостью кисты и полостью рта.

Показания

1. в полость кисты проецируются **3 интактных зуба и более**;
2. большая киста верхней челюсти с разрушением костного дна полости носа и нёбной пластинки;
3. обширная киста нижней челюсти с истончением основания **менее 0,5 см**;
4. опасность повредить нижнечелюстной сосудисто-нервный пучок;
5. врастание кисты в верхнечелюстную пазуху или полость носа.

Марсупиализация — двухэтапная операция: сначала цистостомия, затем удаление остатков оболочки и свищевого хода. Метод выбора, чтобы снизить травматичность и риск осложнений.

После декомпрессии кость восстанавливается аппозиционным ростом; полость промывают через трубку. Второй этап — в среднем **через 0,5–1,5 года**.

Удаление зуба — если его нельзя вылечить эндодонтически или ретроградно запломбировать.

Удаляют

1. все временные зубы;
2. постоянные «причинные» зубы, если нельзя резецировать верхушку;
3. зубы, корни которых выступают в кисту **более чем на 1/2**;
4. подвижность и атрофия альвеолярного отростка больше II–III степени;
5. коронка разрушена и не восстанавливается;
6. значительное искривление корней.

Киста челюсти, проникающая в верхнечелюстную пазуху, — цисториносинусостомия: удаление оболочки кисты с радикальной операцией на пазухе, сообщение с нижним носовым ходом; при эндоскопической операции расширяют естественное соустье.

Показания

1. интрасинусальная киста оттесняет дно пазухи вверх **на 1/3 высоты и более** (средняя и большая);
2. малая интрасинусальная киста с резким истончением костной перемычки — высок риск перфорации дна пазухи.

4.3 Кисты мягких тканей

Нагноившаяся киста мягких тканей лица и шеи — цистотомия или пункция с эвакуацией гноя.

Срединная киста шеи — экстирпация кисты и свища **с резекцией тела подъязычной кости**. Лечение только хирургическое.

Под эндотрахеальным наркозом, горизонтальный разрез по кожной складке на уровне подъязычной кости; кисту выделяют тупо, не повреждая оболочку. Тело подъязычной кости резецируют клиновидно, **на 0,5 см** в обе стороны от свищевого хода.

Боковая киста шеи — цистэктомия. Лечение только хирургическое.

Под эндотрахеальным наркозом; разрез по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы (безопаснее) или по верхней шейной складке (косметичнее). Резиновый выпускник удаляют **на 2–3-и сутки**.

Киста подъязычной слюнной железы — цистэктомия.

Чтобы снизить риск рецидива — марсупиализация или цистэктомия с удалением подъязычной или поднижнечелюстной слюнной железы.

Марсупиализация — при большой рануле или повреждении оболочки: иссекают купол кисты, стенку подшивают к слизистой, в полость — турунда.

4.4 Малоинвазивные операции

Старше 16 лет: боковая киста шеи без свищевого хода, дермоидная киста боковой области шеи — при наличии оборудования видеоэндоскопическое или роботассистированное удаление.

Под эндотрахеальным наркозом; заушный доступ (RAHI, face-lift) или тоннельный доступ из разреза в волосистой части затылочной области. Вакуумный дренаж удаляют **на 1–2-е сутки**.

Старше 16 лет: киста поднижнечелюстной слюнной железы — видеоэндоскопическая или роботассистированная цистэктомия либо цистэктомия с удалением железы.

4.5 Профилактика раневой инфекции

Перед операцией — профилактика инфекционных осложнений в области хирургического вмешательства; по показаниям — обезболивание и противоотёчная терапия.
Антибиотикопрофилактика — по национальным рекомендациям «СКАТ», «НАСКИ».

Антибактериальный препарат системного действия — в разовой терапевтической дозе.

Повторная интраоперационная доза — если операция дольше **двух периодов полувыведения** препарата или при массивной кровопотере.

Однократное введение; при продлении профилактики препарат отменяют **не позднее 24 часов** после операции, даже если стоит дренаж.

При длительном сообщении раны с полостью рта профилактику можно продлить **до 48, максимум 72 часов**.

Разрабатывать локальные протоколы антибиотикопрофилактики.

Антибиотикопрофилактика

Операция	Препараты выбора	Альтернатива	Категория
Нет риска сообщения раны с полостью рта («чистая рана»)	не рекомендуется	не рекомендуется	B
Риск сообщения раны с полостью рта или околоносовыми пазухами	цефазолин + метронидазол или амоксициллин + клавулановая кислота	клиндамицин	A

1. цефазолин + метронидазол — внутривенно детям **с 1 месяца**, дозы по инструкции; взрослым **2 г** цефазолина + **500 мг** метронидазола **за 60 минут** до операции;
2. клиндамицин — взрослым **600–900 мг** внутривенно перед операцией;
3. амоксициллин + клавулановая кислота — внутривенно взрослым и подросткам **старше 12 лет**, дозы по инструкции.

Цефазолин, метронидазол и клиндамицин в КР отмечены знаком # — применение вне инструкции.

Инфицированная рана (застарелая травма, предшествующая инфекция, гной, нежизнеспособные ткани) — антибактериальную терапию начинают до операции.

После операции — терапевтические дозы с учётом веса, возраста, функции почек и печени, тяжести инфекции, риска резистентности и локальных микробиологических данных; при инфицированной ране — микробиологическое исследование. Препараты выбора — группы: комбинации пенициллинов с ингибиторами бета-лактамаз, другие бета-лактамы, ко-тримоксазол, линкозамиды, аминогликозиды, фторхинолоны, гликопептиды, производные имидазола, прочие.

4.6 Лекарственная терапия

Обезболивание — анальгетики и НПВП с учётом противопоказаний и возрастных ограничений.

Нарушена целостность стенок верхнечелюстной пазухи или была операция в области носа — после операции деконгестанты и другие назальные препараты: уменьшить отёк слизистой пазухи и соустья, улучшить дренаж, предупредить воспаление.

По показаниям — противоотёчная терапия глюкокортикоидами.

Местно — антисептики и дезинфицирующие средства для профилактики инфекционных осложнений.

4.7 Диета

Киста нижней челюсти — челюстная диета: снизить риск патологического перелома и нагноения.

Киста подъязычной, поднижнечелюстной или околоушной слюнной железы — исключить слюногонную пищу.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Небольшая киста (**менее 3 зубов**) — амбулаторно.

Госпитализация

1. небольшая киста при тяжёлой сопутствующей патологии;
2. киста **более 3 зубов**;
3. нагноение — экстренно, в остальных случаях планово.

Выписка

1. острое воспаление купировано;
2. нет риска послеоперационного кровотечения.

5.2 Реабилитация

После операции — многоэтапная реабилитация до полного социального и физического восстановления.

Ежедневные осмотры и перевязки, швы снимают **на 7–10-й день**. Койко-день до операции **0–2**, после — **4–10**. После цистотомии и цистэктомии йодоформный тампон меняют **через 5–6 дней**, до 3–4 раз; к концу 3-й недели рана эпителизируется, полость пациент промывает сам. Полость уменьшается за счёт роста кости **за 1,5–2 года**.

Инфицирование сгустка — отток экссудата между швами и промывание полости антисептиками; ежедневные промывания **3–4 дня** обычно купируют воспаление. Если гной сохраняется — рану раскрывают, в полость вводят йодоформный тампон до гранулирования (**2–3 недели**).

5.3 Профилактика и диспансерное наблюдение

При первых симптомах кисты челюсти или мягких тканей — консультация стоматолога-хирурга. Профилактика воспалительных одонтогенных кист — своевременное лечение осложнённого кариеса и перикоронита.

Пломбирование зубов в зоне радикулярной кисты — накануне или перед операцией. Парадентальные, фолликулярные и первичные кисты — контроль **через 6 месяцев** после цистэктомии и до восстановления кости; при фолликулярных и парадентальных — наблюдение ортодонта.

При первых симптомах кисты мягких тканей — УЗИ мягких тканей шеи.

Киста верхней челюсти, растущая в полость носа или верхнечелюстную пазуху, — консультация оториноларинголога.

Киста мягких тканей шеи со свищевым ходом в области глотки или корня языка — консультация оториноларинголога.

На исход влияют отрицательно

1. инфекционные осложнения;
2. нарушение ограничительного режима в раннем послеоперационном периоде;
3. нарушение диеты.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Кисты челюстно-лицевой области и шеи»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 28.07.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2028 года
Код в рубрикаторе	`931_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии; Стоматологическая Ассоциация России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для кисты челюсти в разделе 3.2 сразу три операции названы оптимальными: цистэктомия — «как наиболее оптимального», цистостомия — «как наиболее оптимального», марсупиализация — «как метод выбора». Выбор — по показаниям из комментариев.
- Антибиотикопрофилактику рекомендовано отменять не позднее 24 часов после операции, а комментарий допускает продление до 48–72 часов.

- В таблице антибиотикопрофилактики категории рекомендаций A и B, а сами рекомендации раздела 3.5 — C, 5.
- Текст PDF — скан с ошибками распознавания; цитаты журнала сверки приведены по распознанному тексту, таблицы сверены по изображениям страниц 28 и 35.

Клинические рекомендации

Коклюш у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A37** — Коклюш
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.01.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1023_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Коклюш — острая инфекция, вызываемая Bordetella pertussis, с длительным приступообразным судорожным (спазматическим) кашлем и поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
- Коклюш подозревают при кашле **более 7 дней**: сначала сухой навязчивый, затем приступообразный судорожный, с репризами, рвотой или вязкой стекловидной мокротой; температура тела, как правило, нормальная, интоксикации нет.
- Подтверждение диагноза: ПЦР мазка со слизистой оболочки носоглотки однократно при кашле **от 7 до 28–35 дней**; при кашле **3 недели и более** — антитела к B. pertussis методом ИФА.
- Антибиотики (в первую очередь макролиды) показаны детям первого года жизни при обращении **в течение 6 недель** от начала болезни, остальным — **в течение 3 недель**; на длительность кашля они не влияют, но снижают заразность.
- Показания к переводу в ОРИТ: апноэ **более 15 секунд** у младенца или **более 10 секунд** у новорождённого, десатурация **SpO_2 менее 90%** при пароксизме, судороги, угнетение сознания.
- Осложнения, с которыми обращаются к оториноларингологу: носовые кровотечения на высоте кашля, кровотечения из заднеглоточного пространства и наружного слухового прохода, разрывы барабанной перепонки, вторичный отит.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Коклюш (Pertussis) — острое антропонозное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Bordetella (преимущественно Bordetella pertussis) и передающееся воздушно-капельным путём. Характеризуется длительным приступообразным судорожным (спазматическим) кашлем и поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Репризы — звучные судорожные вдохи, возникающие при прохождении воздуха через суженную вследствие ларингоспазма голосовую щель.

2.2 Этиология и патогенез

Возбудитель — Bordetella pertussis, грамотрицательная палочка, неустойчивая во внешней среде. Коклюшеподобное заболевание вызывают также B. parapertussis, редко B. bronchiseptica. Основное значение в патогенезе имеет коклюшный токсин с системным действием.

Длительный кашель связан с гиперреактивностью бронхов на фоне колонизации носоглотки B. pertussis; колонизация у реконвалесцентов и контактных может длиться более 3 и до 6 месяцев.

2.3 Эпидемиология

Заразность наиболее высока в предсудорожном периоде и в начале периода судорожного кашля; **к 25-му дню** больной, как правило, незаразен. На фоне эффективной антибактериальной терапии ребёнок незаразен **через 5 дней** лечения или после окончания курса.

Без антибиотиков непривитый ребёнок в тесном контакте может заразиться **до 7-й недели** периода судорожного кашля.

Индекс контагиозности у непривитых детей первого года жизни достигает 70–100%. Наибольшая заболеваемость и риск летальных осложнений — у детей до 1 года; источниками заражения младенцев чаще являются школьники и взрослые. После перенесённого коклюша иммунитет сохраняется 10–20 лет.

2.4 Классификация

1. **по форме** — типичная; атипичные — стёртая, бактерионосительство
2. **по тяжести** — лёгкая, среднетяжёлая, тяжёлая
3. **по течению** — гладкое; негладкое — с осложнениями, с наслоением вторичной инфекции, с обострением хронических заболеваний

2.5 Клиническая картина

Инкубационный период — **от 3 до 14 дней** (в среднем 7–8), реже до 21 дня.

Типичная форма

1. постепенное начало при нормальной температуре тела, без интоксикации;
2. сухой навязчивый кашель, нарастающий в динамике;
3. в разгаре — приступообразный судорожный кашель с репризами;
4. после приступа — рвота или отхождение вязкой стекловидной мокроты.

Степень тяжести коклюша

Тяжесть	Клиническая картина	Гемограмма
лёгкая	8–10 непродолжительных приступов в сутки, рвоты и кислородной недостаточности нет, состояние удовлетворительное	лейкоциты не более $10–15 \cdot 10^9$/л, лимфоциты до 70%
среднетяжёлая	до 15–20 продолжительных приступов в сутки, рвота, периоральный цианоз при кашле; одутловатость лица, отёчность век, кровоизлияния в склеры; надрыв или язвочка уздечки языка	лейкоцитоз до $20–30 \cdot 10^9$/л, лимфоцитоз до 80%
тяжёлая	25–30 и более приступов в сутки с рвотой и пароксизмами, постоянный цианоз, геморрагии на коже шеи и плечевого пояса; угрожающие жизни осложнения — апноэ, внутричерепные кровоизлияния, судороги	лейкоцитоз $40 \cdot 10^9$/л и более, лимфоцитоз 85% и более

При определении тяжести основное значение имеют клинические критерии; гематологические изменения вспомогательны и оцениваются при моноинфекции.

Критерии степени тяжести по клиническим и гематологическим признакам

Признак	Лёгкая	Среднетяжёлая	Тяжёлая
цианоз лица при кашле	нет	цианоз носогубного треугольника	цианоз лица
длительность предсудорожного периода	10–14 дней	6–9 дней	3–5 дней
частота приступов кашля	до 15 в сутки, репризы редко	16–25 в сутки, репризы часто	более 25 в сутки, пароксизмы
лейкоцитоз	$10–15 \cdot 10^9$/л	до $20–30 \cdot 10^9$/л	более $40–50 \cdot 10^9$/л
лимфоцитоз	до 70%	70–80%	более 80%

Специфические осложнения

1. пневмония, ателектаз, эмфизема средостения;
2. задержки дыхания до 30 секунд и остановки дыхания (апноэ) более 30 секунд;
3. коклюшная энцефалопатия (гипоксический отёк мозга, кровоизлияние в мозг);
4. кровотечения из носа, заднеглоточного пространства, бронхов, наружного слухового прохода; кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки, склеры, сетчатку, головной мозг;
5. грыжи, выпадение слизистой оболочки прямой кишки;
6. разрывы барабанной перепонки и диафрагмы.

Неспецифические осложнения связаны с вторичной бактериальной флорой: пневмония, бронхит, бронхиолит, лимфаденит, отит.

Апноэ возникает преимущественно у детей первых месяцев жизни. Спазматическое апноэ развивается во время приступа кашля и длится от 30 секунд до 1 минуты; синкопальное не связано с кашлем: вялость, бледность, затем цианоз, остановка дыхания на 1–2 минуты при сохранённой сердечной деятельности.

Резидуальные изменения: хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, задержка психомоторного развития, судорожный синдром, речевые расстройства; редко у непривитых без лечения — слепота, глухота, парезы.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. эпидемиологических данных: контакт с больным коклюшем или кашляющими;
2. клинической картины: длительный, чаще приступообразный кашель;
3. прививочного статуса;
4. результатов лабораторной диагностики.

Для подтверждения диагноза достаточно положительного результата одного из лабораторных исследований.

3.2 Жалобы и анамнез

Целенаправленно выявляют кашель **более 7 дней** и уточняют его характер.

Что уточнить

1. в первые **7–14 дней** кашель сухой навязчивый, затем приступообразный судорожный; рвота после кашля присоединяется **на 2–3-й неделе**;
2. чем заканчивается приступ: рвотой, вязкой стекловидной мокротой;
3. репризы, цианоз лица во время приступа (признак тяжёлого течения);
4. задержки дыхания, судороги, нарушения сознания;
5. другие катаральные симптомы: ринорея, заложенность носа, боль или першение в горле, осиплость голоса, одышка.

Отсутствие типичных приступов не исключает атипичных (стёртых) форм у детей, привитых **в предшествующие 3–4 года**, подростков и взрослых. Отсутствие репризов коклюш не исключает.

Уточняют контакт с больным коклюшем или длительно (**более 3–4 недель**) кашляющим ребёнком или взрослым. При контакте с лабораторно подтверждённым случаем и коклюшеподобной картине можно диагностировать эпидемиологически связанный случай.

Уточняют температуру тела в начале болезни: в предсудорожном периоде она повышается редко, что помогает дифференциальной диагностике; лихорадка возможна при наслоении ОРВИ или осложнениях. Интоксикации при гладком течении нет.

Уточняют вакцинальный статус: вакцинация не исключает заболевания, но исключает тяжёлую форму.

3.3 Осмотр кожи и уздечки языка

Оценивают кожу: периоральный цианоз, отёчность лица и век, петехии на лице, кровоизлияния в склеры и кожу век. Цианоз, отёчный и геморрагический синдромы свидетельствуют о среднетяжёлом или тяжёлом течении; геморрагический синдром проявляется также носовыми кровотечениями на высоте кашля.

Осматривают уздечку языка: надрыв или язвочка характерны для коклюша, но их отсутствие коклюш не исключает.

3.4 Аускультация лёгких

При аускультации в периоде судорожного кашля выслушивают жёсткое дыхание и непостоянные грубые проводные хрипы, исчезающие после приступа. Постоянные хрипы, очаговая симптоматика и бронхообструктивный синдром для моноинфекции нехарактерны и указывают на осложнение или сочетанную инфекцию.

3.5 Общий анализ крови

Всем пациентам с подозрением на коклюш показан общий развёрнутый анализ крови: лейкоцитоз за счёт лимфоцитоза при нормальной СОЭ свидетельствует в пользу коклюша.

Отсутствие типичных изменений коклюш не исключает. Нейтрофилёз, сдвиг формулы влево, ускорение СОЭ указывают на осложнения или сочетанную инфекцию. При лейкоцитозе анализ повторяют до нормализации.

3.6 ПЦР мазка из носоглотки

Определение ДНК B. pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica в мазке со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР однократно — для подтверждения диагноза.

ПЦР применяется у пациентов, кашляющих **более 7, но не более 28–35 дней**, и у контактных работников детских учреждений; результат не зависит от вакцинации и антибактериальной терапии. Для контроля эффективности лечения ПЦР не используется: ДНК погибших микробов сохраняется **до 3–4 недель**.

Специфичность ПЦР 85–98%, чувствительность 45–65%.

3.7 Антитела к Bordetella pertussis методом ИФА

Пациентам, кашляющим **3 недели и более**, определяют антитела к B. pertussis методом ИФА: IgM, IgA в ранние сроки, IgG — в поздние. Метод предпочтителен у подростков и на сроке **более 4 недель**.

У привитых **в последние 5–7 лет** диагноз подтверждается четырёхкратным нарастанием титров IgG через 10–14 дней либо выявлением IgA и высоких титров IgG у привитых более 5 лет назад. Специфичность 89%, чувствительность 65%.

3.8 Посев слизи с задней стенки глотки

Двукратное культуральное исследование слизи с задней стенки глотки — при кашле **не более 14–21 дня**, до начала антибактериальной терапии, натощак или не ранее чем **через 2 часа** после еды.

Специфичность 100%, чувствительность 15% и менее: отрицательный результат коклюш не исключает; результат получают с задержкой.

3.9 Исследования на другие респираторные возбудители

Показания: негладкое течение или отсутствие эффекта терапии — лихорадка, нарастание катаральных симптомов, бронхообструкция.

Исследования

1. ПЦР мазков из носо- и ротоглотки на парагрипп, РС-вирус, метапневмовирус, риновирус, аденовирус, бокавирус;
2. ПЦР на Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae;
3. антитела к Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в крови.

Детям первого года жизни при тяжёлом и негладком течении определяют маркеры активной цитомегаловирусной инфекции (IgM, ДНК ЦМВ в крови, моче, слюне): она достоверно повышает риск тяжёлого течения и неблагоприятного исхода.

3.10 Рентгенография лёгких

Показание: подозрение на пневмонию или ателектаз — лихорадка, интоксикация, очаговая симптоматика, одышка, тахипноэ, «стонущее» дыхание, учащение приступов.

3.11 Электрокардиография и эхокардиография

Показание: тяжёлое течение — ранняя диагностика кардиальных осложнений и лёгочной гипертензии; также фоновые заболевания и пороки сердца, тахикардия, аритмия.

3.12 Электроэнцефалография и нейросонография

Электроэнцефалография — при тяжёлом негладком течении с декомпенсацией неврологической патологии, судорогами, признаками отёка мозга.

Нейросонография — детям первого года жизни при появлении или нарастании неврологической симптоматики.

3.13 Бронхоскопия

Показание: обширные или не расправляющиеся **2 недели и более** ателектазы — оценка бронхиальной проходимости.

3.14 Пульсоксиметрия

Показание: тяжёлое течение, особенно с задержками дыхания, судорогами, пневмонией, бронхообструкцией — уточнение показаний к ИВЛ.

3.15 Консультации специалистов

Офтальмолог — при субконъюнктивальных кровоизлияниях.

Невролог — при тяжёлых формах с неврологической симптоматикой или сопутствующей неврологической патологией.

---

4. Лечение

Цели лечения

1. эрадикация возбудителя;
2. купирование приступов судорожного кашля;
3. предупреждение и лечение осложнений, в том числе апноэ и коклюшной энцефалопатии.

4.1 Этиотропная терапия

Всем пациентам с коклюшем назначают антибактериальные препараты системного действия: в первую очередь макролиды, при их непереносимости — пенициллины широкого спектра или цефалоспорины III поколения.

1. азитромицин — детям **старше 6 месяцев** 10 мг/кг в сутки в 1 приём, **5 дней**;
2. эритромицин — 10–15 мг/кг каждые 8 часов, не более 2 г в сутки, **14 дней**;
3. #кларитромицин — детям **старше 1 месяца** 7,5 мг/кг 2 раза в сутки, не более 1 г в сутки, **7–14 дней**;
4. #пиперациллин + тазобактам — тяжёлое течение, в том числе **младше 2 месяцев**: 40–50 мг/кг внутривенно каждые 8 часов, **1–2 недели**;
5. #цефоперазон + сульбактам — тяжёлое течение: 50–60 мг/кг внутривенно каждые 12 часов, **1–2 недели**;
6. цефотаксим, цефтриаксон, ампициллин, амоксициллин — по инструкции.

Антибиотики назначают детям первого года жизни, обратившимся **в течение 6 недель** от начала болезни, остальным — **в течение 3 недель**. Они уменьшают колонизацию и заразность, но не влияют на выраженность и длительность кашля.

Независимо от сроков антибиотики показаны при бронхолёгочных осложнениях вторичной флоры и хронических заболеваниях лёгких.

Азитромицин в суспензии 100 мг/5 мл: от 2,5 мл (50 мг) при массе 5 кг до 5 мл (100 мг) при 10 кг; 200 мг/5 мл: 2,5 мл при 10–14 кг, 5 мл при 15–24 кг, 7,5 мл при 25–34 кг, 10 мл при 35–44 кг, 12,5 мл (500 мг) при 45 кг и более.

Бессимптомным носителям в очагах антибиотики (предпочтительно макролиды) назначают только при тесном контакте с детьми групп риска тяжёлого течения и по эпидемическим показаниям.

Группы риска тяжёлого течения

1. младенцы **моложе 3 месяцев**;
2. непривитые или не получившие полный первичный курс;
3. недоношенные, с низкой массой тела при рождении или оценкой по Апгар менее 8;
4. тяжёлые врождённые пороки сердца;
5. лейкоцитоз более $20 \cdot 10^9$/л с лимфоцитозом более $10 \cdot 10^9$/л;
6. апноэ и цианоз в дебюте;
7. коинфекция или сопутствующая пневмония.

4.2 Патогенетическая и симптоматическая терапия

При спазматическом кашле — противокашлевые средства центрального действия: бутамират в каплях **с 2 месяцев**, в сиропе и таблетках — по инструкции.

При обильной вязкой трудноотделяемой мокроте — амброксол по инструкции. Одновременно противокашлевые и муколитические средства не назначают.

При среднетяжёлом, тяжёлом и осложнённом течении с дыхательными расстройствами, энцефалопатией или поражением нижних дыхательных путей — оксигенотерапия (кислородная палатка или маска, кислорода не более 40%).

Показания к кислороду

1. бледность, цианоз;
2. брадикардия;
3. сатурация **менее 93%**, в том числе во время пароксизма.

При остановке дыхания — ритмичное надавливание на грудную клетку и искусственное дыхание ручным респиратором. При повторных задержках или остановке дыхания **более 30 секунд** ребёнка переводят в ОРИТ.

При признаках тяжёлого коклюша и угрожающих жизни осложнений показана консультация анестезиолога-реаниматолога для перевода в ОРИТ.

Признаки утяжеления и отёка мозга

1. судороги, апноэ;
2. выбухание и пульсация большого родничка;
3. любая степень угнетения сознания;
4. изменение ритма мочеиспусканий, нарастание отёков;
5. поражение нижних дыхательных путей, одышка, цианоз лица при кашле.

Тяжёлый коклюш с отёком мозга и нарушениями ритма дыхания, разлитой цианоз лица при приступах у детей первых месяцев — системные глюкокортикоиды: #гидрокортизон 5–7 мг/кг **3 дня**, преднизолон или дексаметазон; курс **2–5 дней, не более 7–9**.

Судороги при коклюшной энцефалопатии — #диазепам внутривенно или внутримышечно.

1. #диазепам — 0,25 мг/кг, возможно 2 раза в сутки; суточная доза не более 5 мг детям до 5 лет, 20 мг — 6–12 лет, 40 мг — старше 12 лет.

Другие противоэпилептические препараты — по назначению анестезиолога-реаниматолога или невролога.

При тяжёлом коклюше у детей раннего возраста для уменьшения гипоксии мозга назначают фенобарбитал (в КР указано «для детей **с 3 лет**»).

4.3 Иное лечение

При затруднённом откашливании — отсасывание слизи из верхних дыхательных путей электроотсосом, планово 2–3 раза в день или по показаниям, преимущественно у детей первого года.

При сочетанной ОРВИ назначают противовирусные препараты или иммуностимуляторы: интерферон альфа-2b, меглюмина акридонацетат (**с 4 лет**), антитела к гамма-интерферону аффинно очищенные (**старше 1 месяца**), комбинированные антитела к гамма-интерферону, гистамину и CD4 (**старше 6 месяцев**).

Специальных программ реабилитации нет. Реконвалесцентам тяжёлого негладкого коклюша (энцефалопатия, пневмония) и при коморбидных состояниях — реабилитация у профильных специалистов и санаторно-курортное лечение.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Лёгкое и среднетяжёлое течение без факторов риска лечится амбулаторно у педиатра или инфекциониста. Тяжёлое течение, среднетяжёлое с факторами риска, эпидемиологические показания — стационар с ОРИТ; угрожающие жизни осложнения — ОРИТ. В стационаре пациентов размещают в боксах.

Показания к переводу в ОРИТ

1. брадикардия или пароксизм с десатурацией **SpO_2 менее 90%**;
2. цианоз, вялость, выраженная бледность;
3. апноэ **более 15 секунд** у младенца или **более 10 секунд** у новорождённого;
4. апноэ любой продолжительности с десатурацией;
5. прогрессирующая дыхательная недостаточность;
6. угнетение сознания;
7. судороги;
8. подозрение на отёк головного мозга.

Критерий выписки из стационара — удовлетворительное состояние.

Критерии выздоровления

1. нет тяжёлых приступов кашля с репризами;
2. приступов кашля нет или их стало меньше;
3. гемограмма нормализовалась (лимфоцитоз может сохраняться долго);
4. при пневмонии — нормализация клинической, гематологической и рентгенологической картины.

5.2 Противоэпидемические мероприятия

Дети с коклюшем изолируются **на 25 суток** от начала заболевания. На контактных детей **до 7 лет** накладывается карантин **14 суток** от изоляции больного; дети старше 7 лет разобщению не подлежат. О случае сообщают по телефону **в течение 2 часов**, экстренное извещение — **в течение 12 часов**.

Реконвалесцентов выписывают в коллектив при клиническом выздоровлении. От физкультуры освобождают **на 2 недели**, медицинский отвод от прививок — **1 месяц**.

Всем контактным детям, в том числе новорождённым, и взрослым после изоляции больного проводится постконтактная профилактика; препараты выбора — макролиды.

Профилактика показана независимо от возраста и вакцинального статуса при тесном контакте с больным манифестной формой в закрытом помещении **в течение 1 часа и более** или при контакте с его респираторными секретами.

Детям первого года жизни и непривитым детям **до 2 лет** с аллергией на макролиды вводят иммуноглобулин человека нормальный.

1. иммуноглобулин человека нормальный — 3,0 мл двукратно с интервалом 24 часа, как можно раньше после контакта.

5.3 Вакцинопрофилактика

По национальному календарю вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка проводится в **3 – 4,5 – 6 – 18 месяцев**. При нарушении сроков стремятся к полному курсу: 3 введения с интервалом не менее 1–1,5 месяца и ревакцинация через 12 месяцев; дополнительных доз при удлинении интервалов не требуется.

Перенесённый коклюш не создаёт длительной защиты и не является противопоказанием к вакцинации. В очаге активная иммунизация не проводится; частично привитым вакцинацию продолжают по календарю.

Для защиты ребёнка до начала вакцинации возможна однократная вакцинация беременной во II или III триместре, не позднее **15 дней до родов**, вакциной АаКдС.

Оптимальная стратегия — своевременный охват детей первых двух лет жизни и поэтапное внедрение возрастных ревакцинаций в 6–7 лет, 14 лет и взрослых каждые 10 лет.

Первоочередные группы для ревакцинации

1. дети и взрослые с хронической бронхолёгочной патологией, бронхиальной астмой;
2. иммунодефицитные состояния, ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания;
3. дети, первично привитые бесклеточными вакцинами;
4. дети из многодетных семей и закрытых учреждений;
5. сотрудники медицинских, образовательных и социальных учреждений;
6. взрослые в семьях с новорождёнными и непривитыми детьми до 1 года;
7. женщины, планирующие беременность.

1. **АКДС, АКДС-ГепВ** — с 3 месяцев до 3 лет 11 месяцев 29 дней
2. **АаКДС** — с 2 месяцев до 7 лет
3. **АаКДС-ИПВ//ХИБ** — с 2 месяцев, при нарушении сроков — до 6 лет
4. **АаКДС-ИПВ-ВГВ//ХИБ** — с 2 месяцев до 2 лет
5. **АакдС** — с 4 лет и взрослым, разрешена беременным

5.4 Диспансерное наблюдение

Сроки наблюдения за реконвалесцентами коклюша

Специалисты	Длительность	Показания и сроки осмотров
пульмонолог, педиатр	6 месяцев	среднетяжёлые и тяжёлые формы с пневмонией, ателектазом, дыхательными расстройствами — через 2 и 6 месяцев после выписки
невролог, педиатр	1 год	тяжёлые формы с энцефалопатией, судорогами, внутричерепной гипертензией, кровоизлияниями — через 2, 6 и 12 месяцев после выписки

У реконвалесцентов тяжёлых форм с коклюшной энцефалопатией возможны задержка психомоторного и речевого развития; после внутримозговых кровоизлияний — снижение слуха и зрения, парезы.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Коклюш у детей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.01.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2029 года

Код в рубрикаторе	1023_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Частота приступов кашля по степеням тяжести различается: в разделе 1.6 лёгкая — 8–10 в сутки, среднетяжёлая — до 15–20, тяжёлая — 25–30 и более; в приложении Г1 — до 15, 16–25 и более 25 соответственно.
- Фенобарбитал рекомендован «детям раннего возраста», но с пометкой «для детей с 3 лет» (раздел 3.1): ранний возраст — до 3 лет, указания противоречат друг другу.
- Суточный максимум #диазепама указан для детей до 5 лет и 6–12 лет; для детей от 5 до 6 лет предел не приведён (раздел 3.1).

Клинические рекомендации

Краниальные мононейропатии у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B02.2** — Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы **G44.0** — Синдром «гистаминовой» головной боли **G50.0** — Невралгия тройничного нерва **G50.1** — Атипичная лицевая боль **G50.8** — Другие поражения тройничного нерва **G50.9** — Поражение тройничного нерва неуточненное **G51.0** — Паралич Белла **G51.1** — Воспаление узла коленца **G51.2** — Синдром Россолимо-Мелькерссона **G51.3** — Клонический гемифациальный спазм **G51.4** — Лицевая миокимия **G51.8** — Другие поражения лицевого нерва **G51.9** — Поражение лицевого нерва неуточненное **G52.0** — Поражения обонятельного нерва **G52.1** — Поражения языкоглоточного нерва **G52.2** — Поражения блуждающего нерва **G52.3** — Поражения подъязычного нерва **G52.7** — Множественные поражения черепных нервов **G52.8** — Поражения других уточненных черепных нервов **G52.9** — Поражение черепного нерва неуточненное **G53.0** — Невралгия после опоясывающего лишая (B02.2+) **G90.0** — Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии; Некоммерческая организация «Ассоциация интервенционного лечения боли»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/895_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Поражения тройничного нерва (невралгия, атипичная лицевая боль, нейропатическая боль, автономные цефалгии), лицевого нерва (нейропатия, гемифациальный спазм, миокимия) и других черепных нервов.
- Паралич Белла — диагноз исключения; развивается за 24–48 часов, максимум за 72 часа. Глюкокортикоиды — **как можно раньше, лучше в первые 72 часа**, при любой тяжести; при тяжёлой форме — вместе с противовирусными.
- Нейропатия лицевого нерва — всем оториноларинголог с отоскопией, по показаниям аудиометрия и тимпанометрия. Снижение слуха на стороне поражения нехарактерно — заподозрить объёмное образование.
- «Красные флаги» или симптомы **более 3 недель** — МРТ головного мозга с контрастом.
- Тяжёлая нейропатия (V–VI степень) — ЭНМГ **не ранее 8 суток**: М-ответ ниже на 90% и более — к хирургу. Электростимуляция и форсированные упражнения не рекомендуются.
- Тригеминальная невралгия: препараты первой линии — карбамазепин и окскарбазепин.
- Невралгия языкоглоточного нерва — приступы боли по типу удара тока в задней части языка, миндалине, глотке, у угла челюсти, в ухе; обследование включает МРТ, УЗИ шеи и видеоларингоскопию.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Тройничный нерв: определения

Тригеминальная невралгия — односторонние повторяющиеся кратковременные приступы боли по типу удара током, внезапно начинающиеся и прекращающиеся, провоцируемые безболевыми раздражителями, в зоне одной или нескольких ветвей тройничного нерва. Может сопровождаться постоянной фоновой болью умеренной интенсивности.

Атипичная лицевая боль и нейропатическая боль

Состояние	Определение
Персистирующая идиопатическая лицевая боль	постоянная боль в лице, ежедневно **более 2 часов в день** **более 3 месяцев**, без выраженных неврологических нарушений и предшествующей причины
Миофасциальная орофациальная боль, связанная с мышечным спазмом	боль от внезапного непроизвольного обратимого тонического сокращения жевательной мышцы; возможно острое нарушение прикуса
Синдром пылающего рта	жжение или дизестезия в полости рта ежедневно **более 2 часов в день** **более 3 месяцев** без признаков основного заболевания
Тригеминальная нейропатическая боль	боль в зоне одной или нескольких ветвей тройничного нерва, вызванная другим заболеванием и указывающая на повреждение нерва

Тригеминальные автономные (вегетативные) цефалгии — первичные головные боли

1. **кластерная головная боль** — короткие односторонние атаки крайне сильной боли в области орбиты, подглазничной или височной области с вегетативными симптомами со стороны глаза и носа
2. **пароксизмальная гемикрания** — строго односторонняя боль в области орбиты, подглазничной или височной области по 2–30 минут, много раз в день, с вегетативными симптомами; купируется индометацином
3. **SUNCT** — короткие односторонние атаки боли в глазничной и окологлазничной области, всегда с инъекцией конъюнктивы и слезотечением
4. **SUNA** — то же, но инъекции конъюнктивы и слезотечения нет или есть только один из этих симптомов
5. **гемикрания континуа** — непрерывная односторонняя головная боль умеренной интенсивности с обострениями и вегетативными симптомами, абсолютный эффект индометацина

2.2 Лицевой нерв: определения

Нейропатия лицевого нерва — асимметрия лица из-за односторонней слабости мимических мышц (прозопарез — движения есть, прозоплегия — нет) с неполным закрытием глаза; симптомы по уровню поражения и поздние осложнения — ниже. Паралич Белла — идиопатическая форма.

Гемифациальный спазм — хронические пароксизмальные безболезненные непроизвольные односторонние тонические или клонические сокращения мышц лица, в том числе в покое и ночью.

Лицевая миокимия — спонтанные односторонние низкоамплитудные пульсирующие подёргивания одной мышцы лица (чаще нижней порции круговой мышцы глаза), от секунд до часов, реже до недель; заметнее пациенту, чем окружающим.

Краниальная невропатия — любое повреждение черепного нерва на любом уровне.

Уровни поражения лицевого нерва

1. мосто-мозжечковый угол;
2. внутренний слуховой проход;
3. костный канал до отхождения большого каменистого нерва;
4. костный канал до отхождения стремянного нерва;
5. выход через шилососцевидное отверстие;
6. околоушная железа;
7. отдельные ветви в мимических мышцах.

2.3 Причины

1. **Классическая тригеминальная невралгия** — нейроваскулярный конфликт — сдавление корешка сосудом, чаще верхней мозжечковой артерией
2. **Симптоматическая** — опухоль, артериовенозная мальформация, демиелинизация при рассеянном склерозе
3. **Идиопатическая** — причина неизвестна

Паралич Белла — диагноз исключения. Основные гипотезы — вирусная (реактивация HSV-1, HSV-2, VZV на фоне стресса, переохлаждения, другой инфекции) и аутоиммунная. Связан с осенью, перепадами температуры, сахарным диабетом.

1. **Синдром Рамсея Ханта** — герпетическое поражение коленчатого узла: прозопарез или прозоплегия на фоне боли и кожных высыпаний; у 50–85% тяжелее паралича Белла, склонен к рецидивам
2. **Синдром Россолимо — Мелькерссона** — генетическое заболевание: рецидивирующий прозопарез с отёком губ и складчатым языком
3. **Объёмные образования (8–12%)** — шванномы лицевого нерва, опухоли мосто-мозжечкового угла и околоушной железы
4. **Другие частые причины** — осложнения хирургических, косметологических и стоматологических вмешательств, черепно-мозговая травма, неврологические заболевания, инфекции, метаболические нарушения; реже — радиохирургия вестибулярной шванномы
5. **Боррелиоз** — изолированная нейропатия лицевого нерва у 34–56% — учитывать при дифференциальной диагностике

Гемифациальный спазм

1. **первичный** — сдавление корешка лицевого нерва сосудом, чаще передней нижней мозжечковой артерией
2. **вторичный** — опухоль мосто-мозжечкового угла или околоушной железы, сосудистые аномалии, аномалия Киари, инфекции сосцевидного отростка и уха (средний отит, холестеатома), травма, поражение ствола мозга, перенесённая нейропатия лицевого нерва (постпаралитический гемиспазм)
3. **провоцируют** — холод, яркий свет, стресс

Синкинезии — непроизвольное сокращение одной группы мышц (или работа железы) при произвольном сокращении другой. Чаще всего окуло-скуловая и окуло-оральная (более 90%), оро-окулярная (59%), «крокодиловы слёзы» — слезотечение при жевании. Несколько синкинезий вместе — постпаралитический гемиспазм.

Первичная миокимия — от физического или эмоционального перенапряжения, кофеина, проходит сама. Вторичная — побочный эффект препаратов (топирамат, габапентин), дебют рассеянного склероза, объёмного процесса ствола, вестибулярной шванномы, тиреотоксикоза.

Невралгия языкоглоточного нерва

1. **классическая** — нейроваскулярный конфликт
2. **вторичная** — травма шеи, рассеянный склероз, тонзиллярные или регионарные опухоли, опухоль мосто-мозжечкового угла, мальформация Арнольда — Киари
3. **идиопатическая** — причина не найдена

Поражения обонятельного нерва, нервов глазодвигательной и каудальной групп — проявления другого заболевания

1. нарушение мозгового кровообращения;
2. травма головы и шеи;
3. тромбоз венозных синусов;
4. воспалительные заболевания околоносовых пазух;
5. опухоли головы и шеи;
6. системные и метаболические заболевания;
7. миастения, боковой амиотрофический склероз;
8. сосудистые мальформации.

Тригеминальная нейропатическая боль — после травмы нерва, герпетической инфекции и других причин; постгерпетическая невралгия — реактивация Herpes zoster.

2.4 Классификация

Тригеминальная невралгия: классическая, идиопатическая, симптоматическая. По Burchiel: 1 тип — только типичные прострелы; 2 тип — ещё и постоянная фоновая боль.

Атипичная лицевая боль (ICOP)

1. синдром пылающего рта: без соматосенсорных изменений, с соматосенсорными изменениями, возможный;
2. персистирующая идиопатическая лицевая боль: без соматосенсорных изменений, с ними, возможная;
3. миофасциальная орофациальная боль, связанная с мышечным спазмом.

«Возможный» — те же признаки, но **менее 3 месяцев**.

Тригеминальная нейропатическая боль (ICOP)

1. связанная с Herpes zoster;
2. постгерпетическая невралгия;
3. посттравматическая (и возможная посттравматическая);
4. связанная с другим нарушением (и возможная);
5. идиопатическая.

Тригеминальные автономные цефалгии

1. **эпизодическая кластерная головная боль** — не менее 2 периодов **более 7 дней** в году, ремиссия **более 3 месяцев** (около 80% пациентов)
2. **хроническая кластерная головная боль** — приступы **1 год** без ремиссий или с ремиссиями **менее 3 месяцев**
3. **пароксизмальная гемикрания** — эпизодическая — атаки от 7 дней до 1 года, ремиссия **от 1 месяца**; хроническая — **более 1 года** без ремиссий или с ремиссией менее 1 месяца
4. **SUNCT и SUNA** — эпизодические — атаки от 7 дней до 1 года, ремиссия **3 месяца и более**; хронические — более 1 года без ремиссии или с ремиссией менее 3 месяцев
5. **гемикрания континуа** — ремиттирующая (ремиссия не менее 1 дня без лечения) и неремиттирующая

Нейропатия лицевого нерва: идиопатическая (G51.0) и симптоматическая (G51.1, G51.2, G51.8, G51.9), поражение отдельных ветвей (G51.8). Гемифациальный спазм — первичный (G51.3) и вторичный. Лицевая миокимия — первичная (G51.4) и вторичная.

Языкоглоточный нерв (ICOP)

1. невралгия: классическая, идиопатическая, вторичная;
2. нейропатическая боль: с установленной причиной, идиопатическая.

2.5 Клиническая картина: тригеминальная невралгия

Диагноз — клинический, по характеру боли

1. приступ **от доли секунды до 2 минут**;
2. высокая интенсивность;
3. боль как электрический разряд, стреляющая, колющая, острая;
4. провокация безболевым воздействием на триггерные точки.

Провоцируют холодный воздух, чистка зубов, умывание, разговор, еда. Чувствительных нарушений нет — кроме симптоматической невралгии.

Персистирующая идиопатическая лицевая боль

1. постоянная тупая ноющая боль, без атак и курковых зон;
2. не соответствует зонам иннервации ветвей тройничного нерва;
3. чаще в области верхней челюсти, распространяется на периорбитальную область, нос, щёку, висок; бывает в одном зубе (атипичная одонталгия);
4. ночью обычно стихает, но у 50–70% нарушен сон;
5. обостряется от холода, стресса, хирургических и стоматологических вмешательств.

Миофасциальная боль со спазмом жевательной мышцы: внезапная боль и ограничение движений челюсти.

Синдром пылающего рта: постоянная жгучая боль на неизменённой слизистой, чаще языка, обычно двусторонняя, к вечеру сильнее; изменение вкуса и сухость во рту при нормальном слюноотделении.

Нейропатическая боль: негативные симптомы (гипестезия, анестезия) и позитивные (гипералгезия, аллодиния, гиперпатия, спонтанная боль, парестезии); аллодиния бывает механическая, температурная, двигательная. Постгерпетическая невралгия — жгучая, колющая боль с парестезией, гипералгезией, зудом, потерей чувствительности и аллодинией.

Нейропатическая боль: симптомы и механизмы

Симптом	Механизм
длительная жгучая боль	нарушение центрального тормозного контроля, центральная сенситизация, эктопические разряды
стреляющая, пронзающая боль	эктопические разряды
парестезия, дизестезия	эктопические разряды, центральная сенситизация
гипералгезия	центральная сенситизация от усиления ноцицептивной афферентации
механическая аллодиния	нарушение центрального торможения, центральная сенситизация, сенситизация ноцицепторов
парадоксальные реакции на температуру	нарушение центрального тормозного контроля
онемение, утрата чувствительности	дегенерация сенсорных волокон, нарушение центрального тормозного контроля

2.6 Клиническая картина: тригеминальные автономные цефалгии

Кластерная головная боль: односторонняя очень сильная боль в области глазницы, подглазничной или височной области, **15–180 минут**, чаще ночью; пациент возбуждён, не находит себе места.

Вегетативные симптомы на стороне боли

1. слезотечение (91%);
2. инъекция конъюнктивы (77%);
3. заложенность носа (75%);
4. птоз, отёк век, миоз;
5. ринорея;
6. потливость и покраснение лица.

Триггеры: алкоголь, вазодилататоры, нарушение сна, перепады давления (авиаперелёт, дайвинг), смена погоды, запахи.

Пароксизмальная гемикрания: сильная боль в области орбиты с вегетативными симптомами по **2–30 минут**, приступы в течение всего дня.

SUNCT и SUNA: короткие (секунды — минуты) приступы боли в области орбиты, часто от прикосновения к коже; при SUNA — чаще в виске, со слезотечением, заложенностью носа, ринореей, без рефрактерного периода (в отличие от тригеминальной невралгии).

Гемикрания континуа: односторонняя боль средней интенсивности с обострениями — в височной, глазничной, лобной, ретроорбитальной или затылочной области.

2.7 Клиническая картина: нейропатия лицевого нерва

Уровень поражения лицевого нерва

Уровень поражения	Симптомы, кроме слабости мимических мышц
мосто-мозжечковый угол	нарушение функции тройничного, отводящего и преддверно-улиткового нервов
внутренний слуховой проход	сухость глаза, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, снижение слуха на стороне поражения, головокружение
костный канал до отхождения большого каменистого нерва	сухость глаза, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, гиперакузия
до отхождения стремянного нерва	слезотечение, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, гиперакузия
выход через шилососцевидное отверстие	только двигательные нарушения и слезотечение
околоушная железа	только двигательные нарушения
отдельные ветви	только двигательные нарушения в зоне иннервации

Диагноз — по осмотру, МРТ и ЭНМГ. Паралич Белла развивается за **24–48 часов**, **максимум за 72 часа**.

Признаки уровня и причины

1. слабость только нижней группы мимических мышц — центральное поражение или поражение отдельных ветвей;
2. гиперакузия, нарушение вкуса, сухость во рту — периферическое поражение выше отхождения стремянного нерва;
3. **снижение слуха на стороне поражения** нехарактерно — заподозрить объёмное образование;
4. боль в ухе или за ухом — симптом идиопатической нейропатии или отогенного процесса;
5. рецидив — у 6,5%; нейропатия в анамнезе ставит идиопатическую форму под сомнение.

«Красные флаги» — нужны дополнительные исследования и консультации

1. симптомы нарастают **более 72 часов**;
2. тяжесть пареза колеблется;
3. слабы только мышцы нижней половины лица;
4. эпизод слабости мышц лица в анамнезе;
5. поражены обе половины лица;
6. снижение слуха;
7. головокружение;
8. другие неврологические симптомы.

У **60–70%** функция восстанавливается полностью или частично **за 3–6 месяцев**, но из-за частых осложнений заболевание считают прогрессирующим и наблюдают. Гипертонус мышц здоровой стороны — **с 7-го дня** у 67%; синкинезии — **с 4 месяцев до года**. Лагофтальм — у 3/4 пациентов, ведёт к ксерозу роговицы, кератиту, язве.

Первичные двигательные нарушения

1. снижение силы и тонуса мышц поражённой стороны;
2. лагофтальм.

Вторичные

1. гипертонус или контрактуры мышц здоровой или поражённой стороны;
2. атрофия мышц поражённой стороны;
3. синкинезии до постпаралитического гемиспазма.

Факторы риска контрактур и синкинезий

1. тяжёлое поражение: прозоплегия, по ЭНМГ поражение нерва **более 90%**;
2. активная стимуляция мышц: ЛФК с максимальной амплитудой движений, электростимуляция.

Изолированное поражение краевой нижнечелюстной ветви (после стоматологических и косметологических вмешательств, операций на голове и шее, травм) — асимметрия улыбки, ошибочно принимаемая за центральное поражение; выявляется пробой «Ы-Ы».

2.8 Клиническая картина: гемифациальный спазм и миокимия

Гемифациальный спазм: спонтанный односторонний клонический и (или) тонический спазм мышц лица, в покое и во сне; бывают щелчки в ухе (сокращение стременной мышцы) и боль как при невралгии тройничного нерва. Обычно начинается с круговой мышцы глаза. Двусторонний — менее 5%.

«Красные флаги» при лицевой миокимии

1. подёргивания и в других мышцах лица или тела;
2. двусторонний процесс;
3. глаз открывается с трудом, опущение века;
4. покраснение или отёк века, боль;
5. не проходит за несколько недель;
6. другие неврологические симптомы.

Непроизвольные движения лица

Состояние	Отличительный признак
Лицевая миокимия	периодические низкоамплитудные сокращения 1–2 мышц, проходят сами, заметнее пациенту
Блефароспазм, лицевой параспазм	длительные прогрессирующие двусторонние скручивающие движения, вовлекаются соседние мышцы
Синкинезии	только при определённом движении: одна мышца провоцирует сокращение другой
Тики	дебют в 3–7 лет, прогрессируют только до подросткового возраста
Эпилепсия с миоклонией век (синдром Дживонса)	миоклония век с абсансами или без, дрожание век с двух сторон сразу после медленного закрытия

2.9 Клиническая картина: другие черепные нервы

1. **Обонятельный** — гипосмия, аносмия, гиперосмия
2. **Глазодвигательные** — птоз, косоглазие, диплопия, изменение ширины зрачка, нарушение конвергенции, аккомодации и сочетанных движений глаз
3. **Языкоглоточный** — невралгия — пароксизмальная боль по типу удара тока в задней части языка, миндалине, глотке, у угла нижней челюсти и (или) в ухе; нейропатия — расстройство вкуса задней трети языка, снижение чувствительности верхней половины глотки; болевая нейропатия — постоянная боль в зоне нерва

1. **Блуждающий** — редко изолированно; парез мышц глотки и голосовых складок — дисфагия, дисфония, дизартрия; тахи- или брадикардия; при двустороннем поражении — нарушение ритма дыхания
2. **Добавочный** — голова отклонена в больную сторону, ограничен поворот в здоровую, затруднено поднимание плеч; позже атрофия грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц
3. **Подъязычный** — парез половины языка, язык отклоняется в сторону поражения; при ядерном поражении — атрофия и фибриллярные подёргивания; двустороннее — глоссоплегия, дизартрия или анартрия

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Тригеминальная невралгия — диагноз клинический. Нейроваскулярный конфликт на МРТ сам по себе не основание для диагноза классической невралгии. То же для невралгии языкоглоточного нерва.

Общепринятых критериев для поражений лицевого нерва нет: диагноз — по жалобам, анамнезу, осмотру и инструментальным данным. Цель — установить уровень поражения, причину, тяжесть и прогноз восстановления.

Поражения обонятельного нерва, нервов глазодвигательной и каудальной групп — по жалобам и неврологическому осмотру; нужно найти основное заболевание.

Критерии диагноза: атипичная лицевая боль

Форма	Критерии
Персистирующая идиопатическая лицевая боль	ежедневно более 2 часов более 3 месяцев; плохо локализована, не соответствует зоне нерва; тупая, ноющая или тянущая; обследование патологии не выявляет
Миофасциальная боль со спазмом	спазм жевательной мышцы, боль связана со спазмом по времени и динамике; боль в челюсти, виске, ухе или перед ухом, вызывается пальпацией мышцы или открыванием рта
Синдром пылающего рта	ежедневно более 2 часов более 3 месяцев; жжение поверхностно в слизистой; слизистая не изменена, местные и системные причины исключены

Критерии диагноза: тригеминальная нейропатическая боль

Форма	Критерии
Связанная с Herpes zoster	односторонняя боль менее 3 месяцев; высыпания в зоне нерва или VZV в ликворе (ПЦР) или в материале из очагов; бывает без высыпаний (zoster sine herpete)
Постгерпетическая невралгия	боль более 3 месяцев в зоне ветвей, поражённых Herpes zoster, связана с ним по времени

Форма	Критерии
Посттравматическая	боль **более 3 месяцев**, повреждение нерва в анамнезе и по исследованиям, начало **не позднее 6 месяцев** после травмы, соматосенсорные симптомы в той же зоне; часто — после стоматологического лечения
Связанная с другим нарушением	боль 3 месяца и более, есть способное её вызвать расстройство, соматосенсорные симптомы в зоне боли
Идиопатическая	боль 3 месяца и более с соматосенсорными симптомами, поражение нерва есть, травмы и другой причины нет

Критерии диагноза: тригеминальные автономные цефалгии

Форма	Критерии
Кластерная головная боль	не менее 5 атак; сильная односторонняя боль в глазничной, подглазничной и (или) височной области **15–180 минут**; на стороне боли — инъекция конъюнктивы или слезотечение, заложенность носа или ринорея, отёк век, потливость лица, миоз или птоз, и (или) беспокойство; от 1 раза в 2 дня до 8 раз в день
Пароксизмальная гемикрания	не менее 20 атак по **2–30 минут**, более 5 в день, те же вегетативные симптомы, полностью проходит от индометацина
SUNCT	не менее 20 атак **1–600 секунд**, с вегетативными симптомами, не реже раза в день
SUNA	не более одного из симптомов: инъекция конъюнктивы, слезотечение
Гемикрания континуа	односторонняя боль **более 3 месяцев** с обострениями, вегетативные симптомы (в том числе ощущение распирания в ухе), абсолютный эффект индометацина

3.2 Жалобы и анамнез

Асимметрия лица от слабости мимических мышц — активный сбор жалоб и анамнеза, включая эпиданамнез: центральный или периферический уровень, причина.

Уточнить

1. длительность и скорость развития, порядок появления симптомов;
2. слабость верхней и нижней групп мимических мышц;
3. гиперакузию, нарушение вкуса, сухость во рту;
4. боль в ухе или за ухом накануне или в начале асимметрии;
5. травмы, операции, косметологические и стоматологические вмешательства;
6. гипертоническую болезнь, сахарный диабет, неврологические заболевания, беременность;
7. лихорадку, увеличение лимфатических узлов, покраснение или отёк тканей головы и шеи;
8. высыпания на лице, в околоушной области, в ушной раковине;
9. пребывание в регионах клещевого энцефалита **в течение месяца** до начала.

Есть «красные флаги» — расширенное клинико-лабораторно-инструментальное обследование.

«Красные флаги» при лицевой боли — признаки вторичной природы

1. внезапное начало;
2. лихорадка, сыпь, менингеальные симптомы;
3. боль усиливается при перемене положения, нагрузке, кашле, чихании;
4. нарастающая боль, резистентная к лечению;
5. боль впервые **после 50 лет**;
6. изменения неврологического статуса;
7. необъяснимая потеря веса, гипергидроз;
8. онкологическое заболевание, иммунодефицит, длительный приём глюкокортикоидов.

Атипичная лицевая боль — диагноз по критериям Международной классификации орофациальной боли.

Боль в зоне ветвей тройничного нерва — анамнез, жалобы, оценка боли и чувствительных нарушений в лице. Нейропатический характер подтверждают опросниками DN-4, painDETECT, LANSS.

3.3 Неврологический осмотр

Тригеминальная невралгия — осмотр невролога: чувствительность в зонах ветвей тройничного нерва, бимануальная пальпация жевательных мышц, провокация боли с триггерных точек. Цель — исключить симптоматическую невралгию, дисфункцию ВНЧС, миофасциальную боль.

Атипичная лицевая боль — неврологический, соматический и местный статус; при «красных флагах» — поиск причин вторичной боли.

Осмотр головы и шеи: повреждения и цвет кожи, отёк; пальпация лимфатических узлов и слюнных желёз. Пальпация мышц лица с усилием **1 кг**: **2 секунды** — местная боль, **5 секунд** — отражённая.

Подозрение на тригеминальную нейропатическую боль — чувствительность в зонах ветвей, корнеальный рефлекс, депигментация или пигментация кожи лица.

Сомнительный диагноз тригеминальной нейропатической боли — бимануальная пальпация жевательных и височных мышц: исключить дисфункцию ВНЧС.

Впервые возникшая боль в зоне глазничной ветви **после 50 лет** с эпизодами amaurosis fugax — пальпация поверхностной височной артерии: исключить гигантоклеточный артериит.

Тригеминальные автономные цефалгии — осмотр невролога: исключить вторичный характер.

Асимметрия лица — осмотр невролога с пальпацией околоушных слюнных желёз и лимфатических узлов.

Оценить силу каждой мимической мышцы, тонус на обеих сторонах, смещение средней линии лица, синкинезии — уровень и степень поражения.

Проверка мимических мышц

Мышца	Проба
лобное брюшко надчерепной мышцы	поднять брови
мышца, сморщивающая бровь	нахмуриться
круговая мышца глаза, вековая часть	спокойно закрыть глаза
круговая мышца глаза, орбитальная часть	зажмуриться

Мышца	Проба
мышцы, поднимающие верхнюю губу, крыло носа, угол рта	показать «оскал»
малая и большая скуловые	сомкнуть губы и улыбнуться
щёчная	надуть щёки
мышца смеха	широко улыбнуться с разомкнутыми губами
круговая мышца рта	вытянуть губы трубочкой
опускающая угол рта	грустная улыбка
опускающая нижнюю губу	опустить губу, сказать «Ы-Ы»
подбородочная	поднять нижнюю губу
подкожная мышца шеи	сказать «Ы-Ы» и напрячь шею

Патологические синкинезии

Синкинезия	Проявление
оро-окулярная	при вытягивании губ, надувании щёк, жевании сужается глазная щель
окуло-фронтальная	при моргании и зажмуривании морщится лоб
окуло-скуловая	при моргании и зажмуривании углубляется носогубная складка
окуло-назальная	при моргании и зажмуривании сокращается носовая мышца (может быть физиологической)
синкинезия Гюйе	при зажмуривании крыло носа поднимается вверх и кнаружи
окуло-оральная	при моргании и зажмуривании сокращаются носогубная складка, скуловые мышцы, верхняя губа
окуло-платизменная	зажмуривание напрягает подкожную мышцу шеи
окуло-аурикулярная	при зажмуривании поднимается ушная раковина
фронто-назальная	поднимание бровей сокращает носовую мышцу
фронто-оральная	при наморщивании лба сокращается угол рта
синкинезия Марина-Амата	открывание рта или боковые движения челюсти закрывают веки (редко)
«крокодиловы слёзы»	слезотечение на поражённой стороне при жевании
окуло-стапедиальная	при моргании и закрывании глаз — одностороннее снижение слуха или шум в ухе
звукоиндуцированная	звуки (клавиши, хлопки, труба) вызывают сокращение мимических мышц
ретроаурикулярная боль	хроническая боль за ухом во время менструации после паралича Белла

Тяжесть — по шкале House-Brackmann с записью в документацию; для наблюдения в динамике — шкала Sunnybrook (чувствительнее).

Оценить лагофтальм: смыкание век спокойно и с усилием, расстояние между веками в мм, положение век, инъекция конъюнктивы — для ранней профилактики осложнений и направления к офтальмологу.

Повторный осмотр невролога в течение нескольких месяцев после начала восстановления — профилактика и лечение осложнений, в том числе глазных.

Гемифациальный спазм — осмотр невролога с пальпацией околоушных желёз и лимфатических узлов, оценка всех мимических мышц и непроизвольных движений; возможны прозопарез и гипертонус.

Лицевая миокимия — тот же осмотр: выявить «красные флаги».

Подозрение на невралгию языкоглоточного нерва — неврологический осмотр с пальпацией: исключить вторичную причину.

3.4 Анализы крови

Нейропатия лицевого нерва — развёрнутый общий анализ крови: сдвиг формулы к нейтрофилам — неблагоприятный прогноз.

Биохимический анализ крови с глюкозой натощак — исключить метаболические причины.

Сахарный диабет — гликированный гемоглобин: понадобятся высокие дозы глюкокортикоидов.

Подозрение на инфекционную причину — в начале болезни антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, вирусу простого герпеса, VZV, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна — Барр, вирусу герпеса 6 типа.

Подозрение на клещевой энцефалит — антитела к вирусу клещевого энцефалита.

ТТГ — при гипотиреозе риск нейропатии лицевого нерва выше.

Гемифациальный спазм — общий и биохимический анализ крови с глюкозой: исключить вторичные формы.

Лицевая миокимия — анализы только при «красных флагах».

Синдром пылающего рта — анализы крови

1. общий и биохимический с глюкозой;
2. витамин B12, фолиевая кислота;
3. гемоглобин, железо, ферритин, трансферрин;
4. эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон.

Дефицит питания, диабет, климактерические нарушения указывают на вторичный синдром.

Не рекомендуется определять антитела к VZV для подтверждения постгерпетической невралгии: они слишком распространены в популяции.

Боль в зоне глазничной ветви **после 50 лет** с amaurosis fugax — СРБ и СОЭ; значимы СОЭ **≥ 50 мм/ч** или СРБ **≥ 10 мг/л**.

3.5 МРТ головного мозга

Тригеминальная невралгия — всем обзорная МРТ с 3D SPGR: исключить опухоль и демиелинизацию; при подозрении на них — с контрастом.

Фармакорезистентность, непереносимость или низкая приверженность лечению — МРТ в режимах FIESTA и 3D TOF: подтвердить или исключить нейроваскулярный конфликт.

Конфликт диагностируют при структурных изменениях корешка (дистопия, атрофия). Толщина среза **0,4–0,6 мм**, аппарат лучше 3 Тл, не менее 1,5 Тл.

Впервые выявленная атипичная лицевая боль с «красными флагами» — МРТ головного мозга.

Атипичная картина, «красные флаги», изменения неврологического статуса — МРТ головного мозга, мягких тканей головы, шейного отдела позвоночника и шеи.

Дифференциальный диагноз: патология костей черепа, болезни уха, синусит, патология челюстей, зубов, ВНЧС, краниальных нервов, тригеминальная и языкоглоточная невралгия, невралгия промежуточного нерва, внутричерепные опухоли и опухоли полости рта и др.

Возможная посттравматическая, возможная связанная с другим нарушением и идиопатическая тригеминальная нейропатическая боль — обзорная МРТ.

Впервые возникшие приступы SUNCT или SUNA — МРТ: исключить очаговое поражение мозга.

Впервые выявленные кластерная головная боль или пароксизмальная гемикрания — МРТ с контрастом: исключить опухоль, мальформацию, воспаление; гемикрания континуа — МРТ.

Кластерную головную боль отличают от других цефалгий, мигрени, височного артериита, тригеминальной невралгии, синусита, глаукомы, опухоли, мальформации, инсульта, диссекции артерий.

Нейропатия лицевого нерва с другими неврологическими симптомами — экстренно КТ или МРТ: исключить инсульт. При типичной картине экстренная МРТ не нужна.

Симптомы **более 3 недель** или «красные флаги» — МРТ головного мозга с контрастом по расширенному протоколу, по возможности с околоушной железой. Нельзя МРТ — КТ с контрастом.

Цель — исключить

1. объёмное образование;
2. воспаление, демиелинизацию;
3. инсульт;
4. нейроваскулярный конфликт.

При типичной картине объёмное образование находят в **8–12%**, из них 30% злокачественные. У 80% выздоравливающих восстановление начинается **в первые 2–3 недели**.

Гемифациальный спазм — всем МРТ по расширенному протоколу (3D-T2, 3D-TOF, FIESTA и др.): нейроваскулярный конфликт.

Нет конфликта на бесконтрастных сериях — МРТ с контрастом: опухоль и другие причины.

Лицевая миокимия: «красные флаги» — МРТ с контрастом; без них МРТ **не рекомендуется**.

Невралгия языкоглоточного нерва — всем МРТ с захватом краниовертебрального перехода и 3D SPGR; после исключения вторичных причин — FIESTA и 3D TOF (классическая невралгия).

3.6 КТ височной кости и другие лучевые исследования

Нейропатия лицевого нерва при подозрении на ЛОР-патологию или травму височной кости — КТ височной кости; нельзя — рентгенография височной кости.

Возможная связанная с другим нарушением и идиопатическая тригеминальная нейропатическая боль — ОПТГ, КЛКТ и (или) КТ или рентгенография околоносовых пазух: исключить одонтогенные причины и синусит.

Лицевая боль, не отвечающая критериям тригеминальной невралгии, — по клинической картине ОПТГ, КЛКТ, МРТ ВНЧС, УЗИ слюнных желёз, осмотр и пальпация мышц.

Невралгия языкоглоточного нерва без причины на МРТ — КТ краниовертебрального перехода: удлинённый шиловидный отросток, кальцинированная шилоподъязычная связка.

Подозрение на вторичную невралгию или нейропатическую боль языкоглоточного нерва без причины на МРТ головы — МРТ мягких тканей шеи с контрастом и жироподавлением.

3.7 Видеоларингоскопия

Невралгия языкоглоточного нерва — всем видеоларингоскопия: уточнить причину.

3.8 УЗИ

Нейропатия лицевого нерва неясной причины **более 3 недель**, если МРТ затруднена, — УЗИ околоушной слюнной железы.

Тяжёлое поражение по ЭНМГ **более 3 месяцев** — УЗИ мягких тканей лица: атрофия мышц, своевременное направление к хирургу.

Тяжёлое поражение **более 3 месяцев** и подозрение на атрофию — МРТ мягких тканей лица, прежде всего скуловых мышц: при тотальном поражении атрофия наступает быстро, позднее хирургическое лечение может быть нецелесообразно.

Гемифациальный спазм неясной причины — УЗИ околоушной слюнной железы (или МРТ).

Невралгия языкоглоточного нерва — всем УЗИ слюнных желёз и мягких тканей шеи.

3.9 Электронейромиография

Тяжёлая нейропатия лицевого нерва (V–VI степень по House-Brackmann) — стимуляционная ЭНМГ **не ранее 8 суток**, лучше **на 9–20 день**, с обеих сторон (круговые мышцы глаза и рта). Амплитуда М-ответа на поражённой стороне ниже **на 90% и более** — неблагоприятный прогноз, нужна игольчатая ЭМГ.

Асимметрия М-ответа более 90% — игольчатая ЭМГ не менее двух мышц верхней и нижней порций: нет потенциалов двигательных единиц при произвольном сокращении — тотальное поражение, неблагоприятный прогноз, показание к операции.

Отсутствие потенциалов двигательных единиц может не иметь прогностического значения **до 15 дня** — исследование повторяют.

Изолированное поражение ветви — игольчатая ЭМГ плегированной мышцы (например, опускающей нижнюю губу). При травме потенциалы могут появиться только на 4-м месяце.

Сохраняется тяжёлая нейропатия — игольчатая ЭМГ **через 6 месяцев** (можно **через 3 месяца** без восстановления и без травмы): нужна ли операция.

Неполное поражение (**менее IV степени**), движения есть во всех ветвях — ЭНМГ и ЭМГ **не рекомендуются**: прогноз благоприятный.

Миофасциальная боль со спазмом при недостатке данных — накожная ЭМГ: потенциалы двигательных единиц в покое.

Возможная и идиопатическая тригеминальная нейропатическая боль — коротколатентные вызванные потенциалы тройничного нерва (если повреждение не подтверждено иначе).

Персистирующая идиопатическая лицевая боль с подозрением на сенсорные нарушения — количественное сенсорное тестирование.

Тригеминальная нейропатическая боль — количественное сенсорное тестирование для объективизации нарушений.

3.10 Консультация оториноларинголога

Нейропатия лицевого нерва — всем оториноларинголог с отоскопией: исключить отогенную причину; по показаниям — аудиометрия и тимпанометрия.

Кондуктивная тугоухость — заподозрить опухоль лицевого нерва в пирамиде височной кости; **нейросенсорная** — сдавление нерва образованием в мосто-мозжечковом углу. Тимпанометрия оценивает акустический рефлекс стременной мышцы.

Подозрение на лицевую боль от заболевания околоносовых пазух (при тригеминальной невралгии и поражениях других черепных нервов) — оториноларинголог.

3.11 Другие консультации

Стоматолог — при сомнительном диагнозе тригеминальной невралгии или невралгии языкоглоточного нерва, всем с синдромом пылающего рта и персистирующей идиопатической лицевой болью, при подозрении на одонтогенную нейропатическую боль.

Синдром пылающего рта: слизистая должна быть без изменений; эрозии и язвы, не заживающие **2 недели**, — биопсия.

Челюстно-лицевой хирург — подозрение на боль от травм и других заболеваний челюстно-лицевой области.

Психиатр — тревога, депрессия, все случаи сомнительной тригеминальной невралгии после исключения орофациальной боли.

Синдром пылающего рта с тревогой, депрессией или болью **более 3 месяцев** — психиатр.

Персистирующая идиопатическая лицевая боль с тревогой, депрессией или хронической болью — психиатр.

Миофасциальная боль со спазмом с тревогой, депрессией или хронической болью — психиатр.

Тригеминальная нейропатическая боль с тревогой и депрессией — психиатр.

Хроническая тригеминальная нейропатическая боль — медицинский психолог: факторы хронизации.

Тригеминальная невралгия с фармакорезистентностью, непереносимостью или низкой приверженностью лечению — нейрохирург.

Тригеминальная нейропатическая боль с фармакорезистентностью или непереносимостью лечения — нейрохирург: пункционные и хирургические методы.

Невралгия языкоглоточного нерва с фармакорезистентностью или непереносимостью лечения — нейрохирург.

Подозрение на демиелинизирующее заболевание по МРТ — невролог кабинета рассеянного склероза.

Нейропатическая боль, связанная с Herpes zoster, — дерматовенеролог и (или) инфекционист; при глазничной локализации — офтальмолог.

Боль в зоне глазничной ветви **после 50 лет** с amaurosis fugax — ревматолог: гигантоклеточный артериит.

Лагофтальм без осложнений — офтальмолог планово; **осложнённый** (покраснение, жжение, боль, светобоязнь, дефекты роговицы) — **экстренно**.

Подозрение на инфекционную нейропатию лицевого нерва — инфекционист.

Нейропатия лицевого нерва — психолог: социальная дезадаптация, неприятие внешности, тревога, апатия, нарушения сна; при суицидальных мыслях — психиатр.

Тяжёлая нейропатия (V–VI степень) или осложнения (гипертонус, синкинезии) — обязательно врач ЛФК; остальным — домашняя самореабилитация.

3.12 Направление к хирургу при нейропатии лицевого нерва

Операция — при неблагоприятных клинических и миографических признаках

1. **до 3 месяцев, идиопатическая форма** — декомпрессия лабиринтного сегмента нерва
2. **до 18 месяцев** — реиннервирующая операция
3. **позже** — реконструктивно-пластическая операция

Идиопатическая нейропатия тяжёлой степени — нейрохирург как можно раньше, но после ЭНМГ и ЭМГ (**не ранее 8 суток**): показания к декомпрессии.

Отбор: V–VI степень, разница М-ответа **более 90%**, рецидивы и другие причины исключены. Декомпрессию предпочтительно делают **в течение 14 дней**, через среднюю черепную ямку; возможна **до 3 месяцев**. Есть положительная динамика — не оперируют.

Тяжёлая нейропатия **после 3 месяцев** (идиопатическая или симптоматическая) — челюстно-лицевой хирург: реиннервирующая (до 18 месяцев) или реконструктивно-пластическая операция; учитывают атрофию по УЗИ или МРТ.

Постпаралитический гемиспазм с выраженными синкинезиями — челюстно-лицевой хирург: селективная нейрэктомия. Лёгкий и умеренный — ботулинический токсин и реабилитация.

Первичный гемифациальный спазм с нейроваскулярным конфликтом на МРТ — нейрохирург: васкулярная декомпрессия.

Вторичный гемифациальный спазм с объёмным образованием на МРТ — нейрохирург: показания к операции.

---

4. Лечение

4.1 Тригеминальная невралгия: подходы

Три подхода: консервативная терапия (профилактическое лечение и купирование приступов), малоинвазивные вмешательства, операции.

Всем с установленным диагнозом — профилактическая терапия, чтобы приступы стали реже. Препараты первой линии — карбамазепин и окскарбазепин, остальные — вторая линия (отдельно или вместе с первой).

Правила

1. начинать с монотерапии, препараты добавлять поочерёдно;
2. заменять препарат постепенно, по инструкции;
3. ремиссия — нет боли **не менее 4 недель**: медленно снижать дозу, можно отменить;
4. рецидив — постепенно вернуться к минимальной эффективной дозе;
5. на противоэпилептических препаратах — анализы крови **каждые 3–6 месяцев**: общий, биохимия (глюкоза, ЩФ, АЛТ, АСТ, билирубин), натрий, калий; по показаниям ЭКГ и концентрация препарата;
6. нет эффекта при хорошей переносимости — психиатр;
7. для направления к нейрохирургу не нужно перепробовать все препараты.

Профилактическое лечение тригеминальной невралгии

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
карбамазепин	100 мг 2 раза в день, повышать на 100–200 мг каждые 3 дня до 200 мг 4 раза в день	800–1200 мг	седация, головокружение, нечёткость зрения, тошнота, неустойчивость, вялость, диплопия, головная боль; гипонатриемия, кожная сыпь, панцитопения; остеопороз при длительном приёме; снижает эффективность оральных контрацептивов

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
#окскарбазепин	150 мг 2 раза в день, повышать на 150–300 мг каждые 3 дня до 300 мг 4 раза в день	1200–1800 мг	сонливость, головокружение, диплопия, спутанность сознания, тошнота, боль в животе, головная боль, депрессия, диарея; высокий риск гипонатриемии; остеопороз при регулярном приёме; снижает эффективность оральных контрацептивов
#ламотриджин	25 мг 1 раз в день, повышать на 25 мг каждые 2 недели, после 100 мг — каждую неделю; свыше 100 мг — в 2 приёма	200 мг	нечёткость зрения, возбуждение, агрессия, неустойчивость, головокружение, тошнота, сухость во рту, бессонница, боль в суставах; сыпь и синдром Стивенса — Джонсона при быстром повышении дозы; можно отменять без титрации
#баклофен	5 мг 3 раза в день, повышать на 5 мг каждые 3 дня	40–80 мг	тревога, депрессия, возбуждение, неустойчивость, головная боль, седация, тремор, кожная сыпь, нечёткость зрения, сухость во рту, боль в животе; синдром отмены при слишком быстром прекращении
#габапентин	300 мг 1 раз в день, повышать на 300 мг ежедневно до 900 мг, затем на 300 мг каждые 3–5 дней	900–3600 мг	амнезия, спутанность сознания, головокружение, сонливость, депрессия, тошнота, нечёткость зрения, периферические отёки и отёки лица, запор, вздутие живота, прибавка веса
#прегабалин	75 мг 2 раза в день	600 мг	спутанность сознания, сонливость, запор, нечёткость зрения, головокружение, тошнота, периферические отёки и отёки лица, повышение аппетита, прибавка веса

Каждый из препаратов таблицы рекомендован отдельно; при непереносимости баклофена — можно #клоназепам. Пометка off-label (в КР — знак #) — применение вне инструкции.

Опиоиды для профилактического лечения **не рекомендуются**.

Дополнительно — ботулинический токсин типа А: 1,25–5 ЕД внутрикожно в триггерные точки через 15–20 мм, всего 25–100 ЕД.

Дополнительно — высокочастотная ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция.

4.2 Тригеминальная невралгия: купирование приступа

Острая боль — местные анестетики. Перед блокадой ветви — кожная проба.

Купирование приступа

Препарат	Применение
#лидокаин	10% спрей — 2 впрыскивания в носовой ход на стороне боли (частое применение повреждает слизистую из-за спирта); 5% гель на триггерную зону; 2% раствор с #эпинефрином 1:80 000 — блокада ветви; внутривенно 1,5–5 мг/кг дольше 1 часа
#ботулинический токсин типа А	50 ЕД в 1,0 мл 0,9% раствора натрия хлорида подкожно в триггерные точки

НПВП при тригеминальной невралгии **не рекомендуются**: при невропатической боли неэффективны. Если НПВП помогают — искать местное воспаление.

4.3 Тригеминальная невралгия: хроническая боль

Хроническая боль — #амитриптилин.

Хроническая боль — #дулоксетин.

Хроническая боль — #венлафаксин.

Хроническая боль при тригеминальной невралгии

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
#амитриптилин	с 5–6,25 мг вечером за полтора часа до сна, повышать на 5–6,25 мг каждые 3–5 дней	12,5–75 мг	седация, сухость во рту, затруднение мочеиспускания, запор, нечёткость зрения, диплопия, повышение внутриглазного давления, нарушение памяти, тремор, аритмия
#дулоксетин	30 мг утром 1–2 недели, затем 60 мг утром	60 мг	головокружение, сонливость или бессонница, сухость во рту, тошнота, запор, потливость, снижение массы тела
#венлафаксин	с 18,75 мг 2 раза в день во время еды, повышать на 18,75 мг каждые несколько дней; после 75 мг — на 37,5 мг	75–225 мг	тошнота, снижение аппетита, запор, снижение массы тела, артериальная гипертензия, головокружение, бессонница, парестезии, тремор, нечёткость зрения, сексуальная дисфункция, потливость, высокая вероятность синдрома отмены

Психотерапия — когнитивно-поведенческая терапия, биологическая обратная связь, релаксация, майндфулнесс: меньше тревоги, депрессии, катастрофизации боли.

4.4 Тригеминальная невралгия: малоинвазивные вмешательства

Классическая невралгия в зоне надглазничного нерва при недостаточном эффекте лечения — термическая радиочастотная абляция надглазничного нерва под КТ или УЗИ; сначала диагностическая блокада.

В зоне подглазничного нерва — импульсная и (или) термическая радиочастотная абляция подглазничного нерва под КТ после диагностической блокады.

Идиопатическая или симптоматическая невралгия, если лечение основного заболевания не помогло или невозможно, — микробаллонная компрессия гассерова узла.

Там же — термическая радиочастотная абляция тройничного нерва.

Там же — глицериновая ризотомия.

4.5 Тригеминальная невралгия: операции

Фармакорезистентность или непереносимость лечения — нейрохирургическое лечение в специализированном отделении. 25–40% пациентов выбирают операцию в первые 2 года.

Классическая невралгия — микроваскулярная декомпрессия корешка (ретросигмоидный доступ), если на МРТ конфликт со структурными изменениями корешка; **старше 75 лет** — индивидуально.

Классическая невралгия, если декомпрессия невозможна или пациент отказался, — стереотаксическая радиохирургия корешка (до **90 Гр**, предпочтительно «Гамма-нож»); повторно — **не ранее 1 года**.

Классическая невралгия без эффекта лечения — имплантация нейростимулятора после тестовой стимуляции.

Идиопатическая невралгия — стереотаксическая радиохирургия.

Идиопатическая невралгия при неэффективности других методов — частичная сенсорная ризотомия.

Идиопатическая невралгия при неэффективности других методов — имплантация нейростимулятора после тестовой стимуляции.

Невралгия при рассеянном склерозе — стереотаксическая радиохирургия; при неэффективности — медиальная таламотомия.

При рассеянном склерозе и неэффективности других методов — частичная сенсорная ризотомия.

При рассеянном склерозе с нейроваскулярным конфликтом и изменениями корешка — микроваскулярная декомпрессия. Методы равноценны; безопаснее радиохирургия и пункционные вмешательства.

При рассеянном склерозе и неэффективности других методов — имплантация нейростимулятора.

Симптоматическая невралгия — операция по поводу причины (например, удаление опухоли) с декомпрессией корешка.

Симптоматическая невралгия без регресса боли после лечения причины — стереотаксическая радиохирургия.

Там же, при неэффективности других методов — частичная сенсорная ризотомия.

Симптоматическая невралгия при неэффективности других методов — имплантация нейростимулятора.

4.6 Атипичная лицевая боль: лекарства

Персистирующая идиопатическая лицевая боль — #амитриптилин: 6,25–12,5 мг вечером, повышать на 6,25–12,5 мг каждые 3–14 дней до 10–75 мг.

Противопоказания, плохая переносимость или неэффективность трициклических антидепрессантов — #венлафаксин: 18,75 мг 2 раза в день во время еды, повышать на 18,75 мг каждые несколько дней до 75 мг.

Не подошёл и венлафаксин — #флуоксетин 20 мг 1 раз в день.

Неэффективны или непереносимы антидепрессанты — габапентин (300 мг 1 раз в день с повышением до 900–3600 мг) или прегабалин (75 мг 2 раза в день, до 600 мг).

Недостаточен эффект лекарств — ботулинический токсин типа А в область боли.

Синдром пылающего рта — #амитриптилин с минимальной дозы на ночь, в среднем 10–50 мг в сутки.

Синдром пылающего рта — габапентин.

Синдром пылающего рта — #альфа-липоевая (тиоктовая) кислота 600 мг в сутки; вместе с габапентином эффективнее.

Миофасциальная боль со спазмом — НПВП, лучше внутрь, не комбинировать, **10–14 дней**; учитывать риски со стороны ЖКТ и сердца.

Хроническая миофасциальная боль — #амитриптилин с 10 мг на ночь, до 150 мг в сутки.

Неэффективны антидепрессанты — #габапентин с 300 мг, повышать на 300 мг каждые 3 дня до 4200 мг.

Ботулинический токсин типа А в поражённые мышцы.

4.7 Атипичная лицевая боль: психотерапия и вмешательства

Персистирующая идиопатическая лицевая боль — когнитивно-поведенческая терапия.

Синдром пылающего рта — когнитивно-поведенческая терапия и психотерапия.

Миофасциальная боль — биологическая обратная связь для мышечного и психологического расслабления.

Миофасциальная боль — когнитивно-поведенческая терапия.

Персистирующая идиопатическая лицевая боль без эффекта лекарств — импульсная радиочастотная абляция крылонёбного узла после положительной блокады (подскуловой доступ).

4.8 Тригеминальная нейропатическая боль

Габапентин (300 мг 1 раз в день, повышать до 900–3600 мг) или прегабалин (75 мг 2 раза в день, до 600 мг) — отдельно или в комбинации.

#Окскарбазепин — с 300 мг, повышать на 300 мг каждые 3 дня до 1800 мг в 2 приёма.

Антидепрессанты — отдельно или в комбинации с препаратами других групп; каждый из трёх препаратов таблицы рекомендован и отдельно (A, 1).

Антидепрессанты при нейропатической боли

Препарат	Схема	Доза в сутки
#амитриптилин	с 5–6,25 мг вечером за полтора часа до сна, повышать на 5–6,25 мг каждые 3–5 дней	75 мг
#дулоксетин	30 мг утром 1–2 недели, затем 60 мг утром	60 мг
#венлафаксин	9,375–18,75 мг 2 раза в день, повышать на 9,375–18,75 мг каждые 3–7 дней	75–225 мг

Дополнительно — пластырь с 5% #лидокаином или гель с #лидокаином на область боли.

Опиоиды — третья линия из-за зависимости: тапентадол (B, 2), налоксон + оксикодон, трамадол, морфин (A, 1); доза индивидуально.

Дополнительно — #альфа-липоевая (тиоктовая) кислота 600 мг в сутки.

Психотерапия: когнитивно-поведенческая, биологическая обратная связь, релаксация, майндфулнесс.

Дополнительно — ботулинический токсин типа A в зоне боли.

Дополнительно — ритмическая ТМС 5–20 Гц, 5–10 сеансов, на моторную или дорсолатеральную префронтальную кору.

Постгерпетическая невралгия и посттравматическая боль — гипербарическая оксигенация, не менее 10 сеансов: меньше аллодинии и зуда.

Посттравматическая боль после облучения

1. **#альфа-токоферола ацетат** — выше 400 мг в сутки — вместе с ретинолом
2. **#пентоксифиллин** — 400 мг 2 раза в день 4–6 недель

Там же

1. **гипербарическая оксигенация** — не менее 10 сеансов
2. **глюкокортикоиды** — #дексаметазон 8–20 мг в сутки 3–5 дней с постепенной отменой или #преднизолон в эквивалентной дозе

Неэффективны другие методы — имплантация нейростимулятора прецентральной коры.

Постгерпетическая невралгия в зоне надглазничного нерва — импульсная или термическая радиочастотная абляция надглазничного нерва под КТ после диагностической блокады.

Постгерпетическая невралгия — имплантация системы периферической стимуляции ветвей после тестовой стимуляции.

Посттравматическая боль — имплантация нейростимулятора ветвей тройничного нерва после тестовой стимуляции.

Посттравматическая боль при неэффективности других методов — тригеминальная нуклеотрактотомия; риск неврологических осложнений.

4.9 Кластерная головная боль

Приступ — 100% кислород через маску (лучше с клапаном) **12 л/мин**, иногда 15 л/мин, **20 минут**.

Приступ — триптаны; предпочтительно золмитриптан 5–10 мг интраназально в противоположную ноздрю.

Приступ — спрей #лидокаина 4 дозы в ноздрю на стороне боли, полулёжа под 45°, голова повёрнута **на 30–40°** в сторону боли; действует около 2 часов.

Профилактика — #верапамил с **240 мг** в сутки, повышать на 80 мг каждые 3–4 дня, ЭКГ до начала и после 480 мг на каждые 160 мг; до 960 мг под наблюдением кардиолога.

На время подбора верапамила или при эпизодической форме **до 8 недель** — #преднизолон 100 мг утром 5 дней, затем снижать на 20 мг каждые 3 дня.

#Лития карбонат 353–900 мг; уровень лития 0,6–0,8 ммоль/л (не выше 1,2), контроль электролитов, почек, ТТГ, крови, ЭКГ.

#Мелатонин 10 мг.

#Топирамат с титрацией до 50–100 мг.

Тяжёлое течение до подбора лечения — блокады большого затылочного нерва анестетиком с глюкокортикоидом или без; эффект 2–4 недели.

Приступ — трансназальная блокада крылонёбного ганглия: тампон с 10% #лидокаином в носовой ход; эффект **через 30–40 минут**, **не менее 5 часов**.

Фармакорезистентная эпизодическая форма — радиочастотная абляция крылонёбного ганглия.

Фармакорезистентная хроническая форма после положительной блокады — радиочастотная абляция крылонёбного ганглия.

Фармакорезистентная хроническая форма — стимуляция затылочных нервов.

Фармакорезистентная хроническая форма — стимуляция крылонёбного ганглия.

4.10 Другие тригеминальные автономные цефалгии

Пароксизмальная гемикрания — #индометацин, до 250 мг в сутки.

SUNCT — #ламотриджин с 50 мг в сутки (при SUNA менее эффективен).

SUNCT — #габапентин с 300 мг, повышать на 300 мг каждые 3 дня, до 4200 мг.

SUNA — другие противоэпилептические средства.

Обострение SUNCT на время подбора лечения — #лидокаин внутривенно.

Гемикрания континуа — #индометацин 25 мг 3 раза в день 5–7 дней; нет эффекта — 50 мг, затем 75 мг 3 раза в день 2 недели.

4.11 Паралич Белла: лекарства

Как можно раньше, лучше в первые 72 часа, при любой тяжести — глюкокортикоиды: частота полного восстановления выше на 17%.

Дозы

1. #преднизолон внутрь **60 мг** 5 дней, затем снижать на 10 мг в сутки 5 дней;
2. или **1 мг/кг** 7–10 дней; при V–VI степени без противопоказаний — до **2 мг/кг** в сутки 10 дней;
3. всю дозу утром в 6:00–8:00 после еды или в 2 приёма в первой половине дня;
4. начало лечения **до 3 дней** и тяжесть выше IV степени — лучше однократно #метилпреднизолон **500 мг** внутривенно.

Интратимпанальное введение глюкокортикоидов **до 10 дней** вместе с системной терапией может улучшить исход, но данных пока недостаточно.

Противовирусные средства — вместе с глюкокортикоидами (в монотерапии неэффективны), на ранней стадии при тяжёлой нейропатии и (или) подтверждённой вирусной инфекции: ацикловир 800 мг 5 раз в сутки или валацикловир 1000 мг 3 раза в сутки.

Синдром Рамсея Ханта — рано глюкокортикоиды (#преднизолон или #метилпреднизолон) вместе с противовирусными, **курс 7 дней**.

Подозрение на болезнь Лайма — рано антибиотики: доксициклин, амоксициллин или цефуроксим по инструкции.

Боль в мышцах — НПВП, предпочтительно ибупрофен.

Комплекс витаминов группы В.

Неосложнённый лагофтальм — невролог сразу назначает увлажнение: днём искусственная слеза, на ночь декспантенол (гель); до нескольких раз в день и ночью.

4.12 Нейропатия лицевого нерва: ботулинотерапия

В остром периоде — в мышцы здоровой стороны при гипертонусе или высоком риске его (смещение средней линии ухудшает восстановление); в хроническом — в поражённую сторону при синкинезиях и в здоровую для симметрии. Интервал в среднем 5 месяцев; эффективнее вместе с реабилитацией. Побочно: гематома, избыточная слабость мышцы или соседних мышц (диплопия, нарушение речи).

Гипертонус мышц здоровой стороны умеренной и выраженной степени — ботулинический токсин типа А в мышцы здоровой стороны, всего **до 50 ЕД**, вместе с ЛФК.

Гипертонус поражённой стороны — инъекции с двух сторон, всего **до 100 ЕД**, вместе с ЛФК.

Постпаралитический гемиспазм умеренной и выраженной степени — инъекции с двух сторон, **до 100 ЕД**, вместе с ЛФК.

Поражение краевой нижнечелюстной ветви — в мышцу, опускающую нижнюю губу, на здоровой стороне: 5 ЕД в одну точку или по 2 ЕД в 2 точки.

4.13 Нейропатия лицевого нерва: операции

Метод выбирают по сроку, уровню, причине и тяжести поражения.

1. **патогенетическое лечение идиопатической формы** — декомпрессия нерва в канале височной кости — только при V–VI степени и разнице М-ответа более 90% с отсутствием потенциалов двигательных единиц
2. **симптоматическое лечение при любой форме** — реиннервирующая операция (**до 2 лет**, оптимально **до 18 месяцев**) или реконструктивно-пластическая; реиннервация — если нет динамики **6 месяцев**

Симптоматическое хирургическое лечение

Пациенты	Операция	Цель
тяжёлая нейропатия до 18 месяцев	реиннервирующие операции	восстановить функцию собственных мимических мышц
тяжёлая нейропатия более 18 месяцев	реконструктивно-пластические (аутотрансплантация мышцы)	заместить атрофированные мышцы
постпаралитический гемиспазм	селективная невротомия, нейрорафия, невролиз	естественная улыбка за счёт разобщения движений
лагофтальм	нейропластические, динамические и статические методы	восстановить или имитировать функцию круговой мышцы глаза

Паралич Белла тяжёлой степени — невролиз и декомпрессия лабиринтного сегмента лицевого нерва.

Сроки

1. лучше **в первые 14 дней**, через среднюю черепную ямку;
2. возможно **до 3 месяцев**;
3. при положительной динамике не оперируют.

Перед декомпрессией — КТ височной кости: ориентиры пирамиды, планирование доступа.

Перед декомпрессией — тональная аудиометрия: риск потери слуха на стороне операции **2–5%**.

Тяжёлая нейропатия **после 3 месяцев и до 2 лет** (лучше до 18 месяцев) — реиннервирующая операция (нейрорафия).

Тяжёлая нейропатия **более 2 лет** — реконструктивно-пластическая операция: свободная пересадка или перемещение мышц.

Выраженный постпаралитический гемиспазм — невролиз, нейрорафия, невротомия или миотомия; тщательный отбор из-за риска слабости мышц.

1. **интракраниальное повреждение до 2 лет** — нейрорафия XII–VII «бок в конец» со вставкой из большого ушного нерва или «конец в конец» с челюстно-подъязычной или жевательной ветвью (C, 4)
2. **нет симметричных синхронных движений** — нейрорафия XII–VII «конец в конец» с икроножным нервом, в том числе по типу мионевротизации (C, 4)
3. **экстракраниальное повреждение с сохранением ствола и ветвей до 2 лет** — нейрорафия XII–VII «бок в конец» с большим ушным нервом, «конец в конец» с жевательной ветвью или анастомоз V–VII с челюстно-подъязычной ветвью (в КР — «СВ», 4)

1. **экстракраниальное без сохранения ствола и ветвей до 2 лет** — ревизия со вставками из большого ушного и (или) икроножного нерва или нейрорафия XII–VII, V–VII со вставками (C, 4)
2. **интракраниальное более 2 лет с атрофией** — пересадка или перемещение мышц с реиннервацией жевательной ветвью и кросс-пластикой (C, 4); если невозможно — статическая коррекция фасцией (C, 4) или нитями

1. **интракраниальное повреждение** — нейрорафии XII–VII «бок в бок», V–VII «конец в бок», VII–VII «конец в бок» с икроножным нервом или с мионевротизацией (C, 4)
2. **экстракраниальное повреждение** — ревизия ствола и ветвей, нейрорафии, вставки, кросс-пластика (C, 4)

1. **контрактуры здоровой стороны** — селективная миотомия или нейротомия на здоровой стороне с мониторингом нерва, нейрорафия VII–VII (C, 4)
2. **контрактуры и синкинезии поражённой стороны** — нейрорафия VII–VII, селективная нейротомия, миотомия (C, 4)
3. **птоз тканей** — статическая коррекция фасцией или круговая подтяжка лица (C, 4)

Паралитический лагофтальм **более 2 лет** — устранение ретракции верхнего века и лагофтальма: золотой грузик в верхнее веко, кожно-хрящевой лоскут с ушной раковины, кантопексия, блефарорафия.

4.14 Гемифациальный спазм

Лечение первой линии — ботулинический токсин типа А с двух сторон, всего до 100 ЕД, лучше на ранних этапах.

Мишени

1. круговая мышца глаза;
2. щёчная мышца;
3. подкожная мышца шеи.

Улучшение у 76–100% в течение 7 дней, эффект **до 90 дней**, интервал **от 3 месяцев**.

Возврат спазма после васкулярной декомпрессии — ботулинический токсин, до 100 ЕД.

Нет показаний к операции, противопоказания, отказ или неэффективна ботулинотерапия — препараты

1. #карбамазепин 400–1200 мг в сутки;
2. #габапентин 600–1200 мг;
3. #клоназепам 0,5–4 мг, #диазепам и #лоразепам — в эквивалентных дозах;
4. #баклофен 15–80 мг;
5. #леветирацетам 500–1500 мг;
6. #зонисамид 150 мг 2 раза в сутки 6 недель.

Эффективность не доказана, частая седация и утомляемость.

Первичный спазм с нейроваскулярным конфликтом на МРТ — микроваскулярная декомпрессия корешка лицевого нерва; излечение **более 90%** за год.

При декомпрессии — интраоперационный мониторинг Lateral Spread Recording.

Операция не показана, противопоказана, отказ или неэффективны другие методы — радиохирургия лицевого нерва перед внутренним слуховым отверстием: 8 Гр однократно или 15 Гр за 5 фракций.

4.15 Лицевая миокимия

Первичная миокимия — покой, меньше кофеина, устранить провоцирующие факторы (курение, алкоголь); проходит за дни — недели. Вторичная — лечение причины.

Миокимия **более 3 месяцев** — сначала исключить другие причины, затем ботулинический токсин 5–20 ЕД в мышцу с гиперкинезом.

4.16 Невралгия языкоглоточного нерва

Три подхода, как при тригеминальной невралгии: консервативный, малоинвазивный, хирургический. Начинать с монотерапии, препараты добавлять поочерёдно.

#Карбамазепин — по правилам дозирования при тригеминальной невралгии, 100–2000 мг в сутки.

#Окскарбазепин — с 300 мг, постепенно до 1200 мг в сутки.

#Габапентин — по правилам при тригеминальной невралгии, 100–5000 мг в сутки.

Дополнительно — ботулинический токсин типа А по 1,25–5 ЕД внутрикожно в перикраниальные мышцы и мышцы шеи, всего 25–100 ЕД.

Импульсная радиочастотная абляция языкоглоточного нерва под КТ или УЗИ.

Блокада языкоглоточного нерва в проекции шиловидного отростка под КТ или УЗИ.

Фармакорезистентная первичная невралгия — микроваскулярная декомпрессия корешка в нейрохирургическом центре.

Декомпрессия невозможна или отказ — радиохирургия корешка (предпочтительно «Гамма-нож»).

Декомпрессия невозможна — частичная сенсорная ризотомия.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Реабилитация при нейропатии лицевого нерва

Медицинская реабилитация в остром и хроническом периоде: массаж лица, растяжение и расслабление, укрепление мышц лица и шеи, нервно-мышечное переобучение, биологическая обратная связь.

Тяжёлая нейропатия (V–VI степень): лечение положением (пластырь, кинезиотейп), массаж, пассивные упражнения. Лёгкая и умеренная (до IV степени): массаж, активные упражнения с дозированной симметричной нагрузкой. Пациенту объясняют: **избегать тепла, «грубого» массажа, электростимуляции, активной мимики** и упражнений с максимальной амплитудой.

Тяжёлая нейропатия — кинезиотейп на поражённую сторону: не дать мышцам перерастянуться, восстановить симметрию.

Тяжёлая нейропатия — пассивные упражнения; умеренная и лёгкая (IV степень и меньше) — активные с дозированным сокращением. **Активная ЛФК при тяжёлой нейропатии не рекомендуется**: здоровая сторона берёт гиперфункцию и смещает среднюю линию.

Комплекс упражнений для самостоятельного выполнения.

Биологическая обратная связь — зеркало (или миография).

Гипертонус здоровой стороны или риск его в остром периоде — упражнения на растяжение и расслабление мышц здоровой стороны.

Гипертонус и (или) синкинезии на поражённой стороне — растяжение и расслабление с двух сторон; синкинезии появляются **с 3-го месяца**.

Контроль домашней самореабилитации; обучение — на первичном приёме невролога.

Неосложнённый лагофтальм — днём пластырь или кинезиотейп на верхнее веко, подтягивание нижнего века при эктропионе; на ночь окклюзия глаза при несмыкании **более 4 мм**.

Неосложнённый лагофтальм — упражнения для баланса круговой мышцы глаза и леватора верхнего века.

Изолированное поражение краевой нижнечелюстной ветви — упражнения для мышцы, опускающей нижнюю губу, 2–3 раза в день перед зеркалом; при благоприятном прогнозе симметрия за 4–5 месяцев.

Дополнительно к стандартному лечению — иглорефлексотерапия, эффективнее в остром периоде.

Форсированные упражнения **не рекомендуются**: укорачивают мышечные волокна, повышают риск синкинезий.

Электростимуляция мышц **не рекомендуется**: по тем же причинам.

Гипербарическая оксигенация.

Лазерная физиотерапия (низко- и высокоинтенсивная) челюстно-лицевой области.

5.2 Диспансерное наблюдение

Сохраняются симптомы нейропатии лицевого нерва или гемифациального спазма — наблюдение невролога.

Сохраняется лицевая миокимия — наблюдение невролога.

5.3 Показания к госпитализации

Нейропатия лицевого нерва — экстренно

1. первые 72 часа — для внутривенного #метилпреднизолона в высокой дозе;
2. другие неврологические симптомы: слабость или онемение конечностей, головокружение, нарушение глотания;
3. ухудшение с нарушением сознания, лихорадкой, менингеальными симптомами;
4. декомпенсация давления или сахара, беременность.

Планово

1. операция.

Выписка

1. диагноз установлен;
2. состояние стабилизировано.

Тригеминальная невралгия — экстренно

1. впервые сильная боль в зоне глазничной ветви с вегетативными симптомами (отёк век, гиперемия склеры, потливость лба, изменение зрачка, слезотечение, ринорея или заложенность носа) — исключить патологию кавернозного синуса;
2. другие очаговые неврологические симптомы;
3. некупируемая боль.

Планово

1. малоинвазивные вмешательства и операции.

Выписка

1. диагноз установлен, боль уменьшилась, состояние стабильно.

Атипичная лицевая боль и автономные цефалгии — экстренно

1. нарушение сознания;
2. лихорадка и менингеальные симптомы;
3. нарастающая очаговая или общемозговая симптоматика;
4. некупируемая кластерная головная боль — для ингаляций кислорода.

Планово

1. нарастающая боль;
2. резистентная боль — ботулинотерапия или вмешательства (возможно в дневном стационаре).

Выписка

1. снижение интенсивности боли.

Тригеминальная нейропатическая боль: экстренно — подозрение на связь с Herpes zoster у пожилых, при иммунодефиците и онкологических заболеваниях; планово — вмешательства и операции.

1. **гемифациальный спазм** — планово — для операции
2. **лицевая миокимия** — амбулаторно
3. **другие черепные нервы** — экстренных показаний нет; планово — для вмешательств и операций

5.4 Исход

Полное восстановление — от **61%** при тотальной прозоплегии до **94%** при более лёгком парезе.

Осмотр не всегда отражает истинную тяжесть: при V–VI степени ЭНМГ обязательна; асимметрия М-ответа **более 90%** хотя бы по одной ветви — неблагоприятный прогноз. Гипертонус здоровой стороны — у 68,5% в первые 3 месяца, он ограничивает восстановление.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Краниальные мононейропатии у взрослых»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	895_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Союз реабилитологов России; Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии; Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии; Ассоциация интервенционного лечения боли
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки реконструктивно-пластической операции при нейропатии лицевого нерва расходятся: в таблице 21 и разделе 2.5 — после 18 месяцев, в рекомендации раздела 3.2.1 — после 2 лет.
- Гемифациальный спазм в разделе 1.5 назван «первичный (симптоматический)», а в разделе 1.2 первичный спазм — от сдавления сосудом, симптоматический — вторичный.
- В разделе 2.3 рекомендация об анализах при гемифациальном спазме адресована «всем пациентам с НЛН»; в разделе 2.5.3 (другие черепные нервы) рекомендации о психиатре и нейрохирурге говорят о тригеминальной невралгии.
- У одной рекомендации о реиннервирующей операции (раздел 3.2.1) уровень убедительности указан как «СВ».
- Код G52.2 (поражения блуждающего нерва) есть в каталоге рубрикатора, но не в разделе 1.4 КР.

Клинические рекомендации

Круп, эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J05.0** — Острый обструктивный ларингит [круп] **J05.1** — Острый эпиглоттит **J38.4** — Отек гортани **J38.6** — Стеноз гортани
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/352_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Круп (острый обструктивный ларингит): воспаление гортани и подскладочного пространства с сужением просвета; вирусный, до 80% — парагрипп; чаще дети **от 6 месяцев до 6 лет**. Эпиглоттит: острое бактериальное воспаление надгортанника (Haemophilus influenzae типа b), угрожает быстрой асфиксией.
- Круп: всем — кортикостероиды (#дексаметазон однократно или будесонид ингаляционно). Антибиотики и паровые ингаляции не назначают. При тяжёлом крупе — ингаляция #эпинефрина, при сатурации **92% и ниже** — кислород, при стенозе IV степени — интубация.
- Эпиглоттит: экстренная госпитализация в отделение с возможностью интубации, только сидя, ранняя интубация, обязательно антибиотик внутривенно. Ротоглотку осматривают только в операционной в готовности к интубации; ингаляции, седация и беспокойство ребёнка запрещены.
- Госпитализация при крупе:
  1. стеноз гортани II–III степени;
  2. невозможность адекватного лечения дома;
  3. прогрессирующее ухудшение.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. острый обструктивный ларингит (круп): воспаление гортани и тканей подскладочного пространства с сужением просвета гортани; прежние названия — «стенозирующий ларинготрахеит», «ложный круп»;
2. эпиглоттит: остро возникшее бактериальное воспаление надгортанника и окружающих тканей, может быстро привести к жизнеугрожающему нарушению проходимости дыхательных путей.

2.2 Этиология

1. круп: респираторные вирусы, до 80% — вирус парагриппа; также грипп A и B, аденовирусы, PCB, риновирусы и другие; бактерии (Mycoplasma pneumoniae) — крайне редко;
2. постинтубационный отёк: давление эндотрахеальной трубки — отёк, изъязвления, грануляции, ограничение подвижности голосовых складок; сужение в первые 24 часа после экстубации; у половины требуется реинтубация;

Эпиглоттит

1. Haemophilus influenzae типа b: более 90%;
2. у привитых детей редок, при массовой вакцинации чаще у взрослых;
3. реже пневмококк, стрептококки групп A и C, золотистый стафилококк, Moraxella catarrhalis и другие.

2.3 Степени стеноза гортани

Степени стеноза гортани по В. Ф. Ундрицу (1969)

Степень	Клинические проявления
I (стадия компенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, умеренная одышка
II (стадия неполной компенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, выраженная одышка, возбуждение, дыхание с участием вспомогательной мускулатуры, втяжение податливых мест грудной клетки, раздувание крыльев носа, цианоз носогубного треугольника, тахикардия

Степень	Клинические проявления
III (стадия декомпенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, беспокойство, страх, возможна апатия, резкая одышка с выраженным втяжением податливых мест грудной клетки, бледность, акроцианоз
IV (терминальная стадия, асфиксия)	Сознание отсутствует, резкая бледность и цианоз, гипотермия, возможны судороги, мидриаз, частое поверхностное дыхание, артериальная гипотензия, нитевидный пульс; предшествует остановке дыхания и сердца

Шкала тяжести крупа Westley

Признак	Баллы
Стридор	отсутствует: 0 при возбуждении: 1 в покое: 2
Втяжение уступчивых мест грудной клетки	отсутствует: 0 лёгкое: 1 умеренно выраженное: 2 резко выраженное: 3
Проходимость дыхательных путей	нормальная: 0 нарушена умеренно: 1 значительно снижена: 2
Цианоз	отсутствует: 0 при двигательной активности: 4 в покое: 5
Сознание	без изменений: 0 нарушения сознания: 5

Оценка суммы баллов

1. лёгкий круп: **2 и менее**;
2. среднетяжёлый: **3–7**;
3. тяжёлый: **8 и более**;
4. угроза остановки дыхания: **12 и более**.

За рубежом используют также классификацию по степени тяжести: лёгкий, среднетяжёлый, тяжёлый и терминальный круп по лающему кашлю, стридору, втяжению межрёберий, возбуждению или сонливости и цианозу.

2.4 Клиническая картина

Круп

Начало

1. признаки ОРВИ: ринорея, першение в горле, кашель;
2. чаще невысокая температура;
3. перед стенозом — осиплость и (или) сухой грубый кашель, затем лающий кашель и шумный вдох (стридор);
4. симптомы обычно вечером, ночью, под утро.

По степени стеноза

1. I: периодический лающий кашель, осиплость; в покое стридора нет, появляется при беспокойстве или нагрузке;
2. II: кашель чаще, стридор и в покое, выраженное втяжение уступчивых мест грудной клетки;
3. III: выраженная дыхательная недостаточность, беспокойство или угнетение сознания — нужна экстренная помощь;
4. IV: асфиксия.

Более 2/3 обращаются со стенозом I степени, тяжёлый стеноз — менее чем у 1% детей; симптомы обычно купируются **за 48 часов**.

Постинтубационный отёк гортани: отёк начинается вскоре после интубации, симптомы — после удаления трубки.

1. лёгкие: боль в горле, дисфония, затруднение глотания;
2. стридор — клинически значимая обструкция; стридор и дыхательная недостаточность при сужении более половины просвета;
3. обычно в первые минуты и часы после экстубации, описано и через **48–72 часа**;
4. в среднем симптомы купируются **через 72 часа**, у большинства спонтанно **за 24–48 часов**.

Безопасного верхнего предела длительности интубации у детей нет.

Эпиглоттит: тяжёлая бактериальная инфекция.

1. острое начало с высокой температуры и нарушения общего состояния;
2. боль в горле, тризм, слюнотечение, поза «треножника», приоткрытый рот;
3. быстро нарастающий стридор, западение надгортанника в положении на спине;
4. типичного для крупа лающего кашля нет.

Факторы риска постинтубационного отёка

Связанные с интубацией

1. трудная интубация в анамнезе;
2. большой размер трубки;
3. подвижность трубки;
4. интубация у детей более недели;
5. ИВЛ 48 часов у детей до 12 месяцев;
6. экстренная интубация вне стационара.

После интубации

1. длительная интубация;
2. высокое давление в манжете;
3. возбуждение пациента;
4. самоэкстубация и реинтубация;
5. агрессивная аспирация слизи из трахеи.

Пациент и операция

1. операции на голове и шее, положение лёжа на животе при нейрохирургических операциях;
2. беременность, инфузионная терапия;
3. повреждения шеи и дыхательных путей, ингаляционные повреждения и ожоги;
4. низкий балл по шкале Глазго, лечение без седации;
5. женский пол, индекс массы тела более 26,5, гастроэзофагеальный рефлюкс, узкая гортань;
6. малый гестационный возраст, низкая масса тела при рождении, детский возраст.

---

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. круп: клинический диагноз — анамнез, осиплость голоса, лающий кашель, инспираторный стридор;
2. эпиглоттит: характерные клинические признаки (см. «Клиническая картина»);
3. постинтубационный отёк: боль в горле, дисфония, затруднение глотания, стридор после экстубации; инструментально — УЗИ гортани у интубированных, у взрослых также тест на герметичность манжеты.

Ротоглотку ребёнка с подозрением на эпиглоттит осматривают только в операционной в полной готовности к интубации: высок риск рефлекторного спазма гортани и асфиксии.

При крупе и эпиглоттите уточняют вакцинацию против гемофильной, пневмококковой инфекции и дифтерии.

3.1 Осмотр

Признаки респираторного дистресса

1. цианоз;
2. участие вспомогательной мускулатуры;
3. втяжение яремной ямки и межрёберных промежутков;
4. частота дыхания;
5. сатурация.

Аускультативно уточняют характер одышки: при крупе инспираторная; экспираторная или смешанная — при сопутствующей бронхиальной обструкции или тяжёлом крупе.

3.2 Пульсоксиметрия

Показания

1. круп и эпиглоттит: оценка дыхательной недостаточности, необходимости кислорода, динамики.

3.3 Общий анализ крови и С-реактивный белок

Показания

1. круп: только при высокой лихорадке, когда нужно исключить бактериальную инфекцию; в стационаре общий анализ крови всем, СРБ по необходимости.

Показания

1. подозрение на эпиглоттит, высокая лихорадка: развёрнутый общий анализ крови, при необходимости СРБ.

Для эпиглоттита характерны лейкоцитоз **более 15×10^9/л** и повышенный СРБ. Анализы берут, только когда это безопасно, иногда лишь после интубации.

3.4 Посев с надгортанника и посев крови

Показания

1. эпиглоттит, селективно: этиологическая диагностика с определением чувствительности.

Берут после восстановления проходимости дыхательных путей; посев с надгортанника у неинтубированного пациента противопоказан.

3.5 Рентгенография мягких тканей шеи

При крупе рутинно не проводят: неспецифична и малоинформативна.

Показания

1. сомнительные случаи эпиглоттита со стёртой симптоматикой: боковая проекция.

Диагностические признаки

1. отёк надгортанника — симптом «большого пальца».

Любое исследование при подозрении на эпиглоттит может спровоцировать обструкцию дыхательных путей.

3.6 УЗИ гортани и фиброларингоскопия перед экстубацией

Показания

1. интубированные взрослые и дети, селективно: проходимость верхних дыхательных путей перед экстубацией.

Измеряют ширину воздушного столба на уровне складок до и после сдувания манжеты; её уменьшение предсказывает постэкстубационный стридор, точность метода окончательно не установлена.

Фиброларингоскопия перед экстубацией при наличии ресурсов — пациентам с факторами риска, прежде всего после трудной интубации или со стридором и дисфонией через 48–72 часа. Подсвязочное пространство не видно, а стенозы обычно подсвязочные.

Показания

1. взрослые перед экстубацией: тест на герметичность манжеты (утечка воздуха при сдутой манжете).

У детей прогностическая ценность низкая, широко не применяется.

3.7 Дифференциальная диагностика

Круп и эпиглоттит дифференцируют между собой и с другими причинами обструкции верхних дыхательных путей. Эпиглоттиту не свойственны катаральные явления, кашель и осиплость. Уточняют атопию, эпизоды бронхообструкции или стеноза, признаки гастроэзофагеального рефлюкса.

Круп и эпиглоттит: клинические различия

Признак	Круп	Эпиглоттит
Возраст	6 месяцев – 3 года	старше 3 лет
Развитие стридора	постепенное (24–72 ч)	быстрое (8–12 ч)
Симптомы	катаральный продром, грубый лающий кашель, осиплость, грубый инспираторный стридор, редко шум на выдохе; боли в горле нет или умеренная	умеренный ринит, несильный кашель, приглушённый, но не осиплый голос, умеренный стридор, усиливается лёжа на спине, низкий звук на выдохе; боль в горле; «опасные» признаки: гиперсаливация, тризм
Лихорадка и интоксикация	чаще субфебрилитет, интоксикации нет	температура выше 39 °C, выраженная интоксикация и недомогание
Рентгенография	сужение дыхательных путей	отёк надгортанника, симптом «большого пальца»

Другие состояния, сходные с крупом

1. паратонзиллярный абсцесс;
2. заглоточный абсцесс;
3. ангиоотёк.

Также аспирация инородного тела (чаще до 3 лет), химический и термический ожог дыхательных путей, эпиглоттит, дифтерийный (истинный) круп, бактериальный трахеит, гемангиома, аномалии верхних дыхательных путей.

Новообразования; увулит, который может сопутствовать эпиглоттиту. При врождённом стридоре, подскладочной гемангиоме, парезах, ларингомаляции затруднение вдоха усиливается на фоне ОРВИ и имитирует острый стеноз.

Постэкстубационный стридор дифференцируют с

1. ларингоспазмом;
2. ангионевротическим отёком, анафилаксией;
3. инородным телом дыхательных путей;
4. послеоперационной гематомой со сдавлением дыхательных путей;
5. парезом голосовых складок после операций на шее;
6. апноэ сна.

---

4. Лечение

4.1 Круп

Антибиотики при крупе не назначают: неэффективны.

Показания

1. все пациенты с крупом: ингаляционный будесонид и (или) системные кортикостероиды (#дексаметазон, #преднизолон).

Обычно достаточно однократного введения; детям **старше 3 лет** предпочтителен приём внутрь, он так же эффективен, как парентеральный. Повторное введение, как правило, не нужно.

1. #дексаметазон: 0,15–0,6 мг/кг внутримышечно или внутривенно при любой степени стеноза; внутрь предпочтительно 0,15 мг/кг;
2. нет дексаметазона: #преднизолон в эквивалентной дозе (1 или 2 мг/кг соответствуют 0,15 и 0,6 мг/кг дексаметазона); после преднизолона выше риск повторных симптомов.

1. будесонид, суспензия через компрессорный или мэш-небулайзер: 2 мг в сутки однократно или по 1 мг дважды с интервалом 30 минут;
2. в 85% случаев (обычно при стенозе I степени) достаточно одной ингаляции.

Системные кортикостероиды, по ряду данных, эффективнее ингаляционных: беспокойство ребёнка мешает ингаляции.

Будесонид к #дексаметазону рутинно не добавляют: дополнительного эффекта нет.

Показания

1. тяжёлый круп или нет кортикостероидов: ингаляция #эпинефрина.

Доза

1. раствор 1:1000, 5 мл на ингаляцию независимо от возраста и массы.

Эффект быстрый, но нестойкий (**не более 2 часов**): в монотерапии не применяют. Применение у детей — вне инструкции, по решению врачебной комиссии с информированным согласием.

Показания

1. круп гриппозной этиологии: ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир **с 1 года**, занамивир **с 5 лет**.

Других этиотропных средств против вирусов крупа нет.

Паровые ингаляции не рекомендуются: эффективность низкая.

Сатурация **92% и ниже**: оксигенотерапия.

Стеноз гортани IV степени: неотложная интубация; при III степени — рассмотреть интубацию.

4.2 Эпиглоттит

Пациента не укладывают: только сидя, в том числе при транспортировке.

Ранняя интубация трахеи для профилактики внезапной асфиксии. Экстубация безопасна после нормализации температуры, прояснения сознания и стихания симптомов, обычно **через 24–48 часов**. В редких нетяжёлых случаях интубация может не понадобиться.

Категорически нельзя: ингаляции, снотворные и седативные средства, провоцирование беспокойства — риск рефлекторного ларингоспазма.

Показания

1. все пациенты с эпиглоттитом: системный антибиотик внутривенно.

Препараты и дозы

1. цефотаксим по инструкции или цефтриаксон: дети от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг в сутки, оптимально 75 мг/кг в сутки; масса более 50 кг и старше 12 лет — дозы для взрослых;
2. в монотерапии или с антистафилококковым препаратом, например #ванкомицином 40 мг/кг в сутки;
3. неэффективность (вероятен S. aureus): клиндамицин 30 мг/кг в сутки внутривенно (по инструкции с 3 лет) или ванкомицин 40 мг/кг в сутки;
4. взрослые: те же препараты по инструкции, ванкомицин в средней дозе 40 мг/кг в сутки.

Длительность **7–10 дней**: сначала внутривенно, после снижения температуры и восстановления питья — внутрь: амоксициллин + клавулановая кислота, цефуроксим и другие цефалоспорины II–III поколения. Макролиды при эпиглоттите не применяют.

Сатурация **ниже 92%**: оксигенотерапия.

4.3 Постэкстубационный отёк гортани

Показания

1. симптомы постэкстубационного отёка у взрослых и детей: системные глюкокортикоиды внутривенно.

Дозы

1. дексаметазон: взрослым 5 мг на введение; детям в среднем 0,6 мг/кг в сутки;
2. метилпреднизолон: взрослым 20–40 мг;
3. #преднизолон: детям в среднем 1 мг/кг в сутки (от менее 1 до 2 мг/кг в сутки);
4. длительность **не менее 48 часов**.

Дополнительно, селективно

1. #эпинефрин ингаляционно: взрослым 1000 мкг в 5 мл 0,9% натрия хлорида; детям 1% раствор 0,25 мл в 2 мл 0,9% натрия хлорида или 0,5 мл, 2,5 мл, максимально 5 мл;
2. #будесонид небулайзером: взрослым и детям 1000 мкг 2 раза в сутки.

Возможны и более низкие дозы эпинефрина: после экстубации причина отёка устранена.

Нет улучшения **в течение часа** консервативной терапии: реинтубация, не прерывая лечения.

Профилактика у пациентов с риском отёка (селективно)

1. взрослые: #метилпреднизолон 40 мг внутривенно за 24 ч до экстубации, или 40 мг 4 раза за 24 ч, или 20 мг 3 раза за 12 ч, или 40 мг за 4 ч; либо #дексаметазон 8 мг внутривенно за 1 ч или 5 мг 4 раза за 48 ч до экстубации;
2. дети: #дексаметазон 0,5 мг/кг на дозу каждые 6 часов в течение 24 ч до экстубации;
3. недоношенные новорождённые: 0,25 мг/кг, 4 дозы с интервалом 6 часов.

Наиболее эффективно введение **за 12–24 часа** до экстубации, далее при показаниях 24–48 часов после неё; у детей раннее введение (за 6–12 часов) важнее дозы.

Системные глюкокортикоиды с профилактической целью — пациентам с риском постэкстубационного отёка, у взрослых, например, при отрицательном тесте утечки воздуха, не менее чем за 4 часа до экстубации.

4.4 Стеноз гортани вследствие отёка и хирургическое лечение

Стеноз гортани любого возраста: консервативная дестенозирующая терапия — парентерально глюкокортикоиды и петлевые диуретики.

Асфиксия при невозможности интубации у ребёнка с крупом и пациента с эпиглоттитом: трахеотомия с временной трахеостомой или коникотомия. В неосложнённых случаях хирургическое лечение не требуется.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Круп: дети с суммой баллов по шкале Westley **1–2**, как правило, не нуждаются в госпитализации; эффект ингаляции будесонида или инъекции #дексаметазона дома или амбулаторно позволяет обойтись без неё.

Показания к госпитализации

1. стеноз гортани II–III степени;
2. невозможность адекватной терапии дома;
3. прогрессирующее ухудшение состояния.

Госпитализируют в инфекционный стационар или боксированное отделение. Выписка после купирования стеноза, нормализации температуры и сатурации; в среднем **1–2 дня**.

Родителей детей с рецидивирующим крупом обучают и составляют план действий: при симптомах нового эпизода — ингаляция будесонида или #дексаметазон (#преднизолон) внутримышечно.

Эпиглоттит: обязательная экстренная госпитализация, обычно бригадой скорой помощи, в отделение с интенсивной терапией и возможностью интубации.

Любые болезненные или неприятные пациенту манипуляции — инъекции, инфузии, иногда даже ингаляции — могут вызвать асфиксию. В стационаре в среднем **3–5 дней**.

Выписка

1. купирование стеноза;
2. нормальная температура и сатурация;
3. самостоятельный приём пищи и жидкости, аппетит.

5.2 Профилактика

Круп

1. гигиена: мытьё рук после контакта с больным, маски, обработка поверхностей и инструментов, изоляция заболевших детей, проветривание;
2. вакцинация от сезонного гриппа всем детям без противопоказаний.

Вакцинация от гриппа снижает риск крупа, вызванного вирусами гриппа.

Эпиглоттит: вакцинация против гемофильной инфекции всем детям без противопоказаний. Диспансерное наблюдение при крупе и эпиглоттите не требуется; медицинская реабилитация не требуется.

Исход крупа при своевременной диагностике и адекватном лечении благоприятный; при поздней диагностике со стенозом III–IV степени и невозможности интубации или трахеостомии возможна смерть от асфиксии. Прогноз эпиглоттита всегда серьёзный, своевременное лечение обеспечивает выздоровление.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый обструктивный ларингит [круп], эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани»

Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 14.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	352_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; МАКМАХ; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Мастоидит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H70** — Мастоидит и родственные состояния
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.09.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/311_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Мастоидит представляет собой деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной основы ячеистой структуры сосцевидного отростка. При остром мастоидите изменения существуют **не более 1 месяца**, при хроническом (латентном) **более 1 месяца**.
- Критерии диагноза:
  1. боль в ухе и заушной области, головная боль, недомогание, лихорадка;
  2. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости в анамнезе;
  3. оттопыренность ушной раковины, гиперемия и пастозность заушной области, болезненность при пальпации и перкуссии сосцевидного отростка;
  4. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода при отоскопии;
  5. нарушение пневматизации среднего уха и костная деструкция по данным компьютерной томографии (КТ) височной кости.
- Каждый пациент с мастоидитом, независимо от этиологии и стадии процесса, подлежит экстренной госпитализации в оториноларингологический стационар.
- Антибактериальную терапию начинают сразу после постановки диагноза, не дожидаясь результатов посева, препараты вводят парентерально:
  1. амоксициллин + клавулановая кислота;
  2. цефотаксим;
  3. цефтриаксон.
- Хирургическое лечение выполняют в экстренном порядке:
  1. первый этап при целой барабанной перепонке: парацентез или шунтирование и дренирование барабанной полости;
  2. второй этап при отсутствии положительной динамики **в течение 48–72 часов**: антромастоидотомия.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Мастоидит представляет собой деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной основы ячеистой структуры сосцевидного отростка. Первичный мастоидит развивается без предшествующего среднего отита, вторичный является осложнением среднего отита.

Антритом (отоантритом) называют деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной ткани пещеры сосцевидного отростка, осложняющее острый средний отит у новорождённых и детей грудного возраста.

2.2 Классификация

Мастоидит классифицируют по преимущественной локализации воспалительного процесса в отростке и по клиническому течению.

1. Острый мастоидит: воспалительно-деструктивные изменения в ячеистой структуре сосцевидного отростка существуют **не более 1 месяца**.
2. Хронический (латентный) мастоидит: изменения сохраняются **более 1 месяца** и чаще связаны с хроническим гнойным средним отитом или затянувшимся острым средним отитом.

2.3 Клиническая картина

Общие симптомы

1. ухудшение общего состояния;
2. повышение температуры тела;
3. у детей вялость, сонливость, капризность, снижение аппетита.

Местные симптомы

1. нарастающая боль в ухе с иррадиацией в висок и затылок;
2. усиление гноетечения из уха (при блоке входа в пещеру может отсутствовать);
3. болезненность при надавливании на сосцевидный отросток;
4. оттопыренность ушной раковины;
5. гиперемия и пастозность заушной области;
6. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода;
7. снижение слуха.

Лабораторные изменения

1. лейкоцитоз;
2. выраженное повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ);
3. нарастание С-реактивного белка (СРБ).

Лабораторные изменения неспецифичны для мастоидита, но дополняют клиническую картину.

2.4 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. повышение температуры тела, ухудшение общего состояния;
2. снижение слуха;
3. головная боль;
4. боль в ухе и заушной области;
5. оттопыренность ушной раковины, припухлость и покраснение кожи за ухом;
6. у детей вялость, сонливость, капризность, снижение аппетита.

Анамнез

1. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости.

При хроническом мастоидите общее состояние может не страдать: беспокоят интермиттирующие спонтанные боли, особенно ночью, возможно снижение слуха.

2.5 Физикальное обследование

Отоскопия

1. сужение наружного слухового прохода за счёт нависания задневерхней стенки, гиперемия кожи нависающей части;
2. гиперемия, инфильтрация и выбухание барабанной перепонки;
3. при перфорации профузное гноетечение и пульсирующий рефлекс; при блоке входа в пещеру гноетечения может не быть.

Заушная область

1. пастозность мягких тканей и гиперемия кожи над сосцевидным отростком;
2. сглаженность складки у места прикрепления ушной раковины;
3. оттопыренность ушной раковины.

Следует оценить симметричность лица и функцию мимических мышц: при остром мастоидите возможен парез лицевого нерва.

2.6 Атипичные формы

Зигоматицит: отёк мягких тканей в проекции скулового отростка с распространением на щёку и веко.

Петрозит проявляется триадой Градениго:

1. ретроорбитальная боль (раздражение первой ветви тройничного нерва);
2. диплопия вследствие пареза отводящего нерва на стороне поражения;
3. симптомы воспаления среднего уха.

Мастоидит Бецольда проявляется кривошеей в больную сторону, отёком кожи и болезненностью по ходу грудино-ключично-сосцевидной, двубрюшной, ремённой мышц и длиннейшей мышцы головы.

При мастоидите Орлеанского вокруг места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы формируется инфильтрат: гной прорывается на наружную поверхность верхушки отростка без образования абсцесса. Повороты головы болезненны, но кривошеи нет, а надавливание на инфильтрат не усиливает гноетечение из уха.

Мастоидит Чителли представляет собой поражение угловых ячеек сосцевидного отростка с тромбозом сигмовидного синуса. Повороты головы болезненны, пальпация заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы вызывает боль, верхушка отростка при пальпации свободна.

При мастоидите Муре гной с верхушки сосцевидного отростка прорывается в ткани шеи и парафарингеальное пространство. Характерны дисфония, ощущение инородного тела в глотке, припухлость в переднем отделе боковой поверхности шеи, резкая болезненность при надавливании на грудино-ключично-сосцевидную мышцу под верхушкой отростка; при фарингоскопии выявляется инфильтрат или выбухание боковой и задней стенок глотки.

2.7 Этиология

При вторичном мастоидите инфекция проникает в ячейки сосцевидного отростка преимущественно отогенным путём при остром или хроническом гнойном среднем отите.

Возбудители, как правило, те же, что при остром гнойном среднем отите

1. преобладают Streptococcus pneumoniae и Streptococcus pyogenes;
2. обнаруживают также Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus aureus и другие.

Факторы риска вторичного мастоидита

1. возраст до двух лет;
2. рецидивирующий острый средний отит;
3. неполная пневматизация сосцевидного отростка;
4. сопутствующие заболевания, снижающие иммунитет.

Первичный мастоидит имеет травматическое (удары, ушибы, переломы и трещины костей черепа, огнестрельные ранения) или гематогенное происхождение (септикопиемия, переход гнойного процесса из лимфатических узлов области сосцевидного отростка). Изолированное поражение сосцевидного отростка возможно при специфических инфекциях: туберкулёзе, инфекционных гранулёмах.

Ведущее звено патогенеза вторичного мастоидита заключается в недостаточном дренировании гнойного очага в среднем ухе. Ему способствуют запоздалое дренирование барабанной полости при задержке спонтанной перфорации или парацентеза при остром среднем отите, высокое расположение и малый размер перфорации при хроническом гнойном среднем отите, а также разобщение ячеек, антрума и барабанной полости отёчной утолщённой слизистой оболочкой.

Чаще всего костная деструкция формируется в проекции площадки сосцевидного отростка, и в заушной области образуется субпериостальный абсцесс, реже в области задней костной стенки наружного слухового прохода с отслойкой кожи и образованием свища. Деструкция чешуи височной кости приводит к сквамиту, вовлечение пирамиды к петрозиту. Распространение процесса к средней или задней черепной ямке ведёт к тяжёлым внутричерепным осложнениям: менингиту, абсцессам мозга и мозжечка, синустромбозу, сепсису.

2.8 Стадии

Экссудативная стадия продолжается первые 7–10 дней заболевания. Отёк слизистой оболочки разобщает ячейки с пещерой и пещеру с барабанной полостью, ячейки заполняются серозно-гнойным или гнойным экссудатом, образуя множество замкнутых эмпием. На КТ перегородки между завуалированными ячейками ещё различимы.

Пролиферативно-альтеративная стадия (истинный мастоидит) формируется обычно на 7–10-й день заболевания, у детей раньше. Грануляции и расплавление кости разрушают перегородки между ячейками, и образуются полости различной величины, заполненные гноем и грануляциями, или одна большая полость.

У детей плохой аэрации среднего уха и затруднению оттока способствуют частое нарушение носового дыхания, широкие короткие прямые слуховые трубы, эмбриональная миксоидная ткань в барабанной полости и высокое расположение сосцевидной пещеры, поэтому антрит возникает уже на ранней стадии острого среднего отита, особенно у новорождённых. Решающее значение имеют реактивность организма, инфекционные заболевания, недоношенность, перинатальная патология, гипо- и паратрофия, эндокринные заболевания.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на боль в ухе и заушной области, головную боль, недомогание, повышение температуры тела;
2. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости в анамнезе;
3. оттопыренность ушной раковины, гиперемия и пастозность заушной области, болезненность при пальпации и перкуссии сосцевидного отростка;
4. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода при отоскопии;
5. нарушение пневматизации структур среднего уха и костная деструкция по данным КТ височной кости.

3.2 Осмотр оториноларинголога

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: первичный осмотр для постановки диагноза и определения тактики лечения.

3.3 Компьютерная томография височной кости

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита.

Диагностические признаки

1. нарушение пневматизации структур среднего уха;
2. костно-деструктивные изменения.

При отсутствии технической возможности КТ допустима рентгенография височной кости в проекциях Майера и Шюллера.

Уровни приведены для детей; для взрослых УУР С, УДД 4.

Показания к КТ с внутривенным болюсным контрастированием

1. подозрение на внутричерепные осложнения.

3.4 Общий (клинический) анализ крови и С-реактивный белок

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: оценка общего состояния и выраженности воспаления.

Диагностические признаки

1. нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево;
2. повышение СОЭ;
3. умеренная анемия;
4. повышение СРБ.

3.5 Микробиологическое исследование отделяемого из уха

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: выбор антибактериальной терапии.

3.6 Исследование слуха

Камертональное исследование и (или) речевая аудиометрия.

Показания

1. пациенты **старше 7 лет** с подозрением на мастоидит: диагностика нарушения слуха.

3.7 Консультация невролога

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: исключение осложнений.

---

4. Лечение

Консервативное лечение начинают незамедлительно после постановки диагноза. Цели лечения:

1. эрадикация возбудителя;
2. ограничение воспаления пределами височной кости;
3. уменьшение субъективных и объективных симптомов;
4. предупреждение стойкого снижения слуха.

4.1 Системная антибактериальная терапия

Всем пациентам назначают один из препаратов, не дожидаясь результатов посева; у взрослых и детей препараты вводят парентерально:

1. амоксициллин + клавулановая кислота;
2. цефотаксим;
3. цефтриаксон.

Препараты резерва

1. ванкомицин: при выделении метициллинорезистентного золотистого стафилококка (MRSA), стрептококков, резистентных к пенициллинам, при непереносимости бета-лактамных антибиотиков или отсутствии ответа на другие препараты;
2. #меропенем (детям): при выделении синегнойной палочки или штаммов, устойчивых к пенициллинам и другим бета-лактамам.

Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

4.2 Режим дозирования антибактериальных препаратов

Препарат	Пациенты	Доза, путь и кратность введения
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослые и дети старше 12 лет или с массой тела 40 кг и более	1 г (по амоксициллину) внутривенно 3 раза в сутки
Амоксициллин + клавулановая кислота	Дети от 3 месяцев до 12 лет с массой тела менее 40 кг	25 мг/кг (по амоксициллину) внутривенно 3–4 раза в сутки, 5–14 дней
Цефотаксим	Взрослые и дети старше 12 лет с массой тела 50 кг и более	1–2 г внутривенно или внутримышечно каждые 12 часов; доза зависит от тяжести инфекции, чувствительности возбудителя и состояния пациента
Цефотаксим	Дети до 12 лет с массой тела до 50 кг	100–150 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно в 2–4 введения, 7–10 дней
Цефотаксим	Новорождённые	50 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно в 2–4 введения
Цефтриаксон	Взрослые и дети старше 12 лет с массой тела более 50 кг	1–2 г каждые 24 часа
Цефтриаксон	Дети до 12 лет с массой тела менее 50 кг	20–80 мг/кг/сут 1 раз в сутки
Цефтриаксон	Новорождённые (до 14 дней)	20–50 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно, 7–14 дней
Ванкомицин	Взрослые и дети старше 12 лет	2 г/сут внутривенно капельно: по 0,5 г каждые 6 часов или по 1 г каждые 12 часов. Скорость введения не более 10 мг/мин, продолжительность инфузии не менее 60 минут; максимальная разовая доза 1 г, суточная 2 г
Ванкомицин	Дети от 1 месяца до 12 лет	10 мг/кг внутривенно каждые 6 часов, инфузия не менее 60 минут; суточная доза 40 мг/кг
#Меропенем	Дети	60 мг/кг/сут внутривенно в 3 введения каждые 8 часов

> Длительность курса в рекомендации указана только для части групп: амоксициллин + клавулановая кислота 5–14 дней, цефотаксим у детей до 12 лет 7–10 дней, цефтриаксон 7–14 дней (указано после дозы для новорождённых). Для остальных групп срок в тексте не приведён.

4.3 Местная терапия

Показания к ушным каплям с противомикробными препаратами

1. перфорация барабанной перепонки;
2. послеоперационный период: введение через парацентезное отверстие или тимпаностомический шунт.

Препараты

1. офлоксацин взрослым и детям **старше 15 лет**: по 5 капель 2 раза в сутки, 10 дней;
2. рифамицин детям: по 3 капли 3 раза в сутки, 7 дней.

Для офлоксацина у взрослых УДД 4.

Для восстановления функции слуховой трубы всем пациентам назначают назальные деконгестанты (оксиметазолин, ксилометазолин) **не дольше 7 дней**. У детей их применяют с особой осторожностью.

Уровни приведены для детей; для взрослых УДД 4.

Препарат	Возраст	Доза и кратность
Оксиметазолин 0,01%	до 4 недель	по 1 капле в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,01%	с 5-й недели до 1 года	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,025%	от 1 года до 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,05%	взрослые и дети старше 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Ксилометазолин 0,05%	от 2 до 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–3 раза в сутки
Ксилометазолин 0,1%	взрослые и дети старше 6 лет	по 2–3 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки

4.4 Симптоматическая терапия

При боли и (или) лихорадке, в том числе после операции, в формах и дозах согласно инструкциям применяют:

1. парацетамол;
2. нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, диклофенак, кеторолак, кетопрофен, лорноксикам, декскетопрофен.

Для лорноксикама и диклофенака у взрослых УУР В, УДД 2.

4.5 Хирургическое лечение

Мастоидит и антрит требуют экстренного хирургического лечения, цель которого состоит в скорейшем обеспечении оттока экссудата из полостей среднего уха и предотвращении распространения процесса за пределы сосцевидного отростка.

4.6 Первый этап: парацентез или шунтирование барабанной полости

Показания

1. мастоидит при целой барабанной перепонке;
2. спонтанная перфорация недостаточного размера.

Это первый этап лечения неосложнённого острого мастоидита и антрита.

Предпочтительно установить тимпаностомический шунт, если для этого есть условия: перфорация не закрывается быстро, облегчаются введение ушных капель и отток отделяемого. При отсутствии положительной динамики **в течение 48–72 часов** переходят ко второму этапу.

4.7 Второй этап: антромастоидотомия или антродренаж (антротомия)

Показания

1. отсутствие эффекта от консервативного лечения и парацентеза или шунтирования **в течение 48–72 часов**;
2. субпериостальный абсцесс или абсцесс шеи;
3. признаки перехода инфекции на мозговые оболочки и другие внутричерепные осложнения;
4. отогенный сепсис;
5. вялотекущий процесс в сосцевидном отростке **более месяца** с рентгенологической картиной разрушения его тканей и жалобами пациента.

1. комбинированный эндотрахеальный наркоз, желательно под контролем операционного микроскопа;
2. дети раннего возраста: вскрытие сосцевидного отростка ограничивается антральной клеткой;
3. дети **старше года** и взрослые: обязательна ревизия всей клеточной системы отростка;
4. после вскрытия антрума и окружающих клеток проверяют проходимость входа в пещеру.

Разрез мягких тканей ведут сверху вниз до верхушки сосцевидного отростка, отступив 5 мм от линии прикрепления ушной раковины; послойное рассечение позволяет выполнять гемостаз по ходу операции. Трепанацию проводят в пределах треугольника Шипо, антрум находят в глубине и кпереди, в проекции треугольника Траутмана. Ограничиваться вскрытием антрума не следует: при любой форме мастоидита необходима ревизия клеточной системы отростка с удалением всех патологически изменённых тканей и костных осколков, после чего полость промывают.

4.8 Послеоперационное ведение

1. При субпериостальном абсцессе или ожидаемом продолжении воспаления заушную рану полностью не ушивают: накладывают один-два шва в верхнем и нижнем углах и ведут рану открытым способом.
2. В остальных случаях в антрум устанавливают силиконовую дренажную трубку и рану ушивают полностью.
3. Перевязки выполняют ежедневно.
4. Дренажную трубку удаляют **на 5–7-е сутки**.
5. Открытую рану ушивают после полного очищения послеоперационной полости.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Все пациенты с мастоидитом, независимо от этиологии и стадии процесса, подлежат экстренной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профилю «оториноларингология».

Критерии выписки

1. нормализация общего состояния: отсутствие лихорадки и признаков интоксикации;
2. нормализация показателей общего и биохимического анализов крови;
3. отсутствие выделений из уха.

5.2 Медицинская реабилитация

Контрольное исследование слуха **через 1 месяц** после выздоровления всем перенёсшим мастоидит:

1. тональная аудиометрия пациентам **старше 7 лет**;
2. игровая аудиометрия детям **от 3 до 7 лет**;
3. регистрация вызванной отоакустической эмиссии детям **младше 3 лет**.

При снижении слуха пациента направляют к сурдологу-оториноларингологу.

5.3 Профилактика

1. профилактика острого среднего отита, заболеваний носа, околоносовых пазух и лимфоглоточного кольца;
2. квалифицированное лечение хронического среднего отита;
3. своевременное хирургическое лечение на среднем ухе, в полости носа, околоносовых пазухах, носоглотке и глотке.

Диспансерное наблюдение после мастоидита не требуется.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мастоидит»
Версия	2-я, год утверждения 2026, опубликована в рубрикаторе 04.09.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2029 года
Код в рубрикаторе	311_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность антибактериальной терапии приведена не для всех групп пациентов: для амоксициллина + клавулановой кислоты и цефтриаксона срок указан один раз в конце фразы, для цефотаксима только у детей до 12 лет.
- Границы массы тела для цефтриаксона заданы как «более 50 кг» и «менее 50 кг»; пациенты с массой ровно 50 кг формально не охвачены.

Клинические рекомендации

Множественные переломы мозгового и лицевого черепа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S02.0** — Перелом свода черепа **S02.1** — Перелом основания черепа **S02.4** — Перелом скуловой кости и верхней челюсти **S02.6** — Перелом нижней челюсти **S02.7** — Множественные переломы черепа и лицевых костей **S02.8** — Переломы других лицевых костей и костей черепа **S02.9** — Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей **S07** — Размозжение головы
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Ассоциация травматологов-ортопедов России; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Всероссийское Общество по детской нейрохирургии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/871_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Черепно-лицевая травма — повреждение мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа. При подозрении на перелом черепа показана экстренная госпитализация в специализированный стационар.
- Первоочередные задачи на месте: восстановление дыхания (асфиксия при переломах челюстей), остановка кровотечения, транспортная иммобилизация, экстренная доставка в стационар.
- Базальная ликворея — признак перелома основания черепа. Её отличают от отделяемого из носа по глюкозе и специфическим маркерам (beta-2 transferrin); фистулу закрывают хирургически при неэффективности консервативной терапии в течение **5–7 дней**, в том числе эндоназально эндоскопически.
- При кровотечении из носа с угрозой аспирации — интубация или S-образный воздуховод и передняя и задняя тампонада носа; при профузных рецидивирующих носовых кровотечениях — эндоваскулярная эмболизация или эндоназальная перевязка (коагуляция) крылонёбной артерии.
- В стационаре — МСКТ головного мозга и лицевого отдела черепа; консультации нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога и оториноларинголога.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Множественная травма — травма, в результате которой возникло два и более повреждения мягких тканей и (или) костей в пределах одной анатомической области.

Черепно-лицевая (краниофациальная) травма — повреждения мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа.

Перелом костей основания черепа — повреждение основания черепа с нарушением его анатомической целостности и функциональными расстройствами; к ним относятся переломы глазничной поверхности лобной кости, пирамиды височной кости, решётчатой пластинки, клиновидной кости, затылочной кости с переходом на большое затылочное отверстие.

Вдавленный перелом черепа — перелом, при котором фрагменты кости смещаются более чем на толщину прилежащей кости.

Повреждения средней зоны лица чаще всего множественные и сочетанные. При одновременном повреждении костей носа, решётчатой кости и других костей средней зоны их объединяют понятием травмы средней зоны лица. Сочетанные повреждения вызывают «синдром взаимного отягощения».

2.2 Этиология и эпидемиология

Переломы лицевого черепа составляют 3–4% травм с повреждением костей: нижняя челюсть — 65,1%, скуловая кость и дуга — 12,8%, кости носа — 3,8%, верхняя челюсть — 2,0%. Причины — ДТП, падения с высоты, реже производственная и спортивная травма. Переломы челюстей в пределах зубного ряда считаются заведомо открытыми.

Переломы основания черепа составляют 4% тяжёлых ЧМТ; у 32–59% линия перелома переходит со свода на основание. Летальность при сочетанной черепно-лицевой травме у детей — 7,1–22%.

2.3 Классификация

1. **верхняя зона лица** — передняя стенка лобной пазухи, крыша глазницы
2. **средняя зона лица** — назоэтмоидальный комплекс, кости носа, скулоорбитальный комплекс, верхняя челюсть по верхнему, среднему и нижнему уровню, альвеолярный отросток
3. **нижняя зона лица** — нижняя челюсть

Переломы костей носа рассматриваются в отдельных КР (оториноларингология), переломы орбиты — в офтальмологических; здесь они упоминаются только в составе множественных переломов.

1. **субкраниальные** — назоорбитальные и назомаксиллярные, центральные (Ле Фор I, II, Вассмунд I, II), центролатеральные (Ле Фор III, Вассмунд IV), латеральные (скуловая кость, дуга, скулоорбитальный комплекс)
2. **краниофациальные** — верхняя и средняя зоны лица с передней черепной ямкой; панфациальные — все зоны лица и основание черепа
3. **фронтофациальные** — передняя черепная ямка и верхняя зона: стенки лобной пазухи, верхний край и стенка орбиты, решётчатая пластинка, задние решётчатые ячейки, верхняя и латеральная стенки клиновидной пазухи

Из-за плотного прилегания твёрдой мозговой оболочки и сообщения с пазухами большинство переломов основания черепа рассматриваются как открытые проникающие; они возможны даже при незначительной травме.

2.4 Клиническая картина

Признаки перелома основания черепа

1. гипосмия или аносмия;
2. базальная ликворея;
3. глазодвигательные нарушения (III, IV, VI нервы), повреждение зрительного нерва;
4. одно- и двусторонние нарушения слуха, спонтанный нистагм;
5. при поперечном переломе пирамиды — выпадение слуха и вестибулярной функции, повреждение лицевого нерва.

Наружные признаки, указывающие на характер перелома

1. периорбитальная гематома (симптом «очков») **через 12–48 часов** — перелом передней черепной ямки;
2. гематома в области сосцевидного отростка (симптом Бэттла), лагофтальм, асимметрия лица — перелом пирамиды височной кости, парез лицевого нерва;
3. гемотимпанум или разрыв барабанной перепонки — возможный перелом основания черепа;
4. рино- или отоликворея — перелом передней или средней черепной ямки;
5. эмфизема лица — перелом лицевых костей, возможно дна передней черепной ямки;
6. экзофтальм с отёком конъюнктивы — каротидно-кавернозное соустье или ретробульбарная гематома;
7. кровотечение из носа или ушей, нарушение слуха, нистагм, рвота.

Раннюю ликворею трудно распознать при сочетании с кровотечением; помогает проба со светлым ободком вокруг кровянистого пятна на марлевой салфетке.

1. **верхняя зона** — асимметрия, параорбитальные гематомы, симптом «лица панды» в первые часы, истинный симптом «очков» через сутки, затруднение носового дыхания, диплопия, эмфизема, кровотечение и (или) ликворея из носа
2. **средняя зона** — уплощение средней зоны, деформация носа, симптом «очков», затруднение носового дыхания, кровотечение и (или) ликворея из носа, подвижность фрагментов, нарушение прикуса и открывания рта
3. **нижняя зона** — симптом «ступеньки», патологическая подвижность фрагментов, симптом непрямой нагрузки, нарушение движений челюсти и прикуса

Симптомы множественных переломов лица малозаметны из-за отёка и кровоизлияний; даже при кровотечении и ликворее их не всегда вовремя диагностируют у тяжелопострадавших с явными повреждениями других областей.

---

3. Диагностика

3.1 Догоспитальный этап

При наличии или подозрении на перелом черепа — экстренная госпитализация в специализированный стационар.

Признаки перелома лицевых костей на догоспитальном этапе

1. деформация лица за счёт западения или отёка;
2. нарушение прикуса;
3. нарушение чувствительности в зоне подглазничного и (или) подбородочного нерва;
4. ограничение подвижности нижней челюсти;
5. патологическая подвижность и крепитация отломков, положительная проба непрямой нагрузки.

Восстановление дыхания

1. осмотр и санация полости рта: сгустки, осколки зубов, инородные тела;
2. при двустороннем переломе нижней челюсти — фиксация языка;
3. боковое стабильное положение;
4. при отёке, затрудняющем дыхание, — S-образный воздуховод.

Асфиксия при челюстно-лицевых ранениях: дислокационная (40%), обтурационная (29%), стенотическая (23%), клапанная (5%), аспирационная (3%).

Остановка кровотечения: зажим, тугая тампонада раны, жгут на шею через поднятую противоположную руку, пальцевое прижатие. Транспортная иммобилизация — стандартная повязка или теменно-подбородочная пращевидная повязка.

1. **первая очередь** — тяжёлое и крайне тяжёлое состояние: нарушение сознания, очаговая неврологическая симптоматика, продолжающееся кровотечение, ликворея, нарушение дыхания, тахикардия 100 и более, АД 100 мм рт. ст. и ниже, гемоглобин менее 100 г/л
2. **вторая очередь** — удовлетворительное или среднетяжёлое состояние с множественными повреждениями, подозрением на сотрясение мозга, возрастом **старше 60 лет**, сопутствующими заболеваниями
3. **третья очередь** — изолированная травма челюстно-лицевой области без неврологической симптоматики и кровотечения

3.2 Жалобы и анамнез

Анамнез собирают у пострадавшего, сопровождающих и из листа скорой помощи.

Что уточнить

1. механизм травмы, травмирующий предмет, время и место;
2. нарушение сознания и амнезию, их длительность;
3. прививку от столбняка, аллергию, сопутствующие заболевания;
4. лечение до поступления и его результат.

3.3 Осмотр, пальпация и перкуссия

Всем — оценка общего состояния, осмотр, пальпация и перкуссия челюстно-лицевой области; выявляют признаки перелома черепа, следы кровотечения, истечения ликвора или детрита из раны.

Что отметить при осмотре

1. деформацию и симметричность лица, отёк, гематомы, раны, эмфизему;
2. движения глазных яблок, межкантальное расстояние;
3. кровотечение или ликворею из носа, уплощение средней зоны лица;
4. зоны нарушения чувствительности;
5. открывание рта, прикус, болезненность при перкуссии зубов.

При кровотечении и переломах основания и лицевого отдела черепа с угрозой аспирации — срочная интубация трахеи или S-образный воздуховод; механическая остановка кровотечения — передняя и задняя тампонада носа и ротоглотки.

Высокий риск осложнений: асфиксия, анемия, бронхолёгочные гнойные заболевания, синуситы, внутричерепные гнойные осложнения, травматический остеомиелит, посттравматическая деформация.

Тяжесть состояния оценивают нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, анестезиолог-реаниматолог, при сочетанной травме — травматолог и хирург.

3.4 Анализы крови и мочи

Всем — лабораторные исследования для оценки тяжести (общий анализ крови и мочи и др.); при ЧМТ — по рекомендациям «Очаговая травма головного мозга» и «Черепно-мозговая травма у детей».

3.5 Компьютерная томография

В стационаре — МСКТ; всем с подозрением на перелом черепа при поступлении — КТ головного мозга. При необходимости — конусно-лучевая КТ, особенно для средней зоны лица.

ЛОР-структуры при МСКТ

1. верхнечелюстные пазухи: положение, симметричность, гемосинус, повреждение стенок;
2. решётчатые ячейки, лобные и клиновидная пазухи;
3. кости носа, перегородка, носовые раковины, сошник.

Для поиска ликворной фистулы — КТ с толщиной срезов 1–3 мм и коронарной реконструкцией: решётчатая пластинка, стенки решётчатых ячеек, верхняя стенка клиновидной пазухи, крыша барабанной полости; аксиальные срезы — задняя стенка лобной пазухи, стенки клиновидной пазухи, ячейки сосцевидного отростка. Для визуализации фистулы — КТ-цистернография.

По показаниям — МРТ головного мозга и лицевого черепа (кровоизлияния, эмфизема в тканях глазницы); КТ-ангиография — при вдавленном переломе над крупными венозными синусами.

При отсутствии КТ — рентгенография черепа как минимум в 2 проекциях.

3.6 Исследование ликвора и отделяемого из носа

Спинномозговая пункция — при подозрении на интракраниальные гнойные осложнения, при отсутствии признаков дислокации.

При подозрении на базальную ликворею исследуют глюкозу в отделяемом из носа и уха. В ликворе глюкозы больше (2,3–4,0 ммоль/л), а белка меньше (0,10–0,22 г/л), чем в серозном отделяемом.

Специфические маркеры ликвора — beta-2 transferrin (есть только в ликворе) и beta-trace protein (в ликворе 18,4 мг/л, в крови 0,59 мг/л).

3.7 Консультации специалистов

Для исключения ЧМТ, повреждения ЛОР-органов и органа зрения — МСКТ и консультации специалистов.

1. нейрохирург (при его отсутствии — невролог);
2. челюстно-лицевой хирург;
3. офтальмолог;
4. оториноларинголог;
5. детский стоматолог.

При подозрении на повреждение внутренних органов — хирург, травматолог, реаниматолог.

---

4. Лечение

План лечения составляет челюстно-лицевой хирург совместно с нейрохирургом; офтальмолог, оториноларинголог, травматолог привлекаются по характеру травмы. Часто приоритетны нейрохирургические операции. Решающий фактор исхода — время от травмы до специализированного лечения.

4.1 Консервативное лечение

Без показаний к операции лечение проводят по тяжести ЧМТ. Консервативно начинают при посттравматическом парезе лицевого нерва при переломе височной кости (глюкокортикоиды, вазодилататоры, физиотерапия) и при базальной ликворее (постельный режим полусидя, серия люмбальных пункций или наружный люмбальный дренаж, дегидратация).

Репозицию и фиксацию отломков целесообразно отложить до стабилизации: при тяжёлом состоянии — через **2–7 суток и более**, после противошоковых мероприятий. Первичная хирургическая обработка ран — как можно раньше; глухой шов — до **24–36 часов** после травмы.

4.2 Ортопедическое лечение

У детей ортопедический метод основной. Иммобилизация — индивидуальными проволочными, ленточными или пластмассовыми назубными шинами.

При ЧМТ с позывами на рвоту, особенно у детей, назубные шины и межчелюстную тягу в первые **2–3 суток** лучше не накладывать — риск аспирации и асфиксии; возможна шина без межчелюстной фиксации.

4.3 Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению

1. невозможность репозиции ортопедически, многооскольчатые переломы, недостаточно устойчивых зубов, интерпозиция тканей;
2. переломы скуловорбитального, скулоназоорбитального, скулоназоэтмоидального комплексов, стенок орбиты, стенок лобной пазухи;
3. проникающий вдавленный перелом, активное кровотечение, сильное загрязнение раны, раневая инфекция;
4. истечение ликвора через нос, не останавливающееся консервативно;
5. отсроченный парез лицевого нерва или отсутствие эффекта консервативного лечения;
6. отсроченное ухудшение зрения при повреждении зрительного нерва в канале;
7. сдавление мозга, «растущий перелом», косметически значимая деформация.

Противопоказания

1. декомпенсированная соматическая патология;
2. острая ЧМТ тяжёлой и крайне тяжёлой степени, реже средней;
3. травматический или геморрагический шок с нестабильной гемодинамикой.

Основной метод — остеосинтез пластинами и винтами для черепно-лицевой хирургии. Детям нерассасывающиеся пластины после консолидации обязательно удаляют.

Доступы к средней зоне: коронарный, трансконъюнктивальный, субцилиарный, транскутанный по нижнему краю глазницы, трансоральный, трансантральный (гайморотомия), по Лимбергу.

Операции при переломах черепа

1. удаление внутричерепных гематом, декомпрессивная трепанация;
2. закрытие базальной ликворной фистулы при неэффективности консервативной терапии **5–7 дней** — транскраниально или эндоназально эндоскопически;
3. декомпрессия лицевого нерва через среднюю черепную ямку или транслабиринтно;
4. декомпрессия зрительного нерва;
5. эндоваскулярные вмешательства при ложных аневризмах, соустьях и профузных рецидивирующих носовых кровотечениях; перевязка или коагуляция крылонёбной артерии эндоназальным доступом;
6. репозиция вдавленного перелома у детей элеватором.

При переломе черепа рекомендуется раннее хирургическое вмешательство; при вдавленном переломе давностью до суток без загрязнения раны — репозиция отломков или первичная пластика дефекта.

4.4 Антибактериальная профилактика

Всем, кому планируется операция, — периоперационная антибиотикопрофилактика: разовая терапевтическая доза за **30–60 минут** до разреза, как правило однократно; при продлении — отмена не позднее **24 часов** после операции.

1. наружный доступ без сообщения с полостью рта — цефазолин или цефуроксим;
2. внутриротовой доступ, сообщение с полостью рта, открытый перелом — цефазолин или цефуроксим + метронидазол либо амоксициллин + клавулановая кислота;
3. аллергия на бета-лактамы, риск MRSA — ванкомицин (за 120 минут до разреза).

Детям **после 3 лет** при массе до 80 кг цефазолин 1 г, от 80 кг — 2 г. При инфицированной ране — антибиотикотерапия в терапевтических дозах.

4.5 Обезболивание и иное лечение

Остеосинтез — под общим обезболиванием с интубацией через нос или рот; ортопедические манипуляции — под премедикацией и местной анестезией.

При нарушении всех компонентов приёма пищи кормят через зонд, при неэффективности — парентерально. Детям **до 3 лет** назначают молочную диету, старше — челюстную. Физиотерапия — по назначению физиотерапевта.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в отделение челюстно-лицевой хирургии

1. подозрение на перелом челюсти любой локализации или его наличие;
2. раны мягких тканей лица и полости рта;
3. обширные раны мягких тканей челюстно-лицевой области.

Пострадавших с множественными переломами госпитализируют в многопрофильный стационар с нейрохирургией и нейрореанимацией, круглосуточной КТ; при транспортировке — временная иммобилизация челюстей. Плановой госпитализации нет.

Показания к выписке

1. выполнены запланированные исследования;
2. восстановлена анатомическая целостность челюстно-лицевой области;
3. нет признаков послеоперационных осложнений.

5.2 Диспансерное наблюдение

Детям диспансеризация — на весь период до завершения роста лицевых костей. Осмотры — **через 2–4 недели**, 3, 6 месяцев и год.

Участники наблюдения

1. челюстно-лицевой хирург;
2. невролог и офтальмолог;
3. оториноларинголог;
4. ортодонт и детский стоматолог.

Невролог после выписки — **1 раз в 3 месяца** в первый год, затем **1 раз в 6 месяцев**: возможны посттравматическая эпилепсия, гидроцефалия, ликворея.

Через **4 недели** после операции — контрольное рентгенологическое исследование: консолидация фрагментов и исключение посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

Сроки иммобилизации по сочетанию ЧМТ и переломов лица

1. тяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица — временная иммобилизация после выведения из шока, лечебная — на 2–5-е сутки, остеосинтез не ранее 7-х суток;
2. тяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы лица — лечебная иммобилизация через 1–3 суток;
3. нетяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица — иммобилизация и остеосинтез в первые сутки;
4. нетяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы — в первые часы.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Множественные переломы мозгового и лицевого отделов черепа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года

Код в рубрикаторе	871_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 7 при делении на группы перелом верхней челюсти по Ле Фор I и II отнесён к тяжёлым переломам лица (1-я группа), а Ле Фор III (черепно-лицевое разъединение) — к нетяжёлым (2-я группа); от группы зависят сроки иммобилизации.

Клинические рекомендации

Наружные отиты

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.4** — Холестеатома наружного уха **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 13.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/663_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Наружный отит является воспалительным поражением ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
- При неосложнённом наружном отите:
  1. местно ушные капли; при бактериальном отите препараты первого выбора: фторхинолоны;
  2. туалет наружного слухового прохода;
  3. обезболивание.
- При неосложнённом отите системная антибактериальная терапия не показана. Показания к системным антибиотикам:
  1. постлучевой отит;
  2. сахарный диабет;
  3. иммуносупрессия;
  4. хондроперихондрит.
- Эффективность терапии оценивают **через 48–72 часа**. При отсутствии эффекта уточняют диагноз и исключают атопический или контактный дерматит, псориаз, экзему.
- Признаки злокачественного наружного отита:
  1. выраженный болевой синдром;
  2. грануляции;
  3. синегнойная палочка при посеве;
  4. отсутствие эффекта от лечения **более недели**;
  5. чаще у пожилых пациентов с сахарным диабетом.

  При злокачественном наружном отите необходимы
  1. определение уровня глюкозы крови;
  2. компьютерная томография (КТ);
  3. госпитализация;
  4. системная антибактериальная терапия **не менее 6 недель**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Наружный отит характеризуется воспалительными изменениями ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.

По течению

1. острый;
2. хронический: **более 6–12 недель**.

Диффузный наружный отит

1. экзема;
2. дерматит;
3. рожистое воспаление;
4. герпес;
5. перихондрит, хондроперихондрит;
6. злокачественный наружный отит.

Ограниченный наружный отит

1. фурункул;
2. абсцесс.

Развитию воспаления предшествует нарушение целостности кожи:

1. травма;
2. длительное пребывание во влажной среде;
3. сахарный диабет;
4. дерматит или экзема.

Предрасполагающие факторы

1. узкий наружный слуховой проход, экзостозы;
2. ношение слухового аппарата;
3. попадание воды в уши;
4. нарушение образования ушной серы;
5. лучевое воздействие.

2.2 Жалобы

Жалобы

1. дискомфорт и боль в ухе, нередко усиливающаяся при надавливании и жевании, с иррадиацией в глаз, зубы, глотку;
2. снижение слуха при полной обтурации слухового прохода;
3. в ряде случаев зуд и выделения из уха.

Температура тела, как правило, субфебрильная.

2.3 Физикальное обследование

Признаки при осмотре

1. гиперемия, отёк, инфильтрация и лихенификация кожи наружного слухового прохода, в ряде случаев ушной раковины и поверхностного слоя барабанной перепонки;
2. патологическое отделяемое;
3. при ограниченной форме абсцессы и инфильтраты, возможен регионарный лимфаденит.

2.4 Особенности клинических форм

При фурункуле наружного слухового прохода в стадии инфильтрации ведущей жалобой является дискомфорт, усиливающийся при манипуляциях в ухе, в стадии абсцедирования на первый план выходит боль. При диффузном отите беспокоят боль, выделения из уха, возможно снижение слуха.

При экзематозном отите определяются желтовато-розовые очаги с шелушением, беспокоит зуд, в ряде случаев интенсивный и предшествующий высыпаниям. В дальнейшем образуются микровезикулы,

эрозии, участки мокнутия, причём элементы разных стадий наблюдаются одновременно.

При герпетическом поражении за 1–2 суток до высыпаний возникают жжение, зуд и покалывание, затем появляются эритема, пузырьки и корочки. Как правило, процесс разрешается за 10–14 дней, а при присоединении вторичной инфекции в течение 3–4 недель.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании характерных жалоб и клинической картины; при необходимости его подтверждают лабораторными и другими методами исследования.

3.1 Бактериологическое, микологическое и цитологическое исследования

Выполняют

1. бактериологическое исследование отделяемого;
2. микроскопическое и культуральное исследование на грибы;
3. цитологическое исследование;
4. при подозрении на новообразование: биопсию.

Забор материала

1. до начала противомикробной терапии;
2. под контролем отоскопии;
3. тампоном диаметром до 0,3 см из просвета или со стенок наружного слухового прохода, без контакта с его наружными отделами.

3.2 Аудиометрия

Показания

1. жалобы на снижение слуха после купирования воспаления: исключение острой нейросенсорной тугоухости.

При неосложнённом наружном отите возможна кондуктивная тугоухость.

3.3 Компьютерная и магнитно-резонансная томография

Показания к КТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ)

1. осложнённая форма: формирование костных секвестров, абсцессов.

При неосложнённом отите необходимости в лучевой диагностике нет.

3.4 Консультация профильного специалиста

Показания

1. поражение наружного уха на фоне системного, в том числе инфекционного, заболевания: консультация профильного специалиста и дообследование.

3.5 Злокачественный наружный отит

Показания

1. злокачественная форма: определение уровня глюкозы крови, поскольку в 90–100% случаев злокачественный наружный отит сочетается с сахарным диабетом.

Основные признаки злокачественного наружного отита

1. боль в ухе и головная боль на стороне поражения;
2. отёк стенок и выделения из слухового прохода;
3. грануляции в слуховом проходе;
4. микроабсцессы в области уха и основания черепа;
5. очаг воспаления по данным сцинтиграфии;
6. отсутствие эффекта от лечения **более недели**;
7. синегнойная палочка при посеве.

Дополнительные признаки

1. сахарный диабет;
2. поражение черепных нервов;
3. истощение;
4. пожилой возраст.

При невозможности выполнить сцинтиграфию назначают местное лечение **на 1–3 недели**; отсутствие улучшения свидетельствует в пользу злокачественного отита.

---

4. Лечение

Основа лечения:

1. устранение предрасполагающих факторов;
2. адекватное обезболивание;
3. регулярный туалет наружного слухового прохода.

4.1 Неосложнённый наружный отит: местное лечение

Для местного лечения неосложнённого наружного отита используют препараты, активные в отношении золотистого стафилококка и синегнойной палочки. Эффективность оценивают **через 48–72 часа**. Сохранение симптомов требует уточнения диагноза и исключения атопического или контактного дерматита, псориаза, экземы.

При бактериальном наружном отите препаратами первого выбора являются ушные капли с фторхинолонами.

Ушные капли рекомендованы всем пациентам с бактериальным наружным отитом; перечень препаратов приведён в таблице ниже.

При всех формах:

1. антисептики: бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид; йод с калия йодидом и поливиниловым спиртом;
2. противомикробные средства: фторхинолоны, аминогликозиды, противогрибковые препараты.

На фоне местного лечения выздоровление на 7–10-е сутки наступает у 65–95% пациентов.

При экзематозной форме применяют кортикостероиды в сочетании с противомикробными средствами.

Ушные капли

Препарат	Состав	Возраст
Офлоксацин	офлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (в КР под названием «Комбинил»)	ципрофлоксацин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	с 18 лет

Препарат	Состав	Возраст
Норфлоксацин	норфлоксацин	с 15 лет
Рифамицин	рифамицин	без ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин B	неомицин + полимиксин B (антибактериальный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 1 года
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол	хлорамфеникол (антибактериальный компонент), клотримазол (противогрибковый компонент), беклометазон (противовоспалительный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 6 лет
Дексаметазон + неомицин + полимиксин B	неомицин + полимиксин B (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон	фрамицетин + грамицидин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений

> В данной рекомендации капли с норфлоксацином разрешены с 15 лет, тогда как в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года. Возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.

4.2 Системная антибактериальная терапия

При неосложнённом наружном отите системная антибактериальная терапия не показана, поскольку её добавление к местному лечению не улучшает результатов.

Показания к системной антибактериальной терапии:

1. постлучевой наружный отит;
2. сахарный диабет;
3. иммуносупрессия.

При хондроперихондрите ушной раковины применяют системные антибиотики и противовоспалительные средства для купирования болевого синдрома и отёка.

4.3 Злокачественный наружный отит

Системная антибактериальная терапия продолжительностью **не менее 6 недель** препаратами с антисинегнойной и антистафилококковой активностью.

4.4 Хирургическое лечение

Хирургическое лечение

1. ограниченный отит: вскрытие и дренирование абсцессов наружного слухового прохода;
2. злокачественный отит: удаление грануляций, костных и хрящевых секвестров и холестеатомы в пределах зоны поражения.

4.5 Физиотерапия

Для повышения эффективности лечения применяется физиотерапия.

Микробиологическое исследование повторяется до подтверждения элиминации возбудителя.

При сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе необходим контроль уровня глюкозы крови.

5. Профилактика. Показания к госпитализации

Профилактика

1. ограничить использование ватных палочек;
2. избегать избыточного туалета наружного слухового прохода;
3. соблюдать гигиену при использовании берушей, слуховых аппаратов и наушников.

Лечение, как правило, амбулаторное.

Показания к госпитализации

1. некротический (злокачественный) наружный отит.

Критерии выписки

1. стихание воспалительных явлений в наружном слуховом проходе;
2. отсутствие гнойно-септических осложнений.

Медицинская реабилитация не рекомендована.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружные отиты»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее ноября 2027
Код в рубрикаторе	663_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые. Для детей — отдельная КР «Наружный отит» (21_3)

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены с 15 лет, в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года.

Клинические рекомендации

Наружный отит у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.2** — Наружный отит при микозах **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/21_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Наружный отит: воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки. Формы по течению:
  1. острая: **до 6 недель**;
  2. хроническая: симптомы **более 3 месяцев** или **более 4 эпизодов в год**.
- Критерии диагноза:

  Обязательный критерий

  1. признаки воспаления слухового прохода: болезненный козелок и (или) ушная раковина, или диффузный отёк, или гиперемия слухового прохода.

  Возможные признаки

  1. оторея;
  2. регионарная аденопатия;
  3. эритема барабанной перепонки или целлюлит ушной раковины и прилегающей кожи;
  4. боль в ухе, иногда с иррадиацией в челюсть;
  5. зуд или ощущение распирания в ухе.
- Основа лечения: местная терапия ушными каплями, активными против синегнойной палочки и золотистого стафилококка. Эффект оценивают **через 48–72 часа**, курс в среднем **7–10 дней** (до 14).
- При неосложнённом наружном отите системные антибактериальные препараты не назначают: они неэффективны.
- Лечение, как правило, амбулаторное. Госпитализируют детей в тяжёлом состоянии; неэффективность лечения, подозрение на прогрессирование и осложнения требуют консультации оториноларинголога и госпитализации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Наружный отит (НО): воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода (НСП) и эпидермального слоя барабанной перепонки.

2.2 Классификация

По течению

1. острая форма: **до 6 недель**;
2. хроническая форма: симптомы сохраняются **более 3 месяцев** или **более 4 эпизодов** наружного отита в год.

Нозологические формы

1. диффузный наружный отит;
2. ограниченный наружный отит: фурункул, абсцесс;
3. экзема и дерматит;
4. рожистое воспаление;
5. перихондрит;
6. герпетическое поражение;
7. грибковый наружный отит;
8. злокачественный наружный отит.

Злокачественный наружный отит (ЗНО): наиболее тяжёлая форма; быстрое прогрессирующее течение с распространением процесса за пределы ушной раковины, слухового прохода и наружного уха.

2.3 Этиология

Воспалению предшествует нарушение целостности кожи.

Причины и предрасполагающие факторы

1. травматические повреждения;
2. длительное пребывание во влажной среде, попадание воды в уши;
3. изменения кожи при нарушении обмена веществ, сахарном диабете, дерматитах, экземе;
4. узкие наружные слуховые проходы, экзостозы;
5. ношение слухового аппарата, наушников;
6. недостаточное образование или изменение состава ушной серы;
7. нарушение местного и общего иммунного статуса;
8. лучевое воздействие.

Ведущие возбудители у детей: синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus); также P. vulgaris и E. coli.

1. бактериальная природа у 60–98%;
2. P. aeruginosa выделяют в 20–60%, S. aureus в 10–70%;
3. анаэробы в 4–25%;
4. смешанная флора в трети случаев.

Грибковый наружный отит у детей не редкость: в России более 20% поражений наружного уха. Основные возбудители: плесневые грибы Aspergillus и Penicillium, дрожжеподобные грибы Candida. Часто выделяют грибково-бактериальные ассоциации с синегнойной палочкой, стрептококками и стафилококками.

Факторы развития микоза

1. травматическое повреждение кожи;
2. нарушение обмена веществ и гормонального баланса;
3. иммунодефицит;
4. длительное применение системных антибактериальных препаратов и кортикостероидов.

2.4 Клиническая картина

Диффузный наружный отит, острая форма.

Отоскопия

1. отёк и гиперемия кожи НСП, выделения вязкого секрета;
2. барабанная перепонка может быть не видна из-за отёка стенок слухового прохода в хрящевом и костном отделах;
3. детрит в НСП.

Симптомы

1. болезненность в области НСП, усиливается при оттягивании ушной раковины или надавливании на козелок;
2. возможна лихорадка до фебрильных цифр;
3. болезненность и ограничение движений в височно-нижнечелюстном суставе при открывании рта;
4. увеличение и болезненность заушных лимфатических узлов («псевдомастоидит»).

Хроническая фаза: утолщение кожи из-за инфильтрации или фиброза, мирингит. Кондуктивное снижение слуха при значительном сужении или обтурации слухового прохода отделяемым.

Фурункул слухового прохода (ограниченный наружный отит).

Отоскопия

1. сужение просвета очерченным конусовидным или округлым возвышением с локальной гиперемией;
2. стадия инфильтрации (**1–3-и сутки**): локальное уплотнение кожи;
3. стадия абсцедирования: просвечивающая гнойная головка;
4. после самопроизвольного вскрытия: кратерообразное углубление с гноем.

Симптомы

1. боль в ухе, усиливается при оттягивании раковины или надавливании на козелок;
2. иррадиация в зубы, глаз, шею, околоушную область, глотку;
3. инфильтрация может распространяться на мягкие ткани, сосцевидный отросток и веки;
4. фурункул задней стенки: возможны кашель и рвота (раздражение ветвей блуждающего нерва);
5. фурункул передней или нижней стенки: воспаление околоушной железы;
6. увеличенные, плотные, болезненные регионарные лимфатические узлы;
7. возможна фебрильная лихорадка;
8. кондуктивное снижение слуха при значительном сужении слухового прохода.

Экзема и дерматиты.

Острая экзема

1. гиперемия и инфильтрация кожи раковины и НСП;
2. везикулёзно-пустулёзная сыпь на отёчном основании, мокнутие, серо-жёлтые корки;
3. выраженный зуд;
4. вторичная инфекция ведёт к ограниченному или диффузному наружному отиту.

Хроническая экзема

1. зуд;
2. утолщение кожи;
3. шелушение, трещины, мокнутие.

Рожистое воспаление.

1. выраженная гиперемия и припухлость кожи раковины, включая мочку, с линией демаркации за пределами раковины;
2. жжение и резкая болезненность при пальпации;
3. интоксикация (озноб, головная боль), лихорадка **до 39–40 °C**;
4. при буллёзной форме пузыри с серозным содержимым.

Перихондрит ушной раковины: мочка уха не вовлечена.

1. выраженная боль в раковине с возможной иррадиацией в голову или шею;
2. отёк, гиперемия, сглаженность контуров раковины;
3. резкая болезненность при пальпации;
4. гной между надхрящницей и хрящом, флюктуация;
5. интоксикация;
6. при позднем обращении расплавление хряща, свищи и рубцовая деформация раковины.

Герпетическое поражение.

1. множественные сгруппированные пузырьки на раковине, в НСП, иногда на барабанной перепонке; после вскрытия корочки;
2. резкая боль, покалывание, зуд;
3. возможна интоксикация;
4. в тяжёлых случаях нейросенсорная тугоухость, нарушение равновесия, парез лицевого и тройничного нервов.

Грибковое поражение: картина зависит от возбудителя.

1. грудные и ясельные дети: беспокойство, маятникообразные движения головы, расчёсы кожи раковин;
2. старшие дети: жидкие выделения (при кандидозе), корочки, зуд, боль, заложенность и снижение слуха; редко головная боль, лихорадка, чувствительность раковины и заушной области.

Возбудитель	Картина
Candida	1. гиперемия, инфильтрация и мацерация кожи НСП, гиперемия барабанной перепонки; 2. отделяемое менее густое, беловатое; 3. на раковине гиперемия с эрозиями, легко снимающиеся беловатые налёты; 4. возможен хондроперихондрит с деформацией раковины.
Aspergillus	1. казеозно-некротические массы в просвете; 2. инфильтрация сильнее в костном отделе, возможен мирингит; 3. беловато-серые наложения с чёрными вкраплениями («молотый перец»); 4. Aspergillus glaucus: зеленоватое отделяемое.
Penicillium	1. желтоватое отделяемое, иногда похоже на серу, по всему слуховому проходу; 2. инфильтрация кожи, сухие корочки и плёнки.
Geotrichum capitatum	1. выраженная инфильтрация кожи НСП, мирингит; 2. плотные «замазкообразные» серовато-жёлтые массы по всему слуховому проходу.

Злокачественный (некротизирующий) наружный отит у детей редок, возможен при иммунодефиците, в том числе при лейкозе после трансплантации костного мозга.

1. интенсивная боль в ухе, головная боль на стороне поражения;
2. системные признаки: интоксикация или лихорадка;
3. возможны болезненность височной кости и парез лицевого нерва;
4. классический симптом: грануляции в костно-хрящевом соединении дна НСП;
5. инфекция распространяется к основанию черепа с остеомиелитом височной кости.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу и физикальному осмотру с отоскопией; другие исследования нужны для выбора лечения, диагностики осложнений и контроля.

3.1 Жалобы

Местные

1. боль в ухе, может усиливаться при пальпации и жевании;
2. зуд в НСП;
3. выделения из уха;
4. снижение слуха.

Системные

1. лихорадка, как правило субфебрильная;
2. ухудшение самочувствия (инфекционный токсикоз).

3.2 Отоскопия

Показания

1. все пациенты с подозрением на наружный отит.

Диагностические признаки

1. болезненность при нажатии на козелок и оттягивании ушной раковины;
2. НСП гиперемирован, как правило сужен отёком;
3. барабанная перепонка видна частично, возможна умеренная гиперемия;
4. при отопневмоскопии подвижность барабанной перепонки, как правило, сохранена.

3.3 Микробиологическое исследование отделяемого из уха

Показания

1. тяжёлое течение: до начала терапии;
2. рецидивирующий и хронический наружный отит;
3. иммунодефицит: иммунодепрессанты, ВИЧ-инфекция, химио- или лучевая терапия;
4. инфекция после операции на ухе;
5. нет ответа на начальную терапию.

Посев на аэробы и факультативные анаэробы с определением чувствительности, микроскопия и посев на дрожжевые и мицелиальные грибы.

Забор материала

1. до начала антимикробной терапии;
2. под зрительным контролем;
3. тонким стерильным зондом-тампоном из просвета или со стенок НСП, не касаясь дистальных отделов наружного уха.

При необходимости контроля или без эффекта исследование повторяют.

3.4 Анализы крови

Рутинно не проводят: лабораторных исследований, подтверждающих диагноз, нет.

Показания

1. все госпитализированные, в том числе со злокачественным наружным отитом: развёрнутый общий анализ крови и С-реактивный белок.

3.5 Рентгенография или КТ височной кости

Показания

1. подозрение на злокачественный наружный отит или деструктивный процесс: рентгенография или КТ височных костей, при необходимости с контрастированием.

Диагностические признаки

1. деструкция височной кости и основания черепа для наружного отита не характерна, кроме злокачественного.

3.6 МРТ височных костей и основания черепа

Показания

1. подозрение на распространение воспаления на окружающие мягкие ткани: уточнение диагноза, распространённости и тактики.

Наркоз по показаниям.

3.7 Консультации специалистов

При поражении наружного уха на фоне системных, в том числе инфекционных, заболеваний: консультация профильного специалиста и обследование по соответствующим КР.

1. детский онколог;
2. инфекционист;
3. аллерголог-иммунолог;
4. детский эндокринолог;
5. невролог;
6. дерматовенеролог.

3.8 Дифференциальная диагностика

Проводят всем с подозрением на наружный отит, в том числе при оторее.

Заболевание	Отличия от наружного отита
Средний отит	1. перфорация барабанной перепонки: диагноз наружного отита сомнителен, вероятен очаг в среднем ухе со вторичным воспалением НСП.
Мастоидит	1. сглаженность заушной складки; 2. изменения больше в заушной области, в проекции антрума; 3. на рентгенограмме или КТ: снижение воздушности, нарушение структуры и целостности клеток сосцевидного отростка.
Гнойный паротит	1. припухлость и болезненность книзу и кпереди от НСП (проекция околоушной железы); 2. обильное гноетечение из уха при прорыве абсцесса через санториниевы щели.
Отомикоз	1. налёты и наложения на коже НСП: тёмный налёт как угольная пыль или «мокрая газетная бумага» (Aspergillus niger), белесоватые хлопья (Candida albicans); 2. предрасполагают влажность и микротравмы, может быть осложнением антибактериальной терапии; 3. подтверждается микробиологическим исследованием.

Злокачественный наружный отит: дифференцировать особенно важно.

Признаки злокачественного наружного отита

1. грануляции в слуховом проходе;
2. микроабсцессы в области наружного уха и основания черепа;
3. костная деструкция по лучевым методам;
4. нет эффекта консервативной терапии **более одной недели**.

Отягощающие факторы

1. сахарный диабет;
2. нейропатии черепных нервов;
3. истощение.

Отсутствие положительной динамики **в течение 1–3 недель** свидетельствует в пользу ЗНО.
Подтверждение: КТ или МРТ (остеомиелит основания черепа), дополнительно маркеры воспаления: нейтрофильный лейкоцитоз, повышение С-реактивного белка.

---

4. Лечение

4.1 Местная терапия

Показания

1. все пациенты с установленным наружным отитом: ушные препараты (противомикробные, кортикостероиды, их комбинации, анальгетики и анестетики).

Препарат должен действовать на синегнойную палочку и золотистый стафилококк. Эффект оценивают **через 48–72 часа**, длительность лечения в среднем **7–10 дней** (до 14).

Препараты из таблицы — начальная местная терапия неосложнённого наружного отита: безопасны и эффективны, осложнения практически не возникают.

Местная терапия создаёт оптимальную концентрацию в очаге, почти не всасывается и реже ведёт к отбору устойчивых штаммов.

Препараты для местного лечения у детей

Препарат	Компоненты	Возрастные ограничения
Офлоксацин, капли глазные и ушные	антибактериальный: офлоксацин	с 12 лет; с 1 года при тимпаностомической трубке
Ципрофлоксацин, капли глазные и ушные	антибактериальный: ципрофлоксацин	с рождения (с 0 лет)
Норфлоксацин, капли глазные и ушные	антибактериальный: норфлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (Комбинил), капли глазные и ушные	антибактериальный: ципрофлоксацин; противовоспалительный: дексаметазон	с 1 года
Бетаметазон + гентамицин, капли глазные и ушные	антибактериальный: гентамицин; противовоспалительный: бетаметазон	с 8 лет

Препарат	Компоненты	Возрастные ограничения
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон, капли глазные и ушные	антибактериальный: грамицидин + фрамицетин; противовоспалительный: дексаметазон	с 1 года
Дексаметазон + неомицин + полимиксин В, капли ушные	антибактериальный: полимиксин В + неомицин; противовоспалительный: дексаметазон	нет ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин В, капли ушные	антибактериальный: полимиксин В + неомицин; анестезирующий: лидокаин	нет ограничений; детям до 1 года только при крайней необходимости и под контролем врача
Рифамицин, капли ушные	антибактериальный: рифамицин	нет ограничений
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол, капли ушные	антибактериальный: хлорамфеникол; противогрибковый: клотримазол; противовоспалительный: беклометазон; анестезирующий: лидокаин	с 6 лет
Миконазол, крем 2% [1] [3]	противогрибковый: миконазол	нет ограничений
Клотримазол, крем 1% [2] [3]	противогрибковый: клотримазол	нет ограничений
Натамицин, крем 2%	противогрибковый: натамицин	нет ограничений

[1] При перфорированной барабанной перепонке грибковое поражение расценивают как системную (инвазивную) инфекцию: противогрибковый препарат системного действия по данным посева, например флуконазол при кандидозном и итраконазол при аспергиллёзном наружном отите, с учётом возрастных ограничений инструкции.

[2] Клотримазол не активен в отношении Aspergillus. [3] Курс **не менее 10 дней**.

Наружный отит как проявление контактного, атопического или себорейного дерматита, псориаза, системной красной волчанки: лечение по соответствующим КР. При себорейном дерматите возможна инфекция грибами Malassezia: нужна местная противогрибковая и (или) противовоспалительная терапия.

Возможны аллергические реакции на местное лечение, в том числе на препараты с неомицином.

4.2 Туалет наружного слухового прохода

Показания

1. все пациенты с наружным отитом: регулярная атравматичная очистка от серы и экссудата, экссудат снижает эффективность местного лечения.

Туалет обычно проводит оториноларинголог. После исключения дефекта барабанной перепонки слуховой проход можно осторожно промывать дистиллированной водой или 0,9% раствором натрия хлорида. Ватными палочками уши не чистить: микротравмы способствуют инфекции.

Грибковый наружный отит: тщательный туалет НСП — обязательное условие местной противогрибковой терапии; его проводят аттиковым зондом и ватником с противогрибковым препаратом.

Кандидозный отит: 1% раствор клотримазола или 1% раствор нафтифина

1. туалет и аппликации на турундах: 2 раза в сутки, экспозиция до 10 минут;
2. курс в среднем **4 недели**.

Плесневые и диморфные грибы: 1% раствор нафтифина

1. туалет и аппликации на турундах: 2 раза в сутки, экспозиция до 15 минут;
2. курс в среднем **4 недели**.

4.3 Обезболивание

Показания

1. выраженный болевой синдром.

Системно ибупрофен или парацетамол в возрастных дозах и (или) местное обезболивание. Ибупрофен в суспензии разрешён **с 3 месяцев**, у парацетамола есть ограничения для детей младшего возраста. Местное обезболивание может замаскировать прогрессирование: такого пациента наблюдают **48 часов**.

Устранение предрасполагающих факторов ускоряет разрешение воспаления (см. «Этиология»).

4.4 Системная антибактериальная терапия

При неосложнённом наружном отите не назначают: результаты местного лечения с системными антибиотиками и с плацебо не различаются.

Показания

1. воспаление вышло за пределы НСП: заушный абсцесс, мастоидит;
2. острый средний отит, в том числе у детей младшего возраста;
3. постлучевой наружный отит;
4. злокачественный (некротизирующий) отит;
5. неконтролируемый сахарный диабет;
6. иммуносупрессия;
7. невозможность местной антибактериальной терапии.

Препарат должен действовать на P. aeruginosa и S. aureus.

Злокачественный наружный отит: доказательных данных недостаточно. До результатов посева — препараты, активные против синегнойной палочки.

1. #ципрофлоксацин внутрь: 20–30 мг/кг в сутки в 2 приёма каждые 12 часов, не более 1500 мг в сутки;
2. или парентерально в эквивалентной дозе: антисинегнойные пенициллины, цефалоспорины III или IV поколения с антисинегнойной активностью, с аминогликозидами или без, по чувствительности возбудителя.

Многие штаммы P. aeruginosa устойчивы к ципрофлоксацину из-за его широкого амбулаторного применения. При иной этиологии (Enterobacterales, Aspergillus и другие плесневые грибы, MRSA) назначают соответствующие системные противомикробные препараты.

Курс **4–6–8 недель**, при грибковой этиологии дольше, например **до 12 недель**.

1. параллельно местная терапия, возможны антисептики и препараты йода;
2. прогрессирование или плохой ответ: хирургическое лечение, возможно с гипербарической оксигенацией.

Во время лечения регулярно контролируют клинику и КТ или МРТ, чтобы оценить ответ и вовремя заметить возобновление; проводят контрольный посев отделяемого. Частота исследований индивидуальна.

4.5 Хирургическое лечение

Показания

1. устранение причины или осложнения наружного отита.

Вмешательства

1. вскрытие и дренирование абсцесса (флегмоны) НСП;
2. иссечение грануляций;
3. секвестрэктомия: удаление костных и хрящевых секвестров;
4. удаление холестеатомы НСП.

Объём в пределах зоны поражения; выполняет оториноларинголог с анестезиологом-реаниматологом.

4.6 Физиотерапия

Селективно как дополнительное лечение: низкочастотное магнитное поле, низкоинтенсивное лазерное излучение эндоаурально, короткое ультрафиолетовое облучение наружного уха. Убедительных доказательств эффективности нет.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Лечение в большинстве случаев амбулаторное. При бактериальном наружном отите улучшение наступает **через 12–24 часа** после начала антибактериальной терапии.

Показания к госпитализации

1. тяжёлое состояние ребёнка;
2. неэффективность лечения;
3. подозрение на прогрессирование воспаления;
4. развитие осложнений.

При неэффективности, прогрессировании и осложнениях нужна консультация оториноларинголога, при злокачественном отите также детского онколога и других специалистов. Выписка: устойчивое купирование проявлений и отсутствие угрозы жизни и здоровью.

Осложнения нелеченого или неадекватно леченого отита

1. переход в хроническую форму с обострениями при неблагоприятных факторах;
2. разрушение хрящевой и костной ткани НСП;
3. распространение на прилегающие ткани и органы.

5.2 Профилактика

Не допускать травм и переувлажнения НСП

1. периодически обрабатывать антисептиком наушники, ушные вкладыши слуховых аппаратов и беруши;
2. пользоваться только своими наушниками, вкладышами и берушами;
3. ограничить время в наушниках;
4. не использовать ватные палочки;
5. избегать жёстких многоразовых берушей;
6. высушивать слуховой проход после попадания воды, в том числе феном.

Детям **старше 2 лет**: своевременное удаление ушной серы как возможной причины острого наружного отита.

Медицинская реабилитация не требуется.

Диспансерное наблюдение не требуется.

Прогноз в большинстве случаев благоприятный.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружный отит»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 18.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	21_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; МАКМАХ
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Нейросенсорная тугоухость у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя **H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная **H91.1** — Пресбиакузис **H91.2** — Внезапная идиопатическая потеря слуха **H91.8** — Другие уточненные потери слуха
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/518_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз сенсоневральной тугоухости:
  1. жалобы на снижение слуха;
  2. нормальная отоскопическая картина;
  3. тимпанограмма типа «А»;
  4. средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц **26 дБ и выше**;
  5. костно-воздушный интервал **не более 10 дБ**.
- Степень тугоухости по среднему порогу воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц:
  1. I степень: **26–40 дБ**;
  2. II степень: **41–55 дБ**;
  3. III степень: **56–70 дБ**;
  4. IV степень: **71–90 дБ**;
  5. глухота: **91 дБ и более**.
- Внезапная и острая идиопатическая потеря слуха: тональная аудиометрия **не позднее суток** от первого обращения и повторно перед выпиской.
- Острая сенсоневральная тугоухость:
  1. экстренная госпитализация в оториноларингологическое (или неврологическое) отделение;
  2. глюкокортикоиды по убывающей схеме.
- Хроническая тугоухость, реабилитация:
  1. слуховой аппарат: средний порог в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе **31 дБ и выше**;
  2. кохлеарная имплантация: двусторонняя тугоухость IV степени или глухота.
- Хроническая тугоухость: наблюдение сурдолога-оториноларинголога, тональная и речевая аудиометрия **1–2 раза в год**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость (СНТ) характеризуется снижением слуха вплоть до его утраты вследствие поражения какого-либо участка звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

2.2 Этиология и патогенез

Основным условием развития тугоухости является повреждение чувствительных структур улитки. Начальным звеном служит дистрофия волосковых клеток, которая при своевременно оказанной помощи может быть обратимой.

Причинами внезапной и острой СНТ являются инфекционные заболевания (грипп, эпидемический паротит, корь, клещевой энцефалит, менингококковый менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис), острые интоксикации и ототоксические препараты (аминогликозиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные препараты и другие), заболевания сердца и сосудов, в том числе нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне и нарушения реологических свойств крови, дегенеративные заболевания позвоночника с синдромом позвоночной артерии, а также моногенная наследственная патология и генетическая предрасположенность.

2.3 Степени тугоухости

Степень тугоухости определяется по усреднённому порогу слышимости воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Степень	Средний порог воздушного звукопроведения
I степень	26–40 дБ
II степень	41–55 дБ
III степень	56–70 дБ
IV степень	71–90 дБ
Глухота	91 дБ и более

2.4 Другие классификации

По темпу развития

1. внезапная: снижение слуха **до 12 часов**;
2. острая: развивается **за 1–3 суток**, сохраняется до месяца;
3. подострая: сохраняется **1–3 месяца**;
4. хроническая (стойкая): сохраняется **более 3 месяцев**.

По времени возникновения

1. врождённая;
2. приобретённая.

По течению

1. стабильная;
2. прогрессирующая;
3. флюктуирующая;
4. обратимая.

По стороне поражения

1. односторонняя;
2. двусторонняя, симметричная или асимметричная.

По этиологии

1. генетическая (наследственная);
2. мультифакториальная (с наследственной предрасположенностью);
3. приобретённая.

2.5 Клиническая картина

Основные проявления

1. снижение слуха;
2. ухудшение разборчивости речи;
3. шум в ушах;
4. ощущение заложенности ушей.

Ведущей жалобой является снижение слуха в сочетании с шумом в ухе, чаще постоянным, преимущественно смешанной тональности.

Острая сенсоневральная тугоухость: внезапное одно- или двустороннее снижение слуха вплоть до глухоты.

Иногда сопровождается (острая травма, нарушение кровотока в лабиринтной артерии, токсическое поражение лабиринта)

1. шумом в ухе;
2. атаксией, головокружением;
3. тошнотой, потливостью;
4. тахикардией, колебаниями артериального давления;
5. спонтанным нистагмом.

2.6 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. время возникновения и темп нарастания снижения слуха;
2. различие слуха на правое и левое ухо;
3. выраженность затруднений при общении;
4. шум в ушах: интенсивность и тональность;
5. вестибулярные нарушения и неврологическую симптоматику.

В анамнезе

1. слух у ближайших родственников;
2. профессиональная деятельность;
3. перенесённые инфекционные и соматические заболевания;
4. наблюдение у других специалистов.

Факторы риска

1. тугоухость у родственников, особенно при совпадении степени, формы и условий возникновения;
2. производственный шум;
3. ототоксические препараты;
4. перенесённые инфекции: менингит, эпидемический паротит, корь, грипп и другие;
5. соматическая патология.

При острой тугоухости сбор анамнеза проводится по следующему плану: общее самочувствие и температура тела; на какое ухо снижен слух, когда и при каких обстоятельствах произошло снижение, изменялся ли слух в динамике, с чем пациент связывает его снижение, отмечалось ли снижение слуха ранее; наличие шума в ушах; наличие и характер головокружения (с определённым направлением или хаотичное), наличие тошноты, рвоты, диареи, потливости, уменьшение головокружения и шума после рвоты; приступы системного головокружения в анамнезе и установленный ранее диагноз болезни Меньера; отиты в анамнезе, принимаемые лекарственные препараты, уровень артериального давления.

Уточняется также наличие гипертонической, ишемической или цереброваскулярной болезни; травмы головы или шейного отдела позвоночника, интенсивного звукового воздействия, плавания или приёма ванны перед снижением слуха; слабости в конечностях, асимметрии лица, нарушений чувствительности, движений и зрения; недавнего стоматологического лечения или протезирования зубов.

3. Диагностика

Основания для диагноза

1. жалобы на снижение слуха, шум в ушах, ухудшение разборчивости речи;
2. нормальная отоскопическая картина;
3. тимпанометрия: тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха регистрируются или отсутствуют;
4. тональная аудиометрия: средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц **26 дБ и более**, костно-воздушный интервал **не более 10 дБ**;
5. речевая аудиометрия соответствует тональной.

3.1 Отоскопия

Диагностические признаки при сенсоневральной тугоухости (норма)

1. наружный слуховой проход свободный;
2. барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая;
3. опознавательные знаки чёткие.

Острая сенсоневральная тугоухость может развиться и у пациента с перенесённой или текущей патологией среднего уха, поэтому отоскопия необходима, однако для постановки диагноза и выбора тактики её недостаточно.

Осматривают также другие ЛОР-органы для исключения заболеваний уха, носа и глотки, нарушающих воздушное звукопроведение.

3.2 Анализы крови

Показания

1. все пациенты: общий (клинический) анализ крови.

При сопутствующей патологии

1. липидный спектр: холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности (ЛПНП, ЛПВП);
2. биохимический анализ: глюкоза, общий и прямой билирубин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевина;
3. коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), протромбиновое время, фибриноген;
4. тиреотропный гормон.

3.3 Акуметрия

Показания

1. все пациенты с подозрением на сенсоневральную тугоухость (СНТ): слуховой паспорт: шёпотная и разговорная речь, камертональные пробы.

Акуметрия носит ориентировочный характер, однако на приёме оториноларинголога её достаточно для направления пациента к сурдологу-оториноларингологу.

3.4 Тональная пороговая аудиометрия

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: базовый метод первичной диагностики и наблюдения.

Частоты

1. воздушное звукопроведение: 125–8000 Гц;
2. костное звукопроведение: 250–6000 Гц;
3. при нормальных порогах и жалобах на снижение слуха или шум: расширенный диапазон 125–20 000 Гц.

Внезапная и острая идиопатическая потеря слуха: аудиометрия **не позднее суток** от первого обращения; перед выпиской повторно:

1. восстановление порогов до нормы;
2. частичное восстановление;
3. стабилизация (без дальнейшего прогрессирования).

По результату определяют дальнейшую тактику.

Хроническая двусторонняя тугоухость: по аудиограмме определяют показания

1. к слухопротезированию, традиционному или имплантационному, включая кохлеарную имплантацию;
2. при необходимости к направлению на медико-социальную экспертизу (МСЭ) и составлению индивидуальной программы реабилитации.

У пользователей слуховых аппаратов, аппаратов костной проводимости и кохлеарных имплантов оценивают эффективность слухопротезирования и при необходимости корректируют его.

При асимметричном снижении слуха маскируют лучше слышащее (неисследуемое) ухо.

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: выявление нарушения функции громкости (рекрутмента).

Тесты

1. пороги дискомфорта;
2. тест SISI;
3. тест Люшера.

Исследование может быть дополнено сопоставлением порогов слышимости с порогами акустического рефлекса на частотах 500–4000 Гц.

3.5 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: тимпанометрия и акустический рефлекс ипси- и контралатерально.

Цели

1. исключение патологии среднего уха;
2. дифференциальная диагностика сенсоневральной и кондуктивной тугоухости;
3. выявление поражения слухового и лицевого нервов, центральных слуховых путей и ядер VII и VIII пар на уровне продолговатого мозга и моста.

Регистрация рефлекса в широком временном окне (до 10 секунд) позволяет выявить его распад, который является признаком ретрокохлеарного поражения.

Других типов тимпанограмм рекомендация не описывает: в критериях диагноза сенсоневральной тугоухости указана тимпанограмма типа «А», акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха могут регистрироваться или отсутствовать.

3.6 Речевая аудиометрия и объективные методы

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: речевая аудиометрия в тишине и на фоне маскирующего шума.

Исследование позволяет определить пороги восприятия и разборчивость речи; речетональная диссоциация (несоответствие речевой и тональной аудиограмм) может указывать на центральные нарушения.

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: раннее выявление эндолимфатического гидропса (электрокохлеография).

В амбулаторных условиях применяют экстратимпанальную электрокохлеографию с внутриушным электродом с регистрацией ответов на стимулы со сгущением и разрежением в начальной фазе.

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ: дифференциальная и топическая диагностика.

Методы

1. коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП);
2. вызванная отоакустическая эмиссия;
3. отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения.

При асимметричной тугоухости целесообразны предъявление стимулов низкой частоты и сравнение межпиковых интервалов I–V с обеих сторон.

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) представляет собой слабые звуковые колебания, генерируемые наружными волосковыми клетками улитки и регистрируемые зондом в наружном слуховом проходе. ОАЭ не регистрируется при порогах слышимости выше 25–30 дБ на частотах 1–4 кГц, охватывающих большую часть речевого диапазона.

КСВП отражают электрическую активность слухового пути в ответ на звуковой стимул и регистрируются с поверхности головы. Ответ представляет собой комплекс положительных пиков I–VII, наиболее стабильным из которых является V пик.

3.7 Интерпретация аудиограммы

1. периферическое (кохлеарное) поражение: нисходящая аудиограмма без костно-воздушного разрыва, феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНТ);
2. центральное (корковое и подкорковое) поражение: аудиограмма чаще нисходящая, без костно-воздушного разрыва, ФУНТ отсутствует; значительно нарушены разборчивость речи в шуме и локализация звука.

3.8 Вестибулометрия и лучевые методы исследования

Показания

1. подозрение на СНТ: оценка преддверия и полукружных каналов, выявление дисфункции лабиринта, дифференциальная диагностика.

Показания

1. все пациенты с подозрением на СНТ, особенно при односторонней и асимметричной тугоухости.

Методы

1. магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, в том числе с внутривенным контрастированием: внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка;
2. компьютерная томография (КТ) височных костей высокого разрешения, в том числе с болюсным контрастированием.

1. рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами;
2. МРТ головного мозга;
3. при односторонней тугоухости МРТ с контрастным усилением: подтверждение или исключение невриномы слухового нерва.

МРТ позволяет уточнить дифференциальный и топический диагноз, уровень поражения слухового анализатора и анатомические особенности уха.

При сопутствующей патологии

1. дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстра- и интракраниальных отделов) с цветным допплеровским картированием;
2. триплексное сканирование вен.

3.9 Консультации и дифференциальная диагностика

Показания

1. любой вид СНТ независимо от длительности: консультации терапевта, невролога, эндокринолога;
2. аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния: исследование иммунного статуса.

Выявление нарушений липидного и углеводного обмена позволяет обосновать патогенетическое лечение.

Дифференцируют с

1. лабиринтопатиями после хронического гнойного отита, радикальной операции на ухе, перенесённого лабиринтита;
2. поражением внутреннего уха при инфекциях и интоксикациях;
3. невриномой VIII нерва;
4. нарушением кровообращения в вертебро-базилярном бассейне;
5. рассеянным склерозом;
6. объёмными образованиями головного мозга;
7. черепно-мозговой и спинальной травмой;
8. серной пробкой;
9. сахарным диабетом, гипотиреозом, хронической почечной недостаточностью и другими состояниями.

На догоспитальном этапе диагноз острой сенсоневральной тугоухости является предположительным. Однако и предположительный диагноз требует экстренной защиты сенсорных структур внутреннего уха и срочной медицинской эвакуации в многопрофильный стационар с ЛОР-отделением для дифференциальной диагностики и лечения.

Показания

1. подозрение на невриному слухового нерва или другое объёмное образование по МРТ или КТ: консультация нейрохирурга.

---

4. Лечение и реабилитация

4.1 Острая и внезапная тугоухость

1. Экстренная госпитализация в оториноларингологическое или неврологическое отделение.
2. Охранительный слуховой режим.
3. Глюкокортикоиды внутривенно (инфузионно) по убывающей схеме с учётом сопутствующей патологии, противопоказаний и побочных эффектов.

   Глюкокортикоиды могут вводиться системно (внутрь или инфузионно) и местно (транстимпанально и транстубарно), возможно сочетание этих путей введения. В остром периоде сочетанное применение позволяет снизить системную дозу без потери эффективности.

4. Предположительно ишемический генез на фоне сердечно-сосудистых нарушений: внутривенно препараты для лечения заболеваний нервной системы, например #этилметилгидроксипиридина сукцинат.

Пациент с диагнозом «острая сенсоневральная тугоухость» направляется на лечение в стационар или дневной стационар.

> В одном разделе рекомендации допускается лечение острой тугоухости в дневном стационаре, тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию в оториноларингологическое или неврологическое отделение.

Препарат	Доза
#Дексаметазон	Внутривенно на 100 мл натрия хлорида: в 1-й и 2-й дни — 24 мг, в 3-й и 4-й — 16 мг, в 5-й — 8 мг, в 6-й — 4 мг, в 7-й день препарат не вводится, в 8-й — 4 мг.
#Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Раствор 5% — 4 мл на 16 мл натрия хлорида внутривенно, 8–10 дней.

4.2 Хроническая тугоухость

По индивидуальным показаниям с учётом соматической патологии назначают поддерживающие курсы лечения.

Назначается охранительный слуховой режим.

Лечение фоновой соматической патологии; **1–2 раза в год** курсы поддерживающей терапии таблетированными препаратами, улучшающими мозговой и лабиринтный кровоток и тканевой обмен.

При некоторых формах хронической тугоухости (наследственной, постменингитной, ототоксической) лечение в отдалённом периоде неэффективно.

При острой тугоухости восстановление слуха на фоне лечения ещё возможно, при хронической вероятность медикаментозного улучшения порогов крайне мала.

Корректнее лечить сопутствующие нарушения; это одновременно профилактика прогрессирования тугоухости

1. сердечно-сосудистые;
2. неврологические;
3. эндокринные;
4. иммунные.

При вестибулярных нарушениях и ушном шуме применяют патогенетическое и симптоматическое лечение.

4.3 Слухопротезирование

Подбор и настройка слуховых аппаратов при среднем пороге на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) на лучше слышащем ухе **31 дБ и более**.

В алгоритме рекомендации уточнено, что пороги должны быть стабильными, а при выборе аппарата учитываются возраст, профессия, образовательные потребности и социальная активность пациента.

Если слуховые аппараты невозможно использовать: имплант среднего уха при порогах костного звукопроведения **не выше 55 дБ на 500 Гц** и **не выше 75 дБ на высоких частотах**.

У пациентов со сниженным зрением и другими инвалидизирующими заболеваниями показания к слухопротезированию расширяются, а требования к техническим средствам реабилитации возрастают.

4.4 Кохлеарная имплантация

При двусторонней тугоухости IV степени или глухоте проводится слухоречевая реабилитация методом кохлеарной имплантации (КИ).

В настоящее время кохлеарная имплантация является единственным эффективным методом реабилитации при тугоухости высокой степени и глухоте и включает комплекс аудиологических, сурдопедагогических, психологических и хирургических мероприятий.

4.5 Показания к кохлеарной имплантации

№	Показание
1	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени с порогами слуха 80 дБ и более по данным КСВП
2	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени со средними порогами на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц 80 дБ и более по данным тональной пороговой аудиометрии
3	Пороги в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами (бинаурально) выше 55 дБ на частотах 2–4 кГц
4	Отсутствие выраженного улучшения восприятия речи с оптимально подобранными слуховыми аппаратами при среднем пороге выше 95 дБ после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)
5	Разборчивость речи в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами менее 40% после 3–6 месяцев их использования (по заключению сурдопедагогической комиссии)

> Пороговые значения для кохлеарной имплантации в КР не согласованы с классификацией той же рекомендации. По разделу 1.5 IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как показания 1 и 2 касаются «IV степени с порогами 80 дБ и более», то есть охватывают и глухоту, но не всю IV степень. Показание 4 предусматривает средний порог выше 95 дБ, что соответствует глухоте, хотя речь в нём идёт о «высокой степени тугоухости».

Абсолютные противопоказания

1. полная аплазия внутреннего уха (аномалия Мишеля);
2. полная облитерация улитки;
3. тяжёлые соматические, неврологические и психические заболевания;
4. недостаточность интеллекта и отсутствие коммуникативных возможностей (исключения возможны для слабовидящих и слепых).

Относительные противопоказания

1. отсутствие мотивации и возможностей для длительной реабилитации;
2. частичная облитерация улитки;
3. выраженные аномалии улитки и слухового нерва;
4. обострение воспалительных заболеваний ЛОР-органов;
5. ретрокохлеарная патология.

При облитерации, аномалиях и ретрокохлеарной патологии решение принимает врачебная комиссия центра, выполняющего операцию.

Двусторонняя (бинауральная) имплантация выполняется одномоментно или последовательно. Она обеспечивает стимуляцию слуховых путей с обеих сторон, локализацию звука, лучшую разборчивость речи в шуме и при разговоре нескольких собеседников, более естественное и менее утомительное восприятие, а также сохранение слуха при поломке одного импланта.

Одномоментная бинауральная имплантация показана при хронической двусторонней тугоухости IV степени и глухоте после перенесённого менингита (при наличии выписки из стационара) по решению врачебной комиссии.

Последовательная бинауральная имплантация показана при оссификации или облитерации улитки после перелома височных костей и при отосклерозе, при аномалиях развития внутреннего уха, а также при хорошей динамике слуха и речи после односторонней имплантации и высокой мотивации; во всех случаях решение принимает врачебная комиссия центра. Объём последовательных имплантаций не должен превышать 10% годового объёма данного вида помощи в учреждении.

Противопоказания аналогичны противопоказаниям к кохлеарной имплантации; дополнительным противопоказанием является интервал между операциями, при котором система КИ используется с одной стороны более 5 лет.

Объём кохлеарной имплантации взрослым пациентам в учреждении не должен превышать 20% государственного задания по данному виду высокотехнологичной медицинской помощи. Гарантийный срок на имплант составляет не менее 10 лет, на речевой процессор не менее 5 лет.

4.6 Повторная имплантация

Причина	Тактика ведения
Техническая неисправность импланта	Реимплантация
Гнойное воспаление среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)	Санация полостей среднего уха, тимпанопластика. При невозможности сохранения импланта показаны эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Экструзия корпуса импланта	Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Миграция корпуса импланта, исключающая использование речевого процессора, или экстракохлеарное положение электродной решётки	В таблице КР не заполнено

Реимплантация выполняется системой того же производителя; установка системы другого производителя возможна только за счёт внебюджетных средств, что отражается в информированном согласии.

При выходе импланта из строя в течение гарантийного срока производитель по заявлению медицинской организации в течение 10 суток предоставляет первичное заключение и в течение 30 суток после него предоставляет новый имплант. Неисправность окончательно устанавливается по результатам технической экспертизы извлечённого импланта, продолжительность которой не превышает трёх месяцев.

4.7 Физиотерапевтическое лечение и другие методы реабилитации

Пациентам с тугоухостью и шумом в ушах проводится электростимуляция.

Применяются постоянный импульсный ток прямоугольной формы и флюктуирующие токи силой 0,5–2 мА; частота подбирается в соответствии с частотой шума. Продолжительность процедуры 10–15 минут, курс 10–15 процедур. Метод противопоказан пользователям кохлеарного, стволомозгового импланта и импланта среднего уха.

Гипербарическая оксигенация: **10–20 процедур** при давлении 1,5–2,5 атм по 1–2 часа.

Лечение предпочтительно начинать в течение первого месяца от начала заболевания; результаты лучше при сочетании с глюкокортикоидами.

В курс лечения включается рефлексотерапия.

Эффективен как дополнительное лечение, в том числе на поздней стадии; электропунктура эффективнее классической иглорефлексотерапии.

Параметры

1. импульсы длительностью 1 мс переменной полярности частотой 61 Гц;
2. амплитуда до ощущения лёгкого покалывания;
3. по 10 минут на пару точек;
4. курс 10–15 процедур ежедневно или через день.

Проводится электронейростимуляция головного мозга.

Наибольшая эффективность отмечается при начальной и лёгкой степени тугоухости, в том числе при аудиоселективной транскраниальной электростимуляции: сила тока до 1,0 мА, продолжительность 20 минут, 15 процедур через день. Метод противопоказан пользователям имплантов.

В курс лечения включаются дозированные физические нагрузки.

Используются баланстерапия и дыхательная гимнастика курсами по 3 месяца, 3 раза в неделю по 40 минут, а также ежедневный терренкур продолжительностью не менее 20 минут.

Проводится транскраниальная магнитная стимуляция, в том числе при шуме в ушах на фоне тугоухости.

Выполняют ритмическую стимуляцию височно-теменных, лобных и префронтальных областей коры. Метод противопоказан пользователям имплантов.

Применяются лекарственный ультрафонофорез и внутриушной электрофорез лекарственных препаратов.

В наружный слуховой проход вводится 1,5–2,0 мл лекарственного препарата, нагретого до 36–37 °C. Продолжительность процедуры 5–15 минут при частоте 880 кГц, мощности до 0,2 Вт/см^2 и гальваническом токе до 0,3 мА; курс 10–12 процедур. Метод противопоказан пользователям имплантов.

В курс лечения включается медицинский массаж.

Назначают лечебный массаж шеи и воротниковой зоны (классический, точечный или вакуумный) ежедневно, курсом до 10 процедур.

В комплексной терапии применяется лазеротерапия.

Внутривенное лазерное облучение крови сочетается с введением трентала: длина волны 630 нм, мощность 1,0–2,0 мВт, продолжительность 25–30 минут, 5–7 процедур ежедневно. При эндауральной методике длина волны составляет 808–810 нм, плотность потока 8–15 мВт/см^2, продолжительность 8–10 минут, 12–14 процедур ежедневно.

В курс лечения включается слуховой тренинг в виртуальной реальности.

Метод показан в качестве дополнительного при хронической тугоухости лёгкой степени и скрытой потере слуха: ежедневно в течение 7 дней по 15 минут с одной паузой продолжительностью 2 минуты.

Проводятся вестибулярные тренировки, в том числе в виртуальной реальности.

Тренировки равновесия назначают ежедневно или через день по 30 минут, курс 20 процедур.

Для улучшения слуха, в том числе после кохлеарной имплантации, используются мобильные приложения с шумоподавлением в режиме реального времени.

Методы, перечисленные в пунктах 4–15 раздела реабилитации, как правило, применяются в ходе санаторно-курортного лечения после консультации врача.

4.8 Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение рекомендуется в хронической стадии тугоухости, врождённой или приобретённой; в таблице КР перечислены все степени, от I до глухоты.

Код	Заболевание
H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя
H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточнённая

Показаны бальнеологические курорты с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми и йодобромными водами, климатические (приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные) и грязевые курорты.

При неэффективности как слуховых аппаратов, так и кохлеарных имплантов необходим альтернативный способ коммуникации: обучение дактилю и жестовому языку, сурдоперевод.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Диспансерное наблюдение у сурдолога-оториноларинголога в сурдологическом кабинете или центре по месту жительства.

Эффективность слуховых аппаратов оценивают по речевой аудиометрии в свободном звуковом поле в тишине и в шуме и по анкете о качестве жизни.

1. тональная и речевая аудиометрия в тишине и в шуме, коррекция настроек аппарата: **1–2 раза в год**.

При остром ухудшении или быстром прогрессировании тугоухости исследование повторяется незамедлительно для своевременного проведения лечения и восстановления порогов.

После кохлеарной имплантации

1. речевая аудиометрия в свободном звуковом поле в тишине и в шуме: после подключения процессора и на каждой настроечной сессии, **2–4 раза в год**, с анкетированием;
2. тональная и речевая аудиометрия: **1–2 раза в год**;
3. настройка речевого процессора: **2–4 раза в год**.

Для оценки эффективности слуховых аппаратов в рекомендации приведён опросник «Международная оценка использования слуховых аппаратов» из 7 вопросов. Если во всех вопросах выбраны ответы 1 и 2, необходимы коррекция настроек, повторное обследование слуха и направление пациента на слухоречевую реабилитацию; если во всех вопросах выбран вариант 3, требуется коррекция настроек; при вариантах 4 и 5 изменение настроек не требуется.

При односторонней тугоухости необходима дополнительная дифференциальная диагностика, при вестибулярных нарушениях и ушном шуме требуются дополнительные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия.

По показаниям пациента направляют на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о стойкой нетрудоспособности.

Одновременно с установлением группы инвалидности составляют индивидуальную программу реабилитации с выбранным способом коррекции слуха

1. традиционное слухопротезирование;
2. имплантационное слухопротезирование;
3. кохлеарная имплантация.

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. острая сенсоневральная тугоухость;
2. замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации (круглосуточный или дневной стационар).

Выписка осуществляется при выздоровлении или улучшении состояния.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у взрослых»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 22.03.2023 (год утверждения в PDF не заполнен: «20__»)
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года; следующая версия ожидалась не позднее марта 2026 года, но на 22.10.2026 в рубрикаторе действует эта
Код в рубрикаторе	518_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Пороги для кохлеарной имплантации не согласованы с классификацией: IV степени соответствуют пороги 71–90 дБ, тогда как в показаниях указаны «IV степень с порогами 80 дБ и более» и средний порог «более 95 дБ» (по классификации это соответствует глухоте).
- В разделе 3.1 пациент с острой тугоухостью направляется «в стационар или дневной стационар», тогда как следующая рекомендация предусматривает экстренную госпитализацию.
- В схеме #дексаметазона на 7-й день препарат не вводится, а на 8-й день вновь вводится 4 мг; так указано в тексте КР.

Клинические рекомендации

Нейросенсорная тугоухость у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя **H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 10.02.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/22_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Основные признаки: нет или сомнительная реакция ребёнка на звуки, задержка речевого развития; если слух снизился после овладения речью — распад речи. Степени по среднему порогу воздушной проводимости на 500, 1000, 2000 и 4000 Гц:
  1. I степень: **26–40 дБ**;
  2. II степень: **41–55 дБ**;
  3. III степень: **56–70 дБ**;
  4. IV степень: **71–90 дБ**;
  5. глухота: **91 дБ и более**.
- Аудиологический скрининг всем новорождённым:
  1. 1-й этап, регистрация ОАЭ: **до 1 месяца**;
  2. 2-й этап, подтверждающая диагностика в сурдологическом центре: **до 3 месяцев**;
  3. начало реабилитации при подтверждённой тугоухости: **до 6 месяцев**.

  Дети с факторами риска проходят полное аудиологическое обследование независимо от результата скрининга.
- Острая тугоухость: глюкокортикоиды системно или интратимпанально, госпитализация. Хроническую (стойкую) тугоухость консервативно не лечат.
- Слухопротезирование: двусторонняя хроническая тугоухость со средним порогом на лучше слышащем ухе **31 дБ и более**.
- Кохлеарная имплантация: хроническая двусторонняя тугоухость IV степени или глухота (пороги **80 дБ и более** на 500–4000 Гц) без эффекта от слуховых аппаратов за **3–6 месяцев**; приоритет — дети **до 3 лет**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Сенсоневральная тугоухость (СНТ): снижение слуха вплоть до утраты при поражении звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

2.2 Классификация

По степени тяжести: средний порог воздушной проводимости на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц

1. I степень: **26–40 дБ**;
2. II степень: **41–55 дБ**;
3. III степень: **56–70 дБ**;
4. IV степень: **71–90 дБ**;
5. глухота: **91 дБ и более**.

По времени возникновения

1. врождённая: тугоухость с рождения или выявленный патологический генотип независимо от срока выявления тугоухости;
2. приобретённая: после установленной причины с ухудшением реакции на звуки и возможным регрессом речи, или по неизвестной причине при доказанном ранее нормальном слухе.

По остроте

1. внезапная (идиопатическая): развивается **до 12 часов**;
2. острая: развивается **за 1–3 суток**, сохраняется **до 1 месяца**;
3. подострая: **1–3 месяца** от начала;
4. хроническая (стойкая): **более 3 месяцев** или нет данных о начале.

По течению

1. стабильная;
2. прогрессирующая;
3. флюктуирующая;
4. с улучшением.

По речевому развитию

1. доречевая (долингвальная): до овладения речью;
2. послеречевая (постлингвальная): после овладения речью.

2.3 Этиология

Наследственные причины

1. изменения генотипа у 70% детей с врождённой и доречевой тугоухостью, в 70–85% несиндромальные формы;
2. чаще всего мутации гена GJB2 (коннексин 26), в России прежде всего 35delG: более 50% детей со стойкой двусторонней тугоухостью; рецессивные мутации дают врождённую двустороннюю тугоухость тяжёлой степени и глухоту;
3. синдромальные формы: синдромы Пендреда, Ашера IIA, бранхио-ото-ренальный, Ваарденбурга и другие.

Ненаследственные причины врождённой тугоухости

1. самая частая: врождённая цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ); при бессимптомной форме тугоухость в 25%, в половине случаев прогрессирующая;
2. реже краснуха, токсоплазмоз, сифилис.

Причины приобретённой тугоухости

1. менингит;
2. вирусные детские инфекции;
3. ототоксические препараты: аминогликозиды, диуретики и другие;
4. травмы головы: перелом височных костей, основания черепа;
5. нейродегенеративные заболевания.

Факторы риска стойкой врождённой и перинатальной тугоухости

1. ближайшие родственники с нарушением слуха с детства;
2. синдромы или генетические заболевания, связанные с нарушением слуха;
3. аномалии ушной раковины, слухового прохода, другие челюстно-лицевые аномалии (кроме ушных привесков и изолированной расщелины верхней губы);
4. внутриутробные инфекции: ЦМВИ, краснуха, токсоплазмоз, сифилис;
5. пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых **более 48 часов**;
6. недоношенность **32 недели и менее** или масса тела при рождении **менее 1500 г**;
7. гипербилирубинемия, потребовавшая заменного переливания крови;
8. перинатальная асфиксия, гипоксия;
9. тяжёлое гипоксически-ишемическое или геморрагическое поражение ЦНС, ДЦП, органическое поражение ЦНС, нейродегенеративные заболевания;
10. лечение ототоксическими препаратами;
11. экстракорпоральная мембранная оксигенация.

2.4 Клиническая картина

Признаки

1. нет или сомнительная реакция на окружающие звуки;
2. задержка этапов речевого развития: гуления, лепета, первых слов, простых фраз;
3. после овладения речью: распад речи — нет новых слов, ухудшается звукопроизношение вплоть до исчезновения устной речи;
4. старшие дети сами отмечают снижение слуха, плохую разборчивость речи, шум в ушах.

В анамнезе уточняют

1. слух ближайших родственников;
2. течение беременности, гестационный возраст, течение родов, массу тела при рождении, оценку по шкале Апгар;
3. течение перинатального периода;
4. инфекционные и соматические заболевания, наблюдение у других специалистов.

Отоскопия: слуховой проход свободный, барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая, опознавательные знаки чёткие. Осматривают и другие ЛОР-органы, чтобы исключить нарушение воздушного звукопроведения.

---

3. Диагностика

Перед исследованием слуха выполняют отоскопию. У детей раннего возраста диагноз основан на объективных методах (ОАЭ, КСВП, ASSR, акустическая импедансометрия) и оценке поведенческих реакций на звуки и речь; у старших дошкольников и школьников добавляют тональную пороговую, надпороговую и речевую аудиометрию.

Критерии диагноза

1. подозрение на тугоухость при скрининге новорождённых, нет или изменены реакции на звуки, задержка или нарушение речевого развития, жалобы на снижение слуха, факторы риска;
2. нормальная отоскопическая картина;
3. повышение порогов и (или) изменение морфологии КСВП (при слуховой нейропатии регистрируется микрофонный потенциал улитки), повышение порогов ASSR, нет ОАЭ (при слуховой нейропатии ОАЭ может регистрироваться), повышение порогов при тональной аудиометрии по типу нарушения звуковосприятия.

3.1 Аудиологический скрининг новорождённых

Показания

1. все новорождённые: регистрация отоакустической эмиссии (ОАЭ) перед выпиской из роддома и (или) в поликлинике **до 1 месяца**.

Не прошедшим скрининг в роддоме и родившимся вне родовспомогательного учреждения — в поликлинике **до 3 месяцев**. При более позднем обращении с сомнительной реакцией на звуки — сразу полное обследование в специализированном центре.

Протокол

1. ОАЭ на **3–4-е сутки** в роддоме, при переводе в отделение патологии новорождённых — при выписке;
2. нет чёткого ответа на одно или оба уха: повтор в поликлинике **в 1 месяц**;
3. ОАЭ не зарегистрирована: 2-й этап в сурдологическом центре **до 3 месяцев**.

Полное аудиологическое обследование независимо от результата скрининга

1. ближайшие родственники с нарушением слуха с детства;
2. синдромы, связанные с нарушением слуха;
3. челюстно-лицевые аномалии (кроме ушных привесков и изолированной расщелины верхней губы);
4. внутриутробные инфекции: ЦМВИ, краснуха, токсоплазмоз, сифилис;
5. реанимация новорождённых **более 48 часов**;
6. недоношенность **32 недели и менее** или масса тела **менее 1500 г**;
7. тяжёлая гипербилирубинемия с заменным переливанием крови;
8. тяжёлое гипоксически-ишемическое или геморрагическое поражение ЦНС;
9. ототоксические препараты.

У новорождённых высокого риска возможна отсроченная или прогрессирующая тугоухость. При задержке слуховых реакций или речи на любом этапе ребёнка направляют на исследование слуха по возрасту.

3.2 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы и ASSR

Показания

1. ОАЭ не зарегистрирована на 1-м этапе скрининга;
2. дети **до 3 лет** с факторами риска;
3. дети **до 3 лет** с задержкой развития, когда поведенческие реакции на звуки трудно оценить.

Проводят в сурдологическом центре во время естественного сна; под медикаментозной седацией — только в учреждении с реанимационной службой.

1. пороги КСВП в каждом ухе на щелчки и (или) широкополосные Chirp-стимулы, шаг не более 10 дБ; анализ морфологии, межпиковых интервалов и латентностей;
2. для выявления слуховой нейропатии: стимулы противоположной полярности, внутриушные телефоны, тест с пережатым звуководом для верификации микрофонного потенциала;
3. для степени тугоухости и слухопротезирования нужна частотно-специфичная информация: ASSR, тональные посылки 1000 или 500 Гц;
4. ASSR не используют изолированно (ей предшествует КСВП на щелчок) и при подтверждённой слуховой нейропатии.

3.3 Отоакустическая эмиссия

Показания

1. подозрение на нарушение слуха: задержанная вызванная ОАЭ и (или) ОАЭ на частоте продукта искажения, оценка функции улитки.

Проводят и при нормальных порогах КСВП на щелчки — для частотно-специфичной информации.

3.4 Акустическая импедансометрия

Показания

1. все дети, обследуемые у сурдолога-оториноларинголога: тимпанометрия и акустическая рефлексометрия.

Детям **до 6 месяцев** тимпанометрия с высокочастотным зондирующим тоном (обычно 1000 Гц), недоношенным — **до 8–12 месяцев**.

3.5 Аудиометрия по возрасту

Показания

1. дети **от 6 месяцев до 2 лет**: тональная пороговая аудиометрия со зрительным подкреплением.

Ребёнок с родителем в звукозаглушённой камере; на звук (трель 1000 Гц) ребёнок поворачивается — включается игрушка или картинка. Частоты 250–4000 Гц. В свободном звуковом поле результат относят к лучше слышащему уху.

Показания

1. дети **от 2 до 5 лет**: игровая аудиометрия, пороги на 125–8000 Гц для каждого уха по воздушной и костной проводимости.

Показания

1. дети **старше 5 лет**: тональная пороговая аудиометрия по стандартной методике, 125–8000 Гц, воздушная и костная проводимость.

При возможности — расширенный диапазон до 16–20 кГц, в том числе для контроля ототоксичности.

Показания

1. дети **старше 6–7 лет**: речевая аудиометрия в тишине и на фоне шума.

Тоно-речевая диссоциация может указывать на слуховую нейропатию или центральные слуховые расстройства.

Открытый выбор: ребёнок повторяет слово; закрытый: показывает картинку. Подача в телефонах или в свободном звуковом поле; при подаче в оба уха или через колонки результат относится к лучше слышащему уху. Для оценки слухопротезирования и КИ — в свободном звуковом поле.

Показания

1. дети **старше 6–7 лет**: надпороговая аудиометрия — пороги дискомфорта, тесты на центральные слуховые расстройства.

Определяет уровень поражения; центральные расстройства меняют тактику реабилитации.

3.6 Молекулярно-генетическое исследование гена GJB2

Показания

1. все дети с несиндромальной двусторонней СНТ любой степени: исследование мутации 35delG гена GJB2 в крови.

При двух рецессивных мутациях GJB2 и без воспаления в среднем ухе восстановления слуха не ждут, пороги обычно стабильны; раннее начало реабилитации даёт хороший результат.

Консультация врача-генетика по результатам молекулярно-генетического исследования.

3.7 ПЦР на цитомегаловирус

Показания

1. новорождённые с подозрением на ЦМВИ: ДНК цитомегаловируса в мазке со слизистой ротоглотки методом ПЦР в первые **3 недели жизни**.

Субклиническая врождённая ЦМВИ — причина 20% нарушений слуха у новорождённых; тугоухость может развиться отсроченно.

3.8 КТ височных костей и МРТ

Показания

1. тугоухость неясной этиологии и (или) односторонняя: КТ височных костей с шагом **не более 0,6 мм**.
2. по показаниям: МРТ головного мозга (мостомозжечковый угол) и внутреннего уха.

Диагностические признаки

1. КТ: аномалии внутреннего уха, изменения внутреннего слухового прохода, оссификация лабиринта;
2. МРТ: гипо- и аплазия, объёмные образования слухового нерва, фиброзная облитерация, ликворные свищи лабиринта, поражения центральных отделов.

3.9 Оценка развития и консультации

Всем детям с нарушением слуха: оценка слухоречевого, когнитивного и коммуникативного развития. Слухоречевое развитие оценивает сурдопедагог по опросникам, общее развитие — специалист, предпочтительно психолог.

1. LittlEARS, шкалы уровней слухового восприятия и разборчивости речи, PEACH, Макартуровский опросник, батарея EARS;
2. общее развитие: шкала KID (до 16 месяцев), RCDI-2000 (от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев), M-CHAT (16–30 месяцев), тест Векслера (старше 4 лет), матрицы Равена (старше 5 лет).

Консультация педиатра, при необходимости других специалистов:

1. невролог;
2. офтальмолог;
3. генетик;
4. кардиолог;
5. нефролог;
6. медицинский психолог;
7. психиатр.

У 24–40% детей с нарушением слуха есть дополнительные расстройства, влияющие на реабилитацию.

---

4. Лечение

4.1 Острая сенсоневральная тугоухость

Показания

1. острая СНТ любой этиологии: глюкокортикоиды системно или интратимпанально.

Например, #метилпреднизолон 1 мг/кг в сутки внутрь однократно, 14 дней, с постепенным снижением дозы каждые 4 дня.

При острой, подострой и хронической СНТ — лечение сопутствующей неврологической и иной патологии профильными специалистами.

Хроническую (стойкую) СНТ у детей консервативно не лечат.

4.2 Слухопротезирование

Индивидуальная программа реабилитации формируется при подтверждённой тугоухости **до 6 месяцев** (у недоношенных — скорректированного возраста) и начинается сразу после выявления нарушения слуха.

Включает

1. слухопротезирование;
2. помощь сурдопедагога, логопеда и психолога;
3. информационную и психологическую поддержку семьи;
4. социальную поддержку;
5. диспансерное наблюдение.

При оформлении инвалидности готовят заключение для МСЭ с реабилитационными мероприятиями и техническими средствами реабилитации (ТСР).

Показания

1. двусторонняя хроническая тугоухость: средний порог воздушной проводимости на 500–4000 Гц на лучше слышащем ухе **31 дБ и более**;
2. двусторонняя тугоухость I степени и корригируемая односторонняя: решение после речевого тестирования и (или) психолого-педагогической оценки;
3. некорригируемая односторонняя тугоухость (глухота): системы выносного микрофона.

Противопоказания

1. острое снижение слуха: нужна диагностика и лечение;
2. для аппаратов воздушного звукопроведения: обострение гнойного воспаления наружного или среднего уха;
3. в ряде случаев тяжёлое головокружение.

Показания определяют по КСВП и ASSR и поведенческим порогам методикой по возрасту.

Валидация — оценка эффективности слухопротезирования и программы реабилитации — **не реже 1 раза в 6 месяцев**: один-два аудиологических метода, анкета и сурдопедагогическое тестирование.

При неудовлетворительном результате ищут и устраняют причину и повторяют валидацию **через 1–3 месяца**.

1. тональные пороги с аппаратом или имплантом в свободном поле для каждого уха;
2. речевая аудиометрия с аппаратом в свободном поле детям старше 5 лет при достаточном развитии речи, в тишине и в шуме;
3. анкетирование родителей и педагогов, батарея EARS;
4. критерии эффективности: положительная динамика слухового и речевого развития, рост разборчивости слов в тишине.

Адаптация к аппарату обычно **1–3 месяца**: не менее 1–4 повторных консультаций сурдолога и сурдопедагога. В первые 2 года пользования настройки контролируют **не реже раза в 3 месяца**.

Частота наблюдения после настройки

1. дети до 2 лет: **раз в 3 месяца**;
2. до 6–7 лет: **раз в 6 месяцев**;
3. далее 1–2 раза в год.

Детям с аппаратами и имплантами показано диспансерное наблюдение оториноларинголога и сурдолога-оториноларинголога.

Все дети с аппаратами и имплантами — кандидаты на вспомогательные слуховые технологии, особенно школьники, при высокой степени тугоухости, слуховой нейропатии и центральных расстройствах.

1. персональные и коллективные FM-системы;
2. индукционные устройства;
3. цифровые системы: выносные микрофоны, беспроводные стримеры;
4. телефоны с усилителем, с текстовым выходом;
5. телевизор с телетекстом;
6. вибрационные и световые сигнализаторы звука.

4.3 Кохлеарная имплантация

Показания

1. хроническая двусторонняя СНТ IV степени или глухота со средними порогами **80 дБ и более** на 500–4000 Гц по комплексному обследованию, включая КСВП и ASSR;
2. пороги в свободном поле с оптимально подобранными аппаратами на оба уха **выше 40 дБ** на 0,5–4 кГц;
3. нет выраженного улучшения восприятия речи с аппаратами **за 3–6 месяцев** по заключению сурдопедагогической комиссии;
4. слуховая нейропатия любой степени при неэффективности аппаратов **не менее 3–6 месяцев**.

1. приоритет: дети **до 3 лет**;
2. **старше 3 лет** без слухоречевых навыков: по решению врачебной комиссии центра после консультации сурдолога и педагогического наблюдения;
3. вопрос о КИ решают после постоянного ношения аппаратов на оба уха **3–6 месяцев**;
4. мутации GJB2 и тугоухость после менингита: можно направлять на КИ, минуя этап слуховых аппаратов.

Абсолютные противопоказания

1. полная аплазия внутреннего уха (аномалия Michel);
2. полная облитерация улитки;
3. тяжёлые соматические, неврологические и психические заболевания, препятствующие наркозу, пользованию имплантом и реабилитации.

Относительные противопоказания (решает врачебная комиссия центра)

1. нет мотивации и возможностей семьи для длительной реабилитации;
2. частичная облитерация улитки;
3. аномалии развития улитки и слухового нерва;
4. обострение воспалительных заболеваний ЛОР-органов;
5. ретрокохлеарная патология.

Двусторонняя кохлеарная имплантация

Одномоментная

1. хроническая двусторонняя СНТ IV степени и глухота после менингита (с выпиской из стационара), по решению врачебной комиссии.

Последовательная

1. оссификация или облитерация улитки после перелома височных костей и отосклероза;
2. комбинированные или изолированные аномалии внутреннего уха;
3. нарушения зрения;
4. положительная динамика после односторонней КИ при высокой мотивации семьи; не более 20% годового объёма таких операций в учреждении.

Даёт локализацию источника звука, лучшую разборчивость в шуме, лучшую динамику развития речи, сохраняет слух при поломке одного импланта.

Гарантийный срок импланта не менее 10 лет, речевого процессора не менее 5 лет.

Повторная кохлеарная имплантация (реимплантация)

Причина	Методы лечения
Техническая неисправность кохлеарного импланта	Реимплантация кохлеарного импланта
Гнойные воспалительные заболевания среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)	Санация полостей среднего уха, тимпанопластика; если имплант сохранить нельзя — эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на противоположном ухе при отсутствии противопоказаний
Экструзия корпуса внутренней части импланта	Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на противоположном ухе при отсутствии противопоказаний
Миграция корпуса внутренней части с невозможностью пользоваться речевым процессором, экстракохлеарное положение электродной решётки	Репозиция внутренней части системы КИ

Реимплантацию выполняют по решению комиссии оперирующей клиники. При поломке импланта в гарантийный срок производитель проводит предварительную экспертизу и предоставляет новую внутреннюю часть; окончательно неисправность устанавливает техническая экспертиза извлечённого импланта.

Стволомозговой слуховой имплант: показания (решает врачебная комиссия)

1. двусторонняя глухота при повреждении слуховых нервов: нейрофиброматоз 2 типа, черепно-мозговая травма;
2. значительная или полная оссификация улиток;
3. аплазия слуховых нервов или улиток.

Противопоказания

1. сопутствующая патология, препятствующая операции;
2. нет мотивации и возможностей семьи для длительной реабилитации.

4.4 Медико-социальная экспертиза

Направлять на МСЭ при двусторонней тугоухости

1. II степени (**41–55 дБ**) со стойкими умеренными нарушениями языковых и речевых функций;
2. III степени (**56–70 дБ**);
3. IV степени (**71–90 дБ**), в том числе после КИ;
4. двусторонней глухоте (**более 91 дБ**), в том числе после КИ;
5. III–IV степени на одно ухо и глухоте на другое;
6. сочетании нарушений зрения и слуха, нарушениях артикуляции и голосообразования.

А также при ограничениях жизнедеятельности (общение, ориентация, обучение и другие) и потребности в социальной защите, включая реабилитацию. Направление оформляет поликлиника по результатам аудиологического обследования.

Всем признанным инвалидами разрабатывают индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА); выписку из неё МСЭ направляет в органы, которые организуют её выполнение.

4.5 Психолого-педагогическая помощь

Всем детям с нарушением слуха: на этапе диагностики, до, во время и после слухопротезирования — занятия и консультации сурдопедагога, логопеда и психолога с вовлечением семьи, включая консультации близких по уходу за ТСР, общению с ребёнком и занятиям дома.

Долингвальная тугоухость: развитие слухового восприятия и устной речи с аппаратом или имплантом, занятия с сурдопедагогом 1–5 раз в неделю на протяжении 1–7 лет.

Постлингвальная тугоухость: адаптация к восприятию с ТСР и развитие слухо-зрительного восприятия речи, 1–100 занятий с сурдопедагогом.

4.6 Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, санаторно-курортное лечение

Физиотерапия в курсе лечения: гальванизация, внутриушной электрофорез, электростимуляция, амплипульстерапия, магнитотерапия, ультрафиолетовое и лазерное излучение, вибротерапия, оксигенотерапия; курс 8–10 процедур ежедневно или через день.

Детям с кохлеарным, стволомозговым имплантом и имплантом среднего уха магнитотерапия и электротерапия на голову и шейно-воротниковую область противопоказаны; гидрокинезотерапия — со снятой наружной частью импланта.

Лечебная физкультура: баланс-терапия и дыхательная гимнастика курсами 3 месяца, 3 раза в неделю по 30–40 минут; терренкур не менее 20 минут ежедневно.

Лечебный массаж околоушной, затылочной и воротниковой области ежедневно, курс 8–10 процедур.

Мобильные приложения с шумоподавлением в реальном времени, в том числе после кохлеарной имплантации.

Санаторно-курортное лечение 1 раз в год по показаниям, при хронической стадии.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. острая сенсоневральная тугоухость;
2. замена речевого процессора КИ (дневной стационар);
3. объективное аудиологическое обследование под общей анестезией (дневной стационар).

Выписка

1. выздоровление;
2. улучшение.

5.2 Диспансерное наблюдение

Показания

1. подтверждённая СНТ: наблюдение сурдолога-оториноларинголога по месту жительства.

Частота аудиологических обследований

1. первые 2 года жизни и (или) пользования аппаратом: **не реже раза в 3 месяца**;
2. 2–5 лет и (или) 2–3-й год пользования: **каждые 3–6 месяцев**;
3. **старше 5 лет** и (или) после 3–4 лет пользования: **1–2 раза в год**;
4. после КИ — по КР «Реабилитация пациентов после КИ».

Односторонняя тугоухость или не требующая слухопротезирования: слух, язык и речь **каждые 6 месяцев** **до 3 лет**, далее 1–2 раза в год.

Особые группы (аномалии улитки и слухового нерва, оссификация улитки, слуховая нейропатия, сопутствующие нарушения, длительная глухота, тугоухость после черепно-мозговой травмы): индивидуальный график тестирования и настройки.

Показания

1. любая форма врождённой ЦМВИ: наблюдение сурдолога-оториноларинголога, тугоухость может развиться отсроченно.

Частота обследований

1. до 12 месяцев: **раз в 3 месяца**;
2. 13–36 месяцев: **раз в 6 месяцев**;
3. 3–6 лет: **раз в 12 месяцев**.

Повторное обследование при слухопротезировании

1. поведенческая аудиометрия по воздушной и костной проводимости;
2. акустическая импедансометрия;
3. настройка по аудиометрии и возрасту;
4. проверка аппарата и индивидуального вкладыша, измерения в реальном ухе и функционального усиления при возможности.

После кохлеарной имплантации

1. сурдопедагогическое тестирование;
2. тональная (игровая) аудиометрия в свободном поле;
3. телеметрия нервного ответа;
4. речевая аудиометрия в свободном поле;
5. настройка речевого процессора, консультация сурдопедагога.

Сроки пользования: слуховой аппарат не менее 4 лет, индивидуальный вкладыш не менее 1 года. Досрочная замена — при невозможности ремонта или ухудшении порогов, не компенсируемом аппаратом. Речевой процессор КИ заменяют через 5 лет за счёт ОМС.

При острой СНТ есть вероятность восстановить слух лечением, при хронической медикаментозно повысить слух практически невозможно: лечат сопутствующую патологию, при вестибулярных нарушениях и шуме — патогенетически и симптоматически. При сниженном зрении и других инвалидизирующих заболеваниях показания к слухопротезированию расширяются. Если аппараты и импланты не помогают — обучение дактильной азбуке и жестовому языку.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у детей»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 10.02.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее февраля 2028 года
Код в рубрикаторе	22_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Носовое кровотечение

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.0** — Носовое кровотечение
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/977_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Первое мероприятие при кровотечении из передних отделов полости носа: плотное прижатие крыльев носа к носовой перегородке **на 5 минут и более**.
- Если кровотечение не угрожает жизни, порядок действий:
  1. местная остановка кровотечения: прижатие крыльев носа, сосудосуживающие средства, коагуляция или тампонада;
  2. только после этого коррекция гемостаза или отмена антикоагулянтов.
- При продолжающемся кровотечении, источник которого визуализировать не удаётся, необходима передняя тампонада полости носа.
- Артериальное давление измеряют у каждого пациента, что позволяет выявить артериальную гипертензию и оценить объём кровопотери.
- Показания к госпитализации:
  1. неэффективность первичных мероприятий;
  2. значительная кровопотеря или интенсивное кровотечение;
  3. признаки гиповолемии;
  4. тяжёлая сопутствующая патология;
  5. высокий риск рецидива.

  Госпитализация обязательна, если нужны

  1. переливание крови;
  2. задняя тампонада;
  3. перевязка сосудов;
  4. эмболизация.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Под носовым кровотечением понимается кровотечение из повреждённых сосудов полости носа, околоносовых пазух или носоглотки, а также из сосудов полости черепа при повреждении верхней стенки полости носа.

2.2 Этиология

Различают посттравматические, в том числе послеоперационные, и спонтанные носовые кровотечения. Спонтанное кровотечение является симптомом местного или общего заболевания.

Поражение сосудов слизистой оболочки полости носа наблюдается при её атрофии, специфическом воспалении (туберкулёз, сифилис), опухолях полости носа и околоносовых пазух, сосудистых мальформациях, гранулематозе с полиангиитом.

У детей кровотечение в большинстве случаев обусловлено повреждением слизистой оболочки (инородное тело, травма, в том числе ятрогенная), острыми инфекциями верхних дыхательных путей и опухолями.

У детей до двух лет носовое кровотечение встречается очень редко, приблизительно в одном случае из 10 000. При возникновении кровотечения в этом возрасте необходимо исключить заболевания крови и врождённую патологию, в частности гемангиому полости носа и носоглотки.

2.3 Классификация

По механизму развития

1. изменения сосудов полости носа;
2. нарушения свёртывания крови;
3. сочетание этих причин.

По источнику

1. передние отделы полости носа;
2. задние отделы полости носа;
3. околоносовые пазухи;
4. носоглотка;
5. внутричерепные сосуды.

2.4 Клиническая картина

При переднем кровотечении кровь вытекает преимущественно наружу, при заднем стекает в носоглотку.

Жалобы

1. кровянистые выделения из носа;
2. стекание крови по задней стенке глотки;
3. недомогание;
4. при заглатывании крови дискомфорт в животе, тошнота, стул чёрного цвета.

2.5 Общие симптомы и объём кровопотери

Шок	Признаки	Кровопотеря
Отсутствует	Признаки отсутствуют	до 10% объёма циркулирующей крови (до 500 мл)
Лёгкий	Пульс до 100, систолическое артериальное давление выше 100 мм рт. ст., конечности холодные, диурез не нарушен	15–20% (750–1250 мл)
Средний	Пульс до 120, систолическое артериальное давление 90–100 мм рт. ст., пульсовое давление снижено, беспокойство, потливость, бледность кожных покровов, диурез менее 50 мл в час	25–35% (1250–1750 мл)
Тяжёлый	Пульс более 120, систолическое артериальное давление ниже 60 мм рт. ст. или не определяется, ступор, резкая бледность кожных покровов, конечности холодные, сухость языка и кожи, анурия	более 35% (более 1750 мл)

2.6 Анамнез

При сборе анамнеза уточняют

1. время начала, длительность и частоту кровотечений;
2. сторону предшествующих кровотечений;
3. госпитализации и переливания крови в связи с ними;
4. приём антиагрегантов, антикоагулянтов и других препаратов;
5. артериальную гипертензию, коагулопатии, анемию;
6. кровотечения у родственников;
7. травмы и операции на полости носа и околоносовых пазухах.

Носовое кровотечение, особенно рецидивирующее, может быть первым проявлением коагулопатии, наследственной геморрагической телеангиэктазии, опухоли полости носа или носоглотки, заболеваний печени или почек. Беспричинное появление синяков и петехий, кровотечения из внутренних органов в анамнезе свидетельствуют в пользу системного нарушения свёртывания крови.

Повышают риск кровотечения

1. антикоагулянты: варфарин, гепарин, дабигатран, апиксабан и другие;
2. антиагреганты: ацетилсалициловая кислота, клопидогрел;
3. многие назальные спреи, в том числе сосудосуживающие и глюкокортикостероидные;
4. некоторые наркотические вещества.

Кровотечение на фоне антикоагулянтов или антиагрегантов может потребовать их отмены или снижения дозы; у таких пациентов чаще рецидивы и кровопотеря более 250 мл, требующая переливания крови.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается при подтверждении кровянистых выделений из носа данными риноскопии и фарингоскопии.

3.1 Осмотр оториноларинголога

Показания

1. все пациенты с носовым кровотечением: осмотр оториноларинголога с оценкой общего состояния, поиском источника кровотечения и определением тактики лечения.

При необходимости госпитализации следует выбирать стационар, в котором имеется дежурный оториноларинголог. Если во время кровотечения пациент не был осмотрен оториноларингологом, в том числе в связи с самопроизвольной остановкой кровотечения, необходима плановая консультация оториноларинголога.

3.2 Оценка гиповолемии

Оценка гиповолемии: пульс, сознание, кожные покровы и слизистые оболочки

Диагностические признаки гемодинамических нарушений вследствие кровопотери

1. обморок;
2. тахикардия;
3. тахипноэ;
4. бледность кожных покровов.

Кровоизлияния на коже и слизистых оболочках при отсутствии травмы могут указывать на системное нарушение свёртывания крови.

Показания к поиску телеангиэктазий на слизистой оболочке носа и рта

1. повторные кровотечения из обеих половин носа;
2. носовые кровотечения у родственников.

Цель: исключение наследственной геморрагической телеангиэктазии (болезни Рандю—Ослера—Вебера).

3.3 Измерение артериального давления

Показания

1. все пациенты.

Диагностические признаки

1. артериальная гипертензия;
2. артериальная гипотензия может свидетельствовать о значительной кровопотере.

3.4 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки

Показания

1. источник кровотечения не визуализируется при передней риноскопии.

Повторяющееся одностороннее кровотечение может быть первым признаком опухоли, не визуализируемой при передней риноскопии, а у детей также инородного тела.

3.5 Общий анализ крови

Показания

1. оценка постгеморрагической анемии и уровня тромбоцитов.

Диагностические признаки

1. о кровопотере судят по уровню гемоглобина и гематокриту (таблица ниже).

Степень кровопотери у взрослых

Степень	Объём кровопотери	Гемоглобин, г/л	Гематокрит, %
I	до 500 мл	более 120	более 40
II	500–1000 мл	100–120	30–40
III	1000–1500 мл	80–100	20–30
IV	более 1500 мл	менее 80	менее 20

3.6 Коагулограмма

Международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время.

Показания

1. рецидивирующие кровотечения;
2. кровотечение, требующее госпитализации.

У пациентов, получающих варфарин, МНО **выше 4,5** прогностически неблагоприятно.

На фоне приёма прямых пероральных антикоагулянтов (дабигатран, ривароксабан и др.) эти показатели могут не отражать степень гипокоагуляции.

3.7 Консультации специалистов

Консультация терапевта или педиатра

1. артериальная гипертензия;
2. анемия;
3. коагулопатия;
4. другие сопутствующие заболевания, влияющие на течение кровотечения.

Консультация гематолога

1. рецидивирующие кровотечения и лабораторные признаки тромбоцитопатии или коагулопатии.

---

4. Лечение

Целью лечения является остановка кровотечения, устранение факторов риска и коррекция последствий кровопотери, в том числе гиповолемии и анемии.

Если кровотечение не угрожает жизни, его в первую очередь останавливают местными методами:

1. прижатие крыльев носа;
2. сосудосуживающее средство;
3. коагуляция;
4. тампонада.

Корригировать гемостаз или отменять антикоагулянты и антиагреганты следует лишь после этого: системная коррекция сопряжена с риском осложнений, прежде всего тромбоэмболических.

4.1 Остановка кровотечения: порядок действий

1. Прижатие крыльев носа к носовой перегородке **на 5 минут и более**, как правило **на 5–15 минут**. Предварительно пациент сморкается для удаления сгустков, сидит или стоит с небольшим наклоном головы вперёд; манипуляцию может выполнить сам пациент. Если кровь продолжает стекать, источник, вероятнее всего, расположен глубже.
2. Источник установлен, кровотечение продолжается: аппликация на источник турунды с сосудосуживающим средством (взрослым); взрослым и детям возможна аппликация гемостатического средства.
    1. однократно на турунде: #ксилометазолин или #эпинефрин;
    2. #оксиметазолин, спрей: по 2 впрыскивания в каждую половину носа 3 раза в сутки, 3–5 дней.

    Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции.

    При артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (ИБС) и ишемии головного мозга сосудосуживающие препараты применяют с осторожностью.
3. Источник установлен, кровотечение продолжается: коагуляция кровоточащего сосуда.

    Коагуляция может выполняться химическим методом (нитратом серебра), электрокоагуляцией, лазером или радиоволновым методом. Предварительная аппликация сосудосуживающего средства повышает эффективность коагуляции.
4. Источник обнаружить не удаётся: передняя тампонада полости носа.
    1. рассасывающиеся материалы (например, коллагеновая гемостатическая губка) не нужно удалять, а при удалении тампона кровотечение может возобновиться;
    2. высокий риск повторного кровотечения (наследственная геморрагическая телеангиэктазия, заболевания крови): по возможности рассасывающиеся материалы.

    1. у детей источник кровотечения, как правило, в передних отделах;
    2. поведение ребёнка позволяет: предпочтительны бестампонные методы остановки;
    3. ребёнок не готов к манипуляциям: предпочтительна передняя тампонада.

5. Кровотечение из задних отделов не останавливается передней тампонадой: сочетанная передняя и задняя тампонада с установкой тампона в области хоан и носоглотки.

   Пациенты с задним тампоном подлежат наблюдению и лечению в стационаре. Нить или фиксатор не должны оказывать избыточного давления на крыло носа во избежание образования пролежня. Ряд авторов указывает на необходимость системной антибактериальной терапии при задней тампонаде.
6. Коагуляция и тампонада неэффективны: эмболизация сосудов или перевязка артерии.

   В редких случаях перевязывают наружную сонную артерию на стороне кровотечения. Эффективность эмболизации достигает 87%, однако осложнения при ней развиваются чаще, чем при перевязке; эмболизация может выполняться под седацией и без удаления тампонов.

Возможна однократная аппликация на источник кровотечения турунды с #транексамовой кислотой (взрослым: 5 мл на кусочек ваты или марли на 10–30 минут) или этамзилатом (взрослым и детям).

При рецидивирующих кровотечениях из зоны Киссельбаха рекомендуется отслойка слизистой оболочки перегородки носа.

При субатрофии слизистой оболочки и выраженном искривлении перегородки носа от операции воздерживаются.

4.2 Медикаментозная терапия

Повышенное артериальное давление требует антигипертензивной терапии, которая позволяет уменьшить кровопотерю и риск рецидива.

При недостаточной эффективности первичных мероприятий применяют гемостатические средства в дозах согласно инструкции:

1. транексамовая кислота: внутривенно **с 1 года**, в таблетках **с 3 лет**;
2. аминокапроновая кислота;
3. аминометилбензойная кислота;
4. этамзилат.

При продолжающемся кровотечении предпочтительно внутривенное введение, таблетированные формы используют для профилактики рецидивов.

Системное применение этамзилата оправдано только при диапедезном кровотечении из мелких сосудов слизистой оболочки.

При травматическом кровотечении или риске тяжёлого кровотечения пациентам старше года вводят транексамовую кислоту внутривенно в максимально ранние сроки, предпочтительно **в первые 3 часа** после травмы.

Ведение пациентов с коагулопатиями и переливание крови по возможности осуществляются совместно с гематологом, терапевтом или педиатром.

Детям с геморрагическим синдромом при дефиците витамина К вводится менадиона натрия бисульфит: новорождённым — до 4 мг в сутки, детям от месяца до года — 2–5 мг в сутки. Возможно также профилактическое введение, не дожидаясь подтверждения дефицита.

После кровотечения или его остановки рекомендуются увлажняющие и ранозаживляющие средства для слизистой оболочки полости носа.

Эти средства уменьшают сухость и образование корок, что позволяет пациенту избегать самостоятельного туалета носа; применяют их и при субатрофическом рините.

5. Профилактика. Показания к госпитализации

Пациентам разъясняются факторы риска повторного кровотечения, способы его самостоятельной остановки и показания для обращения к врачу.

Разъясняют

1. детям, родителям и пожилым пациентам: недопустимость пальцевой травмы слизистой оболочки носа;
2. пожилым: связь риска кровотечения с приёмом лекарственных препаратов и подъёмом артериального давления.

Для профилактики учитывают

1. сухость слизистой оболочки вызывают кислородные канюли и дыхательные аппараты повышенного давления;
2. получающим варфарин обязателен контроль МНО;
3. рецидивы на фоне назальных спреев: уменьшить дозу и обучить пациента правильной технике применения.

Если кровотечение связано с повышением артериального давления, для подбора антигипертензивной терапии пациента направляют к терапевту, педиатру или кардиологу.

5.1 Показания к госпитализации

Решение о госпитализации после передней тампонады учитывает

1. длительность кровотечения;
2. объём кровопотери;
3. признаки гиповолемии;
4. сопутствующие заболевания;
5. тип тампона;
6. доступность амбулаторной помощи.

Активное кровотечение или нестабильная гемодинамика: обследование и лечение в приёмном или оториноларингологическом отделении.

На фоне гипертонической болезни кровотечение останавливает оториноларинголог в приёмном отделении, после чего пациент госпитализируется в терапевтический стационар для нормализации артериального давления.

При незначительном или остановившемся кровотечении обследование пациента возможно в амбулаторных условиях.

Показания к госпитализации

1. неэффективность первичных мероприятий;
2. значительная кровопотеря или интенсивное кровотечение;
3. признаки гиповолемии;
4. тяжёлая сопутствующая патология;
5. высокий риск рецидива.

Госпитализация обязательна, если нужны

1. переливание крови;
2. задняя тампонада;
3. перевязка сосудов;
4. эмболизация;
5. передняя тампонада нерассасывающимся материалом, если удалить тампоны амбулаторно невозможно.

1. значительная кровопотеря: **более 10%** объёма циркулирующей крови (около 500 мл у взрослого);
2. интенсивное кровотечение: **более 1 мл/кг в минуту**;
3. риск тяжёлого кровотечения повышают госпитализации по поводу кровотечений в анамнезе, особенно с переливанием крови, и более трёх эпизодов за последние 3 месяца.

Пациента выписывают при:

1. стойкой остановке кровотечения;
2. отсутствии признаков гиповолемии;
3. стабильной гемодинамике;
4. компенсации сопутствующих заболеваний.

Исход во многом определяется скоростью и объёмом кровопотери: массивная кровопотеря более 40% объёма циркулирующей крови может быть несовместима с жизнью.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Носовое кровотечение»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 08.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	977_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных расхождений не выявлено.

Клинические рекомендации

ОРВИ у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная **B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J04.1** — Острый трахеит **J06.0** — Острый ларингофарингит **J06.8** — Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации **J06.9** — Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная **J39.9** — Болезнь верхних дыхательных путей неуточненная
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 02.09.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Союз педиатров России; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии; Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/25_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- ОРВИ: самая частая острая инфекция дыхательных путей, в большинстве случаев проходит сама. Клиника практически не зависит от возбудителя; лечение — облегчение симптомов. Изменение цвета слизи из носа на жёлто-зелёный — не признак бактериальной инфекции.
- Детям с ринитом и лихорадкой — отоскопия. Рентгенографию пазух **в первые 10–14 дней** не делают. Бактериальный синусит заподозрить при заложенности **более 7 дней** и второй волне температуры; отит чаще **на 2–5-е сутки**.
- Промывания носа, сосудосуживающие **не более 5 дней**, при лихорадке парацетамол или ибупрофен (оба **с 3 месяцев**). Антибиотики при неосложнённой ОРВИ не назначают, в том числе при риносинусите, ларингите, крупе, бронхите в первые 10–14 дней.
- Госпитализация: дети **до 3 месяцев** с фебрильной лихорадкой и дети любого возраста с опасными признаками — отказ от питья, вялость, дыхательная недостаточность, цианоз, тяжёлое обезвоживание, лихорадка **более 4–5 суток**, геморрагический синдром.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

ОРВИ — самая частая острая инфекция дыхательных путей; в большинстве случаев проходит сама и специфического лечения не требует.

Проявления катарального воспаления

1. лихорадка;
2. ринит, чихание;
3. кашель;
4. боль в горле, осиплость;
5. нарушение общего состояния.

Нозологические формы

1. острый ринофарингит;
2. острый фарингит;
3. острый трахеит;
4. острая инфекция верхних дыхательных путей неуточнённая.

ОРИ без установленной этиологии (вирусная и (или) бактериальная) раньше называли ОРЗ.

2.2 Этиология

Возбудители — преимущественно вирусы: одновременно циркулируют десятки, но клиника от этиологии почти не зависит, и диагноз должен отражать нозологическую форму.

Передача: чаще самоинокуляция на слизистую носа или конъюнктиву с загрязнённых рук и поверхностей, а также воздушно-капельно. Инкубация **2–7 дней**; пик выделения вируса на 3-и сутки, слабое выделение **до 2 недель**.

Симптомы — реакция иммунной системы; цвет назального секрета меняется на бело-жёлтый или зеленоватый из-за лейкоцитов, поэтому считать его признаком бактериальной инфекции безосновательно. «Вирусно-бактериальная» ОРИ практикой не подтверждается: бактериальные осложнения редки.

Основные возбудители

Возбудитель	Особенности
Риновирус	25–40% ОРВИ, круглый год с подъёмами весной и осенью, чаще дети до 5 лет; ринит, бронхит, провоцирует бронхообструкцию и обострения астмы; выделение вируса 5–10 дней
Аденовирус	поражает дыхательные пути, лимфоидную ткань, конъюнктиву, кишечник; устойчив во внешней среде до 2 недель; до 6 месяцев защищают материнские антитела; вспышки в коллективах
Респираторно-синцитиальный вирус	высококонтагиозен, иммунитет нестойкий; у детей до 2 лет — бронхиолит с дыхательной недостаточностью; есть пассивная иммунизация для групп риска
Метапневмовирус	от лёгких форм до бронхита, бронхиолита, пневмонии; пик зимой и ранней весной
Грипп	антигенная изменчивость; ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит; тяжёлое течение с пневмонией и ОРДС; есть вакцинация
Парагрипп	у маленьких детей может давать «ложный круп» (острый обструктивный ларингит); иммунитет нестойкий
Сезонные коронавирусы	до 30% сезонных ОРВИ у детей; инкубация 2–3 дня; ринит, фарингит, сухой кашель, диарея
Бокавирус	ринофарингит, иногда обструктивный бронхит, может ухудшать астму

2.3 Тяжесть

Температура не отражает тяжесть: опасные состояния бывают и без лихорадки. Главное — стратификация риска, особенно у детей с тяжёлой сопутствующей патологией.

Степени тяжести

1. лёгкая: слабая интоксикация, неяркие местные изменения;
2. среднетяжёлая: умеренная интоксикация — головная боль, слабость, снижение аппетита, возможен абдоминальный синдром;
3. тяжёлая: выраженное нарушение общего состояния, многократная рвота, изменения сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, возможны бред, судороги.

Признаки особой тяжести: судорожный, менингеальный, геморрагический синдромы, признаки энцефалита, гипотермия.

2.4 Клиническая картина

Начало острое, чаще субфебрилитет (**37,5–38,0 °C**).

Фебрильная лихорадка характернее для

1. гриппа;
2. аденовирусной инфекции;
3. энтеровирусных инфекций.

У 82% температура снижается **на 2–3-й день**, при гриппе и аденовирусной инфекции держится **до 5–7 дней**.

Признаки бактериальной инфекции и осложнений

1. температура нарастает, признаки бактериальной интоксикации — бактериальная инфекция;
2. повторный подъём после улучшения — часто острый средний отит на фоне ринита.

1. ринофарингит: заложенность, выделения, жжение и сухость в носоглотке, стекание слизи с кашлем и чиханием; пик **на 1–3-й день**, длительность **до 6–8 дней**; при евстахеите щелчки, шум, боль в ушах, снижение слуха; у грудных — беспокойство, трудности кормления и засыпания;
2. ларингит: осиплость, грубый сухой кашель; в отличие от крупа нет стеноза и дыхательной недостаточности;
3. фарингит: гиперемия, отёчность и зернистость задней стенки глотки, непродуктивный навязчивый кашель;
4. трахеит: навязчивый изнуряющий кашель, затем влажный; **до 10–14 дней**.

---

3. Диагностика

Общепринятых критериев нет. Диагноз — по жалобам, анамнезу, осмотру и эпиданамнезу; обследование нацелено прежде всего на осложнения, тактику и маршрутизацию.

Катаральное воспаление верхних дыхательных путей, возможны

1. лихорадка;
2. чихание, кашель;
3. боль в горле, осиплость;
4. нарушение обоняния.

В анамнезе уточняют

1. контакт с больными, заболеваемость в детском учреждении, эпидемический подъём, сезон;
2. характер и длительность жалоб: недомогание, лихорадка, у грудных — отказ от груди, беспокойство; боль в горле, насморк, осиплость, кашель, лимфоузлы, боли в животе;
3. при осложнениях: одышка, сердцебиение, сильная головная боль, рвота, судороги, потеря сознания;
4. переносимость температуры, фебрильные судороги в анамнезе, динамику симптомов;
5. хронические заболевания — риск осложнений;
6. прививки (у детей **до 6 месяцев** — и вакцинацию матери), пассивную иммунизацию против РСВ у детей из групп риска.

3.1 Осмотр

Показания

1. все с подозрением на ОРВИ: кожа и слизистые, склеры, дужки и задняя стенка глотки (гиперемия, зернистость, фолликулы), миндалины, регионарные лимфоузлы.

Те же признаки бывают при стрептококковом тонзиллофарингите.

Всем

1. частота сердечных сокращений и аускультация сердца — миокардит, кардиомиопатия, эндокардит, нарушения ритма;
2. пальпация и аускультация лёгких — бронхит, бронхообструкция, пневмония;
3. осмотр и пальпация живота — поражение ЖКТ, гепатоспленомегалия (инфекционный мононуклеоз).

Пальпация и аускультация грудной клетки — уровень поражения дыхательных путей: бронхит, бронхообструкция, локальная симптоматика пневмонии.

Осмотр и пальпация живота: при аденовирусной инфекции возможны тошнота, рвота, диарея; гепатомегалия со спленомегалией или без — инфекционный мононуклеоз.

Головная боль, вялость, сонливость: проверить менингеальные симптомы — инфекции ЦНС (в том числе корь) могут начинаться с катаральных симптомов.

Лихорадка, рвота, диарея: оценить степень обезвоживания по шкале CDS. На каждый 1 °C повышения температуры потери жидкости и электролитов растут примерно на 10%.

3.2 Отоскопия

Показания

1. дети с ОРВИ, ринитом и лихорадкой: отоскопия по возможности — своевременно выявить отит.

3.3 Экспресс-тесты и ПЦР

Показания

1. подозрение на острый стрептококковый тонзиллит: экспресс-тест на БГСА в мазке из зева.

Показания

1. высокая лихорадка и подозрение на грипп: ПЦР на РНК вирусов гриппа A и B в мазке из носоглотки или иммунохроматографический экспресс-тест — для своевременного противовирусного лечения.

ПЦР выявляет вирус в среднем **до 7 дней**, максимум **до 2 недель** от начала; результат **через 4–6 часов**.

Диагноз

1. в эпидемию «грипп» можно ставить клинически;
2. без возможности этиологической диагностики — «гриппоподобное заболевание».

Селективно, чаще в стационаре: экспресс-тесты на аденовирус, РСВ, метапневмовирус, парагрипп, риновирусы, бокавирус, SARS-CoV-2 или ОТ-ПЦР в реальном времени на возбудителей ОРИ.

ПЦР мазка из носоглотки на РСВ, аденовирус, метапневмовирус, парагрипп, риновирусы, бокавирус, SARS-CoV-2.

Выявление вируса не всегда означает его роль (носительство); рутинная верификация сомнительна, нужна у иммунокомпрометированных.

3.4 Анализы крови и мочи

Показания

1. выраженные общие симптомы и лихорадка: развёрнутый общий анализ крови; в стационаре — всем.

Повышение маркеров воспаления — повод искать «немую» пневмонию, отит, инфекцию мочевых путей. Лейкопения характерна для гриппа и энтеровирусов; при РСВ возможен лимфоцитарный лейкоцитоз выше 15×10^9/л, при аденовирусе лейкоцитоз $15–20\times10^9$/л и выше, СРБ выше 30 мг/л. Повторять анализ после выздоровления не нужно.

Показания

1. лихорадка **выше 38 °C**, особенно без видимого очага: С-реактивный белок селективно.

Выше 50 мг/л — характернее для бактериальной инфекции (точки отсечения в литературе 40–100 мг/л); оценивать вместе с клиникой и в динамике. В первые **12 часов** лихорадки низкий СРБ бактериальную инфекцию не исключает. Прокальцитонин рутинно не показан.

Показания

1. подозрение на инфекцию мочевых путей, в том числе у лихорадящих детей без катаральных явлений: общий анализ мочи (возможно тест-полосками).

У 5–10% детей раннего возраста с инфекцией мочевых путей есть и вирусная ко-инфекция с картиной ОРВИ.

3.5 Рентгенография

Рентгенографию пазух при остром рините или ринофарингите **в первые 10–14 дней** без признаков бактериального синусита не делают: ранняя рентгенография часто показывает вирусное воспаление пазух, которое проходит само за 2 недели.

Рентгенографию и КТ лёгких каждому ребёнку с ОРВИ не выполняют — лучевая нагрузка. Усиление бронхососудистого рисунка и расширение корней — не пневмония и не показание к антибиотикам.

3.6 Пульсоксиметрия, ЭКГ, ЭЭГ

Признаки дыхательной недостаточности: пульсоксиметрия.

Подозрение на нарушения ритма или миокардит, тяжёлая и осложнённая ОРВИ, пороки сердца, кардиомиопатия или миокардит в анамнезе: ЭКГ и (или) эхокардиография.

Неврологическая симптоматика (декомпенсация фоновой патологии, афебрильные судороги, подозрение на отёк мозга, менингит, энцефалит): ЭЭГ селективно.

3.7 Консультации

Подозрение на отит или синусит: осмотр оториноларинголога.

По показаниям: невролог (нейроинфекция), детский гематолог (выраженные изменения крови, геморрагический синдром), детский кардиолог (миокардит, сердечная недостаточность).

---

4. Лечение

Важно объяснить родителям доброкачественный характер болезни, ожидаемую длительность симптомов и достаточность минимальных вмешательств. Основа — облегчение симптомов. Противовирусное лечение не входит в рутинное: оно разработано только для гриппа.

4.1 Ринит и боль в горле

Показания

1. ринит: несколько раз в день 0,9% раствор натрия хлорида (**с 2 лет**) или стерильная морская вода.

У младенцев с обильным отделяемым — аспирация слизи отсосом, затем солевой раствор; приподнятый головной конец. Гипертонические растворы могут вызывать неприятные ощущения и боль.

Заложенность носа: сосудосуживающие капли или спреи по инструкции, коротким курсом **не более 5 дней**. Системные препараты с деконгестантами крайне нежелательны.

Местные антисептики для горла (спреи, таблетки, пастилки) — селективно, с осторожностью: риск резистентности и нарушения микробиома; доказательств недостаточно.

4.2 Лихорадка

Показания

1. здоровые дети **3 месяцев и старше**: температура **выше 38,5 °C** в подмышечной впадине или **выше 39–39,5 °C** ректально;
2. **до 3 месяцев**, при хронической патологии, при дискомфорте — и при меньшей температуре.

Препараты

1. парацетамол: до 60 мг/кг в сутки, противопоказан **до 3 месяцев**;
2. ибупрофен: до 30 мг/кг в сутки, противопоказан **до 3 месяцев**.

Правила

1. первую дозу парацетамола — внутрь;
2. повторная доза — только при новом подъёме температуры, строго соблюдая интервал; курсом не давать;
3. не чередовать и не сочетать жаропонижающие;
4. ректально — только при рвоте или непереносимости приёма внутрь;
5. любая лихорадка у младенца **до 3 месяцев** требует тщательного обследования и направления к специалисту или в стационар.

Жаропонижающие вместе с антибиотиками могут маскировать неэффективность последних.

Физическое охлаждение — селективно, с осторожностью: раскрыть, обтирать водой 25–30 °C; при «белой» лихорадке не применять.

Не применяют для снижения температуры

1. «литические смеси» — гипотермия, постуральная гипотензия;
2. системные кортикостероиды — иммуносупрессия, жизнеугрожающие осложнения;
3. ацетилсалициловую кислоту;
4. нимесулид;
5. метамизол натрия рутинно — агранулоцитоз; только в исключительных случаях однократно, если нет альтернативы.

Жаропонижающие и противосудорожные для профилактики фебрильных судорог не назначают; родителей учат распознавать судороги.

Системные кортикостероиды для снижения температуры не назначают: подавляют воспалительный ответ, иммуносупрессия, при многих инфекциях — жизнеугрожающие осложнения.

Ацетилсалициловую кислоту детям для снижения температуры не применяют — высокий риск нежелательных реакций.

Нимесулид детям для снижения температуры не применяют.

Метамизол натрия рутинно не используют — риск агранулоцитоза, ранние признаки которого на фоне лихорадки могут остаться незамеченными.

Профилактика фебрильных судорог жаропонижающими или противосудорожными не рекомендуется: побочные эффекты, нет доказательств.

Показания

1. лихорадка: адекватная гидратация, прежде всего пероральными солевыми растворами для регидратации (не раствором декстрозы); при невозможности — зонд или внутривенно.

Маленьким — по 0,5–1 чайной ложке, старшим — небольшими глотками.

Требования к раствору

1. натрий 50–60 ммоль/л;
2. глюкоза менее 90 ммоль/л;
3. общая осмолярность 200–245 ммоль/л.

Суточная потребность по Holliday — Segar: до 10 кг — 100 мл/кг; 10–20 кг — 1000 мл + 50 мл на каждый кг свыше 10; более 20 кг — 1500 мл + 20 мл на каждый кг свыше 20. При тяжёлой гиповолемии — болюс сбалансированного кристаллоида 20 мл/кг за 30–60 минут, до 3 раз.

4.3 Кашель

1. противокашлевые рутинно не назначают; при сухом навязчивом кашле в исключительных случаях — бутамират, леводропропизин или преноксдиазин;
2. трахеит с трудноотделяемой мокротой: муколитики коротко и с осторожностью, особенно **до 2 лет** и при нервно-мышечных болезнях («заболачивание»);
3. муколитики и отхаркивающие не сочетают с противокашлевыми;
4. паровые ингаляции не применяют — ожоги, нет пользы;
5. системные антигистаминные не назначают — неэффективны;
6. аскорбиновую кислоту не назначают.

Муколитики (амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин) и отхаркивающие — селективно при трахеите с трудноотделяемой мокротой.

Отхаркивающие одновременно с противокашлевыми не назначают: подавление кашля ведёт к застою мокроты.

Паровые ингаляции детям не рекомендуются: опасность ожогов, нет доказательств пользы; ВОЗ их не рекомендует.

Системные антигистаминные при ОРВИ не назначают: не уменьшают ринит и кашель.

Аскорбиновую кислоту всем детям с ОРВИ не назначают: явного улучшения нет.

4.4 Противовирусные препараты

Показания

1. подозрение на грипп у пациентов групп риска или подтверждённый грипп A и B: в первые **24–48 часов** ингибитор нейраминидазы — осельтамивир или занамивир **с 5 лет**, по инструкции.

На вирусы без нейраминидазы не действуют. При лёгком и среднетяжёлом гриппе без факторов риска и для постконтактной профилактики не применяют. Возможны тошнота, рвота, у занамивира — бронхоспазм.

Грипп средней тяжести, в том числе у пациентов групп риска: балоксавир марбоксил, детям массой **от 20 кг** по инструкции.

Пациенты **старше 2 лет** с гриппом или ОРВИ неустановленной этиологии: умифеновир в первые 24–48 часов, селективно.

Распространённые в России противовирусные и иммуномодулирующие препараты не имеют достаточных доказательств: эффект — сокращение болезни в пределах одного дня. Рутинно не использовать, избегать полипрагмазии.

4.5 Антибиотики

Системные антибиотики не назначают — они не предотвращают, а способствуют бактериальной суперинфекции.

Антибиотики не назначают

1. неосложнённая ОРВИ и грипп;
2. **в первые 10–14 дней**: риносинусит, конъюнктивит, ларингит, круп, бронхит, бронхообструктивный синдром.

Могут быть показаны детям с хронической бронхолёгочной патологией (например, муковисцидозом) и иммунодефицитом — по микробиологии мокроты.

4.6 Иное лечение

Острый трахеит с трудноотделяемой мокротой: селективно препараты листьев плюща (капли с 2 лет, сироп с грудного возраста), первоцвет + тимьян (таблетки с 12 лет), плющ + тимьян (сироп с 2 лет) или другие растительные средства без противопоказаний.

Есть — по аппетиту, не заставлять; польза обильного питья сомнительна. При лихорадке выше 38 °C — пероральные солевые растворы, не раствор декстрозы. Мёд, лимон, травяные чаи — безопасная альтернатива для облегчения симптомов при отсутствии аллергии.

Гомеопатические средства для лечения ОРВИ у детей не рекомендуются — нет доказательств.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализируют

1. детей **до 3 месяцев** с фебрильной лихорадкой;
2. детей с любым опасным признаком (см. ниже);
3. детей со сложными фебрильными судорогами (**более 15 минут** и (или) повторно в течение суток) — на весь период лихорадки;
4. лихорадящих с подозрением на тяжёлую бактериальную инфекцию: вялость, отказ от еды и питья, снижение мочеотделения, геморрагическая сыпь, рвота (возможна и гипотермия);
5. с дыхательной недостаточностью;
6. с коморбидной патологией и риском декомпенсации;
7. по эпидемическим показаниям.

Опасные признаки

1. неспособность или отказ пить, сосать грудь;
2. сонливость, вялость, отсутствие контакта или резкое беспокойство;
3. респираторный дистресс: одышка, тахипноэ, втяжение уступчивых мест, кряхтящее дыхание, апноэ;
4. центральный цианоз;
5. сердечная недостаточность;
6. тяжёлое обезвоживание;
7. фебрильная лихорадка **более 4–5 суток**, не снижающаяся жаропонижающими;
8. геморрагический синдром: носовое кровотечение, прожилки крови при кашле, геморрагическая сыпь.

Признаки дыхательной недостаточности

1. кряхтящее дыхание, раздувание крыльев носа, кивательные движения;
2. частота дыхания: **до 2 месяцев** более 60 в минуту, **2–11 месяцев** более 50, **старше 1 года** более 40;
3. втяжение нижней части грудной клетки;
4. сатурация **менее 95%** на воздухе.

Коморбидность: иммунодефицит, онкологические и гематологические болезни, нарушения свёртывания, пороки сердца и аритмии, кардиомиопатия, лёгочная гипертензия, хронические болезни лёгких, ЦНС, эндокринные (сахарный диабет 1 типа), печени, почек, ЖКТ.

1. лечение обычно амбулаторное у педиатра или инфекциониста;
2. повторный осмотр — при температуре **более 3 дней** или ухудшении;
3. ринит, ринофарингит, ларингит, трахеит без опасных признаков — без госпитализации;
4. после простых фебрильных судорог ребёнка осматривают, решение о госпитализации индивидуально;
5. в стационаре в среднем 3–7 дней.

5.2 Осложнения

1. острый синусит, чаще бактериальный: заложенность носа **более 7 дней**, вторая волна температуры, тяжесть в голове, головная боль;
2. острый средний отит: на фоне назофарингита у маленьких детей обычно **на 2–5-е сутки**, до 20–40%, но гнойный, требующий антибиотиков, — далеко не у всех;

1. острый бронхит: длительный продуктивный кашель;
2. пневмония: температура **38,0 °C и выше** **более 3 дней**; при гриппе до 12% детей;
3. бактериемия: около 1% при РСВ, 6,5% при энтеровирусах;
4. обострение хронических болезней: астмы, инфекции мочевых путей.

Без осложнений ОРВИ скоротечна, выделения из носа и кашель могут держаться 1–2 недели. Мнение, что частые ОРВИ — признак «вторичного иммунодефицита» или переходят в хронические болезни, безосновательно.

5.3 Профилактика

1. мытьё рук;
2. маски;
3. обработка поверхностей и инструментов;
4. изоляция заболевших детей;
5. проветривание.

Правила «3Р»
Руки мыть не менее 30 секунд, рот и нос закрыты маской, расстояние не менее 1,5 м.

Правила «3П»
Избегать плохо проветриваемых помещений, мест скопления людей и близко говорящих людей.

Ежегодная вакцинация против гриппа **с 6 месяцев**; вакцинация от гриппа и пневмококка снижает риск острого среднего отита. После ОРВИ прививают обычно **через неделю** после выздоровления.

Паливизумаб 15 мг/кг в/м ежемесячно, 5 инъекций — группы риска

1. дети **до 6 месяцев**, рождённые на **35-й неделе** и раньше;
2. дети **до 2 лет**, лечившиеся по поводу бронхолёгочной дисплазии в последние 6 месяцев;
3. дети **до 2 лет** с гемодинамически значимыми пороками сердца.

Также #паливизумаб — детям, рождённым до 28 недель 6 дней, **в первые 12 месяцев** жизни; после операций на сердце с искусственным кровообращением или ЭКМО — дополнительная доза; детям до 24 месяцев с врождёнными дефектами иммунитета; по решению консилиума — при тяжёлой нервно-мышечной патологии, травме ЦНС, аномалиях дыхательных путей, муковисцидозе, первичной цилиарной дискинезии, синдроме Дауна, после трансплантации.

Постконтактная профилактика: умифеновир селективно по инструкции; доказательства невысокие.

Дети с рецидивирующими респираторными инфекциями (раньше «часто болеющие»): причины — свойства возбудителей, экология, пассивное курение, атопия, хронические болезни.

1. селективно лизаты бактерий или пидотимод (**с 3 лет**);
2. достаточное потребление витамина D;
3. селективно пробиотики L. rhamnosus GG и (или) S. salivarius K12 не менее 10^9 КОЕ в сутки 3–6 месяцев;
4. рутинно не используют растительные средства, аскорбиновую кислоту, гомеопатию.

Витамин D и его аналоги — для коррекции дефицита и профилактики респираторных инфекций.

L. rhamnosus GG и S. salivarius — снижение частоты и длительности респираторных инфекций, в том числе отитов.

Растительные средства, аскорбиновая кислота и гомеопатия для профилактики рецидивирующих ОРВИ рутинно не применяются.

Реабилитация обычно не нужна; острые инфекции — противопоказание к санаторному лечению. Детям, часто болеющим ОРВИ, — селективно реабилитация и санаторно-курортное лечение; избегать курения в окружении, недосыпа, переохлаждения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 02.09.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2029 года
Код в рубрикаторе	25_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии; Российское общество скорой медицинской помощи
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная **B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная **B34.9** — Вирусная инфекция неуточненная **B97.0** — Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках **B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J01** — Острый синусит **J02** — Острый фарингит **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J04** — Острый ларингит и трахеит **J05** — Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит **J06** — Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации **J20** — Острый бронхит **J21** — Острый бронхиолит **J22** — Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/724_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- При неосложнённой ОРВИ **в первые 10–14 дней** антибактериальная терапия не назначается, в том числе при:
  1. рините;
  2. конъюнктивите;
  3. затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме;
  4. ларингите и крупе;
  5. бронхите.
- При затруднении носового дыхания **более 3–5 дней** и подозрении на бактериальный синусит необходимы рентгенография или компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух для своевременного направления пациента к оториноларингологу. Это осложнение встречается в 0,5–2% случаев, а изменения в пазухах не всегда свидетельствуют о бактериальном воспалении.
- Противовирусные препараты начинают **не позднее 48 часов** от начала заболевания:
  1. первая линия: препараты прямого противовирусного действия;
  2. вторая линия: иммунотропные препараты.
- При выраженной заложенности носа при рините и риносинусите применяют местные деконгестанты, которые облегчают носовое дыхание и восстанавливают проходимость слуховой трубы.
- Препаратом выбора при бактериальном риносинусите является амоксициллин по 500–1000 мг 3 раза в сутки **7–10 дней**.
- Показания к срочной госпитализации:
  1. частота дыхания **более 24 в минуту**;
  2. сатурация **ниже 95%**;
  3. очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) представляют собой группу вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём и поражающих преимущественно верхние, реже нижние дыхательные пути.

Грипп А и В и новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) рассматриваются в отдельных клинических рекомендациях и в данном документе не освещаются.

2.2 Этиология

Наиболее частые возбудители ОРВИ

1. респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) А и В;
2. респираторный энтеровирус;
3. риновирус;
4. аденовирус;
5. метапневмовирус человека;
6. вирусы парагриппа 1–4 типов;
7. сезонные коронавирусы.

Большинство из них РНК-содержащие; их объединяют общие механизмы и пути передачи, стадии развития заболевания и клинические проявления.

2.3 Возбудители и ведущие клинические синдромы

Возбудитель	Основные синдромы
Вирусы парагриппа	Ларингит, ринофарингит, ложный круп
Респираторно-синцитиальный вирус	Бронхит, бронхиолит
Аденовирусы	Фарингит, тонзиллит, бронхит
Риновирусы	Ринит, фарингит
Коронавирусы человека	Ринофарингит, бронхит
Коронавирус ТОРС (тяжёлого острого респираторного синдрома)	Бронхит, бронхиолит, респираторный дистресс-синдром

2.4 Классификация

По типу течения

1. типичная (манифестная);
2. атипичная (бессимптомная, стёртая).

По тяжести

1. лёгкая;
2. средняя;
3. тяжёлая;
4. очень тяжёлая.

По характеру течения

1. неосложнённая;
2. осложнённая: со специфическими осложнениями, с осложнениями, обусловленными вторичной микрофлорой, или с обострением хронических заболеваний.

По длительности

1. острая: **5–10 дней**;
2. подострая: **11–30 дней**;
3. затяжная: **более 30 дней**.

2.5 Критерии степени тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Температура тела 37–37,5 °C или нормальная, умеренно выраженные катаральные явления, продолжительность заболевания 4–6 дней
Среднетяжёлая	Температура тела 38–39 °C, выраженные катаральные явления; при отсутствии осложнений выздоровление наступает через 6–10 дней
Тяжёлая	Температура тела 39–41 °C; на фоне слабо или резко выраженных катаральных симптомов развиваются угрожающие жизни осложнения

2.6 Клиническая картина

Инкубационный период **от 1 до 14 суток**, у наиболее распространённых вирусов **1–5 дней**. Заболевание, как правило, начинается постепенно.

Интоксикация (умеренно выраженная)

1. повышение температуры тела до субфебрильных или фебрильных значений;
2. слабость;
3. головная боль;
4. боли в мышцах и суставах.

Катаральный синдром

1. першение в горле;
2. кашель;
3. насморк;
4. в ряде случаев конъюнктивит.

Возможно увеличение лимфатических узлов, реже печени (при аденовирусной инфекции).

2.7 Синдромы поражения дыхательных путей

Синдром	Признаки
Острый ринит	Воспаление слизистой оболочки полости носа: чихание, выделения из носа (ринорея), нарушение носового дыхания. Стекание слизи по задней стенке глотки вызывает кашель.
Фарингит	Воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки: внезапно возникающие першение и сухость в горле, боль при глотании.
Тонзиллит	Изменения нёбных миндалин как вирусной природы, так и при обострении бактериальной (стрептококковой) инфекции. Характерны интоксикация, гиперемия и отёк миндалин, нёбных дужек, язычка и задней стенки глотки, рыхлые налёты в лакунах.
Ларингит	Воспаление гортани с вовлечением голосовых складок и подскладкового пространства. Первыми симптомами являются сухой «лающий» кашель и осиплость голоса.
Трахеит	Воспаление слизистой оболочки трахеи: саднение и боль за грудиной, сухой надсадный кашель.
Бронхит	Надсадный кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, удлинённый выдох, рассеянные сухие хрипы, в тяжёлых случаях одышка. Кашель сохраняется 2 недели и более (до месяца). На второй неделе мокрота может приобретать желтовато-зеленоватый оттенок вследствие примеси фибрина и присоединения бактериальной флоры.

2.8 Осложнения

Специфические осложнения

1. менингизм;
2. острая дыхательная недостаточность;
3. энцефалопатия;
4. инфекционно-токсический шок;
5. респираторный дистресс-синдром взрослых;
6. острая сердечно-сосудистая недостаточность;
7. миокардит;
8. тромбоэмболия.

Осложнения, обусловленные вторичной бактериальной микрофлорой

1. острый синусит;
2. острый отит;
3. острый бронхит;
4. обострение хронических бронхолёгочных заболеваний;
5. пневмония.

2.9 Жалобы и анамнез

У всех пациентов уточняют

1. недомогание, утомляемость, слабость, снижение аппетита;
2. повышение температуры тела;
3. головную боль;
4. боль в горле;
5. затруднение носового дыхания, насморк;
6. осиплость;
7. сухой или влажный кашель;
8. увеличение лимфатических узлов;
9. боль в животе, рвоту;
10. одышку, затруднённый вдох;
11. судороги, потерю сознания.

Уточняются длительность заболевания, а также наличие причин, препятствующих незамедлительному началу лечения или требующих его коррекции в связи с сопутствующими заболеваниями.

К таким причинам относятся непереносимость лекарственных препаратов, неадекватное психоэмоциональное состояние, угрожающее жизни острое состояние или обострение хронического заболевания, требующее участия профильного специалиста, а также отказ от лечения.

Эпидемиологический анамнез

1. контакт с больным ОРВИ в пределах инкубационного периода;
2. сезонный подъём заболеваемости;
3. вспышки в организованных коллективах;
4. вакцинация против гриппа.

Факторы риска тяжёлого и осложнённого течения

1. хронические заболевания лёгких и сердца;
2. нарушения обмена веществ;
3. хроническая болезнь почек;
4. заболевания печени;
5. неврологические состояния;
6. гемоглобинопатии;
7. иммунодефициты (ВИЧ-инфекция, приём иммуносупрессоров);
8. злокачественные новообразования;
9. возраст **старше 65 лет**;
10. беременность.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании

1. жалоб и анамнеза;
2. физикального обследования;
3. лабораторных и инструментальных исследований.

Цель диагностики: определить

1. нозологическую и клиническую форму;
2. степень тяжести;
3. наличие осложнений;
4. показания к лечению.

3.1 Осмотр кожи, слизистых оболочек, носа и ротоглотки

Диагностические признаки при осмотре

1. кожные покровы и видимые слизистые оболочки: гиперемия, бледность, цианоз, влажность, отёчность;
2. инъекция сосудов склер, конъюнктивит;
3. носовое дыхание и признаки ринита;
4. ротоглотка: гиперемия нёбных дужек и задней стенки глотки, состояние миндалин, рыхлость и зернистость задней стенки глотки, слизистый налёт, увеличение лимфоидных фолликулов.

Катаральные симптомы необходимо выявлять уже на первом этапе обследования, однако они встречаются и при некоторых бактериальных инфекциях, в частности при стрептококковом или менингококковом назофарингите.

3.2 Осмотр и пальпация лимфатических узлов

Показания

1. все пациенты: осмотр и пальпация лимфатических узлов головы и шеи с оценкой размеров и болезненности.

3.3 Обследование лёгких

Показания

1. все пациенты: пальпация, перкуссия и аускультация лёгких.

Диагностические признаки

1. частота дыхания;
2. характер дыхательных шумов;
3. хрипы;
4. крепитация (появляется при пневмонии).

3.4 Обследование сердечно-сосудистой системы

Показания

1. оценка степени тяжести, выявление тахикардии, шумов, осложнений и сопутствующих заболеваний: частота пульса, артериальное давление, аускультация сердца.

3.5 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Показания

1. все пациенты: оценка тяжести, своевременное выявление осложнений, исключение бактериальных осложнений.

Для вирусной инфекции характерны лейкопения или нормальное количество лейкоцитов, лимфоцитоз и моноцитоз.

3.6 Общий анализ мочи

Показания

1. все пациенты: выявление нарушения функции почек, декомпенсации сопутствующих заболеваний, исключение инфекции мочевыводящих путей и нефропатии.

При неосложнённой ОРВИ изменения отсутствуют; при выраженной лихорадке возможны преходящее повышение относительной плотности мочи, незначительные лейкоцитурия, протеинурия и цилиндрурия.

3.7 Биохимический анализ крови

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение: активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), амилазы, уровень мочевины и электролитов.

3.8 Экспресс-тест на антигены вирусов

Показания

1. своевременное назначение противовирусной терапии.

Иммунохроматографический тест: антигены вирусов гриппа A и B, РСВ, аденовируса и SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки.

Показан пациентам, обратившимся **не позднее 2 суток** от начала симптомов.

3.9 Методы амплификации нуклеиновых кислот

Мазки из носоглотки и ротоглотки исследуют методами амплификации нуклеиновых кислот (полимеразная цепная реакция (ПЦР), петлевая изотермическая амплификация (LAMP) и другие) на вирусы ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2.

Показания

1. идентификация возбудителя.

1. наиболее эффективный метод;
2. нуклеиновые кислоты вирусов выявляются в среднем **до 7 дней**, максимально **до 2 недель** от начала заболевания при сохранении признаков поражения верхних дыхательных путей;
3. результат готов **через 4–6 часов**.

Обследование пациентов с тонзиллитом и пневмонией осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями по данным заболеваниям.

3.10 Пульсоксиметрия

Измерение сатурации крови кислородом (SpO2).

Показания

1. ранняя диагностика дыхательной недостаточности: выявление пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной поддержке.

3.11 Рентгенография органов грудной клетки или КТ лёгких

Показания

1. бронхит продолжительностью **более 3–5 дней**;
2. физикальные признаки поражения лёгких.

Цель: исключение или подтверждение пневмонии.

3.12 Рентгенография или КТ околоносовых пазух

Показания

1. затруднение носового дыхания **более 3–5 дней** и подозрение на синусит вследствие присоединения бактериальной флоры.

Цель: своевременное направление пациента к оториноларингологу.

Данное осложнение встречается в 0,5–2% случаев ОРВИ у взрослых. Изменения в околоносовых пазухах не всегда свидетельствуют об их бактериальном поражении.

3.13 Электрокардиография

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение, особенно у пациентов пожилого возраста: оценка функции сердца и выявление нарушений ритма на фоне интоксикации.

3.14 Консультации специалистов

Консультации смежных специалистов при подозрении на осложнения

1. оториноларинголог: синусит, отит;
2. невролог: энцефалопатия;
3. пульмонолог: признаки пневмонии;
4. гематолог: выраженные изменения в анализе крови, геморрагический синдром;
5. кардиолог: миокардит, острая сердечно-сосудистая недостаточность;
6. акушер-гинеколог: беременность.

Консультация анестезиолога-реаниматолога для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ):

1. быстро нарастающая острая дыхательная недостаточность: частота дыхания **более 25 в минуту**, SpO2 **ниже 92%**;
2. другая органная недостаточность: **2 балла и более** по шкале SOFA.

3.15 Алгоритм ведения на амбулаторном этапе

1. при катаральных явлениях: общий анализ крови и обследование лёгких;
2. изменений в лёгких нет: лечение амбулаторное; при сохранении лихорадки на фоне лечения анализ крови повторяют, при изменениях направляют к инфекционисту;
3. есть изменения в лёгких: рентгенография; если признаков пневмонии нет, выполняют рентгенографию околоносовых пазух;
4. изменения в пазухах: направление к оториноларингологу.

3.16 Дифференциальная диагностика

ОРВИ дифференцируют с острыми респираторными заболеваниями бактериальной природы, в том числе вирусной пневмонии с бактериальной.

3.17 Дифференциально-диагностические признаки основных ОРВИ

Возбудитель	**Начало и течение заболевания**	**Лихорадка и интоксикация**	**Поражение носа и глотки**	**Кашель и другие проявления**
Парагрипп	Инкубационный период 2–7 дней, чаще 3–4; начало постепенное, течение подострое	37–38 °С, может сохраняться длительно; интоксикация слабо или умеренно выражена, 1–3 дня	Катаральные явления с первого дня, осиплость голоса; заложенность носа; слабая или умеренная гиперемия слизистой оболочки зева, мягкого нёба и задней стенки глотки	Сухой «лающий» кашель, в ряде случаев до 12–21 дня; ведущими синдромами являются ларингит и ложный круп
РС-инфекция	Инкубационный период 3–6 дней; начало постепенное, течение подострое, в ряде случаев затяжное	Субфебрильная, в ряде случаев нормальная; интоксикация умеренная или слабая, 2–7 дней	Катаральные явления нарастают постепенно; заложенность носа, необильные серозные выделения; слабая гиперемия слизистых оболочек	Сухой приступообразный кашель до 3 недель с болью за грудиной; бронхит, бронхиолит, возможен бронхоспазм

Возбудитель	Начало и течение заболевания	Лихорадка и интоксикация	Поражение носа и глотки	Кашель и другие проявления
Аденовирусная инфекция	Инкубационный период 4–14 дней; начало постепенное, течение затяжное, волнообразное	Фебрильная или субфебрильная; интоксикация умеренная, 8–10 дней	Резко выраженные катаральные явления; обильные слизисто-серозные выделения, резкое затруднение носового дыхания; умеренная гиперемия и гиперплазия фолликулов задней стенки глотки	Влажный кашель; ринофаринго-конъюнктивит, тонзиллит, конъюнктивит, кератит; возможны полиаденит, гепатоспленомегалия, экзантема, диарея

4. Лечение

Целями лечения являются подавление репликации вируса в ранние сроки, предотвращение прогрессирования заболевания, достижение полного выздоровления и профилактика осложнений.

Хирургическое лечение не проводится.

4.1 Базисная терапия

Всем пациентам независимо от степени тяжести:

1. постельный режим;
2. диета: легкоусвояемые продукты, богатые витаминами;
3. обильное питьё;
4. исключение алкоголя в любом виде.

Дезинтоксикационная терапия всем пациентам без поражения лёгких:

1. лёгкое и среднетяжёлое течение, амбулаторно: приём **2–3 литров** жидкости в сутки;
2. среднетяжёлое течение, стационар: пероральная регидратация и (или) инфузия **800–2000 мл** растворов, влияющих на водно-электролитный баланс;
3. осложнённое и тяжёлое течение: внутривенная дезинтоксикационная терапия с коррекцией электролитных нарушений.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при поражении лёгких для купирования интоксикации применяют меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно со скоростью 1–4,5 мл/мин, в среднем 10 мл/кг в сутки, курсом до 11 дней.

4.2 Противовирусная терапия

Противовирусные препараты начинают **не позднее 48 часов** от начала заболевания:

1. первая линия: препараты прямого противовирусного действия;
2. вторая линия: иммунотропные препараты с опосредованным действием: интерфероны, другие иммуностимуляторы и общетонизирующие средства.

Выбор препарата определяется возбудителем. Раннее назначение противовирусной терапии предупреждает тяжёлое течение и развитие осложнений; целесообразность назначения противовирусного препарата определяется врачом индивидуально для каждого пациента.

Препарат	Доза	УУР, УДД
Риамиловир (первая линия)	Внутрь 250 мг 3 раза в день в течение 5 дней; лечение следует начать не позднее 2-го дня болезни	C, 1
Умифеновир (первая линия)	200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток. Противопоказан в I триместре беременности	C, 2
Энисамия йодид (первая линия)	Внутрь 500 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней. Противопоказан при беременности и грудном вскармливании, тяжёлых поражениях печени и почек, непереносимости лактозы и фруктозы	C, 2
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (вторая линия)	90 мг 1 раз в день в течение 5–7 дней, приём желательно начать в первые 2 суток. Противопоказан при беременности и в период лактации	C, 5
Меглюмина акридонацетат (вторая линия)	По 4 таблетки однократно на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки (всего 20 таблеток). Противопоказан при беременности и в период лактации	B, 1
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (вторая линия)	В первый день 200 мг 3 раза, в последующие 7 дней по 200 мг 1 раз в сутки (на курс 2000 мг)	C, 5
Азоксимера бромид (вторая линия)	Таблетки: по 1 таблетке под язык 2 раза в день в течение 7 дней. Раствор: парентерально 6 мг в сутки в течение 3 дней, затем через день, всего 10 инъекций, или интраназально либо сублингвально по 6 мг в сутки в 2–3 приёма. Суппозитории: 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев	C, 5
Тилорон (вторая линия)	125 мг в сутки в первые 2 дня, затем по 125 мг через 48 часов, на курс 750 мг (6 таблеток)	C, 5
Антитела к гамма-интерферону, гистамину и CD4 (Эргоферон)	В 1-й день 8 таблеток: по 1 таблетке каждые 30 минут в течение первых 2 часов, затем ещё 3 раза; со 2-го дня по 1 таблетке 3 раза в день до выздоровления	C, 2
Антитела к гамма-интерферону, CD4 и молекулам MHC (Рафамин)	В 1-й день по той же схеме, затем по 1 таблетке 3 раза в день; общая продолжительность 5 дней, с 18 лет	B, 2

Возможно применение интраназальных интерферонов, которые обладают опосредованным действием и используются в комплексной терапии с первых признаков заболевания. В рекомендации отмечено, что они не входят в перечень препаратов международных клинических рекомендаций.

Интерферон альфа-2b

1. по 3 капли (дозы) в каждый носовой ход 5–6 раз в день: 3000 МЕ на приём, 15 000–18 000 МЕ в сутки;
2. курс 5 дней.

Интерферон гамма человеческий рекомбинантный

1. по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носа 5 раз в день;
2. курс 5–7 дней.

Лизаты бактерий в комплексном лечении для стимуляции иммунитета

1. неосложнённая ОРВИ;
2. частые, тяжёлые или затяжные респираторные инфекции в анамнезе.

С первых дней заболевания по 1 капсуле утром натощак за 30 минут до еды до исчезновения симптомов, **не менее 10 дней**.

4.3 Жаропонижающая терапия

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) назначают при температуре тела **выше 38 °C** и болях в мышцах и суставах.

Препараты выбора

1. парацетамол по 500–1000 мг каждые 4–6 часов при необходимости, **не более 4000 мг в сутки**;
2. ибупрофен по 400 мг 3 раза в сутки, **не более 1200 мг в сутки**;
3. возможны комбинации ибупрофена с парацетамолом и парацетамола с фенилэфрином и фенирамином.

НПВП применяются только для снижения температуры тела и обезболивания; длительные курсы нецелесообразны, поскольку могут затруднить оценку эффективности лечения.

4.4 Местная терапия ринита и риносинусита

Физиологический раствор натрия хлорида вводится в полость носа 2–3 раза в день; он разжижает секрет, способствует удалению слизи и восстанавливает функцию мерцательного эпителия.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексном лечении ринита и риносинусита применяются местные деконгестанты для уменьшения заложенности носа и восстановления проходимости слуховой трубы.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Ксилометазолин	По 1–2 капли (1 впрыскивание) 3 раза в день
Нафазолин	По 1–3 капли 0,05–0,1% раствора 3–4 раза в сутки
Ипратропия бромид + ксилометазолин	Фиксированная комбинация, применяется при обильной ринорее; доза в рекомендации не указана
Оксиметазолин	0,05% раствор, по 1–2 капли или 1–2 впрыскивания 2 раза в сутки

Показания

1. назофарингит и неосложнённый риносинусит с заложенностью носа, ринореей и стеканием слизи по задней стенке глотки; назначают с первого дня.

Комбинированный растительный препарат: корень горечавки, цветки первоцвета, трава щавеля, цветки бузины, трава вербены. Улучшает функцию мукоцилиарного аппарата и отток экссудата, ускоряет выздоровление, способствует профилактике осложнений.

1. сухой экстракт: по 160 мг (1 таблетка) 3 раза в день;
2. измельчённое растительное сырьё: по 156 мг (2 таблетки) 3 раза в день;
3. капли: по 50 капель 3 раза в день;
4. курс 7–14 дней.

Беременным при насморке, назофарингите и остром риносинусите препарат может быть назначен после консультации врача в форме таблеток, а при невозможности их приёма в форме капель.

4.5 Местная терапия фарингита и тонзиллита

Для уменьшения воспаления и болевого синдрома и профилактики вторичной инфекции слизистой оболочки ротоглотки назначаются препараты для лечения заболеваний горла и антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций, таблеток и пастилок для рассасывания.

1. грамицидин С с цетилпиридинием (в том числе с оксибупрокаином);
2. бензидамин или флурбипрофен с цетилпиридинием;
3. гексэтидин;
4. лизоцим с пиридоксином;
5. хлоргексидин;
6. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний;
7. биклотимол;
8. препараты йода.

Показания: фарингит и тонзиллит

1. боль в горле в покое и при глотании;
2. гиперемия слизистой оболочки глотки и миндалин;
3. увеличение миндалин.

Растительный антисептик: корень алтея, цветки ромашки, трава тысячелистника, кора дуба, листья грецкого ореха, трава хвоща, трава одуванчика. Уменьшает боль и воспаление, способствует профилактике осложнений и повторных эпизодов ОРВИ.

Таблетки — по 2 таблетки (96 мг) 5–6 раз в день, капли — по 25 капель 5–6 раз в день до купирования боли в горле, затем ещё в течение недели 3 раза в день. Препарат может назначаться беременным и пациентам с соматическими заболеваниями после консультации врача.

4.6 Противокашлевая и мукоактивная терапия

При сухом непродуктивном надсадном кашле, значительно ухудшающем качество жизни (болевой синдром, нарушение сна), назначают противокашлевые средства:

1. бутамират;
2. леводропропизин;
3. антитела к брадикинину, морфину и гистамину;
4. декстрометорфан в составе комбинированных препаратов.

Бутамират в форме сиропа — по 15 мл 4 раза в сутки. Леводропропизин — по 60 мг 1–3 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов. Антитела к брадикинину, морфину и гистамину — по 1–2 таблетки или 5–10 мл раствора 3 раза в сутки, в первые 3 дня до 4–6 раз.

При остром вирусном бронхите и трахеите с влажным кашлем и бронхообструкцией назначаются муколитические и отхаркивающие средства, но не в комбинации с противокашлевыми. Муколитические препараты, в том числе растительные, применяются только при продуктивном кашле.

Ацетилцистеин — 600 мг в сутки до 5–7 дней; амброксол — 90 мг в сутки, в форме капсул пролонгированного действия 75 мг в сутки, до 14 дней. Растительные комбинации экстрактов тимьяна с плющом или первоцветом применяются в течение 10–14 дней.

Одновременное назначение отхаркивающих и противокашлевых средств не рекомендуется, поскольку подавление кашлевого рефлекса может привести к застою мокроты.

При остром вирусном бронхите с влажным кашлем для облегчения отхождения вязкой мокроты рекомендуются небулайзерные ингаляции гипертонического раствора натрия хлорида (3% или 7%) с гиалуронатом натрия по 5 мл 2 раза в день.

При бронхообструктивном синдроме, обусловленном бронхоспазмом, применяют комбинацию ипратропия бромида с фенотеролом: в форме дозированного аэрозольного ингалятора по 1–2 вдоха до 3–4 раз в сутки или через небулайзер по 1–2 мл до 3–4 раз в сутки.

При продуктивном кашле, особенно с признаками бронхиальной обструкции, взрослым может назначаться амброксол с гвайфенезином и левосальбутамолом по 10 мл 3 раза в день в течение 2 недель.

4.7 Антибактериальная терапия

При неосложнённой ОРВИ **в первые 10–14 дней** антибактериальная терапия не назначается, в том числе при:

1. рините;
2. конъюнктивите;
3. затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме;
4. ларингите и крупе;
5. бронхите и бронхообструктивном синдроме.

Показания к антибактериальной терапии:

1. вероятная сопутствующая бактериальная инфекция;
2. неэффективность патогенетической, симптоматической и противовирусной терапии;
3. бактериальные осложнения среднетяжёлой и тяжёлой ОРВИ: бронхит, пневмония и другие.

4.8 Антибактериальная терапия бактериального риносинусита

Препарат	Доза
Амоксициллин	Внутрь 500–1000 мг 3 раза в сутки в течение 7–10 дней
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутрь 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки в течение 7–10 дней
Азитромицин	Внутрь 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней
Кларитромицин	500 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней (кратность приведена по тексту рекомендации)
Левофлоксацин	Внутрь 500 мг до 5–7 дней; применяется при устойчивой микрофлоре, неэффективности других антибиотиков, экзантеме или лекарственной аллергии на другие антибиотики

> В рекомендации имеется расхождение в сроках. Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а в разделе об организации медицинской помощи сохранение высокой температуры тела более 3 дней названо клиническим признаком вторичной бактериальной инфекции.

Лечение пневмонии в данных рекомендациях не рассматривается и проводится в соответствии с клиническими рекомендациями по внебольничной пневмонии у взрослых.

4.9 Терапия тяжёлого течения

При тяжёлой ОРВИ с инфекционно-токсическим шоком или отёком головного мозга применяют системные глюкокортикоиды; лечение таких пациентов осуществляется в ОРИТ в соответствии с рекомендациями по неотложным состояниям.

При поражении лёгких с дыхательной недостаточностью (SpO2 **ниже 92%**) необходима оксигенотерапия через носовые канюли, лицевую маску или аппарат высокопоточной оксигенации. Начальная скорость потока **5–7 л/мин**, при необходимости до 10 л/мин для поддержания SpO2 выше 90%.

4.10 Дополнительная терапия

Для защиты слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне приёма лекарственных препаратов, в том числе НПВП, назначается омепразол 20 мг 1 раз в день.

Пробиотики рекомендованы пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, функциональными расстройствами пищеварения, заболеваниями кожи, а также при приёме антибиотиков более 7 дней в настоящее время или в предшествующие 1–2 месяца. Пробиотики применяются в ранние сроки заболевания в сочетании с другими препаратами.

4.11 Медицинская реабилитация

Реабилитация начинается в периоде ранней реконвалесценции.

При вирусной и поствирусной астении применяют общетонизирующие препараты, в частности оксиэтиламмония метилфеноксиацетат: в первый день 600 мг, в последующие 7 дней по 200 мг, всего 2000 мг за 8 дней.

Восстановительное лечение проводится комплексно, с участием специалистов разного профиля, последовательно и преемственно на всех этапах, с учётом резервов пациента и при постоянном контроле эффективности. Физическая и умственная нагрузка увеличивается постепенно.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Перед выбором тактики ведения определяется характер течения заболевания (неосложнённое или осложнённое).

Лечение лёгкой и среднетяжёлой ОРВИ амбулаторное. При неэффективности лечения или невозможности его проведения в домашних условиях решается вопрос о госпитализации.

Госпитализации подлежат пациенты:

1. с тяжёлым, среднетяжёлым и осложнённым течением;
2. из групп риска;
3. по эпидемическим показаниям, в том числе с лёгким течением при проживании в общежитии или в неблагоприятных условиях.

> В рекомендации имеется противоречие в отношении среднетяжёлого течения: одна рекомендация раздела 6 предусматривает амбулаторное лечение таких пациентов, следующая предусматривает их госпитализацию.

Показания к срочной госпитализации:

1. частота дыхания **более 24 в минуту**;
2. SpO2 **ниже 95%**;
3. очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

Показания к переводу в ОРИТ:

1. быстро нарастающая острая дыхательная недостаточность: частота дыхания **более 30 в минуту**, SpO2 **ниже 90%**, систолическое артериальное давление **ниже 90 мм рт. ст.**;
2. другая органная недостаточность, например острая почечная недостаточность.

> Пороговые значения для перевода в ОРИТ в разных разделах рекомендации различаются: в разделе 2.5 консультация анестезиолога-реаниматолога показана при частоте дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 перевод в ОРИТ показан при частоте дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.

При прогрессировании заболевания схему ведения срочно пересматривают. Признаки прогрессирования:

1. гипоксия и сердечно-лёгочная недостаточность: одышка, цианоз, кровянистая мокрота, боль в грудной клетке, артериальная гипотензия, снижение сатурации;
2. поражение нервной системы: нарушение сознания, сонливость, судороги, выраженная слабость, параличи;
3. вторичная бактериальная инфекция, в том числе сохранение высокой температуры тела и других симптомов **более 3 дней**;
4. тяжёлая дегидратация.

Выписка возможна при:

1. стойком улучшении состояния;
2. нормальной температуре тела;
3. регрессе респираторно-катарального синдрома;
4. нормальных показателях общего анализа крови.

Группы риска тяжёлого течения

1. беременные и родильницы;
2. хронические заболевания лёгких, сердца и сосудов;
3. сахарный диабет, ожирение 2–3 степени;
4. хроническая болезнь почек;
5. заболевания печени;
6. некоторые неврологические состояния;
7. гемоглобинопатии;
8. иммунодефициты;
9. злокачественные новообразования;
10. возраст **65 лет и старше**.

5.2 Диспансерное наблюдение

При развитии осложнений наблюдение осуществляет терапевт, после аденовирусной инфекции инфекционист кабинета инфекционных заболеваний поликлиники.

В течение месяца после выписки вакцинация не проводится, за исключением введения анатоксина столбнячного и вакцины против бешенства по показаниям.

После перенесённого заболевания рекомендуется ограничение инсоляции на срок от 2 недель до месяца в зависимости от тяжести течения.

5.3 Профилактика

Вакцины против ОРВИ отсутствуют.

1. среди контактных лиц выявляют заболевших;
2. больного изолируют на дому, при необходимости в отдельном боксе стационара, до клинического выздоровления, в среднем **на 1–2 недели**; затем он может приступить к работе;
3. карантин для контактных лиц не вводится.

При работе с больными ОРВИ необходимо использование маски со сменой каждые 3–4 часа.

Необходимы обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей, влажная уборка и проветривание помещений.

После контакта с больным ОРВИ рекомендуется химиопрофилактика. Экстренная профилактика в очаге продолжается 2 дня при прекращении контакта и 5–7 дней при его сохранении. Плановая сезонная профилактика проводится перед эпидемическим подъёмом заболеваемости лицам с высоким риском заражения и неблагоприятного исхода.

Препарат	Доза для профилактики	УУР, УДД
Умифеновир	После контакта — 200 мг в сутки в течение 10–14 дней; сезонная профилактика — 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель	B, 3
Оксодигидроакридинилацетат натрия	250 мг (1 ампула) или 4–6 мг/кг на введение; при длительном применении — с интервалом 3–7 суток	C, 4
Интерферон альфа-2b	По 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в сутки в течение 5–7 дней; при однократном контакте достаточно однократного закапывания	B, 3
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный	По 2–3 капли в каждый носовой ход за 30 минут до завтрака в течение 10 дней	B, 3
Меглюмина акридонацетат	Не позднее 3 дней после контакта — 600 мг (4 таблетки) в сутки на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки	C, 5
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат	200 мг в сутки после еды в течение 14 дней	C, 5
Азоксимера бромид	По 1 таблетке в день в течение 10 дней, или 6 мг в сутки интраназально или сублингвально, или суппозитории 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев	C, 5
Тилорон	125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель	C, 5
Антитела к гамма-интерферону (Анаферон)	По 1 таблетке в день в течение 1–3 месяцев в период подъёма заболеваемости	B, 2

Лизаты бактерий для профилактики повторных респираторных инфекций и вторичной бактериальной инфекции, независимо от сезона:

1. лица, проживающие в неблагоприятных экологических условиях;
2. хронический бронхит;
3. хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ);
4. бронхиальная астма;
5. хронический риносинусит;
6. хронический тонзиллит.

Три курса по 10 дней с интервалами по 20 дней.

Взрослым перед эпидемическим сезоном и во время него длительно, от 6 месяцев до года, рекомендуется #колекальциферол: при отсутствии ожирения 2000 МЕ в сутки или 10 000 МЕ в неделю, при ожирении 3000–6000 МЕ в сутки (пометка off-label, в КР — знак #, означает применение вне инструкции по медицинскому применению).

Пациенту разъясняется необходимость срочного обращения к врачу при высокой температуре тела, одышке, стойкой головной боли, повторной рвоте, не приносящей облегчения, и резком снижении артериального давления.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее августа 2028 года
Код в рубрикаторе	724_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российское научное медицинское общество терапевтов; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 6 одна рекомендация предусматривает амбулаторное лечение среднетяжёлой ОРВИ, а следующая предусматривает госпитализацию.
- Пороговые значения для перевода в реанимацию расходятся: в разделе 2.5 частота дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 частота дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.
- Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а сохранение температуры более 3 дней в разделе 6 расценивается как признак вторичной бактериальной инфекции.
- В алгоритме (приложение Б) рентгенография околоносовых пазух предусмотрена только при изменениях в лёгких без признаков пневмонии, тогда как в разделе 2.4 она назначается в зависимости от длительности затруднения носового дыхания.
- Кларитромицин при риносинусите указан в дозе 500 мг 1 раз в сутки; для оксиметазолина в одной фразе смешаны капли и впрыскивания; доза бромгексина записана неразборчиво («по 8 мг 3 (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки»).

Клинические рекомендации

Острый ларингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J04.0** — Острый ларингит **J04.2** — Острый ларинготрахеит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 01.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/309_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Ларингоскопия показана всем пациентам. **С 12 лет** гортань осматривают гортанным зеркалом; если у ребёнка младшего возраста такой осмотр невозможен, прибегают к видеофиброринофаринголарингоскопии.
- При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции и длительности симптомов **менее 10 дней** антибактериальная терапия не назначается.
- При дисфонии показан полный голосовой покой **на 1–2 суток** с последующим ограничением голосовой нагрузки; из рациона исключаются острая, солёная, горячая и холодная пища, необходим отказ от алкоголя и курения.
- Показания к срочной госпитализации в стационар с отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи:
  1. флегмонозный ларингит;
  2. абсцедирующий ларингит;
  3. инфильтративный ларингит;
  4. хондроперихондрит гортани.
- Ларингит без стеноза гортани на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не требует госпитализации. При дыхательной недостаточности **выше I степени** необходима экстренная госпитализация.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острый ларингит (ОЛ): острое воспаление слизистой оболочки гортани длительностью **до 3 недель**. При длительности **более 3 недель** необходимо исключить аутоиммунную природу.

Абсцедирующий, или флегмонозный, ларингит: форма острого ларингита с образованием абсцесса, чаще на язычной поверхности надгортанника или на черпалонадгортанных складках.

Проявления абсцедирующего ларингита

1. резкая боль при глотании и разговоре с иррадиацией в ухо;
2. повышение температуры тела;
3. плотный инфильтрат в тканях гортани.

Острый хондроперихондрит гортани: острое воспаление хрящей гортани с вовлечением надхрящницы и окружающих тканей.

Острый подскладочный ларингит (круп) характеризуется воспалением в подголосовом пространстве с отёком слизистой оболочки под голосовыми складками, затруднением дыхания и одышкой. Заболевание встречается у детей в возрасте **от 6 месяцев до 6 лет**.

2.2 Этиология

Как правило, острый ларингит является проявлением острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ):

1. грипп;
2. парагрипп;
3. аденовирусная инфекция.

Воспаление затрагивает также слизистую оболочку полости носа и глотки, в ряде случаев бронхи и лёгкие; может быть продолжением катарального воспаления полости носа или глотки.

Основными возбудителями бактериального ларингита являются S. pneumoniae (20–43%) и H. influenzae (22–35%); достаточно часто высеваются Moraxella catarrhalis (2–10%), различные стрептококки и стафилококки, значительно реже Neisseria, Corynebacterium и другие микроорганизмы.

Неинфекционные причины

1. наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том числе ингаляционная;
2. инородное тело;
3. аллергия;
4. гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
5. повышенная голосовая нагрузка.

Предрасполагающие факторы

1. хронические заболевания бронхов и лёгких, полости носа и околоносовых пазух;
2. сахарный диабет, гипотиреоз;
3. заболевания желудочно-кишечного тракта;
4. хроническая почечная недостаточность;
5. нарушение разделительной функции гортани;
6. употребление алкоголя, курение;
7. лучевая терапия в анамнезе.

2.3 Классификация

По форме

1. катаральный;
2. отёчный;
3. флегмонозный (инфильтративно-гнойный, в том числе инфильтративный и абсцедирующий);
4. острый подскладочный.

По этиологии

1. вирусный;
2. бактериальный;
3. грибковый;
4. специфический.

2.4 Клиническая картина

Основные симптомы

1. нарушение голоса, от лёгкой дисфонии до афонии;
2. острая боль в горле;
3. кашель;
4. возможны затруднение дыхания и ухудшение самочувствия.

Заболевание начинается внезапно, на фоне удовлетворительного состояния или небольшого недомогания. При катаральном ларингите температура тела нормальная или субфебрильная; фебрильная лихорадка, как правило, свидетельствует о вовлечении нижних дыхательных путей или о переходе катарального процесса во флегмонозный.

Инфильтративная и абсцедирующая формы

1. выраженная боль в горле;
2. нарушение глотания, в том числе жидкости;
3. повышенное слюноотделение;
4. вынужденное положение головы;
5. выраженная интоксикация;
6. нарастающие признаки стеноза гортани.

Общее состояние тяжёлое. При отсутствии адекватного лечения возможно развитие флегмоны шеи, медиастинита, сепсиса, абсцедирующей пневмонии, стеноза гортани.

Клиническая картина острого стеноза гортани не зависит от его причины и определяется степенью сужения:

1. шумное дыхание с нарушением ритма;
2. западение надключичных ямок и втяжение межрёберных промежутков на вдохе;
3. запрокидывание головы;
4. гортань опускается на вдохе и поднимается на выдохе.

При неполной обструкции возникает стридор. При преобладании отёка дыхание свистящее, при преобладании гиперсекреции хриплое, клокочущее. В терминальной стадии стеноза дыхание становится всё более тихим вследствие уменьшения дыхательного объёма.

При абсцессе надгортанника на фоне острой боли вначале развивается невозможность глотания, а по мере прогрессирования процесса затруднение дыхания. Голосовая щель может закрыться очень быстро, что требует экстренных мероприятий для спасения жизни пациента.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливают на основании анамнеза, жалоб, данных физикального обследования и ларингоскопии.

Жалобы

1. изменение голоса;
2. боль при глотании;
3. кашель;
4. повышение температуры тела.

Признаки тяжёлых форм

1. ухудшение общего состояния;
2. боль при глотании даже жидкости;
3. фебрильная лихорадка;
4. повышенное слюноотделение;
5. нарушение дыхания;
6. болезненность шеи и гортани при пальпации, нарушение подвижности хрящей гортани;
7. вынужденное положение головы и шеи.

3.2 Осмотр

Показания

1. подозрение на острый ларингит: осмотр оториноларинголога, врача общей практики (семейного врача) или педиатра.

Степень дыхательной недостаточности (основной признак: одышка)

1. I степень: одышка при физической нагрузке;
2. II степень: одышка при незначительной нагрузке (неспешная ходьба, умывание, одевание);
3. III степень: одышка в покое.

Стадии стеноза гортани

Стадия	Признаки
Компенсация	Одышка в покое отсутствует, возникает при ходьбе; просвет гортани сужен на треть.
Субкомпенсация	Инспираторная одышка при нагрузке с участием вспомогательной мускулатуры, втяжение межрёберных промежутков, яремной и надключичных ямок, стридор, бледность кожных покровов; артериальное давление нормальное или повышенное; просвет гортани сужен наполовину и более.
Декомпенсация	Дыхание поверхностное, частое, резко выраженный стридор, вынужденное положение сидя, максимальные экскурсии гортани, лицо бледно-синюшное, потливость, акроцианоз, пульс частый, нитевидный, артериальное давление снижено; просвет гортани щелевидный.
Асфиксия	Дыхание прерывистое или отсутствует, голосовая щель резко сужена, сердечная деятельность угнетена, пульс частый, нитевидный, часто не определяется, кожные покровы бледно-серые; потеря сознания, экзофтальм, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца.

При быстром нарастании стеноза состояние пациента тяжелее, поскольку компенсаторные механизмы не успевают развиться. Это учитывается при решении вопроса об экстренном хирургическом вмешательстве.

3.3 Ларингоскопия

Показания

1. все пациенты с острым ларингитом.

1. непрямая ларингоскопия гортанным зеркалом обязательна при осмотре оториноларингологом пациентов **12 лет и старше** в поликлинике и в стационаре;
2. дети дошкольного и младшего школьного возраста в поликлинике: часто невозможна из-за эмоциональной лабильности и выраженного глоточного рефлекса; проводят видеофиброринофаринголарингоскопию.

Ларингоскопия позволяет определить характер процесса, его локализацию, уровень, протяжённость и степень сужения дыхательных путей.

Диагностические признаки острого ларингита

1. гиперемия и отёк слизистой оболочки гортани с усилением сосудистого рисунка;
2. голосовые складки розовые или ярко-красные, утолщены;
3. голосовая щель при фонации овальной или линейной формы, со скоплением мокроты;
4. при подскладковом ларингите валикообразное утолщение слизистой оболочки под голосовыми складками.

Признаки по формам

1. катаральная форма: изменения преимущественно на голосовых складках, в межчерпаловидном или подскладковом пространстве; расширенные поверхностные сосуды, слизистый или слизисто-гнойный секрет, усиливающий охриплость;
2. отёчная форма: вся слизистая оболочка гортани гиперемирована и отёчна, смыкание голосовых складок неполное;
3. геморрагический ларингит на фоне гриппа или ОРВИ: кровоизлияния в слизистую оболочку, от петехий до небольших гематом.

Налёты

1. белый или беловато-жёлтый фибринозный налёт: переход в более тяжёлую, фибринозную форму;
2. налёт серого или бурого цвета: возможна дифтерия;
3. налёт у взрослого, не связанный с интубационной травмой: срочная дифференциальная диагностика с системными заболеваниями и туберкулёзом.

Инфильтративный ларингит, хондроперихондрит, абсцесс надгортанника

1. поражённый отдел гортани значительно инфильтрирован, гиперемирован, увеличен в объёме, малоподвижен, часто покрыт фибринозными налётами; в зоне формирования абсцесса просвечивает гной;
2. при тяжёлой форме и хондроперихондрите гортань болезненна при пальпации, хрящи малоподвижны, кожа над гортанью может быть инфильтрирована и гиперемирована;
3. абсцесс надгортанника: шаровидное образование на язычной поверхности надгортанника с просвечивающим гноем, выраженная боль и нарушение глотания.

3.4 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. оценка общего состояния и выявление воспалительной реакции.

Диагностические признаки

1. лейкоцитоз;
2. повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

При флегмонозном ларингите при госпитализации необходимо комплексное клинико-лабораторное обследование всех пациентов.

3.5 Микробиологическое исследование гнойного отделяемого

Посев на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителя и определением его чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. гнойное отделяемое: выбор адекватной терапии.

При поступлении в стационар проводится стандартное лабораторное обследование.

3.6 Пульсоксиметрия

Показания

1. дети младшего и дошкольного возраста: оценка степени дыхательной недостаточности и определение показаний к кислородотерапии.

3.7 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием

Показания

1. подозрение на гнойные осложнения (в стационаре);
2. затруднение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями гортани.

КТ целесообразна в условиях стационара при подозрении на гнойные осложнения или при затруднении дифференциальной диагностики с другими заболеваниями гортани. Если у ребёнка с признаками стеноза выполнение КТ невозможно, в сомнительных случаях проводится рентгенография шеи в прямой и боковой проекциях.

---

4. Лечение

Тактика лечения определяется формой и тяжестью воспалительного процесса.

4.1 Неосложнённый ларингит

1. Ограничение голосовой нагрузки (исключение крика и шёпота **не менее 2 дней**) и лечебно-охранительный режим при дисфонии любой степени.
    1. при дисфонии полный голосовой покой **на 1–2 суток**, затем ограничение любой голосовой нагрузки;
    2. из рациона исключают острую, солёную, горячую и холодную пищу, спиртные напитки;
    3. отказ от курения.
2. При катаральном ларингите на фоне ОРВИ повышенное потребление жидкости не рекомендуется.
   Польза обильного питья сомнительна, тогда как повышенная в период заболевания секреция антидиуретического гормона способствует задержке жидкости.
3. При фебрильной лихорадке противовоспалительные и жаропонижающие препараты (дозы в таблице ниже).
   Детям с температурой тела выше 39–39,5 °C, помимо лекарственных средств, показаны физические методы охлаждения: раскрытие ребёнка и обтирание водой температуры 25–30 °C.
4. Детям противокашлевые и отхаркивающие препараты рутинно не назначают, за исключением случаев мучительного кашля.
   Перед назначением противокашлевых средств необходимо исключить состояния, при которых подавление кашля опасно и которые требуют специфического лечения, например бронхиальную обструкцию, а у детей также острый обструктивный ларингит (круп).
5. Местная противовоспалительная терапия: вливания лекарственных препаратов в гортань и ингаляции.
   Для вливаний в гортань чаще всего используются антисептики из группы производных хинолина и четвертичных аммониевых соединений. Раствор подогревается до температуры тела и вливается по каплям, в объёме до 2 мл. Детям вливания в гортань не проводятся в связи с угрозой ларингоспазма.
6. Небулайзерные ингаляции аэрозолей средней и низкой дисперсности (препараты в таблице ниже).
   Продолжительность ингаляции, как правило, составляет 10 минут, интервал между ингаляциями различных препаратов около 30 минут. При наличии корок в гортани ингаляции начинаются с муколитика.
7. При вирусной инфекции и длительности симптомов **менее 10 дней** антибактериальная терапия не назначается.
8. Системные антибиотики назначают при сохранении симптомов **в течение 10 дней** и при осложнённом течении.
   Взрослым назначение антибиотика целесообразно при затяжном течении ларингита (10 дней и более), а также при выраженной инфильтрации голосовых складок и экссудации.
   Взрослым антибиотик подбирают эмпирически и назначают внутрь:
    1. амоксициллин: 500–1000 мг 3 раза в сутки, 5–10 дней;
    2. амоксициллин + клавулановая кислота: 875/125 мг 2 раза в сутки, 5–10 дней;

3. цефиксим: 400 мг 1 раз в сутки, 5–10 дней;
4. цефдиторен: 400 мг 1 раз в сутки, 10 дней;
5. кларитромицин: 250–500 мг 2 раза в сутки, 6 дней;
6. джозамицин: 1000 мг 2 раза в сутки, 5–10 дней.

9. При аллергических заболеваниях (аллергический ринит, крапивница, поллиноз, аллергический конъюнктивит) системные антигистаминные препараты.
10. Противогрибковые препараты только после подтверждения кандидоза: взрослым флуконазол 100 мг в сутки или итраконазол 100 мг 1 раз в сутки **15 дней**.
11. Консультация физиотерапевта.

Жаропонижающие препараты

Препарат	Доза
Парацетамол	До 60 мг/кг в сутки. Детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.
Ибупрофен	До 30 мг/кг в сутки. Детям — 7,5 мг/кг каждые 6–8 часов, не более 30 мг/кг в сутки.

Препараты для ингаляций

Препарат	Доза
Ацетилцистеин (раствор для инъекций и ингаляций)	Ингаляционно по 1 ампуле (3 мл) 1–2 раза в сутки, 5–7 дней.
#Будесонид	Ингаляционно 1000 мкг 1–2 раза в сутки, курс 5–8 процедур.

Возможно применение готовых аптечных смесей на основе растительных препаратов с учётом противопоказаний и возраста: масла листьев эвкалипта прутовидного, а также 5–10% отваров цветков ромашки, листьев шалфея, травы тимьяна ползучего (чабреца), цветков календулы, листьев подорожника. Такие ингаляции могут быть тёплыми и холодными; продолжительность первой ингаляции составляет 1–2 минуты, последующих 5–10 минут.

Антигистаминные препараты

Препарат	Доза
Лоратадин, цетиризин	Детям 3–12 лет с массой тела более 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки, менее 30 кг — 5 мг 1 раз в сутки; взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет и взрослым — 5 мг 1 раз в сутки.
Дезлоратадин	От 6 до 12 месяцев — 1 мг, с 1 года до 5 лет — 1,25 мг, 6–11 лет — 2,5 мг, взрослым и детям старше 12 лет — 5 мг; кратность приёма 1 раз в сутки.

При дисфонии на фоне острого ларингита рекомендацией предусмотрено включение в терапию комплексных гомеопатических препаратов для уменьшения выраженности нарушений голоса. Приведённый в рекомендации препарат зарегистрирован по показанию «ларингиты различной этиологии» и применяется у взрослых и детей старше 6 лет с первых дней заболевания на 6 дней.

4.2 Антибактериальная терапия у взрослых

Препарат	Показание	Доза внутрь
Амоксициллин	Препарат выбора	500 мг 3 раза в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 1000 мг 3 раза в сутки.

Препарат	Показание	Доза внутрь
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернативный препарат; при факторах риска продукции бета-лактамаз	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	Альтернатива	400 мг 1 раз в сутки.
Цефдиторен	Альтернатива	400 мг; в таблице кратность зачёркнута, в тексте указано 1 раз в сутки.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	250–500 мг 2 раза в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	1000 мг 2 раза в сутки.

Факторами риска устойчивости пневмококка к бета-лактамам являются приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детские учреждения, проживание в «закрытых» учреждениях. Амоксициллин с клавулановой кислотой предпочтителен при риске инфицирования возбудителем, продуцирующим бета-лактамазы (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis): при бронхиальной астме, сахарном диабете, хроническом бронхите, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет, при неэффективности предшествующего лечения амоксициллином.

> В тексте рекомендации цефдиторен назначается по 400 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней, тогда как в таблице 1 кратность его приёма зачёркнута целиком («2 раза в сутки 1 раз в сутки»).

4.3 Антибактериальная терапия у детей

В тексте рекомендации детям предлагаются:

1. амоксициллин: 40–60 или 80–90 мг/кг в сутки, 5–7 дней;
2. амоксициллин + клавулановая кислота: до 3 месяцев 30 мг/кг в сутки в 2 приёма; с 3 месяцев 25 мг/кг в сутки в 2 приёма или 20 мг/кг в сутки в 3 приёма; 5–10 дней;
3. цефиксим, суспензия: 8 мг/кг в сутки в 1–2 приёма, 5–10 дней;
4. цефтриаксон: с 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе тела более 50 кг дозы для взрослых;
5. кларитромицин: 7,5–15 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 14 дней;
6. джозамицин: 50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, 5–10 дней;
7. тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат: внутримышечно, 10 дней.

Препарат	Показание	Доза
Амоксициллин	Препарат выбора	Внутрь 40–60 мг/кг в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива	Внутрь, суспензия 4:1 (125 мг + 31,25 мг в 5 мл или 250 мг + 62 мг в 5 мл) в 3 приёма каждые 8 часов; доза «45–60 мг/кг/сутки в 2–3 приёма» в таблице зачёркнута.
Цефиксим	Альтернатива	8 мг/кг в сутки 1 раз в сутки.
Цефтриаксон	Альтернатива	С 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе тела более 50 кг — дозы для взрослых.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	Внутрь 7,5 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.

Препарат	Показание	Доза
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	При невозможности применения бета-лактамов и макролидов	До 2 лет — по 125 мг 2 раза в сутки; 3–6 лет — по 250 мг 2 раза в сутки; 7–12 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; взрослым — по 500 мг 2–3 раза в сутки; 10 дней.

> Детские дозы в тексте и в таблице 2 не совпадают. Для кларитромицина в тексте указана «для детей старше 12 лет разовая доза» 7,5–15 мг/кг/сут, в таблице 7,5 мг/кг/сут в 2 приёма. Для амоксициллина с клавулановой кислотой в тексте приведена доза 20–30 мг/кг/сут, в таблице доза 45–60 мг/кг/сут зачёркнута и указана только суспензия в 3 приёма. Цефиксим в тексте назначается в 1–2 приёма, в таблице 1 раз в сутки. Для тиамфеникола возрастные группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет» не включают детей от 2 до 3 лет.

4.4 Флегмонозный, абсцедирующий, инфильтративный ларингит, хондроперихондрит гортани

1. Обязательная срочная госпитализация в учреждение с отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи (раздел «Показания к госпитализации»).
2. Антибактериальная терапия в стационаре начинается эмпирически с учётом региональной резистентности основных возбудителей; после улучшения состояния возможен переход на приём антибиотика внутрь (ступенчатая терапия). Препараты и дозы в таблице ниже.
3. Промывание полости абсцесса растворами антисептиков: 0,01% раствором бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата или гидроксиметилхиноксалиндиоксидом.
4. При дисфагии и тяжёлых формах: дезинтоксикационная терапия, коррекция гиповолемии, глюкокортикостероиды, парентеральное питание.
5. При осложнённых формах хирургическое лечение.

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Амоксициллин + клавулановая кислота	С 3 месяцев внутривенно 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов, 5–10 дней	Внутривенно 1,2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 150 мг/кг в сутки в 4 введения	Внутривенно 2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефтриаксон	С 15 дней до 12 лет внутримышечно или внутривенно 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, 5–10 дней	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки, 7–10 дней
Цефепим	При тяжёлом флегмонозном ларингите и осложнениях в отделении реанимации: при массе тела более 40 кг — 2 г каждые 12 часов, до 40 кг — 50 мг/кг каждые 12 часов, 7–10 дней	—
Меропенем	В тех же условиях: от 3 месяцев до 12 лет — 10–20 мг/кг 3 раза в сутки, при массе тела более 50 кг — доза для взрослых, 5–10 дней	—
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	До 2 лет — 125 мг 2 раза в сутки, 3–6 лет — 250 мг 2 раза, 7–12 лет — 250 мг 3 раза в сутки	500 мг 2–3 раза в сутки, 10 дней

4.5 Стеноз гортани

1. Для профилактики стеноза: консервативная противовоспалительная терапия; дестенозирующая терапия: парентеральное введение глюкокортикоидов.
2. Детям с декомпенсированным стенозом гортани: неотложная интубация трахеи.
3. При невозможности интубации: трахеостомия или коникотомия.

> В комментарии о дестенозирующей терапии фраза оборвана: указана доза «60–120 мг», однако не указано, к какому глюкокортикоиду она относится и предназначена ли она для взрослых или для детей.

При неосложнённом остром ларингите хирургическое лечение не требуется.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациентам голосоречевых профессий после перенесённого острого ларингита показано наблюдение оториноларинголога до полного восстановления голосовой функции.

1. сроки нетрудоспособности продлевают до полного восстановления голоса;
2. неосложнённый ларингит разрешается за **7–14 дней**;
3. инфильтративные формы разрешаются **более 14 дней**.

Профилактика хронизации воспалительного процесса гортани заключается в своевременном лечении острого ларингита, повышении сопротивляемости организма, лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и инфекций верхних и нижних дыхательных путей, отказе от курения и соблюдении голосового режима.

Пациенту рекомендуют

1. ограничить голосовую нагрузку;
2. исключить горячую, холодную и острую пищу, спиртные напитки, курение и паровые ингаляции;
3. постоянно увлажнять воздух в помещении увлажнителем.

В составе комплексного лечения в рекомендации упоминаются противовирусные препараты.

> В разделе 7 и в памятке для пациента паровые ингаляции запрещены, тогда как в разделе 3.1 ингаляции отваров трав допускаются «тёплыми». Там же рекомендованы противовирусные препараты, однако в разделе о лечении такая рекомендация отсутствует.

5.1 Показания к госпитализации

Пациенты с острым ларингитом без стеноза гортани на фоне ОРВИ не нуждаются в госпитализации. Госпитализации подлежат все пациенты с осложнённым течением.

Обязательной срочной госпитализации в учреждение с отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи подлежат пациенты с осложнёнными и тяжёлыми формами:

1. флегмонозный ларингит;
2. абсцедирующий ларингит;
3. инфильтративный ларингит;
4. хондроперихондрит гортани.

Показанием к экстренной госпитализации является острая дыхательная недостаточность выше I степени.

Пациента выписывают при:

1. регрессе воспалительных изменений;
2. отсутствии дыхательной недостаточности;
3. отсутствии осложнений.

При неосложнённом ларингите прогноз благоприятный. При осложнённых формах со стенозом гортани решающее значение для сохранения жизни пациента имеют своевременная специализированная помощь и хирургическое лечение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый ларингит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 01.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`309_2` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для цефдиторена в тексте указано 400 мг 1 раз в сутки, в таблице 1 кратность зачёркнута целиком.
- Детские дозы кларитромицина, амоксициллина с клавулановой кислотой и цефиксима в тексте и в таблице 2 различаются; для кларитромицина «разовая доза» приведена в мг/кг/сут и «для детей старше 12 лет».
- Для тиамфеникола глицината ацетилцистеината не указана доза для детей от 2 до 3 лет: выделены только группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет».
- В комментарии о дестенозирующей терапии не назван глюкокортикоид, к которому относится доза «60–120 мг».
- Раздел 7 запрещает паровые ингаляции и рекомендует противовирусные препараты, тогда как раздел 3.1 допускает тёплые ингаляции и не содержит рекомендации о противовирусных препаратах.

Клинические рекомендации

Острый синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J01** — Острый синусит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/313_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз острого синусита у взрослых:

  Обязательные критерии

  1. острое начало заболевания;
  2. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа и (или) выделения из носа, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки (постназальный синдром);
  3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

  Возможные симптомы

  1. боль или ощущение давления в проекции околоносовых пазух на лице;
  2. снижение или потеря обоняния.
- Диагноз острого синусита у детей:

  Обязательные критерии

  1. острое начало заболевания;
  2. **не менее двух** симптомов из перечисленных ниже;
  3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

  Симптомы

  1. заложенность носа;
  2. выделения из носа, в том числе стекание по задней стенке глотки (постназальный синдром);
  3. кашель.
- Системная антибактериальная терапия взрослым показана:
  1. при среднетяжёлом и тяжёлом течении;
  2. при лёгком течении рецидивирующего синусита с сохранением симптомов **5–7 дней и более**;
  3. при лёгком течении на фоне тяжёлой сопутствующей патологии или иммунодефицита.
- При впервые возникшем синусите стартовым препаратом является незащищённый аминопенициллин (амоксициллин). Если заметного эффекта нет **в течение 3 дней**, препарат заменяют.
- Местная терапия:
  1. промывание полости носа солевыми растворами;
  2. сосудосуживающие капли **не более 5–7 дней**;
  3. интраназальные глюкокортикостероиды пациентам **старше 12 лет**.
- Показания к экстренной госпитализации:
  1. тяжёлое течение;
  2. орбитальные или внутричерепные осложнения;
  3. отсутствие улучшения на фоне системной антибактериальной терапии **в течение 3–5 дней**;
  4. ухудшение состояния в любой момент.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острый синусит представляет собой острое воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух продолжительностью **менее 12 недель**, проявляющееся не менее чем двумя симптомами (перечислены в критериях диагноза ниже). Часть симптомов может быть заменена данными риноскопии, эндоскопии или компьютерной томографии (КТ).

Синусит считается рецидивирующим при 4 эпизодах и более за последний год, если между эпизодами имеются периоды не менее 8 недель без симптомов и без лечения.

Острый поствирусный синусит диагностируется при сохранении симптомов более 10 дней после острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и отсутствии признаков бактериального синусита. Как правило, он протекает легче и разрешается без антибактериальной терапии.

2.2 Критерии диагноза

У взрослых:

Обязательные критерии

1. острое начало заболевания;
2. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа и (или) выделения из носа, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки (постназальный синдром);
3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

Возможные симптомы

1. боль или ощущение давления в проекции околоносовых пазух на лице;
2. снижение или потеря обоняния.

У детей:

Обязательные критерии

1. острое начало заболевания;
2. **не менее двух** симптомов из перечисленных ниже;
3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

Симптомы

1. заложенность носа;
2. выделения из носа, в том числе стекание по задней стенке глотки (постназальный синдром);
3. кашель.

Болевой синдром может отсутствовать. При верхнечелюстном синусите боль локализуется в проекции пазухи, реже в области переносицы и надбровья, и может иррадиировать в верхние зубы. Для сфеноидита характерна боль в центре головы и в затылочной области (каскообразная боль).

У детей синусит часто сочетается с гипертрофией и хроническим воспалением глоточной миндалины и может проявляться упорным кашлем или выраженным затруднением носового дыхания.

2.3 Степень тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Лихорадка отсутствует. Умеренные симптомы, не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни. Головная боль в проекции околоносовых пазух (ОНП) отсутствует. Осложнений нет
Среднетяжёлая	Выраженные симптомы, умеренно или значительно влияющие на качество жизни. Ощущение тяжести в проекции ОНП при движении или наклоне головы. Осложнение со стороны среднего уха (острый средний отит). Внутричерепные и орбитальные осложнения отсутствуют
Тяжёлая	Выраженные или мучительные симптомы. Болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении, наклоне головы, перкуссии. Внутричерепные или орбитальные осложнения

2.4 Классификация

В 90–98% случаев возбудителями синусита являются вирусы, на долю бактериального синусита приходится лишь 2–10%.

По этиологии выделяют вирусный, бактериальный, травматический, грибковый (в виде острого процесса встречается крайне редко) и смешанный синусит. Изолированный бактериальный синусит встречается редко; как правило, имеет место сочетание вирусов или вирусов и бактерий.

По локализации различают гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит. Поражение всех пазух одной половины носа обозначается как гемисинусит, обеих половин как пансинусит.

---

3. Диагностика

3.1 Осмотр ЛОР-органов

Показания

1. всем пациентам при обращении к оториноларингологу и при госпитализации в стационар: общий осмотр и стандартный оториноларингологический осмотр.

Диагностические признаки при риноскопии

1. отделяемое в носовых ходах;
2. гиперемия и отёк слизистой оболочки полости носа;
3. отделяемое в среднем носовом ходе (передняя риноскопия) указывает на возможное поражение лобной и верхнечелюстной пазух, передних и средних клеток решётчатого лабиринта;
4. отделяемое в верхнем носовом ходе (задняя риноскопия) указывает на возможное поражение задних клеток решётчатого лабиринта и клиновидной пазухи.

Отсутствие отделяемого не исключает острого синусита: его может не быть при блоке естественных соустий и высокой вязкости секрета.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. оценка состояния полости носа и носоглотки;
2. дифференциальная диагностика.

В большинстве случаев эндоскопия не информативнее передней и средней риноскопии, но помогает отличить сфеноидит от аденоидита и выявить длительно находящееся инородное тело полости носа.

Диагностические признаки

1. гнойное отделяемое и (или) отёк слизистой оболочки в области остиомеатального комплекса; эти данные подтверждают диагноз.

3.3 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания к спиральной КТ

1. подозрение на внутричерепные или орбитальные осложнения;
2. затяжное тяжёлое течение;
3. сложные диагностические случаи.

Диагностические признаки

1. признаки воспаления в околоносовых пазухах и (или) в области остиомеатального комплекса; они подтверждают диагноз.

КТ является наиболее информативным методом: она показывает характер и распространённость изменений, а также анатомические особенности полости носа и пазух, ведущие к рецидивам, и визуализирует структуры, неразличимые на рентгенограмме.

3.4 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение;
2. сложные диагностические случаи при невозможности выполнить КТ.

Диагностические признаки

1. утолщение слизистой оболочки пазухи;
2. горизонтальный уровень жидкости;
3. тотальное снижение пневматизации пазухи.

Интерпретацию затрудняют наложение окружающих костных структур и гипоплазия пазухи.

Данные рентгенографии и КТ совпадают лишь в 34% случаев, для верхнечелюстной пазухи в 77%.

3.5 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на верхнечелюстной или лобный синусит при невозможности выполнить рентгенографию и КТ.

3.6 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение.

Диагностические признаки

1. лейкоцитоз с нейтрофилёзом не является специфическим маркером бактериального синусита, однако его нарастание при повторном исследовании учитывают при решении вопроса о системной антибактериальной терапии.

3.7 Бактериологическое исследование

Посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение у пациентов в стационаре;
2. затяжное течение;
3. неэффективность эмпирической антибактериальной терапии.

Забор материала

1. при верхнечелюстном синусите материал получают при пункции пазухи иглой Куликовского с аспирацией содержимого; если его нет, вводят стерильный 0,9% раствор натрия хлорида и аспирируют;
2. посев из носового хода нецелесообразен из-за попадания в материал посторонней микрофлоры.

Иные диагностические исследования не показаны.

3.8 Дифференциальная диагностика

У взрослых острый синусит дифференцируют с обострением хронического риносинусита, аллергическим и хроническими ринитами, у детей также с аденоидитом и инородным телом полости носа.

Заболевание	Общие с острым синуситом признаки	Отличия от острого синусита
Хронический риносинусит	Манифестация и обострения по клиническим проявлениям идентичны острому синуситу	1. назальные симптомы полностью не разрешаются в течение 12 недель даже на фоне лечения: пациенты отмечают улучшение, но не полное исчезновение симптомов; 2. у детей хронический риносинусит встречается значительно реже острого синусита; 3. в этиологии преобладают неинфекционные факторы: генетические аномалии, аллергия, аномалии строения полости носа.
Аллергический ринит	Сходные назальные симптомы: заложенность носа, выделения из носа, кашель вследствие постназального затекания. Аллергический ринит повышает риск острого синусита	1. симптомы повторяются; 2. значительно чаще беспокоят зуд в носу и (или) чихание; 3. характерны глазные симптомы (зуд в глазах, слезотечение), особенно при поллинозе; 4. в основе патогенеза лежит IgE-ассоциированное воспаление слизистой оболочки; 5. диагноз устанавливают по аллергологическому анамнезу, характеру симптомов и результатам специфического аллергологического обследования.
Аденоидит	Сходные назальные симптомы: заложенность носа, кашель вследствие постназального затекания, реже выделения из носа. У детей младше 10–12 лет воспаление в полости носа и околоносовых пазухах всегда сопровождается реактивным воспалением глоточной миндалины	1. у детей раннего и дошкольного возраста, не перенёсших аденотомию, при жалобах на «острый насморк» граница между острым синуситом и аденоидитом очень условна; 2. в отдельных случаях помогает эндоскопия полости носа и носоглотки: скопление отделяемого в среднем носовом ходе при небольшом его количестве в носоглотке больше характерно для острого синусита; 3. у дошкольников без признаков внутричерепных и орбитальных осложнений и без критериев острого бактериального синусита основным диагнозом целесообразно указывать аденоидит или острый назофарингит.

Заболевание	Общие с острым синуситом признаки	Отличия от острого синусита
Инородное тело полости носа	Родители ребёнка могут жаловаться на остро возникшую заложенность носа и (или) гнойные выделения из носа, особенно при инородном теле органического происхождения	1. трудности возникают, когда ребёнок незаметно для родителей вводит в нос органические вещества: кусочки пищи, семена растений, бумагу, поролон; 2. воспалительные изменения, как правило, односторонние, гнойные выделения появляются на фоне полного здоровья без предшествующего эпизода острого респираторного заболевания; 3. инородное тело выявляют при передней риноскопии после анемизации и аспирационного туалета полости носа, в ряде случаев при эндоскопии полости носа и носоглотки.

4. Лечение

4.1 Базисная терапия при любой степени тяжести

1. Промывание полости носа изотонической стерильной морской водой или солевыми растворами. Слабые гипертонические растворы применяют только в остром периоде, **не дольше 5–7 дней**.
2. Сосудосуживающие капли **не более 5–7 дней** из-за риска медикаментозного ринита. Нафазолин не применяют.
   Детям **до 6 лет**:
   1. фенилэфрин 0,125%;
   2. оксиметазолин 0,01–0,025%;
   3. ксилометазолин 0,05%: с 2 лет.
3. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) при лихорадке, головной и лицевой боли.
   1. дети **до 6 лет**: только парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки);
   2. взрослые: возможен кетопрофен.
4. Мукоактивные препараты, например ацетилцистеин или карбоцистеин. Перед назначением следует свериться с инструкцией: не все препараты разрешены при заболеваниях ЛОР-органов и в сочетании с антибиотиками.
5. Растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием: комбинации корня горечавки, цветков первоцвета, шалфея, цветков бузины и вербены, миртол, экстракт пеларгонии сидовидной.
6. Пациентам **старше 12 лет** для облегчения симптомов комбинированные препараты с парацетамолом без психотропных компонентов.
7. Системные антигистаминные препараты при сопутствующем аллергическом рините и в начальном периоде вирусной инфекции.
8. При вирусном синусите противовирусные препараты, в том числе растительного происхождения.

4.2 Лёгкое течение

Базисная терапия, а также:

1. При гнойных выделениях (признаках бактериального воспаления) местные антибактериальные препараты, в том числе в монотерапии. Эффект оценивают **через 3–4 дня**; если его нет, решают вопрос о системной антибактериальной терапии.

   Зарегистрированы для лечения синусита

   1. фрамицетин: детям с первых лет жизни;
   2. дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин: с 2,5 лет.

   Введение растворов антибиотиков для инъекций в полость носа и пазухи не допускается.
2. Интраназальные глюкокортикостероиды пациентам **старше 12 лет**: в монотерапии при затяжном поствирусном синусите либо вместе с системными антибиотиками при показаниях к ним. Детям до 12 лет монотерапия допустима только при сопутствующем аллергическом рините.

   Для монотерапии синусита без признаков бактериальной инфекции в России зарегистрирован только спрей мометазона.
3. Комплексные гомеопатические препараты по зарегистрированным показаниям на амбулаторном этапе.

Взрослым системная антибактериальная терапия показана при среднетяжёлом и тяжёлом течении. При лёгком течении её назначают только в следующих случаях:

1. рецидивирующий синусит с сохранением симптомов **5–7 дней и более**;
2. тяжёлая сопутствующая патология (например, сахарный диабет);
3. иммунодефицит.

Детям системная антибактериальная терапия показана при среднетяжёлом и тяжёлом течении и при признаках бактериального синусита. При лёгком течении её назначают при наличии хотя бы одного из условий:

1. орбитальные или внутричерепные осложнения;
2. **три признака** бактериального синусита и более (перечислены ниже);
3. иммунодефицит, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, некомпенсированный сахарный диабет I типа;
4. **4 эпизода** синусита и более за последний год.

О бактериальном синусите свидетельствуют **три признака и более**:

1. гнойные выделения или выделения только из одной половины носа **в течение 3 дней и более**;
2. головная боль или ощущение давления в проекции верхнечелюстных или лобных пазух;
3. температура тела **38,0 °C и выше**;
4. «вторая волна» заболевания;
5. лейкоцитоз **выше 15×10^9/л**.

На бактериальную этиологию указывают также выраженные с самого начала симптомы, сохраняющиеся 3–4 дня и угрожающие развитием орбитальных или внутричерепных осложнений.

4.3 Среднетяжёлое течение

Базисная терапия и системная антибактериальная терапия:

1. При впервые возникшем синусите стартовым препаратом является незащищённый аминопенициллин (амоксициллин).

   При высоком риске устойчивости пневмококка дозу амоксициллина увеличивают.

   Сразу защищённые аминопенициллины — при

   1. сопутствующие заболевания;
   2. иммуносупрессия;
   3. возраст **старше 65 лет**;

4. неэффективность ранее назначенного амоксициллина.

2. Если заметного эффекта нет **в течение 3 дней**, препарат меняют, не дожидаясь окончания курса. У детей эффективность оценивают **через 48–72 часа**.
3. Пункция верхнечелюстной пазухи при рентгенологически подтверждённом содержимом в пазухе, если лечение с системными антибиотиками **в течение 5–7 дней** не дало эффекта; при тяжёлом течении пункцию выполняют и без этого условия.
   Детям пункция и трепанопункция выполняются только в условиях стационара; во многих случаях вместо них возможно применение синус-катетера.
4. Дренирование пазух, в том числе с помощью синус-катетера, при затяжном экссудативном синусите без обструкции соустий. При впервые возникшем неосложнённом синусите дренирование не показано.

Препараты, дозы и длительность курса приведены в таблице «Антибактериальные препараты и дозы» ниже.

4.4 Тяжёлое течение

Экстренная госпитализация в оториноларингологическое отделение (показания приведены в разделе «Показания к госпитализации»), базисная терапия и парентеральная антибактериальная терапия:

1. Взрослым при тяжёлом синусите вводятся цефотаксим или цефтриаксон, возможно также внутривенное введение амоксициллина с клавулановой кислотой. При риске анаэробной инфекции применяют клиндамицин в сочетании с цефалоспорином III поколения. При неэффективности стартовой парентеральной терапии рассматривается назначение цефоперазона с сульбактамом 2–4 г в сутки внутривенно в 2 введения, при резистентных штаммах препаратов резерва с учётом чувствительности.
2. Детям вводятся ампициллин с сульбактамом 300 мг/кг в сутки в 3–4 введения, цефтриаксон 75 мг/кг в сутки в 2 введения или цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 4 введения. При неэффективности этой терапии переходят на цефоперазон с сульбактамом 75–160 мг/кг в сутки в 2–4 введения (в КР со знаком #, то есть вне инструкции).
3. При орбитальных или внутричерепных осложнениях хирургическое лечение в стационаре: вскрытие пазухи и дренирование абсцесса.
4. Бактериофаги взрослым с острым бактериальным синуситом; местное применение оправдано при устойчивости возбудителя к антибиотикам или их непереносимости.

4.5 Антибактериальные препараты и дозы

Взрослые

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	500 мг × 3 р/сут — без факторов риска[1] 1000 мг × 3 р/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[2]	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут
Цефуроксим	250–500 мг × 2 р/сут
Цефиксим	400 мг × 1 р/сут
Цефдиторен внутрь	200 мг × 2 р/сут
Цефподоксим внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	

Препарат	Доза
Кларитромицин внутрь	250–500 мг × 2 р/сут
Левофлоксацин внутрь	500 мг × 1 р/сут
Моксифлоксацин внутрь	400 мг × 1 р/сут
Клиндамицин в/м (в КР со знаком #)	400–900 мг × 3 р/сут, 7–10 дней

[1] Риск устойчивости пневмококка повышают приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детский сад, и проживание в закрытых учреждениях.

[2] Риск продукции бета-лактамаз (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis) повышают бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит, иммуносупрессия, возраст **старше 65 лет** и неэффективность предшествующей терапии амоксициллином.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7 дней, осложнённого 10–14 дней.

Макролиды являются препаратами резерва и применяются только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов. Фторхинолоны допустимы только у взрослых и только при отсутствии других вариантов; детям и подросткам они противопоказаны.

Дети

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	40–60 мг/кг/сут — без факторов риска[1] 80–90 мг/кг/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь	45–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Цефуроксим	30 мг/кг/сут в 2 приёма, не более 500 мг в сутки
Цефиксим	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен, цефподоксим (старше 12 лет) внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	15 мг/кг/сут в 2 приёма, макс. 1000 мг/сут
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат в/м (стационар, если β-лактамы невозможны)	125–250 мг 2–3 р/сут в зависимости от возраста

Амоксициллин с клавулановой кислотой предпочтителен, если за последние 3 месяца ребёнок получал антибиотики или посещает детский коллектив, а также при неэффективности амоксициллина **в течение 48–72 часов**. При лёгкой аллергии на пенициллины применяют цефалоспорины III поколения внутрь.

Дозы из расчёта на килограмм массы тела предназначены для детей с массой тела менее 40 кг; при массе 40 кг и более используют дозы для взрослых.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7–10 дней, при орбитальных и внутричерепных осложнениях или рецидивирующем течении 10–14 дней.

> В тексте КР имеется расхождение: в разделе 3.1 стартовая доза амоксициллина для детей составляет 50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, в таблице 5 указано 40–60 мг/кг в сутки (80–90 мг/кг при факторах риска). На сайте приведены данные таблицы.

Иное лечение (раздел 3.3) и медицинская реабилитация (раздел 4) не требуются.

4.6 Профилактика

Детям из групп риска по респираторным заболеваниям рекомендованы местные и системные лизаты бактерий.

При рецидивирующем синусите и предрасполагающих к нему изменениях перегородки носа или латеральной стенки полости носа показано плановое хирургическое лечение.

4.7 Особые случаи

Сопутствующий аллергический ринит способствует затяжному течению синусита; в этом случае необходимы системные антигистаминные препараты и более высокая доза глюкокортикостероидов.

Лечение одонтогенного синусита хирургическое, с удалением пломбировочного материала и секвестров. Из антибактериальных препаратов предпочтительны респираторные фторхинолоны, поскольку преобладает анаэробная микрофлора.

---

5. Показания к госпитализации. Осложнения

Экстренная госпитализация в оториноларингологическое отделение показана:

1. при тяжёлом течении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями;
2. при отсутствии улучшения на фоне системной антибактериальной терапии **в течение 3–5 дней**;
3. при прогрессирующем ухудшении состояния в любой момент.

Орбитальные и внутричерепные осложнения свидетельствуют о тяжёлом течении, острый средний отит о среднетяжёлом.

Пациента выписывают при стабильно удовлетворительном состоянии **в течение не менее 3 дней**.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый синусит»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (карточка рубрикатора на 22.10.2026); год окончания действия не указан
Актуализация	По правилу из самой КР — «не реже чем один раз в три года» (прил. А2): следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	313_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети
Целевая аудитория	Оториноларингологи, терапевты, педиатры

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина: в тексте раздела 3.1 указано 50–60 мг/кг/сут, в таблице 5 указано 40–60 (80–90) мг/кг/сут.
- Пометка off-label стоит там, где в КР у препарата знак #; в этой КР он не расшифрован. ⚠ В российских КР им, как правило, обозначается применение вне инструкции; это следует проверить по инструкции к препарату.

6.2 Шкалы доказательности

Шкала	Интерпретация
УУР А	Сильная рекомендация: все критерии эффективности являются важными, исследования высокого или удовлетворительного качества, выводы согласованы
УУР В	Условная рекомендация: не все критерии эффективности являются важными, не все исследования высокого качества и/или выводы не согласованы
УУР С	Слабая рекомендация: доказательства надлежащего качества отсутствуют
УДД 1–5	Для лечения: от 1 (систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований с метаанализом) … до 5 (только обоснование механизма действия или мнение экспертов). Для диагностики используется отдельная шкала (табл. П1); точная расшифровка открывается при нажатии на бейдж

Клинические рекомендации

Острый тонзиллит и фарингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J02** — Острый фарингит **J02.0** — Стрептококковый фарингит **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J02.9** — Острый фарингит неуточненный **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J03.0** — Стрептококковый тонзиллит **J03.8** — Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями **J03.9** — Острый тонзиллит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Возбудителями тонзиллофарингита в большинстве случаев являются вирусы, и антибактериальная терапия при этом не показана. Из бактериальных возбудителей лечения требует только бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА); выделение из зева стафилококка, пневмококка и других микроорганизмов расценивается как колонизация.
- По клинической картине отличить вирусный тонзиллофарингит от бактериального невозможно. Пациентам **старше 3 лет** выполняют экспресс-тест на БГСА; при отрицательном результате у ребёнка его подтверждают бактериологическим исследованием (посевом).
- Антибактериальная терапия назначается только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии. При вирусной инфекции антибиотики неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.
- Препаратом выбора является амоксициллин, курс лечения составляет **10 дней**.
- При отсутствии улучшения **через 48–72 часа** от начала антибактериальной терапии следует пересмотреть диагноз: заболевание может быть обусловлено острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) или инфекционным мононуклеозом.
- Показания к госпитализации:

  Госпитализация в инфекционное отделение

  1. тяжёлое состояние;
  2. отказ от еды и питья, требующий инфузионной терапии.

  Консультация оториноларинголога и госпитализация в хирургическое отделение

  1. подозрение на гнойное осложнение;
  2. атипичная клиническая картина;
  3. необходимость хирургического вмешательства.
- Рутинно не показаны:
  1. определение С-реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина;
  2. общий анализ крови в амбулаторных условиях;
  3. исследование антистрептолизина О (АСЛ-О);
  4. контрольный мазок после лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острый тонзиллофарингит является острым инфекционным воспалением слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки (нёбных миндалин и лимфоидных фолликулов задней стенки глотки). Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, поскольку чаще в воспалительный процесс вовлекаются оба отдела.

По локализации (преимущественно поражённый отдел ротоглотки)

1. тонзиллит;
2. фарингит;
3. тонзиллофарингит.

По этиологии

1. стрептококковый;
2. нестрептококковый (вирусный).

Тактика лечения определяется этиологией.

2.2 Клиническая картина

Заболевание начинается остро.

1. повышение температуры тела **выше 38 °C**, реже температура нормальная или субфебрильная;
2. боль в горле, усиливающаяся при глотании, возможна иррадиация в ухо;
3. увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов;
4. у детей младшего возраста отказ от еды.

Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

2.3 Чувствительность возбудителя и колонизация

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. Устойчивость к макролидам выявляется примерно у каждого пятого штамма, к клиндамицину у 3–4%.

Выделение из зева *S. aureus*, *S. pneumoniae* или других бактерий при клинической картине тонзиллофарингита расценивается как колонизация и не требует назначения антибиотиков.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на выраженную боль в горле при глотании;
2. данные осмотра: гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличение регионарных лимфатических узлов;
3. результаты экспресс-теста на БГСА или бактериологического исследования.

3.2 Фарингоскопия и общий осмотр

Показания

1. каждый пациент: осмотр оториноларинголога, педиатра, врача общей практики или терапевта.

Признаки стрептококковой этиологии

1. увеличение подчелюстных или переднешейных лимфатических узлов;
2. высокая температура тела;
3. выраженная боль в горле;
4. «пылающий зев»;
5. налёт на миндалинах;
6. отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

Признаки вирусной этиологии

1. насморк;
2. конъюнктивит;
3. кашель;
4. при инфекции вирусом Эпштейна — Барр генерализованная лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки.

Петехии на мягком нёбе встречаются как при стрептококковой инфекции, так и при инфекции вирусом Эпштейна — Барр.

Также следует учитывать

1. У детей **старше 3 лет** насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит при стрептококковой инфекции встречаются не более чем у 10% пациентов и только при сопутствующей вирусной инфекции.
2. Симметричное увеличение миндалин отличает тонзиллофарингит от паратонзиллярного абсцесса.

3.3 Экспресс-тест на БГСА

Показания

1. пациенты **старше 3 лет**.

Оценка результата

1. положительный результат: посев не требуется;
2. отрицательный результат у взрослых: посев не требуется;
3. отрицательный результат у детей и подростков: результат подтверждают бактериологическим исследованием.

Детям **до 3 лет** экспресс-тест рутинно не проводится; исключением является стрептококковый тонзиллит у кого-либо из окружения ребёнка, например у старшего брата или сестры.

3.4 Бактериологическое исследование мазка из зева

Показания

1. пациенты **старше 3 лет**, если экспресс-тест не проводился или его результат отрицательный.

Результат готов **в течение 72 часов**.

Забор материала

1. до начала антибактериальной терапии;
2. до утренней гигиены полости рта, натощак или **через 2 часа** после еды;
3. под контролем орофарингоскопии, без касания зубов и языка;
4. из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

3.5 Дифференциальная диагностика стрептококкового и вирусного тонзиллофарингита

Дифференциальную диагностику стрептококкового и вирусного тонзиллофарингита проводят у каждого пациента. Шкалы позволяют выявить пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции.

Шкала Центора в модификации МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1

Признак	Баллы
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Отсутствие катаральных явлений и кашля	1
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Лечебная тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Посев и/или антибактериальная терапия не показаны
2–3	21–38% / 23–37%	Антибактериальная терапия по результатам экспресс-теста и/или посева
4 и более	57% / 55%	Антибактериальная терапия на основании клинической картины

Шкала FeverPAIN

По одному баллу начисляется за каждый признак: повышение температуры тела за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня в связи с выраженными симптомами, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

Вероятность стрептококковой инфекции групп A, C или G составляет 16% при 0–2 баллах, 43% при 3 баллах, 63% при 4–5 баллах.

Шкалы позволяют выявить пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, однако не дают возможности установить диагноз с абсолютной точностью.

3.6 Дифференциальная диагностика с другими заболеваниями

1. Инфекционным мононуклеозом чаще болеют подростки и лица молодого возраста **до 30 лет**. Характерны слабость, лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в периферической крови. Диагноз подтверждается методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ДНК вируса Эпштейна — Барр и выявлением IgM к капсидному антигену.
2. Синдромом «рука — нога — рот» болеют дети **до 5 лет**, как правило в летний период: на слизистой оболочке полости рта появляются везикулы без налётов на миндалинах, на кистях и стопах отмечается сыпь.
3. При ангине Симановского — Плаута — Венсана на одной миндалине формируется некротическая язва, отмечается гнилостный запах.
4. При дифтерии зева налёт плотный, снимается с трудом, после снятия остаётся кровоточащая поверхность.
5. Синдром Маршалла (PFAPA) характеризуется периодической лихорадкой **до 39–40 °C** в сочетании с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом. Приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей составляет 5 лет; приступ быстро купируется системными кортикостероидами.

3.7 Исследования, не показанные рутинно

В амбулаторных условиях определение СРБ и прокальцитонина не позволяет отличить вирусное воспаление от бактериального.

Показания

1. СРБ: госпитализация;
2. прокальцитонин: тяжёлое состояние пациента в стационаре.

Общий анализ крови в амбулаторных условиях рутинно не выполняют.

Показания

1. исключение инфекционного мононуклеоза и другие показания.

АСЛ-О применимо только для ретроспективной диагностики: его уровень повышается лишь **на 7–9-й день**.

Показания

1. подозрение на ревматическую лихорадку;
2. подозрение на гломерулонефрит;
3. подозрение на детские аутоиммунные нейропсихиатрические расстройства, ассоциированные со стрептококковой инфекцией (PANDAS).

Контрольный мазок на БГСА после лечения не показан.

Контрольный мазок показан при

1. высокий риск ревматической лихорадки;
2. рецидив симптомов.

---

4. Лечение

4.1 Вирусный тонзиллофарингит

1. Системные антибактериальные препараты не применяют: они неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.
2. Профилактическое назначение антибиотиков не рекомендуется.
3. Симптоматическая терапия (ниже).

4.2 Стрептококковый тонзиллофарингит

1. Антибактериальную терапию назначают только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии.
2. Препарат выбора: амоксициллин.

   При инфекционном мононуклеозе на фоне приёма амоксициллина возможно появление сыпи, однако она возникает и при приёме других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе следует избегать назначения любых системных антибактериальных препаратов.
3. Курс пенициллинов, цефалоспоринов, линкозамидов и макролидов, кроме азитромицина, составляет **10 дней**.
4. Если **через 48–72 часа** от начала антибактериальной терапии температура тела и боль в горле не уменьшились, следует пересмотреть диагноз: наиболее вероятны ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.
5. При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите препараты выбора: амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям **старше 3 лет**) курсом **10 дней**. Необходима консультация оториноларинголога для исключения хронического тонзиллита, у детей также синдрома PFAPA.

6. При нетяжёлой аллергии на пенициллины: цефалоспорины II–III поколения (цефуроксим, цефиксим, цефдиторен, цефподоксим). Перекрёстная аллергия с пенициллинами встречается менее чем в 2% случаев для цефалоспоринов II поколения и менее чем в 1% для III поколения.

   Уровни доказательности в рекомендации различаются

   1. цефуроксим: УУР C, УДД 5;
   2. цефиксим: C и 5 у детей, B и 1 у взрослых;
   3. цефдиторен: C и 2;
   4. цефподоксим: B и 2.

   Курс лечения **10 дней**.

7. При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница): макролиды или линкозамиды с учётом возможной устойчивости стрептококка к макролидам.
8. Бензатина бензилпенициллин однократно внутримышечно вместо курса приёма внутрь только при сомнениях в том, что пациент будет принимать препарат. Доза для детей с массой тела до 27 кг составляет 600 тысяч ЕД, более 27 кг 1,2 миллиона ЕД.

4.3 Дозы для приёма внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия, 10 дней		
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1] [3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма

Препарат	Взрослые	Дети
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] При сомнениях в соблюдении пациентом назначений, ревматической лихорадке у пациента или его родственников, неблагоприятных бытовых условиях и вспышках инфекции в коллективе. [3] Доза клавулановой кислоты не должна превышать 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

> Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте 250 мг 2 раза в сутки, в таблице 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 40 мг/кг в сутки, в таблице 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки, в таблице в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор дозы остаётся за врачом; дозы следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

4.4 Парентеральная терапия

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, антибиотик вводится парентерально до стабилизации состояния с последующим переходом на пероральный приём.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (при тяжёлом течении — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

4.5 Симптоматическая терапия

При лихорадке и болевом синдроме применяют ибупрофен, парацетамол или, у пациентов **старше 15 лет**, ацетилсалициловую кислоту; детям применяют только парацетамол и ибупрофен.

Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающие назначают при температуре

1. **выше 39,0 °C** при измерении в прямой кишке;
2. **выше 38,5 °C** в подмышечной впадине.

Ибупрофен

1. взрослые: 200–400 мг;
2. дети: 7,5 мг/кг, не более 30 мг/кг в сутки.

Парацетамол

1. взрослые: 500–1000 мг;
2. дети: 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначаются.

Исключением являются выраженный дискомфорт и угроза асфиксии, например при инфекционном мононуклеозе. В этом случае однократно внутрь назначается #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При выраженном болевом синдроме используют местные анестетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в виде спреев, растворов и таблеток для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение не заменяет системную антибактериальную терапию.

Бензидамин разрешён с 3 лет, бензокаин с хлоргексидином у детей старше 4 лет, флурбипрофен старше 12 лет, кетопрофен с 12 лет. Препараты для лечения заболеваний горла в целом применяются с 3–4 лет из-за риска ларингоспазма. «Смазывание» миндалин и механическое удаление налётов не рекомендуются.

Дополнительно, в том числе курсами в межрецидивный период, возможно применение растительных препаратов: корня алтея, ромашки, тысячелистника, коры дуба, хвоща, листьев грецкого ореха, одуванчика.

Рекомендуется ограничение раздражающей пищи (острой, кислой, солёной, горячей и холодной); пища должна иметь мягкую консистенцию.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения

После тесного бытового контакта с больным стрептококковой инфекцией антибиотикопрофилактика показана:

1. беременным со сроком гестации **37 недель и более**;
2. новорождённым и родильницам **в первые 28 дней**;
3. лицам в возрасте **75 лет и старше**.

Больные стрептококковым тонзиллофарингитом подлежат изоляции от организованных коллективов, их контакты ограничиваются.

Для профилактики рецидивов тонзиллофарингита применяют лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациент находится под наблюдением **в течение месяца**:

1. общий анализ крови и мочи **через 7–10 дней** и **через 3 недели**;
2. электрокардиография (ЭКГ) при жалобах со стороны сердца.

Лечение, как правило, амбулаторное. На фоне антибактериальной терапии улучшение наступает **через 12–24 часа**. Ребёнок допускается в детский коллектив после полного выздоровления.

Госпитализация в инфекционное отделение

1. тяжёлое состояние;
2. отказ от еды и питья, требующий инфузионной терапии.

Консультация оториноларинголога и госпитализация в хирургическое отделение

1. подозрение на гнойное осложнение;
2. атипичная клиническая картина;
3. необходимость хирургического вмешательства.

Гнойные осложнения стрептококковой инфекции

1. паратонзиллярный абсцесс;
2. парафарингеальный абсцесс;
3. ретрофарингеальный абсцесс;
4. гнойный лимфаденит.

Негнойные осложнения

1. острая ревматическая лихорадка;
2. ревматическая болезнь сердца;
3. постстрептококковый гломерулонефрит;
4. стрептококковый токсический шок;
5. PANDAS.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина с клавулановой кислотой и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются; расхождения приведены в блоке «Текст КР и таблица 1 расходятся» на вкладке «Лечение».
- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» указано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед»; по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.

Клинические рекомендации

Отит средний острый

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.0** — Острый средний серозный отит **H65.1** — Другие острые негнойные средние отиты **H66.0** — Острый гнойный средний отит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Острый средний отит (ОСО) является воспалительным процессом, охватывающим все три отдела среднего уха: барабанную полость, клетки сосцевидного отростка и слуховую трубу. Заболевание проявляется болью в ухе, повышением температуры тела, снижением слуха, в ряде случаев гноетечением из уха.
- Диагноз острого среднего отита:

  Обязательные критерии (все три одновременно)

  1. острое начало заболевания;
  2. воспалительные изменения барабанной перепонки: гиперемия, инфильтрация;
  3. признаки выпота в барабанной полости: выбухание барабанной перепонки или снижение её подвижности при пневмоотоскопии или тимпанометрии.

  Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.
- Показания к системной антибактериальной терапии:
  1. возраст **до 2 лет**: во всех случаях при клинических признаках отита;
  2. гнойная форма независимо от возраста;
  3. сохранение симптомов **более 72 часов**;
  4. рецидивирующее течение;
  5. отягощающая сопутствующая патология;
  6. невозможность повторного осмотра пациента.
- Препаратом первой линии является амоксициллин. При отсутствии эффекта **в течение 3 дней** его заменяют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим. Курс составляет **7–10 дней**.
- Для обезболивания используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол; ушные капли с лидокаином и феназоном допустимы только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.
- Показания к экстренной госпитализации:
  1. тяжёлое течение;
  2. отсутствие положительной динамики при лёгком течении на фоне адекватной терапии **в течение 3–5 дней**;
  3. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.
- **Через 3–4 недели** пациента повторно осматривают с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы своевременно выявить экссудативный средний отит.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Острый средний отит: воспаление всех трёх отделов среднего уха (барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы); поражается только слизистая оболочка.

Проявляется одним или несколькими симптомами

1. боль в ухе;
2. повышение температуры тела;
3. снижение слуха;
4. в ряде случаев гноетечение.

Рецидивирующим считается отит при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

Затянувшимся считается отит, при котором симптомы воспаления среднего уха сохраняются **в течение 3–12 месяцев** после одного или двух курсов антибактериальной терапии.

У детей возможны возбуждение, раздражительность, рвота и диарея. Заболевание, как правило, длится не более трёх недель.

2.2 Стадии

1. острый евстахеит;
2. острое катаральное воспаление;
3. доперфоративная стадия острого гнойного воспаления;
4. постперфоративная стадия острого гнойного воспаления;
5. репаративная стадия.

Отоскопическая картина каждой стадии приведена в разделе «Диагностика».

2.3 Степень тяжести

Лёгкое течение	**Тяжёлое течение**
Осложнения отсутствуют	Интратемпоральные или внутричерепные осложнения
Выбухание барабанной перепонки отсутствует	Выраженное выбухание барабанной перепонки
Непродолжительная боль в ухе, хорошо купируется лекарственными средствами	Выраженный болевой синдром (у детей раннего возраста проявляется изменением поведения), плохо купируется или не купируется лекарственными средствами
Общее состояние не изменено: сон, аппетит и активность не нарушены	Общее состояние изменено
Нормальная температура тела или субфебрилитет не более 3 дней	Субфебрилитет более 3 дней или температура тела выше 38,0 °C

2.4 Клиническая картина

Дети старше 2 лет

1. остро возникшая боль в ухе;
2. воспалительные изменения барабанной перепонки: гиперемия, выбухание, снижение подвижности при пневмоотоскопии;
3. оторея в постперфоративной стадии.

Дети раннего возраста

1. выбухание барабанной перепонки;
2. изменения поведения: беспокойство, отказ от еды, ребёнок теребит и трёт ухо.

Взрослые пациенты чаще предъявляют жалобы на заложенность уха, аутофонию и шум в ухе.

Снижение слуха носит кондуктивный характер; сенсоневральный компонент присоединяется редко.

2.5 Возбудитель и выбор антибактериального препарата

Возбудителя в ряде случаев можно предположить по клинической картине. При сочетании отита с конъюнктивитом наиболее вероятным возбудителем является H. influenzae. Стремительное начало с лихорадкой, спонтанной перфорацией и симптомами со стороны дыхательных путей характерно для S. pyogenes, нарастающая боль, лихорадка и спонтанная перфорация характерны для S. pneumoniae.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии (все три одновременно)

1. острое начало заболевания;
2. воспалительные изменения барабанной перепонки: гиперемия, инфильтрация;
3. признаки выпота в барабанной полости: выбухание барабанной перепонки или снижение её подвижности при пневмоотоскопии или тимпанометрии.

Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.

3.2 Отоскопия

Показания

1. все пациенты с острым средним отитом: первичный осмотр оториноларинголога при обращении и при госпитализации.

Диагностические признаки по стадиям

1. В стадии острого катарального воспаления барабанная перепонка гиперемирована, утолщена, опознавательные знаки определяются с трудом или не определяются.
2. В стадии острого гнойного воспаления боль в ухе резко усиливается, температура тела достигает фебрильных значений; барабанная перепонка ярко гиперемирована, выбухает, опознавательные знаки не определяются, возможна перфорация.
3. В постперфоративной стадии через перфорацию барабанной перепонки в наружный слуховой проход поступает гнойное отделяемое.
4. В репаративной стадии жалобы практически отсутствуют, цвет и толщина барабанной перепонки восстанавливаются, перфорация в большинстве случаев закрывается рубцом, однако восстановление слизистой оболочки среднего уха ещё не наступило.

3.3 Пневматическая отоскопия

Показания

1. отсутствие реактивных изменений барабанной перепонки: оценка её подвижности.

Диагностические признаки

1. снижение подвижности (податливости) барабанной перепонки указывает на воспалительный выпот в барабанной полости.

3.4 Тональная аудиометрия

Показания

1. затяжное течение (**более 10 дней**);
2. рецидивирующий отит;
3. исключение нейросенсорной тугоухости.

3.5 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. все пациенты с острым средним отитом.

Диагностические признаки

1. уровень лейкоцитоза позволяет оценить вероятность бактериальной природы воспаления (пороговые значения в таблице ниже).

3.6 Прокальцитонин крови

Показания

1. подозрение на тяжёлое течение;
2. сложные диагностические случаи: подтверждение бактериальной природы отита.

Маркеры бактериального воспаления

Показатель	Катаральный отит	Гнойный отит
Лейкоциты <10 / 10–15 / >15 ×10^9/л	50% / 38% / 12%	12% / 29% / 59%
СРБ <15 / 15–60 / ≥60 мг/л	33% / 50% / 17%	14% / 36% / 50%
ПКТ <0,5 / 0,5–2 / 2–10 нг/мл	58% / 38% / 4%	4% / 32% / 64%

Пороговые значения для гнойного отита

1. лейкоциты >15×10^9/л (ППР 85%, ПОР 64%);
2. С-реактивный белок (СРБ) >30 мг/л (ППР 79%, ПОР 52%);
3. прокальцитонин (ПКТ) >2 нг/мл (ППР 94%, ПОР 74%).

Таблица в PDF представлена изображением; значения перенесены вручную и сверены по изображению страницы 13.

3.7 Микробиологическое исследование отделяемого

Посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. парацентез или отделяемое из барабанной полости у пациентов в стационаре с тяжёлым и рецидивирующим течением.

Забор материала

1. отделяемое из барабанной полости забирают сухим стерильным ватным тампоном;
2. материал с соблюдением асептики помещают в пробирку с транспортной питательной средой;
3. оптимальное время доставки в лабораторию **40 минут**.

3.8 Компьютерная томография височных костей

Показания

1. затяжное течение (**более 10 дней**);
2. выраженная стойкая отрицательная динамика;
3. подозрение на мастоидит или внутричерепные осложнения.

Если КТ выполнить невозможно, по тем же показаниям проводят рентгенографию височных костей в проекциях по Шюллеру и Майеру.

4. Лечение

4.1 Обезболивающая и жаропонижающая терапия

При болевом синдроме и лихорадке применяют НПВП или парацетамол разово:

1. при боли в ухе;
2. при температуре тела **выше 38,5 °C**;
3. при фебрильных судорогах в анамнезе уже **при 38,0 °C**.

Детям **до 6 лет** допустимы только:

1. парацетамол: до 60 мг/кг в сутки, 10–15 мг/кг на приём;
2. ибупрофен: до 30 мг/кг в сутки, 8–10 мг/кг на приём.

Местное обезболивание обеспечивают ушные капли с лидокаином и феназоном; их применение допустимо только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.

4.2 Показания к антибактериальной терапии

Системную антибактериальную терапию назначают при наличии хотя бы одного из показаний:

Показание	Пояснение
Возраст до 2 лет	Во всех случаях при наличии клинических признаков ОСО
Гнойная форма независимо от возраста	Перфорация барабанной перепонки с гнойным отделяемым; при отсутствии перфорации болевой синдром, не купируемый анальгетиками, в сочетании с выраженной гиперемией, отсутствием опознавательных знаков и выбуханием барабанной перепонки
Сохранение симптомов более 72 часов независимо от возраста	Боль, лихорадка или интоксикация при отоскопических признаках ОСО в течение 72 часов и более от начала заболевания
Рецидивирующее течение	3 и более эпизода за 6 месяцев или 4 и более за год
Сопутствующая патология	Сахарный диабет, иммунодефицитные состояния, муковисцидоз, синдромы цилиарной дискинезии, синдром Дауна, врождённые аномалии твёрдого и мягкого нёба
Невозможность повторного осмотра	Отсутствует возможность контрольного осмотра с отоскопией врачом-оториноларингологом или врачом общей практики

4.3 Выбор антибактериального препарата

Препаратом первой линии является амоксициллин при условии, что пациент не принимал его в течение последних 30 дней, а гнойный конъюнктивит и непереносимость аминопенициллинов отсутствуют.

Препаратами второй линии являются защищённые пенициллины и цефалоспорины III поколения. При отсутствии эффекта от амоксициллина **в течение 3 дней** его заменяют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим.

При затянувшемся и рецидивирующем отите стартовыми препаратами являются амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим внутрь.

Макролиды у детей относятся к препаратам третьей линии; их применение оправдано только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов, поскольку устойчивость пневмококка к ним превышает 40%.

При лёгкой непереносимости пенициллинов альтернативой служат цефалоспорины III поколения: в амбулаторных условиях цефиксим, в стационаре при необходимости цефтриаксон парентерально.

Продолжительность курса составляет **7–10 дней**. Более длительные курсы необходимы:

1. детям до 2 лет;
2. пациентам с отореей;
3. пациентам с сопутствующими заболеваниями;
4. при затянувшемся и рецидивирующем отите: как правило, **не менее 14 дней**.

Антибактериальную терапию не прекращают до купирования отореи.

Тетрациклины, линкозамиды, аминогликозиды и ко-тримоксазол не рекомендуются в связи с низкой активностью в отношении пневмококка и гемофильной палочки и высокой частотой нежелательных явлений.

В постперфоративной стадии системная антибактериальная терапия продолжается.

4.4 Суточные дозы

Препарат	Взрослые	Дети
Препарат выбора		
Амоксициллин (независимо от приёма пищи)	0,5 г 3 раза в сутки без факторов риска[1]; 1,0 г 3 раза в сутки при факторах риска[2]	50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма[1]
Альтернативные препараты		
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[3] (в начале приёма пищи)	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки	40–45 мг/кг в сутки в 2–3 приёма
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в[4]	3,6 г в сутки в 3 введения	90 мг/кг в сутки в 3 введения (при массе тела 4–40 кг); 60 мг/кг в сутки (при массе тела менее 4 кг)
Ампициллин + сульбактам в/в[3]	1,5–3 г в сутки в 4 введения	150–300 мг/кг в сутки в 3–4 введения
Цефтриаксон[4]	2,0–4,0 г в сутки в 1 введение	50–80 мг/кг в сутки в 1 введение
Аллергия на пенициллины (не анафилактическая)		
Цефуроксим (непосредственно после приёма пищи)	500 мг в сутки в 2 приёма (так в таблице КР)	до 3 лет: 30 мг/кг в сутки в 2 приёма; старше 3 лет: 500 мг в сутки в 2 приёма
Цефиксим	400 мг в сутки в 1 приём	8 мг/кг в сутки в 1 приём
Аллергия на пенициллины и цефалоспорины		
Кларитромицин внутрь (показание «острый средний отит» зарегистрировано только для гранул для приготовления суспензии 125 и 250 мг/5 мл)	1000 мг в сутки в 2 приёма	15 мг/кг в сутки в 2 приёма

[1] [2] Без факторов риска / при факторах риска устойчивости пневмококка: приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца; дети дошкольного возраста в семье, посещающие детские учреждения; проживание в «закрытых» учреждениях. [3] Факторы риска продукции β-лактамаз: сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит), иммуносупрессия, неэффективность терапии амоксициллином. [4] При высоком риске осложнений.

> В тексте рекомендации имеется расхождение. В комментарии к рекомендации об амоксициллине стандартная доза для детей составляет 45–60 мг/кг в сутки, а при высоком риске устойчивости пневмококка 80–90 мг/кг в сутки, тогда как в таблице 4 для детей указано 50–60 мг/кг в сутки.

У детей до 3 лет амоксициллин применяют только в форме суспензии или диспергируемых таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой и цефиксим в таблетках и капсулах разрешены к применению с 12 лет; для детей младше 12 лет с массой тела менее 40 кг предназначены гранулы, порошок для приготовления суспензии или диспергируемые таблетки.

4.5 Местная и вспомогательная терапия

При перфорации барабанной перепонки купирование отореи ускоряют ушные капли на основе фторхинолонов или дексаметазона в комбинации с противомикробными средствами. Капли, содержащие аминогликозиды, и спиртосодержащие капли противопоказаны в связи с ототоксическим действием.

Ушные капли с норфлоксацином разрешены детям старше 1 года, с ципрофлоксацином с 15 лет. Капли с офлоксацином и дексаметазоном в комбинации с противомикробными средствами применяются у детей старше 1 года при остром гнойном отите и установленной тимпаностомической трубке.

Сосудосуживающие капли в нос используют во всех стадиях для восстановления проходимости слуховой трубы на срок **не более 5–7 дней**. Применение нафазолина не рекомендуется.

Детям **до 6 лет**:

1. фенилэфрин 0,125%;
2. оксиметазолин 0,01–0,025%;
3. ксилометазолин 0,05%: с 2 лет.

До года допустимы только капли, после года по возможности переходят на дозированный назальный спрей.

Детям рекомендуется орошение полости носа изотоническим раствором морской воды 1–2 раза в день. У детей дошкольного возраста от промывания полости носа большими объёмами растворов следует воздержаться, поскольку это повышает риск развития отита.

Муколитические препараты применяют у детей старше 2 лет. Перед назначением следует свериться с зарегистрированными показаниями в инструкции, поскольку не каждый муколитик, эффективный при патологии бронхов, пригоден для лечения отита.

4.6 Хирургическое лечение

Показания к парацентезу:

1. выраженная клиническая симптоматика и выбухание барабанной перепонки без перфорации;
2. болевой синдром, не купируемый НПВП;
3. отсутствие улучшения **через 48–72 часа** антибактериальной терапии.

Во всех сомнительных случаях решение принимают в пользу парацентеза.

Внутривисочные или внутричерепные осложнения требуют экстренной антромастоидотомии.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Через 3–4 недели необходим повторный осмотр оториноларингологом с пневмоотоскопией или тимпанометрией для исключения экссудативного среднего отита.

Жалобы на снижение слуха после перенесённого отита служат поводом для консультации сурдолога-оториноларинголога.

В репаративной стадии проводятся продувание слуховых труб и пневмомассаж барабанных перепонок. Восстановление аэрации подтверждается объективными методами, в том числе тимпанометрией.

Консультация физиотерапевта рекомендуется в репаративной стадии.

Всем детям показана вакцинация против пневмококковой инфекции в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.

При рецидивирующем отите в плановом порядке выполняется шунтирование барабанной полости (тимпаностомия).

Показания к экстренной госпитализации:

1. тяжёлое течение;
2. отсутствие положительной динамики при лёгком течении на фоне адекватной терапии **в течение 3–5 дней**;
3. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.

Пациента выписывают при стабильно удовлетворительном состоянии **не менее 3 дней**.

Более тяжёлое течение и высокий риск осложнений отмечаются у пациентов с иммунодефицитом и сахарным диабетом. Риск развития отита повышен у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), аллергическим ринитом, а также у курильщиков, в том числе пассивных.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Отит средний острый»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	314_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина в комментарии к рекомендации составляет 45–60 мг/кг/сут («стандартная») и 80–90 мг/кг/сут (при высоком риске устойчивости пневмококка), тогда как в таблице 4 указано 50–60 мг/кг/сут.
- Для цефуроксима у взрослых в таблице 4 указано «500 мг/сут в 2 приёма»; дозу следует сверить с инструкцией в ГРЛС.
- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены детям старше 1 года, в КР «Наружные отиты» (663_2) с 15 лет; возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.

Клинические рекомендации

Отосклероз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H80** — Отосклероз
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/315_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Клиническая картина:
  1. прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха;
  2. шум в ушах;
  3. при отомикроскопии барабанная перепонка не изменена.
- Тональная пороговая аудиометрия всем пациентам:
  1. двустороннее повышение порогов воздушной проводимости на низких и средних частотах (**0,125–2 кГц**);
  2. чаще восходящая кривая;
  3. костно-воздушный интервал.
- Акустическая импедансометрия:
  1. тимпанограмма типа A или As;
  2. отсутствие акустического рефлекса.
- Стапедопластика:
  1. возраст **старше 15 лет**;
  2. кондуктивная или смешанная тугоухость;
  3. костно-воздушный интервал **не менее 25–30 дБ**;
  4. нет признаков активного отосклероза;
  5. нет общих противопоказаний.
- Инактивирующая терапия взрослым:
  1. кохлеарная форма;
  2. активные очаги.
- Слуховые аппараты при недостаточном уровне слуха и разборчивости речи:
  1. после операции;
  2. кохлеарная форма;
  3. противопоказания к операции или отказ от неё.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Отосклероз: первичное метаболическое поражение костной капсулы ушного лабиринта, особая форма остеодистрофии, как правило двусторонняя и очаговая, в энхондральном слое капсулы.

1. резорбция кости с образованием мягких кровенаполненных отоспонгиозных очагов;
2. отложение солей кальция и формирование плотной склеротической кости;
3. фазы размягчения и склерозирования сменяют друг друга волнообразно.

2.2 Этиология

Отосклероз наследуется по аутосомно-доминантному типу; пенетрантность гена составляет 20–40%.

2.3 Аудиометрическая классификация

Классификация Н. А. Преображенского и О. К. Патякиной (1973): средние пороги костной проводимости (КП) на частотах **0,5, 1 и 2 кГц** по данным тональной пороговой аудиометрии (ТПА).

Форма	Средний порог КП (0,5–2 кГц)
Тимпанальная	до 20 (единица измерения в КР не указана)
Смешанная I	21–30 дБ
Смешанная II	более 30 дБ
Кохлеарная	более 50 дБ

> Границы форм в КР пересекаются: для смешанной формы II указано «>30 дБ» без верхней границы, для кохлеарной формы «КП >50 дБ». В таблице алгоритма обследования (приложение А3) для смешанной формы указаны пороги КП «до 50 дБ», при этом смешанные формы I и II не разделены.

2.4 Другие классификации

1. гистологический и клинический отосклероз;
2. активная (незрелая, отоспонгиоз) и неактивная (зрелая) стадии; тактика лечения во многом зависит от стадии.

Формы по распространённости очагов (мультиспиральная КТ, МСКТ)

1. фенестральная: очаги в области окна преддверия;
2. ретрофенестральная: очаги вокруг базального и апикального завитков улитки, в области окна улитки, полукружных каналов и дна внутреннего слухового прохода;
3. смешанная.

Очаги единичные и множественные.

Денситометрия капсулы лабиринта

1. норма: +2000…+2200 HU;
2. **ниже 1000 HU**: активный процесс (деминерализация, отоспонгиоз);
3. **выше 1000 HU**: неактивный.

По интраоперационной картине в нише окна преддверия стапедиальный отосклероз подразделяется на ограниченный, умеренный, распространённый и облитерирующий. Наиболее сложными для стапедопластики являются облитерирующие формы, которые подразделяются на три степени. При 1-й степени подножная пластина стремени равномерно утолщена очагами; при 2-й степени очаги сужают нишу окна преддверия по краям при неизменённой пластине; при 3-й степени очаги сужают нишу и захватывают как пластину, так и суперструктуры стремени.

2.5 Клиническая картина

Основные симптомы

1. прогрессирующее, чаще двустороннее снижение слуха;
2. шум в одном или обоих ушах: низко- и среднечастотный у половины пациентов, высокочастотный у 10%;
3. разборчивость речи в шуме лучше, чем в тишине (paracusis Willisii, паракузия Виллизия): примерно у половины;
4. головокружение и нарушение равновесия: лишь у 24%.

3. Диагностика

Основания для диагноза

1. жалобы на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах;
2. нормальная отомикроскопическая картина;
3. тональная аудиометрия: кондуктивная, смешанная или нейросенсорная тугоухость;
4. речевая аудиометрия: 100% разборчивость;
5. импедансометрия: тимпанограмма типа А или As, отсутствие акустических рефлексов.

Учитывают также

1. латерализацию ультразвука и пороги его восприятия;
2. КТ височных костей с денситометрией: участки пониженной плотности на фоне плотной однородной капсулы лабиринта;
3. фенестральная форма: очаг пониженной плотности в промонториальной стенке кпереди от окна преддверия;
4. кохлеарная форма: очаги повторяют ход завитков улитки и распространяются до стенок внутреннего слухового прохода.

> В критериях диагноза для смешанной формы указано, что ей свойственны признаки, «характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм». По смыслу, вероятно, имелась в виду кохлеарная форма.

3.1 Жалобы и анамнез

Снижение слуха (уточняют у всех)

1. постепенное, без видимой причины;
2. как правило, двустороннее;
3. темп зависит от возраста начала (в «Подробнее»).

При всех формах слух снижается постепенно, без видимой причины. Тугоухость, как правило, двусторонняя, односторонняя встречается в 15–30% случаев. При раннем начале заболевания очаги чаще облитерирующие и распространённые, тугоухость быстро нарастает; при позднем начале очаги ограниченные, быстрого прогрессирования не наблюдается.

Шум в одном или обоих ушах (уточняют у всех).

Шум, как правило, низко- и среднечастотный (у 50%), реже высокочастотный (у 10%). В начале заболевания он ощущается только в тишине, по мере нарастания тугоухости усиливается.

Улучшение слуха в шумной обстановке (уточняют у всех).

Паракузия Виллизия встречается примерно у половины пациентов, чаще при выраженной фиксации стремени с сохранной костной проводимостью. При переходе тугоухости в смешанную форму этот симптом выявляется реже.

Головокружение и нарушения равновесия (уточняют у всех).

Эти жалобы предъявляют около 24% пациентов с отосклерозом. Их связывают с внутрилабиринтной гипертензией, поскольку после операции данные расстройства регрессируют.

3.2 Отомикроскопия

Показания

1. все пациенты: отомикроскопия или отоэндоскопия.

Диагностические признаки

1. барабанная перепонка целостная, опознавательные знаки чёткие;
2. характерные признаки отосклероза только у 10–21% пациентов (в «Подробнее»).

Барабанная перепонка целостная, опознавательные знаки чёткие. Характерные признаки отосклероза выявляются лишь у 10–21% пациентов.

К ним относятся симптом Лемперта (истончение барабанной перепонки с изменением её цвета вследствие атрофии фиброзного слоя), симптом Хилова (истончение кожи слухового прохода), симптом Тойнби (отсутствие или малое количество серы), симптом Швартца (просвечивание расширенных сосудов мыса через истончённую барабанную перепонку; является признаком активной стадии, встречается у 50%) и симптом Вирховского–Тилло (снижение чувствительности кожи слухового прохода и барабанной перепонки, снижение потоотделения, широкий слуховой проход). Ни один из этих симптомов не является патогномоничным, они оцениваются только в совокупности с другими проявлениями заболевания.

3.3 Лабораторные исследования

Специфической лабораторной диагностики нет; анализы нужны при подготовке к плановой операции.

3.4 Камертональные пробы

Показания

1. все пациенты: скрининговая оценка характера тугоухости (Ринне, Федеричи, Вебер).

Диагностические признаки

1. камертоны С128–С512: костно-воздушный интервал (Ринне, Федеричи) и хуже слышащее ухо (Вебер), это показание к тональной аудиометрии;
2. кохлеарная форма: пробы Ринне и Федеричи положительные, звук в пробе Вебера латерализуется в лучше слышащее ухо.

3.5 Тональная и речевая аудиометрия

Показания

1. все пациенты: форма и степень тугоухости.

Диагностические признаки

1. пороги воздушной (ВП) и костной проводимости, костно-воздушный интервал (КВИ, резерв улитки);
2. двустороннее повышение порогов ВП на **0,125–2 кГц**, чаще восходящая кривая с небольшим подъёмом;
3. по мере прогрессирования повышаются и пороги КП;
4. по типу кривой: тимпанальная, смешанная, кохлеарная форма.

Теория Р. Кархарта объясняет механическую природу сенсоневрального компонента нарушением микромеханики и гидродинамики улитки на частотах 0,5–2 кГц.

По данным речевой аудиометрии разборчивость речи составляет 100%.

3.6 Чувствительность к ультразвуку

Показания

1. все пациенты: оценка характера тугоухости по чувствительности к ультразвуку и его латерализации.

Диагностические признаки

1. пороги восприятия ультразвука **до 15 дБ**; при кохлеарной форме норма или незначительно повышены;
2. кохлеарная форма с односторонней или асимметричной тугоухостью: латерализация в лучше слышащее ухо;
3. латерализация в хуже слышащее ухо (60,9%): возможен гидропс лабиринта; характерно при длительности заболевания **более 10 лет**, подтверждается экстратимпанальной электрокохлеографией (ЭКоГ).

Очаги могут вовлекать утрикулярный нерв и сдавливать эндолимфатический проток, а выраженная обструкция его дистального отдела может приводить к расширению саккулюса вплоть до контакта с основанием стремени. Однако ни одна методика не позволяет с полной уверенностью выявить гидропс лабиринта и установить его эндо- или перилимфатический характер, хотя это имеет значение для определения показаний к операции и её результата.

3.7 Акустическая импедансометрия

Показания

1. все пациенты: тимпанометрия и акустическая рефлексометрия.

Цели

1. исключение патологии среднего уха;
2. оценка давления в среднем ухе, функции слуховой трубы, подвижности барабанной перепонки, состояния цепи слуховых косточек.

Диагностические признаки

1. тимпанограмма типа А или As;
2. отсутствие акустического рефлекса.

Акустическая импедансометрия является комплексным методом, включающим тимпанометрию, определение акустического импеданса (сопротивления) и акустического миорефлекса.

3.8 Данные аудиологического исследования при различных формах

Показатель	Тимпанальная	Смешанная	Кохлеарная
Тональная аудиометрия: вид кривой; пороги КП (0,5–2 кГц); КВИ	горизонтальная; до 20 дБ; 30–50 дБ	пологонисходящая; до 50 дБ; 30 дБ	крутонисходящая; выше 50 дБ; менее 10 дБ
Разборчивость речи	100%	100%	100%
Пороги чувствительности к ультразвуку (в КР единица «вт»)	10	10–15	более 15
Феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ)	не выявляется	редко	часто
Тимпанометрия	тип А	тип А	тип А
МСКТ височных костей	фенестральная локализация очагов	фенестральная и улитковая локализация очагов	часто деминерализация улитки

3.9 Мультиспиральная КТ височных костей с денситометрией

Показания

1. все пациенты: подтверждение диагноза, локализация и распространённость очагов, оценка их активности.

МСКТ с шагом 0,3–1 мм в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией и денситометрией является единственным объективным неинвазивным методом решения этих задач; чувствительность метода составляет 80–95%, специфичность 99,1%.

До операции МСКТ выявляет состояния, имитирующие отосклеротическую тугоухость или снижающие эффективность операции

1. неотосклеротическая фиксация цепи слуховых косточек;
2. дегисценция верхнего полукружного канала;
3. расширение водопровода преддверия;
4. остеодистрофии (синдром Ван-дер-Хуве);
5. облитерирующий отосклероз;
6. оссификация окна улитки и лабиринта.

Снижение плотности капсулы лабиринта с нормальных +2000…+2200 до **+1500…+300 HU**: начальная или далеко зашедшая деминерализация.

Фенестральная форма

1. очаги чаще в области впередиоконной щели и переднего полюса основания стремени с переходом на переднюю ножку;
2. плотность зрелых очагов +1000…+1100 HU;
3. плотность **+500…+800 HU**: вероятен активный отосклероз (отоспонгиоз);
4. тугоухость от тимпанальной до смешанной формы.

При смешанной форме, помимо фенестральных очагов, определяются участки пониженной плотности капсулы вокруг улитки с переходом на область окна улитки, в ряде случаев до дна внутреннего слухового прохода. На аудиограмме при этом может регистрироваться смешанная тугоухость 1–2 степени.

При кохлеарном отосклерозе в начальной стадии в капсуле вокруг улитки определяются участки плотностью +1500…+1100 HU. В умеренно активной стадии вокруг базального и апикального завитков визуализируются отчётливые участки плотностью +1000…+600 HU, которые часто переходят на область окна улитки и могут распространяться до дна внутреннего слухового прохода и горизонтального полукружного канала.

В стадии высокой активности деминерализация распространяется на капсулу на уровне базального и апикального завитков, может достигать преддверия и полукружных каналов, плотность составляет +300…+600 HU. В этой стадии возможна костная облитерация структур лабиринта, чаще всего базального завитка и горизонтального полукружного канала.

> Плотность активных очагов в КР указана неодинаково: в тексте о фенестральной форме +500…+800 HU, в подписи к рисунку 1 +300…+800 HU. В подписи к рисунку 3 для кохлеарной формы указано +600…+800 HU, тогда как в тексте рядом приведены значения +1000…+600 HU для умеренной и +300…+600 HU для высокой активности.

МСКТ позволяет установить и причину неудачной стапедопластики: оценить положение протеза и глубину его погружения в преддверие, выявить некроз длинной ножки наковальни, перилимфатическую фистулу и гранулему окна преддверия.

4. Лечение

4.1 Инактивирующая терапия

Показания к инактивирующей терапии (взрослые)

1. кохлеарная форма;
2. тимпанальная и смешанная формы в активной стадии перед операцией;
3. активный отосклероз, выявленный во время операции.

Цель: инактивация очагов отоспонгиоза.

Эффекты

1. снижает активность отосклероза;
2. замедляет нарастание сенсоневрального компонента;
3. повышает плотность капсулы лабиринта;
4. уменьшает вероятность реоссификации после операции;
5. останавливает рост очагов и препятствует облитерации улитки.

Число курсов определяют по плотности очагов отоспонгиоза по данным МСКТ височных костей с денситометрией. Все препараты комплекса в КР отмечены знаком #, что обозначает применение вне инструкции.

4.2 Схема одного курса у взрослых

Препарат	Доза
#Ибандроновая кислота	Внутривенно болюсом за 15–30 секунд 3 мг/3 мл однократно в процедурном кабинете, 1 раз в 3 месяца, или внутрь 150 мг 1 раз в месяц за час до еды, запивая стаканом воды.
#Алендроновая кислота	Вместо ибандроновой кислоты: 70 мг 1 раз в неделю за час до еды, запивая стаканом воды.
#Кальция глюконат	500 мг 3 раза в день после еды.
#Натрия фторид	30–60 мг (0,5 мг/кг) в течение 2 месяцев.
#Альфакальцидол	0,25 мкг 1 раз в день.

Курс **3 месяца**. По плотности очагов назначают 1, 2 или 4 курса с интервалами по 3 месяца до достижения плотности **+1000…+1500 HU**.

Плотность очагов по МСКТ	Число курсов
ниже +300 HU	4
+300…+600 HU	2
+600…+900 HU	1

> Активными в КР считаются очаги плотностью ниже 1000 HU, однако число курсов указано только для очагов до +900 HU: для очагов +900…+1000 HU схема не приведена.

4.3 Стапедопластика

Показания к стапедопластике

1. жалобы на снижение слуха и шум в ухе;
2. кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ **не менее 30 дБ**;
3. нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ с денситометрией;
4. нет перфорации барабанной перепонки и инфекции слухового прохода;
5. нет общих противопоказаний к плановой операции.

Стапедопластика пациентам **старше 15 лет** при кондуктивной или смешанной тугоухости с КВИ **не менее 25–30 дБ**, без признаков активного отосклероза (отомикроскопия, КТ с денситометрией) и общих противопоказаний.

Операция является паллиативной. В пользу её выполнения свидетельствует то, что в неоперированных ушах нейросенсорный компонент нарастает в большей степени, чем в оперированных.

Противопоказания

1. острый воспалительный процесс, обострение хронического;
2. декомпенсация сопутствующих заболеваний.

Относительные противопоказания

1. активный отосклероз;
2. единственное слышащее ухо;
3. расширенный водопровод преддверия по МСКТ: описаны случаи глухоты после операции.

> Пороговое значение КВИ для операции в КР приведено трижды и неодинаково: в показаниях к хирургическому лечению (раздел 3.2) не менее 30 дБ, в тексте рекомендации 25–30 дБ, в показаниях к госпитализации (раздел 6) не менее 25 дБ.

Основание стремени вскрывают двумя способами: стапедотомия (методика малого окна, поршневая) или стапедэктомия (методика большого окна, частичная или тотальная). Протезы изготавливаются из алло- и аутотканей и биосовместимых материалов (тефлон, керамика, пластипор, сталь, титан, платина); сухожилие стременной мышцы и наковальне-стременное сочленение сохраняются или не сохраняются, окно преддверия изолируется аутотканью (вена, жир, клетчатка, фасция) или не изолируется.

Наибольшее распространение в мире получила поршневая методика J. Shea (1962) ввиду минимальной травматичности для внутреннего уха и простоты выполнения; она обеспечивает КВИ не более 10 дБ у 58–98% пациентов.

Эффективны как стапедотомия, так и частичная стапедэктомия; при стапедэктомии сокращение КВИ в раннем послеоперационном периоде происходит быстрее. Сенсоневральная тугоухость после операции развивается у 3,5–5,9% пациентов, глухота у 0,9–2%.

Выбор методики учитывает

1. до операции: возраст, жалобы, анамнез, пороги КП и КВИ, строение височной кости по МСКТ;
2. во время операции: распространённость и активность очагов, строение ниши окна преддверия и канала лицевого нерва, кровоточивость тканей, давление перилимфы.

1. поршневая стапедопластика: молодой возраст (**до 40 лет**), активные очаги, узкая ниша окна преддверия, распространённые формы с крупными очагами на промонториуме, облитерирующие формы, выраженная кровоточивость;
2. аутотканевая стапедопластика: пожилой возраст, особенно при длительном снижении слуха; смешанные формы; расширенный водопровод улитки по МСКТ;
3. невозможна аутотканевая: протез на аутовенозный трансплантат.

4.4 Выбор методики стапедопластики

Критерий	Поршневая	Протез на аутовену	Аутоткани
Молодой возраст (до 40 лет)	+	+	–
Длительность заболевания более 10 лет	–	–	+
Смешанная форма II	–	+	+
Активный отосклероз	+	+	–
Облитерирующий отосклероз	+	–	–
Анатомически узкая ниша окна преддверия	+	+	–
Гидропс лабиринта по данным ЭКоГ	+	+	+
Расширенный водопровод улитки, дегисценция верхнего полукружного канала и гидропс по данным ЭКоГ (перилимфатический гидропс)	–	+	+
Расширенный водопровод преддверия и гидропс по данным ЭКоГ (эндолимфатический гидропс)	–	в КР не заполнено	–

Чем больше диаметр отверстия в основании стремени и протеза при качественном выполнении операции, тем лучше гидродинамика лабиринта: пороги КП снижаются на 10–20 дБ по всей тон-шкале. При поршневой методике такой эффект не наблюдается.

4.5 Доля пациентов с КВИ не более 10 дБ после операции

Методика	10–12 дней	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
Аутотканевая	38%	78%	96%	96%	100%
Поршневая	20%	50%	56%	78%	76%

4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование

Кохлеарная имплантация взрослым с отосклерозом.

Показания

1. кохлеарная форма или высокие пороги после стапедопластики с двусторонней тугоухостью 4–5 степени;
2. разборчивость простых односложных слов со слуховыми аппаратами на оба уха **менее 30%**;
3. нет патологии улитки по МСКТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ);
4. достаточная мотивация.

Слуховые аппараты при недостаточном уровне слуха и разборчивости речи

1. после операции;
2. кохлеарная форма;
3. общие противопоказания к операции;
4. отказ от операции.

Уровень слуха ниже социального: пороги КП **более 30 дБ** или ВП **более 45 дБ** на речевых частотах.

При слухопротезировании учитывают

1. феномен ускоренного нарастания громкости (после операции и вне связи с ней);
2. желание пациента;
3. единственное слышащее ухо;
4. противопоказания к операции и отказ от неё.

---

5. Медицинская реабилитация. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Слухопротезирование при уровне слуха ниже социального (пороги КП **более 30 дБ** или ВП **45 дБ и более** на речевых частотах):

1. после операции, в том числе на единственном слышащем ухе;
2. при противопоказаниях к операции или отказе от неё;
3. при кохлеарной форме.

Методы профилактики отосклероза и диспансерного наблюдения в КР не приведены.

Первичный осмотр пациента выполняют оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

5.1 Показания к госпитализации

Показания к плановой госпитализации для операции

1. жалобы на снижение слуха и шум;
2. кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ **не менее 25 дБ**;
3. нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ;
4. нет перфорации барабанной перепонки, инфекции слухового прохода, общих противопоказаний;
5. выполнено обследование для госпитализации.

Выписка **на 7–10-й день** после контрольной тональной аудиометрии:

1. пороги КП на дооперационном уровне;
2. КВИ в зависимости от методики прежний или сократился за счёт улучшения порогов ВП.

После операции

1. постельный режим **1–2 суток** на противоположном ухе (в зависимости от методики);
2. **месяц**: беречь ухо от воды и громких звуков;
3. **3 месяца**: не летать на самолёте.

В информации для пациента указано, что операция даёт положительный результат у девяти из десяти пациентов и неэффективна менее чем у 1%.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Отосклероз»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «Пересмотр не позднее: 2026», следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	315_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В алгоритме действий врача (приложение Б) инактивирующая терапия стоит на ветви «Нет» вопроса «Есть кохлеарный отосклероз?», тогда как в разделе 3.1 она рекомендована именно при кохлеарной форме.
- Пороговое значение КВИ для стапедопластики указано трижды и неодинаково: 30 дБ (показания, раздел 3.2), 25–30 дБ (рекомендация), 25 дБ (показания к госпитализации, раздел 6).
- В классификации Преображенского–Патякиной границы смешанной формы II («>30 дБ») и кохлеарной формы («>50 дБ») пересекаются, для тимпанальной формы («до 20») не указана единица измерения; в таблице приложения А3 для смешанной формы указано «до 50 дБ».
- Пороги ультразвука в таблице приложения А3 приведены в ваттах, в тексте раздела 2.4 в децибелах.
- В тексте для отосклероза указана тимпанограмма типа «А» или «As», в таблице приложения А3 только тип А.
- В критериях диагноза для смешанной формы указано «признаки характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм», вероятно, вместо «кохлеарной».
- Плотность активных очагов по данным МСКТ в тексте и в подписях к рисункам 1 и 3 не совпадает.
- Число курсов инактивирующей терапии указано только для очагов до +900 HU, хотя активными считаются очаги плотностью ниже 1000 HU.

Клинические рекомендации

Паратонзиллярный абсцесс

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J36** — Перитонзиллярный абсцесс **J39.0** — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс **J39.1** — Другой абсцесс глотки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Лечение в стационаре у оториноларинголога; основной метод: хирургическое вскрытие абсцесса.
- Передневерхний абсцесс: более 70% случаев, между капсулой нёбной миндалины и верхней частью передней нёбной дужки.
- Антибиотики широкого спектра, активные в отношении анаэробов, эмпирически, до результатов посева; курс **10–14 дней**.
- Абсцесстонзиллэктомия (миндалины удаляют одновременно со вскрытием):
  1. частые ангины в анамнезе;
  2. повторный паратонзиллит или абсцесс;
  3. затяжное течение;
  4. неадекватное дренирование;
  5. кровотечение после вскрытия.
- Если выполнено только вскрытие: двусторонняя тонзиллэктомия в плановом порядке **через 3 месяца**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Паратонзиллярный абсцесс характеризуется гнойным расплавлением паратонзиллярной клетчатки, расположенной между псевдокапсулой нёбной миндалины и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

2.2 Этиология

Пути инфицирования

1. осложнение ангины (большинство случаев);
2. хронический тонзиллит;
3. одонтогенный: кариес задних зубов нижней челюсти (вторые моляры, зубы мудрости), периостит альвеолярного отростка;
4. инородное тело в паратонзиллярной клетчатке (например, рыбная кость).

Наиболее частыми возбудителями являются бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробные микроорганизмы.

На момент обращения отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная форма выявляется у 15–20% пациентов, абсцедирующая форма у 80–85%. Абсцесс формируется, как правило, через 4–6 дней от начала заболевания, в ряде случаев в течение нескольких часов.

2.3 Локализация

1. передневерхний (супратонзиллярный): более 70%; между капсулой миндалины и верхней частью передней нёбной дужки;
2. задний: около 15%; между миндалиной и задней нёбной дужкой;
3. нижний: несколько более 5%; между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки;
4. боковой: менее 5%; между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

2.4 Клиническая картина

Абсцесс развивается, как правило, на фоне ангины или через несколько дней после неё.

1. боль при глотании, становится постоянной, резко усиливается при глотании слюны, иррадиирует в ухо и зубы;
2. головная боль, разбитость, лихорадка до фебрильных значений;
3. отказ от пищи и питья;
4. нарастающий тризм жевательной мускулатуры;
5. невнятная, гнусавая речь;
6. вынужденное положение головы набок, поворот всем корпусом.

Передневерхний абсцесс:

1. резкое выбухание верхнего полюса миндалины вместе с нёбными дужками и мягким нёбом к средней линии;
2. язычок смещён в противоположную сторону;
3. миндалина оттеснена книзу и кзади.

Задний абсцесс:

1. припухлость в области задней нёбной дужки, возможен переход на боковую стенку глотки;
2. миндалина и передняя дужка изменены незначительно;
3. отёк язычка и мягкого нёба.

Нижний абсцесс:

1. при фарингоскопии лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки при выраженных жалобах;
2. возможно вовлечение корня языка, отёк язычной поверхности надгортанника;
3. распространение отёка на гортань может привести к её стенозу.

Боковой абсцесс: встречается реже других, но протекает тяжелее всех (условия для самопроизвольного прорыва гноя в глотку наименее благоприятны).

1. отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения;
2. кривошея;
3. тризм;
4. при фарингоскопии лишь умеренное выбухание всей миндалины.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. недавно перенесённые ангины;
2. хронический тонзиллит;
3. паратонзиллиты и абсцессы в прошлом и их лечение;
4. кариес;
5. возможное попадание инородного тела (рыбная кость).

Местные жалобы

1. выраженная, как правило односторонняя боль в горле, усиливающаяся при глотании, с иррадиацией в ухо и зубы;
2. ощущение инородного тела;
3. гнусавость;
4. неприятный запах изо рта;
5. боль в шее при поворотах головы;
6. тризм;
7. слюнотечение.

Общие жалобы (неспецифичны)

1. слабость, разбитость;
2. фебрильная лихорадка;
3. головная боль.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании:

1. анамнеза;
2. физикального обследования с оценкой подчелюстной области и регионарных лимфатических узлов;
3. фарингоскопии;
4. лабораторных исследований.

3.1 Осмотр и фарингоскопия

Показания

1. каждый пациент с подозрением на паратонзиллярный абсцесс: осмотр оториноларинголога.

Диагностические признаки (наиболее выражены при переднем абсцессе)

1. яркая гиперемия, отёк и инфильтрация нёбных дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка;
2. асимметрия мягкого нёба;
3. смещение миндалины;
4. ограничение открывания рта;
5. регионарный лимфаденит.

Показания

1. все дети и взрослые; данные фарингоскопии решающие для диагноза.

3.2 Ларингоскопия

Показания

1. подозрение на распространение воспаления на гортаноглотку: непрямая ларингоскопия или фиброларингоскопия.

3.3 КТ и УЗИ шеи

Показания к КТ и УЗИ шеи

1. тяжёлые случаи: уточнение диагноза и локализации абсцесса;
2. дифференциальная диагностика с воспалением глубоких отделов шеи.

3.4 Анализы крови и мочи, посев

Показания

1. все пациенты: развёрнутый общий анализ крови, С-реактивный белок (СРБ), общий анализ мочи.

Диагностические признаки

1. выраженный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и высокий СРБ: высокий риск осложнений, нужна коррекция лечения, в том числе антибактериальной терапии.

Показания

1. гнойное отделяемое после вскрытия: посев на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности;
2. мазок с миндалин на палочку дифтерии: исключение дифтерии.

Для исследования предпочтительно брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости, поскольку ферменты гноя разрушают микроорганизмы. Материал доставляется в лабораторию в транспортной среде, оптимально **в течение 40 минут**.

3.5 Дифференциальная диагностика

Дифференцируют также с абсцессами подъязычной области и перикоронитом.

Заболевание	Отличия от паратонзиллярного абсцесса
Дифтерия	1. слизистая бледная, с цианотичным оттенком (отёк); 2. налёты сероватые, выходят за пределы миндалин; 3. тризма нет.
Скарлатина	1. розеолёзная сыпь на коже; 2. чёткая граница поражённой и интактной слизистой; 3. «малиновый» язык.
Абсцесс язычной миндалины	1. нет тризма; 2. нет характерных изменений в ротоглотке.
Флегмона дна полости рта	1. боль, отёк и инфильтрация в подчелюстной области; 2. движения языка ограничены; 3. нёбные дужки и миндалины не изменены.
Опухоли миндалины: рак, лимфосаркома, лимфоэпителиома	1. медленное развитие; 2. нет лихорадки, сильной боли в горле и тризма; 3. регионарные лимфатические узлы плотные, малоболезненные, малоподвижные.
Поверхностное расположение сонной артерии или её аневризма (редко)	1. визуально определяемая пульсация.

---

4. Лечение

Лечение осуществляет оториноларинголог в специализированном учреждении; основным методом лечения является хирургическая санация полости абсцесса.

4.1 Хирургическое лечение

Впервые возникший абсцесс: вскрытие и дренирование.

Правила (при любой технике)

1. убедиться в отсутствии пульсации в месте разреза;
2. глубже **0,5 см** продвигаться только тупым путём;
3. разрез достаточно широкий, **до 4 см**.

Местная аппликационная анестезия; место разреза по локализации:

1. передневерхний: через переднюю нёбную дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания;
2. задний: через заднюю дужку, отступив 0,5 см от её края;
3. нижний: в нижней части передней дужки.

Ткани рассекают вдоль хода сосудов на глубину 0,5–1 см, далее разводят корнцангом.

В последующем края разреза регулярно разводятся до начала заживления полости.

Абсцесстонзиллэктомия (удаление нёбных миндалин одновременно со вскрытием) устраняет и сам очаг инфекции. Показания:

1. частые ангины в анамнезе;
2. повторный паратонзиллит или абсцесс;
3. затяжное течение;
4. неадекватное дренирование;
5. кровотечение после вскрытия.

Возраст: **от 3–4 до 70 лет и старше**.

Противопоказания

1. терминальное или крайне тяжёлое состояние вследствие заболеваний внутренних органов;
2. тромбоз сосудов мозга;
3. разлитой менингит.

После операции осматривают тонзиллярную нишу; выбухание в ней свидетельствует о парафарингеальном абсцессе.

4.2 Антибактериальная терапия

1. начинают эмпирически, не дожидаясь результатов посева;
2. в полости абсцесса, как правило, анаэробы: нужны препараты широкого спектра, активные и в отношении анаэробов.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	С 12 лет или при массе тела от 40 кг — 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки. Возможно применение #амоксициллина с сульбактамом по 1 г 2–3 раза в сутки с 12 лет, до 10 дней. Детям до 12 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Цефтриаксон	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки; длительность в таблице рекомендации указана как «в течение 4–14 дней до 10 дней». Новорождённым до 2 недель — 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не более 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки.
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 1 г 2 раза в сутки, до 10 дней. Новорождённым и детям до 12 лет — 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; недоношенным — не более 50 мг/кг в сутки.

Препарат	Доза
Клиндамицин	300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении — до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма. Детям при непереносимости цефалоспоринов III поколения — #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

Курс **10–14 дней**.

1. препараты выбора: пенициллины, в том числе с ингибиторами бета-лактамаз;
2. затруднённое глотание: диспергируемые формы, суспензии, инъекции;
3. выраженный отёк тканей глотки и шеи, выраженный тризм, высокий риск генерализации: парентеральные цефалоспорины III поколения, при непереносимости клиндамицин;
4. дети: предпочтительны ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой.

4.3 Дополнительная терапия

При выраженных воспалительных проявлениях используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в стандартных дозах.

Всем пациентам рекомендованы антигистаминные препараты системного действия.

Рекомендацией предусмотрено также применение средств, повышающих естественную резистентность организма (препараты кальция, витамины С и А); при этом следует избегать полипрагмазии.

При выраженной интоксикации необходима инфузионная дезинтоксикационная терапия.

Всем пациентам дополнительно местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства; системную антибактериальную терапию они не заменяют.

Лекарственные формы местных средств

1. полоскания;
2. инсуффляции;
3. ингаляции;
4. таблетки для рассасывания.

После хирургического лечения, не ранее чем через 3 недели после купирования острого воспаления, показана консультация физиотерапевта.

4.4 Послеоперационное ведение

После вскрытия абсцесса: двусторонняя тонзиллэктомия в плановом порядке **через 3 месяца**.

После тонзиллэктомии ограничение физической нагрузки **в течение месяца**.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения

1. при диспансеризации выявляют факторы риска: хронический тонзиллит, рецидивирующие ангины;
2. закаливание;
3. своевременное лечение заболеваний зубов и дёсен.

Лечение в хирургическом стационаре.

Показания к госпитализации

1. вскрытие абсцесса;
2. удаление нёбных миндалин со вскрытием абсцесса.

После вскрытия улучшение **через 12–24 часа**; при неосложнённом течении после абсцесстонзиллэктомии выписка **на 5–7-е сутки**.

Осложнения при отсутствии или неадекватности лечения

1. флегмона шеи;
2. медиастинит;
3. тонзиллогенный сепсис;
4. инфекционно-токсический шок.

Риск выше при иммунодефиците: врождённом, на фоне иммуносупрессоров и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для цефтриаксона в таблице 1 указано «в течение 4-14 дней до 10 дней», что содержит противоречие в сроках; на странице формулировка приведена дословно.

Клинические рекомендации

Парезы и параличи гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J38.0** — Паралич голосовых складок и гортани
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 07.10.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/305_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Парез гортани: нарушение подвижности мышц гортани из-за нарушения иннервации **до 6 месяцев**; паралич — **более 6 месяцев**. Чаще всего — после операций на щитовидной железе.
- Диагноз ставят ларингоскопически: голосовая складка неподвижна или резко ограничена в подвижности. Для поиска причины — КТ шеи и грудной клетки, УЗИ гортани и шеи, эндокринолог и невролог.
- Одностороннее поражение: как можно раньше логопедическая коррекция голоса, у взрослых в ранние сроки — антихолинэстеразные препараты и витамины группы В; реконструктивная операция — **после 6 месяцев**. Двустороннее с декомпенсацией дыхания — трахеотомия или хордопексия.
- Срочная госпитализация — паралитический стеноз гортани в стадии субкомпенсации и декомпенсации; плановая — для операции.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

1. парез гортани: временное, **до 6 месяцев**, отсутствие или ограничение подвижности мышц гортани вследствие нарушения иннервации;
2. паралич гортани: длительное, **более 6 месяцев**, отсутствие подвижности мышц гортани.

2.2 Этиология

Односторонний паралич: причины

1. операции на щитовидной и околощитовидных железах — 72,4%;
2. операции при атеросклерозе сонных артерий, раке лёгкого, врождённых пороках сердца — 7,2%;
3. новообразования со сдавлением возвратного нерва: рак щитовидной железы, лёгкого, пищевода, метастазы в лимфоузлы средостения — 6,8%;
4. операции на шейном отделе позвоночника, травма, опухоли мозга, инсульт, демиелинизирующая нейропатия — 5,7%;
5. перенесённая ОРИ, туберкулёз лёгких — 4,5%;
6. причина не установлена (идиопатический) — 3,4%.

Двусторонний паралич: причины

1. хирургическая травма — 44%;
2. злокачественные новообразования — 17%;
3. эндотрахеальная интубация — 15%;
4. неврологические заболевания — 12%;
5. причина неизвестна — 12%.

Центральные параличи (10%): надъядерные (кортикальные, кортикобульбарные) и бульбарные — при нарушении мозгового кровообращения, опухолях, черепно-мозговой травме, менингоэнцефалите, полиомиелите, ДЦП, рассеянном склерозе, после операций на мозге. Функциональные центральные — при нервно-психических расстройствах, чаще при истерии.

Односторонний паралич у детей

1. новообразования — 29%;
2. послеоперационные осложнения — 24%;
3. воспалительные процессы — 21%;
4. постинтубационная и наружная травма — 8%;
5. центральные — 5%, идиопатические — 13%.

Повреждение возвратного нерва при кардиохирургии — до 4%; закрытие артериального (боталлова) протока у новорождённых массой **менее 1000 г** часто даёт паралич левого возвратного нерва: стридор, осиплость, трудности кормления, аспирация.

2.3 Классификация

1. по уровню поражения блуждающего нерва: центральные, периферические;
2. по этиологии: врождённые, приобретённые;
3. по распространённости: односторонние, двусторонние.

2.4 Клиническая картина

Страдают все функции гортани: разделительная (защитная), голосовая (охриплость), дыхательная (стеноз или гипервентиляция). Картина зависит прежде всего от положения парализованной складки.

Положение складки у взрослых

1. срединное;
2. парамедианное: 2 мм от срединной линии;
3. интермедианное: 4 мм;
4. латеральное: максимальное отведение на глубоком вдохе.

Проявления по положению голосовых складок

Поражение	Положение складки	Проявления
Одностороннее	медианное, парамедианное	дисфония небольшая; одышка только при нагрузке или избыточной массе; дисфагии нет
Одностороннее	интермедианное, латеральное	дисфония вплоть до афонии; одышки при нагрузке нет, но гипервентиляция; трудно откашляться, поперхивание; латеральное — при полном поражении блуждающего нерва
Двустороннее	латеральное	нарушение разделительной функции, афония, невозможность откашляться, гипервентиляция (головокружение при нагрузке и разговоре)
Двустороннее	интермедианное, парамедианное, медианное	на первый план — дыхательная недостаточность; голос может быть звучным, разделительная функция сохранена

Стадии паралитического стеноза гортани

Стадия стеноза	Голосовая щель у взрослых	Признаки
Компенсация	6–8 мм	одышки в покое нет, появляется при ходьбе
Субкомпенсация	3–4 мм	инспираторная одышка, при нагрузке — вспомогательные мышцы, втяжение межрёберий и ямок, стридор, бледность; давление нормальное или повышено

Стадия стеноза	Голосовая щель у взрослых	Признаки
Декомпенсация	2–3 мм	частое поверхностное дыхание, резкий стридор, вынужденное положение сидя, бледно-синюшное лицо, потливость, акроцианоз, нитевидный пульс, давление снижено
Асфиксия	1 мм	дыхание Чейна — Стокса или остановка, угнетение сердечной деятельности, потеря сознания, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца

Неплотное смыкание складок и ротация черпаловидного хряща ведут к аспирации (поперхиванию); одышка усиливается при голосовой нагрузке.

Последствия аспирации

1. ларингит;
2. трахеит;
3. аспирационная пневмония.

На состояние влияют

1. сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания;
2. эндокринные: гипотиреоз, гипопаратиреоз;
3. деформация шейного и грудного отделов позвоночника.

---

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. анамнез: травма или операция на шее, органах средостения, шейном отделе позвоночника, головном мозге; инфекционные заболевания;
2. жалобы: дисфония, афония, дисфагия, одышка;
3. осмотр и пальпация гортани, оценка дыхания, признаки стеноза;
4. непрямая ларингоскопия, фиброларингоскопия, видеоларингоскопия, микроларингоскопия.

3.1 Жалобы и анамнез

Типичные жалобы

1. одностороннее поражение: утомляемость голоса, придыхание, одышка при нагрузке, аспирация жидкостью; возможна дисфагия;
2. двустороннее: нарушение дыхания, инспираторный стридор при нагрузке, во сне, при разговоре.

Ларингоспазм может быть следствием синкинезии — неправильной реиннервации, когда на вдохе сокращаются суживающие мышцы; а также рефлюкса, гипокальциемии, аллергии, неврологических и психических расстройств.

Дыхательные нарушения при истерии: шумное стридорозное дыхание днём при посторонних, свободнее, когда пациент отвлекается, во сне — спокойное. Трахеотомия противопоказана, лечение — в психоневрологическом стационаре.

У детей

1. односторонний паралич: осиплость — 100% (в первый месяц может быть афония), затем аспирация при кормлении, стридор — около 36%;
2. двусторонний: инспираторный или двухфазный высокотональный стридор — 100%, усиливается при нагрузке, в 30% исчезает во сне; стеноз I–III степени.

3.2 Осмотр

Показания

1. все с подозрением на паралич гортани: осмотр оториноларинголога, пальпация шеи и регионарных лимфоузлов — воспаление, опухоль, травма.

Степени дыхательной недостаточности

1. I степень: одышка при умеренной нагрузке;
2. II: при малой нагрузке;
3. III: в покое.

Оценивают также рубцы на шее (сращение кожи с трахеей нарушает подвижность гортани) и неврологические признаки: асимметрию нёба, языка, фасцикуляции языка.

Подозрение на острое воспаление ЛОР-органов: развёрнутый общий анализ крови.

3.3 Ларингоскопия

Показания

1. все с подозрением на парез или паралич: эндоскопическая ларингоскопия — микроларингоскопия, стробоскопия, видео- и фиброларингоскопия.

Непрямая ларингоскопия обязательна с **12 лет**; у дошкольников и младших школьников — видеофиброларингоскопия или фиброларингоскопия («золотой стандарт» у детей).

Диагностические признаки

1. неподвижность или резкое ограничение подвижности одной или обеих складок, черпаловидный хрящ ограниченно подвижен или неподвижен;
2. при фонации щель между складками: овальная, линейная, треугольная; здоровая складка может заходить за среднюю линию;
3. парализованная складка укорочена, атрофична: вогнутый серповидный край, истончение, выступающий голосовой отросток, складка ниже здоровой;
4. черпаловидный хрящ наклонён вперёд, ротирован медиально.

Дифференцируют

1. перихондрит (артрит) перстнечерпаловидного сустава: отёк, инфильтрация, гиперемия;
2. анкилоз: хрящ полностью неподвижен;
3. вывих: асимметрия суставов, воспаление, нетипичное положение хряща;
4. новообразования, ведущие к неподвижности складки.

Гипертрофия вестибулярных складок — компенсаторная, операции не требует.

У плачущего ребёнка складки сомкнуты, что имитирует двусторонний паралич: дождаться адекватного вдоха с разведением складок, которого при двустороннем параличе не будет.

3.4 КТ, рентгенография, УЗИ

Показания

1. все пациенты с парезом или параличом: КТ верхних дыхательных путей и шеи; если КТ недоступна — рентгенография гортани или шейного отдела позвоночника в двух проекциях;
2. подозрение на новообразование: КТ с контрастированием.

КТ верхних дыхательных путей и шеи с контрастным усилением — при подозрении на новообразование.

Всем: КТ органов грудной полости — поиск объёмных образований.

Всем: УЗИ гортани и лимфатических узлов шеи — поиск объёмных образований.

Эндокринолог и невролог — поиск причины и выбор лечения; при подозрении на другие причины — пульмонолог, гастроэнтеролог, онколог.

---

4. Лечение

4.1 Медикаментозное лечение

Лечение основного заболевания в сочетании с антихолинэстеразными препаратами, стимулирующими нервно-мышечную передачу. Детям **до 18 лет** препараты противопоказаны.

Взрослые

1. #неостигмина метилсульфат в ранние сроки: внутрь 0,015 г 2 раза в день или 1 мл 0,05% раствора подкожно 1–2 раза в день, 2 недели;
2. #ипидакрин при одностороннем параличе: в/м 1 мл (15 мг) 1 раз в день 10 дней, затем 20 мг внутрь 3 раза в день (в КР «45 дней месяца»).

#Ипидакрин у взрослых с односторонним параличом — для восстановления подвижности парализованной складки.

Взрослые в ранние сроки: витамин B1 в комбинации с B6 и (или) B12. Учитывать противопоказания при онкологических заболеваниях; детям **до 18 лет** не назначают.

4.2 Логопедическая коррекция и физиотерапия

Показания

1. взрослые и дети с односторонним параличом: индивидуальная программа логопеда в самые ранние сроки — до окончания обследования и медикаментозного лечения.

Здоровая складка компенсаторно заходит за среднюю линию и смыкается с неподвижной. Три этапа; на каждом — дыхание, тонус и подвижность гортани, высота, сила и тембр голоса. Начинают при отсутствии боли в ране и острого воспаления.

Программа логопедической реабилитации — всем пациентам с параличом гортани, в том числе после операции.

Всем: консультация физиотерапевта — улучшение трофики и нервно-мышечной передачи.

4.3 Хирургическое лечение у взрослых

Операции у взрослых

Ситуация	Операция
двусторонний паралич, декомпенсация дыхания	трахеотомия
двусторонний паралич, декомпенсация, до 6 месяцев от поражения	временная хордопексия (латерофиксация складки)
двусторонний паралич, более 6 месяцев	двусторонняя хордопексия

Ситуация	Операция
двусторонний паралич, дыхание через естественные пути невозможно, консервативное лечение неэффективно более 6 месяцев	микроэндоларингеальная резекция с эндоскопическими и лазерными технологиями, пластика гортани
двусторонний и односторонний паралич	реиннервация и функциональная пластика гортани и трахеи микрохирургически
односторонний паралич, более 6 месяцев	эндоларингеальное реконструктивное вмешательство на складках с имплантами — восстановление голоса

Пластика и резекция гортани не показаны при двустороннем параличе из-за неоперабельных опухолей щитовидной железы, лёгких, пищевода, метастазов в средостение: при декомпенсации — трахеотомия.

4.4 Хирургическое лечение у детей

Операции у детей

Ситуация	Операция
врождённый и приобретённый двусторонний паралич, декомпенсация дыхания	трахеотомия
дети старше 4 лет, двусторонний паралич, субкомпенсация, трахеостомы нет	хордаритеноидотомия эндоскопически
дети старше 4 лет, приобретённый двусторонний паралич, есть трахеостома	хордаритеноидотомия и контрлатеральная **через 6 месяцев** — для деканюляции
дети старше 4 лет, приобретённый двусторонний паралич, есть трахеостома	пластика гортани с рёберным аутотрансплантатом в заднюю стенку
дети старше 5 лет, врождённый двусторонний паралич без признаков восстановления, есть трахеостома	пластика гортани с рёберным аутотрансплантатом в заднюю стенку
дети старшего возраста, двусторонний и односторонний паралич	реиннервация и функциональная пластика

Двусторонний паралич, дети **старше 4 лет** с трахеостомой: пластика гортани с рёберным аутотрансплантатом в заднюю стенку — расширение голосового отдела.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания

1. срочная: острый и хронический паралитический стеноз гортани в стадии субкомпенсации и декомпенсации;
2. плановая: хирургическое лечение одно- или двустороннего паралича.

Выписка

1. после срочной госпитализации: восстановлено дыхание, нет дыхательной недостаточности;
2. после операции при двустороннем параличе: улучшено дыхание через естественные пути, стихли послеоперационные явления;
3. при одностороннем: улучшен голос.

5.2 Реабилитация и наблюдение

Реабилитация — логопед, физиотерапия — с первого обращения, при параличе после операции или инсульта **не позднее 72 часов** после диагноза, по возможности с мультидисциплинарной командой; амбулаторно или в дневном стационаре фониатрического центра.

Диспансерный осмотр оториноларинголога (фониатра) с ларингоскопией **раз в 3 или 6 месяцев** — в зависимости от дыхательной недостаточности.

5.3 Редкие синдромы с парезом гортани

Редкие синдромы

Синдром	Поражение и проявления
Тапиа	двойное ядро (IX, X), ядра XI, XII и пирамидные пути: парез глотки, мягкого нёба, гортани, грудино-ключично-сосцевидной мышцы, языка, контралатеральный гемипарез; осложнение масочной вентиляции, интубации, бронхоскопии
Коле — Сикара	IX–XII нервы: охриплость, дисфагия, боль в глотке, нарушение вкуса задней трети языка; опухоли яремного отверстия, травма, аневризма, метастазы
Вернета	IX–XI: паралич нёба, гортани, глотки, грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц; огнестрельные ранения, переломы основания черепа, тромбоз яремной вены
Вилларе	IX–XII, симпатический нерв, волокна VII: дисфагия на твёрдую пищу, паралич нёба и гортани с одной стороны
Авеллиса	IX–XII: дисфагия, дисфония, дизартрия, гемигипестезия противоположных конечностей, опущение плеча

Односторонний паралич гортани может сопровождать боковой амиотрофический склероз, невралгическую амиотрофию (синдром Персонейджа — Тернера), множественную системную атрофию, травмы, опухоли, инсульт.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Парезы и параличи гортани»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 07.10.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2029 года
Код в рубрикаторе	305_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность приёма #ипидакрина в таблетках записана как «45 дней месяца» — неясно, 45 дней или иной срок. Сверяйте с инструкцией препарата.

Клинические рекомендации

Первичные иммунодефициты с недостаточностью синтеза антител

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D80.0** — Наследственная гипогаммаглобулинемия **D80.1** — Несемейная гипогаммаглобулинемия **D80.2** — Избирательный дефицит иммуноглобулина A [IgA] **D80.3** — Избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G [IgG] **D80.4** — Избирательный дефицит иммуноглобулина M [IgM] **D80.5** — Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M [IgM] **D80.6** — Недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуно глобулинов или с гипериммуноглобулинемией **D80.7** — Преходящая гипогаммаглобулинемия детей **D80.8** — Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител **D80.9** — Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный **D83.0** — Общий вариабельный иммунодефицит с преобладающими отклонениями в количестве и функциональной активности B-клеток **D83.1** — Общий вариабельный иммунодефицит с преобладанием нарушений иммунорегуляторных T-клеток **D83.2** — Общий вариабельный иммунодефицит с аутоантителами к B- или T-клеткам **D83.8** — Другие общие вариабельные иммунодефициты **D83.9** — Общий вариабельный иммунодефицит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.05.2022, пересмотр не позднее 2024 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/735_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Первичные иммунодефициты (ПИД) с преимущественной недостаточностью синтеза антител — генетически обусловленные заболевания с нарушением образования антител в ответ на инфекцию или вакцинацию; самая частая группа ПИД.
- Общий признак — рецидивирующие инфекции синопульмонального тракта (синуситы, отиты, бронхиты, пневмонии), торпидные к стандартной антибиотикотерапии, с повышенной восприимчивостью к инкапсулированным бактериям.
- Тяжёлые хронические или рецидивирующие синуситы и отиты, торпидные к лечению, — повод для скрининга на ПИД: определение IgA, IgG, IgM в крови и консультация аллерголога-иммунолога.
- Гипогаммаглобулинемия — IgG ниже 2 стандартных отклонений от возрастной нормы у детей и **ниже 4,5 г/л** у взрослых; измерение подтверждают минимум двумя исследованиями.
- При агаммаглобулинемии, общей вариабельной иммунной недостаточности (ОВИН) и гипер-IgM-синдроме сразу после диагноза начинают пожизненную заместительную терапию иммуноглобулином человека нормальным; целевой претрансфузионный IgG — **не ниже 7 г/л**.
- При ОВИН, агаммаглобулинемии и гипер-IgM-синдроме живые вакцины не рекомендуются.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Первичные иммунодефициты (ПИД) — группа врождённых заболеваний иммунной системы, насчитывающая более 450 нозологий, связанных с утратой, уменьшением или неправильным функционированием одного или нескольких её звеньев.

Гипогаммаглобулинемия — снижение уровня IgG в крови ниже 2 стандартных отклонений от возрастной нормы у детей и ниже 4,5 г/л у взрослых.

Агаммаглобулинемия — снижение уровня IgG ниже 1,0 г/л в сочетании с IgM ниже 0,2 г/л и IgA ниже 0,1 г/л при уровне периферических CD19+ B-клеток ниже 2%.

Претрансфузионный уровень IgG — уровень IgG, исследованный в день перед введением иммуноглобулина человека нормального (наиболее низкий его показатель в течение месяца).

ПИД с преимущественным нарушением синтеза антител — генетически детерминированные заболевания с нарушением антителообразования в ответ на инфекцию или вакцинацию: от снижения всех классов иммуноглобулинов и отсутствия B-лимфоцитов до селективного дефицита антител.

Основные формы

1. общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН);
2. X-сцепленная агаммаглобулинемия (болезнь Брутона) и аутосомно-рецессивные агаммаглобулинемии;
3. селективный дефицит IgA;
4. дефицит подклассов IgG;
5. нарушение синтеза специфических антител;
6. транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия.

2.2 Этиология и эпидемиология

В основе лежит нарушение дифференцировки В-лимфоцитов в костном мозге или в периферических лимфоидных органах. Около 90% наследственных агаммаглобулинемий составляет болезнь Брутона (ген Btk на Х-хромосоме), поэтому болеют лица мужского пола. Генетическую основу ОВИН в большинстве случаев установить не удаётся.

ПИД с нарушением синтеза антител составляют более 50% всех ПИД. Распространённость ОВИН — от 1:10 000 до 1:50 000, агаммаглобулинемии — от 1:100 000 до 1:200 000, селективного дефицита IgA — от 1:142 до 1:18 000 (у большинства бессимптомно).

2.3 Клиническая картина

Объединяющий признак — рецидивирующие инфекции преимущественно синопульмонального тракта с повышенной восприимчивостью к инкапсулированным бактериям. Характерна торпидность к стандартным схемам антибиотикотерапии при отсутствии предрасполагающих факторов.

Тяжёлые повторные инфекции приводят к бронхоэктазам и пневмосклерозу. На втором месте после синопульмональных — инфекционные поражения ЖКТ.

Х-сцепленная агаммаглобулинемия (болезнь Брутона)

1. дебют, как правило, **от 6 месяцев до 1 года** — после истощения материнских антител;
2. гипоплазия миндалин и лимфатических узлов;
3. хронические синуситы с частыми обострениями;
4. бронхоэктазы после повторных пневмоний;
5. нейросенсорная тугоухость как следствие перенесённых гнойных средних отитов;
6. деформации суставов после артритов, нейтропения в дебюте, отставание в физическом развитии.

Общая вариабельная иммунная недостаточность

1. два пика дебюта: 2–5 лет и 18–25 лет;
2. инфекции, сходные с болезнью Брутона;
3. лимфопролиферация: лимфаденопатия (около 40%), спленомегалия (до 60%), гепатомегалия (до 15%).

Одно из самых тяжёлых неинфекционных осложнений ОВИН — интерстициальная болезнь лёгких; характерны неказеозные саркоидоподобные гранулёмы в лёгких, лимфоузлах, селезёнке.

Другие неинфекционные проявления ОВИН

1. поражение ЖКТ: диарея более чем у 20%, мальабсорбция; целиакия- и кроно-подобное поражение, НЯК, нодулярная лимфоидная гиперплазия;
2. иммунные цитопении (10–29%), нередко первый симптом;
3. повышенный риск злокачественных новообразований, особенно неходжкинских лимфом.

Селективный дефицит IgA у двух третей пациентов протекает бессимптомно; при симптомах характерны не столько тяжёлые, сколько частые инфекции, а также заболевания ЖКТ, аутоиммунные и аллергические болезни. Тяжелее течёт сочетание с дефицитом подклассов IgG.

При дефиците подклассов IgG и специфических антител более характерны синуситы, отиты, бронхиты; пневмонии и менингиты встречаются реже, отмечается склонность к аллергическим заболеваниям.

Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия — удлинение физиологического периода гипогаммаглобулинемии (обычно **до 3–6 месяцев**); может протекать бессимптомно или с частыми инфекциями верхних и нижних дыхательных путей.

Дифференциальная диагностика с саркоидозом по КТ: при ОВИН чаще поражаются нижние доли, узелки крупные, расположены хаотично, характерны бронхоэктазы; при саркоидозе узелки мелкие, перилимфатические, с лимфаденопатией корней лёгких, бронхоэктазов, как правило, нет.

3. Диагностика

3.1 Диагностические критерии ESID

Диагностические критерии ESID форм ПИД с недостаточностью синтеза антител

Форма ПИД	Критерии
ОВИН	1. ≥1 признак: подверженность инфекциям, аутоиммунные проявления, гранулёмы, необъяснимая лимфопролиферация, ПИД у членов семьи; 2. выраженное снижение IgG (в 2 исследованиях на 2 SD от возрастной нормы, у взрослых менее 4,5 г/л) и IgA, с IgM или без; 3. неадекватный ответ на вакцинацию (или отсутствие изогемагглютининов) либо переключённых В-клеток памяти менее 70% от возрастной нормы; 4. вторичная гипогаммаглобулинемия исключена; 5. возраст старше 4 лет; 6. нет глубокого нарушения Т-клеточного звена.
Х-сцепленная агаммаглобулинемия	1. окончательный диагноз: мужчина с CD19+ В-клетками менее 2% и мутацией в гене Btk (или отсутствием мРНК либо экспрессии Btk, или родственниками по материнской линии с CD19+ менее 2%); 2. вероятный: CD19+ менее 2% и все признаки — инфекции до 5 лет, снижение IgG, IgM, IgA более чем на 2 SD, нет изогемагглютининов или плохой ответ на вакцинацию, исключены другие причины; 3. возможный: CD19+ менее 2%, исключены другие причины и хотя бы один из этих признаков.
Гипер-IgM-синдром	1. ≥1 признак: подверженность инфекциям, иммунная дисрегуляция, цитопении, лимфома, ПИД у членов семьи; 2. выраженное снижение IgG при нормальном или повышенном IgM (в 2 исследованиях); 3. исключены другие причины и глубокое нарушение Т-клеточного звена, нет данных за атаксию-телеангиэктазию.
Нарушение синтеза специфических антител	рецидивирующие и тяжёлые бактериальные инфекции; IgG, IgA, IgM и подклассы IgG в норме; глубокое нарушение синтеза антител после полисахаридной вакцины или документированной инфекции; Т-клеточный дефект исключён
Дефицит подклассов IgG	рецидивирующие и тяжёлые бактериальные инфекции; IgA, IgG, IgM в норме; снижение одного или нескольких подклассов IgG при двукратном измерении; поствакцинальный ответ сохранён; Т-клеточный дефект исключён
Дефицит IgA с дефицитом подклассов IgG	рецидивирующие и тяжёлые бактериальные инфекции; IgA отсутствует, IgG и IgM в норме или слегка снижены; снижение подклассов IgG при двукратном измерении; поствакцинальный ответ сохранён; Т-клеточный дефект исключён
Селективный дефицит IgA	подверженность инфекциям, аутоиммунные проявления или ПИД у членов семьи; возраст старше 4 лет; IgA менее 0,07 г/л при нормальных IgG и IgM; вторичный генез и Т-клеточный дефект исключены; поствакцинальный ответ сохранён
Транзиторная гипогаммаглобулинемия	IgG ниже возрастной нормы в первые 3 года жизни (двукратно), другие причины исключены, спонтанное разрешение примерно после 4 лет; до разрешения ребёнка регистрируют как неклассифицируемый ПИД

Всем пациентам с подозрением на ПИД проводят дифференциальную диагностику с другими формами ПИД.

При снижении иммуноглобулинов исключают вторичную гипогаммаглобулинемию: она встречается в 30 раз чаще, чем ПИД, не всегда сопровождается тяжёлыми инфекциями и часто транзиторна.

У всех пациентов с гипогаммаглобулинемией исключают другие заболевания и состояния, способные привести к неконтролируемому инфекционному процессу.

3.2 Жалобы и анамнез

Показания к скринингу на ПИД

1. отягощённый семейный анамнез по иммунологическим заболеваниям;
2. тяжёлые хронические или рецидивирующие инфекции, торпидные к стандартной терапии: синуситы, отиты, бронхиты, пневмонии, артриты, кишечные инфекции, менингиты, сепсис, кожные инфекции;
3. стойкий диарейный синдром, в том числе с мальабсорбцией;
4. патологическая лимфопролиферация: стойкая лимфаденопатия, спленомегалия, лимфоцитарная инфильтрация органов;
5. аутоиммунные проявления, прежде всего цитопении;
6. гранулематозное воспаление, прежде всего саркоидоподобные изменения в лёгких;
7. бронхоэктазы, особенно у молодых;
8. злокачественные новообразования лимфоидной ткани.

Особую настороженность вызывают пациенты с несколькими из этих симптомов.

Тщательно собирают семейный анамнез: смерть родственника в младенчестве или от инфекции, родственники с хроническими или атипичными инфекциями, цитопениями. При Х-сцепленной агаммаглобулинемии семейный анамнез прослеживается почти у половины пациентов.

3.3 Общий осмотр и пальпация

Всем пациентам с подозрением на ПИД проводится полный физикальный осмотр.

На что обратить внимание

1. отставание в физическом развитии, снижение массы тела при энтеропатии;
2. лимфаденопатия (ОВИН) или гипоплазия лимфоузлов без регионарного увеличения при активной инфекции (агаммаглобулинемия);
3. гепато- и спленомегалия;
4. гипопротеинемические отёки;
5. «барабанные палочки», «часовые стёкла», деформация грудной клетки и суставов;
6. кожные сыпи, фурункулы, абсцессы, рубцы.

3.4 Иммуноглобулины A, G, M и белковые фракции

Общий белок и белковые фракции (электрофорез) — для выявления изменения гамма-глобулинов.

Всем пациентам с клиническими признаками ПИД определяют IgA, IgG, IgM в крови.

Изменения подтверждают как минимум двумя исследованиями. Критерии гипо- и агаммаглобулинемии — см. «Определения».

3.5 Субпопуляции лимфоцитов

При гипо- и агаммаглобулинемии определяют CD19+ лимфоциты — для уточнения формы ПИД.

При гипо- и агаммаглобулинемии определяют CD3+, CD4+, CD8+, CD16+/56+ лимфоциты — для исключения комбинированных ПИД.

3.6 Подтверждение ОВИН и дефицита специфических антител

При подозрении на ОВИН — одно из исследований

1. изогемагглютинины в крови;
2. переключённые B-клетки (CD19+CD27+IgD−);
3. при пограничных или нормальных иммуноглобулинах — антитела IgG к двум и более агентам до и после вакцинации.

Оценка поствакцинального ответа

1. непривитым проводят вакцинацию инактивированными вакцинами;
2. ответ на полисахаридные вакцины оценивают **не ранее 2 лет**;
3. оценку проводят до начала заместительной терапии;
4. значимо отсутствие нарастания титра в 2–4 раза **через 4–6 недель**, при сомнительном результате — повтор через 4 недели.

При подозрении на нарушение синтеза специфических антител определяют IgG к дифтерийному и столбнячному анатоксинам, менингококку, гемофильной палочке до и после вакцинации.

При подозрении на дефицит подклассов IgG (изолированный или с дефицитом IgA) исследуют подклассы IgG.

3.7 Молекулярно-генетическое исследование

Показания

1. мужчины с агаммаглобулинемией и B-клетками менее 2% — мутации гена Btk;
2. женщины и мужчины без мутации Btk при B-клетках менее 2% — гены других агаммаглобулинемий;
3. неустановленная мутация — панели генов (NGS), экзомное или геномное секвенирование.

3.8 Исследования при установленном диагнозе

Вирусные и другие инфекции у пациентов с ПИД диагностируют методом ПЦР: серологические методы неинформативны.

Исследования не реже 1 раза в 6 месяцев

1. общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;
2. общий анализ мочи;
3. биохимический анализ крови: белок и фракции, мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ, ГГТП, ЛДГ, билирубин, глюкоза.

На заместительной терапии претрансфузионный IgG определяют **ежемесячно** до достижения целевого уровня, затем **не реже 1 раза в 6 месяцев**.

При инфекционных осложнениях верифицируют возбудителя.

3.9 Компьютерная томография органов грудной полости

Всем пациентам — КТ органов грудной полости при установлении диагноза; при ОВИН — **не реже 1 раза в год**: интерстициальная болезнь лёгких может долго протекать бессимптомно.

3.10 УЗИ лимфатических узлов и органов брюшной полости

При ОВИН — УЗИ доступных лимфоузлов и органов брюшной полости при установлении диагноза и **не реже 1 раза в год**: риск лимфопролиферации и малигнизации.

3.11 Биопсия

Показания к биопсии при ОВИН

1. патологически изменённые лимфоузлы — эксцизионная биопсия с гистологией и иммуногистохимией;
2. подозрение на интерстициальную болезнь лёгких — биопсия лёгких;
3. поражение ЖКТ с гипогаммаглобулинемией — эндоскопическая биопсия кишки (дифференциальная диагностика с целиакией, НЯК, болезнью Крона).

3.12 Консультации специалистов

Аллерголог-иммунолог — **не реже 1 раза в год**. Родственникам пациентов с установленной мутацией показана консультация генетика.

По жалобам и находкам — консультации гастроэнтеролога, пульмонолога, оториноларинголога, стоматолога, гематолога, онколога, ревматолога, фтизиатра.

---

4. Лечение

Основные направления лечения

1. заместительная терапия иммуноглобулином человека нормальным внутривенно (ВВИГ) или подкожно (ПКИГ);
2. профилактика и лечение инфекций;
3. терапия проявлений иммунной дисрегуляции.

4.1 Заместительная терапия иммуноглобулином

Регулярное введение иммуноглобулина человека нормального начинают сразу после установления диагноза при агаммаглобулинемии, ОВИН и гипер-IgM-синдроме.

1. ВВИГ — 0,4–0,8 г/кг 1 раз в 3–4 недели;
2. ПКИГ — 0,4–0,8 г/кг в месяц, суммарная доза делится на несколько инъекций через равные промежутки;
3. 0,6–0,8 г/кг — в начале терапии, после перерыва более 3 месяцев, при тяжёлых инфекциях и потере белка.

Доза и кратность подбираются индивидуально с учётом бронхоэктазов, потери белка, обострения инфекций. Препараты не являются дженериками и различаются по донорам, подклассам IgG, содержанию IgA, стабилизаторам; выбор — по индивидуальным особенностям пациента.

При тяжёлых рецидивирующих инфекциях, не контролируемых антибиотиками, и (или) аутоиммунных проявлениях заместительная терапия назначается и при лёгких формах.

1. дефицит специфических антител — 0,4 г/кг 1 раз в 4 недели (взрослые и дети);
2. транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия — 0,4 г/кг ежемесячно, как правило, 2–3 месяца;
3. дефицит подклассов IgG (с дефицитом IgA или без) — 0,4 г/кг 1 раз в 4 недели.

Дозу подбирают так, чтобы претрансфузионный IgG был **более 7 г/л**.

Требования к препарату

1. подбор с учётом индивидуальной переносимости; риск реакций выше в начале терапии и при смене препарата;
2. содержание IgG не менее 95% — препараты с меньшим содержанием не рекомендуются;
3. распределение подклассов IgG, близкое к физиологическому;
4. этапы элиминации и контроль парвовируса B19;
5. указанное содержание IgA (риск анафилаксии).

Выбор формы введения

1. высокий риск почечной недостаточности, сердечно-сосудистые заболевания, риск тромбоэмболий — 10% ВВИГ или ПКИГ; при заболеваниях почек предпочтителен ВВИГ со стабилизатором мальтозой;
2. затруднённый венозный доступ, особенно у детей, — ПКИГ;
3. системные реакции на внутривенное введение — смена ВВИГ или ПКИГ;
4. потеря белка (нефротический синдром, энтеропатия) — ПКИГ.

Плохая переносимость ВВИГ при невозможности смены препарата

1. начальная скорость 0,01 мл/кг/мин с повышением каждые 15–30 минут до 0,08 мл/кг/мин;
2. премедикация НПВП, антигистаминными средствами, системными глюкокортикоидами;
3. прегидратация #натрия хлоридом за 30 минут: взрослым 500 мл, детям 10–20 мл/кг.

Иммуноглобулин для внутримышечного введения для заместительной терапии категорически не рекомендуется: он инактивируется в месте введения и имеет низкую биодоступность.

4.2 Профилактика и лечение инфекций

1. **тяжёлые формы: ОВИН, агаммаглобулинемия, гипер-IgM** — антибиотики в дополнение к заместительной терапии при хронических очагах; при неконтролируемой инфекции увеличивают дозу или частоту введения иммуноглобулина
2. **лёгкие формы: транзиторная гипогаммаглобулинемия, дефицит IgA, подклассов IgG, специфических антител** — антибиотики — терапия первой линии, заместительная терапия — только при неэффективности

Рекомендуются раннее назначение, комбинированные и пролонгированные курсы антимикробной, противовирусной и противогрибковой терапии: стандартной длительности может быть недостаточно для элиминации возбудителя.

При недостаточном контроле инфекций — профилактическая антибиотикотерапия короткими или длительными курсами, при сезонных обострениях — сезонными курсами.

1. #амоксициллин + клавулановая кислота — дети 10–20 мг/кг, взрослые 500–1000 мг 1–2 раза в день;
2. #ко-тримоксазол — 5 мг/кг в день (детям ежедневно или 3 дня в неделю);
3. #азитромицин — дети 10 мг/кг 1 раз в неделю или 5 мг/кг через день 3 дня в неделю, взрослые 500 мг 1 раз в неделю или 250 мг через день 3 раза в неделю;
4. #кларитромицин — дети 7,5 мг/кг, взрослые 500 мг 1–2 раза в день;
5. #доксициклин — детям **старше 8 лет** 25–50 мг, взрослым 100 мг 1–2 раза в день;
6. #тобрамицин ингаляционно — детям **старше 6 лет** и взрослым 300 мг 2 раза в день 28 дней, перерыв 28 дней.

Методы лечения иммунной дисрегуляции имеют ограниченную доказательную базу и подбираются индивидуально.

Санаторно-курортное лечение — по профилю осложнений; психологическая реабилитация и социальная адаптация.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Плановая госпитализация

1. первичное установление диагноза при симптомах ПИД;
2. коррекция терапии в специализированном центре;
3. осложнения, требующие стационарного лечения: аутоиммунные, малигнизация, энтеропатия.

Экстренная госпитализация — состояния, угрожающие жизни. Выписка — после стабилизации состояния.

Пациент наблюдается врачом по месту жительства и обеспечивается иммуноглобулином и препаратами для контроля иммунной дисрегуляции. На заместительной терапии обследование на осложнения проводится не реже 1 раза в год.

5.2 Профилактика

Перинатальный и ранний постнатальный скрининг агаммаглобулинемий, транзиторной гипогаммаглобулинемии, части гипер-IgM-синдромов и ранней ОВИН — определение TREC и KREC в мазках-отпечатках.

Всем пациентам — ежегодная вакцинация против гриппа инактивированной вакциной, вакцинация против пневмококковой и Hib-инфекции; предпочтительны конъюгированные и адъювантные вакцины.

При ОВИН, агаммаглобулинемии, гипер-IgM-синдроме живые вакцины не рекомендуются.

Вакцинация против ветряной оспы, паротита, кори, краснухи возможна при CD4+ более 500 кл/мм^3 у взрослых, более 1000 — у детей **от 1 до 6 лет**, более 1500 — у детей **до 1 года**.

При дефиците изотипа иммуноглобулинов или лёгких цепей с нормальным числом B-лимфоцитов вакцинация проводится по национальному календарю. Окружение пациента вакцинируется по календарю, ежегодно против гриппа, против пневмококка и Hib.

5.3 Беременность

ПИД не является противопоказанием к беременности и родам; ведение совместно с аллергологом-иммунологом и акушером-гинекологом. Дозу иммуноглобулина при беременности увеличивают; после кесарева сечения курсы антибиотиков в 2–3 раза длиннее стандартных.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Первичные иммунодефициты с преимущественной недостаточностью синтеза антител»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.05.2022
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2024 года (по тексту КР) — срок пересмотра прошёл
Код в рубрикаторе	735_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В списке сокращений перепутаны расшифровки: «АСТ — аланинаминотрансфераза», «АЛТ — аспартатаминотрансфераза»; правильно наоборот (АСТ — аспартатаминотрансфераза).
- В таблице 1 строка «Гипер-IgM-синдром» приведена дважды, а пороги наивных CD4+ в ней содержат два значения для одной группы «2–6 лет» (30% и 25%).

Клинические рекомендации

Перелом верхней челюсти

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S02.4** — Перелом скуловой кости и верхней челюсти
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/632_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Перелом верхней челюсти — повреждение верхней челюсти с нарушением её целостности. Переломы по типу Ле Фор, как правило, сопровождаются сотрясением (ушибом) головного мозга и переломом основания черепа.
- При повреждении ЛОР-органов (гемосинус и др.) показана консультация оториноларинголога. При нарушении стенок верхнечелюстной пазухи назначают деконгестанты для уменьшения отёка слизистой оболочки пазухи и соустья.
- Для переломов характерны носовое кровотечение, иногда с назальной ликвореей, и быстро нарастающий отёк лица с кровоизлиянием в параорбитальную клетчатку.
- Рентгенография не менее чем в 2 проекциях; перед операцией — КТ. Через **6 недель** после операции — контрольная томография для подтверждения консолидации и исключения посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.
- Рентгенологически подтверждённый перелом верхней челюсти — показание к экстренной госпитализации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Гемосинус — скопление крови в придаточных пазухах носа.

Назоликворея — ликворея в полость носа через дефект твёрдой мозговой оболочки в передней черепной ямке. Отоликворея — истечение ликвора через наружный слуховой проход через дефект твёрдой мозговой оболочки в средней черепной ямке.

Симптом «носового платка» — чистый носовой платок, смоченный ликвором, при высыхании остаётся мягким, а смоченный носовым отделяемым становится жёстким («накрахмаленным»). Проба «двойного пятна» — кровь образует на марлевой салфетке бурое пятно в центре, а по периферии — жёлтый венчик цереброспинальной жидкости.

Симптом «очков» — кровоизлияние в клетчатку век.

Симптом Малевича («разбитого горшка») — признак перелома скуловой кости, верхней челюсти: при перкуссии зубов слышен глухой дребезжащий звук, как от треснувшего глиняного горшка.

Симптом Герена — боль по ходу щели перелома при надавливании указательным пальцем на крючки крыловидных отростков клиновидной кости (снизу вверх).

Синдром повреждения верхней глазничной щели — офтальмоплегия, птоз, отсутствие чувствительности верхнего века и кожи лба, расширение и фиксированное положение зрачка.

Средняя зона лицевого черепа — зона между линией по верхним краям глазниц и линией смыкания зубов; включает кости носа, стенки глазниц, скуловые кости и дуги, верхние челюсти.

2.2 Этиология и эпидемиология

Перелом возникает от прямого удара или сдавления лицевого черепа. Ле Фор I — горизонтальная сила к альвеолярному отростку; Ле Фор II и III зависят от направления силы относительно франкфуртской горизонтали: горизонтальный удар — Ле Фор II, косой удар вниз — Ле Фор III.

Переломы верхней челюсти составляют 2–5% переломов лицевого черепа: Ле Фор I — 52–53%, Ле Фор II — 35–37%, Ле Фор III — 13–15%. Причины: дорожно-транспортная травма (63%), падение с высоты (27%), бытовая травма (10%). Повреждение органа слуха (барабанной перепонки, слуховых косточек) — 1,3%; субарахноидальное кровоизлияние — 10%.

2.3 Классификация

Классификация неогнестрельных переломов тела верхней челюсти (Le Fort, 1901)

Тип по Ле Фор	Линия перелома и признаки
I (нижний, перелом Герена)	отделение альвеолярного отростка и твёрдого нёба: от основания грушевидного отверстия через скулоальвеолярный гребень и бугор к крыловидным отросткам; смещение небольшое, возможно носовое кровотечение (повреждена слизистая оболочка дна верхнечелюстной пазухи и полости носа)
II (средний, суборбитальный, пирамидальный)	через носолобный шов, внутреннюю и нижнюю стенки глазницы к скуловерхнечелюстному шву; отрыв верхней челюсти с костями носа; носовое кровотечение, «симптом очков», отёк, нарушение прикуса
III (верхний, суббазальный, черепно-лицевое разъединение)	полное отделение лицевых костей от основания черепа, в отличие от I и II типов — с переломом скуловой кости; симптомы выражены резче

Изолированные типы Ле Фор встречаются редко; чаще сочетание типов с одной или разных сторон. Варианты Вассмунда близки к Ле Фор II и III, но кости носа остаются неподвижными.

1. **другие переломы** — сагиттальные (односторонние); переломы альвеолярного и лобного отростков, твёрдого нёба; оскольчатый перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи; переломы с повреждением назоорбитоэтмоидального комплекса
2. **по давности** — свежие (до 14 дней), застарелые (14–28 дней), неправильно консолидированные (более 28 дней — кодируются как T90.2)
3. **по линии перелома** — линейные, оскольчатые
4. **по механизму** — огнестрельные (классификация Д. Е. Танфильева) и неогнестрельные

2.4 Клиническая картина

Признаки перелома

1. быстро нарастающий отёк лица, кровоизлияние в параорбитальную клетчатку (симптом «лица панды»);
2. носовое кровотечение, иногда с назальной ликвореей;
3. подкожная эмфизема и крепитация (воздух из воздухоносных путей);
4. симптом «плавающего нёба» — подвижность верхней челюсти при раскачивании;
5. симптом «ступеньки» в области скуловерхнечелюстного сочленения и скулоальвеолярного гребня;
6. нарушение прикуса, часто открытый прикус;
7. удлинение или уплощение средней зоны лица;
8. положительные симптомы Малевича и Герена.

Переломы часто сочетаются с переломами костей носа, дна глазницы и лобной пазухи, повреждением органа зрения и ЛОР-органов, черепно-мозговой травмой.

Подвижность костей носа и увеличение межкантального расстояния указывают на повреждение назоорбитоэтмоидального комплекса. При повреждении скуловых костей возможен «скуловой синдром»: снижение чувствительности и функции мимических мышц.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: факт травмы, носовое кровотечение;
2. жалоб: отёк, кровоподтёки, боль, носовое кровотечение, онемение кожи лица и зубов, изменение формы лица и прикуса, ограничение открывания рта;
3. физикального обследования: деформация, патологическая подвижность и крепитация отломков, подкожная эмфизема, затруднение носового дыхания, гипестезия, звук «треснувшего горшка»;
4. инструментального обследования: линии переломов и смещение фрагментов.

3.2 Жалобы и анамнез

Оценивают сознание, факт и длительность потери сознания, амнезию, головокружение, тошноту, рвоту, головную боль — для верификации черепно-мозговой травмы и консультации невролога или нейрохирурга.

Уточняют механизм, дату, время и место травмы. При противоправных действиях или ДТП сообщают в правоохранительные органы.

3.3 Осмотр, пальпация, перкуссия

Всем пациентам — визуальный осмотр, пальпация и перкуссия челюстно-лицевой области.

Определяют прикус: смещение отломков изменяет соотношение верхней и нижней зубных дуг.

Оценивают чувствительность лица: часто снижена в зоне подглазничного нерва (нижнее веко, подглазничная область, скат носа, верхняя губа, зубы на стороне травмы).

Оценивают симптом «очков».

При переломе верхней челюсти он появляется сразу и распространён; при изолированном переломе основания черепа — не ранее чем **через 12 часов** (чаще через 24–48 часов) и не выходит за пределы круговой мышцы глаза.

При подозрении на перелом основания черепа — проба «двойного пятна» или «носового платка» для выявления ликвореи; выявить её сложно из-за сопутствующего кровотечения.

Оценивают энофтальм, гипофтальм, экзофтальм, глазодвигательные нарушения, остроту зрения и диплопию — переломы стенок глазницы, ретробульбарная гематома, синдром верхней глазничной щели.

Подвижность отломков определяют, захватив альвеолярный отросток во фронтальном отделе и осторожно смещая челюсть вперёд-назад; пальцы другой руки — на области носа и нижнеглазничного края.

3.4 Анализы крови перед операцией и на этанол

Перед операцией — лабораторные исследования для исключения противопоказаний; при подозрении на алкогольную интоксикацию, ДТП или производственной травме — определение этанола в крови или моче.

3.5 Рентгенография и компьютерная томография

Всем — рентгенография не менее чем в 2 проекциях (прямая и боковая черепа, аксиальная и полуаксиальная); при планировании операции — КТ челюстно-лицевой области. Переломы без смещения на рентгенограммах выявляются трудно — при необходимости КТ или конусно-лучевая томография.

3.6 Консультации специалистов

Всем на этапе диагноза — консультация нейрохирурга или невролога для исключения черепно-мозговой травмы.

При признаках повреждения ЛОР-органов (гемосинус и др.) — консультация оториноларинголога для уточнения диагноза и тактики обследования.

При глазодвигательных нарушениях, энофтальме, гипофтальме, гифеме, анизокории, диплопии, снижении зрения — консультация офтальмолога.

---

4. Лечение

4.1 Обезболивание

Обезболивание подбирают по интенсивности боли.

1. **слабая боль** — парацетамол
2. **умеренная** — НПВП, парацетамол с кеторолаком или кетопрофеном, опиоиды в комбинации с неопиоидными анальгетиками
3. **интенсивная** — опиоиды

При черепно-мозговой травме опиоиды противопоказаны.

4.2 Антибактериальная профилактика и терапия

Всем, кому планируется операция, — периоперационная антибиотикопрофилактика: разовая терапевтическая доза внутривенно за **30–60 минут** до разреза, однократно; при продлении — отмена не позднее **24 часов** после операции. Все переломы верхней челюсти условно считаются открытыми.

1. #цефазолин 2,0–3,0 г + метронидазол 0,5–1 г, либо цефуроксим 1,5 г, либо амоксициллин + клавулановая кислота;
2. при аллергии на бета-лактамы или высоком риске MRSA — ванкомицин 15 мг/кг или #клиндамицин.

Повторная интраоперационная доза — при операции длительнее 2 периодов полувыведения препарата и при массивной кровопотере.

При инфицированной ране (старая травма, гнойное отделяемое, нежизнеспособные ткани) — антибиотикотерапия.

При нарушении целостности стенок верхнечелюстной пазухи — деконгестанты местно для уменьшения отёка слизистой оболочки пазухи и соустья, улучшения дренажа и профилактики воспаления.

4.3 Иммобилизация и ортопедическое лечение

При подозрении на перелом — транспортная иммобилизация (подбородочно-теменная повязка, пращевидная повязка) для уменьшения боли и кровотечения до решения о лечении.
Противопоказания: бессознательное состояние, тошнота, рвота (угроза асфиксии).

Ортопедический метод — попытка репозиции и иммобилизации отломков назубными шинами или внутрикостными винтами с межчелюстной резиновой тягой и подбородочной повязкой; при беззубых челюстях — шина Порта. Противопоказан при черепно-мозговой травме средней и тяжёлой степени, нестабильной гемодинамике, тошноте и рвоте.

После вмешательства оценивают восстановление прикуса и выполняют контрольную рентгенографию или КТ.

4.4 Хирургическое лечение

Показание — перелом с выраженным смещением отломков; противопоказание — крайне тяжёлое состояние. При тяжёлой сочетанной травме открытую репозицию и фиксацию выполняют после стабилизации (принцип Damage Control).

Накостный остеосинтез выполняют под общим обезболиванием; интубацию целесообразно проводить через носовые ходы, чтобы трубка не мешала восстановлению прикуса. При выраженной деформации носовых ходов — интубация через рот с выведением трубки через подподбородочный разрез или временная трахеостома.

При смещении и подвижности отломков — остеосинтез титановыми или биодеградируемыми накостными пластинами и винтами; после операции — оценка прикуса и контрольная КТ.

4.5 Диетотерапия

При нарушении сосания, жевания и глотания — первая челюстная диета (кормление через зонд); при сохранённых глотании и сосании — вторая челюстная диета (кашицеобразная пища).

4.6 Медицинская реабилитация

Всем после операции — реабилитация: первый этап **с 7-х по 10-е сутки** (стационар 3–5 дней, затем амбулаторно 10–15 дней), второй — **с 15-х по 45-е сутки**, включая профилактику посттравматического верхнечелюстного синусита и контрактуры. Межчелюстные тяги меняют не реже 1 раза в 7 дней.

При черепно-мозговой травме физиотерапия противопоказана.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация — рентгенологически подтверждённый перелом верхней челюсти; плановой госпитализации нет: перелом является неотложным состоянием.

Показания к выписке

1. неосложнённый послеоперационный период, удовлетворительное положение отломков, отсутствие ликвореи и прогрессирующих гнойно-воспалительных процессов;
2. перевод в другое учреждение;
3. требование пациента или законного представителя;
4. несоблюдение режима, если это не угрожает жизни.

5.2 Диспансерное наблюдение

По показаниям при выписке — профилактический осмотр оториноларинголога, офтальмолога, невролога или нейрохирурга.

Всем через **6 недель** после операции — контрольная томография лицевого черепа: консолидация отломков и исключение посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

Неблагоприятно влияют на исход

1. инфекционные осложнения;
2. несоблюдение гипотермии, гигиены полости рта, диеты и ограничения жевательной нагрузки;
3. контактные виды спорта в течение **3 месяцев**;
4. пропуск контрольных осмотров.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Перелом верхней челюсти»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 17.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	632_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.

Клинические рекомендации

Полипозный риносинусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J33.0** — Полип полости носа **J33.1** — Полипозная дегенерация синуса **J33.8** — Другие полипы синуса **J33.9** — Полип носа неуточненный
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/890_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз устанавливают на основании:
  1. жалоб и анамнеза;
  2. данных осмотра;
  3. передней риноскопии;
  4. эндоскопии полости носа и носоглотки;
  5. компьютерной томографии (КТ) околоносовых пазух.
- Препарат выбора: мометазон в форме назального спрея по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс **3–6 месяцев**. Если симптомы не уменьшаются **в течение 5–6 недель**, рассматривают вопрос о хирургическом лечении.
- Системная антибактериальная терапия при полипозном риносинусите не рекомендуется.
- Генно-инженерная биологическая терапия (дупилумаб, омализумаб или меполизумаб) рекомендуется:
  1. при тяжёлом течении;
  2. при сочетании с бронхиальной астмой.
- Показания к хирургическому лечению:
  1. неэффективность медикаментозной терапии;
  2. распространённый полипоз.

  Оптимальный метод: функциональная эндоскопическая риносинусохирургия.
- В течение первого года после операции пациента осматривают **каждые 3 месяца**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Полипозный риносинусит (ПРС): фенотип хронического риносинусита, гетерогенное по этиологии и патогенезу хроническое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП) продолжительностью **более 12 недель**.

Сопровождается

1. ремоделированием слизистой оболочки;
2. образованием и рецидивирующим ростом полипов.

Полипы носа представляют собой доброкачественные новообразования слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

Т2-эндотип ПРС характеризуется воспалением с эозинофилией крови или ткани либо с повышенным уровнем общего иммуноглобулина Е (IgE). К нему относятся эозинофильный хронический риносинусит, аллергический грибковый риносинусит и центральная компартментная атопическая болезнь (CCAD), то есть изолированные полипозные изменения слизистой оболочки верхней и средней носовых раковин и задневерхних отделов перегородки носа у пациентов с установленной аллергией к ингаляционным аллергенам.

2.2 Этиология и патогенез

В развитии ПРС участвуют

1. нарушения врождённого и адаптивного иммунитета;
2. аллергия;
3. генетически обусловленные заболевания: иммунодефициты, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия;
4. изменения внутриносовой анатомии;
5. бактериальная, грибковая и вирусная инфекция.

Вместе или по отдельности эти факторы поддерживают хроническое воспаление слизистой оболочки носа, которое приводит к образованию полипов и рецидивам.

Эозинофильный и неэозинофильный эндотипы ПРС различаются клиническими проявлениями, течением и ответом на лечение.

Из анатомических изменений у больных риносинуситом наиболее часто встречаются искривление перегородки носа (36%), concha bullosa (30%), клетки Оноди (12%) и клетки Галлера (6%), реже парадоксальный изгиб средней носовой раковины (3%) и пневматизация крючковидного отростка (2%).

2.3 Классификация

Единая классификация отсутствует. По клиническим и эндоскопическим данным выделяют три стадии:

1. полипы ограничены средним носовым ходом;
2. полипы выходят за пределы среднего носового хода;
3. полипы обтурируют соответствующую половину носа.

Для эндоскопической оценки применяется шкала Lund–Kennedy: полипы, отёк и отделяемое оцениваются отдельно справа и слева, каждый признак от 0 до 2 баллов.

2.4 Шкала Lund–Kennedy

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Полипы	Полипы отсутствуют	Полипы в пределах среднего носового хода	Полипы распространяются за пределы среднего носового хода
Отёк	Отёк отсутствует	Умеренный отёк	Значительный отёк
Отделяемое	Отделяемое отсутствует	Прозрачное отделяемое	Густое гнойное отделяемое

Шкала Lund–Mackay по данным КТ, справа и слева отдельно

1. каждая пазуха: 0 баллов без изменений, 1 балл при частичном затенении, 2 балла при тотальном затенении;
2. остиомеатальный комплекс: 0 баллов, если интактен, 2 балла при обтурации;
3. сумма для каждой стороны от 0 до 12 баллов, общая сумма от 0 до 24.

> Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не совпадает с текстом раздела 1.5. Верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны в ней дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют. Остиомеатальный комплекс в таблице оценивается в 0, 1 или 2 балла, в тексте только в 0 или 2 балла. В строке «Общее количество баллов» справа указаны 0, 7 и 14, слева 0, 1 и 2, хотя согласно ключу под таблицей сумма составляет от 0 до 12 на сторону. Расчёт следует проводить по тексту раздела 1.5.

По гистологическому строению различают отёчные полипы с преимущественно эозинофильной инфильтрацией (70–85% клеток), фиброзные полипы с преобладанием нейтрофилов, полипы с гиперплазией серозно-слизистых желёз и полипы с атипией стромы.

2.5 Клиническая картина

Основные симптомы

1. заложенность носа;
2. слизистые или слизисто-гнойные выделения, стекание отделяемого по задней стенке глотки;
3. ощущение тяжести и давления в области носа и в проекции околоносовых пазух;
4. диффузная головная боль;
5. снижение или отсутствие обоняния.

В ряде случаев

1. жжение и раздражение в горле, кашель, охриплость;
2. недомогание, снижение работоспособности, сонливость.

Необходимо оценить выраженность и продолжительность симптомов. При обострении симптомы усиливаются.

2.6 Жалобы и анамнез

Группы жалоб

1. назальные: затруднённое носовое дыхание, выделения из носа, снижение или отсутствие обоняния;
2. болевые: лицевая боль, ощущение распирания и давления в области лица, головная и зубная боль;
3. оро- и назофарингеальные: неприятный запах изо рта, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель, заложенность или боль в ушах;
4. системные: недомогание, утомляемость, снижение работоспособности.

Такое разделение позволяет подтвердить диагноз, оценить степень тяжести и выявить факторы, влияющие на выбор тактики лечения.

При сборе анамнеза уточняют время и причины появления симптомов, последовательность их развития, выраженность и динамику, влияющие на них факторы, ранее проведённые обследования и лечение.

Отдельно выясняют

1. связь симптомов с сезонными или круглогодичными аллергенами;
2. непереносимость ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);
3. симптомы бронхиальной астмы;
4. ПРС у близких родственников;
5. одно- или двусторонний характер симптомов;
6. рецидивирующие носовые кровотечения.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании:

1. жалоб и анамнеза;
2. физикального обследования;
3. передней риноскопии;
4. эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки;
5. КТ околоносовых пазух.

3.1 Критерии и тяжесть по жалобам

Обязательные критерии

1. **две жалобы и более**, одна из которых: заложенность носа или выделения из носа.

Возможные симптомы

1. боль и давление в проекции околоносовых пазух;
2. снижение или отсутствие обоняния.

Степень тяжести у всех пациентов оценивают по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Пациент оценивает выраженность симптома от 0 (симптом отсутствует) до 10 баллов (максимальная выраженность).

1. лёгкое течение: **0–3 балла**;
2. умеренное: **3–7 баллов**;
3. тяжёлое: **7–10 баллов**.

Значимое влияние на качество жизни оказывают симптомы выраженностью **5 баллов и более**.

Диагностическая специфичность повышается при сочетании двух или более субъективных симптомов с объективными признаками заболевания (данными эндоскопии носа и лучевых методов исследования).

3.2 Осмотр оториноларинголога

Показания

1. все пациенты с подозрением на ПРС или с установленным диагнозом.

Диагностические признаки

1. болезненность при пальпации и перкуссии в проекции околоносовых пазух;
2. признаки назальной обструкции: затруднённое носовое дыхание, гнусавость;
3. вязкое слизистое или слизисто-гнойное отделяемое;
4. полипы, при длительном течении и распространённом процессе видимые уже в преддверии носа;
5. в ряде случаев расширение спинки наружного носа.

3.3 Передняя риноскопия

Показания

1. все пациенты: оценка распространённости процесса и сопутствующей внутриносовой патологии.

3.4 Эндоскопическая ревизия полости носа и носоглотки

Показания

1. все пациенты: определение локализации и распространённости изменений слизистой оболочки.
1. дифференцирует ПРС от заболеваний со сходной симптоматикой: новообразований, гипертрофии глоточной миндалины и задних концов нижних носовых раковин;
2. в сочетании с жалобами и анамнезом значительно повышает точность диагностики: специфичность 84%, чувствительность 66%.

3.5 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания

1. каждый пациент: оценка распространённости полипоза, состояния внутриносовых структур и костных стенок пазух.

Для повторных исследований в динамике вместо мультиспиральной КТ может применяться конусно-лучевая томография носа и околоносовых пазух, поскольку она сопровождается меньшей лучевой нагрузкой и не приводит к превышению годовой дозы на одну анатомическую зону.

3.6 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на новообразование полости носа и околоносовых пазух (дополнительно к КТ).

Рентгенография околоносовых пазух дешевле и доступнее, однако при ПРС она малоинформативна по сравнению с КТ.

3.7 Патолого-анатомическое исследование

Показания

1. все пациенты: операционный материал для дифференциации субтипов полипозного риносинусита.

3.8 Цитологическое исследование

Показания

1. все пациенты: выявление аллергического воспаления и выбор тактики лечения.

Диагностические признаки

1. содержание эозинофилов **более 10%** в поле зрения свидетельствует о выраженном аллергическом компоненте.

3.9 Консультации специалистов и сахариновый тест

Показания

1. подозрение на бронхиальную астму или атопию: консультация пульмонолога и (или) аллерголога-иммунолога.

Показания

1. подозрение на первичную цилиарную дискинезию: исследование скорости мукоцилиарного транспорта сахариновым тестом.

---

4. Лечение

Медикаментозное и хирургическое лечение значительно и практически в одинаковой степени улучшают качество жизни при ПРС, что подтверждает приоритетное значение адекватной медикаментозной терапии.

4.1 Ограниченный полипоз (полипы в пределах среднего носового хода)

Кортикостероиды в форме назальных спреев применяют в качестве стартовой терапии при ограниченном полипозе, когда полипы не выходят за пределы среднего носового хода, а также в пред- и послеоперационном периоде.

Предпочтение отдаётся препаратам с высокой топической активностью и низкой биодоступностью, поскольку они безопаснее при длительном применении. Назальные кортикостероиды уменьшают размеры полипов и заложенность носа, улучшают обоняние, предупреждают рецидивы и повышают качество жизни.

Если симптомы не уменьшаются **в течение 5–6 недель** применения мометазона, рассматривают вопрос о хирургическом лечении.

4.2 Рефрактерное течение, бронхиальная астма, непереносимость НПВП

Показания к системным кортикостероидам:

1. гиперреактивность бронхов, бронхиальная астма;
2. непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов;
3. рефрактерное течение ПРС;
4. выраженная атопия;
5. уменьшение воспаления в пред- и послеоперационном периоде.

Длительный или частый приём системных кортикостероидов может повышать риск нежелательных явлений и осложнений.

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов применяют дополнительно к системным кортикостероидам или вместо них при их непереносимости, а также при рефрактерном к кортикостероидам течении ПРС.

Системная антибактериальная терапия при ПРС не рекомендуется, поскольку доказательств её эффективности недостаточно, тогда как риски (развитие резистентности микрофлоры, анафилаксия, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта) реальны.

Применение макролидов обсуждается в связи с их иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, однако оптимальный препарат, доза и длительность терапии не определены, поэтому сделать однозначный вывод об их эффективности при ПРС не представляется возможным.

4.3 Тяжёлое течение, сочетание с бронхиальной астмой: генно-инженерная биологическая терапия

При тяжёлом течении ПРС, а также при сочетании ПРС с бронхиальной астмой для повышения эффективности лечения и снижения риска рецидивов рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия (ГИБТ): дупилумаб, омализумаб или меполизумаб.

Препараты ГИБТ представляют собой рекомбинантные человеческие или гуманизированные моноклональные антитела класса IgG, избирательно связывающие IgE, интерлейкины или субъединицы их рецепторов (ИЛ-5, ИЛ-4/13).

Биологическую терапию назначают при двустороннем полипозе и хирургических вмешательствах в анамнезе, если выполнены **три критерия** из пяти:

1. признаки Т2-воспаления: эозинофилы в ткани не менее 10 в поле зрения, или в крови не менее 150 клеток/мкл, или общий IgE не менее 100 МЕ/мл;
2. потребность в системных кортикостероидах (2 курса и более за год или приём **более 3 месяцев**) либо противопоказания к ним;
3. значимое снижение качества жизни: SNOT-22 не менее 40;
4. аносмия по результатам исследования обоняния;
5. бронхиальная астма, требующая регулярного применения ингаляционных кортикостероидов.

Ответ на терапию оценивают по пяти критериям:

1. уменьшение размеров полипов;
2. снижение потребности в системных кортикостероидах;
3. улучшение качества жизни;
4. улучшение обоняния;
5. уменьшение влияния сопутствующих заболеваний.

Оценка ответа на генно-инженерную биологическую терапию

1. 4–5 критериев: хороший ответ;
2. 2–3 критерия: умеренный ответ;
3. 0–1 критерий: слабый ответ или его отсутствие.

Эффективность оценивают **через 6 месяцев** и **через год**. При отсутствии ответа диагноз пересматривают, лечение прекращают и при необходимости переходят на другой препарат.

1. лечение длительное, при его прерывании возможен рецидив;
2. беременность: только если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода;
3. грудное вскармливание: решение о прекращении кормления или отмене препарата принимают с учётом пользы того и другого.

Решение о продолжении терапии принимается врачом с учётом тяжести заболевания и степени контроля обострений.

Режимы дозирования

Препарат	Доза
Мометазон, назальный спрей	По 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс 3–6 месяцев. После достижения эффекта — по 2 впрыскивания в каждую половину носа 1 раз в сутки (200 мкг в сутки).
Преднизолон	Коротким курсом при недостаточном контроле симптомов назальными кортикостероидами: внутрь, в таблетках, 30–60 мг в сутки в течение 14 дней.
Дупилумаб	Подкожно 300 мг (2 мл раствора 150 мг/мл) 1 раз в 2 недели, с 18 лет. При пропуске введения лечение возобновляется как можно скорее; у пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Омализумаб	Подкожно 75–600 мг 1 раз в 2 или 4 недели; доза и кратность введения определяются исходным уровнем IgE и массой тела и корректируются при значительном изменении массы тела.
Меполизумаб	Взрослым с плохо контролируемым тяжёлым ПРС — подкожно 100 мг 1 раз в 4 недели, длительно.

4.4 Неэффективность медикаментозной терапии, распространённый полипоз: хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению для восстановления носового дыхания:

1. неэффективность медикаментозной терапии;
2. распространённый полипоз полости носа и околоносовых пазух.

Оптимальный метод: функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ) под видеоэндоскопическим контролем.

Включает

1. удаление полипозно изменённой слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух;
2. восстановление проходимости естественных соустий;
3. коррекцию анатомических нарушений: как правило, септопластику и (или) резекцию носовых раковин, а также резекцию решётчатой буллы.

В зависимости от выраженности изменений объём вмешательства может быть ограничен минимально инвазивными методиками, обеспечивающими дренирование и аэрацию околоносовых пазух.

Всем пациентам перед операцией рекомендованы кортикостероиды в форме назальных спреев, что позволяет уменьшить кровопотерю, улучшить обзор операционного поля и сократить продолжительность вмешательства.

Результат хирургического лечения во многом определяется предоперационной медикаментозной подготовкой.

4.5 Послеоперационное ведение

После любого хирургического вмешательства необходима комплексная реабилитация, направленная на восстановление носового дыхания и функции слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.

Реабилитация включает

1. охранительный режим **10–14 дней и более**;
2. санацию полости носа и околоносовых пазух под эндоскопическим контролем в режиме «ирригация–аспирация» в раннем послеоперационном периоде;
3. бережное удаление плотных продуктов воспаления и фибрина для профилактики синехий;
4. при избытке вязкого отделяемого или корках орошение полости носа 0,9% раствором натрия хлорида.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с ПРС подлежат диспансерному наблюдению у оториноларинголога для своевременного выявления ухудшения на фоне лечения или рецидива после операции и коррекции терапии.

Специфическая профилактика ПРС отсутствует.

Назальные кортикостероиды **в течение 6–12 месяцев** в пред- и послеоперационном периоде у большинства пациентов:

1. уменьшают выраженность воспаления;
2. улучшают качество жизни;
3. снижают частоту рецидивов;
4. увеличивают продолжительность ремиссии.

Кратность осмотров определяют индивидуально; в течение первого года после операции осматривают **каждые 3 месяца**. При рецидиве, требующем повторного хирургического вмешательства, и при подозрении на осложнённое течение выполняют КТ околоносовых пазух.

Пациентам с ПРС необходимо ежедневное применение назальных кортикостероидов, нередко в течение всей жизни с небольшими перерывами.

> Длительность применения назальных кортикостероидов в рекомендации указана по-разному: курс мометазона 3–6 месяцев (раздел 3.1), в пред- и послеоперационном периоде 6–12 месяцев (раздел 5), в разделе 7 ежедневно, нередко в течение всей жизни.

Наблюдение оториноларинголога должно быть систематическим, не реже одного раза в 3 месяца. Результат лечения зависит не только от операции и опыта хирурга, но и от приверженности пациента лечению и выполнения им рекомендаций.

> В разделе 5 указано, что кратность обследований определяется индивидуально, а осмотры каждые 3 месяца необходимы в течение первого года после операции. В разделе 7 и в информации для пациента указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.

Основной задачей является комплексное лечение, обеспечивающее контроль симптомов и улучшение качества жизни. В ряде случаев необходимы повторные щадящие эндоскопические вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах.

При сопутствующей бронхиальной астме показано также наблюдение аллерголога-иммунолога.

5.1 Показания к госпитализации

Обследование и лечение пациентов могут проводиться как амбулаторно, так и в условиях стационара.

Показания к плановой госпитализации:

1. функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ) с одномоментной коррекцией внутриносовых структур или без неё при отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению;
2. подбор и коррекция терапии (дневной или круглосуточный стационар);
3. проведение генно-инженерной биологической терапии.

Выписка после операции возможна при:

1. удовлетворительном общем состоянии;
2. улучшении или восстановлении носового дыхания.

Согласно алгоритму ведения пациента (приложение Б), после диагностики пациент с аллергией или бронхиальной астмой направляется к аллергологу-иммунологу или пульмонологу. При отсутствии показаний к операции наблюдение и лечение осуществляются амбулаторно; при отрицательной динамике, как и при наличии показаний, показана госпитализация в специализированный стационар для ФЭРСХ с последующим продолжением наблюдения и медикаментозного лечения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Полипозный риносинусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	`890_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не соответствует тексту раздела 1.5: верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют, остиомеатальный комплекс оценивается в 0–1–2 балла вместо 0 или 2, а строка «Общее количество баллов» (0–7–14 и 0–1–2) не соответствует сумме от 0 до 12 на сторону.
- Длительность применения назальных кортикостероидов указана по-разному: 3–6 месяцев (раздел 3.1), 6–12 месяцев (раздел 5), ежедневно, нередко в течение всей жизни (раздел 7).
- Кратность наблюдения в разделе 5 определяется индивидуально, с осмотрами каждые 3 месяца в течение первого года после операции; в разделе 7 указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.

Клинические рекомендации

Потеря слуха, вызванная шумом

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H83.3** — Шумовые эффекты внутреннего уха **Z57.0** — Неблагоприятное воздействие производственного шума
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.03.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Национальная медицинская ассоциация сурдологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/609_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Профессиональная тугоухость: медленно развивающаяся хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость от производственного шума выше предельно допустимого уровня — **80 дБА**.
- Типичная аудиограмма: двусторонний симметричный «провал» **на 4000 Гц** (реже 3000 Гц) с подъёмом на 8000 Гц, без костно-воздушного разрыва; пороги на разговорных частотах ниже, чем на высоких, **не менее чем на 15 дБ**.
- Предварительный диагноз ставит оториноларинголог на периодическом медосмотре или при обращении; заключительный — только центр профпатологии.
- Лечение помогает только на ранних стадиях — «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха; при II–III степени медикаменты малоэффективны, при III степени и трудностях общения — слуховой аппарат.
- Главное — профилактика: средства индивидуальной защиты органа слуха, «защита временем», медосмотры и группы диспансерного наблюдения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Медленно развивающееся хроническое двустороннее нарушение слуха от производственного шума выше предельно допустимого уровня (**80 дБА**): поражение звуковоспринимающего отдела — нейроэпителия внутреннего уха; клинически — хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость.

Акустическая травма в этих КР не рассматривается: её тоже кодируют H83.3, но оформляют как несчастный случай на производстве.

2.2 Этиология и патогенез

Причина — производственный шум выше гигиенических нормативов. Шум **до 90 дБА** учащает временное смещение порогов слуха после смены: это индикатор риска, а не начало профессиональной патологии; при продолжении воздействия возможен переход в постоянное смещение.

Усугубляют действие шума

1. напряжённость и тяжесть труда;
2. нагревающий микроклимат;
3. заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и иммунной систем.

Единой теории нет. Субстрат — дегенерация наружных и внутренних волосковых клеток кортиева органа, процесс восходящий. Главный механизм гибели клеток — оксидативный стресс: апоптоз наружных волосковых клеток проявляется временным повышением порогов, некроз — постоянным смещением порогов и тугоухостью.

Основное звено патогенеза — сосудистые расстройства: снижение кровенаполнения в вертебробазилярной системе, ангиоспазм, затруднение венозного оттока; лабиринтная артерия — концевая, без коллатералей, рецепторы улитки очень чувствительны к гипоксии.

Шум — дополнительный фактор риска артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушений вегетативной регуляции; эти экстраауральные нарушения обычно предшествуют поражению слуха.

На большинстве производств шум действует вместе с вибрацией, инфразвуком, нервно-эмоциональным и физическим напряжением, нагревающим микроклиматом, токсическими веществами.

2.3 Классификация

Классификация потери слуха, вызванной шумом

Степень	Средний порог по воздуху на 500, 1000, 2000, 4000 Гц, дБ
Признаки воздействия шума на орган слуха	11–25
I степень (I «А», I «Б»)	26–40
II степень	41–55
III степень	56–70
IV степень	71–90

Подгруппы I степени

1. I «А»: нет экстраауральной патологии;
2. I «Б»: гипертоническая болезнь 2 степени и выше, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга 2 степени и выше.

Подгруппы нужны для выбора лечения и чтобы предупредить работника с I «Б» о повышенном риске при продолжении работы в шуме.

«Коррекцию на возраст» не применяют: при потере на высоких частотах **более 45–50 дБ** у пожилых нельзя разграничить шум и старение.

Возрастная инволюция слуха начинается **после 35–37 лет** и к 40–49 годам даёт на речевых частотах **до 10 дБ**. Её учитывают только до стадии признаков воздействия шума (Z57.0); при порогах выше параметров пресбиакузиса степень считают от аудиометрического нуля.

2.4 Клиническая картина

Развивается медленно, обычно **10–14 лет**; первые донозологические изменения на аудиограмме возможны **при стаже 5 лет**.

Жалобы по мере развития

1. сначала экстраауральные: нарушение сна, раздражительность, головная боль;
2. позже — хуже разборчивость речи, особенно в шуме, шум в ушах, снижение слуха.

Отоскопия

1. барабанная перепонка втянута, мутная;
2. инъекция сосудов по рукоятке молоточка;
3. световой конус укорочен.

Чаще — при сочетании шума и вибрации.

Развитие изменений на аудиограмме

1. сначала повышение порогов **на 12, 14, 16 кГц**;
2. затем «провал» **на 4000 Гц** (реже 3000 Гц) с подъёмом на 8000 Гц — на восприятие речи не влияет, выявляется только аудиометрией;
3. при продолжении шума «провал» расширяется на соседние частоты; жалоб на слух ещё нет.

Костно-воздушного разрыва нет.

Отличия от пресбиакузиса

1. пологая нисходящая кривая, наибольшее повышение порога на 4000 Гц;
2. средний порог на 500, 1000, 2000 Гц всегда ниже, чем на 3000, 4000, 6000 Гц, разница **не менее 15 дБ**;
3. пороги на 3000, 4000, 6000 Гц всегда выше, чем на 8000 Гц;
4. шум обычно не даёт потери **более 75 дБ** на высоких и **более 40 дБ** на разговорных частотах.

У работников **старше 50–55 лет** «провал» менее выражен; без прежних аудиограмм начальные признаки трудно отличить от пресбиакузиса. При сочетании шума и возраста вместо «провала» формируется «впадина».

Типичные клинико-аудиологические признаки

1. постепенное повышение порогов по типу нарушения звуковосприятия в течение нескольких лет, **не менее 5**;
2. двусторонний процесс;
3. нет костно-воздушного разрыва;
4. нисходящая кривая с «провалом» на 4000 или 3000 Гц;
5. постепенное повышение порогов на 1000 и 2000 или 3000 Гц;
6. при стаже **20 лет и более** — значительнее на речевых частотах, выраженные «провалы» на 2000 и 4000 Гц.

Самые ранние изменения выявляет вызванная отоакустическая эмиссия. Нет задержанной ОАЭ **более чем в 4 частотных полосах** при нормальных тональных порогах — неблагоприятный признак, показание к динамическому наблюдению и реабилитации.

Для скрининга задержанная ОАЭ предпочтительнее ОАЭ на частоте продукта искажения.

Надпороговые и объективные тесты

1. положительный феномен ускоренного нарастания громкости, дифференциальный порог 0,6–0,4 дБ в начале; 1,5–3 дБ — при нарастании тугоухости;
2. показатели теста Si-Si растут с тугоухостью, до 100% при повышении порога **на 40 дБ**;
3. слуховое поле сужено до 90 дБ, возможен гиперакузис;
4. повышение порогов на 16, 14, 12 кГц в расширенном диапазоне;
5. тимпанограмма тип «А», акустический рефлекс сохранён (60–70 дБ), при высокой степени тугоухости не вызывается;
6. амплитуда задержанной ОАЭ снижена, выпадают частоты (прежде всего 4000 или 3000 Гц); при порогах **более 30 дБ** ОАЭ не регистрируется.

Экстрааурaльные проявления

1. головная боль, раздражительность, утомляемость, нарушение сна;
2. шум в ушах, головокружение с потемнением в глазах;
3. боль в области сердца, сердцебиение;
4. при осмотре: изменение сухожильно-периостальных рефлексов, тремор пальцев, стойкий дермографизм, акроцианоз, потливость, неустойчивость в позе Ромберга.

Шум вместе с вибрацией раздражает вестибулярный анализатор: «уплывание глаз», диссоциация вестибуло-окулярных реакций при калорической и вращательной пробах. Для «шумовых» профессий характерно понижение вестибулярной возбудимости.

---

3. Диагностика

Два этапа

1. предварительный диагноз — на периодическом медосмотре или при любом обращении;
2. заключительный — только учреждение профпатологии с лицензией по профпатологии, экспертизе связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности.

Критерии диагноза

1. жалобы: постепенное снижение слуха, больше на высоких частотах, низкочастотный шум в обоих ушах или в голове, хуже разборчивость речи в шуме;
2. в анамнезе нет сердечно-сосудистых болезней, церебрального атеросклероза, остеохондроза, нарушений липидного обмена, сифилиса, сахарного диабета, болезней среднего уха и носоглотки, травм головы, наследственной тугоухости, лечения аминогликозидами;
3. стаж в шуме **10 лет и более**, уровень шума **выше 80 дБА**.

При осмотре

1. пальпация уха и сосцевидного отростка безболезненна;
2. слуховой проход свободен;
3. барабанная перепонка чаще матовая, слегка втянута, световой конус укорочен, сосуды по рукоятке молоточка инъецированы.

Кровь в норме, липидный профиль нарушен.

Инструментально: двусторонняя симметричная нисходящая кривая с «провалом» на 4000 Гц, без костно-воздушного разрыва; надпороговые тесты — как в разделе «Клиническая картина». Отсутствие задержанной ОАЭ **на 4000 Гц** — ранний признак воздействия шума.

3.1 Жалобы и анамнез

Уточнить характер работы, шум на рабочем месте и стаж в нём, все прежние профессии и вредные факторы, сопутствующие болезни.

Характерно для шумовой тугоухости

1. нет недавних острых заболеваний, в том числе COVID-19;
2. раздражительность, нарушение сна;
3. шум в обоих ушах или в голове раньше снижения слуха;
4. нет хронических болезней среднего уха, гипертензии, диабета, нарушений липидного обмена;
5. нет шумных увлечений: громкой музыки, стрельбы;
6. нет тугоухости у близких родственников;
7. постепенное снижение слуха;
8. «шумоопасная» профессия, стаж в шуме выше допустимого **более 8–10 лет**.

3.2 Осмотр и консультации специалистов

Всем работающим в шуме выше допустимого — на медосмотре оториноларинголог: выявить нарушения слуха и противопоказания к работе. При типичных жалобах и аудиограмме и стаже **10 лет и более** он вправе поставить предварительный диагноз профессиональной тугоухости.

Осмотр наружного уха и сосцевидного отростка.

Осмотр верхних дыхательных путей: болезни носа и околоносовых пазух как дополнительная причина снижения слуха.

При подозрении на шумовую тугоухость — повторный осмотр оториноларинголога в учреждении профпатологии: заключительный диагноз, профпригодность, группа диспансерного наблюдения, индивидуальная программа реабилитации слуха.

При углублённом обследовании в стационаре профпатологии — ежедневный осмотр оториноларинголога.

Сурдолог-оториноларинголог: первично — при трудной дифференциальной диагностике; повторно — для заключительного диагноза и программы реабилитации, в том числе слухопротезирования.

Повторный приём сурдолога — углублённое обследование слуха, решение о реабилитации и слухопротезировании.

Терапевт и невролог — на предварительном и периодических медосмотрах: экстраауральные эффекты шума, противопоказания к работе в шуме, лечение сопутствующих болезней; повторно — при заключительном диагнозе.

Повторный приём терапевта — при установлении заключительного диагноза.

Невролог первично — экстраауральные эффекты шума на нервную систему, противопоказания к работе в шуме.

Невролог повторно — при установлении заключительного диагноза.

Профпатолог первично, по результатам медосмотра

1. противопоказания к работе в шуме;
2. возможность предварительного диагноза;
3. запрос санитарно-гигиенической характеристики условий труда;
4. направление в центр профпатологии.

Повторно — заключительный диагноз, профпригодность, диспансерная группа.

Повторный приём профпатолога — в учреждении профпатологии при решении о заключительном диагнозе.

3.3 Анализы крови и мочи

Всем работникам «шумоопасных» профессий и пациентам

1. развёрнутый общий анализ крови;
2. общий анализ мочи;
3. биохимический общетерапевтический анализ крови;
4. липидный профиль: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности — значимы для патогенеза.

Общий анализ мочи — в рамках общеклинического обследования.

Биохимический общетерапевтический анализ крови — в рамках общеклинического обследования.

Липидный профиль — выявить дополнительные экстраауральные эффекты шума.

3.4 Исследование слуха

Аудиометрию работникам в шуме проводят **не ранее чем через 14 часов** после прекращения контакта с шумом — чтобы исключить временное смещение порогов.

Жалобы на снижение слуха: камертональные пробы Вебера и Ринне — ориентировочная оценка, разграничение нарушения звукопроведения и звуковосприятия.

Всем работникам «шумоопасных» профессий — тональная пороговая аудиометрия с воздушным и костным проведением: основной метод диагностики и дифференциальной диагностики, выявляет ранние сдвиги порогов.

Аудиометрия в расширенном диапазоне — самые ранние изменения **на 12, 14, 16 кГц**, не видимые другими методами.

Надпороговые тесты (проба Люшера, порог дискомфорта, тест Si-Si) — углублённая оценка и уточнение уровня поражения.

Речевая аудиометрия — по показаниям, для профпригодности по отраслевым требованиям, прежде всего в гражданской авиации.

Импедансометрия — дифференциальная диагностика и уровень поражения слухового анализатора; при экспертизе связи с профессией обязательна.

Вызванная отоакустическая эмиссия — самые ранние нарушения, подтверждение степени, исключение аггравации и симуляции. Изменения прежде всего в полосе 4 кГц.

Отсутствие ОАЭ **более чем в 4 частотных полосах** — показание к расширенному аудиологическому обследованию; подавление ОАЭ **на 4 кГц** при нормальных тональных порогах — неблагоприятный признак, показание к динамическому наблюдению.

Задержанная ОАЭ предпочтительна для скрининга работающих в шуме.

ОАЭ на частоте продукта искажения — степень повышения порогов, уточнение аудиограммы при экспертизе.

Сложные и спорные случаи: коротколатентные слуховые вызванные потенциалы — основной метод объективного определения порогов; исключение аггравации и симуляции.

Там же — ASSR-тест (вызванные ответы мозга на постоянные модулированные тоны) для объективизации порогов.

Вестибулярная функция — при жалобах на головокружение и шаткость; на медосмотре — оценка спонтанного нистагма, при возможности вестибулометрия.

3.5 Лучевая и ультразвуковая диагностика

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий — кровоснабжение внутреннего уха.

Рентгенография шейного отдела позвоночника — причины нарушения кровообращения в вертебробазилярной области.

Рентгенография околоносовых пазух — состояние пазух и слуховой трубы как сопутствующие причины.

КТ височных костей — дифференциальная и топическая диагностика, по согласованию с рентгенологом, с контрастом или без; односторонние нарушения могут скрывать двусторонний процесс (например, нейрофиброматоз II типа).

МРТ, в том числе с контрастом, — внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка.

Лечить шум в ушах и тугоухость без дифференциальной диагностики нельзя: например, при невриноме слухового нерва витамины, ноотропы и физиотерапия могут ускорить рост опухоли.

3.6 Иные диагностические исследования

Рефлексотерапевт и физиотерапевт — определить показания и противопоказания к своим методам лечения.

Физиотерапевт — показания и противопоказания к физиотерапии.

3.7 Предварительный и заключительный диагноз

Подозрение на профессиональную тугоухость
Двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость с типичной аудиограммой при условии:

1. шум на рабочем месте **до 90 дБА** — стаж **15 лет и более**;
2. шум **более 90 дБА** — стаж **10 лет и более**.

Признаки воздействия шума (Z57.0) на медосмотре — ограничений профпригодности нет; работник в группе повышенного риска, ему разрабатывают индивидуальную программу реабилитации слуха. Это донозологическое состояние, а не заболевание.

После предварительного диагноза работника **в течение 30 дней** направляют в центр профпатологии; подаётся извещение в Роспотребнадзор.

Связь с профессией после прекращения работы в шуме рассматривают, только если тугоухость документально подтверждена в период работы; появление или прогрессирование тугоухости после прекращения контакта с шумом основанием не является. Перерывы в стаже снижают вероятность прогрессирования.

Формулировки заключительного диагноза

1. признаки воздействия шума (Z57.0) — трудоспособен без ограничений;
2. I «А» степень — трудоспособен в профессии при наблюдении в центре профпатологии раз в год, разработана программа реабилитации слуха;
3. I «Б» степень — трудоспособен при наблюдении 2 раза в год, предупреждён о риске;
4. II степень и выше — работа в шуме выше 80 дБА противопоказана, направление на медико-социальную экспертизу.

---

4. Лечение

Лечение эффективно только в самых начальных стадиях — «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха, и только при устранении шума. Лечение такое же, как при нейросенсорной тугоухости непрофессионального генеза: микроциркуляция внутреннего уха, мозговая гемодинамика, оксигенация.

Курсы **не менее 10 дней**, **не реже 2 раз в год**; в группе риска — раз в год.

Работникам «шумоопасных» профессий — охранительный слуховой режим.

4.1 Медикаментозное лечение

Шум в ушах и сенсоневральная тугоухость: «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха

1. ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции;
2. периферические вазодилататоры;
3. ноотропные препараты;
4. препараты для устранения головокружения;
5. психоаналептики.

Применение вне инструкции при H83.3 допускается распоряжением Правительства № 1180-р. При II и III степени медикаментозное лечение малоэффективно.

Шум в ушах, Z57.0 или I степень — витамины группы B, дозы по инструкции.

Поддерживающие курсы — по индивидуальным показаниям с учётом соматических болезней, вместе с профильными специалистами.

4.2 Физические (нелекарственные) методы

Немедикаментозные методы значительно повышают эффективность лекарств. Все — при отсутствии противопоказаний, при шуме в ушах и потере слуха от шума.

Метод	Показания
рефлексотерапия	Z57.0 и I степень
электропунктура	Z57.0 и I степень
лазеропунктура	Z57.0 и I степень
транскраниальная электростимуляция	любая степень
магнитотерапия на шейный отдел позвоночника и сосцевидные отростки	I–II степень
УВЧ на шейный отдел позвоночника и сосцевидные отростки (УДД 4)	любая степень
дарсонвализация органа слуха	любая степень
эндауральная дарсонвализация (УДД 4)	любая степень
внутриушной электрофорез лекарственных препаратов	любая степень
плазмаферез	любая степень
лекарственный ультрафонофорез	любая степень

Метод	Показания
электрофорез синусоидальными модулированными токами (УДД 4)	шум в ушах и потеря слуха
общий медицинский массаж	любая степень
медицинский массаж шеи	любая степень
массаж воротниковой области	любая степень
гипербарическая оксигенация	начальные нарушения, усиление базисной терапии
заушные блокады с лекарственными препаратами	Z57.0 и I степень, шум в ушах и в голове

4.3 Слухопротезирование

Необратимая III степень и трудности общения — подбор слухового аппарата: цифровые аппараты, бинаурально или моноурально, вместе с лечебно-реабилитационными мероприятиями.

Хирургическое лечение при сенсоневральной тугоухости, в том числе шумовой, не показано.

4.4 Иное лечение

Лечебно-оздоровительный режим — уменьшить стресс и экстраауральные эффекты шума.

Диетическое питание индивидуально, с учётом нарушений липидного обмена; без иных показаний — стол № 10 или 15.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация медицинской помощи

Порядок

1. предварительный диагноз ставит оториноларинголог или сурдолог любой медицинской организации амбулаторно;
2. **в течение суток** — направление к профпатологу по месту жительства;
3. профпатолог подтверждает диагноз и **в 3-дневный срок** направляет извещение в Роспотребнадзор.

1. Роспотребнадзор **в 2-недельный срок** составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда;
2. профпатолог **в месячный срок** направляет пациента в учреждение профпатологии.

Документы при направлении в учреждение профпатологии

1. копия трудовой книжки;
2. выписки предварительного и периодических медосмотров;
3. результаты обследований;
4. копии аудиограмм за весь период работы в шуме;
5. санитарно-гигиеническая характеристика — всё заверено печатями.

Заключительный диагноз устанавливает врачебная комиссия учреждения профпатологии — амбулаторно или после обследования в стационаре; извещение **в 3-дневный срок** направляют в Роспотребнадзор, работодателю, страховщику и в направившую организацию.

При предварительном диагнозе показаний к госпитализации нет. Госпитализация в учреждение профпатологии — для углублённого обследования перед заключительным диагнозом.

Выписка — после решения об установлении или отсутствии заключительного диагноза.

5.2 Реабилитация

Всем работникам «шумоопасных» профессий — краткое профилактическое консультирование: причины и профилактика, средства индивидуальной защиты органа слуха, здоровый образ жизни.

Медицинская реабилитация при любой степени — разработка индивидуальной программы реабилитации слуха.

Санаторно-курортное лечение — всем работающим в шуме, в том числе без нарушений слуха: в отпуск, **не реже раза в год**, в санатории, дневном стационаре, профилактории, доме отдыха.

Объём определяют

1. терапевт, невролог, хирург;
2. медицинский психолог или психиатр;
3. офтальмолог, оториноларинголог.

Программы оздоровления составляют с учётом шума и сопутствующих факторов, класса условий труда, здоровья работника, формы и степени тугоухости.

Результат реабилитации: устранение или значительное улучшение слуха, положительная динамика аудиометрии, лучшее самочувствие.

Эффективность оздоровления оценивают по медико-социальным и экономическим показателям: заболеваемость с временной нетрудоспособностью, новые случаи профессиональной тугоухости, число профнепригодных и инвалидов.

Лечебный массаж шеи и воротниковой области — ежедневно, курс **до 10 процедур**.

Слуховой тренинг в шлеме виртуальной реальности — дополнительно при лёгкой сенсоневральной тугоухости и скрытой потере слуха: ежедневно **7 дней**, занятие **15 минут** с паузой 2 минуты.

Вестибулярные тренировки, в том числе с виртуальной реальностью: ежедневно или через день **по 30 минут**, курс **20 процедур**.

5.3 Первичная профилактика

Технические меры

1. специальная оценка условий труда;
2. снижение шума и усиливающих его факторов (вибрации, напряжения, вынужденной позы) до нормативов;
3. замена шумных технологий;
4. коллективная защита: шумозащитные панели, перегородки, потолки.

Средства индивидуальной защиты органа слуха

1. противошумные наушники;
2. вкладыши («беруши»);
3. шлемы и костюмы.

Применяют, если коллективная защита не снижает шум до нормы; работодатель предоставляет их бесплатно.

«Защита временем»

1. 10-минутные регламентированные перерывы с подменой: при высокой нагрузке — **каждые 2 часа**, при средней — **не реже чем каждые 4 часа**;
2. работа с шумом или вибрацией **не более 2/3 смены**;
3. микропаузы в шумных операциях, смена «шумоопасной» профессии на «шумобезопасную» в комплексной бригаде.

Для обоснования мер первичной профилактики — расчёт группового избыточного риска потери слуха от шума (приложение Г1 КР).

Вспомогательно: производственная гимнастика, ультрафиолетовое облучение, витамины, сбалансированное питание; отдых в комнатах психологической разгрузки.

Отдых в комнатах психологической разгрузки, домах отдыха — снятие хронического стресса от шума.

Медицинский отбор в профессию — на предварительном и периодических медосмотрах по приказу Минздрава № 29н.

5.4 Диспансерное наблюдение

Периодические медосмотры — диспансеризация трудовых коллективов; по их результатам выделяют группы динамического наблюдения.

Группы наблюдения формируют по результатам медосмотров.

Группы динамического наблюдения

Группа	Кто входит	Наблюдение
I «А»	практически здоровые: шум **не выше 90 дБА** при любом стаже или **выше 90 дБА** при стаже **до 10 лет**	медосмотр раз в год, профилактика, подбор и использование средств защиты
I «Б»	практически здоровые: шум **выше 90 дБА**, стаж **более 10 лет**	как I «А» + массаж воротниковой зоны 2 раза в год, рефлексотерапия раз в год

Группа	Кто входит	Наблюдение
II	признаки воздействия шума на орган слуха (Z57.0)	как I «Б» + гипербарическая оксигенация, лекарства, санаторно-курортное лечение раз в год
III «А»	потеря слуха от шума I «А» степени	трудоспособен; центр профпатологии раз в год, программа реабилитации, лекарства и немедикаментозное лечение, санаторий раз в год
III «Б»	I «Б» степень: в сочетании с гипертонической болезнью или хронической ишемией мозга 2 степени и выше	как III «А» + лечение сосудистой патологии; курс и центр профпатологии 2 раза в год
III «В»	II степень и выше (H83.3, H90.3) любой этиологии	непригоден к работе в шуме, медико-социальная экспертиза; наблюдение по месту жительства 2 раза в год

При хронической сенсоневральной тугоухости любой степени — индивидуальная программа реабилитации слуха; разрабатывает и контролирует оториноларинголог или сурдолог-оториноларинголог.

5.5 Факторы, влияющие на исход

Сердечно-сосудистые болезни и нарушения липидного обмена усиливают действие шума: тугоухость развивается быстрее, пороги на высоких частотах выше, типичные аудиологические признаки стираются. Шум может вызвать соматизированное депрессивное расстройство.

Усиливают вред шума

1. стрельба, охота, громкая музыка, особенно в наушниках;
2. алкоголь, курение, наркотики;
3. лечение аминогликозидами в анамнезе;
4. глухота у близких родственников;
5. травмы головы.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Потеря слуха, вызванная шумом»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 15.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее марта 2027 года
Код в рубрикаторе	`609_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Национальная медицинская ассоциация сурдологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Липиды противоречат друг другу: в разделе 1.2 при действии шума снижены ЛПВП, в критериях диагноза (раздел 2) — «повышены» общий холестерин, ЛПВП и ЛПНП.

- Стаж для подозрения на профессиональную тугоухость указан по-разному: «10 и более лет» (раздел 2), «более 8–10 лет» (раздел 2.1), 15 лет при шуме до 90 дБА и 10 лет при шуме выше 90 дБА (приложение Б).
- Для группы III «А» немедикаментозное лечение отсылает к разделу 3.2, но там хирургическое лечение (не рекомендуется); немедикаментозные методы — раздел 3.1.2.
- PDF в рубрикаторе — распознанный скан: в цитатах журнала сверки встречаются ошибки распознавания (например, «257.0» вместо Z57.0, «81-81» вместо Si-Si). Цифры таблиц сверены по изображениям страниц.

Клинические рекомендации

РСВ-инфекция у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J04.1** — Острый трахеит **J04.2** — Острый ларинготрахеит **J06.0** — Острый ларингофарингит **J20.5** — Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом **J21.0** — Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 12.09.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общественная организация "Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины"; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/943_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Острая вирусная инфекция с умеренной лихорадкой и интоксикацией и частым поражением нижних дыхательных путей: бронхит, бронхиолит, пневмония, бронхиальная обструкция, дыхательная недостаточность.
- С ринитом, особенно при лихорадке, — отоскопия: острый средний отит частый, развивается преимущественно в первые дни. При подозрении на отит или синусит — осмотр оториноларинголога.
- Тяжесть определяет дыхательная недостаточность, а не температура. Сатурация **ниже 92%**, нарастание дыхательной недостаточности или судороги — осмотр реаниматолога.
- Лечение лёгкой и среднетяжёлой формы — как при ОРВИ. При неосложнённом бронхиолите антибиотики, ингаляционные бронхолитики и кортикостероиды рутинно не назначают.
- Бронхиолит, пневмония, дыхательная недостаточность, тяжёлый преморбидный фон — госпитализация в инфекционный стационар с реанимацией.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острое респираторное вирусное заболевание с катаральным синдромом и преимущественным поражением нижних дыхательных путей, умеренной лихорадкой и интоксикацией; часто бронхит, бронхиолит, пневмония, нередко острая бронхиальная обструкция и дыхательная недостаточность.

2.2 Этиология и патогенез

Возбудитель — РНК-вирус семейства Paramyxoviridae, рода Pneumovirus; один серотип, подтипы A и B по тяжести не различаются.

Наибольшие изменения — в бронхах среднего и мелкого калибра, бронхиолах и альвеолах: просвет заполняют слущенный эпителий и экссудат, клапанный механизм задерживает воздух, при полной обструкции — ателектазы. Отёк слизистой мелких бронхов у ребёнка всего **на 1 мм** повышает сопротивление потоку **более чем на 50%**.

Высоко контагиозна; инкубационный период **3–5 дней**, до 8. Путь передачи — воздушно-капельный и контактный. Иммунитет нестойкий: повторно болеют даже в течение одного сезона, реинфекция легче. Вирус выделяется в среднем **10–14 дней**.

Группа риска тяжёлого течения

1. недоношенные с массой тела **2,5 кг и меньше**;
2. бронхолёгочная дисплазия;
3. врождённые пороки сердца;
4. после трансплантации органов, системные и хронические заболевания.

2.3 Классификация

1. по тяжести: лёгкая, среднетяжёлая, тяжёлая;
2. по течению: гладкое, негладкое (осложнённое);
3. по симптомам: типичная, атипичная (бессимптомная);
4. по локализации: ринит, фарингит, трахеит, ларингит, бронхит, бронхиолит, пневмония и их сочетания.

2.4 Клиническая картина

Начало острое или постепенное, тяжесть нарастает. Температура субфебрильная или нормальная, реже фебрильная; интоксикация умеренная. Катаральные явления умеренные: необильный серозный ринит и фарингит, возможен ларинготрахеит.

У детей **старше 6 лет** и взрослых обычно лёгкое течение с поражением только верхних дыхательных путей.

У детей раннего возраста начинается с ринофарингита, **на 2–3-й день** — бронхит и бронхиолит с бронхиальной обструкцией: экспираторная одышка, втяжение межреберий, приступообразный мучительный кашель.

Аускультация

1. бронхит: на фоне жёсткого дыхания сухие свистящие, у части — влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы;
2. бронхиолит: обильные мелкопузырчатые влажные и крепитирующие хрипы, коробочный звук.

Степени тяжести

Тяжесть	Признаки
лёгкая	температура **не выше 38,5 °C**, интоксикация и катар слабые; нижние дыхательные пути обычно не поражены; чаще дети **старше 3 лет**
среднетяжёлая	**86–90%** случаев, чаще первые годы жизни: ринит, фарингит, ларингит, трахеит, возможен стенозирующий ларинготрахеит; бронхит с обструкцией или бронхиолит, дыхательная недостаточность I–II степени; обратное развитие **через 5–7 дней**
тяжёлая	чаще первый год жизни: вялость, шумное свистящее дыхание, бледность, цианоз, одышка **более 80 в минуту** с участием вспомогательных мышц; обструктивный бронхит, бронхиолит или бронхопневмония с дыхательной недостаточностью II–III; у недоношенных возможна гипотермия

При тяжёлой форме сатурация **ниже 90%**; возможны брадипноэ, апноэ, кардиопульмональная синкопа. Тяжесть поражения нижних дыхательных путей не соответствует выраженности лихорадки: ориентируются на дыхательную недостаточность.

Степени дыхательной недостаточности

Степень	Признаки
I	одышка, тахикардия, раздувание крыльев носа при значительной нагрузке
II	одышка и тахикардия при небольшой нагрузке, небольшой цианоз губ, втяжение межреберий и подреберий
III	одышка и тахипноэ в покое, разлитой цианоз, вспомогательные мышцы; SaO_2 **ниже 90%**, PaO_2 **ниже 60 мм рт. ст.**; возможны гипоксическая энцефалопатия и кардиопульмональная синкопа
IV	гипоксемическая кома: сознания нет, дыхание аритмичное, поверхностное, апноэ

3. Диагностика

Диагноз РСВ-инфекции ставят после этиологической диагностики (ПЦР, иммуноферментный анализ); без неё — синдромальный диагноз. Лабораторная диагностика обычно — при госпитализации или по эпидемическим показаниям.

Основные методы: ОТ-ПЦР на РНК вируса, иммунофлюоресценция и иммунохроматография на вирусные частицы, иммуноферментный анализ на IgM и IgG.

Всем — оценка дыхательной недостаточности: участие вспомогательной мускулатуры, частота дыхания.

3.1 Этиологическая диагностика

При подозрении — однократно ПЦР мазка из носоглотки на РНК РСВ: достоверна на ранних сроках, специфичность и чувствительность 100%.

Для дифференциальной диагностики — ПЦР мазков из носо- и ротоглотки на грипп, парагрипп, риновирусы, аденовирус, коронавирусы, бокавирус, метапневмовирус, SARS-CoV-2: возможна смешанная инфекция.

Если ПЦР невозможна или поздний срок — IgM и IgG к РСВ методом ИФА.

Оценка результата

1. IgM появляются **на 4–5-й день**;
2. диагноз подтверждает и нарастание IgG **в 2–4 раза** в парных сыворотках;
3. однократно выявленные IgG об острой инфекции не говорят;
4. **10–30%** переболевших остаются серонегативными.

Без ПЦР и ИФА — иммунохроматографический экспресс-тест мазка из носоглотки: результат **через 15–30 минут**, чувствительность 75–95%; отрицательный результат подтверждают более чувствительным методом.

Реакция иммунофлюоресценции мазка из носоглотки — если молекулярно-генетическое исследование невозможно.

Иммуноцитохимия мазков-соскобов из ротоглотки — если молекулярно-генетическое исследование невозможно.

3.2 Анализы крови и мочи

Среднетяжёлая и тяжёлая форма, длительная лихорадка — развёрнутый общий анализ крови. Для вирусной инфекции типичны лейкопения или нормоцитоз с лимфоцитозом и моноцитозом, но возможны и изменения как при бактериальной.

Среднетяжёлая и тяжёлая форма — общий анализ мочи: при лихорадке на фоне бронхиолита возможна «токсическая почка» или инфекция мочевых путей.

Подозрение на бактериальную инфекцию и сепсис — С-реактивный белок или прокальцитонин. Посев крови и мочи, СРБ и прокальцитонин — при высокой лихорадке со SpO_2 **ниже 92%** и апноэ; в остальных случаях бактериемия при бронхиолите крайне маловероятна.

3.3 Инструментальная диагностика

Поражение нижних дыхательных путей — пульсоксиметрия: степень тяжести, кислородная поддержка, маршрутизация.

Среднетяжёлое и тяжёлое поражение нижних дыхательных путей — ЭКГ: фоновая патология сердца, подозрение на аритмию, миокардит; SaO_2 **ниже 95%**.

Подозрение на пневмонию — рентгенография грудной клетки: температура **выше 38 °C** **более 3 дней**, токсикоз, укорочение перкуторного звука, асимметрия хрипов.

Рутинная рентгенография при бронхиолите не рекомендуется: ателектазы принимают за пневмонию и необоснованно назначают антибиотики.

Тяжёлое течение, если рентгенографии недостаточно, — КТ органов грудной полости.

3.4 Консультации

Подозрение на отит или синусит — осмотр оториноларинголога. Ринит, особенно с лихорадкой, — отоскопия: острый средний отит частый, ЛОР-осложнения — преимущественно в первые дни, но возможны и позже.

Нарастание дыхательной недостаточности, сатурация **ниже 92%**, судороги — осмотр анестезиолога-реаниматолога для решения о переводе в реанимацию.

3.5 Дифференциальная диагностика бронхиальной обструкции

Дифференциальная диагностика

Диагноз	В пользу диагноза
острый бронхиолит	первый эпизод обструкции **до 2 лет**, сезон вирусов, катар, выраженная одышка, диффузная крепитация и хрипы, слабый ответ на бронхолитики
обструктивный бронхит	обструкция только при простуде, нет атопии у ребёнка и в семье, возможен ответ на бронхолитики
бронхиальная астма	первый эпизод **после 1 года**, аллергены и другие триггеры, атопия, повторные эпизоды и вне простуды, хороший ответ на бронхолитики и ингаляционные ГКС
инородное тело дыхательных путей	внезапное начало во время еды или игры с мелкими предметами, хрипы с одной стороны, нет ответа на бронхолитики
пневмония	лихорадка, влажный кашель, локальные хрипы, притупление, инфильтрат на рентгенограмме, лейкоцитоз, повышение СРБ
муковисцидоз	хроническая инфекция лёгких, кишечные проявления, полипы носа, солёная кожа, отставание в развитии
коклюш	приступообразный кашель с репризами и рвотой, апноэ, нет лихорадки и катара, лимфоцитарный лейкоцитоз

---

4. Лечение

Лёгкая и среднетяжёлая форма без осложнений — амбулаторно, по общим принципам лечения ОРВИ. Специфической этиотропной терапии нет; лечение начинают с первых симптомов.

4.1 Противовирусная терапия

Дети раннего возраста, в том числе с рождения, с поражением нижних дыхательных путей — интерферон альфа-2b. Эффективнее всего **в первые 3 суток**; при бронхиолите — вспомогательно.

Лекарственные формы интерферона

1. местно: спрей, капли в нос, гель, мазь;
2. системно: свечи.

4.2 Бронхиолит

Неосложнённый бронхиолит — без антибиотиков.

Дегидратация при одышке и поражении нижних дыхательных путей — регидратация.

1. прежде всего перорально;
2. при невозможности — через назогастральный зонд;
3. внутривенно — при эксикозе II–III степени: 0,9% натрия хлорид или натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид), **не более 20 мл/кг/сут** из-за риска отёка лёгких.

Рутинно не применяют при бронхиолите

1. ингаляционные бронхолитики (адреномиметики);
2. ингаляционный будесонид;
3. системные кортикостероиды.

Системные кортикостероиды при бронхиолите — нет убедительных данных об эффективности (УУР B, УДД 2).

Ингаляционный будесонид — нет убедительных данных об эффективности.

4.3 Симптоматическая терапия

Температура **выше 38,5 °C** — парацетамол или ибупрофен по инструкции; при судорогах в анамнезе или на фоне болезни — снижать и при меньшей температуре.

Дети первого года с субфебрилитетом **37,5–38,5 °C**, нарушением самочувствия и сна — гомеопатический Вибуркол, ректальные свечи, по инструкции.

4.4 Кислород

Бронхиолит или дыхательная недостаточность — увлажнённый кислород через носовые канюли или маску при SaO_2 **ниже 92–94%**, до устойчивых **95%**. Тяжёлый бронхиолит, выраженная гипоксия, апноэ — CPAP.

Амбулаторно — местные средства по симптомам: полоскания, тёплое питьё, ингаляции, таблетки для рассасывания, физиотерапия.

Хирургическое лечение не показано.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация

1. среднетяжёлая и тяжёлая форма, особенно с осложнениями или обострением сопутствующих болезней у детей первых 2 лет, а у старших — с обострением болезней сердца и лёгких;
2. бронхиолит или пневмония с обструкцией у новорождённых, особенно недоношенных **2,5 кг и меньше**;
3. гемодинамическая нестабильность: холодные конечности, цианоз, мраморность, коллапс, кома;
4. тяжёлый преморбидный фон: пороки лёгких, бронхолёгочная дисплазия, пороки сердца, муковисцидоз, бронхиальная астма, трансплантация.

Чем младше ребёнок, тем шире показания: состояние может ухудшиться катастрофически быстро. Госпитализируют в инфекционный стационар с реанимацией.

Выписка — при стабилизации, купировании дыхательной недостаточности и интоксикации.

5.2 Факторы риска тяжёлого бронхиолита

1. мужской пол;
2. недоношенность, масса при рождении **менее 2500 г**;
3. возраст **до 3–6 месяцев**, масса **менее 5 кг**;
4. врождённая пневмония, аспирация мекония, ИВЛ в неонатальном периоде;
5. скученность, старшие братья и сёстры в детских коллективах, пассивное курение;
6. бронхолёгочная дисплазия, муковисцидоз, пороки дыхательных путей;
7. тяжёлые поражения ЦНС, синдром Дауна, нервно-мышечные болезни, аспирация пищи;
8. пороки сердца с сердечной недостаточностью или лёгочной гипертензией;
9. иммунодефициты.

5.3 Профилактика

Как при ОРВИ: ограничение контактов, маски, мытьё рук; в стационаре — профилактика внутрибольничного заражения. Грудное вскармливание **не менее 6 месяцев** защищает от РСВ.

Паливизумаб — группы риска

1. дети **до 6 месяцев**, рождённые на **35-й неделе** и раньше;
2. дети **до 2 лет**, лечившиеся по поводу бронхолёгочной дисплазии в последние 6 месяцев;
3. дети **до 2 лет** с гемодинамически значимыми пороками сердца.

Дозы — по инструкции.

Специальной реабилитации нет: без поражения мелких бронхов дети восстанавливаются сами; при осложнениях — реабилитация по осложнению.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 12.09.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2028 года
Код в рубрикаторе	`943_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Инкубационный период указан по-разному: 3–5 (до 8) дней в разделах 1.3 и 1.6, 2–4 дня в комментарии раздела 2.3. Длительность выделения вируса — 10–14 дней (раздел 1.3) и 5–7 дней (раздел 2.3).
- Гомеопатический Вибуркол рекомендован детям первого года (УУР С, УДД 3), тогда как КР «ОРВИ у детей» гомеопатию для лечения ОРВИ не рекомендуют.

Клинические рекомендации

Рак гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C32** — Злокачественное новообразование гортани **D38.0** — Гортани
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/475_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак гортани — злокачественная опухоль из элементов неороговевающего эпителия гортани. Основные симптомы — изменение тембра голоса, осиплость, поперхивания.
- Заподозрить рак: стойкая осиплость; кашель и боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения; затруднение дыхания; увеличение шейных лимфоузлов, образования на шее.
- Предопухолевые заболевания: хронический гиперпластический ларингит, пахидермия, лейкоплакия, дисплазия и гиперкератоз слизистой оболочки, полипы голосовых складок, папилломатоз гортани.
- Всем с подозрением на рак гортани — фиброларингоскопия с биопсией; при повторных неинформативных биопсиях — видеофиброларингоскопия с биопсией под общей анестезией.
- При подозрении на онкологическое заболевание пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет); консультация — **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. **надскладочный отдел** — гортанная поверхность надгортанника (включая верхушку), черпалонадгортанные связки, черпаловидные хрящи и межчерпаловидная область, часть надгортанника ниже подъязычной кости, вестибулярные складки, гортанные желудочки
2. **складочный отдел** — голосовые складки, передняя и задняя комиссуры
3. **подскладочный отдел** — от нижней поверхности голосовых складок до уровня первого кольца трахеи

Голосовой протез — клапанное устройство для восстановления голоса, имплантируемое при трахеопищеводном шунтировании. Электрогортань — вибрирующий аппарат, прикладываемый к подбородку; голос металлический, без тембровой и эмоциональной окраски.

2.2 Этиология и эпидемиология

Факторы риска: длительное курение, алкоголь, запылённость (текстильное производство), канцерогены (нефть и продукты перегонки, бензол, фенольные смолы, асбест). Высокий риск озлокачествления — при папилломах (рак, ассоциированный с ВПЧ), рецидивирующем папилломатозе, пахидермии, дискератозе, хронических ларингитах.

Заболеваемость в России в 2019 г. — 31,1 на 100 тыс. населения, летальность — 7,2%.

2.3 Клиническая картина

1. **вестибулярный (надскладочный) отдел** — на ранних стадиях может протекать бессимптомно; парестезия, сухость, ощущение инородного тела, неудобство при глотании; позже боль при глотании с иррадиацией в ухо, дисфагия, гнилостный запах, кровохарканье
2. **голосовой (складочный) отдел** — рано — охриплость, кашель, реже кровохарканье; при прогрессировании — стеноз, боль с иррадиацией в ухо, гнилостный запах
3. **подскладочный отдел** — раннее затруднение дыхания

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC)

Символ T: складочный отдел гортани

T	Складочный отдел
T1	опухоль ограничена голосовыми связками, подвижность сохранена (может быть вовлечена передняя или задняя комиссура); T1a — одна связка, T1b — обе
T2	распространение на надсвязочную и (или) подсвязочную области с нарушением подвижности голосовых связок
T3	ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок и (или) прорастанием в надсвязочное пространство, небольшой эрозией щитовидного хряща
T4a / T4b	T4a — прорастание в щитовидный хрящ или ткани вокруг гортани (трахея, мягкие ткани шеи, мышцы языка, щитовидная железа, пищевод); T4b — предпозвоночное пространство, средостение, оболочка сонной артерии

Символ T: надскладочный отдел гортани

T	Надскладочный отдел
T1	ограничена одной анатомической областью надсвязочной части, подвижность голосовых связок сохранена
T2	несколько анатомических частей надсвязочной или связочной области либо вненадсвязочная часть (корень языка, валлекула, медиальная стенка грушевидного синуса) без фиксации гортани
T3	ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок и (или) распространением на преднадгортанную ткань, минимальная эрозия щитовидного хряща

Подскладочный отдел: T1 — ограничена подсвязочной частью; T2 — распространение на голосовые связки со свободной или ограниченной подвижностью; T3 — фиксация связок и (или) эрозия щитовидного хряща; T4a — прорастание в перстневидный или щитовидный хрящ, ткани вокруг гортани.

1. **N1** — метастаз в одном ипсилатеральном лимфоузле до 3 см без экстракапсулярной инвазии (ENE−)
2. **N2** — один ипсилатеральный до 3 см с ENE+ или 3–6 см ENE−; несколько ипсилатеральных; с обеих сторон или контралатеральные до 6 см ENE−
3. **N3** — более 6 см ENE−; любой метастаз с ENE+ кроме N2a

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4 N0–N2 M0
IVB	T4b, любая N, M0; любая T, N3, M0
IVC	любая T, любая N, M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования соскоба, мазков, пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: фиброларингоскопия, пункция узлов шеи под УЗИ, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ.

3.2 Жалобы и анамнез

Симптомы, на которые обращают внимание

1. стойкое нарушение голоса (осиплость), реже кашель;
2. затруднение дыхания при перекрытии просвета гортани;
3. постоянный кашель и боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения;
4. увеличение шейных лимфоузлов, образования на шее.

3.3 Осмотр и пальпация шеи

Признаки при осмотре

1. изменение контуров шеи;
2. увеличение регионарных лимфоузлов;
3. изменение подвижности и ширины остова гортани.

3.4 Фиброларингоскопия с биопсией

Всем с подозрением на рак гортани — фиброларингоскопия с биопсией (патологоанатомическое исследование) и цитологией отпечатков и мазков для оценки распространённости и верификации опухоли.

При повторных неинформативных биопсиях и клинико-рентгенологических данных о злокачественном процессе — видеофиброларингоскопия с биопсией под общей анестезией.

3.5 УЗИ шеи, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ

Всем при раке гортани — УЗИ лимфоузлов шеи с пункцией подозрительных узлов.

При распространённом раке с поражением регионарных лимфоузлов — КТ органов грудной полости для выявления отдалённых метастазов.

При стадиях III–IV — ПЭТ-КТ с ФДГ для исключения отдалённых метастазов и оценки эффекта лечения, в том числе регрессии регионарных метастазов после лучевой или химиолучевой терапии.

При подозрении на распространение на хрящи гортани, основание черепа, магистральные сосуды — КТ или МРТ мягких тканей шеи и головного мозга с контрастированием; при подозрении на переход на гортаноглотку или пищевод перед ЛТ — МРТ шеи.

3.6 Лабораторные и морфологические исследования

Специфических лабораторных исследований нет. При распространённых стадиях, не предусматривающих только локальное лечение, — экспрессия PD-L1 (TPS, CPS).

В заключении по операционному материалу отражают

1. размер и глубину инвазии опухоли;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
4. pT и pN с числом исследованных и поражённых лимфоузлов, экстранодальное распространение;
5. состояние краёв резекции.

---

4. Лечение

4.1 Складочный отдел гортани

Лечение рака складочного отдела гортани по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
Tis (карцинома in situ)	эндоларингеальная резекция (предпочтительно CO_2-лазером) или ЛТ
T1–T2 N0	самостоятельная ЛТ или резекция гортани (эндоскопическая лазерная или открытая)
T1–T2 N+	конкурентная ХЛТ или резекция гортани с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией
T3 N0	конкурентная ХЛТ; индукционная ХТ для сохранения органа; ларингэктомия с гемитиреоидэктомией и паратрахеальной лимфодиссекцией
T3 N+	одномоментная ХЛТ; индукционная ХТ с последующей ХЛТ; ларингэктомия с шейной лимфаденэктомией
T4a, любая N	ларингэктомия с тиреоидэктомией, паратрахеальной и шейной лимфодиссекцией; при отказе от операции — ХЛТ или индукционная ПХТ с ХЛТ

После операции тактику определяют по неблагоприятным прогностическим факторам (НПФ). Нет НПФ и pN0 — наблюдение.

1. **R1** — перезекция, при невозможности — ЛТ или ХЛТ
2. **1 НПФ (периневральная, периваскулярная, перилимфатическая инвазия)** — ЛТ
3. **2 и более НПФ, pN2** — ХЛТ
4. **ENE+** — конкурентная ХЛТ

1. **полная или частичная регрессия после индукционной ХТ** — ЛТ или ХЛТ
2. **стабилизация или регрессия менее 50%** — операция
3. **остаточная опухоль после ЛТ или ХЛТ** — операция
4. **полная регрессия** — динамическое наблюдение

Эффект ХЛТ оценивают не ранее чем через 2–3 месяца.

1. **T4b, неоперабельные метастазы, M1 при ECOG 0–1** — лекарственная терапия (в отдельных случаях ХЛТ) или симптоматическое лечение
2. **ECOG 2** — лекарственная терапия
3. **ECOG 3** — симптоматическое лечение

4.2 Надскладочный отдел гортани

Лечение рака надскладочного отдела гортани по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
T1–T2 N0–1	резекция гортани (эндоскопическая или открытая) с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией; при N0 — также самостоятельная ЛТ
T1–T2 N2–3	одномоментная ХЛТ, индукционная ХТ с ХЛТ или резекция гортани с шейной лимфодиссекцией
T3 N0–3	одномоментная ХЛТ или индукционная ХТ с ХЛТ; ларингэктомия с тиреоидэктомией и шейной лимфодиссекцией
T4a N0–3	ларингэктомия с тиреоидэктомией и шейной лимфодиссекцией с послеоперационной ХЛТ; при отказе — ХЛТ или индукционная ПХТ с ХЛТ

При раке надскладочного отдела без клинических признаков поражения лимфоузлов всем рекомендуется профилактическая одно- или двусторонняя шейная лимфодиссекция II–IV уровней.

Удаление узлов II–V уровней

1. метастазы в лимфоузлах IV или V уровня;
2. регионарный метастаз более 6 см;
3. множественные метастазы более 3 см;
4. экстракапсулярное распространение;
5. регионарный рецидив.

1. **рецидив без предшествующей ЛТ** — операция при резектабельности; при ECOG 0–1 — ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; нерезектабельный при ECOG 2 — паллиативная ЛТ или лекарственная терапия
2. **рецидив после ЛТ** — операция при резектабельности с обсуждением повторной ЛТ или ХЛТ
3. **рецидив с отдалёнными метастазами** — ECOG 0–1 — лекарственная терапия; ECOG 2 — лекарственная; ECOG 3 — симптоматическое лечение

4.3 Лучевая и лекарственная терапия

Самостоятельная ЛТ: на опухоль и регионарные метастазы 66–70 Гр (2,0–2,2 Гр за фракцию) **6–7 недель**, на зоны регионарного метастазирования 44–63 Гр. При T1N0M0 голосового отдела возможно гипофракционирование 50–55 Гр.

При ХЛТ — 70 Гр за 7 недель; стандарт — цисплатин 100 мг/м² в 1, 22 и 43-й дни ЛТ; альтернатива — карбоплатин или цетуксимаб (СКФ менее 50–60 мл/мин, возраст старше 65 лет, ECOG более 1).

Послеоперационная ЛТ показана при pT3–4 и N0–1, у отдельных пациентов с pT1–2. Интервал после операции — **до 6 недель**, **не более 3 месяцев**. Доза при R0 — 60 Гр, при R+ — 66 Гр.

Показания к послеоперационной ХЛТ

1. прорастание капсулы лимфоузла;
2. положительный край резекции при отказе от реоперации;
3. 2 и более неблагоприятных фактора.

Лекарственная терапия плоскоклеточного рака индивидуализируется: схемы на основе препаратов платины, фторурацила, таксанов и цетуксимаба; иммунотерапия ниволумабом или пембролизумабом (с учётом PD-L1); при ECOG 2 — монотерапия. Режимы и дозы — таблица 1 КР.

При местно-распространённом раке оценивают риск кровотечения (изъязвление, близость ветвей сонной артерии, состоявшееся кровотечение); при риске — ангиография и суперселективная эмболизация сосудов опухоли.

4.4 Медицинская реабилитация

До и в раннем послеоперационном периоде всем пациентам — логопедические занятия при дисфагии и обучение речи.

Методы восстановления голоса

1. пищеводный голос;
2. трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезом;
3. электронные голосообразующие аппараты (электрогортань).

Активную тренировку не проводят в раннем послеоперационном периоде, на этапе заживления и при свищах.

Всем до начала лечения — профилактическая гимнастика и занятия при дисфагии для уменьшения нарушений глотания.

Всем — нутритивная поддержка **не менее 7 суток**. Показания перед операцией: потеря 10% массы за 6 месяцев, ИМТ менее 20, белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л, ухудшение питания за последнюю неделю.

При невозможности питаться через рот — назогастральный зонд (на срок **до 3–4 недель**) или гастростома.

Всем перед ЛТ или ХЛТ — консультация и сопровождение стоматолога; удаление зубов в облучённой зоне — только при необходимости и на фоне антибиотиков (риск лучевого остеомиелита).

Профилактика и лечение мукозита на фоне ХЛТ — низкоинтенсивная лазеротерапия; при болевом синдроме — консультация альголога.

На фоне лекарственной и химиолучевой терапии — лечебная физкультура (аэробные упражнения и упражнения на сопротивление, тренировка баланса при полинейропатии).

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Частота наблюдения после лечения

1. 1-й год — **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год — **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5 лет — **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет — 1 раз в год или при жалобах.

Объём обследования

1. анамнез и осмотр, фиброларингоскопия;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
3. рентгенография грудной клетки каждые 12 месяцев, КТ и МРТ по показаниям;
4. ПЭТ-КТ после индукционной ХТ — **не ранее чем через 2–3 месяца**;
5. ТТГ каждые 6–12 месяцев (функция щитовидной железы).

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация — **не позднее 5 рабочих дней**, патологоанатомическое исследование — **не более 15 рабочих дней**. Тактику лечения определяет онкологический консилиум.

1. **экстренная госпитализация** — осложнения заболевания или лечения, требующие специализированной помощи
2. **плановая** — сложные интервенционные диагностические вмешательства, специализированное противоопухолевое лечение

Факторы прогноза

1. размер и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
5. индекс Ki-67, статус краёв резекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак гортани»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 14.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года (по тексту КР)
Код в рубрикаторе	475_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 «Группировка по стадиям» в стадии IVA указано «T4 N0, N1, N2», тогда как T4b относится к стадии IVB; в IVA должна входить только T4a.

Клинические рекомендации

Рак носоглотки

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C11** — Злокачественное новообразование носоглотки
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/535_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак носоглотки — злокачественная опухоль, развивающаяся из неороговевающего эпителия носоглотки.
- Начальные проявления в большинстве случаев скрываются под маской ОРВИ, ринофарингита, аденоидных вегетаций; нередко первым признаком становятся увеличенные лимфоузлы шеи.
- Повод заподозрить опухоль — затруднение носового дыхания, гнусавость, заложенность или пощёлкивание в ухе, снижение слуха, образование на шее.
- Диагноз подтверждает эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки с биопсией; распространённость оценивают по МРТ (предпочтительно) или КТ лицевого отдела черепа и шеи.
- Основным методом радикального лечения является лучевая или химиолучевая терапия.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Стенки носоглотки

1. **верхняя** — основная кость, часть затылочной кости;
2. **задняя** — I и II шейные позвонки;
3. **передняя** — хоаны;
4. **боковые** — глоточные отверстия слуховых труб;
5. **нижняя** — твёрдое нёбо.

Оценка эффекта лечения

1. **полный эффект** — отсутствие признаков опухоли по данным лабораторных и инструментальных методов;
2. **частичная регрессия** — сокращение опухолевых очагов более чем на 50% при отсутствии новых;
3. **прогрессирование** — новый очаг и (или) рост первичного или метастатических очагов более чем на 25%.

2.2 Этиология

Этиологические факторы

1. инфицирование вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ);
2. хронические воспалительные процессы, вызывающие гиперплазию и метаплазию слизистой оболочки носоглотки;
3. анатомические особенности некоторых рас: более высокая заболеваемость у народов Юго-Восточной Азии, Африки, Индокитая.

Канцерогенные факторы

1. курение, в том числе пассивное;
2. контакт с асбестом, древесной пылью, продуктами нефтепереработки;
3. ионизирующее излучение;
4. вирус Эпштейна — Барр.

Заболеваемость раком носоглотки в России в 2023 г. составила 0,36 на 100 тыс. населения; у мужчин — 0,53, у женщин — 0,2 на 100 тыс.

2.3 Клиническая картина

Клиническая картина складывается из местных симптомов, признаков регионарного и отдалённого метастазирования, общего опухолевого симптомокомплекса. Начальные проявления в большинстве случаев маскируются под ОРВИ, ринофарингит, аденоидные вегетации; нередко к врачу заставляют обратиться увеличенные лимфоузлы шеи.

На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно; симптомы зависят от локализации опухоли и направления её роста.

Первичные симптомы

1. прогрессирующее затруднение носового дыхания, гнусавость;
2. пощёлкивание или заложенность уха, снижение слуха, боль в ухе;
3. головная боль, кровотечения;
4. экзофтальм, птоз, косоглазие;
5. тризм жевательной мускулатуры, расстройство глотания и фонации;
6. провисание мягкого нёба, неподвижность половины гортани, отклонение языка в сторону;
7. образования на шее.

2.4 Гистологические варианты

Среди злокачественных опухолей носоглотки преобладают эпителиальные; рак составляет около 70%.

Гистологические варианты рака носоглотки

1. плоскоклеточный ороговевающий рак;
2. плоскоклеточный неороговевающий рак (дифференцированный и недифференцированный);
3. базалоидный вариант плоскоклеточного рака.

2.5 Классификация TNM (8-е издание)

Символ T

T	Первичная опухоль
T0	первичная опухоль не определяется, но имеется поражение регионарных лимфоузлов, связанное с ВЭБ
Tis	преинвазивная карцинома
T1	в пределах носоглотки или с распространением в ротоглотку или полость носа без распространения в парафарингеальное пространство
T2	распространение в парафарингеальное пространство
T3	распространение на основание черепа и (или) придаточные пазухи носа
T4	интракраниальное распространение и (или) поражение черепных нервов, распространение в орбиту, подвисочную ямку, жевательное пространство

1. **N1** — метастазы в шейных лимфоузлах выше надключичной ямки на стороне поражения не более 6 см и (или) одно- или двусторонние ретрофарингеальные не более 6 см;
2. **N2** — двусторонние метастазы в шейных лимфоузлах выше надключичной ямки до 6 см;
3. **N3** — метастазы более 6 см и (или) ниже нижнего края перстневидного хряща.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
0 / I / II / III	TisN0 / T1N0 / T0–T1N1, T2N0–N1 / T0–T2N2, T3N0–N2

Стадия	TNM
IVA / IVB / IVC	T4N0–N2 / любая T N3 / M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнестических данных;
2. клинической картины и осмотра с пальпацией регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования отделяемого верхних дыхательных путей, отпечатков, пунктата увеличенных лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: фиброларингоскопия, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ по показаниям;
6. определения ДНК вируса Эпштейна — Барр.

3.2 Жалобы и анамнез

Всем с подозрением на рак носоглотки — тщательный сбор жалоб и анамнеза; стаж курения оценивают в пачка-летах.

Факторы риска

1. курение, употребление крепких спиртных напитков;
2. производственные вредности;
3. хроническая инфекция: хронический фарингит, отит, ринит, вирус Эпштейна — Барр.

3.3 Передняя и задняя риноскопия

При подозрении на рак носоглотки — передняя и задняя риноскопия, пальпация регионарных лимфоузлов, оценка нутритивного статуса.

3.4 ДНК вируса Эпштейна — Барр в крови

Всем с раком носоглотки или подозрением на него — количественное определение ДНК ВЭБ методом ПЦР в периферической крови для верификации опухоли и оценки эффекта лечения.

ДНК ВЭБ методом ПЦР в реальном времени выявлена у 96% пациентов с раком носоглотки и у 7% здоровых. Высокий исходный или сохраняющийся к концу ЛТ уровень ДНК ВЭБ связан с неблагоприятным прогнозом.

3.5 Эндоскопическая эндоназальная ревизия носоглотки

Всем с подозрением на рак носоглотки — эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки с биопсией и мазками-отпечатками с поверхности эрозий и изъязвлений, пункцией уплотнений без изъязвления.

3.6 УЗИ лимфатических узлов шеи

Всем — УЗИ лимфоузлов шеи с обеих сторон с пункцией подозрительных узлов для цитологического и патологоанатомического исследования.

При подозрении на метастазы в лимфоузлах шеи — цитологическое исследование материала тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем УЗИ.

3.7 МРТ и КТ лицевого отдела черепа и шеи

Всем для оценки распространённости опухоли — КТ лицевого отдела черепа с болюсным контрастированием и (или) МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием. Предпочтительна МРТ; КТ дополняет её при опухоли у основания черепа для оценки костной деструкции.

Зона исследования шеи — от основания черепа до верхней апертуры грудной клетки, при поражении лимфоузлов ниже перстневидного хряща — до бифуркации трахеи. При большом интракраниальном компоненте дополнительно выполняют МРТ головного мозга.

Для планирования ЛТ — МРТ лицевого отдела черепа с контрастированием; КТ с болюсным контрастированием — для оценки распространения на кости основания черепа. При невозможности МРТ выполняют КТ или ПЭТ-КТ.

3.8 КТ органов грудной полости и ПЭТ-КТ

Стадирование

1. КТ органов грудной полости; при невозможности — прицельная рентгенография органов грудной клетки;
2. ПЭТ-КТ с ФДГ — при местно-распространённом процессе и метастазах в регионарных лимфоузлах для поиска отдалённых метастазов.

3.9 Оценка эффективности лечения

1. МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ; при неоднозначном результате — ПЭТ-КТ для отличия постлучевых изменений от рецидива;
2. при регионарных метастазах — ПЭТ-КТ **не ранее чем через 3 месяца** после ЛТ или ХЛТ для решения вопроса о шейной лимфодиссекции;
3. через **2–3 месяца** — пункция подозрительных лимфоузлов шеи под контролем УЗИ для решения вопроса об отказе от лимфаденэктомии.

Подозрительными считают лимфоузлы шеи I–IV групп **более 2 см**, V группы **более 1 см**, а также узлы с изменённой структурой по данным УЗИ.

---

4. Лечение

4.1 Лечение по стадиям

Основным методом радикального лечения является лучевая или химиолучевая терапия.

Лечение рака носоглотки по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
T1N0M0	самостоятельная ЛТ
T2N0M0	самостоятельная ХЛТ
T1N1–3, T2–T4 любая N	одновременная ХЛТ, затем адъювантная ХТ (2 цикла), или индукционная ХТ (3 цикла), затем одновременная ХЛТ
любая T и N, M1	ХТ с препаратами платины, предпочтительно в сочетании с камрелизумабом в 1-й линии независимо от экспрессии PD-L1 и статуса ВЭБ

При остаточных метастатических лимфоузлах после консервативного лечения целесообразно хирургическое лечение; при полной регрессии узлов — динамическое наблюдение.

После ХЛТ при местно-распространённом раке III–IVA стадии (кроме T3–4N0 и T3N1) может быть рассмотрена адъювантная ХТ #капецитабином 650 мг/м² 2 раза в сутки в течение 1 года, начатая **не позднее 12–16 недель** после ХЛТ.

Индукция по схеме DCF (доцетаксел, цисплатин, фторурацил) с последующей ХЛТ при T3–4N+ улучшает 3-летнюю безрецидивную и общую выживаемость по сравнению с одновременной ХЛТ.

4.2 Рецидив или остаточная опухоль после лучевой терапии

В 1-й линии — ХТ с препаратами платины, предпочтительно в сочетании с камрелизумабом. При резектабельной опухоли обсуждают операцию и повторную ЛТ или ХЛТ; при нерезектабельной — повторную ЛТ или ХЛТ, лекарственную терапию либо симптоматическое лечение.

Повторная ЛТ обсуждается при общем состоянии ECOG 0–1 и **не ранее 6 месяцев** (предпочтительно **не ранее 2 лет**) после предшествующего облучения.

Рецидив или остаточная опухоль с отдалёнными метастазами

1. **ECOG 0–1** — лекарственное лечение: полихимиотерапия, монохимиотерапия или иммунотерапия с учётом первичного лечения;
2. **ECOG 2** — монохимиотерапия или симптоматическое лечение;
3. **ECOG 3** — симптоматическое лечение.

4.3 Лучевая терапия

Самостоятельная ЛТ: на первичный очаг 66–70 Гр (1,8–2,2 Гр за фракцию), на локорегионарную область с лимфоузлами 50 Гр (2,0 Гр за фракцию) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр за фракцию).

Одновременная ХЛТ: на первичный очаг и регионарные метастазы 70 Гр (2,0 Гр за фракцию) ежедневно с понедельника по пятницу **в течение 7 недель**; на локорегионарную область — 50 Гр или 54–63 Гр.

Паллиативная ЛТ — для облегчения или профилактики локорегионарных симптомов при невозможности радикального лечения, в том числе 50 Гр (2,5 Гр за фракцию) или 30 Гр (3 Гр за фракцию).

ЛТ проводят в специализированных учреждениях с опытом лечения рака носоглотки. Предпочтительны высокопрецизионные методы (IMRT, VMAT), при значительных ограничениях дозы на нормальные ткани — протонная терапия; допустима 3D-конформная ЛТ.

4.4 Лекарственное лечение

При одновременной ХЛТ — цисплатин 100 мг/м² на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ (суммарно 300 мг/м²). После индукционной ПХТ альтернатива цисплатину — карбоплатин AUC 1,5–2,0 еженедельно с первого дня ЛТ.

Схемы индукционной ХТ

1. доцетаксел 75 мг/м² и цисплатин 75 мг/м² в 1-й день, фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни; 3 цикла с интервалом 3 недели;
2. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни и цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели; 3 цикла;
3. #гемцитабин 1000 мг/м² и цисплатин 40 мг/м² в 1-й и 8-й дни каждые 3 недели; 3 цикла.

ХЛТ с последующей адъювантной ХТ: цисплатин 100 мг/м² 1 раз в 3 недели или 40 мг/м² еженедельно на фоне ЛТ.

Схемы адъювантной ХТ

1. цисплатин 80 мг/м² в 1-й день и фторурацил 1000 мг/м²/сут в 1–4-й дни каждые 4 недели, 3 цикла; при невозможности введения цисплатина — карбоплатин;
2. #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни и цисплатин 80 мг/м² в 1-й день каждые 4 недели, 3 цикла;
3. #гемцитабин 1000 мг/м² и цисплатин 30 мг/м² в 1-й и 8-й дни каждые 3 недели, 3 цикла;
4. #капецитабин 650 мг/м² внутрь 2 раза в сутки в течение года.

При рецидиве и отдалённых метастазах в 1-й линии — камрелизумаб 200 мг в 1-й день, #гемцитабин 1000 мг/м² в 1-й и 8-й дни, цисплатин 80 мг/м² в 1-й день; курс 21 день, 4–6 курсов, далее камрелизумаб 200 мг каждые 3 недели до прогрессирования или непереносимой токсичности.

При невозможности химиоиммунотерапии — комбинированная ХТ (карбоплатин с #паклитакселом, цисплатин с #доцетакселом или фторурацилом, карбоплатин с фторурацилом, #гемцитабин с цисплатином) или монохимиотерапия; число курсов определяется переносимостью и эффективностью.

Во 2-й линии — один из этих режимов, пембролизумаб при MSI или CPS более 1 либо ниволумаб, если 1-я линия не содержала камрелизумаб.

4.5 Профилактика и лечение осложнений

При угрозе или состоявшемся кровотечении из опухоли или метастатических узлов — ангиография наружной сонной артерии и при отсутствии противопоказаний селективная и суперселективная эмболизация сосудов опухоли.

На фоне противоопухолевой лекарственной терапии проводят профилактику и лечение тошноты и рвоты, фебрильной нейтропении, гепато-, нефро- и кардиотоксичности, кожных реакций, мукозитов, анемии, иммуноопосредованных и неврологических осложнений по КР Российского общества клинической онкологии.

4.6 Медицинская реабилитация

До начала лечения — профилактическая гимнастика и обучение тактике глотания для уменьшения нарушений глотания на фоне противоопухолевой терапии.

Всем перед ЛТ или ХЛТ — осмотр стоматолога и сопровождение на всех этапах лечения и реабилитации.

В постлучевом периоде облучённые ткани очень ранимы: **в ранние сроки** инвазивные диагностические процедуры и биопсию без крайней необходимости не выполняют.

Частая причина лучевого остеомиелита — удаление зубов в зоне облучения; по возможности ограничиваются консервативными методами, удаление зубов — только при необходимости на фоне антибиотикотерапии.

Показания к нутритивной поддержке перед операцией

1. непреднамеренная потеря **10% массы тела и более** за 6 месяцев;
2. индекс массы тела **менее 20 кг/м²**;
3. гипопротеинемия **менее 60 г/л** или гипоальбуминемия **менее 30 г/л**;
4. ухудшение возможности приёма пищи за последнюю неделю.

При химиотерапии показания те же, но потеря массы тела — более 5% за 6 месяцев; добавляются невозможность адекватного питания через рот и энтеропатия средней и тяжёлой степени.

Энтеральное питание начинают, если питание через рот покрывает менее 60% потребности **в течение 10 дней**; потеря более 10% исходной массы тела также является показанием. Предпочтителен сиппинг высокобелковыми смесями; при невозможности — назогастральный зонд (при сроке стояния **до 3–4 недель**) или гастростомия. Белок — не менее 1,2–2 г/кг/сут, энергия — 25–30 ккал/кг/сут.

При болевом синдроме на фоне ЛТ или ХЛТ — консультация врача по паллиативной медицинской помощи.

На фоне ХЛТ для профилактики и лечения мукозита полости рта и глотки применяют низкоинтенсивное лазерное излучение на область дёсен.

На фоне химиотерапии рекомендуется раннее начало физических нагрузок для профилактики саркопении, уменьшения слабости и улучшения качества жизни.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Осмотр и сбор жалоб после лечения

1. 1-й год — **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год — **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5-й год — **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет — ежегодно или при появлении жалоб; при высоком риске рецидива интервалы сокращают.

Объём обследования

1. анамнез и физикальное обследование;
2. КТ или МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием;
3. эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа и носоглотки;
4. КТ органов грудной полости каждые 12 месяцев;
5. ПЭТ всего тела **не ранее чем через 1 год** после окончания ЛТ;
6. ТТГ в крови каждые 6–12 месяцев, если облучали шею.

При невозможности адекватного осмотра зоны интереса — фиброларингоскопия **каждые 3 месяца** в первые 2 года после лечения, в 3–5-й год — каждые 4–8 месяцев, далее раз в год.

УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон — **каждые 1–3 месяца** в первые 2 года, в 3–5-й год — каждые 4–8 месяцев, далее раз в год.

КТ или МРТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием — с той же периодичностью, что и УЗИ шеи.

КТ органов грудной полости — каждые 6 месяцев **до 5 лет**, далее раз в год; при невозможности — прицельная рентгенография.

При симптомах рецидива — ПЭТ-КТ с ФДГ или КТ органов грудной и брюшной полостей с контрастированием; при невозможности — рентгенография органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой врач направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи или первичный онкологический кабинет.

Тактику лечения определяет онкологический консилиум с участием онкологов и радиотерапевта.

Показания к госпитализации

1. **экстренная** — осложнения онкологического заболевания или его лечения;
2. **плановая** — сложные интервенционные диагностические вмешательства; специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки опухоли;
3. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость);
4. экстранодальное распространение опухоли.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак носоглотки»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2029 года
Код в рубрикаторе	535_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 3.1 при стадии T2N0M0 рекомендована самостоятельная ХЛТ, а следующий пункт для «T2–T4, любого N» рекомендует ХЛТ с адъювантной или индукционной химиотерапией: стадия T2N0 подпадает под оба пункта.
- Сроки наблюдения расходятся: в разделе 2.4.3 фиброларингоскопия — «каждые 3 месяца в течение первых двух лет…, каждые 2–6 месяцев в течение 2 лет», КТ органов грудной полости — каждые 6 месяцев до 5 лет; в разделе 5 КТ органов грудной полости — каждые 12 месяцев.

Клинические рекомендации

Рак носоглотки у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C11** — Злокачественное новообразование носоглотки
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/66_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 24.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак носоглотки (назофарингеальная карцинома, НФК) — злокачественное эпителиальное новообразование носоглотки; у детей этиологическим фактором почти всегда является вирус Эпштейна — Барр.
- Ведущий симптом — одно- или двусторонняя лимфаденопатия шеи, которая выявляется раньше симптомов опухоли носоглотки.
- Всем — первичный осмотр оториноларинголога: при задней риноскопии видны опухолевые массы, перекрывающие хоаны; при отоскопии — картина экссудативного отита или тубоотита.
- Диагноз подтверждают биопсией опухоли носоглотки под контролем эндоскопии или биопсией изменённого шейного лимфоузла с иммуногистохимическим исследованием.
- Основу лечения составляют системная химиотерапия и лучевая терапия в специализированном детском онкологическом центре.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Ответ на лечение

1. **полный ответ** — исчезновение всех очагов, короткая ось ранее увеличенных лимфоузлов менее 10 мм;
2. **частичный ответ** — уменьшение суммы диаметров очагов не менее чем на 30%;
3. **прогрессия** — новый опухолевый очаг или увеличение измеряемого очага более чем на 20%;
4. **рецидив** — новые очаги после достигнутого полного ответа.

2.2 Этиология и эпидемиология

У детей и подростков вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ) — этиологический фактор в подавляющем большинстве случаев: его серологические признаки есть у 98% больных, ДНК вируса — в клетках опухоли.

Циркулирующая ДНК ВЭБ помогает

1. в дифференциальной диагностике;
2. в оценке прогноза (он ухудшается с ростом вирусной нагрузки);
3. в мониторинге эффекта лечения.

Имеет значение и генетическая предрасположенность (варианты HLA).

Злокачественные опухоли носоглотки составляют 1–3% злокачественных новообразований у детей. До 10 лет НФК почти не встречается; в 10–14 лет заболеваемость — 0,8, в 15–19 лет — 1,3 на 1 млн в год.

2.3 Клиническая картина

Ведущий симптом — одно- или двусторонняя лимфаденопатия, которая обнаруживается раньше симптомов опухоли в носоглотке.

Местные симптомы

1. носовые кровотечения, заложенность носа, выделения из носа;
2. отоалгия и рецидивирующие средние отиты из-за блокады устьев слуховых труб;
3. головная боль;
4. тризм при распространении опухоли на крыловидные и (или) жевательные мышцы.

Группы симптомов

1. носовые;
2. ушные;
3. неврологические;
4. метастатические.

Ранние — носовые и ушные: они обусловлены ростом опухоли в пределах носоглотки. Неврологические симптомы и регионарные метастазы указывают на выход процесса за пределы органа; метастазы в лимфоузлы появляются в первые месяцы болезни. По мере роста опухоли появляются слизисто-гнойные выделения, в далеко зашедших стадиях — ихорозный запах, примесь крови, некротические массы, спонтанные носовые кровотечения.

2.4 Классификация

Гистологические типы НФК (ВОЗ, 2005)

1. I — плоскоклеточный ороговевающий рак;
2. IIa — дифференцированный плоскоклеточный неороговевающий рак;
3. IIb — недифференцированный плоскоклеточный неороговевающий рак;
4. III — недифференцированная карцинома;
5. IV — базалоидный плоскоклеточный рак.

Символ T

T	Первичная опухоль (UICC/AJCC, 8-е издание)
T0	опухоль не обнаружена, но в увеличенных лимфоузлах — клетки НФК, ассоциированные с ВЭБ
T1	носоглотка, ротоглотка или полость носа без окологлоточного распространения
T2	распространение в парафарингеальное пространство, поражение прилегающих мягких тканей
T3	распространение на костные структуры (основание черепа, шейный позвонок) и (или) придаточные пазухи носа
T4	внутричерепное распространение, поражение черепных нервов, гипофаринкса, орбиты, обширное поражение мягких тканей

1. **N1** — односторонние шейные, одно- или двусторонние заглоточные лимфоузлы не более 6 см выше перстневидного хряща;
2. **N2** — двустороннее поражение лимфоузлов не более 6 см выше перстневидного хряща;
3. **N3** — лимфоузлы более 6 см и (или) ниже перстневидного хряща.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I / II / III	T1N0 / T1–2N0–1 / T1–3N2, T3N0–1
IVA / IVB	T1–3N3, T4N0–2 / любая T и N, M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Всех детей с подозрением на опухоль направляют в детские онкологические центры.

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. физикального обследования;
3. лабораторных исследований;
4. инструментального обследования;
5. прижизненного патологоанатомического исследования.

3.2 Жалобы и анамнез

Подробный сбор анамнеза при первичном приёме: семейный анамнез, развитие ребёнка от рождения, доброкачественные и злокачественные опухоли у членов семьи. Жалобы уточняют при каждом приёме онколога, перед каждым курсом химиотерапии и при оценке ответа.

3.3 Осмотр оториноларинголога

Всем при первичном приёме — осмотр оториноларинголога для оценки распространения опухоли.

Что выявляет осмотр

1. **наружный нос** — возможна деформация в области наружного носа и проекции околоносовых пазух;
2. **передняя риноскопия** — опухолевые массы в задних и верхних отделах полости носа;
3. **задняя риноскопия** — опухолевые массы в носоглотке, частично или полностью перекрывающие хоаны;
4. **осмотр ротоглотки** — при росте опухоли в ротоглотку — смещение кпереди и асимметрия мягкого нёба, гнусавость, при больших размерах — затруднение дыхания;
5. **отоскопия** — картина хронического экссудативного отита или тубоотита.

При каждом приёме — пальпация шейных и надключичных лимфоузлов. Поражение шейных лимфоузлов наблюдается в 90% случаев НФК, отдалённые метастазы у детей — не более чем в 25–30%.

При болевом синдроме в области лица и отоалгии — исследование черепных нервов (электродиагностика лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц).

3.4 Антитела к вирусу Эпштейна — Барр

При первичном приёме, при оценке ответа и в динамическом наблюдении — антитела к капсидному (VCA), раннему (EA) и ядерному (NA) антигенам ВЭБ в крови для оценки активности инфекции. Титры IgG VCA и D-EA, как правило, повышаются и снижаются соответственно активности болезни.

Лабораторные исследования при каждом этапе

1. общий (клинический) анализ крови развёрнутый;
2. биохимический анализ крови (ЛДГ, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, билирубин, щелочная фосфатаза, белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, электролиты);
3. коагулограмма;
4. общий анализ мочи;
5. скорость клубочковой фильтрации.

3.5 МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ-КТ

На всех этапах (первичное обследование, оценка ответа, наблюдение, подозрение на рецидив) — МРТ мягких тканей головы и шеи с внутривенным контрастированием на томографах 1,0–3,0 Тл.

МРТ оценивает

1. размер, объём и распространённость опухоли;
2. связь опухоли с сосудами и нервами;
3. изменения костей и васкуляризацию;
4. регионарные лимфоузлы.

Дополнительно

1. КТ мягких тканей головы с контрастированием — для оценки деструкции костей черепа;
2. КТ органов грудной полости с болюсным контрастированием — всем, для исключения метастазов в лёгких;
3. УЗИ шейных лимфоузлов;
4. ПЭТ-КТ с туморотропными РФП — для оценки отдалённых метастазов и динамики на фоне лечения.

3.6 Эпифарингоскопия и биопсия

Всем — эндоскопическое исследование носоглотки (эпифарингоскопия): позволяет осмотреть все стенки носоглотки, определить направление роста опухоли и выполнить прицельную биопсию.

Эндоскопическая картина недифференцированного рака

1. экзофитный рост с изъязвлением поверхности;
2. чаще поражены боковые стенки носоглотки с распространением в ротоглотку и даже гортаноглотку;
3. реже — изолированное поражение купола носоглотки;
4. при росте кпереди опухолевые массы видны в полости носа.

Эндоскопическую эндоназальную ревизию полости носа и носоглотки сочетают с биопсией слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопии.

1. **дети младшего возраста** — в условиях седации, с участием анестезиолога-реаниматолога;
2. **старшие дети и подростки** — при нетяжёлом состоянии — амбулаторно под местной аппликационной анестезией.

Если при эпифарингоскопии биопсия не проведена или материал не получен, выполняют биопсию опухоли носоглотки; при клинически поражённых шейных лимфоузлах возможна биопсия изменённого лимфоузла. Морфологическая верификация необходима всем.

Патологоанатомическое исследование с иммуногистохимией: панцитокератин, цитокератины, p63, маркеры ВЭБ-инфекции.

3.7 Тональная аудиометрия

При подозрении на тугоухость — тональная аудиометрия.

При раке носоглотки у ближайших родственников — генетическое консультирование.

3.8 Оценка ответа на лечение

Динамику первичного и метастатических очагов оценивают по критериям RECIST 1.1.

1. **полный ответ** — исчезновение всех очагов;
2. **частичный ответ** — уменьшение суммы диаметров не менее чем на 30%;
3. **прогрессия** — увеличение на 20% и более или новые очаги;
4. **стабилизация** — всё остальное.

После лучевой терапии: МРТ и КТ головного мозга и шеи — через **6 недель**, ПЭТ-КТ — **не ранее 3 месяцев**.

---

4. Лечение

Лечение мультидисциплинарное, под контролем специализированных центров с опытом лечения НФК. Основу терапии составляют системная химиотерапия и лучевая терапия; КР приводит три режима, показавших эффективность у детей и подростков.

Показания к началу индукционной химиотерапии

1. гистологическая верификация диагноза;
2. лейкоциты выше 2×10^9/л (для режимов 2 и 3 — гранулоциты выше $0{,}75\times10^9$/л), тромбоциты выше 75×10^9/л;
3. нет декомпенсации хронических заболеваний и тяжёлых органных дисфункций;
4. нет (неконтролируемых) инфекционных осложнений;
5. нет аллергических реакций на препараты режима.

4.1 Режимы лечения

Режимы лечения НФК у детей

Режим	Состав
№ 1: химиотерапия + лучевая терапия	4 курса индукции (#винбластин + #циклофосфамид + доксорубицин + #блеомицин) через 21–28 дней, при полном или частичном ответе — 4 курса консолидации, лучевая терапия
№ 2: химиотерапия + химиолучевая терапия	стадии II–IVA — 3 курса индукции #фторурацил + цисплатин через 21–28 дней (IVB — 4 курса), затем лучевая терапия с цисплатином
№ 3: химиотерапия + химиолучевая терапия	стадии II–IVA — 3 курса индукции #гемцитабин + цисплатин через 21 день; IVB — 4 курса с добавлением #пембролизумаба (при решении федерального консилиума)
Стадия I	лучевая терапия без индукционной химиотерапии: СОД 66,6 Гр на опухоль и 45 Гр — профилактически на регионарные лимфоузлы

Режим № 1: индукция (табл. 2 КР)

1. #винбластин 5 мг/м^2 струйно в 1, 8, 15-й дни;
2. #циклофосфамид 600 мг/м^2 за 1 час в 1-й день;
3. доксорубицин 20 мг/м^2 за 1 час в 1, 8-й дни;
4. #блеомицин 10 мг/м^2 за 1 час во 2, 4-й дни; при суммарной дозе 300 мг/м^2 его исключают.

С 7-го дня курса — #оксодигидроакридинилацетат натрия 5 мг/кг в сутки через 48 часов, 5–7 инъекций; всего 4 курса на фоне первых 4 курсов ПХТ и ЛТ.

Консолидация (табл. 3 КР)

1. #винбластин 5 мг/м^2 в 1, 8, 15-й дни;
2. #циклофосфамид 500 мг/м^2 в 1, 8-й дни;
3. #дактиномицин в 1-й день (в КР — «1200 мг/м^2», максимальная разовая доза 2,5 мг; во время ЛТ не вводится).

Интервалы между курсами 21–28 дней.

Лучевая терапия режима № 1: первичная опухоль — СОД 50 Гр; регионарные лимфоузлы — 45,6 Гр при метастатическом поражении и 36 Гр без признаков поражения; при метастазах в лёгких — облучение лёгких 12 Гр, при одиночных метастазах в костях и мягких тканях — до 36–50 Гр.

Режимы № 2 и 3: индукция

1. #фторурацил 1000 мг/м² инфузией 24 часа в 1–5-й дни + цисплатин 100 мг/м² за 6 часов в 1-й день (режим № 2);
2. #гемцитабин 1000 мг/м² за 30 минут в 1, 8-й дни + цисплатин 80 мг/м² за 4 часа в 1-й день (режим № 3);
3. при стадии IVB в режиме № 3 — #пембролизумаб 2 мг/кг (не более 200 мг) в 1-й день.

Лучевая терапия режимов № 2 и 3: первичная опухоль и ретрофарингеальные лимфоузлы — РОД 1,8 Гр, СОД 54 Гр (при локальной прогрессии на фоне ПХТ — 66,6 Гр, остаточная опухоль — до 59,4 Гр); лимфоколлекторы шеи IB–V — 45 Гр, поражённые — 54 Гр, остаточные — до 59,4 Гр. При стадиях II–IVA в первые 3 и последние 3 дня ЛТ — цисплатин 20 мг/м² за 1 час.

4.2 Поддерживающая терапия и рецидив

1. **стадия I** — после лучевой терапии — наблюдение без поддерживающей терапии;
2. **стадии II–IVB** — #интерферон бета-1b 100 тыс. МЕ/кг подкожно 3 раза в неделю **6 месяцев**.

При прогрессии или рецидиве, а также при больших метастатических лимфоузлах шеи со сдавлением жизненно важных структур (решение о шейной лимфодиссекции) — обращение в федеральные центры.

Сопроводительная терапия

1. оценка и коррекция нутритивного статуса;
2. профилактика и лечение тошноты и рвоты;
3. гемотрансфузионная поддержка при анемии, кровотечении, высоком риске геморрагического синдрома;
4. имплантируемый порт или центральный венозный катетер;
5. рациональная антибактериальная терапия инфекционных осложнений.

4.3 Медицинская реабилитация

При жалобах на снижение слуха и при наследственной тугоухости — консультация сурдолога-оториноларинголога и при необходимости сурдологическая коррекция.

После специального лечения — консультация детского эндокринолога и диспансерное наблюдение для своевременной коррекции гипофункции щитовидной железы и гипофиза.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Обследование после окончания лечения

Исследование	1-й год	2-й год	3-й год	4–5-й год
Клинический осмотр, анализы крови и мочи, УЗИ лимфоузлов шеи, МРТ и КТ головы и шеи	1 раз в 3 мес.	1 раз в 4 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
КТ органов грудной полости	1 раз в 3 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
ПЭТ-КТ; ЭКГ и ЭхоКГ; тональная аудиометрия	1 раз в год	1 раз в год	по показаниям	по показаниям

5.2 Организация медицинской помощи

Показания к госпитализации

1. **плановая** — биопсия опухоли носоглотки или шейного лимфоузла; курсы химиотерапии; лучевая терапия;
2. **экстренная** — фебрильная нейтропения; стоматит 3–4 степени; токсичность 2–4 степени, требующая стационарной коррекции.

Неблагоприятные прогностические факторы

1. отдалённые метастазы;
2. снижение доз химиопрепаратов;
3. отказ от лучевой терапии;
4. интервалы между курсами более 28 дней;
5. инфекционные осложнения;
6. распространение опухоли на латеральную крыловидную мышцу.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак носоглотки»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 15.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	66_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 3 (консолидация режима № 1) доза #дактиномицина указана как «1200 мг/м^2», тогда как максимальная разовая доза — 2,5 мг; вероятно, имеются в виду микрограммы (мкг/м^2).

Клинические рекомендации

Рак полости носа и придаточных пазух

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C30** — Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха **C31** — Злокачественное новообразование придаточных пазух
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/3_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Рак полости носа и придаточных пазух — злокачественная опухоль из элементов слизистой оболочки полости носа и пазух; 1,4% всех злокачественных опухолей.
- Повод заподозрить рак — заложенность носа, не поддающаяся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**; первые проявления также выделения из носа, боль, экзофтальм при распространении в орбиту.
- Ранний рак решётчатого лабиринта в большинстве случаев выявляют при гистологическом исследовании материала после операций по поводу предполагаемых неопухолевых процессов (полипозный этмоидит, полипы полости носа).
- Всем — биопсия слизистой оболочки полости носа; распространённость — КТ лицевого черепа и шеи с контрастированием и (или) МРТ, УЗИ лимфоузлов шеи.
- При подозрении на рак пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация — **не позднее 5 рабочих дней**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Верхняя стенка полости носа представлена сетевидной (решётчатой) пластинкой, передней стенкой основной пазухи, передними клетками решётчатого лабиринта; внутренняя — перегородкой носа; наружная — медиальной стенкой верхнечелюстной пазухи; задняя — хоанами; передняя — грушевидным отверстием.

Радикальная операция (R0) — удаление поражённого органа в пределах здоровых тканей вместе с зонами регионарного метастазирования без остаточных проявлений опухолевого процесса.

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиологические факторы

1. хронические воспалительные заболевания: хронические синуситы, вазомоторный ринит, бронхиальная астма, инвертированная папиллома;
2. неблагоприятные факторы внешней среды;
3. канцерогены физической и химической природы, особенно на вредном производстве.

Злокачественные опухоли полости носа и пазух составляют 1,4% всех злокачественных опухолей; в 2021 г. в России — 1012 новых случаев.

2.3 Клиническая картина

В 70% случаев опухоли эпителиальные: плоскоклеточный рак — 80%, аденокарцинома — 6%, эстезионейробластома — 10%, редко меланома.

Первые проявления

1. заложенность носа;
2. выделения из полости носа;
3. болевой синдром;
4. экзофтальм при распространении в орбиту.

2.4 Классификация TNM (8-е издание, 2017)

Символ T: верхнечелюстная пазуха

T	Верхнечелюстная пазуха
T1	ограничена слизистой оболочкой без эрозии или деструкции кости
T2	эрозия или разрушение кости, включая твёрдое нёбо и (или) средний носовой ход, без распространения на заднюю стенку пазухи и крыловидные отростки
T3	задняя стенка пазухи, подкожная клетчатка, дно или медиальная стенка орбиты, крыловидная ямка, решётчатые клетки
T4a	передний край орбиты, кожа щеки, крыловидные отростки, подвисочная ямка, сетевидная пластинка, основная или лобная пазуха
T4b	купол орбиты, твёрдая мозговая оболочка, мозг, средняя черепная ямка, черепные нервы (кроме верхнечелюстной ветви тройничного), носоглотка, скат

Символ T: полость носа и решётчатый лабиринт

T	Полость носа, клетки решётчатого лабиринта
T1	одна сторона полости носа или решётчатых клеток, с эрозией кости или без
T2	две стороны полости носа и прилежащие участки в пределах полости носа и решётчатых клеток
T3	медиальная стенка или дно орбиты, верхнечелюстная пазуха, нёбо, решётчатые клетки
T4a	передние структуры орбиты, кожа носа или щёк, минимально передняя черепная ямка, крыловидные отростки, основная или лобная пазуха

1. **N1** — один ипсилатеральный лимфоузел до 3 см без экстракапсулярной инвазии
2. **N2** — до 3 см с ENE+ или 3–6 см ENE−; несколько ипсилатеральных или контралатеральные до 6 см ENE−
3. **N3** — более 6 см ENE− или любой с ENE+ кроме N2a

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I / II / III	T1N0 / T2N0 / T3N0 или T1–T3N1
IVA	T4a N0–N2; T1–T3 N2
IVB	любая T N3; T4b любая N
IVC	M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: заложенность носа, не поддающаяся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**;
2. осмотра и пальпации образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологии соскоба, мазков, пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: УЗИ шеи, КТ лицевого черепа и шеи с контрастом и (или) МРТ, ПЭТ-КТ, фиброларингоскопия по показаниям.

3.2 Жалобы, анамнез и осмотр

Всем — тщательный сбор жалоб и анамнеза для выбора тактики лечения.

Всем — осмотр и бимануальная пальпация очага и регионарных лимфоузлов, оценка нутритивного статуса.

3.3 Биопсия слизистой оболочки полости носа

Всем — биопсия слизистой оболочки полости носа. При верифицированной опухоли определяют гистологический тип и степень дифференцировки.

При сомнительном результате обязательна повторная биопсия в достаточном объёме с иммуногистохимией; при повторно отрицательном результате биопсию повторяют при убедительных клинических и (или) рентгенологических признаках злокачественной опухоли.

3.4 КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ-КТ

Всем — КТ лицевого черепа и шеи с болюсным контрастированием и (или) МРТ лицевого черепа и шеи с контрастом.

Стадирование

1. УЗИ лимфоузлов шеи и тонкоигольная биопсия изменённых узлов под УЗИ или КТ;
2. УЗИ органов брюшной полости;
3. КТ органов грудной полости (при невозможности — рентгенография лёгких);
4. при T3–T4 или N1 и более — ПЭТ-КТ или КТ грудной и брюшной полостей с контрастом;
5. фиброларингоскопия и ЭГДС по показаниям.

Через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ — ПЭТ-КТ с ФДГ или МРТ с контрастом для оценки эффекта.

В заключении по операционному материалу отражают

1. размер, глубину инвазии, гистологическое строение и дифференцировку;
2. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
3. pT, pN с числом исследованных и поражённых узлов и экстранодальным распространением;
4. состояние краёв резекции.

---

4. Лечение

4.1 Рак полости носа и клеток решётчатого лабиринта

Лечение рака полости носа и решётчатого лабиринта

Ситуация	Рекомендованное лечение
T1–T2, первично выявленный	операция, после неё ЛТ; наблюдение — только при T1 с благоприятными признаками (чистые края, нет прилежания к сетевидной пластинке и медиальной стенке орбиты, высокая дифференцировка)
T3–T4a	операция на первом этапе, или ЛТ/ХЛТ, или индукционная ХТ с операцией или ХЛТ; после операции — ЛТ или ХЛТ при опухоли в краях резекции и (или) внутричерепном распространении
T4b, отказ от операции, противопоказания	по ECOG: 0–1 — ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; 2 — ЛТ ± ХТ; 3 — паллиативная ЛТ, монохимиотерапия или паллиативная помощь

Если диагноз установлен после неполного удаления (полипэктомия) и есть остаточная опухоль — хирургическое удаление, ЛТ или конкурентная ХЛТ; без видимой остаточной опухоли — ЛТ или операция, затем ЛТ. Наблюдение — только при T1 и благоприятных признаках.

Нерадикальная первая операция фактически является расширенной биопсией, и дальнейшее лечение проводят как при впервые установленном диагнозе. Метастазы в лимфоузлы шеи при раке полости носа и решётчатого лабиринта крайне редки; при их выявлении выполняют шейную лимфодиссекцию.

При синоназальной недифференцированной карциноме, низкодифференцированной эстезионейробластоме, синоназальном нейроэндокринном раке в план включают системную химиотерапию.

4.2 Рак верхнечелюстной пазухи (кроме меланомы, саркомы, лимфомы)

Лечение рака верхнечелюстной пазухи

Ситуация	Рекомендованное лечение
T1–T2 N0 (кроме аденокистозного рака)	радикальная операция и наблюдение; при периневральной, сосудистой, лимфатической инвазии — ЛТ или ХЛТ; при положительных краях — ререзекция и ЛТ
T1–T2 N0, аденокистозный рак	радикальная операция и ЛТ; наблюдение — при R0 и отсутствии периневральной инвазии
T3–T4a N0	радикальная операция, затем ЛТ; при опухоли в краях резекции — ХЛТ
T1–T4a N+	удаление опухоли и расширенная шейная лимфаденэктомия, затем ЛТ; при опухоли в краях или экстракапсулярном распространении — ХЛТ
T4b, отказ от операции	по ECOG: 0–1 — ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; 2 — ЛТ ± ХТ; 3 — паллиативное лечение

1. **рецидив без предшествующей ЛТ** — операция, ХЛТ или индукционная ХТ с ХЛТ
2. **рецидив после ЛТ** — операция с обсуждением повторной ЛТ; при невозможности операции — повторная ЛТ и противорецидивная ХТ
3. **рецидив с отдалёнными метастазами** — по ECOG, как при T4b

4.3 Лучевая терапия

1. **самостоятельная ЛТ** — на опухоль и метастазы в лимфоузлах 70 Гр (1,8–2,0 Гр за фракцию) **7 недель**, на неизменённые лимфоузлы 50 Гр
2. **послеоперационная ЛТ** — на ложе опухоли и поражённые узлы 60–66 Гр, на неизменённые узлы 50 Гр; интервал после операции **до 6 недель**, **не более 3 месяцев**

Послеоперационная ХЛТ: 66–70 Гр за 6–7 недель с цисплатином 100 мг/м^2 в 1, 22 и 43-й дни (или еженедельно); при противопоказаниях к препаратам платины (СКФ менее 50–60 мл/мин, возраст старше 65 лет, ECOG более 1) — цетуксимаб.

Паллиативная ЛТ — для облегчения симптомов при невозможности радикального лечения: 50 Гр по 2,5 Гр или 30 Гр по 3 Гр.

Индукционная ХТ — доцетаксел + цисплатин + фторурацил, 2–3 курса через 3 недели; при нейроэндокринной опухоли и эстезионейробластоме — схемы с этопозидом. Противорецидивная поли- или монохимиотерапия, иммунотерапия — по общему состоянию; режимы — в таблице КР.

4.4 Хирургическое лечение

Всех пациентов до лечения оценивают хирург и онколог, специализирующиеся на опухолях головы и шеи. Первичную опухоль удаляют единым блоком с чистыми краями; чистый край — 5 мм и более от инвазивного края опухоли. При прилежании опухоли к нерву — резекция нерва со срочным гистологическим исследованием краёв.

Плохой прогноз (неоперабельность): значительное поражение крылонёбной ямки, тяжёлый тризм из-за инфильтрации крыловидных мышц, распространение на основание черепа, охват сонной артерии на 270° и более, распространение на кожу, средостение, предпозвоночную фасцию.

При угрозе кровотечения из опухоли — оценка риска, ангиография и суперселективная эмболизация сосудов опухоли.

Всем — реабилитация по общим принципам после операций и химиотерапии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Частота осмотров после лечения

1. 1–2-й год — **каждые 3–6 месяцев**;
2. 3–5-й год — **1 раз в 6–12 месяцев**;
3. после 5 лет — ежегодно или при жалобах.

Обследование

1. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон: **каждые 3 месяца** в 1-й год, каждые 3–6 месяцев во 2-й, ежегодно в 3–5-й;
2. КТ или МРТ лицевого черепа и шеи: каждые 3 месяца в 1-й год, 3–6 месяцев во 2-й, далее по показаниям;
3. КТ органов грудной полости каждые 12 месяцев;
4. фиброларингоскопия и ЭГДС при жалобах; при подозрении на рецидив — ПЭТ-КТ.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация — **не позднее 5 рабочих дней**, патологоанатомическое исследование — **не более 15 рабочих дней**. Тактику лечения определяет онкологический консилиум.

Факторы прогноза

1. размер и распространённость опухоли, дифференцировка;
2. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
3. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
4. индекс Ki-67, статус краёв резекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак полости носа и придаточных пазух»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 24.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	3_2 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Периодичность наблюдения в разделах 2.4.3 и 5 различается: в 2.4.3 УЗИ шеи — каждые 3 месяца в 1-й год и ежегодно в 3–5-й, в разделе 5 — каждые 3–6 месяцев; осмотры в 1–2-й год указаны как «каждые 36 месяца» (вероятно, 3–6).

Клинические рекомендации

Расщелина верхней губы и нёба

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**Q35** — Расщелина неба [волчья пасть] **Q36** — Расщелина губы [заячья губа] **Q37** — Расщелина неба и губы [волчья пасть с заячьей губой]
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.06.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Общероссийская общественная организация «Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1050_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Расщелина губы и (или) нёба — тяжёлый порок развития челюстно-лицевой области с нарушением непрерывности верхней губы, альвеолярного отростка и нёба и значимыми нарушениями питания, речи, слуха и носового дыхания.
- Расщепление и неправильное прикрепление нёбных мышц вызывают дисфункцию слуховой трубы: всем пациентам показано наблюдение и лечение у оториноларинголога, при необходимости тимпанотомия — для профилактики и лечения экссудативного среднего отита и сохранения слуха.
- Реабилитация длится с рождения **до 18 лет** и требует команды: челюстно-лицевой хирург, ортодонт, генетик, педиатр, оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог, логопед, психолог.
- Сроки операций: первичная хейлоринопластика — **с 3–6 месяцев** на первом году; щадящая уранопластика — **1–2 года** (при двухэтапной — мягкое нёбо в 1–2 года, твёрдое после 3–4 лет); устранение нёбно-глоточной недостаточности — **с 6 лет**; пластика альвеолярного отростка — **8–10 лет**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Расщелина верхней губы, альвеолярного отростка и нёба — врождённый порок развития с нарушением в средней зоне лица.

Составляющие порока

1. расщепление губы на два или три фрагмента;
2. деформация хрящевого отдела носа;
3. порочное прикрепление и нарушение функции пучков круговой мышцы рта;
4. дефект альвеолярного отростка верхней челюсти.

При расщелине нёба

1. сообщение полости рта с полостью носа через дефект по средней линии нёба;
2. неправильное расположение и прикрепление мышц мягкого нёба;
3. расширение среднего отдела глотки и укорочение мягкого нёба.

Уранопластика — реконструктивная операция при расщелине твёрдого нёба. Пластика мягкого нёба — при расщелине мягкого нёба. Хейлоринопластика — при расщелине верхней губы и деформации хрящевого отдела носа.

Нарушения функций

1. питание: сосание невозможно из-за сообщения полостей носа и рта, затем нарушается жевание;
2. речь: несостоятельность велофарингеального сфинктера — невнятная тихая речь с носовым оттенком, задержка речевого развития;
3. слух: расщепление и неправильное прикрепление нёбной мускулатуры вызывают дисфункцию слуховой трубы;
4. носовое дыхание: деформация концевого и костно-хрящевого отдела носа нарушает воздушный поток и способствует патологии ЛОР-органов.

2.2 Этиология и эпидемиология

Порок мультифакторный: генетическая предрасположенность или новая мутация в сочетании с неблагоприятными факторами — физическими, химическими (дефицит питания, гипо- и гипервитаминоз, тератогенные вещества и лекарства, алкоголь, наркотики), биологическими (грипп, краснуха, герпес, токсоплазмоз).

Расщелины занимают 3–5-е место среди врождённых пороков и первое (87%) среди пороков лица; частота 0,6–1,6 на 1000 новорождённых, в России около 1 на 650–700.

2.3 Классификация

1. односторонняя расщелина верхней губы: скрытая, неполная, полная;
2. двусторонняя расщелина верхней губы (симметричная, асимметричная): скрытая, неполная, полная;
3. односторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка: неполная, полная;
4. двусторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка: неполная, полная;
5. односторонняя полная расщелина верхней губы и нёба;
6. двусторонняя полная расщелина верхней губы и нёба;
7. расщелина нёба: субмукозная (скрытая), неполная, полная.

2.4 Клиническая картина

При полной расщелине губы всегда есть деформация кожно-хрящевого отдела носа. При односторонней — крыло носа на стороне расщелины уплощено и растянуто, кончик носа смещён в больную сторону, перегородка носа выгнута в здоровую. При двусторонней — короткая перегородка, уплощённый кончик, растянутые крылья.

Скрытая (субмукозная) расщелина нёба малозаметна: иногда вдавление слизистой оболочки между половинами мягкого нёба, несращение костных пластинок твёрдого нёба, нёбо укорочено. Характерны открытая гнусавость и нарушения артикуляции, иногда компенсаторные движения мимических мышц и крыльев носа.

При полной расщелине мягкого и твёрдого нёба видны носовые раковины, слизистая оболочка их обычно гипертрофирована; мягкое нёбо укорочено, глоточное кольцо расширено, мышцы мягкого нёба недоразвиты.

---

3. Диагностика

Диагноз клинический: визуальный осмотр, антропометрия, рентгенологические и ультразвуковые исследования. Специфической лабораторной диагностики нет — исследования по назначению генетика и предоперационный комплекс по назначению педиатра.

3.1 Жалобы и анамнез

Собирают наследственный анамнез, данные о тератогенах в I триместре и жалобы на нарушение жевания, речи, дыхания, слуха и эстетический дефект — во всех возрастных периодах.

3.2 Консультации специалистов

1. **педиатр** — общесоматический статус, сопутствующая патология перед плановой операцией
2. **челюстно-лицевой хирург** — диагноз и план лечения
3. **оториноларинголог** — состояние ЛОР-органов, профилактика осложнений
4. **ортодонт** — состояние прикуса, ортодонтическая коррекция до и после операций
5. **генетик** — генетическая патология, сопутствующие синдромы, планирование беременностей

3.3 Наблюдение оториноларинголога

Пациентам с расщелиной губы и нёба показаны наблюдение и лечение у оториноларинголога, при необходимости тимпанотомия, для профилактики и лечения экссудативного среднего отита и сохранения слуха.

Риноскопия с консультацией оториноларинголога — выявление искривления перегородки носа и сообщения полости рта с полостью носа; целесообразна детям **с 7 лет**.

Фарингоскопия (челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог) с заключением логопеда — при дизартрии, для индивидуальной программы логопедической реабилитации.

3.4 Ультразвуковой скрининг и компьютерная томография

Беременным — ультразвуковой скрининг **на 19–21-й неделе** для первичного выявления расщелин и других пороков.

КТ челюстно-лицевой области детям **6–11 лет** — оценка дефекта переднего отдела твёрдого нёба и планирование костного трансплантата; подросткам **12–18 лет** — соотношение челюстей и показания к ортогнатической операции.

---

4. Лечение

4.1 Консервативное лечение

Детям **0–3 месяцев** — ортодонтические аппараты (нёбные пластинки) для облегчения кормления, разделения полостей рта и носа и коррекции деформации челюстей до операции; далее предхирургическое ортодонтическое лечение.

Логопедическая коррекция — с дооперационного периода и после уранопластики; психологическое консультирование семьи.

4.2 Хирургическое лечение

Принципы

1. метод — по типу расщелины, степени гипоплазии и деформации окружающих структур;
2. восстановление анатомической и функциональной целостности зоны расщелины;
3. этапность с учётом соматического статуса;
4. командный подход: челюстно-лицевой хирург и ортодонт.

Первичная хейлоринопластика устраняет дефект губы и деформацию носа; рекомендуемый возраст — **старше 3–6 месяцев**, в течение первого года.

Противопоказания к ранней пластике губы: сопутствующие пороки, родовая травма, постнатальная энцефалопатия, анемия, гипотрофия — операцию откладывают до ремиссии.

Щадящая уранопластика при расщелине вторичного нёба — в **1–2 года**. При расщелине мягкого и твёрдого нёба — два этапа: пластика мягкого нёба в **1–2 года**, щадящая уранопластика **после 3–4 лет**.

Для формирования правильной речи — устранение нёбно-глоточной недостаточности после консультации логопеда и оториноларинголога; целесообразно **с 6 лет**.

Пластика альвеолярного отростка — в **8–10 лет** после ортодонтической подготовки.

Реконструктивная хейлоринопластика, хейлориносептопластика, повторная уранопластика — для устранения последствий операций. Коррекции губы возможны в любом возрасте; полная коррекция кожно-хрящевого отдела носа — **в 14–16 лет**, при деформации пирамиды носа — **до 17 лет** откладывают.

Операции после 18 лет

1. ортогнатическая операция;
2. вторичная хейлоринопластика и риносептопластика;
3. повторная уранопластика и устранение нёбно-глоточной недостаточности;
4. пластика альвеолярного отростка, дентальная имплантация.

Задачи хирургического лечения односторонней расщелины губы и нёба

Проблема	Методики
смещение основания колумеллы и перегородки носа в здоровую сторону	мобилизация и репозиция переднего края четырёхугольного хряща (методики Millard, Козина, Delaire)
деформация крыльного хряща на стороне расщелины	мобилизация крыльного хряща, поднадкостничная мобилизация мышц назолабиального комплекса
укорочение нёба, дистопия мышц нёбно-глоточного кольца	удлинение нёба, восстановление мышечной структуры: Z-пластика по Furlow, методики Фроловой, Иванова — Агеевой, Veau — Wardill — Killner, Bardach

4.3 Медицинская реабилитация

Новорождённым — специальные приспособления для кормления. Зондовое питание не рекомендуется (подавляет рефлекс глотания, усугубляет недоразвитие челюстей и мышц мягкого нёба) — только при тяжёлой соматической патологии и недоношенности; ежедневный контроль веса в первые недели.

На всех этапах — с периода новорождённости **до 18 лет** — оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог оценивают среднее ухо, рото- и носоглотку и слух; лечение симптоматическое по показаниям.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация медицинской помощи

Помощь — высокотехнологичная, в стационаре, плановая; госпитализации проводятся поэтапно по алгоритму лечения.

Диспансерное наблюдение — **с рождения до 18 лет** включительно.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Одно- и двусторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 17.06.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июня 2029 года
Код в рубрикаторе	`1050_1` · открыть текст КР ↗

Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки операций в разделе 3.2 и в приложении В («Информация для пациента») расходятся: пластика альвеолярного отростка — 8–10 лет и «начиная с 7 лет»; хейлоринопластика — «старше 3–6 мес» и «в течение первых четырех-шести месяцев»; уранопластика — 1–2 года и «от 13 месяцев».

Клинические рекомендации

Саркоидоз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D86.0** — Саркоидоз легких **D86.1** — Саркоидоз лимфатических узлов **D86.2** — Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов **D86.3** — Саркоидоз кожи **D86.8** — Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций **D86.9** — Саркоидоз неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское Общество Фтизиатров; Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов" ; Российское респираторное общество; Общероссийская общественная организация Педиатрическое респираторное общество
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/736_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Саркоидоз — системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии с образованием неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным поражением органов и активацией Т-клеток в очагах воспаления.
- Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта составляет менее 1% случаев: синоназальная форма (заложенность носа, корки, носовые кровотечения, узелки на перегородке и верхней раковине), увеличение нёбных миндалин, поражение гортани с риском обструкции, сенсоневральная или кондуктивная тугоухость. Диагноз требует биопсии.
- Синдром Хеерфордта — Вальденстрёма: увеличение околоушных слюнных желёз, передний увеит, лихорадка, иногда паралич лицевого нерва.
- Диагноз верифицируется морфологически: гранулёмы без казеозного некроза хотя бы в одном органе при характерной клинико-рентгенологической картине; синдромы Лёфгрена, Хеерфордта, ознобленная волчанка позволяют поставить предположительный диагноз без биопсии.
- Бессимптомным пациентам без недостаточности органов показано активное наблюдение с оценкой через 3 месяца; системные глюкокортикоиды — при прогрессировании, угрозе функции органа или жизни.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Саркоидоз — системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным поражением различных органов и активацией Т-клеток в месте гранулёматозного воспаления с высвобождением различных хемокинов и цитокинов.

Синдром Лёфгрена — вариант острого течения саркоидоза, проявляющийся внутригрудной лимфаденопатией, узловатой эритемой, суставным синдромом и лихорадкой.

Синдром Хеерфордта — Вальденстрёма — вариант острого течения саркоидоза, проявляющийся увеитом, паротитом, лихорадкой и в ряде случаев сопровождающийся параличом лицевого нерва (паралич Белла).

Саркоидная реакция — образование локализованных групп эпителиоидно-клеточных неказеифицирующихся гранулём саркоидного типа в ответ на экзогенные факторы (импланты, татуировки, филлеры), при применении интерферонов, перифокально при злокачественных опухолях и паразитарных заболеваниях; в отличие от саркоидоза поражение только локальное.

2.2 Этиология и эпидемиология

Решающую роль играет воздействие окружающей среды на генетически предрасположенный организм. Вероятные триггеры — изменённые микобактерии, пропионовокислые бактерии, боррелии; саркоидная реакция возможна при применении интерферонов, индукторов интерфероногенеза и таргетной биологической терапии.

Саркоидоз встречается во всех возрастах и у обоих полов; в России преобладают женщины молодого и зрелого возраста. Синдром Лёфгрена наблюдается в 3,7–22% случаев, семейный саркоидоз — в среднем в 9,5%.

2.3 Классификация

Классификация внутригрудного саркоидоза по данным лучевого обследования

Стадия	Рентгенологическая картина	Частота
0	нет изменений на рентгенограмме органов грудной клетки	5%
I	увеличение внутригрудных лимфатических узлов, паренхима лёгких не изменена	45%
II	увеличение внутригрудных лимфатических узлов и изменения паренхимы лёгких	30%
III	изменения паренхимы без увеличения внутригрудных лимфатических узлов	15%
IV	выраженный фиброз лёгких как ведущий синдром	5%

Рентгенологическая стадия не отражает стадийность клинического течения; КТ точнее характеризует распространённость изменений. В диагнозе перечисляют все поражённые органы и системы.

1. **по локализации** — классический (внутригрудной), с преобладанием внелёгочных поражений, генерализованный
2. **по течению** — с острым началом (синдромы Лёфгрена, Хеерфордта — Вальденстрёма), изначально хронический, с фиброзированием, рецидив
3. **особые формы** — саркоидоз детей моложе 5 лет; саркоидоз, рефрактерный к системным глюкокортикоидам

Обострение — реактивация **в течение года** после окончания основного курса лечения; рецидив — возобновление проявлений **через 1 год и более** после лечения или спонтанной регрессии.

Признаки прогрессирования

1. ухудшение клиники, нарастание изменений в лёгких на КТ;
2. появление или усиление внелёгочных проявлений;
3. снижение ФЖЕЛ на **10% и более** или DLco на **15%** за 1 год;
4. формирование лёгочной гипертензии;
5. повышение АПФ, гиперкальциурия и (или) гиперкальциемия.

Построение диагноза

1. локализация (поражённые органы), при внутригрудном саркоидозе — рентгенологическая стадия 0–IV;
2. активность: 0 — неактивный, 1 — активный (или «синдром Лёфгрена», «синдром Хеерфордта — Вальденстрёма»);
3. течение: стабильное, прогрессирующее, регрессирующее, волнообразное, обострение, рецидив;
4. осложнения: недостаточность органа, стойкие структурные изменения;
5. подтверждение диагноза на клеточном или тканевом уровне.

2.4 Клиническая картина

Чаще течение малосимптомное, хроническое. Наиболее выражены жалобы при синдроме Лёфгрена и при «увеопаротидной лихорадке» — синдроме Хеерфордта — Вальденстрёма.

Синдром Лёфгрена (как правило, не дольше 2 месяцев)

1. лихорадка;
2. узловатая эритема;
3. двусторонний периартрит, преимущественно голеностопных суставов;
4. двусторонняя лимфаденопатия корней лёгких.

Общие симптомы

1. слабость и утомляемость (30–80%), оцениваются по шкале FAS;
2. лихорадка (20–60%) или длительный субфебрилитет;
3. боль, тревога, депрессия, когнитивная дисфункция, нейропатия мелких волокон.

При поражении лёгких и внутригрудных лимфоузлов — боль и дискомфорт в грудной клетке, одышка (оценивается по шкале mMRC), сухой кашель из-за давления увеличенных лимфоузлов на бронхи или раздражения гранулёмами нервных окончаний.

2.5 Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта

Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта составляет менее 1% случаев саркоидоза; чаще это случайные находки.

1. **синоназальный** — заложенность носа, ринорея, корки, носовые кровотечения, боль в носу, нарушения обоняния; эндоскопически — хронический риносинусит с узлами и мелкими узелками на перегородке и верхней раковине; необходима гистологическая верификация
2. **нёбные миндалины** — бессимптомное одно- или двустороннее увеличение, неказеифицирующиеся гранулёмы выявляются после тонзиллэктомии
3. **гортань** — дисфония, дисфагия, кашель; отёк и эритема слизистой оболочки, узелки и узлы; возможна угрожающая жизни обструкция; диагноз — по биопсии
4. **ухо** — снижение слуха, шум в ушах, глухота, вестибулярные расстройства; сенсоневральная тугоухость разной степени, реже поражение среднего уха с кондуктивной тугоухостью
5. **полость рта и ротоглотка** — опухание и изъязвление слизистой оболочки, языка, губ, дёсен; орофарингеальный саркоидоз может быть причиной обструктивного апноэ сна

Саркоидоз слюнных желёз (6%) проявляется двусторонним опуханием околоушных желёз, в том числе в составе синдрома Хеерфордта — Вальденстрёма.

Дифференциальная диагностика

1. хронический сиалоаденит;
2. туберкулёз;
3. болезнь кошачьей царапины;
4. актиномикоз;
5. синдром Шегрена.

Поражение черепных нервов — самое частое проявление нейросаркоидоза (50% случаев), чаще всего лицевого, затем зрительного нерва. Паралич лицевого нерва обычно проходит за несколько месяцев даже без лечения. Описаны потеря слуха (VIII нерв), лицевая боль и нарушения чувствительности (V нерв).

Озноблённая волчанка (lupus pernio) — хроническое рецидивирующее поражение кожи носа, щёк, ушных раковин и пальцев. Поражённые участки уплотнены; их цвет красный, пурпурный или фиолетовый. Часто сочетается с поражением лёгких, костей и глаз и резистентна к лечению.

Периферические лимфатические узлы поражаются в 10–25%, чаще задние и передние шейные и надключичные: плотноэластические, не размягчаются и не образуют свищей. Обнаружение эпителиоидно-клеточных гранулём в удалённом узле требует дифференциальной диагностики с саркоидной реакцией и другими гранулематозами.

2.6 Внелёгочные локализации

Кожа (10–30%): узлы, бляшки, «ожившие рубцы», гранулёмы в татуировках; узловатая эритема саркоидных гранулём не содержит. Глаза (5–25%): передний (70–75%) и задний увеит — требуют офтальмологического обследования. У детей до 5 лет характерна триада: увеит, поражение кожи, артрит без поражения лёгких.

Сердце (2–18%) — жизнеугрожающая локализация: нарушения ритма и проводимости, внезапная смерть. Нервная система (5–10%) — краниальные нейропатии, асептический менингит, гипоталамо-гипофизарная дисфункция. Почки, печень, селезёнка, кости (кистоидный остеит фаланг), суставы — по органам.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается по жалобам, анамнезу, лучевым, функциональным, лабораторным и морфологическим данным и требует исключения саркоидной реакции и сходных заболеваний. Верификация — гранулёмы без казеозного некроза хотя бы в одном органе при характерной клинико-рентгенологической картине.

Синдром Лёфгрена, синдром Хеерфордта, ознобленная волчанка и бессимптомная двусторонняя внутригрудная лимфаденопатия настолько специфичны, что позволяют поставить предположительный диагноз без морфологического исследования.

Диагноз устанавливает и формулирует пульмонолог медицинской организации 2–3 уровня после обследования.

3.2 Осмотр кожи, лимфоузлов и глаз

Всем пациентам — физикальное обследование всех органов и систем.

На что обратить внимание

1. изменения кожи, особенно в области старых рубцов и татуировок;
2. безболезненные подвижные увеличенные периферические лимфоузлы, подкожные саркоиды Дарье — Русси;
3. конъюнктива и радужка — увеит, эписклерит;
4. размеры печени и селезёнки.

3.3 Анализы крови и мочи

Всем пациентам — общий анализ крови: повышение СОЭ при остром течении, лимфопения и моноцитоз как признаки активности, тромбоцитопения при поражении печени, селезёнки, костного мозга.

Всем пациентам — оценка функции почек (общий анализ мочи, креатинин, мочевина, СКФ) при первичной диагностике и **не реже 1 раза в 6 месяцев**.

Подросткам и взрослым — активность АПФ при выявлении и в динамике как маркер активности, не как дифференциально-диагностический критерий. Норма **в 6–18 лет** — 29–112 ед., **старше 18 лет** — 20–70 ед.; значимо повышение более 150% от верхней границы нормы.

При остром саркоидозе — С-реактивный белок: умеренное повышение характерно для синдрома Лёфгрена.

Кальций крови и суточной мочи при выявлении и в динамике: гиперкальциемия (5%) и гиперкальциурия (25%) — признаки активного процесса.

Иммуноглобулины A, M, G при первичном обследовании — дифференциальная диагностика с иммунодефицитами, сопровождающимися гранулёмами (ОВИН).

Исключение туберкулёза

1. детям **до 7 лет** — проба Манту с 2 ТЕ (при активном саркоидозе отрицательна в 80–85%);
2. всем при первичной диагностике обязательна проба с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным;
3. при отказе от кожных проб или их невозможности — IGRA-тесты;
4. положительный результат — углублённое обследование у фтизиатра.

3.4 Рентгенография и компьютерная томография органов грудной полости

Обзорная рентгенография — всем для первичной диагностики и определения стадии; для наблюдения — только если КТ невозможна. Типично симметричное увеличение лимфоузлов корней лёгких и средостения и (или) двусторонние очагово-интерстициальные изменения при относительно удовлетворительном состоянии.

КТ органов грудной полости — всем для первичной диагностики и динамического наблюдения. Характерны увеличенные лимфоузлы центрального средостения и корней лёгких без перифокальной инфильтрации и перилимфатические мелкие очаги вдоль бронхососудистых пучков, междолевых щелей и плевры.

3.5 Другие методы визуализации

МРТ сердца и (или) головного мозга — при подозрении на саркоидоз сердца и ЦНС; ПЭТ-КТ всего тела — для уточнения локализации и выбора места биопсии (накопление ФДГ не отличает саркоидоз от опухоли или инфекции).

При подозрении на генерализованный или внелёгочный саркоидоз — УЗИ брюшной полости, МРТ головного мозга и сердца, эхокардиография, рентгенография и МРТ поражённых костей и мягких тканей.

3.6 Функция внешнего дыхания и ЭКГ

Всем при первичной диагностике, вне зависимости от локализации, — спирометрия (ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ): **не реже 1 раза в 3 месяца** в активной фазе и ежегодно при наблюдении. DLco — в пульмонологических центрах. Пульсоксиметрия — на всех этапах, при необходимости тест с 6-минутной ходьбой.

ЭКГ — обязательный компонент первичного обследования; при нарушениях ритма — холтеровское мониторирование.

3.7 Биопсия

Бронхоскопия с биопсией — всем на этапе первичной диагностики; метод биопсии выбирают по ситуации: прямая, чрезбронхиальная, тонкоигольная биопсия лимфоузлов, криобиопсия.

Всем обязательно исключение туберкулёза в биоптатах и промывных водах бронхов: микроскопия, посев, ПЦР.

При неинформативности эндоскопической биопсии — миниинвазивные хирургические операции: видеоторакоскопическая резекция лёгкого, биопсия внутригрудных лимфоузлов.

При внелёгочном саркоидозе — биопсия поражённого органа: периферического лимфоузла, кожи, подкожных образований, печени; метод выбирают лечащий врач и хирург.

3.8 Дифференциальная диагностика

1. **внутригрудная лимфаденопатия** — туберкулёз, нетуберкулёзный микобактериоз, бруцеллёз, токсоплазмоз, болезнь Кикучи, болезнь кошачьей царапины, саркоидная реакция при карциноме, лимфомы, острый лимфобластный лейкоз, GLUS-синдром, IgG4-ассоциированное заболевание, ОВИН
2. **диссеминация в лёгких** — туберкулёз, микозы, опухолевая диссеминация, гиперчувствительный пневмонит, пневмокониозы, лекарственные реакции, гистиоцитоз X, гранулематоз с полиангиитом (Вегенера), интерстициальные пневмонии, ОВИН
3. **дети до 5 лет** — увеиты, паротиты, артриты и поражения кожи другой этиологии

---

4. Лечение

Этиотропной терапии нет. Активная терапия показана при угрозе недостаточности органов, угрозе жизни или потере качества жизни; в остальных случаях — активное наблюдение. Необходимость лечения соотносят с тяжестью последствий глюкокортикоидной, цитостатической или биологической терапии.

4.1 Активное наблюдение

Бессимптомным пациентам (детям и взрослым) без недостаточности органов — активное наблюдение с оценкой **через 3 месяца**: частота спонтанных ремиссий высока.

Взрослым с бессимптомным течением без функциональных нарушений в качестве альтернативы — #альфа-токоферола ацетат или его сочетание с #пентоксифиллином не менее **6 месяцев**.

1. #альфа-токоферола ацетат — в разделе 3.1 указано «200 мкг 2 раза в сутки» и, ниже, «200–400 мг в сутки» (см. «Неточности»);
2. #пентоксифиллин — в разделе 3.1 указано «400–2000 мкг в сутки» и, ниже, 600–1200 мг в сутки (при стероидзамещающей терапии — до 2000 мг).

4.2 Системные глюкокортикоиды

Препараты первой линии при прогрессирующем течении, выраженных симптомах, внелёгочных проявлениях с нарушением функции органа, lupus pernio, угрозе жизни или резком снижении качества жизни.

1. преднизолон взрослым — внутрь утром 20–40 мг в сутки (0,5 мг/кг) **4 недели**, затем снижение по 5 мг в месяц до минимальной поддерживающей дозы, всего **12–24 месяца**.

Эффект оценивают **через 3 месяца**, при его отсутствии переходят на альтернативную терапию. После отмены обострения развиваются у 30–80%. О полной ремиссии судят **через 3 года** после прекращения терапии.

Нежелательные явления: повышение артериального давления и глюкозы, увеличение массы тела, остеопороз (бисфосфонаты), надпочечниковая недостаточность.

Ингаляционные глюкокортикоиды как основная терапия не рекомендуются; их назначают при выраженном кашле и при саркоидозе гортани. Комбинации с бронхолитиками — только при доказанной обратимой бронхообструкции.

4.3 Препараты второй и третьей линии

#Метотрексат — препарат второй линии (при рефрактерности, побочных реакциях или для снижения дозы глюкокортикоидов) и первой линии в монотерапии или комбинации; тератогенен.

1. #метотрексат — внутрь 10–15 мг 1 раз в неделю; взрослым при нейро- и кардиосаркоидозе — до 25 мг в неделю;
2. #фолиевая кислота — 5 мг 1 раз в неделю или 1 мг ежедневно, не ранее чем через 24 часа после метотрексата; терапия от 6 месяцев.

До лечения — АЛТ, АСТ, креатинин, общий анализ крови; в ходе лечения — **каждые 1–3 месяца**.

Другие препараты второй линии

1. #азатиоприн — **с 3 лет**, 100–200 мг в сутки не менее 6 месяцев;
2. #лефлуномид — **с 18 лет**, 10–20 мг в сутки, эффект не ранее 3 месяцев;
3. #микофенолата мофетил — **с 12 лет**, 500 мг 2 раза в день с увеличением до 750–1000 мг 2 раза в день;
4. #циклофосфамид — 500–1000 мг внутривенно каждые 3–4 недели при полиорганном поражении и рефрактерности;
5. #гидроксихлорохин — **с 6 лет**, 400 мг с возможным снижением до 200 мг в сутки, 6–12 месяцев; при саркоидозе глаз не рекомендуется (ретинопатия).

Ингибиторы ФНО-альфа — третья линия только при рефрактерном саркоидозе в профильных центрах: #инфликсимаб 3 или 5 мг/кг внутривенно на 0-й, 2-й и 6-й неделе, затем каждые 4–8 недель; #адалимумаб 40 мг в неделю.

НПВП — симптоматически при острых формах и артритах с выраженным болевым синдромом, по инструкции.

Антифибротическая терапия — только взрослым при прогрессирующем фиброзе, несмотря на глюкокортикоиды и препараты второй линии.

4.4 Другие методы лечения

При хроническом рефрактерном саркоидозе — плазмаферез (3–4 процедуры с недельным перерывом) или экстракорпоральная модификация лимфоцитов.

Трансплантация лёгких — при терминальной стадии (IV, фиброз); сердца — при кардиосаркоидозе с рефрактерными нарушениями ритма; печени — при тяжёлом поражении.

При дыхательной недостаточности — низкопоточная оксигенотерапия, в тяжёлых случаях неинвазивная ИВЛ до SpO_2 более 90%; при лёгочной гипертензии — по рекомендациям по лёгочной артериальной гипертензии.

Всем пациентам — немедикаментозные программы: физическая активность, физическая и психологическая реабилитация, группы поддержки, лечение боли и нарушений сна.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Плановая госпитализация — первичная комплексная, в том числе инвазивная, диагностика и подбор начальной терапии. Экстренная — острый прогрессирующий саркоидоз с осложнениями (дыхательная недостаточность, нарушения ритма). В большинстве случаев лечение амбулаторное.

Показания к выписке

1. завершение диагностики и установление клинического диагноза;
2. назначение лечения;
3. компенсация острого состояния и осложнений, ставших причиной госпитализации.

5.2 Диспансерное наблюдение

Наблюдение пожизненное: при торакальных формах — пульмонолог, при генерализованных и внеторакальных — пульмонолог и специалист по соответствующей локализации.

Частота осмотров

1. впервые выявленный, первый год и сохраняющаяся активность — **каждые 3 месяца**;
2. стабилизация на 2-м году — **каждые 6 месяцев**, далее ежегодно;
3. рецидивы — каждые 3 месяца **2 года**, затем ежегодно;
4. прогрессирующее течение — каждые 3 месяца 2 года, затем каждые 6 месяцев 2 года, далее ежегодно.

Пациенты с саркоидозом относятся к иммунокомпрометированным; вакцинация — по национальному календарю и календарю по эпидемическим показаниям с учётом периода болезни и терапии.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Саркоидоз»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	736_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское респираторное общество; Российское научное медицинское общество терапевтов; Педиатрическое респираторное общество; Российское общество фтизиатров; Российское общество рентгенологов и радиологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Дозы #альфа-токоферола ацетата и #пентоксифиллина в разделе 3.1 указаны в микрограммах («200 мкг 2 раза в сутки», «400–2000 мкг»), а ниже в том же разделе — в миллиграммах («200–400 мг в сутки», «600 мг в сутки», «до 2000 мг»); различие в тысячу раз.

Клинические рекомендации

Травма гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.1** — Кровотечение из горла **S10.0** — Ушиб горла **S10.1** — Другие и неуточненные поверхностные травмы горла **S11.0** — Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 19.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/813_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Травма гортани опасна для жизни: главное — проходимость дыхательных путей, дыхательная недостаточность может нарасти позже из-за отёка и гематомы. Всех пострадавших госпитализируют для наблюдения, при лёгкой травме **24–48 часов**, особенно детей.
- Значительный или нарастающий отёк гортани — трахеотомия в сознании. Интубации по возможности избегают: трубка может усугубить повреждение; если интубируют — трубкой на размер меньше, с иммобилизацией шейного отдела позвоночника.
- Обследование: ларингоскопия и видеоларингоскопия всем, пальпация шеи (эмфизема), КТ шеи (с контрастом при подозрении на повреждение сосудов, пищевода), исключить повреждение шейного отдела позвоночника. МРТ при осколочных и пулевых ранениях нельзя.
- Без смещения хрящей и нарастания дыхательной недостаточности — консервативно: противоотёчная терапия, ингаляции будесонида и кислород, голосовой покой, антирефлюксные препараты; при открытой ране — антибиотики и профилактика столбняка.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. открытая рана, затрагивающая гортань: повреждение гортани снаружи или изнутри с нарушением целостности кожи и слизистой, целостности и функции органа;
2. ушиб глотки, гортани: закрытое повреждение тупым предметом без нарушения целостности кожи и слизистой, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием.

2.2 Этиология

Причины

1. открытые раны: чаще ножевые и огнестрельные;
2. тупая наружная травма: удар предметом или кулаком, авария, спорт, попытка удушения — с переломом хрящей и подъязычной кости, отрывом гортани, разрывом голосовых складок;
3. внутренняя травма с кровотечением: чаще ятрогенная (интубация, ИВЛ, эндоскопия, операции) или инородное тело (рыбья кость, пища, зубные протезы);
4. кровотечение из горла: также злокачественные опухоли.

Возможные повреждения

1. перелом подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи;
2. отрыв гортани от трахеи или подъязычной кости;
3. разрыв голосовых складок, смещение черпаловидных хрящей, парез гортани;
4. кровоизлияния и гематомы со сдавлением дыхательных путей.

У детей гортань из гибких хрящей, устойчива к перелому, но подслизистый слой слабо прикреплён к надхрящнице: выше риск массивного отёка и гематомы, даже малая травма может повредить слизистую и заднюю стенку трахеи.

2.3 Классификация

1. по этиологии: механические (в том числе ятрогенные), огнестрельные, химические, термические;
2. по механизму: наружные, внутренние, тупые, острые (колотые, резаные);
3. по кожной ране: открытые, закрытые;
4. по проникновению в полость гортани: проникающие, непроникающие;
5. изолированные и сочетанные.

Тяжесть травмы гортани по Schaefer

Группа	Повреждения
1	незначительные эндоларингеальные гематомы без повреждения слизистой и хрящей
2	отёк, гематома, незначительные повреждения слизистой без обнажения хряща или перелом хряща без смещения
3	массивный отёк, большие разрывы слизистой, обнажённый хрящ, перелом хряща со смещением или неподвижность голосовых складок
4	как в 3 группе плюс серьёзные повреждения передних отделов, нестабильные переломы, две и более линии перелома или тяжёлые травмы слизистой
5	полный отрыв гортани от трахеи

Огнестрельные ранения гортани: касательные без проникновения в полость; проникающие слепые или сквозные без повреждения окружающих структур; проникающие с повреждением пищевода, сосудисто-нервного пучка, позвоночника. Травмы глотки делят на наружные и внутренние, по причине, повреждающему фактору (тупые, колото-резаные, огнестрельные, химические и термические ожоги, инородные тела), отделу глотки и распространённости.

2.4 Клиническая картина

Симптомы

1. нарушение дыхания — главный симптом, может развиться сразу или позже из-за отёка, инфильтрации, гематомы;
2. дисфония, афония — при всех травмах, особенно голосового отдела;
3. боль: от дискомфорта до выраженной;
4. дисфагия при повреждении входа в гортань, парезе, патологии глотки;
5. кашель — при инородном теле, внутреннем кровотечении, остром воспалении;
6. подкожная эмфизема шеи — проникающее повреждение гортани или трахеи, может распространяться на грудь и средостение;
7. кровотечение угрожает жизни при повреждении крупных сосудов, аспирации крови или гематоме, суживающей просвет;
8. проникающая рана: на выдохе пузырящийся кровавой пеной воздух, на вдохе засасывание воздуха с шипением;
9. внутренняя травма: кровохарканье, кровь изо рта;
10. повреждение гортанных нервов: парез гортани.

Внутренние повреждения глотки протекают легче наружных: пациент указывает место и причину (эндоскопия, еда, интубация); сразу боль при глотании, нарушение глотания, возможно кровотечение и нарастание отёка.

У детей дыхательные нарушения развиваются быстрее и тяжелее; тупая травма гортани и трахеи может протекать неявно и имитировать обычные респираторные болезни.

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. анамнез, не исключающий травму шеи; после травмы боль, затруднение дыхания, изменение голоса, затруднение глотания, кровотечение, одышка;
2. стридор на вдохе — обструкция надскладкового отдела (отёк, гематома); на выдохе — подскладкового отдела, трахеи; двухфазный — повреждение голосовой щели;
3. рана или отёк и гематома шеи, подкожная эмфизема;
4. исчезновение крепитации («щелчка») гортани при смещении в стороны;
5. на выдохе из раны пузырящаяся кровавая пена, кровь в слюне;
6. видеоларингоскопия: отёк, кровоизлияние, гематома, разрыв слизистой, деформация голосовой щели, нарушение подвижности складок;
7. КТ: деформация контуров шеи, эмфизема, перелом хрящей, изменения просвета, раневой канал, инородные тела, нарушение пассажа контраста при ранении глотки и пищевода.

Выясняют механизм травмы, время после неё, жалобы и их динамику; если пациент без сознания — у родственников или сопровождающих. Первичная оценка — по принципам расширенного жизнеобеспечения при травме (ATLS).

3.1 Ларингоскопия

Показания

1. все пациенты при поступлении в стационар.

Непрямая ларингоскопия зеркалом обязательна пациентам **12 лет и старше**; у дошкольников и младших школьников часто невозможна из-за эмоциональной лабильности и глоточного рефлекса.

Всем: оценка раны — локализация, размеры, глубина, края, отношение к сосудам и нервам; исключить инородные тела, наружное или горловое кровотечение, повреждение дыхательных путей.

Всем: пальпация шеи и грудной клетки для исключения подкожной эмфиземы.

3.2 Видеоларингоскопия и микроларингоскопия

Показания

1. все пациенты: гибкие и ригидные эндоскопы с углом обзора 70° и 90°.

Оценивают слизистую, отёк, голосовую щель и подвижность складок, подскладковый отдел и трахею; при ране — возможен ретроградный осмотр. У детей предпочтительна фиброларингоскопия.

Показания

1. 2–5 группы тяжести по Schaefer: уточнение диагноза, выбор метода и объёма лечения.

После обеспечения стойкой проходимости дыхательных путей: перстнечерпаловидное сочленение, слизистая, хрящевой каркас.

При наличии оборудования всем: ларингостробоскопия и электромиография гортани — объективная оценка подвижности голосовых складок.

Показания

1. дети с травмой гортани: УЗИ гортани в дополнение к ларингоскопии.

Видны подвижность складок и черпаловидных хрящей, их асимметрия, утолщение складок, переломы щитовидного хряща, гематомы.

3.3 КТ шеи и пищевода

Показания

1. подозрение на повреждение сосудов: КТ шеи, в том числе с внутривенным контрастированием.

Рентгенография мягких тканей шеи малоинформативна: видны только отёк, эмфизема, перелом подъязычной кости.

КТ показывает

1. хрящевой каркас гортани и подъязычную кость;
2. раневой канал и инородные тела;
3. вовлечение сосудов шеи;
4. распространённость эмфиземы.

Показания

1. подозрение на повреждение глотки, пищевода: КТ пищевода с пероральным контрастированием при поступлении.

Показания

1. проникающее ранение гортани или глотки: эзофагоскопия для исключения повреждения пищевода.

При любой травме гортани исключают повреждение шейного отдела позвоночника; при его выявлении — немедленная консультация профильного специалиста.

МРТ при осколочных и пулевых ранениях не выполняют: металлические инородные тела могут сместиться.

3.4 Анализы, пульсоксиметрия, посев

Показания

1. кровопотеря или подозрение на неё: общий анализ крови;
2. все пациенты: коагулограмма.

Дети с признаками стеноза: пульсоксиметрия — степень дыхательной недостаточности и необходимость кислорода.

Ранение гортани или глотки: посев отделяемого раны с определением чувствительности.

---

4. Лечение

Принципы при любой тактике

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей;
2. остановка кровотечения, восполнение кровопотери;
3. профилактика травматического шока;
4. противоотёчная, антибактериальная, дезинтоксикационная, противовоспалительная терапия.

Первоочередное внимание — проходимости дыхательных путей: своевременно распознать обструкцию или угрозу её и предотвратить аспирацию.

Лечение по тяжести травмы (Schaefer)

Группа	Тактика
1	обязательна гибкая эндоскопия гортани; обычно медикаментозно, без операции: системные кортикостероиды, антибиотики, антирефлюксные, увлажнение воздуха, голосовой покой

Группа	Тактика
2	дополнительно прямая ларингоскопия и эзофагоскопия; наблюдение в динамике, повреждения могут прогрессировать; иногда трахеотомия; та же медикаментозная терапия
«2» (так в КР, по смыслу 3)	прямая ларингоскопия или эзофагоскопия в операционной; часто трахеотомия, как правило, операция при разрыве передней комиссуры, обширных рваных ранах, разрывах и неподвижности складок, обнажении хряща, переломах со смещением, подвывихе черпаловидного хряща
«3» (по смыслу 4)	обязательны прямая ларингоскопия и эзофагоскопия; всегда трахеотомия; при операции — стент
«4» (по смыслу 5)	тяжёлая дыхательная недостаточность: эндоскопия откладывается до восстановления проходимости; повреждения на уровне перстневидного хряща, перстнетрахеального соединения — трахеотомия (может быть сложной), ларинготрахеопластика

4.1 Консервативное лечение

Показания

1. ссадины и поверхностные повреждения кожи;
2. тупые наружные и внутренние травмы с отёком, ссадинами, гематомами без повреждения хрящей или без смещения отломков;
3. нет нарастания дыхательной недостаточности и гнойного воспаления в тканях шеи.

Ссадины обрабатывают антисептиком и закрывают асептической повязкой; при стабильном состоянии — симптоматическая терапия.

Инфицированная рана или высокий риск инфицирования: антисептики — бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, повидон-йод, хлоргексидин, у взрослых и детей; до разрешения инфекции или эпителизации.

Показания

1. признаки стеноза верхних дыхательных путей: ингаляции лекарственных препаратов и кислорода.

После травмы и при эвакуации — прохладный кислород через маску.

Будесонид ингаляционно

1. взрослые: раствор 1,0 мг 1–2 раза в день, 5–8 процедур;
2. дети **старше 6 месяцев**: суспензия 0,25–0,5 мг 1–2 раза в день, 5 процедур.

Ингаляция обычно 10 минут, между ингаляциями разных препаратов около 30 минут.

Открытая и закрытая травма: противоотёчная терапия — парентерально системные кортикостероиды и диуретики.

Голосовой режим: не кричать и не шептать **не менее 2 дней**; полный голосовой покой **1–2 суток**, затем ограничение нагрузки. Исключить острую, солёную, горячую, холодную пищу, алкоголь, курение.

Рана или воспаление слизистой гортани и гортаноглотки: препараты для лечения язвенной болезни и ГЭРБ (A02BX) — защита от желудочного содержимого.

Ранение гортаноглотки, пищевода, выраженный отёк гортаноглотки, невозможность питаться естественным путём: назогастральный зонд и парентеральное питание.

4.2 Обезболивание

Показания

1. все пострадавшие: анальгетики и НПВП, отдельно или в комбинации, в том числе НПВП с парацетамолом, метамизол натрия; также после операции.

Ограничения у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев — свечи и суспензия, с 6 лет — таблетки, с 12 лет — капсулы;
2. кетопрофен: с 6 лет — гранулы, с 15 лет — парентерально;
3. метамизол натрия: амбулаторно не применять; в стационаре — только если нет других разрешённых детям анальгетиков.

Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г в/в инфузия 15 мин	4 ч	4 г	5–7 сут
Диклофенак	75 мг в/м (в КР «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 сут
Кеторолак	30 мг в/в, в/м	6 ч	60–90 мг	2 сут
Кетопрофен	100 мг в/в, в/м	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Лорноксикам	8 мг в/в, в/м	12 ч	16 мг	1–7 сут
Декскетопрофен	50 мг в/в, в/м	8–12 ч	150 мг	2 сут
Метамизол натрия	500–1000 мг в/в, в/м	8–12 ч	2 г	1–5 сут

Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол в/в	инфузия 15 мин: более 50 кг — 1000 мг; 10–50 кг — 15 мг/кг; менее 10 кг — 7,5 мг/кг; новорождённым до 1 месяца противопоказан	4 ч	более 50 кг — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг	5–7 сут
Парацетамол внутрь, суспензия	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 сут
Парацетамол ректально	10–14 лет 350–500 мг; 5–10 лет 250–350 мг; 3–5 лет 150–200 мг; 1–3 года 100–150 мг; 3–12 мес 50–100 мг	4–6 ч	менее 60 мг/кг	до 5 сут
Ибупрофен внутрь	старше 6 лет 200–400 мг; 4–6 лет 150 мг; 1–3 года 100 мг; 6–12 мес 50 мг; 3–6 мес 50 мг	8 ч; 6–8 ч (в таблице КР не сопоставлены с возрастами построчно)	12–17 лет 1 г; 6–12 лет 800 мг; 4–6 лет 450 мг; 1–3 года 300 мг; 6–12 мес 200 мг; 3–6 мес 150 мг	4 сут
Ибупрофен ректально	3–9 мес 60 мг; 9–24 мес 60 мг	3–9 мес 8 ч; 9–24 мес 6 ч	3–9 мес 180 мг; 9–24 мес 240 мг	не более 3 сут
Кетопрофен в/в, в/м	с 15 лет 100 мг	12 ч	200 мг	не более 2 сут

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кетопрофен внутрь, гранулы	старше 6 лет 40 мг	8 ч	120 мг	не более 2 сут
Метамизол натрия	с 15 лет 500–1000 мг в/в, в/м; 3 мес – 1 год 50–100 мг/10 кг в/м	8–12 ч	с 15 лет 2 г	3 сут

4.3 Антибиотики, столбняк, гемостатики

Показания

1. открытая рана, осложнения, сочетанные повреждения: системная антибактериальная терапия (близость ротоглотки повышает риск инфекции).

Цефалоспорины III поколения (цефотаксим или цефтриаксон) и инфузионно метронидазол; при распространении эмфиземы в средостение и риске медиастинита — меропенем. Доза и длительность — по клинической ситуации.

Антибиотики при травмах шеи

Препарат	Разовая доза	Кратность	Длительность
Цефотаксим в/в, в/м	взрослые и дети старше 12 лет (более 50 кг): 1 г; дети до 12 лет (менее 50 кг): 50–75 мг/кг; новорождённые: 25 мг/кг	2 раза в сутки	7–10 дней
Цефтриаксон в/в, в/м	взрослые 1–2 г; дети 2 мес – 12 лет: 20–100 мг/кг; новорождённые (с 15 дней), грудные и младшего возраста: 20–80 мг/кг	1 раз в сутки	7–10 дней
Метронидазол в/в капельно, 5 мл/мин	старше 12 лет: 500 мг; до 12 лет: 7,5 мг/кг	3 раза в сутки	7–10 дней

Повреждение кожи и слизистой с загрязнением раны: экстренная профилактика столбняка как можно раньше, **до 20-го дня** после травмы — столбнячный анатоксин, противостолбнячный иммуноглобулин человека или сыворотка по инструкции.

Показания

1. наружное кровотечение или кровотечение из горла: гемостатические средства; небольшие наружные — давящая асептическая повязка.

Дозы

1. этамзилат: взрослым 250–500 мг в/в или в/м, затем по 250 мг каждые 4–6 ч; детям 10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней;
2. транексамовая кислота: в/в медленно 1 мл/мин (50 мг/мин); взрослым 10–15 мг/кг каждые 6–8 ч, детям старше 1 года 20 мг/кг в сутки — до остановки кровотечения;
3. аминокапроновая кислота в/в капельно: взрослым 4–5 г за первый час, затем по 1 г/ч не более 8 ч, максимум 30 г в сутки; детям 100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг/ч, максимум 18 г/м^2 в сутки; курс 3–14 дней.

4.4 Хирургическое лечение

Показания

1. стеноз гортани в стадии декомпенсации;
2. кровотечение;
3. открытая, загрязнённая рана, инородные тела, нежизнеспособные ткани, потеря мягких тканей, дефицит кожи;
4. выраженная или нарастающая эмфизема;
5. перелом хрящей гортани со смещением, суживающим просвет.

Показания

1. значительный, особенно нарастающий отёк гортани: трахеотомия в сознании.

На месте травмы допустимо ввести трубку через рану в гортань или трахею, коникотомия или крикотиреоидотомия с последующей заменой на типичную трахеостому с подшиванием трахеи к коже. По возможности избегают интубации. Детям трахеотомию — только под комбинированным ингаляционным наркозом.

Тяжёлые ранения шеи — тактика контроля повреждений (damage control surgery): сокращённая первая операция, окончательное восстановление после стабилизации.

Первый этап

1. устранение асфиксии: интубация, типичная или атипичная трахеотомия;
2. остановка кровотечения: сосудистый шов, перевязка, тугая тампонада, временное протезирование сонных артерий;
3. защита тканей шеи от содержимого полых органов: швы или мазевые тампоны;
4. иммобилизация шеи воротником Шанца при ранении позвоночника.

Интубационная трубка — на размер меньше расчётной, с сохранением иммобилизации шейного отдела.

Показания

1. кровотечение из горла: тампонада раны, коагуляция сосуда, сшивание раны;
2. массивное некупируемое: эндоваскулярная окклюзия или перевязка наружной сонной артерии;
3. обширное повреждение гортани с неясным источником: перевязка верхней щитовидной или наружной сонной артерии после трахеотомии ниже места повреждения.

Кровотечение останавливают экстренно для профилактики геморрагического шока: давящая повязка и гемостатики, при неэффективности — лигатуры на сосуд в ране.

4.5 Хирургическая обработка раны

Объём по типу раны

1. поверхностная: обработка, санация, первичный шов;
2. глубокая с повреждением мягких тканей: рассечение, иссечение, восстановление структур, дренирование, шов, противовоспалительная и антибактериальная терапия;
3. обширные скальпированные и размозжённые: первичная обработка, первичная или отсроченная пластика кожи, восстановление структур, дренирование, по показаниям трансфузия.

Обработка ран гортани — экономная и ранняя, слизистая максимально сохраняется. Раны гортани и трахеи **до 0,5 см** можно не ушивать и лечить дренированием.

Первичную хирургическую обработку не проводят

1. поверхностные раны, царапины, ссадины;
2. раны с расхождением краёв **менее 1 см**;
3. множественные мелкие раны без повреждения мышц и фасций;
4. колотые раны без повреждения органов, сосудов, нервов.

Туалет раны, края можно свести пластырем.

Все раны дренируют доступными способами до прекращения отделяемого.

При инфицировании раны и гнойных осложнениях рану не ушивают до их купирования.

4.6 Переломы и разрывы гортани

Любые переломы хрящей гортани со смещением фиксируют. Сроки спорны: одни авторы оперируют в первые **24–48 часов**, другие откладывают на неделю и более до уменьшения отёка — решают индивидуально.

Показания

1. разрыв слизистой двух и более анатомических областей, свободного края голосовых складок, переломы хрящевого каркаса: тиреоидотомия.

Слизистую восстанавливают, раны складок ушивают рассасывающимся швом 5/0 или 6/0; открытые хрящи закрывают. Перелом **более чем в 3 мм** от передней комиссуры — всё равно срединная тиреоидотомия.

Смещённые черпаловидные хрящи восстанавливают по степени повреждения; изолированные рваные раны укрывают слизистой.

Проникающее ранение с повреждением хрящей без значительного смещения: ларинготрахеопластика местными тканями после типичной трахеотомии; при необходимости наружный и эндоскопический доступ, в просвет на несколько дней — пальчиковый обтуратор.

Ларинготрахеостома при проникающем ранении

1. значительное разрушение и смещение хрящей;
2. разрывы в области передней комиссуры;
3. выраженная рубцовая деформация просвета.

В первые дни — тампон по Микуличу с мазью на основе хлорамфеникола, затем силиконовый протез. Оскольчатые переломы часто требуют стента и наружной фиксации; при стабильных переломах с минимальным повреждением слизистой стентирования избегают.

Перелом подъязычной кости с отрывом гортани: ларингогиоидопексия; отрыв гортани от трахеи: трахеоларингопексия (низкий трахеотомический разрез — трахея втягивается за грудину). Отрыв гортани обычно сопровождается пневмотораксом — его выявляют и лечат.

Хирургическая обработка и манипуляции в гортани — под местными анестетиками с учётом раны, боли и аллергоанамнеза.

Общая восстановительная диета, полноценная по составу, кроме пациентов с заболеваниями, требующими коррекции диеты (сахарный диабет и другие). С зондом или гастростомой — энтеральное или парентеральное питание.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания

1. все пациенты с травмой гортани и глотки: наблюдение за проходимостью дыхательных путей.

Лёгкие травмы, которые могут прогрессировать (отёк, гематома), — стационар **24–48 часов**, особенно дети.

У детей риск кардиогенного шока

1. брадикардия, аритмия;
2. падение артериального давления;
3. остановка сердца.

Небольшие непрогрессирующие гематомы при целой слизистой обычно рассасываются, большие или нарастающие могут потребовать трахеотомии.

Все, кто оказывает помощь на догоспитальном и госпитальном этапах, должны знать признаки обструкции дыхательных путей и владеть навыками поддержания дыхания с защитой шейного отдела позвоночника; на всех уровнях должны быть возможности интубации, коникотомии, трахеотомии.

5.2 Реабилитация и наблюдение

1. после тупой травмы с повреждением гортани и после ларинготрахеопластики без ларингостомы или после её закрытия: повторный осмотр оториноларинголога в поликлинике, при нарушении голоса — фониатр;
2. после ларинготрахеопластики с формированием ларингостомы: наблюдение оториноларинголога стационара.

Пациентам с открытой раной шеи и сформированной ларингостомой — наблюдение оториноларинголога стационара.

Повторный осмотр оториноларинголога **через 1 месяц**, затем **раз в 3 месяца** в течение года — выявить показания к реконструктивной операции: видеоларингоскопия, ларингостробоскопия, по показаниям функция внешнего дыхания. Сроки деканюляции и восстановления просвета — индивидуально.

Профилактика ятрогенной травмы при ИВЛ, ЭГДС, бронхоскопии: интубация и эндоскопия максимально аккуратно, при трудной интубации — видеоларингоскоп. Специфической профилактики других травм гортани и глотки нет.

Факторы неблагоприятного исхода операции

1. системные: пожилой возраст, иммунодефицит, кахексия, инфекция, онкологический процесс, нарушения углеводного обмена, коллагенозы;
2. местные: повреждение пищевода, сосудисто-нервного пучка, позвоночника, флегмона шеи, медиастинит, повторная травма, инфекция, инородные тела.

При первичной пластике и восстановлении просвета грубой деформации обычно нет, но травмы гортани и трахеи часто инвалидизируют и могут потребовать повторных реконструктивных операций.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма гортани»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 19.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года

Код в рубрикаторе	813_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 3 тактика по тяжести травмы описана для групп «1, 2, 2, 3, 4», а классификация Schaefer в разделе 1.5 содержит 5 групп: нумерация в лечебном разделе сдвинута. На странице группы подписаны так, как в КР, с пометкой о соответствии по смыслу.
- Таблица 1: разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — по смыслу 75 мг.
- Таблица 2: для парацетамола внутривенно у детей максимальные суточные дозы заданы для пересекающихся весовых групп «33–50 кг» и «10–50 кг» с разными пределами (3 г и 2 г). Сверяйте с инструкцией.

Клинические рекомендации

Травма носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.3** — Поверхностная травма носа **S01.2** — Открытая рана носа **S02.2** — Перелом костей носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/815_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Для выявления перелома костей носа взрослым и детям **с 3 лет** выполняют рентгенографию костей лицевого скелета в боковой проекции. Чувствительность метода не превышает 70%, поэтому отсутствие изменений на рентгенограмме не исключает перелома.
- При гематоме или абсцессе перегородки носа показаны вскрытие и дренирование с последующей передней тампонадой и ежедневными перевязками до прекращения отделяемого.
- При травматической деформации носа показаны репозиция костей и фиксация отломков:
  1. ранняя операция **в первые 7 суток**;
  2. при тяжёлом состоянии или выраженном отёке вмешательство может быть отложено **до 15 суток**.
- При изолированном переломе, в том числе открытом, рутинное назначение системных антибиотиков не показано. Показания к антибактериальной терапии:
  1. загрязнённые и гнойные раны;
  2. выраженный отёчно-токсический синдром;
  3. осложнённая гематома или абсцесс перегородки носа;
  4. сочетанная и комбинированная травма;
  5. тяжёлая сопутствующая патология.
- При повреждении кожи или слизистой оболочки и загрязнении раны землёй необходима экстренная профилактика столбняка в максимально ранние сроки, но **не позднее 20-го дня** после травмы.
- Показания к госпитализации:
  1. тяжёлое состояние;
  2. кровотечение;
  3. выраженный отёк или болевой синдром;
  4. деформация носа со смещением перегородки;
  5. осложнения травмы;
  6. тяжёлая сопутствующая патология;
  7. приём антикоагулянтов или антиагрегантов;
  8. необходимость закрытой репозиции.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Травма носа представляет собой повреждение носа в результате прямого или опосредованного воздействия травмирующего фактора снаружи или изнутри, сопровождающееся нарушением целостности тканей и структур наружного носа и полости носа и нарушением функций носа.

Поверхностной называется травма наружного носа без повреждения кожи, костей носа и слизистой оболочки полости носа и без неврологической симптоматики.

Ушиб носа является закрытым повреждением тупым предметом без видимого нарушения целостности кожи и слизистых оболочек, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием. При кровоподтёке кровь пропитывает мягкие ткани наружного носа, тогда как гематома представляет собой скопление крови в ограниченной полости. Ссадиной называется повреждение поверхностного слоя кожи с визуально определяемым местом размозжения кожных сосудов.

Перелом костей носа (ПКН) характеризуется частичным или полным нарушением целостности носовых костей, лобных отростков верхней челюсти, перегородки носа или носовой ости. Перелом считается закрытым при сохранённой целостности кожи носа и открытым, если отломки сообщаются с внешней средой через рану.

Раной носа называется повреждение кожи наружного носа на всю глубину, часто с обнажением хрящей и костей и более глубоких структур полости носа, в ряде случаев с отрывом крыла или кончика носа.

2.2 Механизм травмы

При ударе во фронтальной плоскости возникает перелом носовых костей с западением спинки носа. Боковой удар может приводить к разъединению носовой кости и лобного отростка верхней челюсти с формированием сколиоза наружного носа, однако чаще линия перелома проходит выше шва между ними. Как правило, одновременно возникает перелом перегородки носа, чаще её хрящевого отдела.

У детей младшего возраста кости наружного носа эластичны, поэтому переломы встречаются редко, а гематома и абсцесс перегородки носа чаще.

При переломе нередко происходит разрыв и отслойка надхрящницы или надкостницы перегородки, кровь скапливается между хрящом и надхрящницей, и формируется гематома перегородки носа. При её инфицировании развивается абсцесс, четырёхугольный хрящ расплавляется, что приводит к деформации носа и нарушению его функций.

Травма носа может быть изолированной или сочетаться с повреждением околоносовых пазух, глаза, скуловой области, нижней челюсти, полости рта, ушной раковины, сотрясением или ушибом головного мозга.

2.3 Классификация

Общепринятая классификация переломов отсутствует. Согласно классификации Ю. Н. Волкова (1958), выделяют открытые и закрытые переломы, переломы без деформации и с деформацией наружного носа.

Согласно классификации С. Б. Бесшапочного (1984), переломы подразделяются на переломы без деформации и с деформацией наружного носа; последние могут быть одно- и двусторонними, с боковым смещением отломков, со смещением кзади или с сочетанием обоих видов смещения.

Согласно классификации А. С. Лопатина (2019), выделяют изолированные и сочетанные, открытые и закрытые переломы; переломы со смещением подразделяются по направлению удара на латеральные, фронтальные, фронтолатеральные и базальные.

По распространённости

1. изолированные: с деформацией наружного носа или без неё;
2. комбинированные: с травмой кожи лица, внутриносовых структур или околоносовых пазух;
3. сочетанные: с челюстно-лицевой или черепно-мозговой травмой, травмой конечностей, туловища и внутренних органов.

Стадии перелома со смещением

1. острая стадия: **первые 14 дней**; кости репонируют по стандартной методике;
2. застарелый перелом: **от двух недель до двух месяцев**; репозиция возможна только в сочетании с операцией на перегородке носа;
3. стойкая деформация: давность травмы **более двух месяцев**; сопоставление отломков возможно только после остеотомии.

2.4 Клиническая картина

Поверхностная травма характеризуется слабо выраженными проявлениями: в месте удара отмечаются боль, небольшая припухлость и умеренная гиперемия кожи без нарушения её целостности.

Признаки по видам травмы

1. ушиб: пирамида носа увеличена в объёме, контуры сглажены за счёт отёка;
2. кровоподтёк и ссадина: изменены цвет и целостность кожи;
3. перелом: пирамида носа смещена в сторону или вдавлена;
4. гематома: перегородка носа утолщена, носовые ходы сужены.

Возможны также

1. носовое кровотечение;
2. боль и болезненность при пальпации;
3. нарушение дыхания и обоняния.

При сочетанной травме

1. отёки, кровоподтёки, гематомы и раны других областей;
2. нарушения зрения и сознания.

Признаки перелома

1. отёк;
2. боль;
3. деформация наружного носа;
4. крепитация и подвижность отломков;
5. носовое кровотечение;
6. затруднение носового дыхания.

У детей с переломом деформация носа вследствие выраженного отёка определяется лишь в 57,5% случаев. Кроме того, у 7,4% детей деформация имелась до травмы.

При переломе нередко повреждены кожа носа и слизистая оболочка полости носа, возможны эмфизема мягких тканей носа и лица, экхимозы. Носовое кровотечение встречается часто, однако при неосложнённом изолированном переломе обильное и рецидивирующее кровотечение отмечается редко.

Перелом часто сопровождается кровоизлиянием в веки и мягкие ткани орбиты («симптом очков»), однако этот же симптом наблюдается при переломе переднего основания черепа и травме кавернозного синуса.

Крепитация и подвижность отломков выявляются менее чем в половине случаев, поэтому их отсутствие не исключает перелома. Болевой синдром в области носа также неспецифичен и встречается при ушибах и воспалительных заболеваниях носа.

2.5 Жалобы и анамнез

Необходимо выяснить

1. обстоятельства и механизм травмы, направление удара;
2. потерю сознания;
3. перенесённые ранее травмы носа с деформацией и операции на носу;
4. прививочный анамнез в отношении столбняка при комбинированной травме с повреждением кожи.

При общем осмотре оценивают артериальное давление, пульс и частоту дыхания.

3. Диагностика

Основания для диагноза

1. факт травмы со слов пострадавшего или очевидцев;
2. жалобы на боль, изменение формы носа, затруднение дыхания, кровотечение, нарушение обоняния;
3. данные осмотра: повреждения кожи, деформация, крепитация и подвижность отломков, кровотечение.

Подтверждение перелома

1. рентгенография костей лицевого скелета, при противопоказаниях ультразвуковое исследование (УЗИ) костей носа;
2. при сочетанной травме рентгенография черепа и компьютерная томография (КТ) для выявления повреждений околоносовых пазух, орбиты, скуловой кости, верхней челюсти и черепа.

3.1 Осмотр и пальпация

Показания

1. каждый пациент с травмой носа: осмотр оториноларинголога для определения характера и выраженности повреждений.

Показания

1. все пациенты: пальпация челюстно-лицевой области.

Диагностические признаки

1. отёк, гематомы, ссадины и раны;
2. наличие и выраженность деформации;
3. крепитация отломков;
4. подкожная эмфизема и гематома;
5. состояние области носового клапана, подвижность крыльев носа и подвижной части перегородки.

Для врачебной и судебно-медицинской экспертизы важна фотофиксация повреждений.

3.2 Коагулограмма

Показания

1. травма, сопровождающаяся кровотечением: оценка системы гемостаза и кровопотери, подготовка к возможному хирургическому вмешательству.

3.3 Рентгенография костей лицевого скелета

Показания

1. взрослые и дети **с 3 лет**: выявление костных повреждений.

Рентгенограмма в боковой проекции имеет как диагностическое, так и юридическое значение: в 70,2% случаев она позволяет выявить перелом и характер смещения отломков.

Как правило, повреждаются обе носовые кости, однако встречаются одиночные и множественные переломы, поэтому для уточнения стороны перелома боковые снимки выполняют в положении головы на левой и на правой стороне.

Ограничения

1. чувствительность при переломе костей носа не превышает 70%;
2. смещение во фронтальной плоскости на боковом снимке не визуализируется;
3. у детей **до 3 лет** исследование малоинформативно вследствие слабой оссификации и преобладания хрящевой ткани.

Поэтому отрицательный результат не исключает перелома.

3.4 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на смещение отломков в переднезаднем направлении при отсутствии изменений на боковом снимке (взрослые и дети **с 3 лет**).

Смещение отломков снаружи внутрь, не определяемое на боковых снимках, выявляется на рентгенограмме околоносовых пазух в носоподбородочной проекции.

3.5 Компьютерная томография

КТ лицевого отдела черепа или челюстно-лицевой области и (или) КТ головного мозга.

Показания

1. комбинированные и сочетанные переломы;
2. признаки черепно-мозговой травмы (ЧМТ);
3. неинформативность рентгенографии при клинических признаках перелома;
4. планирование расширенного вмешательства;
5. подозрение на назальную ликворею;
6. тяжёлое состояние;
7. продолжающееся или рецидивирующее носовое кровотечение.

Область исследования определяется сопутствующей патологией.

1. чувствительность КТ при переломе приближается к 100%;
2. спиральное сканирование, толщина среза 3 мм;
3. оценивают положение отломков, состояние перегородки носа, повреждения околоносовых пазух, орбиты, мозгового черепа, мягких тканей и головного мозга;
4. перед операцией рекомендуется 3D-реконструкция.

3.6 Ультразвуковое исследование костей носа

Показания

1. противопоказания к лучевым методам;
2. контроль репозиции и сращения отломков (исследование можно повторять).

УЗИ является простым неинвазивным методом, не сопряжено с лучевой нагрузкой и может выполняться повторно для контроля репозиции и сращения отломков. Исследование выполняют в четырёх проекциях: передней продольной, передней поперечной, правой и левой боковой.

3.7 Консультации специалистов

Показания

1. подозрение на повреждение органа зрения: консультация офтальмолога.

Показания

1. все пациенты с травмой носа: консультация невролога для своевременного выявления сопутствующей патологии.

Показания

1. массивное кровотечение;
2. сочетанная травма.

4. Лечение

Консервативное лечение направлено на уменьшение болевого синдрома и отёка, профилактику бактериального воспаления в зоне повреждения, ускорение заживления и восстановление функций носа.

4.1 Обезболивание

Всем пациентам при отсутствии противопоказаний назначаются анальгетики.

Выраженный болевой синдром и травматический стресс способствуют развитию или утяжелению травматического шока.

Анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по отдельности или в сочетании; у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде, рекомендуется сочетание НПВП с парацетамолом, а также метамизол натрия.

НПВП у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев;
2. кетопрофен: с 15 лет;
3. кетопрофен в гранулах для приготовления раствора: с 6 лет.

Метамизол натрия детям амбулаторно не назначают; в стационаре только при отсутствии других разрешённых детям анальгетиков (риск серьёзных нежелательных явлений).

4.2 Анальгетики у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г внутривенно, инфузия 15 минут	4 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 мг внутримышечно (в таблице рекомендации указано «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно, внутримышечно	6 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м», то есть единица измерения приведена неверно; с учётом структуры таблицы и максимальной суточной дозы 150 мг речь идёт о 75 мг.

4.3 Анальгетики у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия 15 минут: масса тела менее 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; более 50 кг — 1000 мг	4 ч	Менее 10 кг — до 30 мг/кг; 10–50 кг — до 60 мг/кг, но не более 2 г (для 33–50 кг в той же ячейке указано не более 3 г); более 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 суток
Парацетамол ректально	3–12 месяцев — 50–100 мг; 1–3 года — 100–150 мг; 3–5 лет — 150–200 мг; 5–10 лет — 250–350 мг; 10–14 лет — 350–500 мг	6 ч	до 60 мг/кг	до 5 суток
Ибупрофен внутрь	3–6 месяцев — 50 мг; 6–12 месяцев — 50 мг; 1–3 года — 100 мг; 4–6 лет — 150 мг; старше 6 лет — 200–400 мг	6–8 ч (в ячейке указано также «8 ч» без пояснения)	3–6 месяцев — 150 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 1–3 года — 300 мг; 4–6 лет — 450 мг; 6–12 лет — 800 мг; 12–17 лет — 1 г	4 суток
Ибупрофен ректально	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	3–9 месяцев — 8 ч; 9–24 месяца — 6 ч	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	не более 3 суток
Метамизол натрия	С 15 лет — 500–1000 мг внутривенно, внутримышечно; 2–14 лет — 50–100 мг/кг внутримышечно, внутривенно; от 3 месяцев до года — 50–100 мг на 10 кг внутримышечно	8–12 ч	с 15 лет — 2 г	1–5 суток; детям младше 15 лет — 3 суток

> В таблице 3 имеются несогласованности. Для внутривенного парацетамола весовые диапазоны пересекаются: для массы тела 33–50 кг указана максимальная суточная доза 3 г, для 10–50 кг 2 г. Для метамизола натрия детям 2–14 лет указана доза 50–100 мг/кг, детям до года 50–100 мг на 10 кг, то есть в 10 раз меньше в пересчёте на килограмм массы тела. Дозы следует сверить с инструкцией по медицинскому применению.

4.4 Профилактика столбняка и антибактериальная терапия

Вакцина для профилактики столбняка показана при повреждении кожи или слизистой оболочки, если:

1. травма получена при ударе о землю;
2. в рану попала почва.

Экстренную профилактику выполняют в максимально ранние сроки, **вплоть до 20-го дня** после травмы, с учётом инкубационного периода столбняка.

Экстренная профилактика включает

1. первичную хирургическую обработку раны;
2. одновременное введение столбнячного анатоксина, противостолбнячного иммуноглобулина человека или столбнячного антитоксина в соответствии с инструкцией.

При изолированном переломе костей носа, в том числе открытом, рутинное назначение системных антибиотиков до и после операции не рекомендуется.

Профилактическое применение антибиотиков не снижает риск инфекционных осложнений после репозиции костей носа ни у взрослых, ни у детей.

Показания к системным антибиотикам:

1. загрязнённые и гнойные раны кожи и слизистой оболочки;
2. выраженный отёчно-токсический синдром;
3. осложнённая гематома или абсцесс перегородки носа;
4. сочетанная и комбинированная травма;
5. тяжёлая сопутствующая патология.

При явном бактериальном воспалении или высоком риске его развития применяют бета-лактамы широкого спектра действия:

1. цефазолин;
2. цефтриаксон;
3. ампициллин с сульбактамом;
4. амоксициллин с клавулановой кислотой.

При аллергии на бета-лактамы применяют клиндамицин.

Ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой обладают более широкой, чем цефазолин, активностью в отношении грамотрицательных и анаэробных бактерий.

Препарат	Доза
Ампициллин и сульбактам	Внутримышечно и внутривенно. Взрослым в зависимости от тяжести инфекции 3–12 г в сутки в 3 введения, детям — 150 мг/кг в сутки в 3 введения (новорождённым — в 2), в течение 5–14 дней.
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутривенно. Взрослым и детям старше 12 лет — по 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, детям младше 12 лет — 25 мг/кг 3 раза в сутки, в течение 5–14 дней.

4.5 Противоотёчная, гемостатическая и местная терапия

При выраженном отёке взрослым и детям **старше 15 лет** назначаются ангиопротекторы, что позволяет выполнить репозицию отломков в более ранние сроки и предупредить осложнения.

Троксерутин (взрослым и детям **старше 15 лет**) или гель гепарина натрия наносится местно на спинку носа на неповреждённую кожу 2 раза в день до регресса отёка.

При обильном кровотечении, а также для профилактики интра- и послеоперационного кровотечения назначаются гемостатические средства.

Кровотечение возможно из полости носа и из повреждённых мягких тканей при открытых ранах. Механическая остановка кровотечения, как правило, дополняется назначением гемостатиков: этамзилата, транексамовой или аминокапроновой кислоты.

Препарат	Взрослые	Дети
Этамзилат	Для остановки кровотечения — 250–500 мг внутривенно или внутримышечно, затем по 250 мг каждые 4–6 часов. При репозиции — 250–500 мг за час до операции, при необходимости 250–500 мг во время операции и 500–750 мг равномерно в течение суток после неё.	10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней. Во время операции — 8–10 мг/кг внутривенно, затем 10–15 мг/кг в течение суток.
Транексамовая кислота	Внутривенно капельно или медленно струйно со скоростью 1 мл/мин (50 мг/мин), 10–15 мг/кг каждые 6–8 часов до остановки кровотечения.	Старше 1 года — 20 мг/кг в сутки до остановки кровотечения.
Аминокапроновая кислота	Внутривенно капельно: 4–5 г за первый час, при продолжающемся кровотечении — по 1 г в час не более 8 часов; при необходимости инфузии повторяются каждые 4 часа; не более 30 г в сутки. Курс 3–14 дней.	100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг в час; не более 18 г/м² в сутки (до года — 3 г, 2–6 лет — 3–6 г, 7–10 лет — 6–9 г, старше 10 лет — как взрослым). При острой кровопотере: до года — 6 г, 2–4 года — 6–9 г, 5–8 лет — 9–12 г, 9–10 лет — 18 г.

> Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере превышают указанные рядом максимальные суточные дозы: например, до года 6 г при максимуме 3 г, в 9–10 лет 18 г при максимуме 6–9 г.

Всем пациентам для облегчения носового дыхания назначаются деконгестанты и другие назальные препараты.

Сосудосуживающие спреи и капли уменьшают реактивный отёк слизистой оболочки после травмы и облегчают носовое дыхание после операции.

Препарат	Доза
Фенилэфрин 0,125%	Интраназально: до года — 1 капля, 1–6 лет — 1–2 капли, старше 6 лет — 3–4 капли до 3 раз в сутки, до 7 дней.
Оксиметазолин	До года — 0,01%, 1–6 лет — 0,025%, старше 6 лет — 0,05%; по 1–2 капли интраназально 2–3 раза в сутки, до 5 дней.
Ксилометазолин	2–6 лет — 0,05%, старше 6 лет — 0,1%; спрей по 1 дозе 2–3 раза в сутки, до 5 дней.

При повреждении кожи или слизистой оболочки с признаками инфицирования раны или высоким риском инфицирования назначаются местные антисептики.

1. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (в форме спрея не применяют у детей **до 3 лет**);
2. повидон-йод;
3. хлоргексидин.

Кратность обработки раны по выраженности воспаления и количеству экссудата; обработку продолжают до разрешения инфекции или начала заживления.

Всем пациентам показано промывание полости носа для ускорения заживления слизистой оболочки.

Уход за полостью носа после травмы и операции ускоряет заживление и предупреждает осложнения, например синехии. Применяются стерильные изотонические растворы морской воды 2–3 раза в день до эпителизации слизистой оболочки и стихания воспаления.

4.6 Хирургическое лечение

Неотложные мероприятия при травме носа включают остановку кровотечения и первичную хирургическую обработку открытых ран. При переломе хирургическое лечение направлено на восстановление формы наружного носа, устранение смещения внутриносовых структур и восстановление дыхания.

При открытых ранах и открытых переломах выполняется хирургическая обработка раны с иссечением инфицированных тканей и наложением косметического шва.

Перед наложением шва необходимы тщательная ревизия раны, удаление инородных тел и зондирование раневого канала.

При неэффективности гемостатической терапии и тампонады показана хирургическая остановка кровотечения.

Метод определяется источником кровотечения.

1. из передних отделов: отслойка участка мукоперихондрия с последующей тампонадой, выскабливание расширенного сосуда, криокоагуляция или электрокаустика;
2. обильное кровотечение: перевязка наружной сонной артерии, эндоскопическое клипирование сосудов или эндоваскулярная эмболизация;
3. из решётчатых артерий: этмоидотомия наружным, внутренним или эндоназальным доступом.

При гематоме или абсцессе перегородки носа показаны вскрытие и дренирование.

После вскрытия выполняют переднюю тампонаду, перевязки проводят ежедневно до прекращения отделяемого.

При травматической деформации наружного носа показаны репозиция костей и фиксация отломков для восстановления формы носа и носового дыхания.

Сроки операции

1. ранняя: **в первые 7 суток** после травмы;
2. отложенная: **на 8–15-е сутки**;
3. плановая: **через 6 месяцев** и позднее.

Показания к ранней операции:

1. минимальный или умеренный отёк;
2. комбинированная травма с повреждением внутриносовых структур или околоносовых пазух;
3. гематома перегородки носа.

Раннее вмешательство позволяет избежать септических осложнений и синехий.

Операция может быть отложена **до 15 суток**:

1. при тяжёлом состоянии;
2. при выраженном отёке;
3. при комбинированных переломах костей и перегородки носа;
4. при ранениях лица.

> Согласно классификации в разделе 1.5, острая стадия, в которой репозиция костей выполняется по стандартной методике, продолжается 14 дней, а по истечении двух недель репозиция возможна только в сочетании с операцией на перегородке носа. В разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.

Показания к плановому хирургическому лечению переломов (риносептопластике):

1. сочетанная травма с переломом основания черепа и назальной ликвореей;
2. тяжёлые функциональные нарушения.

Способы репозиции

1. наружный (пальцевой);
2. эндоназальный (инструментальный);
3. экстраназальный (открытый): при одновременном вмешательстве по поводу внутричерепной травмы или травмы лобных пазух и верхней челюсти.

У детей наружный способ эффективен лишь в 22% случаев, поэтому предпочтительна эндоназальная репозиция элеваторами Манакова или Волкова с последующей передней тампонадой.

При комбинированных назосептальных переломах в остром периоде репозицию костей сочетают с септопластикой. При сочетанной травме репозицию предпочтительно проводить совместно с хирургами других специальностей, если вмешательство выполняется под наркозом.

При подозрении на черепно-мозговую травму репозиция откладывается до осмотра невролога или нейрохирурга и проведения необходимых исследований.

4.7 Анестезия, тампонада и фиксирующая повязка

При операциях по поводу открытых и закрытых переломов и смещения внутриносовых структур проводится анестезия наружного носа и полости носа.

Взрослым при изолированной травме применяют аппликационную анестезию слизистой оболочки полости носа в сочетании с внутримышечным введением анальгетиков или проводниковую анестезию артикаином. Детям рекомендуется сочетанная анестезия.

При переломах костей наружного носа и внутриносовых структур выполняется передняя тампонада для удержания сопоставленных отломков и остановки кровотечения при травме слизистой оболочки.

Тампон вводят на стороне деформации и удаляют **на 2–3-и сутки** после операции; срок определяется подвижностью отломков. Преимущества длительной тампонады (**более 3–5 дней**) после репозиции не доказаны.

При переломах, сложных травмах и после операций накладывается пращевидная повязка для профилактики смещения отломков.

Наружная шина после закрытой репозиции рутинно не применяется и показана только при тяжёлых оскольчатых переломах.

При выраженных реактивных воспалительных явлениях показана консультация физиотерапевта.

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области и магнитотерапия уменьшают воспаление и отёк и ускоряют заживление.

Режим на период лечения

1. ограничение физической активности;
2. исключение действий, способных привести к смещению отломков, в том числе во сне;
3. полноценное витаминизированное легкоусвояемое питание;
4. не рекомендуются горячая ванна, душ, сауна и бассейн.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

После операций по поводу деформации наружного носа или перегородки носа пациент **в течение года** находится под наблюдением оториноларинголога. Обязательные осмотры:

1. через 1 месяц;
2. через 3 месяца;
3. через 6 месяцев;
4. через год после операции.

Профилактика травм основана на общих социальных мерах предупреждения травматизма.

К ним относятся соблюдение техники безопасности в детских учреждениях, на производстве и в быту, разъяснительная работа с родителями и пропаганда здорового образа жизни.

5.1 Показания к госпитализации

1. тяжёлое состояние;
2. выраженный отёк;
3. кровотечение;
4. выраженный болевой синдром;
5. комбинированные переломы костей и перегородки носа с повреждением околоносовых пазух и ранениями лица;
6. травматическая деформация носа со смещением перегородки или нарушением дыхания;
7. тяжёлая сопутствующая патология;
8. приём антикоагулянтов или антиагрегантов;
9. осложнения: гематома и абсцесс перегородки носа, воспаление околоносовых пазух и соседних областей;
10. необходимость закрытой репозиции.

Пациента выписывают при:

1. удовлетворительном состоянии и нормальных клинических показателях;
2. улучшении формы носа и носового дыхания;
3. отсутствии осложнений.

Прогноз благоприятный при проведении лечения в соответствии с рекомендациями и выполнении пациентом назначений врача.

Пациенту разъясняется, что при выраженном отёке лица, деформации носа, повреждении мягких тканей, носовом кровотечении или нарушении дыхания необходима экстренная консультация оториноларинголога, поскольку запоздалое лечение может привести к опасным осложнениям.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	815_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м» вместо миллиграммов.
- В таблице 3 для внутривенного парацетамола пересекаются весовые диапазоны с разными максимальными суточными дозами (33–50 кг: 3 г; 10–50 кг: 2 г); для метамизола натрия доза у детей 2–14 лет (50–100 мг/кг) в 10 раз больше в пересчёте на килограмм, чем у детей до года (50–100 мг на 10 кг). Для ибупрофена внутрь в графе интервала указаны одновременно «6–8 ч» и «8 ч» без пояснения.
- Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере (до года 6 г, в 9–10 лет 18 г) превышают указанные рядом максимальные суточные дозы (3 г и 6–9 г).
- Острая стадия перелома в разделе 1.5 составляет 14 дней, тогда как в разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.

Клинические рекомендации

Травма уха

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.4** — Поверхностная травма уха **S01.3** — Открытая рана уха **S09.2** — Травматический разрыв барабанной перепонки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/812_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Поверхностная травма уха (ПТУ: ушиб, отогематома, раны, дефекты раковины) и травматический разрыв барабанной перепонки (ТРБП). 80–97% разрывов заживают сами **за 2–4 недели**; при взрывной травме реже и дольше, **до 3 месяцев**.
- Отогематому устраняют всегда: **до 48 часов** и **менее 2 см** — аспирация иглой 18G, больше или позже — разрез и дренирование; затем давящая повязка.
- Разрыв барабанной перепонки: **менее 25%** площади — наблюдение; **менее 50%** — консервативная миринготластика; стойкая перфорация — тимпанопластика. Кроме взрывной травмы. Вода в ухо недопустима.
- Инфицированная рана и перихондрит: ранние системные антибиотики **7–10 дней**, фторхинолоны — только взрослым; при инфицированных ранах — столбнячный анатоксин.
- Экстренная госпитализация: осложнения (перихондрит, мастоидит) и необходимость операции.

2. Клиническая картина и классификация

Определения

Термин	Определение
Поверхностная зона уха (ПЗУ)	ушная раковина, перепончато-хрящевая часть слухового прохода, мягкие ткани сосцевидной области
Поверхностная травма уха (ПТУ)	механическое воздействие (удар, ушиб, укус, ранение) в поверхностной зоне уха
Ушиб уха	повреждение мягких тканей без видимого нарушения их целостности
Отогематома	скопление крови между хрящом и надхрящницей ушной раковины после механического воздействия
Посттравматический дефект ушной раковины	частичное нарушение целостности мягких тканей или полное отсутствие раковины (ампутация)
Перихондрит ушной раковины	острое воспаление надхрящницы с переходом на кожу раковины и перепончато-хрящевую часть прохода, без мочки
Посттравматический стеноз слухового прохода	сужение наружного слухового прохода после травмы
Акубаротравма	повреждение среднего и внутреннего уха от одновременного резкого перепада давления и звука высокой интенсивности
Баротравма уха	повреждение среднего и внутреннего уха от резкого перепада давления в слуховом проходе или барабанной полости
Травматический разрыв барабанной перепонки (ТРБП)	нарушение целостности барабанной перепонки от внешних причин

2.1 Этиология

Поверхностная травма

1. удар, ушиб, укус, ранение (колотое, резаное, рваное, огнестрельное);
2. ушиб: удар или падение без повреждения хряща и кровоизлияния;
3. отогематома при более сильном воздействии: борцы, боксёры, тяжёлый физический труд, давление жёсткого головного убора или подушки;
4. укусы, порезы, ранения: дефект раковины вплоть до ампутации;
5. инфицирование раны: перихондрит, деформация раковины, рубцовая атрезия слухового прохода.

Разрыв барабанной перепонки

1. механический: острые предметы, самостоятельная чистка уха («Q-tip injury»), ятрогенно при промывании, удалении инородных тел, аспирации;
2. баротравма: авиаперелёт, ныряние, удар ладонью по уху, взрывная волна;
3. перелом височной кости, огнестрельное ранение;
4. термический: окалина при электросварке, удар молнии;
5. химический: агрессивные жидкости.

У детей чаще тупая травма, баротравма, инородное тело; проникающая травма ватной палочкой, спичкой, шпилькой — самим ребёнком, ухаживающими или ятрогенно при удалении инородного тела.

80–97% разрывов заживают сами **за 2–4 недели** независимо от локализации и выделений, влияет лишь размер дефекта. При взрывной травме с большими перфорациями — в 56–82%, **до 3 месяцев**. Если в ухо попадает вода — риск инфицирования; после минно-взрывной травмы возможна интратимпанальная холестеатома уже **через 6 месяцев**.

2.2 Классификация

Поверхностная травма

1. закрытая (ушиб) и ранения;
2. поверхностная (без повреждения височной кости) и глубокая (с повреждением височной кости).

Разрыв барабанной перепонки

1. по времени: свежая перфорация (**менее 3 месяцев**) и стойкая;
2. с гноетечением или сухая;
3. по размеру: малая — **менее 25%** площади (менее 1 квадранта), средняя — 25–50% (1–2 квадранта), большая — более 75% (более 2 квадрантов).

Нарушения слуха, в том числе при акубаротравме, классифицируют по действующей классификации потери слуха.

Дефекты ушной раковины классифицируют по Ю. Н. Ростокину (1975): частичные верхнего, среднего, нижнего отдела, субтотальные, тотальные; и по H. Weerda (1998): центральные, периферические, частичная реконструкция, дефекты мочки, задние, субтотальные, полная потеря раковины, дефекты околоушных мягких тканей, после ожогов.

2.3 Клиническая картина

Отогематома

1. обычно в верхней половине наружной поверхности раковины;
2. флюктуирующая округлая припухлость синеватого или багрового оттенка;
3. мочку не затрагивает;
4. пальпация обычно безболезненна.

Перихондрит: следствие несвоевременного удаления крови из отогематомы.

1. выраженная боль в раковине и слуховом проходе;
2. раковина увеличена, контуры сглажены, мочка не вовлечена;
3. флюктуация при гное между надхрящницей и хрящом;
4. при позднем обращении гнойное расплавление хряща, секвестры, деформация раковины;
5. лихорадка, бессонница из-за пульсирующей боли, иногда озноб; боль иррадиирует в висок, затылок, шею.

Ранения: возможен частичный или полный отрыв раковины; кровотечение из ветвей наружной сонной артерии обычно умеренное.

Признаки повреждения глубжележащих структур

1. интенсивное кровотечение: затылочная, височная, задняя ушная артерии — нужна неотложная помощь;
2. ограничение подвижности нижней челюсти — повреждение сустава;
3. слюна из раны — околоушная железа;
4. парез лицевого нерва;
5. при глубокой инфекции — лабиринтит и внутричерепные осложнения.

Объём повреждения раковины зависит от силы и направления воздействия: от ссадин и кровоподтёков до отрыва и размозжения.

Разрыв барабанной перепонки: снижение слуха, заложенность, небольшой шум; сразу после травмы возможна кровь из уха.

1. акубаротравма: снижение слуха вплоть до глухоты, головокружение, нарушение равновесия;
2. при взрывной травме из-за тяжёлого общего состояния у половины пострадавших повреждение слуха не диагностируют или диагностируют поздно;
3. проникающая травма у детей: разрыв цепи косточек, повреждение лицевого нерва и подножной пластинки стремени, перилимфатическая фистула, гемотимпанум; потеря слуха, головокружение, нистагм, атаксия.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу, общему осмотру с тщательным осмотром поверхностной зоны уха и барабанной перепонки, отоскопии, заключениям других специалистов и лабораторным данным.

Поверхностная травма: жалобы

1. боль, отёк мягких тканей;
2. кровотечение, дефект тканей раковины, ссадины, кровоподтёки;
3. снижение слуха, головокружение;
4. недомогание, слабость, лихорадка, головная боль.

Разрыв барабанной перепонки

1. механизм: перепад давления (удар ладонью, ныряние, взрывная волна), острые предметы или чистка уха, перелом основания черепа при минно-взрывной травме;
2. резкая боль в момент травмы, снижение слуха, шум, головокружение, нарушение равновесия;
3. кровь или ликвор из уха (перелом основания черепа);
4. звук выходящего воздуха при продувании или сморкании;
5. после попадания воды — слизистые или гнойные выделения.

3.1 Осмотр и отоскопия

Показания

1. все пациенты с подозрением на травму уха: первичный осмотр оториноларинголога.

Местные признаки поверхностной травмы

1. гиперемия, отёк мягких тканей;
2. флюктуация — кровь или гной между надхрящницей и хрящом;
3. дефекты раковины (частичный или полный отрыв), хрящевой части прохода, околоушной области;
4. кровотечение.

Отоскопия при разрыве барабанной перепонки

1. свежая перфорация: рваные, не омозолелые края, вывернутые кнаружи или в барабанную полость; иногда кровь в проходе;
2. стойкая перфорация: омозолелые края;
3. акубаротравму (баротравму) при соответствующем анамнезе ставят только при отоскопически видимом разрыве: без него картина сходна с туботитом.

Дефекты кожи слухового прохода, кровь в нём или подозрение на отоликворею могут указывать на перелом основания черепа. Системные признаки осложнений: лихорадка, интоксикация, выраженная диффузная головная боль.

3.2 Анализы

Показания

1. все пациенты с травмой уха: развёрнутый общий и биохимический анализы крови.

Показания

1. все пациенты с травмой уха: посев гнойного отделяемого с определением чувствительности.

При гнойном перихондрите чаще всего синегнойная палочка; также золотистый стафилококк, кишечная палочка, протей.

3.3 Камертональные пробы и тональная аудиометрия

Показания

1. взрослые с травмой уха и снижением слуха: исключить острую сенсоневральную тугоухость.

Аудиометрия показывает кондуктивную тугоухость и её степень; сенсоневральный компонент указывает на повреждение внутреннего уха. У маленьких детей камертональные пробы трудны.

3.4 КТ височной кости

Показания

1. осложнения: перихондрит, абсцесс;
2. подозрение на повреждение височной кости, слуховых косточек, перилимфатическую фистулу.

Перфорация в задне-верхнем квадранте при проникающей травме может указывать на повреждение косточек или внутреннего уха.

Сопутствующие повреждения (перелом челюсти, околоушной железы, лицевого нерва): консультации невролога, челюстно-лицевого хирурга, нейрохирурга.

---

4. Лечение

Ушибы ушной раковины специального лечения не требуют; ссадины обрабатывают антисептиком, накладывают асептическую повязку или наклейку.

4.1 Обезболивание

Показания

1. поверхностная травма уха: НПВП по выраженности боли.

НПВП у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев — свечи и суспензия, с 6 лет — таблетки, с 12 лет — капсулы;
2. кетопрофен: с 6 лет — гранулы внутрь, с 15 лет — парентерально.

Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Диклофенак	75 мг в/м (в КР «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 сут
Кеторолак	30 мг в/в, в/м	в КР «6- ч»	60–90 мг	2 сут
Кетопрофен	100 мг в/в, в/м	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Лорноксикам	8 мг в/в, в/м	12 ч	16 мг	1–7 сут
Декскетопрофен	50 мг в/в, в/м	8–12 ч	150 мг	2 сут

Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Ибупрофен внутрь	10–12 лет 300 мг; 7–9 лет 200 мг; 4–6 лет 150 мг; 1–3 года 100 мг; 6–12 мес 50 мг; 3–6 мес 50 мг	8 ч; 6–8 ч (в таблице КР интервалы не сопоставлены с возрастами построчно)	10–12 лет 900 мг; 7–9 лет 600 мг; 4–6 лет 450 мг; 1–3 года 300 мг; 6–12 мес 200 мг; 3–6 мес 150 мг	3–5 сут
Ибупрофен ректально	3–9 мес 60 мг; 9–24 мес 60 мг	3–9 мес 8 ч; 9–24 мес 6 ч	3–9 мес 180 мг; 9–24 мес 240 мг	не более 3 дней
Кетопрофен в/в, в/м	с 15 лет 100 мг	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Кетопрофен внутрь	старше 6 лет 40 мг	8 ч	120 мг	не более 2 сут

4.2 Раны: антисептики, столбняк, антибиотики

Показания

1. поверхностная травма уха: местно антисептики и антибактериальные мази.

Средства

1. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, повидон-йод, хлоргексидин;
2. мази у взрослых: хлорамфеникол, неомицин, бацитрацин + неомицин, мупироцин;
3. у детей неомицин, бацитрацин, мупироцин не применяют.

Кратность — по воспалению и экссудату; обрабатывают до разрешения инфекции или начала заживления.

Инфицированные и контаминированные раны: столбнячный анатоксин.

Показания

1. инфицированная рана;
2. перихондрит ушной раковины.

Препараты

1. цефалоспорины III и IV поколения, фторхинолоны;
2. длительность около **7–10 дней**;
3. фторхинолоны только взрослым; детям — только цефалоспорины IV поколения.

4.3 Разрыв барабанной перепонки

Показания

1. разрыв **менее 25%** площади, кроме взрывной травмы: выжидательная тактика.

При выделениях из уха — системные антибиотики.

Показания

1. разрыв **менее 50%** площади, кроме взрывной травмы: консервативная миринготластика — тампонада слухового прохода коллагеновой гемостатической губкой поверх дефекта.

После процедуры

1. не допускать воды в ухо;
2. не вводить препараты в барабанную полость;
3. без самопродувания, чихания, сморкания;
4. осмотр **через 2–4 недели**, раньше — при выделениях или снижении слуха;
5. материал удаляют **не ранее 4 недель**.

Под местной анестезией лидокаином (10% аппликационно или 1% инфильтрационно, кроме детей до 1 года) с оптикой, через ушную воронку; после туалета и при необходимости освежения краёв материал больше перфорации укладывают поверх неё. Детям — под наркозом, используют и папиросную бумагу.

Показания

1. стойкая перфорация после травматического разрыва: тимпанопластика.

Операция показана даже при признаках заживления, если подозревают

1. перелом или смещение слуховых косточек;
2. холестеатому среднего уха;
3. фистулу лабиринтных окон: вестибулярные нарушения **более 2 недель**, костно-воздушный интервал **более 30 дБ**, смешанная тугоухость.

Показания

1. дети с травмой уха и вестибулярными симптомами: тимпанотомия — диагностика и закрытие перилимфатической фистулы.

Заподозрить фистулу

1. сенсоневральная тугоухость;
2. нарушение равновесия, головокружение;
3. нистагм в сторону поражения;
4. перфорация в задне-верхнем квадранте.

Под эндотрахеальным наркозом поднимают тимпаномеатальный лоскут, осматривают окна; при явной травме удаляют или репонируют костные фрагменты. Если после аспирации прозрачная жидкость скапливается у окон **не менее 5 минут** наблюдения — фистула; окна закрывают жиром или фасцией, вестибулярные симптомы обычно проходят.

4.4 Отогематома, перихондрит, раны

Показания

1. все пациенты с отогематомой: устранение для профилактики перихондрита.

Тактика

1. **менее 48 часов** после травмы и диаметр **менее 2 см**: аспирация иглой 18G, вкол у основания гематомы;
2. больше **2 см** или позже **48 часов**: разрез и дренирование без косметического ущерба;
3. профилактика рецидива: циркулярная давящая повязка, матрасные швы, фиксация магнитами.

Анестезия

1. 0,5% прокаин: взрослым и детям старше 12 лет;
2. 2% лидокаин: только взрослым.

Гнойный перихондрит: вскрытие и дренирование абсцесса раковины с удалением некротизированных тканей.

Частичный или полный дефект раковины: устранение дефекта. Хирургическая обработка — как можно раньше, с учётом косметики: удаляют только явно нежизнеспособные ткани, первичные швы, при большом натяжении — направляющие.

Ранение перепончато-хрящевой части слухового прохода: стерильные мягкие эластичные трубки в просвет для его восстановления.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. осложнения поверхностной травмы: перихондрит, мастоидит и другие;
2. необходимость операции: устранение дефекта раковины, слухового прохода и другие.

Выписка

1. нормальное общее состояние: нет лихорадки и интоксикации;
2. нормальный общий анализ крови;
3. нормальное заживление ран.

Профилактика: техника безопасности на производстве и в спорте, средства защиты головы — шлемы, каски.

При адекватном лечении прогноз благоприятный.

Осложнения без лечения или при неадекватном лечении

1. перихондрит;
2. острый гнойный средний отит, мастоидит, лабиринтит;
3. внутричерепные осложнения;
4. флегмона, абсцесс.

При разрыве перепонки прогноз благоприятный; воспаление среднего уха удлиняет течение, но не меняет исход.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма уха»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 18.11.2024

Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	812_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Таблица 1 (обезболивание у взрослых): разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — по смыслу 75 мг; интервал кеторолака записан неполно («6- ч»). Сверяйте с инструкцией препарата.
- Таблица 2 (обезболивание у детей): для ибупрофена внутрь интервалы приёма не сопоставлены с возрастными группами построчно.

Клинические рекомендации

Химический ожог пищевода

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T28.5** — Химический ожог рта и глотки **T28.6** — Химический ожог пищевода **T28.7** — Химический ожог других отделов пищеварительного тракта
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"; Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"; Региональная Общественная организация "Национальное общество Торакальных Хирургов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/821_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Химический ожог пищевода — местное повреждение стенки пищевода веществом прижигающего действия, принятым внутрь; ожог ЖКТ сопровождается токсическим резорбтивным действием.
- В приёмном отделении — оториноларинголог (вовлечение дыхательных путей) и токсиколог. Отёк и угроза асфиксии — интубация, невозможна — трахеостомия. **Отсутствие ожога рта и ротоглотки не исключает ожог пищевода**.
- ЭГДС — **в первые 12–48 часов**, батарейка и кристаллы перманганата калия — экстренно; степень — по Zargar. Взрослым — экстренная КТ с контрастом.
- Нельзя: промывать желудок без зонда с вызыванием рвоты, давать нейтрализаторы.
- Рубцы формируются за **4–6 недель**; стриктуры лечат бужированием (до 12, максимум 24 месяцев), при неэффективности — пластика пищевода. Наблюдение хирурга **3 года**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Химический ожог пищевода — местное повреждение стенки пищевода при случайном или преднамеренном приёме внутрь химического вещества прижигающего действия. Химический ожог ЖКТ — повреждение полости рта, глотки, пищевода, желудка; сопровождается токсическим резорбтивным действием.

Послеожоговый стеноз пищевода — сужение просвета и деформация стенки пищевода разной протяжённости на разных уровнях за счёт рубцовой ткани в месте воздействия.

2.2 Этиология

1. **щелочи** — моющие средства, средства для прочистки труб, электролит батареек; колликвационный некроз, глубокое поражение до трансмурального некроза и перфорации
2. **кислоты** — консерванты, отбеливатели, средства от накипи; коагуляционный некроз, всасывание токсина в кровоток
3. **сильные окислители** — перманганат калия, перекись водорода; кристаллы перманганата калия поражают и глотку, надгортанник, голосовые складки
4. **дисковые батарейки (у детей)** — электролиз с образованием щелочи и кислоты, утечка электролита, пролежень, непроходимость пищевода

Дети чаще всего в 1–3 года (80,3%), прием непреднамеренный; подростки — чаще с суицидальной целью. У взрослых — чаще в 30–40 лет, в 85–87% в алкогольном опьянении по ошибке; у женщин преобладают суицидальные попытки. Приём залпом 50–100 мл и более — глубокие ожоги рта, глотки, пищевода, желудка и кишки, гибель в первые 2–3 суток.

2.3 Классификация

1. **по этиологии** — кислоты, щелочи, прочие
2. **по глубине** — I — катаральное поражение; II — эрозивное, не глубже мышечной пластинки слизистой; III — язвенное поражение слизистой и подслизистого слоя; IV — язвенно-некротическое со слизистым, подслизистым и мышечным слоями
3. **по времени развития непроходимости** — ранняя (**до 3–4 недель**), поздняя (позже 1 месяца)
4. **по стадиям** — острая (токсикогенная); отторжения некротических тканей; формирования рубцовых изменений; отдалённые сроки

1. **по степени сужения** — 1 — избирательная, 1,0–1,5 см, не проходит грубая пища; 2 — компенсированная, 0,3–0,5 см, проходит полужидкая пища; 3 — субкомпенсированная, меньше 0,3 см, проходит только жидкость; 4 — обратимая полная непроходимость; 5 — полная облитерация
2. **по протяжённости** — короткие (мембранозные), циркулярные до 3 см, трубчатые более 3 см, чёткообразные, тотальное поражение
3. **по локализации** — высокие (вход в пищевод, шейный отдел), срединные, низкие (кардиальные), комбинированные
4. **по осложнениям** — ложные дивертикулы, ложные ходы, рубцовое укорочение, свищи (пищеводно-бронхиальные, пищеводно-трахеальные)
5. **по сочетанности** — изолированный ожог пищевода; сочетанный с ожогом желудка или ДПК

Эндоскопическая классификация Zargar S. A.

Степень	Эндоскопическая картина
0	нормальная слизистая оболочка
I	отёк и эритема слизистой
IIA	кровоизлияния, эрозии, волдыри, поверхностные язвы
IIB	глубокие и циркулярные язвы
IIIA	очаговые тёмно-серые или коричнево-чёрные язвы
IIIB	обширные тёмно-серые или коричнево-чёрные язвы
IV	перфорация

2.4 Клиническая картина

Острая токсикогенная стадия (**первые 3–7 суток**). **Отсутствие ожога полости рта и ротоглотки не исключает ожог пищевода**.

Сразу после приёма

1. боль, дисфагия;
2. осиплость голоса;
3. гиперсаливация; у детей — резкое беспокойство;
4. возможна фебрильная лихорадка;
5. ожоги лица, шеи, груди.

Системные синдромы

1. экзотоксический шок;
2. дыхательная недостаточность — аспирация, пневмония, отёк и стеноз гортани;
3. гемолиз и нефропатия (особенно уксусная кислота), метаболический ацидоз; при щелочах — алкалоз;
4. токсическая коагулопатия до ДВС-синдрома, гепатопатия.

При обширных ожогах III–IV степени без лечения пациенты погибают в первые 1–2 суток.

Стадия отторжения некротических масс, или мнимого благополучия (**1–3 неделя**): уменьшаются отёк и слюнотечение, нормализуется температура, пациент начинает есть. **Нельзя выписывать с неустановленной степенью ожога**. При тяжёлых ожогах и осложнениях этой стадии может не быть.

Токсикологи выделяют соматогенную стадию (первые 2 недели): ранние осложнения (1–2 сутки) — механическая асфиксия при ожоге рта и верхних дыхательных путей, делирий, панкреатит; поздние (после 3 суток) — трахеобронхит, пневмония, психоз.

Стадия формирования рубцов (**4–6 недель**).

Проявления

1. нарастающая дисфагия — обычно к концу 3-й недели, сначала для твёрдой пищи, затем для жидкой;
2. пищеводная рвота без кислого запаха;
3. потеря массы тела.

Через **15–20 лет** в рубцах и над стенозом нередко развивается плоскоклеточный рак.

Дисковая батарейка и кристаллы перманганата калия у детей: острая стадия длится не более суток. При перманганате слизистая рта окрашена в тёмно-фиолетовый цвет. Мнимого благополучия часто нет, нераспознанный ожог похож на бронхит или пневмонию.

Острая стадия

1. гиперсаливация, дисфагия;
2. беспокойство, отказ от питья и еды.

Осложнения

1. батарейка — стеноз пищевода, парез гортани, перфорация, медиастинит, трахеопищеводный и аортопищеводный свищ;
2. перманганат калия — стеноз глотки, стеноз гортани.

---

3. Диагностика

Диагноз — по анамнезу (приём химического вещества внутрь), жалобам, осмотру (ожог лица и полости рта, специфический запах) и инструментальным данным.

3.1 Жалобы и осмотр

Жалобы: боль во рту, за грудиной и в эпигастрии, боль при глотании, дисфагия, слюнотечение, осиплость, рвота.

Следы ожога на подбородке и в углах рта, состояние слизистой полости рта, пульс, артериальное давление.

Острая стадия: беспокойство, бледность, при тяжёлом отравлении — акроцианоз; отёк и гиперемия языка, щёк, язычка, дужек, некрозы в виде серых, жёлтых или чёрных плёнок; запах уксуса, формалина, нашатырного спирта; тахикардия. Экзотоксический шок — одышка, холодный пот, нитевидный пульс, гипотония. Ожог желудка — защитное напряжение мышц, затем симптомы раздражения брюшины; кровь в рвотных массах.

В приёмном отделении — оториноларинголог (вовлечение начальных отделов дыхательных путей) и токсиколог (при его отсутствии — реаниматолог).

3.2 Анализы

Всем

1. развёрнутый общий анализ крови, общий анализ мочи;
2. биохимия: билирубин и фракции, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза, натрий, калий, хлориды, кальций.

Нефропатия, гепатопатия, почечно-печёночная недостаточность — дополнительно амилаза, ЩФ, ГГТ, общий белок, альбумин.

Отравление уксусной кислотой — свободный гемоглобин в плазме и моче: лёгкий гемолиз — **5 г/л**, средний — 5–10 г/л, тяжёлый — **более 10 г/л**.

3.3 ЭГДС

Боль в острой фазе — перед эндоскопией анальгетики и спазмолитики (папаверин и производные).

ЭГДС — оценка распространённости и глубины поражения; обычно **в первые 12–48 часов**, безопасна до 96 часов. Батарейка или кристаллы перманганата калия — **экстренно**.

При минимальных проявлениях — в ближайшее время, при тяжёлых — после стабилизации. В 5–15 дней эндоскопия опасна перфорацией истончённой стенки. Экстренная эндоскопия нужна, если нельзя выполнить КТ (нет аппарата, противопоказан контраст, дети, сомнительная КТ).

Диагностическая ЭГДС не рекомендуется до стабилизации

1. нестабильная гемодинамика;
2. рентгенологические признаки перфорации пищевода и медиастинита;
3. ожог надгортанника с отёком, ожог гортани и глотки III степени;
4. ожог дыхательных путей, требующий интубации или трахеостомии.

Ожог надгортанника, гортани и глотки грозит асфиксией из-за отёка голосовых складок, особенно при ожоге кристаллами перманганата калия.

Степень ожога и прогноз — по классификации Zargar.

В первые сутки при ожоге I–II степени — белесые коагуляционные плёнки по рельефу складок; некроз тёмно-коричневый или чёрный; при отторжении струпа (3–4 сутки) — тёмно-красные грануляции.

Ожог I степени, стабильное состояние без жалоб — контрольная ЭГДС **не рекомендуется**.

Ожог II–III степени, стабильное состояние без жалоб — контрольная ЭГДС **через 4–6 недель**.

Альтернатива — эндоскопическая классификация Волкова (1997) в дополнении Песни-Прасоловой (2006).

Стадия грануляций и рубцов — ЭГДС **через 3 недели** после травмы: локализация и протяжённость стеноза, показания к бужированию, баллонной дилатации, стентированию.

Эндоскопическая классификация рубцовых стенозов пищевода (Галлингер, 2000)

Степень	Просвет в зоне сужения
I	9–11 мм, проходит среднекалиберный гастроскоп
II	6–8 мм, проходит бронхофиброскоп 5,5–7 мм
III	3–5 мм, проходит ультратонкий эндоскоп 2,4–2,8 мм
IV	1–2 мм или просвета нет, проходит только струна

Дисфагия — начинать со среднекалиберного эндоскопа, чтобы не пропустить рубцы ротоглотки и входа в пищевод; затем малокалиберные эндоскопы. При подозрении на рак — биопсия.

3.4 Рентгенологическое исследование

Обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости: воздух в средостении — перфорация пищевода, под диафрагмой — перфорация желудка.

Рентгеноконтрастное исследование пищевода: распространённость и глубина поражения пищевода и желудка. Перфорация — водорастворимый йодсодержащий контраст; поздние исследования — бария сульфат.

1. **I степень** — глотание свободное, просвет обычный, складки местами утолщены до 5 мм, перистальтика сохранена
2. **II степень** — глотание болезненное, просвет сужен, складки сглажены, стенка неэластична, не перистальтирует, спазмы, регургитация
3. **III–IV степень** — глотание резко болезненное, просвет расширен до 4–6 см с жидкостью, атония, рельефа нет, плоские ниши

Стадия рубцов — рентгенография пищевода с обязательным исследованием желудка и ДПК: локализация, протяжённость, диаметр стриктур. Непроходимость пищевода или свищ — водорастворимый контраст.

Экзотоксический шок, нарушение глотания и проходимости пищевода — контрастное исследование **не рекомендуется**: аспирация.

3.5 КТ

18 лет и старше — экстренная КТ грудной и брюшной полости с внутривенным контрастом (при сохранной функции почек): локализация, объём и глубина поражения.

КТ точнее ранней эндоскопии оценивает трансмуральный некроз; решение об экстренной экстирпации пищевода основывают на КТ-признаках трансмурального некроза. Прогноз по КТ: I степень — осложнения маловероятны; II — возможна стриктура; III — стриктура неизбежна; IV — трансмуральное поражение, высокий риск перфорации, неотложная эзофагэктомия. Эндоскопию в первые 12–48 часов КТ полностью не заменяет.

Дети — рутинная КТ не рекомендуется (нет данных, лучевая нагрузка); полезна при обширном поражении перед операцией.

Высокий риск перфорации желудка по эндоскопии — диагностическая лапароскопия: исключить перитонит.

---

4. Лечение

4.1 Острая стадия: неотложная помощь

Немедленное комплексное лечение: обезболивание, промывание желудка через зонд, местное лечение, детоксикация с коррекцией нарушений органов. Ожог кристаллами перманганата калия — растворы слабых кислот (аскорбиновая кислота).

Обезболивание у взрослых: опиоиды (морфин, тримеперидин, кодеин + морфин + носкапин + папаверин + тебаин) или кеторолак, метамизол натрия по 1 мл 3–4 раза в сутки; атропин 0,1% 1 мл 2 раза в сутки; папаверин 2% 2 мл, дротаверин 2 мл в/м или платифиллин 0,2% 1 мл подкожно до 4 раз в сутки; глюкозоновокаиновая смесь (500 мл 5% декстрозы и 50 мл 2% прокаина) в/в 2–3 раза в сутки.

Компенсированный стеноз гортани — глюкокортикоиды внутривенно и ингаляционно, атропин внутривенно. Ожог I степени — без глюкокортикоидов, II–III степени — коротким курсом 5–7 дней.

Промывание желудка без зонда с вызыванием рвоты **не рекомендуется**: повторный ожог пищевода, аспирация. Через зонд — эффективно и безопасно **в первые 2–3 часа**, через 12 часов неэффективно.

Нейтрализаторы при неотложной помощи **не рекомендуются**.

Нарастает отёк дыхательных путей, угроза асфиксии — интубация трахеи; невозможна — трахеостомия.

Экзотоксический шок

1. сбалансированные электролитные растворы, затем растворы декстрозы;
2. при неэффективности — альбумин 5% или 10%;
3. в первые 6 часов — меглюмина натрия сукцинат 1,5% против ацидоза.

Интенсивная терапия шока

1. гидроксиэтилкрахмал противопоказан;
2. сердечная недостаточность — добутамин;
3. ацидоз — 4% натрия гидрокарбонат;
4. целевой диурез — 0,5–1,0 мл/кг/ч.

4.2 Острая стадия: кровотечения, инфекция, питание

Ранние вторичные кровотечения — местный гемостаз (лучше локальная гипотермия пищевода и желудка) и гепарин натрия — только после локальной остановки кровотечения.

Поздние кровотечения — гепарин **не рекомендуется**; стандартная гемостатическая терапия: голод, переливание эритроцитов, плазмы, фибриногена.

Профилактика поздних кровотечений — ингибиторы протонного насоса и антациды.

Поздние кровотечения — эндоскопический гемостаз (электро- или лазерная коагуляция).

Взрослые — антикоагулянты для лечения токсической коагулопатии и профилактики микротромбов, под контролем свёртывания, фибриногена, тромбоцитов.

Профилактика инфекционных осложнений — антибиотики широкого спектра, затем по результатам посева.

Ранняя нутритивная поддержка — **в первые 12 часов**.

1. пища механически, термически и химически щадящая;
2. недостаточно — парентеральное питание вместе с энтеральным;
3. энтеральное невозможно — решить вопрос о гастростоме.

Ингибиторы протонного насоса (в остром периоде — внутривенно), облепиховое масло, антациды.

Профилактика рубцового сужения — глюкокортикоиды

1. **лёгкий ожог** — в стационаре **7 суток**, затем амбулаторно **3 недели**
2. **средней тяжести** — **до 20 суток**, затем **1 месяц**
3. **тяжёлый** — **не менее 30 суток**, затем **до 2 месяцев**

4.3 Острая стадия: перфорация

Перфорация пищевода или желудка — экстренные мероприятия по локализации, размеру перфорации и осложнениям; тактика — по рентгеноскопии с водорастворимым контрастом и (или) КТ.

1. **без медиастинита** — кормление через рот исключают, назогастральный зонд, парентеральное питание, антибиотики (цефалоспорины, метронидазол, защищённые пенициллины), иногда гастростомия
2. **медиастинит** — экстренная операция торакотомным или торакоскопическим доступом: санация и дренирование средостения, гастростома с антирефлюксной операцией; возможна эндоскопическая вакуумная терапия
3. **необратимые изменения пищевода** — эзофагэктомия с эзофаго- и гастростомой; у взрослых — эзофагогастрэктомия, летальность 25–34%

4.4 Формирующиеся стриктуры (до 4 недель)

Выраженная дисфагия и быстро формирующиеся рубцы — профилактическое бужирование пищевода.

Бужи не меньше возрастного размера пищевода, в стационаре **3 раза в неделю** по струне-проводнику, затем прямое бужирование; через 3 недели — ЭГДС. Полная эпителизация — бужирование прекращают, контроль через 2–3 месяца. Ожог III степени — 3 недели по 3 раза в неделю, затем амбулаторно раз в неделю 2–3 месяца, 2 раза в месяц 2–3 месяца, раз в месяц полгода; ЭГДС каждые 3 месяца.

4.5 Сформированные стриктуры

Стриктура, нарушающая питание, — поддерживающее бужирование **12 месяцев**; при стойкой положительной динамике — не более **24 месяцев**. Неэффективно — пересмотреть программу или реконструктивная операция.

Начинать через **4–6 недель** после ожога, по струне-проводнику под эндотрахеальным наркозом: не более 3 бужей за сеанс, повтор через 2–3 дня, затем «вслепую» и амбулаторно раз в неделю 3 месяца. Прекращают при полной эпителизации и просвете **не менее 10–12 мм**. Протяжённые стриктуры после щелочей и кислот, ожог гортаноглотки перманганатом у детей — бужирование за нить через гастростому (у детей при ожоге глотки — бужи № 44–60).

Размеры бужей по шкале Шарьера

Возраст	Размер бужа, Fr
до 6 месяцев	33–36
до 1 года	36–40
1–3 года	40–42
4–7 лет	42–44
8–17 лет	44–46

Бужирование неэффективно

1. не достигается максимальный размер бужа;
2. дисфагия или стеноз возвращаются между бужированиями;
3. не удаётся перейти на более редкое бужирование;
4. после курса нарастает дисфагия.

Хороший результат

1. любая пища без дисфагии;
2. поддерживающее бужирование не нужно;
3. просвет в зоне стеноза **не менее 10–12 мм**.

Стриктура **до 5 см** — альтернатива: гидростатическая баллонная дилатация под рентгеноскопией, под общей анестезией.

Стентирование при формирующихся стриктурах **не рекомендуется**: нет положительных результатов, много осложнений.

4.6 Реконструктивные операции

Показания к операции при послеожоговых стриктурах

1. полная облитерация просвета;
2. извилистый просвет со слепыми карманами и дивертикулами;
3. нельзя провести буж № 28–30 из-за плотных рецидивирующих стриктур;
4. пищеводные свищи;
5. перфорация пищевода в анамнезе;
6. рубцы **более 15 лет** — риск малигнизации;
7. укорочение пищевода с грыжей пищеводного отверстия и рефлюкс-эзофагитом.

Изолированный рубцовый стеноз глотки — пластика глотки свободным сегментом кишки.

Изолированные стенозы глотки в 100% случаев — от кристаллов марганца: рубцуются вход в глотку и в гортань (надгортанник лизируется), выживают только при экстренной трахеостомии; пациенты — с трахео- и гастростомой. Трансплантат реваскуляризируют с общей сонной артерией и внутренней яремной веной.

Стеноз глотки и шейного отдела пищевода — пластика свободным сегментом кишки; субтотальное поражение глотки и пищевода — пластика пищевода толстой кишкой.

Протяжённые или множественные стриктуры — пластика пищевода с одномоментной или раздельной экстирпацией; выбор — за хирургами специализированных центров.

Дети с протяжёнными или множественными стенозами — колоэзофагопластика с загрудинным проведением трансплантата.

Протяжённые стриктуры без ожога желудка — резекция пищевода абдоминоцервикальным доступом с пластикой желудком.

Стеноз привратника — операция (задний гастроэнтероанастомоз с анастомозом по Брауну, резекция желудка не рекомендуется) или эндоскопическая баллонная дилатация.

Трахеопищеводное соустье без дыхательной недостаточности — сдерживающая тактика: лапароскопическая фундопликация, гастростомия, консервативная терапия; свищ закрывается в среднем **до 5 месяцев**.

Дети с большим соустьем и дыхательной недостаточностью — пластика трахеи пищеводным лоскутом с экстирпацией пищевода, пластика пищевода позже.

Аортопищеводная фистула — экстренная операция даже без видимого кровотечения.

Триада Киари

1. нарастающая загрудинная боль;
2. необильные периодические кровотечения;
3. массивное кровотечение после «светлого промежутка».

При кровотечении — зонд Блэкмора (пищеводный баллон на среднюю треть); клипирование ошибочно.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация

1. клинико-анамнестические признаки химического ожога ЖКТ.

Выписка

1. нормализация общего состояния и анализов;
2. нет эрозивно-язвенного эзофагита при эндоскопии;
3. нет осложнений;
4. нормальный нутритивный статус, возможно энтеральное питание (естественное или через гастростому).

Ожог I степени — сразу кормить и выписать через **24–48 часов**: риска стриктуры нет.

Суицидальная попытка — перед выпиской осмотр психотерапевта; долгосрочное наблюдение.

5.2 Реабилитация

Реабилитация — как можно раньше, одновременно с лечением: индуктотермия, цинк-электрофорез, электрофорез органно-минерального комплекса, низкоинтенсивное лазерное излучение; после бужирования — магнитотерапия курсами 5–7 сеансов.

5.3 Диспансерное наблюдение

После выписки — хирург (детский хирург) поликлиники **3 года** от травмы.

Ожог III степени — плановая госпитализация для ЭГДС **через 1 месяц** после выписки, затем через 3 и 6 месяцев.

Нет признаков стриктуры — осмотр хирурга **каждые 6 месяцев**, всего **в течение 3 лет**; появилась дисфагия — госпитализация для ЭГДС. Рубцовая деформация без сужения — ЭГДС **каждые 3 года**: риск рака.

На догоспитальном этапе — подтвердить приём, определить вещество, причину и время. Нельзя: положение лёжа на спине, разбавители, нейтрализация — повторный ожог и аспирация. Лечение поздних последствий — в специализированных центрах.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Химический ожог пищевода»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 25.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	821_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Российская ассоциация детских хирургов; Российское общество хирургов; Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов; Национальное общество торакальных хирургов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки глюкокортикоидов расходятся: при стенозе гортани — ожог I степени без глюкокортикоидов, II–III степени — 5–7 дней; для профилактики рубцового сужения — от 7 суток (лёгкий ожог) до не менее 30 суток (тяжёлый) с продолжением амбулаторно.

- Таблица Zargar в разделе 1.5 и в приложении А3 различается: степень IIB — «глубокие и циркулярные язвы» и «окружные поражения».

Клинические рекомендации

Хронический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.0** — Вазомоторный ринит **J31.0** — Хронический ринит **J34.3** — Гипертрофия носовой раковины
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 06.10.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Национальная ассоциация ринохирургов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1082_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Хронический ринит (ХР): воспаление слизистой носа с двумя и более симптомами — заложенность, выделения, чихание, зуд — **не менее 1 часа** ежедневно **не менее 12 недель** в год. Кроме атрофического, это «диагноз второй очереди»: ставят после исключения инфекции и аллергии.
- Лечение: устранить причину и триггеры, промывания солевыми растворами. Вазомоторный ринит: назальные кортикостероиды или азеластин **с 12 лет**. Медикаментозный ринит: постепенная отмена деконгестанта на фоне других средств.
- Деконгестанты — **не более 7 дней**, при хронических заболеваниях носа и пазух лучше **не более 3 дней**.
- Операция — симптоматическое лечение: при неэффективности адекватной терапии **6–12 месяцев** или при гипертрофическом рините. Турбинэктомию (радикальную конхотомию) не выполняют.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический ринит: любое воспаление слизистой оболочки носа с двумя и более симптомами — заложенность, ринорея, чихание, зуд в носу — **не менее 1 часа** ежедневно **не менее 12 недель** в год. Обычно так называют все хронические риниты, кроме аллергического (неаллергический ринит).

2.2 Фенотипы

Фенотипы хронического ринита

Фенотип	Определение
Вазомоторный (идиопатический) ринит, неаллергическая ринопатия	самый частый фенотип; диагноз после исключения инфекции, аллергии и других форм ХР; в основе — нарушение нервно-рефлекторной регуляции микроциркуляции слизистой
Гипертрофический ринит (гипертрофия нижних носовых раковин)	необратимое увеличение нижних раковин как проявление ХР, реже за счёт костной основы; стойкое затруднение носового дыхания
Гормональный ринит	при гипотиреозе или изменении уровня половых гормонов: беременность, менопауза, фазы цикла, пубертат
Ринит беременных (гестационный)	стойкая заложенность, возникшая во время беременности (чаще во II–III триместре), 6 недель и более, без инфекции и аллергии, проходит за 2 недели после родов
Лекарственно-индуцированный ринит	изменения слизистой от системных и назальных лекарственных препаратов
Медикаментозный ринит	самый частый лекарственно-индуцированный: длительное применение назальных деконгестантов
Профессиональный ринит	назальные симптомы, связанные с рабочей средой; неаллергический — от низкомолекулярных раздражителей (менее 5 кДа), высокомолекулярные чаще вызывают аллергический
Ринит курильщика	разновидность профессионального: раздражитель — табачный дым

Фенотип	Определение
Вкусовой ринит	водянистая ринорея на острую пищу или алкоголь, без чихания, зуда, кожных симптомов и бронхообструкции
Ринит пожилых (старческий)	старше 65 лет; водянистая ринорея, усиливается от триггеров; иногда сухость и корки
Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом (NARES)	эозинофильное воспаление слизистой при отрицательных аллергопробах
Атрофический ринит	атрофия слизистой: заложенность, сухость, корки, носовые кровотечения; первичный и вторичный
Хронический катаральный ринит	по морфологической классификации Л. Б. Дайняка (1966): постоянное негнойное воспаление; используется при смешанных фенотипах

По течению

1. интермиттирующий: симптомы **менее 4 дней** в неделю или **менее 4 недель** в году;
2. персистирующий: **более 4 дней** в неделю и **более 4 недель** в году.

По тяжести

1. лёгкая: слабые симптомы, не нарушают дневную активность и сон;
2. средняя: мешают работе, учёбе, спорту, нарушают сон;
3. тяжёлая: значительно ухудшают качество жизни, без лечения нормальная жизнь невозможна, значительно нарушен сон.

У взрослых и подростков — 10-балльная ВАШ: **менее 5 баллов** — лёгкое течение, **5 и более** — среднетяжёлое или тяжёлое. Около 20% пациентов — смешанные или неклассифицируемые формы.

2.3 Этиология

Выделяют воспалительный эндотип (воспаление слизистой) и нейрогенный (нарушение вегетативной регуляции тонуса сосудов и секреции).

Общее для всех форм, кроме атрофического, — гиперреактивность слизистой к неспецифическим триггерам, слабее, чем при аллергическом рините.

Препараты, вызывающие лекарственно-индуцированный ринит

Группа препаратов	Препараты
Нестероидные противовоспалительные (M01A)	диклофенак, кеторолак, целекоксиб
Альфа-адреноблокаторы (G04CA, C02CA)	алфузозин, доксазозин, силодозин, тамсулозин
Антиадренергические центрального действия (C02A)	клонидин, метилдопа
Агонисты дофаминовых рецепторов (N04BC)	пирибедил
Бета-адреноблокаторы (C07A)	атенолол, бисопролол, карведилол, метопролол, пропранолол

Группа препаратов	Препараты
Противоопухолевые (L01)	анагрелид
Антитромботические (B01)	цилостазол, дипиридамол
Для лечения эректильной дисфункции (G04BE)	силденафил, тадалафил, варденафил
Ингибиторы АПФ (C09A)	каптоприл, эналаприл, лизиноприл, рамиприл
Психолептики (N05) и психоаналептики (N06)	алпразолам, амитриптилин, хлорпромазин, миансерин, рисперидон, тиоридазин; гинкго билоба листья
Ингибиторы кальциневрина (L04AD)	циклоспорин
Эстрогены (G03C)	—
Диуретики (C03)	гидрохлоротиазид
Противоэпилептические (N03A)	габапентин

Вещества, вызывающие профессиональный ринит

Вещество	Профессия, категория населения
Высокомолекулярные (более 5 кДа), аллергический ринит: зерновая мука; эпидермис животных; латекс	пекари, пищевая промышленность; лаборатории, животноводство, скотобойни, ветеринары; медработники, лаборатории, клининг
Низкомолекулярные (менее 5 кДа), неаллергический ринит: персульфаты; древесная пыль; формальдегиды; выхлопные газы; бензол, толуол; тальк; аммиак, растворители; табачный дым	парикмахеры; столяры, деревообработка; строители, химпром, лаборатории, морги; автомеханики, дорожные рабочие, жители мегаполисов; маляры; косметическая промышленность, лаборатории, медработники; химпром, лаборатории; курящие и их окружение

Первичный атрофический ринит обычно у людей старше 50 лет, чаще у отдельных этнических групп (юг Азии, Африка); вторично присоединяется Klebsiella ozaenae. Вторичный — чаще после ринохирургии (прежде всего на нижних раковинах), реже от назальных препаратов, лучевой терапии, при гранулематозе с полиангиитом.

2.4 Клиническая картина

Выраженность симптомов по фенотипам

Фенотип	Заложенность	Ринорея	Зуд, чихание	Гипосмия
Старческий	++	+++	+	++
Профессиональный	++	+	++	+

Фенотип	Заложенность	Ринорея	Зуд, чихание	Гипосмия
Медикаментозный, лекарственно-индуцированный	+++	+	+	+
Гормональный	++	++	+	+
Вкусовой	++	+++	+	+
Вазомоторный	++	++	++	++
NARES	++	++	+	+++

Патогномоничных симптомов нет.

Общие симптомы, кроме атрофического ринита

1. заложенность носа;
2. передняя и задняя ринорея;
3. чихание, зуд;
4. гипосмия.

Глазных симптомов, в отличие от аллергического ринита, нет; триггеры действуют слабее.

Течение

1. постоянные симптомы: старческий ринит, NARES, медикаментозный, тяжёлый профессиональный;
2. только при воздействии причины: лёгкий профессиональный, вкусовой;
3. волнообразное: вазомоторный и гормональный;
4. лекарственно-индуцированный: зависит от схемы и длительности приёма препарата.

Атрофический ринит

1. сухость и раздражение в носу, корки, носовые кровотечения;
2. заложенность и снижение обоняния;
3. при тяжёлом течении — полное отсутствие носового дыхания, не восстанавливающееся после деконгестантов, аносмия;
4. тяжелее всего первичный и вторичный при гранулематозных полиангиитах: поражение хрящей и костей вплоть до перфорации перегородки, деформации носа и секвестрации раковин.

Первичный крайне редок у детей; вторичный у детей чаще первичного, но реже, чем у взрослых.

---

3. Диагностика

Чётких общих критериев нет. Формула фенотипа: периодические или постоянные симптомы ринита + связь с определённым внешним или внутренним фактором (после исключения инфекции и аллергии). Выявленная инфекционная или аллергическая причина не исключает сопутствующий фенотип ХР (смешанные формы).

Смешанные формы ринитов существуют: признаки инфекции или аллергии не исключают у пациента фенотип ХР.

Критерии диагноза по фенотипам

Фенотип	Критерии диагноза
Ринит беременных	1. заложенность носа, которой не было до беременности; 2. симптомы 6 недель и более; 3. исключены аллергия и инфекция; 4. полное разрешение за 2 недели после родов (ретроспективно).
Медикаментозный	1. регулярное ежедневное применение назальных сосудосуживающих вне простуд для улучшения дыхания.
Лекарственно-индуцированный	1. симптомы (прежде всего заложенность) вне простуд на фоне некоторых классов препаратов, проходят по окончании их действия.
Профессиональный	1. симптомы на рабочем месте или их усиление на работе; 2. уменьшаются или проходят вне работы; 3. исключён аллергический ринит.
Ринит пожилых	1. постоянные (чаще слизистые) выделения или стекание по задней стенке глотки; 2. старше 65 лет; 3. исключены аллергия и другие причины ринореи.
Вкусовой	1. симптомы на пряную пищу, проходят после её прекращения; 2. исключён аллергический ринит; 3. нет симптомов в начале приёма пищи.
NARES	1. эозинофилы более 25% в цитологии мазка со слизистой носа; 2. исключён аллергический ринит; 3. персистирующие симптомы с выраженным нарушением обоняния.
Вазомоторный	1. периодические или постоянные симптомы без связи с внешними и внутренними факторами; у взрослых чаще попеременная заложенность половин носа, заложенность на стороне, на которой лежит; 2. исключён аллергический ринит; 3. исключены другие причины по осмотру оториноларинголога.
Гормональный	1. общепринятых критериев нет: подтверждённый гипотиреоз или акромегалия с персистирующими симптомами, либо симптомы при менструации, в пубертате — после исключения других причин.
Атрофический	1. признаки атрофии: корки, сухость слизистой; 2. ощущение сухости, заложенность, нарушение обоняния или неприятный запах выделений; 3. и (или) периодические носовые кровотечения.

3.1 Жалобы, анамнез и осмотр

Уточняют

1. длительность, что спровоцировало начало, динамику жалоб, влияние на сон и активность;
2. лечение и его эффект, нежелательные явления;
3. симптомы вне эпизодов ОРИ;
4. сопутствующие заболевания, прежде всего аллергию;
5. ринохирургические вмешательства и манипуляции в носу.

Первичный осмотр оториноларинголога всем пациентам с ХР.

3.2 Цитологическое исследование мазка из носа

Показания

1. подростки и взрослые с персистирующими симптомами и выраженным нарушением обоняния при исключённом аллергическом рините: подтверждение или исключение NARES.

Для остальных фенотипов рутинно не проводят: низкие чувствительность и специфичность.

3.3 Посев отделяемого из носа

Показания

1. признаки первичного атрофического ринита: выявление Klebsiella ozaenae.

3.4 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. стойкая выраженная одно- или двусторонняя назальная обструкция: оценка полости носа и дифференциальная диагностика.

3.5 КТ или конусно-лучевая томография пазух

Показания

1. подозрение на сопутствующий хронический риносинусит.

Конусно-лучевая томография — вариант КТ с меньшей лучевой нагрузкой.

3.6 Консультации специалистов

Показания

1. аллерголог-иммунолог: все фенотипы, кроме атрофического ринита, — подтвердить или исключить аллергический ринит.

При аллергическом рините сопутствующий фенотип ХР выделяют, если сенсибилизация не объясняет течение (например, круглый год при сенсибилизации только к пыльце) или нет контроля при максимальном лечении.

Показания

1. эндокринолог: взрослые с ХР без диагностированной эндокринной патологии, но с признаками гипотиреоза.

Признаки гипотиреоза

1. утомляемость, сонливость;
2. сухость кожи, выпадение волос;
3. замедленная речь, охриплость;
4. отёчность лица, пальцев;
5. запоры, зябкость, снижение памяти, подавленность.

Показания

1. детский эндокринолог: дети с ХР после исключения аллергического и медикаментозного ринита, с признаками врождённого гипотиреоза;
2. девочки пубертатного возраста с ХР после исключения аденоидов, аденоидита, аллергического и медикаментозного ринита.

Показания

1. профпатолог: взрослые с подозрением на профессиональный ринит — связь с производственной средой.

4. Лечение

Ключевое — устранить или уменьшить влияние причины.

1. кроме гипертрофического ринита, ХР изначально не требует операции, необоснованная операция часто вредит;
2. операция лишь симптоматична: может улучшить дыхание, но почти не влияет на ринорею, чихание, зуд, обоняние.

ХР не угрожает жизни: консервативное лечение плановое, амбулаторное; операция — плановая, в стационаре.

4.1 Базисная терапия

Показания

1. все пациенты: лечебно-оздоровительный режим — ограничить причинные факторы и триггеры.

Триггеры

1. табачный дым и пар электронных сигарет;
2. перепады температуры, запылённость, резкие запахи;
3. пряности, алкоголь;
4. нарушение сна, гиподинамия, стресс.

Показания

1. все фенотипы: промывание или орошение носа морской водой, стерильными солевыми растворами.

Способ, кратность, изо- или гипертонический раствор и длительность выбирает врач по фенотипу и течению.

4.2 Вазомоторный ринит

Показания

1. вазомоторный ринит, пациенты **старше 12 лет**: назальные кортикостероиды.

Дозы

1. беклометазон: 200–400 мкг в сутки, курс **не более 3 месяцев**;
2. #мометазон: 200 мкг 1 раз в день, **6 недель**;
3. #флутиказон: 200 мкг 1 раз в день, **3 месяца**.

Минимальная эффективная доза; предупредить о носовых кровотечениях. Не применять при атрофии слизистой, в том числе при атрофическом рините.

Азеластин назально курсом **2–3 недели** пациентам **старше 12 лет** с вазомоторным ринитом; данных о пользе более длительного курса нет.

Показания

1. смешанные фенотипы с сопутствующим аллергическим ринитом.

Фиксированные комбинации

1. азеластин + флутиказон, мометазон + олопатадин: **старше 12 лет**;
2. азеластин + мометазон: **старше 18 лет**.

4.3 Обострение и медикаментозный ринит

Обострение с выраженной заложенностью: оксиметазолин коротким курсом **до 7 дней**. Деконгестанты уменьшают только заложенность. Предпочтительны назальные препараты без антисептиков-консервантов.

Медикаментозный ринит: постепенная отмена деконгестанта — сначала уменьшают кратность и разовую дозу — с одновременным назначением морской воды, назальных кортикостероидов, противоаллергических средств. Требование одномоментной отмены часто не выполняется.

4.4 Атрофический и хронический катаральный ринит

Атрофический ринит: увлажняющие средства на основе натрия гиалуроната.

Тяжёлый первичный атрофический ринит с выделением Klebsiella ozaenae: системные антибиотики по чувствительности возбудителя.

Хронический катаральный ринит с гнойным отделяемым, пациенты **старше 18 лет**: фрамицетин.

Хронический катаральный ринит с вязким секретом, пациенты **старше 18 лет**: назальный спрей ацетилцистеин + туаминогептан.

Вазомоторный, медикаментозный или лёгкий атрофический ринит у пациентов, приверженных такому лечению: гомеопатические средства, зарегистрированные в России как лекарственные препараты, по показаниям инструкции.

Вазомоторный или медикаментозный ринит с ограничениями медикаментозного лечения: консультация физиотерапевта.

4.5 Хирургическое лечение

Хирургическое лечение по фенотипам

1. гипертрофический ринит: всем;
2. обоснованно: вазомоторный, медикаментозный, NARES; редко старческий, профессиональный, атрофический;
3. данных о пользе нет: гормональный, гестационный, вкусовой, лекарственно-индуцированный.

Показание

1. адекватное лечение **6–12 месяцев** не улучшило качество жизни или операция может значительно его улучшить.

Принцип минимальной травматизации слизистой; пациента предупреждают о возможной нестойкости результата и повторных вмешательствах.

Показания

1. гипертрофический, вазомоторный, медикаментозный ринит или NARES, рефрактерные к лечению: подслизистая вазотомия или пластика нижних раковин под эндоскопическим контролем.

У дошкольников и младших школьников чаще консервативный подход; у детей все манипуляции на раковинах — только в подслизистом слое.

Варианты: передняя и (или) задняя конхотомия, пластика раковин, подслизистая вазотомия, в том числе с латерализацией костной части; лазерные технологии. Сохранение слизистой уменьшает нарушения мукоцилиарного клиренса, синехии и корки.

Тяжёлое, медикаментозно неконтролируемое течение: селективная нейрэктомия нижней задней носовой ветви большого нёбного нерва; при выраженной заложенности — вместе с операцией на раковинах. Не показана при атрофическом рините.

Гипертрофический ринит с увеличенным костным остовом нижней раковины: остеоконхотомия.

Турбинэктомию (радикальную конхотомию) не выполняют, кроме тяжёлого первичного атрофического ринита: нарушение воздушного потока, корки, инфицирование, риск синдрома «пустого носа».

Тяжёлый первичный атрофический ринит: резекция поражённых структур латеральной стенки по типу секвестрэктомии — паллиативно, для облегчения ухода.

Тяжёлый ятрогенный атрофический ринит с синдромом «пустого носа»: пластика нижних раковин по типу аугментации нижнего носового хода.

Иное лечение

1. ранний период после операций на нижних раковинах: промывание или орошение изотонической морской водой, солевыми растворами;
2. тяжёлый первичный атрофический ринит с выделением Klebsiella ozaenae — системные антибиотики с учётом чувствительности;
3. субатрофические проявления после операции на раковинах — увлажняющие средства с натрия гиалуронатом.

Средства с натрия гиалуронатом после операции на раковинах при субатрофических проявлениях облегчают туалет носа и ускоряют восстановление слизистой.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Диагностика и консервативное лечение — амбулаторно, плановое хирургическое — в стационаре.

Показания к плановой госпитализации для операции

1. вазомоторный и медикаментозный ринит (реже тяжёлый NARES, гормональный, профессиональный, сенильный) без эффекта адекватного лечения **6–12 месяцев**;
2. гипертрофический ринит с увеличенным костным остовом, постоянной выраженной заложенностью и значительным снижением качества жизни;
3. тяжёлый первичный атрофический ринит;
4. тяжёлый ятрогенный атрофический ринит с синдромом «пустого носа».

Выписка

1. хирургическое лечение выполнено в необходимом объёме;
2. удовлетворительное состояние, нет острого инфекционного воспаления.

5.2 Профилактика

Не применять назальные деконгестанты **более 7 дней**; при хронических воспалительных заболеваниях носа и пазух лучше ограничиться **3 днями**.

Показания

1. взрослые, которым нужен деконгестант дольше недели при обострении ХР или острой инфекции носа с выраженной заложенностью.

Схема

1. оксиметазолин спрей вместе с #мометазоном 100–200 мкг в сутки, **15–20 дней**.

1. отказ от курения и электронных сигарет;
2. группа риска профессионального ринита: промывания изотоническими растворами и средства индивидуальной защиты;
3. вкусовой ринит в анамнезе: отказ от пряностей и (или) алкоголя;
4. при назначении препаратов, вызывающих ринит, предупредить пациента и при появлении симптомов решить вопрос об отмене или замене;
5. функциональный подход при операциях на нижних раковинах для профилактики ятрогенного атрофического ринита.

Специфической профилактики ринита беременных, гормонального, ринита пожилых, NARES и вазомоторного ринита нет. Медицинская реабилитация не показана.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический ринит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 06.10.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2029 года
Код в рубрикаторе	`1082_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Национальная ассоциация ринохирургов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.

Клинические рекомендации

Хронический синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J32.0** — Хронический верхнечелюстной синусит **J32.1** — Хронический фронтальный синусит **J32.2** — Хронический этмоидальный синусит **J32.3** — Хронический сфеноидальный синусит **J32.4** — Хронический пансинусит **J32.8** — Другие хронические синуситы **J32.9** — Хронический синусит неуточненный **J34.1** — Киста или мукоцеле носового синуса
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/955_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз хронического синусита у взрослых:

  Обязательные критерии

  1. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа (затруднение носового дыхания) или выделения из носа, передние или стекающие по задней стенке глотки;
  2. сохранение симптомов **12 недель и более**.

  Возможные симптомы

  1. боль или ощущение распирания в проекции пазух;
  2. снижение или потеря обоняния.

  Подтверждение диагноза

  1. эндоскопия: полипы, слизисто-гнойные выделения или отёк и обструкция слизистой оболочки, преимущественно в среднем носовом ходе;
  2. компьютерная томография (КТ): изменения слизистой оболочки остиомеатального комплекса или пазух.
- Основа консервативного лечения:
  1. промывание полости носа солевым раствором всем пациентам;
  2. интраназальные глюкокортикостероиды **с 12 лет**; для оценки эффекта их применяют **не менее 3 месяцев**.
- К системной антибактериальной терапии прибегают только при среднетяжёлом и тяжёлом обострении или осложнениях; стартовый препарат в амбулаторной практике: амоксициллин с клавулановой кислотой.
- Взрослым при неэффективности **1–2 курсов** адекватной консервативной терапии показана функциональная риносинус-хирургия.
- Показания к экстренной госпитализации в оториноларингологическое отделение:
  1. внутричерепные или внутриглазничные осложнения;
  2. тяжёлое обострение;
  3. среднетяжёлое обострение при неэффективности амбулаторного лечения **в течение 5–7 дней**;
  4. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.
- При случайном выявлении бессимптомной кисты околоносовой пазухи большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку многие кисты медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.
- Мукоцеле характеризуется медленным ростом, растягивает, а в ряде случаев разрушает стенку пазухи, поэтому его во всех случаях удаляют хирургически.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический синусит (хронический риносинусит, ХРС): воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух длительностью **более 12 недель** с **двумя и более** симптомами.

Симптомы

1. заложенность носа или выделения из носа (передние или стекающие в носоглотку): один из них обязателен;
2. боль или ощущение давления в области лица;
3. снижение или потеря обоняния.

1. ретенционные (истинные, секретирующие) кисты: закупорка выводных протоков желёз слизистой оболочки; стенки с двусторонней выстилкой мерцательным цилиндрическим эпителием;
2. лимфоэктатические (несекретирующие, ложные, интрамуральные) кисты: в толще слизистой оболочки, без внутренней эпителиальной выстилки; следствие хронического воспаления в пазухах или баротравмы.

Мукоцеле представляет собой доброкачественное, медленно растущее кистовидное образование околоносовой пазухи. Оно формируется при стойком нарушении дренажной функции естественного соустья пазухи и часто вызывает растяжение, реже разрушение её стенок.

2.2 Этиология

Заболевания, ассоциированные с ХРС

1. аллергический ринит;
2. первичная цилиарная дискинезия;
3. муковисцидоз;
4. бронхиальная астма;
5. гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
6. иммунодефицитные состояния;
7. системные аутоиммунные заболевания.

Анатомические особенности остиомеатального комплекса

1. искривление перегородки носа;
2. буллёзная или парадоксально изогнутая средняя носовая раковина;
3. гиперпневматизация решётчатой буллы, супрабуллярной или инфраорбитальной клетки;
4. аномалии крючковидного отростка;
5. добавочное соустье верхнечелюстной пазухи.

Эти особенности нарушают вентиляцию полости носа и отток секрета из полости носа и околоносовых пазух. У детей, значительно реже у взрослых, ХРС может быть связан с гипертрофией аденоидов.

У детей, особенно дошкольного возраста, основной причиной ХРС является муковисцидоз, реже первичная цилиарная дискинезия. По данным отечественных исследований, связь между ХРС и искривлением перегородки носа у детей не выявлена.

Предрасполагающим фактором может являться также аллергический отёк слизистой оболочки в области среднего носового хода; аллергический ринит и хронический синусит часто сочетаются.

Одонтогенный синусит связан с заболеваниями зубов и стоматологическим лечением; среди возбудителей преобладают анаэробы.

Причины хронического верхнечелюстного синусита

1. периодонтит или пародонтит;
2. эндодонтическое лечение (частая причина): инфицированный детрит или пломбировочный материал попадает в пазуху через корневые каналы;
3. дентальная имплантация с предшествующим наращиванием костной ткани.

ГЭРБ также может способствовать развитию ХРС: попадание рефлюктата на слизистую оболочку полости носа и носоглотки вызывает воспаление и нарушение мукоцилиарного клиренса, что может привести к блоку остиомеатального комплекса.

Важным фактором риска является курение: табак оказывает токсическое действие на слизистую оболочку полости носа, вызывает её сухость и изменяет свойства слизи.

Связь ретенционных кист с воспалительными заболеваниями полости носа и травмами не доказана. Лимфоэктатические кисты в большинстве случаев обусловлены хроническим, прежде всего аллергическим, воспалением слизистой оболочки; риск их развития повышают гипервентиляция верхнечелюстной пазухи и баротравма. Радикулярная одонтогенная киста развивается из эпителиальной гранулёмы у верхушки корня кариозного зуба; зубная киста может оттеснять дно верхнечелюстной пазухи или прорастать в неё; фолликулярная киста развивается очень медленно из зубного фолликула.

Причины мукоцеле

1. в подавляющем большинстве случаев операции на околоносовых пазухах;
2. травма;
3. хроническое воспаление пазух;
4. опухоли;
5. лучевая терапия;
6. описаны врождённые мукоцеле;
7. у детей чаще всего вторичный хронический синусит при муковисцидозе.

Более чем в трети случаев причину установить не удаётся.

2.3 Классификация

По локализации (с указанием стороны)

1. верхнечелюстной;
2. этмоидальный;
3. фронтальный;
4. сфеноидальный.

Воспаление пазух только одной стороны обозначают как гемисинусит, поражение нескольких пазух как полисинусит.

В клинической практике хронический синусит принято подразделять на полипозный риносинусит и синусит без полипов.

По этиологии выделяют бактериальный, грибковый и бактериально-грибковый синусит.

Тяжесть оценивают по суммарной выраженности симптомов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10:

1. лёгкая форма: **0–3 балла**;
2. среднетяжёлая: **4–7 баллов**;
3. тяжёлая: **8–10 баллов**.

> Классификация по тяжести содержит ссылку на приложение Г1, однако в нём описана ВАШ только для оценки интенсивности боли и с другой градацией: значение до 2 см соответствует слабой боли, 2–4 умеренной, 4–6 сильной, 6–8 сильнейшей, до 10 невыносимой. Способ подсчёта суммарной выраженности симптомов в рекомендации не указан.

Классификация EPOS 2020 года основана на эндотипах и фенотипах. Первичный синусит может быть односторонним (локализованным), с воспалением 2-го типа или не 2-го типа (сюда же относят аллергический грибковый синусит и изолированный синусит одной пазухи), и двусторонним (диффузным) с теми же двумя эндотипами, эозинофильным или неэозинофильным. Вторичный односторонний синусит связан с одонтогенным процессом, мицетомой («грибковым шаром») или опухолью. Вторичный двусторонний синусит может быть механическим, воспалительным и иммунным; к его фенотипам относятся первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, гранулематоз с полиангиитом, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом и селективный иммунодефицит.

В России кисты околоносовых пазух, как правило, классифицируют по М. И. Кадымовой:

1. ретенционные;
2. лимфоэктатические;
3. одонтогенные (радикулярные) кисты верхнечелюстной пазухи;
4. кисты, связанные с пороками развития.

Более 90% кист локализуются в верхнечелюстной пазухе, около 5% в клиновидной пазухе, в лобной пазухе и клетках решётчатого лабиринта кисты встречаются крайне редко. Более чем в 80% случаев киста односторонняя; множественные кисты выявляются лишь у четверти пациентов.

Мукоцеле чаще всего поражает лобные пазухи, реже клетки решётчатого лабиринта, верхнечелюстные и клиновидные пазухи; ряд авторов считает наиболее частой лобно-решётчатую локализацию. Описаны также крайне редкие локализации: нижняя стенка орбиты, крыловидное пространство, средняя и нижняя носовые раковины.

2.4 Клиническая картина

Клиническая картина ХРС неспецифична:

1. заложенность носа;
2. выделения из носа и стекание по задней стенке глотки;
3. головная или лицевая боль;
4. снижение или отсутствие обоняния;
5. ощущение неприятного запаха в носу;
6. у детей кашель, связанный со стеканием слизи по задней стенке глотки.

Основные симптомы, в наибольшей степени влияющие на самочувствие, это заложенность носа и выделения. Хронический синусит отличается от острого сохранением симптомов **более 12 недель** без полного их разрешения.

Кисты часто протекают бессимптомно и выявляются случайно при лучевом исследовании головы.

Крупная киста

1. чаще всего головная или лицевая боль;
2. редко внезапное истечение из носа жидкости янтарного цвета при самопроизвольном разрыве кисты;
3. онемение верхней губы или зубная боль.

Заложенность носа, выделения и кашель от стекания слизи у пациента с кистой, вероятнее всего, обусловлены сопутствующим аллергическим ринитом или ХРС.

Проявления мукоцеле зависят от локализации и размера.

Основные симптомы мукоцеле

1. головная боль;
2. ощущение давления в области лица;
3. заложенность носа;
4. выделения из носа;
5. боль в периорбитальной области.

Небольшое мукоцеле может протекать бессимптомно, однако значительно реже, чем киста.

2.5 Жалобы и анамнез

Жалобы взрослых

1. стойкая односторонняя или попеременная заложенность носа;
2. слизистые или слизисто-гнойные выделения;
3. необходимость сморкания или стекание слизи по задней стенке глотки, более выраженное после пробуждения или постоянное в течение дня;
4. неприятный запах в полости носа или носоглотке;
5. снижение обоняния вплоть до аносмии;
6. при хроническом сфеноидите периодическая боль в теменной и затылочной областях.

Для хронического фронтита характерна выраженная боль в проекции лобной пазухи на стороне поражения при обострении или при перемене атмосферного давления. Возможно ощущение давления за спинкой носа и глазными яблоками, усиливающееся при обострении.

У детей младшего возраста жалобы выясняют у родителей или опекунов:

1. частые затяжные «насморки»;
2. заложенность носа;
3. слизистые выделения;
4. кашель, преимущественно ночью или в положении лёжа на спине.

При выявлении кистоподобного образования по данным лучевых исследований в первую очередь уточняется наличие головной или лицевой боли, её постоянный характер, провоцирующие и усиливающие её факторы. Выясняются перенесённые ранее операции на полости носа и околоносовых пазухах и стоматологическое лечение.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии

1. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа (затруднение носового дыхания) или выделения из носа, передние или стекающие по задней стенке глотки;
2. сохранение симптомов **12 недель и более**.

Возможные симптомы

1. боль или ощущение распирания в проекции пазух;
2. снижение или потеря обоняния.

Подтверждение диагноза

1. эндоскопия: полипы, слизисто-гнойные выделения или отёк и обструкция слизистой оболочки, преимущественно в среднем носовом ходе;
2. компьютерная томография (КТ): изменения слизистой оболочки остиомеатального комплекса или пазух.

У детей необходимы **два и более** из четырёх симптомов на протяжении **12 недель и более**:

1. затруднение носового дыхания;
2. боль или ощущение распирания в проекции пазух;
3. выделения из носа или стекание по задней стенке глотки;
4. кашель.

Эндоскопические признаки и изменения по данным КТ такие же, как у взрослых.

Киста околоносовой пазухи: признаки на КТ или магнитно-резонансной томографии (МРТ)

1. округлое однородное мягкотканное образование на широком основании;
2. чёткие границы;
3. отсутствие деструкции кости и выраженной деформации стенок.

Отличить ретенционную кисту от лимфоэктатической можно только гистологически, по оболочке удалённой кисты.

Одонтогенная киста верхнечелюстной пазухи: признаки на КТ

1. однородное образование на широком основании на нижней стенке пазухи;
2. чёткие границы, оболочка костной плотности;
3. связь с корнями верхних зубов.

Учитывают заключение стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга о заболевании соседних зубов.

Мукоцеле: признаки на КТ

1. образование в пазухе с округлым ровным контуром;
2. однородное содержимое без кальцинатов и включений;
3. возможны истончение прилежащих костных структур и пролабирование в соседние анатомические области.

3.2 Осмотр оториноларинголога и консультации специалистов

Показания

1. все пациенты с хроническим синуситом, с подозрением на кисту или мукоцеле: осмотр оториноларинголога, сбор жалоб и анамнеза, планирование лечения.

Консультация аллерголога

1. хронический синусит и отягощённый аллергологический анамнез;
2. взрослые с подозрением на кисту или мукоцеле и отягощённым аллергологическим анамнезом.

Консультация гастроэнтеролога

1. симптомы рефлюкса.

Консультация генетика

1. признаки муковисцидоза или первичной цилиарной дискинезии.

Консультация стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга

1. подозрение на одонтогенный синусит или кисту верхнечелюстной пазухи: подтверждение или исключение одонтогенной причины.

3.3 Бактериологическое исследование

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности.

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение;
2. обострение: выбор или коррекция антибактериальной терапии.

Оптимальным материалом для исследования является аспират непосредственно из поражённой пазухи, полученный при пункции верхнечелюстной пазухи или интраоперационно.

3.4 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки

Показания

1. все пациенты с предполагаемым хроническим синуситом: оценка состояния синоназальных структур и подтверждение диагноза.

Диагностические признаки

1. полипы;
2. слизисто-гнойные выделения;
3. отёк и обструкция слизистой оболочки, преимущественно в среднем носовом ходе.

3.5 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания к спиральной КТ околоносовых пазух

1. признаки осложнений при обострении;
2. подготовка к хирургическому вмешательству;
3. необходимость дифференциальной диагностики.

КТ является наиболее информативным методом как у взрослых, так и у детей.

Диагностические признаки

1. типичные признаки ХРС: утолщение слизистой оболочки и снижение пневматизации в области соустий;
2. изолированное воспаление;
3. блок соустья;
4. инородное тело;
5. диффузный грибковый процесс или мицетома;
6. опухоль;
7. аномалии развития пазух;
8. признаки одонтогенной причины.

Для планирования объёма операции КТ выполняется не ранее чем за 6 месяцев до вмешательства.

Показания

1. подозрение на кисту, выявленную другим методом и сопровождающуюся постоянными или периодическими симптомами;
2. подозрение на мукоцеле.

При затруднении дифференциальной диагностики мукоцеле с другими образованиями КТ выполняется с внутривенным болюсным контрастированием: контрастное вещество накапливается в оболочке мукоцеле, но не в его содержимом.

---

4. Лечение

Этиологических факторов ХРС много, и они могут действовать одновременно, поэтому лечение подбирают каждому пациенту индивидуально.

Основой консервативного лечения является медикаментозная терапия; по показаниям её назначают и после функциональной риносинус-хирургии.

Доказательства эффективности консервативного лечения кист и мукоцеле околоносовых пазух отсутствуют; уменьшение симптомов возможно лишь при эффективности медикаментозной терапии сопутствующего ХРС или аллергического ринита.

4.1 Базисная терапия

1. Промывание полости носа гипертоническим или изотоническим солевым раствором всем пациентам: очищает полость носа и уменьшает антигенную нагрузку на слизистую оболочку.
   Промывание полости носа имеет важное значение и в составе послеоперационного лечения.
2. Интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС) пациентам **старше 12 лет** для уменьшения выраженности симптомов.
   Единая схема дозирования, кратности и длительности применения отсутствует; допустимо применение как низких, так и высоких доз. Для оценки эффекта лечение продолжается **не менее 3 месяцев**.
   Носовые кровотечения вследствие сухости слизистой оболочки чаще при высоких дозах.

   Зарегистрированное показание при ХРС есть только у мометазона, назальный спрей

1. взрослые и дети старше 12 лет: по 2 дозы (100 мкг) в каждую половину носа 2 раза в сутки, 400 мкг в сутки.

4.2 Симптоматическая терапия при обострении

1. Сосудосуживающие капли или спреи в нос для облегчения оттока секрета из пазух, **не более 5–7 дней**.
   1. нафазолин в оториноларингологической практике не допускается: выраженное токсическое действие;
   2. предпочтительны оксиметазолин 0,01–0,05% и ксилометазолин 0,05–0,1%;
   3. строго по назначению и под контролем врача, **не более 5–7 дней**: при более длительном применении развивается медикаментозный ринит.
2. Растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием для более быстрого регресса симптомов.

   Эффективны комбинированные препараты, содержащие экстракты корня горечавки жёлтой, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины чёрной и травы вербены, а также миртол.
3. Муколитические препараты для разжижения отделяемого и облегчения его оттока.
   1. карбоцистеин коротким курсом, **до 2–3 недель**, при обострении с густым секретом в полости носа;
   2. возможны курсы около 3 месяцев в сочетании с противовоспалительными средствами;
   3. одновременно с другими отхаркивающими и муколитическими средствами, в том числе местными, не назначают: усиливается стекание слизи по задней стенке глотки.
4. Нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол при повышении температуры тела, головной или лицевой боли.
   Детям **до 6 лет** допустимы только:
   1. парацетамол: до 60 мг/кг в сутки;
   2. ибупрофен: до 30 мг/кг в сутки.

4.3 Лёгкое обострение

1. Пациентам, ранее перенёсшим синусотомию, при появлении гнойных выделений: местные антибактериальные препараты.

   Эффект оценивается **через 3–4 дня**; при его отсутствии решается вопрос о системной антибактериальной терапии.

   Зарегистрированы в России для лечения ХРС
   1. фрамицетин, назальный спрей: детям с первых лет жизни; при обострении не более 7 дней;
   2. комбинированный спрей (дексаметазон, неомицин, полимиксин B, фенилэфрин): с 2,5 лет; при обострении не более 10 дней.

   Разовая и суточная дозы строго по инструкции.

   Введение в полость носа и околоносовые пазухи растворов антибиотиков, предназначенных для внутримышечного и внутривенного введения, не допускается: они не адаптированы для этой цели и оказывают повреждающее действие на мерцательный эпителий. Для введения в пазуху может применяться тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат.

4.4 Среднетяжёлое и тяжёлое обострение

1. Системная антибактериальная терапия: при среднетяжёлом и тяжёлом обострении, в том числе с периорбитальными и внутричерепными осложнениями, а также при таком обострении у пациентов с заболеваниями, повышающими риск бактериальной инфекции. Стартовый препарат в амбулаторной практике: амоксициллин с клавулановой кислотой (препараты и дозы в таблице ниже).

2. Эффект антибиотика должен проявиться **на третьи сутки**; при наличии эффекта препарат применяют **10–14 дней**.
3. Если стартовый антибиотик в амбулаторных условиях неэффективен, решают вопрос о неотложном направлении в оториноларингологическое отделение. В стационаре при среднетяжёлом течении предпочтителен приём препаратов внутрь, при его невозможности парентеральное введение; при тяжёлом, в том числе осложнённом, обострении антибиотики вводят внутривенно.
4. При неэффективности цефалоспоринов III поколения или выделении устойчивых к ним штаммов: препарат резерва (цефалоспорин IV поколения, карбапенем, оксазолидинон, гликопептид и другие) с учётом чувствительности возбудителя.
5. Детей с обострением, требующим системных антибиотиков, при невозможности назначения пенициллинов предпочтительно лечить в стационаре.
6. Пункция верхнечелюстной пазухи для дренирования: при тяжёлом обострении хронического верхнечелюстного синусита, при среднетяжёлом в случае неэффективности консервативного лечения.

   Через пункционную иглу промывают пазуху раствором антисептика, удаляют секрет и вводят антибиотик.

   Пункция допустима только при наличии результатов лучевого исследования, исключающих гипоплазию и ателектаз верхнечелюстной пазухи и подтверждающих скопление в ней секрета.

   При тяжёлом обострении пункция часто не заменяет санирующую операцию. Детям пункцию выполняют только в условиях стационара.

   Для дренирования возможны установка синус-катетера или зондирование пазух через естественные соустья.

Системные антибиотики

Препарат	Показания и режим дозирования
Амоксициллин и клавулановая кислота	Стартовый препарат при обострении в амбулаторной практике у детей и взрослых. Детям от 3 месяцев до 12 лет или с массой тела менее 40 кг — 40 мг/кг в сутки в 3 приёма каждые 8 часов (суспензии 125/31,25 мг и 250/62,5 мг в 5 мл); суспензия 400/57 мг в 5 мл назначается по 45 мг/кг в сутки в 2 приёма. При высоком риске полирезистентного пневмококка — суспензия 600/42,9 мг в 5 мл, 90 мг/кг в сутки по амоксициллину в 2 приёма. Пациентам с массой тела более 40 кг и старше 12 лет — таблетки 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	При лёгкой аллергии на пенициллины. Детям младше 12 лет или с массой тела менее 50 кг — 8 мг/кг в сутки в 1 приём; старше 12 лет — 400 мг 1 раз в сутки.
Цефиксим, цефтриаксон, цефотаксим	При неэффективности амоксициллина с клавулановой кислотой. Старше 12 лет или с массой тела от 50 кг: цефиксим внутрь 400 мг 1 раз в сутки, цефтриаксон внутривенно или внутримышечно 1–2 г 1 раз в сутки, цефотаксим внутривенно или внутримышечно 1 г каждые 12 часов. Детям младше 12 лет или с массой тела менее 50 кг: цефиксим 8 мг/кг в сутки в 1 приём, цефтриаксон 75–80 мг/кг в сутки в 1 введение, цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 2–4 введения.
#Левофлоксацин, #моксифлоксацин	Только взрослым пациентам в амбулаторных условиях при непереносимости всех бета-лактамов или тяжёлой аллергии на пенициллины: #левофлоксацин 500 мг внутрь 1 раз в сутки или #моксифлоксацин 400 мг внутрь 1 раз в сутки, курс 10–14 дней. Пометка off-label (в КР — знак #) обозначает применение вне инструкции.

4.5 Хирургическое лечение

Сроки операции определяются тяжестью:

1. тяжёлое обострение, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями: неотложное или экстренное вмешательство;
2. среднетяжёлое обострение и неэффективность консервативного лечения: возможны малоинвазивные манипуляции в неотложном порядке;
3. остальные пациенты: плановое вмешательство по показаниям; при отсутствии показаний или наличии противопоказаний консервативное лечение и наблюдение оториноларинголога.

1. Взрослым при неэффективности **1–2 курсов** адекватной консервативной терапии: функциональная риносинус-хирургия для восстановления аэрации пазух, устранения симптомов и предотвращения осложнений.
2. Детям с хроническим синуситом и гипертрофией аденоидов III степени при неэффективности консервативного лечения **в течение 3–6 месяцев**: первым этапом удаление аденоидов.
   Вмешательство планируют при отсутствии противопоказаний, предпочтительно под общим обезболиванием в условиях оториноларингологического отделения или стационара кратковременного пребывания; при наличии соответствующего оснащения вмешательство проводится под эндоскопическим контролем.
3. Детям со среднетяжёлым и тяжёлым ХРС при неэффективности лечения **в течение 3–6 месяцев**, если гипертрофия аденоидов исключена или аденоиды удалены **более 6 месяцев** назад: функциональная эндоскопическая риносинус-хирургия.
   Операция плановая. Вмешательство не нарушает рост пазух и лицевого скелета, однако у детей выше риск рубцевания и повторного стенозирования, а малые размеры анатомических структур требуют современного оборудования.
4. Детям с изолированным поражением пазухи: эндоскопическое дренирование пазухи.

   Детям операцию выполняют независимо от состояния аденоидов, если

   1. на КТ отграниченное тотальное или субтотальное затемнение одной пазухи или резкое снижение её пневматизации;
   2. в сочетании с типичными жалобами.

   У детей необходима онкологическая настороженность в отношении любого образования на КТ, кроме кист с чёткими типичными признаками, не увеличивающихся в размерах.
5. Киста околоносовой пазухи с постоянными или периодическими симптомами: эндоскопическое удаление с опорожнением кисты и полным или частичным удалением её оболочки.
   При случайном выявлении бессимптомной кисты большинство экспертов считают хирургическое вмешательство нецелесообразным, поскольку кисты, за исключением одонтогенных, часто медленно уменьшаются самостоятельно или не изменяются.
6. Мукоцеле: эндоскопическое дренирование у всех пациентов.
   При лобной локализации методом выбора считается эндоскопическая марсупиализация с передней этмоидэктомией и фронтотомией по Драфу. При латеральном расположении мукоцеле, дефекте передней стенки лобной пазухи и большом мукоцеле с распространением в полость черепа используется наружный доступ.

> В тексте рекомендации имеется расхождение: в рекомендации о хирургическом лечении взрослых показанием является неэффективность 1–2 курсов консервативной терапии, тогда как в разделе 6 показанием к плановой госпитализации для операции названа неэффективность адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев.

Под функциональной риносинус-хирургией в рекомендации понимаются фронтотомия, этмоидотомия, сфеноидотомия, гайморотомия и вмешательства на структурах полости носа. У взрослых при наличии соответствующего оснащения предпочтительна эндоскопическая техника; у детей при плановом вмешательстве она обязательна.

Кисты и неосложнённые мукоцеле оперируют в плановом порядке, как правило, теми же методами функциональной риносинус-хирургии; при кистах верхнечелюстной пазухи и мукоцеле лобной пазухи в ряде случаев используются микрогайморотомия и фронтотомия через переднюю стенку.

4.6 Иное лечение

Пациенты с вторичным ХРС, у которых изменения в полости носа и околоносовых пазухах являются проявлением другого заболевания, находятся под наблюдением и получают лечение у профильного специалиста. Лечение одонтогенных кист верхнечелюстной пазухи осуществляют совместно со стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Послеоперационное ведение

После операции все пациенты находятся под амбулаторным наблюдением оториноларинголога для оценки состояния полости носа и своевременного выявления поздних осложнений.

Первый осмотр **через 7–14 дней** после выписки, далее повторно несколько раз в течение года.

Цели осмотров

1. контроль состояния полости носа: при неадекватном уходе образуются корки и синехии;
2. выявление и предупреждение осложнений;
3. выполнение манипуляций при необходимости;
4. контроль течения заболевания и своевременная коррекция лечения.

В течение месяца после операции щадящий режим; избегать факторов, повышающих давление и способных спровоцировать кровотечение:

1. интенсивных физических нагрузок;
2. перегревания;
3. переохлаждения.

Для профилактики острой респираторной инфекции избегать мест массового скопления людей, по возможности больше времени проводить дома.

5.2 Профилактика

Первичная профилактика: защита от неблагоприятных факторов внешней среды; вторичная: максимально раннее выявление заболевания.

Профилактике способствуют

1. своевременное лечение заболеваний зубов;
2. лечение гастроэзофагеального рефлюкса;
3. отказ от курения;
4. техника безопасности при работе с веществами, вредными для дыхательных путей.

Профилактикой мукоцеле является соблюдение принципов функциональной хирургии при операциях на полости носа и околоносовых пазухах, профилактикой лимфоэктатических кист своевременное лечение хронического воспаления в полости носа, радикулярных кист своевременное лечение верхних зубов.

Пациенту разъясняют

1. полное излечение затруднительно, но выраженность симптомов можно уменьшить;
2. как правило, требуется пожизненный контроль;
3. тактику лечения определяет оториноларинголог, в ряде случаев совместно с другими специалистами.

Образ жизни и лечение

1. отказ от курения или по крайней мере уменьшение количества сигарет;
2. при аллергии гипоаллергенный быт;
3. приверженность лечению и соблюдение режима дозирования;
4. правильная техника введения препаратов и промывания полости носа.

5.3 Показания к госпитализации

Лечение ведёт прежде всего оториноларинголог, при необходимости совместно с:

1. аллергологом-иммунологом;
2. гастроэнтерологом;
3. ревматологом;
4. стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

Консервативное лечение и лечение лёгких обострений проводят амбулаторно.

Показания к экстренной госпитализации в оториноларингологическое отделение

1. внутричерепные или внутриглазничные осложнения;
2. тяжёлое обострение;
3. среднетяжёлое обострение при неэффективности амбулаторного лечения **в течение 5–7 дней**;
4. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.

Показания к плановой госпитализации для хирургического лечения:

1. подтверждённый хронический синусит, резистентный к адекватной консервативной терапии **в течение 6 месяцев**;
2. рецидив симптомов после операции;
3. сохранение жалоб и признаков синусита у детей после удаления аденоидов;
4. изолированное воспаление с субтотальным или тотальным снижением пневматизации по данным КТ **более 2 месяцев**;
5. подозрение на новообразование пазухи неясного характера;
6. «синдром молчащего синуса» верхнечелюстной пазухи по данным КТ;
7. киста с постоянными или периодическими симптомами;
8. мукоцеле.

Пациента выписывают:

1. после выполнения операции в запланированном объёме;
2. при удовлетворительном общем состоянии;
3. при отсутствии местного или системного острого инфекционно-воспалительного процесса.

5.4 Прогноз

Эффективность лечения зависит от

1. анатомических особенностей полости носа и околоносовых пазух;
2. хронических системных заболеваний;
3. активного и пассивного курения;
4. профессиональных вредностей;
5. климатических и экологических условий;
6. приверженности пациента лечению.

Одонтогенные кисты не регрессируют самостоятельно, и их лечением совместно занимаются несколько специалистов.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический синусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	955_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки хирургического лечения у взрослых расходятся: в рекомендации о функциональной риносинус-хирургии операция показана после 1–2 неэффективных курсов консервативной терапии, в показаниях к плановой госпитализации (раздел 6) после 6 месяцев неэффективной терапии.
- Классификация по тяжести (0–3, 4–7, 8–10 баллов суммарной выраженности симптомов) ссылается на приложение Г1, в котором описана ВАШ только для оценки боли и с другой градацией.

Клинические рекомендации

Хронический средний отит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.2** — Хронический серозный средний отит **H65.3** — Хронический слизистый средний отит **H65.4** — Другие хронические негнойные средние отиты **H66.1** — Хронический туботимпанальный гнойный средний отит **H66.2** — Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит **H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты **H72.0** — Центральная перфорация барабанной перепонки **H90.0** — Кондуктивная потеря слуха двусторонняя **H90.1** — Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.2** — Кондуктивная потеря слуха неуточненная **H90.6** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя **H90.7** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя, с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.8** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/698_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Основной метод лечения хронического гнойного среднего отита хирургический; каждый пациент рассматривается как потенциальный кандидат на операцию. Оперируют в период ремиссии, **не ранее чем через 3–6 месяцев** после последнего обострения.
- Всем пациентам выполняют тональную пороговую аудиометрию: она определяет степень и вид тугоухости и позволяет прогнозировать результат операции. При порогах костной проводимости **выше 30 дБ** в диапазоне разговорных частот качественного улучшения слуха не следует ожидать даже после безупречно выполненной операции.
- При подозрении на холестеатому или её рецидив показана магнитно-резонансная томография (МРТ) височных костей: в режимах T1, T2 и диффузионно-взвешенных изображений метод позволяет отличить холестеатому от секрета, грануляций и холестероловой гранулемы.
- В консервативном лечении основная роль принадлежит местным средствам: антисептикам, ушным каплям с противомикробными препаратами и кортикостероидами. Топические фторхинолоны не обладают ототоксичностью и допустимы при перфорации барабанной перепонки. Местное лечение эффективно только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.
- Диспансерное наблюдение:
  1. неоперированные пациенты: **раз в 6 месяцев**;
  2. после тимпанопластики или санирующей операции: **ежегодно не менее 5 лет**.

  Цель: своевременно выявить рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) характеризуется хроническим воспалением полостей среднего уха со стойкой перфорацией барабанной перепонки, постоянным или периодическим гноетечением из уха и прогрессирующим снижением слуха на протяжении **более 3 месяцев**.

Мукозитом называется хроническое катаральное воспаление слизистой оболочки среднего уха. Тимпаносклероз является необратимым исходом неспецифического воспаления и сопровождается тугоухостью вследствие фиксации звукопроводящей цепи. Тимпанофиброз представляет собой незавершённый процесс, при котором в барабанной полости фиброзирование преобладает над воспалением. Холестеатома является белесовато-перламутровым эпидермальным образованием с оболочкой (матриксом), покрытой многослойным плоским эпителием; матрикс плотно прилежит к кости и нередко врастает в неё.

2.2 Этиология

Фон у взрослых

1. хронические заболевания полости носа, околоносовых пазух и носоглотки;
2. перенесённые острые средние отиты;
3. системная и специфическая патология.

Пусковой фактор

1. как правило, острый средний отит, после которого сохраняется стойкая перфорация или ретракция с атрофичной неомембраной;
2. травматическая или ятрогенная перфорация: после врачебных манипуляций сохраняется у 1,3–10,8% пациентов.

Хронизации процесса способствуют анатомические особенности среднего уха и слуховой трубы, неадекватная антибактериальная терапия острого отита без дренирования среднего уха, устойчивые штаммы возбудителей, ретракция после острого отита, экссудативный средний отит, снижение местной иммунной защиты, а также заболевания носоглотки и полости носа, нарушающие мукоцилиарный клиренс слуховой трубы.

Ведущим возбудителем среди аэробов является синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), второе место по значимости занимает золотистый стафилококк. Из анаэробов чаще высеваются пептококки и пептострептококки, реже бактероиды; анаэробная флора чаще сопутствует холестеатоме. В 1,4–20% случаев выявляется грибковая флора, как правило Aspergillus и Candida.

2.3 Классификация

Формы ХГСО по МКБ-10

1. мезотимпанит (туботимпанальный отит): поражается преимущественно слизистая оболочка мезо- и гипотимпанума;
2. эпитимпанит (эпитимпано-антральный отит): процесс распространяется из эпитимпанума на клетки сосцевидного отростка и вовлекает костные структуры среднего уха.

Неперфоративные формы

1. экссудативный отит;
2. адгезивный (рубцовый) отит;
3. отит с тимпаносклерозом или тимпанофиброзом.

Перфоративные формы

1. сухой отит;
2. отит с мукозитом;
3. отит с тимпаносклерозом;
4. отит с холестеатомой.

Расположение перфорации отражает лишь преимущественную локализацию воспалительного процесса и не позволяет судить об изменениях в среднем ухе: даже при мезотимпаните разрушение цепи слуховых косточек выявляется у 10–22% пациентов, а холестеатома в барабанной полости у 11,6–42%. Поэтому для планирования операции необходима диагностика этих изменений.

Классификация Европейской академии отологии и нейроотологии и Японского отологического общества (EAONO/JOS) выделяет 4 типа холестеатомы (врождённая холестеатома, холестеатома ненатянутой части, холестеатома натянутой части барабанной перепонки и вторичная холестеатома при перфорации натянутой части) и 4 стадии: 1-я стадия соответствует поражению одного региона, 2-я стадия поражению двух и более регионов, 3-я стадия наличию внечерепного осложнения, 4-я стадия наличию внутричерепного осложнения. Регионы обозначаются по системе STAM: труднодоступные зоны (надтубарный и тимпанальный синусы), барабанная полость, аттик и сосцевидный отросток.

2.4 Клиническая картина

Пациенты предъявляют жалобы на снижение слуха и шум в ухе; при отоскопии определяется перфорация барабанной перепонки с отделяемым или холестеатомой.

Мезотимпанит: перфорация в натянутой части барабанной перепонки, встречается у 48–69% больных ХГСО. Форма относительно благоприятная: признаки активной остеодеструкции отсутствуют.

1. эпитимпанит у 15–19% больных: перфорация в ненатянутой части барабанной перепонки, в среднем ухе кариозный процесс, способный привести к лабиринтным и внутричерепным осложнениям;
2. в 79–97% случаев деструкция кости обусловлена холестеатомой;
3. ретракционный карман: начальная стадия холестеатомы, в 80% случаев она развивается именно из него.

Эпимезотимпанит выявляется у 17–33% пациентов и сочетает признаки обеих форм.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании совокупности жалоб, данных анамнеза, физикального обследования, лабораторных и инструментальных исследований.

3.1 Жалобы и анамнез

Необходимо уточнить наличие снижения слуха на одно или оба уха.

Снижение слуха отмечается у 93–99% пациентов, чаще двустороннее. При длительном течении заболевания с формированием тимпаносклероза, тимпанофиброза и ретракционного кармана тугоухость становится выраженной.

Следует уточнить длительность, частоту и характер выделений из уха.

1. вторая по значимости жалоба, у 76–100% пациентов;
2. около половины: выделения 1–2 раза в год после переохлаждения, попадания воды в ухо или острого респираторного заболевания (ОРЗ);
3. почти треть: частые или постоянные выделения в последние годы;
4. характер: от скудных слизистых до гнойных с ихорозным запахом.

Редкие обострения на фоне выраженной тугоухости характерны для тимпаносклероза, тимпанофиброза и холестеатомы, постоянное отделяемое характерно для мукозита, гнойное отделяемое с неприятным запахом характерно для холестеатомы. Опасность эпитимпанита заключается в длительном бессимптомном течении.

Необходимо уточнить наличие шума в одном или обоих ушах.

Шум в ухе беспокоит 19–48% пациентов. Низкочастотный шум, как правило, связан с дефектом барабанной перепонки, высокочастотный шум связан с поражением внутреннего уха. При тимпаносклерозе и тимпанофиброзе шум усиливается.

Следует уточнить наличие заложенности, ощущения жидкости и дискомфорта в ухе.

Подобные жалобы чаще встречаются при сохранённой натянутой части барабанной перепонки.

Необходимо выяснить, отмечались ли эпизоды головокружения в анамнезе.

Системное головокружение или неустойчивость встречаются у 10–27% больных с холестеатомой и возникают при обострении, нагрузке, наклонах и поворотах головы. В половине случаев эти симптомы свидетельствуют о фистуле лабиринта. При деструкции стенки канала лицевого нерва возможен его парез.

Следует уточнить наличие головной боли.

Головная боль различной локализации часто возникает при обострении. Для неосложнённого эпитимпанита боль в ухе и головная боль не характерны; их появление, как правило, свидетельствует о развитии осложнения.

3.2 Отоскопия и отоэндоскопия

Показания

1. все пациенты: отоскопия или видеоотоскопия; наряду с отоэндоскопией это определяющий метод диагностики ХГСО.

Что оценивают

1. барабанную перепонку: тонкая, утолщённая, рубцовая, очаги тимпаносклероза;
2. наличие и глубину ретракционных карманов;
3. размер и локализацию перфорации, состояние её краёв;
4. слизистую оболочку барабанной полости: мукозит, тимпаносклероз, полипы, грануляции, эпидермизация;
5. доступные осмотру слуховые косточки: кариес, лизис;
6. латеральную стенку аттика и адитус.

3.3 Степени мукозита по данным отоскопии

Степень	Изменения слизистой оболочки
I	Слизистая оболочка медиальной стенки барабанной полости утолщена, свободное отделяемое отсутствует
II	Подушкообразное утолщение слизистой оболочки медиальной стенки с большим количеством слизистых желёз, скудное слизистое отделяемое
III	Выраженная полиповидная гиперплазия слизистой оболочки мезогипотимпанума, слизистое отделяемое

При отоэндоскопии холестеатома визуализируется в 61% случаев.

Перфорация при эпитимпаните может

1. быть точечной;
2. определяться только при продувании;
3. прикрываться серной коркой;
4. временно отсутствовать в период стойкой ремиссии.

В этих случаях тщательно осматривают латеральную стенку аттика, чтобы выявить даже минимальную деструкцию.

Иногда заболевание протекает под маской рецидивирующего экссудативного отита: за прозрачным экссудатом определяется холестеатомный мешок при небольшом ретракционном кармане в ненатянутой части.

Глубокие карманы осматривают эндоскопами с углом обзора 0°, 30° и 70°.

3.4 Фистульная проба и функция слуховой трубы

Распознать фистулу лабиринта позволяет фистульная проба.

Проходимость слуховой трубы оценивают пустым глотком, пробой Тойнби, приёмом Вальсальвы или продуванием баллоном Политцера.

1. чем более выражен мукозит, тем хуже вентиляционная и дренажная функции слуховой трубы;
2. дисфункция слуховой трубы может объяснять ретракцию барабанной перепонки до операции и в отдалённом периоде и учитывается при лечении и реабилитации;
3. при нормальной функции слуховой трубы у пациента с хроническим серозным отитом следует заподозрить спонтанную отоликворею.

3.5 Осмотр полости носа и носоглотки

Необходима оценка состояния полости носа, околоносовых пазух и носоглотки: искривление перегородки носа, гипертрофический ринит, хронические заболевания околоносовых пазух и носоглотки нарушают функцию слуховых труб и снижают эффективность лечения.

3.6 Исследование слуха: камертональные пробы и тональная пороговая аудиометрия

Показания

1. подозрение на снижение слуха.

Количественные (камертоны С128–2048) и качественные (С128–512) пробы Ринне, Федериче и Вебера являются скрининговым методом, позволяющим определить вид тугоухости (кондуктивная или сенсоневральная) и хуже слышащее ухо. По их результатам составляется слуховой паспорт; они же служат показанием к тональной пороговой аудиометрии.

Показания

1. все пациенты с ХГСО при диагностике.

Что даёт исследование

1. степень и вид тугоухости: кондуктивная, смешанная или нейросенсорная;
2. возможности реабилитации;
3. прогноз и контроль результата операции.

При порогах костной проводимости **выше 30 дБ** в диапазоне разговорных частот качественного улучшения слуха не следует ожидать даже после идеально выполненной операции. Динамику предпочтительно оценивать на одном аудиометре у одного специалиста.

Для ХГСО характерна кондуктивная и смешанная тугоухость.

Степень зависит от

1. величины дефекта барабанной перепонки;
2. целостности и подвижности цепи слуховых косточек;
3. токсического воздействия воспалительного процесса на внутреннее ухо.

Глухота при ХГСО часто обусловлена фистулой лабиринта вследствие деструкции кости холестеатомой.

По данным аудиометрии холестеатому распознать невозможно: костно-воздушный интервал не коррелирует с характером разрушения цепи слуховых косточек, а холестеатома и грануляции сами могут проводить звук к внутреннему уху.

3.7 Рентгенография височных костей

Показания

1. ХГСО без холестеатомы: оценка сосцевидного отростка (рентгенография височных костей по Шюллеру и Майеру).

К нему прибегают только при отсутствии подозрения на холестеатому и осложнённое течение.

3.8 Компьютерная томография височных костей

Показания

1. пациенты с ХГСО: оценка структур височных костей; метод первичной диагностики.

Что оценивают

1. распространённость процесса;
2. анатомические особенности: низкое стояние дна средней черепной ямки, высокое стояние луковицы яремной вены, предлежание сигмовидного синуса, дегисценции канала лицевого нерва и лабиринта, перегородка Кёрнера;
3. стенки барабанной полости и антромастоидального отдела;
4. цепь слуховых косточек;
5. слизистую оболочку и узкие пространства барабанной полости.

Исследование выполняют в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией; оптимальная толщина среза 0,5–0,8 мм.

КТ выявляет признаки ХГСО в 99% случаев, деструкцию стенок среднего уха в 55–97% случаев. Дифференцировать холестеатому от фиброза, грануляций, экссудата и гноя по плотности невозможно: плотность всех этих тканей составляет от +30 до +40 HU. Заподозрить холестеатому в 88% случаев позволяют локализация образования, деструкция стенок барабанной полости, слуховых косточек и антромастоидальной области, расширение входа в антрум, разрушение латеральной стенки аттика или адитуса, дефект задней стенки наружного слухового прохода, разрушение канала лицевого нерва и фистула лабиринта, чаще горизонтального полукружного канала.

При ХГСО без холестеатомы на КТ определяются изменения слизистой оболочки, рубцы вокруг цепи слуховых косточек, в ряде случаев её дефект, чаще вследствие лизиса длинной ножки наковальни. Антрум при мезотимпаните в стадии ремиссии, как правило, пневматизирован; сосцевидный отросток в большинстве случаев компактный, склеротический.

Информативность КТ при оценке оперированного уха низкая: рубцы, грануляции и пластический аутоматериал по плотности не отличаются от холестеатомы. Заподозрить холестеатому позволяет только увеличение «подозрительного» образования в динамике.

Для объективной оценки распространённости процесса КТ проводят **не ранее чем через 3–6 месяцев** после обострения. КТ в период обострения приводит к необоснованному расширению объёма операции и оправдана только при осложнённом течении.

3.9 Магнитно-резонансная томография височных костей

Показания

1. подозрение на холестеатому;
2. подозрение на рецидив холестеатомы.

1. режимы T1, T2, EPI DWI и non-EPI DWI надёжно выявляют холестеатому и её рецидив после операции: чувствительность 77–100%, специфичность 86–100%;
2. холестеатома: низкий сигнал в режиме T1, высокий или промежуточный в режимах T2 и non-EPI DWI;
3. на точность влияет размер холестеатомы;
4. для выявления рецидива МРТ имеет преимущества перед ревизионной операцией и служит ей альтернативой.

Ряд авторов для выявления холестеатомы рекомендует сочетать или совмещать КТ и МРТ: чувствительность в этом случае составляет 96%, специфичность 100%.

3.10 Вестибулометрия

Показания

1. ХГСО с холестеатомой, осложнённый фистулой лабиринта.

Исследование необходимо при системном головокружении, неустойчивости и признаках фистулы. Выявление фистулы до операции позволяет предупредить послеоперационные кохлеовестибулярные расстройства.

3.11 Общеклинические лабораторные исследования

Показания

1. подготовка к плановой операции: общеклинические лабораторные исследования.

3.12 Посев отделяемого из уха

Показания

1. посев отделяемого из уха на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Посев необходим при любой форме ХГСО для подбора этиотропной терапии.

Показания

1. подозрение на грибковый процесс: посев отделяемого на дрожжевые и мицелиальные грибы.

Показания

1. удалённые ткани уха: цитологическое и патоморфологическое исследование.
1. удалённую патологическую ткань во всех случаях направляют на патоморфологическое исследование;
2. атипичное течение: спектр исследований расширяют для исключения туберкулёза и гранулематоза Вегенера;
3. нет диагностических данных и стандартное лечение неэффективно: исследования повторяют **через 3 месяца**.

3.13 Консультации специалистов

Показания

1. сопутствующие заболевания и подозрение на осложнение: консультации невролога, нейрохирурга и терапевта.

При атипичном течении воспаления и осложнениях может также потребоваться консультация фтизиатра и ревматолога.

---

4. Лечение

Целью лечения является санация среднего уха для достижения стойкой ремиссии и предупреждения осложнений и тугоухости.

4.1 Консервативное лечение: обострение и подготовка к операции

Консервативная терапия проводится:

1. при обострении;
2. при подготовке к операции при неосложнённом течении.

Её применяют при обострении для достижения ремиссии перед операцией, а также в раннем периоде после санирующей операции.

Включает

1. бета-лактамные антибиотики;
2. анальгетики;
3. кортикостероиды;
4. процедуры, улучшающие функцию слуховой трубы.

При неосложнённом течении лечение амбулаторное, при осложнённом стационарное. В качестве основного метода лечения консервативная терапия носит паллиативный характер и оправдана только у пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией при условии регулярного наблюдения.

При сухом перфоративном среднем отите проведение какого-либо лечения не рекомендуется.

> Расхождение в тексте рекомендации: в разделе 3.1 указано, что при сухом перфоративном отите лечение не проводится, тогда как в разделе 3.2 указано, что при перфорации без возможности улучшения слуха тимпанопластику следует выполнять для предупреждения рецидивов, а наилучшие результаты тимпанопластики достигаются именно при сухих перфорациях. В алгоритме (приложение Б) от сухого перфоративного отита стрелки ведут к лечению. Вероятно, запрет относится только к консервативной терапии.

Антибактериальный препарат выбирается с учётом микрофлоры, её чувствительности и способности препарата проникать через гематоэнцефалический барьер. Препаратами выбора являются бета-лактамы (пенициллины и другие бета-лактамные антибиотики), в ряде случаев респираторные фторхинолоны.

К системным препаратам прибегают, как правило, при выраженном обострении и тяжёлых распространённых деструктивных формах. Периоперационная антибиотикопрофилактика должна соответствовать характеру и объёму операции.

При смешанной микрофлоре рекомендацией предусмотрено сочетание 2–3 препаратов, например цефалоспоринов и фторхинолонов. Допускается сочетание местных противомикробных препаратов с противогрибковыми.

Основная роль принадлежит местным средствам:

1. антисептики;
2. ушные противомикробные препараты: наиболее эффективны и безопасны топические фторхинолоны (к ним чувствительны 75,6% возбудителей, они не ототоксичны и допустимы при перфорации);
3. местные противогрибковые средства;
4. кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами.

Местное лечение эффективно только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.

Грануляции в барабанной полости по возможности удаляются или прижигаются соединениями серебра; кроме того, они хорошо регрессируют под действием топических кортикостероидов.

При грибковой флоре противомикробные препараты и кортикостероиды в каплях противопоказаны. Ведение таких пациентов осуществляется строго по алгоритмам применения местных противогрибковых средств; лечение часто длительное и требует участия миколога.

> Расхождение в тексте рекомендации: абзацем выше допускается сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми, тогда как при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны. Кроме того, «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом АТХ D01A, который относится к противогрибковым препаратам.

Дисфункцию слуховой трубы устраняют поэтапно:

1. лечение заболеваний полости носа и носоглотки, от деконгестантов и назальных кортикостероидов до хирургического вмешательства;
2. восстановление проходимости слуховой трубы продуванием по Политцеру или курсом катетеризаций с введением лекарственных препаратов;
3. восстановление активного открытия и закрытия слуховой трубы гимнастикой или электростимуляцией её мышц.

4.2 Мукозит

Кортикостероиды в каплях или в составе комбинированных препаратов используют при вялотекущем воспалении слизистой оболочки (мукозите). При неэффективности местного лечения **в течение 1–3 месяцев**, что характерно для мукозита, показано хирургическое вмешательство с дренированием.

При ХГСО с мукозитом II и III степени выполняются дренирующие операции.

Методика определяется индивидуально с учётом формы ХГСО и распространённости процесса, анатомии височной кости, степени тугоухости, состояния слуховой трубы, наличия осложнений и опыта хирурга.

1. при мукозите тимпанопластика оправдана: после восстановления функции слуховой трубы и аэрации утолщённая слизистая оболочка нормализуется;
2. слизистую оболочку удаляют инструментально или лазером;
3. выраженный мукозит: лучше оставить дренажную трубку под меатальным лоскутом или вскрыть антрум и дренировать через него барабанную полость на срок **до 2 недель**.

4.3 Хирургическое лечение: общие положения и тимпанопластика

Основной метод лечения ХГСО хирургический: только операция полностью санирует ухо и улучшает качество жизни, поэтому каждого пациента рассматривают как потенциального кандидата на операцию.

Оперируют в период ремиссии, **не ранее чем через 3–6 месяцев** после последнего обострения: объём вмешательства меньше, операция безопаснее и эффективнее.

1. при обострении или осложнении вынужденное вмешательство ограничивается санацией среднего уха открытого типа, при внутричерепных осложнениях расширенной; из-за кровоточивости тканей оно технически сложно и чаще сопровождается ятрогенными осложнениями;
2. пациентов с осложнениями оперируют в ургентных отделениях;
3. вне обострения: в специализированных отделениях и центрах, владеющих реконструктивной хирургией среднего уха;
4. ранняя операция на «сухом ухе»: более полная санация очага, сохранение слуха и анатомических структур, короче реабилитация.

Для санации среднего уха и улучшения слуха выполняется тимпанопластика.

При мезотимпаните применяют тимпанопластику различных типов и миринготимпанопластику в зависимости от степени разрушения цепи слуховых косточек.

Варианты тимпанопластики

1. протезы из хряща, наковальни, кортикальной кости, титана;
2. для пластики барабанной перепонки аутоматериалы;
3. доступ через наружный слуховой проход, эндауральный или заушный;
4. местная анестезия или наркоз;
5. под контролем эндоскопа или микроскопа;
6. в один или два этапа.

Обязательное условие успешной тимпанопластики: отсутствие выделений из уха **не менее 3–6 месяцев**.

Результат зависит от

1. срока после последнего обострения;
2. изменений в среднем ухе;
3. локализации и размера перфорации;
4. функции слуховой трубы и состояния слизистой оболочки;
5. способа реконструкции;
6. опыта хирурга и послеоперационного ведения.

Тимпанопластика эффективна в 43–98% случаев, риск глухоты на оперированное ухо составляет 1–2%. Наилучшие результаты (у 93,3% пациентов) достигаются при сухих перфорациях независимо от техники укладки трансплантата.

Второй этап тимпанопластики проводят **через 8–12 месяцев**. При перфорации без возможности улучшения слуха тимпанопластика также показана для предупреждения рецидивов ХГСО.

У пациентов без холестеатомы мастоидотомия при тимпанопластике не улучшает ни анатомический результат, ни аэрацию сосцевидного отростка, но увеличивает объём и риск вмешательства. Обязательной она считается при вялотекущем хроническом перфоративном отите без холестеатомы в случае неэффективности системной и местной антибактериальной терапии.

Применение эндоскопа в дополнение к микроскопу улучшает обзор барабанной полости, однако, по данным систематического обзора, преимущества исключительно эндоскопических операций перед микроскопическими не доказаны.

При тотальных и субтотальных дефектах барабанной перепонки с изменённой слизистой оболочкой большинство хирургов для профилактики реперфорации сочетают аутофасцию, аутохрящ и кожные трансплантаты. Тонкие пластинки аутохряща препятствуют ретракции и не ухудшают акустические свойства.

Искусственные протезы и аутопротезы при оссикулопластике не различаются по слуховым результатам, однако искусственный протез без прикрытия аутохрящом смещается в 6 раз чаще.

4.4 Холестеатома

При холестеатоме эффективно местное применение препаратов борной кислоты: помимо антисептического действия, они оказывают подсушивающее действие на ткани и тем самым уменьшают воспаление.

При ХГСО с холестеатомой выполняются санирующие операции.

Основным принципом является полное удаление холестеатомы и устранение причин рецидива.

При эпитимпаните и эпимезотимпаните с холестеатомой в зависимости от распространённости процесса выбирают «открытые», «полуоткрытые» или «закрытые» санирующие операции с тимпанопластикой или без неё. С учётом объёма и длительности вмешательства операции выполняют под общей анестезией.

При холестеатоме, ограниченной аттиком или аттиком и адитусом, допустима аттикотомия через наружный слуховой проход при обязательном тщательном удалении патологического процесса из синусов и карманов среднего уха.

1. «открытая» техника (с удалением задней стенки наружного слухового прохода) избавляет от повторных операций, но не от регулярного ухода за полостью у оториноларинголога;
2. после «закрытой» операции обязательна ревизия **через 8–12 месяцев** или МРТ для исключения рецидива;
3. «закрытые» операции сопряжены с более высоким риском внутричерепных осложнений: при невозможности постоянного послеоперационного наблюдения предпочтительна «открытая» методика.

Выбор методики

1. «закрытые» методики (аттикоадитотомия, аттикоантротомия, раздельная антромастоидотомия): при ограниченной холестеатоме;
2. «открытые» методики (модифицированная радикальная, консервативно-радикальная, общеполостная операция, антромастоидотомия с удалением задней стенки, радикальная мастоидэктомия): при распространённой деструкции, активной холестеатоме или вялотекущем обострении.

Современной тенденцией является применение «полуоткрытой» (гибридной) техники: аттикоантро- или мастоидотомии с облитерацией антрума и сосцевидного отростка аутотканями или инертными материалами и тимпанопластикой. При этом анатомия уха остаётся близкой к исходной, болезнь послеоперационной полости не развивается и необходимость в пожизненном наблюдении отсутствует.

При выявлении рецидива холестеатомы после «закрытой» операции объём вмешательства расширяется до антромастоидотомии с удалением задней стенки наружного слухового прохода и формированием открытой полости.

4.5 Послеоперационное ведение

После операции наружный слуховой проход тампонируют с противомикробными препаратами:

1. после тимпанопластики **на 10–14 дней**;
2. после санирующей операции **на 14–21 день**.

Дополнительно необходимо медикаментозное и физиотерапевтическое воздействие на слуховую трубу и слизистую оболочку. Важно квалифицированное наблюдение в отдалённом периоде.

4.6 Слухопротезирование

Электроакустическая реабилитация показана при асоциальном слухе (тугоухость **выше II степени**) и отсутствии возможности его улучшения.

Слухопротезирование показано при порогах костной проводимости выше 30 дБ на оба уха, в том числе в отдалённом послеоперационном периоде.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты, которым операция противопоказана или отложена, а также отказавшиеся от неё, наблюдаются в поликлинике **раз в 6 месяцев**; при обострении применяют консервативное лечение.

После тимпанопластики и санирующих операций пациента осматривают **ежегодно не менее 5 лет** врач поликлиники и отохирург клиники, где выполнялась операция. Цель: своевременно выявить рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

Профилактика обострений

1. санация полости носа и носоглотки;
2. разъяснение пациенту характера заболевания;
3. защита уха от попадания воды, предупреждение обострений при ОРЗ;
4. своевременное обращение к врачу поликлиники и в клинику, где выполнялась операция.

После операции

1. постельный режим с положением на противоположном ухе (в зависимости от методики);
2. избегать физических нагрузок **в течение месяца**;
3. избегать авиаперелётов **в течение 3 месяцев**;
4. защищать ухо от попадания воды до завершения реабилитации.

5.1 Показания к госпитализации и выписке

Первичный осмотр пациента выполняют оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

Показания к экстренной госпитализации

1. обострение ХГСО с внечерепными или внутричерепными осложнениями.

Плановая госпитализация для операции при ХГСО, в том числе с холестеатомой, в стадии вялотекущего воспаления или ремиссии **не менее 3–6 месяцев**. Показания:

1. снижение слуха с шумом в ухе;
2. снижение слуха со скудным отделяемым, не купирующимся консервативной терапией;
3. любые клинические проявления ХГСО независимо от вида тугоухости при отсутствии общих противопоказаний и при условии обследования пациента в соответствии с требованиями стационара.

Выписка

1. после экстренной госпитализации: при отсутствии угрозы жизни и восстановлении жизнедеятельности;
2. после плановой: в зависимости от объёма операции и самочувствия, **на 3–5-е сутки** после завершения противовоспалительной и симптоматической терапии, с тампонами в наружном слуховом проходе.

После выписки амбулаторно

1. удаление тампонов **через 2–3 недели**;
2. контроль слуха по данным ТПА **через 3 и 12 месяцев**.

Эффективность лечения оценивается по жалобам на снижение слуха и выделения из уха, по данным отоэндоскопии (закрытие перфорации, отсутствие отореи, эпидермизация полости), ТПА, КТ или МРТ (санация уха, отсутствие деструкции и холестеатомы), а также по данным вестибулометрии при фистуле лабиринта.

Осложнения ХГСО

1. прогрессирующая тугоухость;
2. лабиринтит;
3. периферический парез лицевого нерва;
4. менингит;
5. абсцесс мозга;
6. тромбоз сигмовидного синуса.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический средний отит»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 29.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	698_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- При сухом перфоративном среднем отите раздел 3.1 исключает любое лечение, тогда как раздел 3.2 и алгоритм в приложении Б предусматривают при перфорации тимпанопластику.
- Сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми допускается, однако при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны; «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом противогрибковых препаратов D01A.
- Сроки тампонады после операции различаются: в разделе 3.2 указано 10–14 дней после тимпанопластики и 14–21 день после санирующей операции, в разделе 6 указано удаление тампонов через 2–3 недели.
- Название и коды МКБ охватывают и негнойные формы (H65.2–H65.4), однако определение и весь текст рекомендации посвящены только хроническому гнойному среднему отиту.

Клинические рекомендации

Хронический тонзиллит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.2** — Хронический фарингит **J35.0** — Хронический тонзиллит **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов **J35.9** — Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании данных фарингоскопии: решающее значение имеют местные признаки хронического воспаления миндалин, наиболее важным из которых является жидкий гной в лакунах. Размер миндалин диагностического значения не имеет.
- В период острого воспаления глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливают: достоверная оценка его признаков возможна только **через 3–4 недели** после купирования острого процесса.
- По классификации Солдатова выделяют компенсированную и декомпенсированную формы; форму определяют по анамнезу **за последние три года**.
- Консервативное лечение назначают курсами в межрецидивный период:
  1. компенсированная форма: **2 раза в год**, весной и осенью;
  2. рецидивирующие ангины: **до 4 раз в год**, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Показания к тонзиллэктомии:
  1. любой вид декомпенсации;
  2. рецидивирующие ангины при неэффективности противорецидивного лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический тонзиллит является инфекционно-аллергическим заболеванием всего организма с местными проявлениями в виде стойкого воспаления нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

2.2 Местные признаки

Пять групп местных признаков

1. гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек;
2. рубцовые спайки между миндалинами и нёбными дужками;
3. разрыхлённые или, напротив, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины;
4. казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах;
5. увеличение регионарных лимфатических узлов.

1. признак Гизе: гиперемия краёв передних нёбных дужек;
2. признак Зака: отёк в месте соединения передних и задних дужек;
3. признак Преображенского: валикообразное утолщение краёв верхних отделов передних и задних дужек.

2.3 Классификация Солдатова

Компенсированная форма

1. местные признаки;
2. общие симптомы нерезко выражены или отсутствуют.

Декомпенсированная форма: местные признаки и хотя бы один вид декомпенсации

1. рецидивы ангин;
2. паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс;
3. тонзиллогенная интоксикация: длительный субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности при отсутствии другой причины;
4. тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов;
5. заболевания органов, патогенетически связанные с тонзиллитом.

Форму определяют по данным анамнеза **за последние три года**.

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна

Простая форма

1. только местные признаки;
2. в подавляющем большинстве случаев в анамнезе ангины.

Токсико-аллергическая форма I степени (признаки периодические)

1. субфебрилитет;
2. слабость, быстрая утомляемость;
3. боли в суставах;
4. увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов;
5. непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца;
6. нестойкие отклонения лабораторных показателей.

Токсико-аллергическая форма II степени

1. функциональные нарушения сердечной деятельности, подтверждённые электрокардиографией (ЭКГ);
2. сердцебиение и нарушения ритма;
3. боли в области сердца и в суставах как во время ангины, так и вне её;
4. функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов.

Сопряжённые заболевания

1. паратонзиллярный абсцесс;
2. парафарингит;
3. тонзиллогенный сепсис;
4. ревматизм;
5. артрит;
6. приобретённые пороки сердца;
7. гломерулонефрит.

Описано около 100 заболеваний, патогенетически связанных с хроническим тонзиллитом; наиболее часто поражаются сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В сложных случаях тактика ведения определяется совместно с профильным специалистом.

2.5 Жалобы и анамнез

Местные жалобы

1. незначительная боль;
2. першение;
3. ощущение инородного тела в горле;
4. периодический сухой кашель;
5. неприятный запах изо рта.

Жалобы неспецифичны: встречаются также при хроническом фарингите, заболеваниях гортани, полости рта и зубов; у части пациентов жалоб нет.

Общие жалобы при декомпенсированной форме

1. длительное недомогание;
2. снижение работоспособности;
3. затяжной субфебрилитет.

Эти жалобы неспецифичны и требуют обследования для исключения других причин.

У детей и взрослых, особенно часто и длительно болеющих, уточняются местные и общие жалобы, а также частота ангин. Многие авторы считают ангины в анамнезе наиболее достоверным признаком хронического тонзиллита, однако сведения о них должны быть подтверждены.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании:

1. анамнеза: ангины, длительная утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, сопряжённые с тонзиллитом заболевания;
2. физикального обследования;
3. лабораторных данных;
4. фарингоскопии.

3.1 Фарингоскопия

Показания

1. дети и взрослые: исключение острого тонзиллита и выявление местных признаков хронического тонзиллита.

При остром воспалении глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливают: достоверная оценка признаков возможна только **через 3–4 недели**.

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Диагностические признаки

1. решающее значение имеют фарингоскопические признаки;
2. наиболее важный признак: жидкий гной в лакунах, нередко с неприятным запахом;
3. увеличение регионарных лимфатических узлов может быть обусловлено и другими воспалительными процессами головы и шеи;
4. размер миндалин диагностического значения не имеет.

Осмотр при ярком направленном освещении двумя шпателями, при необходимости зондом.

За 20–30 минут до осмотра пациенту не рекомендуется (иначе возможна транзиторная гиперемия)

1. принимать пищу;
2. пить горячие, холодные и газированные напитки;
3. курить;
4. разговаривать на холоде.

Надавливание вторым шпателем на нёбную дужку выявляет содержимое лакун и спайки.

3.2 Анализы крови и мочи

Показания

1. выявление сопряжённых с тонзиллитом заболеваний: общий анализ крови и мочи, С-реактивный белок (СРБ), ревматоидный фактор.

3.3 Антистрептолизин-О

Показания

1. дифференциальная диагностика активной стрептококковой инфекции и носительства.

Высокий уровень АСЛ-О при отсутствии стрептококка в посевах свидетельствует о возможной внутриклеточной персистенции и рассматривается как подтверждение декомпенсации. Однако высокий уровень АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не является показанием к лечению.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

3.4 Исследование на БГСА

Показания

1. бактериологическое исследование отделяемого с нёбных миндалин на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитологическое исследование содержимого лакун для постановки диагноза практически не имеют значения. Они необходимы для уточнения формы заболевания, роли микрофлоры, связи с заболеваниями других органов и оценки эффективности лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, ультразвуковое исследование (УЗИ) и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательства их эффективности отсутствуют.

---

4. Лечение

Перед началом любого лечения необходимы осмотр и при необходимости санация зубов, околоносовых пазух и носоглотки.

4.1 При обострении (ангине)

Тактика при ангине определяется рекомендациями по острому тонзиллофарингиту, при паратонзиллите и абсцессе рекомендациями по этим заболеваниям. Курсы лечения хронического тонзиллита назначают в межрецидивный период.

Взрослым при обострении рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для местного применения.

4.2 Системные антибиотики

При обострении, выделении стрептококка или признаках осложнений

1. системные антибиотики; препараты выбора: пенициллины.

Вне обострения: при функциональных нарушениях внутренних органов, отрицательных посевах на БГСА и стойко повышенном АСЛ-О

1. 14-членные макролиды курсом **до 2 недель**.

Целесообразность антибактериальной терапии в межрецидивный период остаётся дискутабельной, поэтому решение принимается индивидуально на основании объективных данных, динамики симптомов и лабораторных показателей.

При подтверждённой грибковой этиологии используют противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

4.3 Межрецидивный период: консервативное лечение

Форма	Курсы консервативного лечения
Компенсированная, простая	2 раза в год, весной и осенью
Декомпенсация в виде рецидивов ангин, токсико-аллергическая форма I степени	до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины
Другие виды декомпенсации, токсико-аллергическая форма II степени	только при противопоказаниях к операции

1. Обязательное условие эффективности: дренирование лакун и очищение складок и карманов от экссудата и детрита.
2. Промывание лакун миндалин курсом **10 процедур** ежедневно или через день; не ранее чем **через 2–3 недели** после острого воспаления.
3. Антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.
4. Топические бактериальные лизаты в таблетках для рассасывания: уменьшают частоту и продолжительность обострений.
5. Растительные препараты курсами для снижения частоты ангин: корень алтея, цветки ромашки, трава тысячелистника, кора дуба, трава хвоща, корень одуванчика.
6. Консультация физиотерапевта в период ремиссии; физиотерапии предшествует курс промываний.

Для промывания используются стерильный раствор натрия хлорида или растворы антисептиков с соблюдением дозировок и возрастных ограничений и с учётом возможной аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур выполняют отдельно или непосредственно после промывания.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста от промывания и смазывания миндалин следует воздержаться в связи с риском рефлекторного ларингоспазма.

4.4 Хирургическое лечение

Двусторонняя тонзиллэктомия выполняется в межрецидивный период для радикального устранения очага инфекции.

Показания к тонзиллэктомии

Основание	Показания к тонзиллэктомии
Показания по классификации Солдатова	1. любой вид декомпенсации, кроме рецидивов ангин без проведённого противорецидивного лечения; 2. рецидивы ангин: при неэффективности консервативного лечения с сохранением ангин или появлением другого вида декомпенсации.
Показания по классификации Преображенского — Пальчуна (сами формы — во вкладке «Клиника»)	1. токсико-аллергическая форма II степени; 2. простая форма и токсико-аллергическая форма I степени при неэффективности **2–3 тщательно проведённых курсов** консервативного лечения в год.
Показания у детей	1. частые стрептококковые ангины: **не менее 7** за последний год, **не менее 5 в год** за последние 2 года или **не менее 3 в год** за последние 3 года; 2. два и более паратонзиллярных абсцесса (в ряде случаев и после одного); 3. заключение профильных специалистов, если тонзиллэктомия необходима как этап лечения сопутствующего заболевания.
Показания по критериям Paradise	1. 7 эпизодов боли в горле за год, 5 эпизодов в каждом из двух лет или 3 эпизода в каждом из трёх лет. Эпизод: боль в горле и хотя бы один признак: температура тела 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, увеличение шейных лимфатических узлов более 2 см с болезненностью, БГСА в посеве или положительный экспресс-тест.

Абсолютные противопоказания

1. заболевания крови: гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы;
2. аномалии сосудов глотки (пульсация боковой стенки);
3. тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени;
4. выраженная почечная недостаточность;
5. тяжёлый сахарный диабет с кетонурией;
6. тяжёлые заболевания печени;
7. тяжёлые нервно-психические заболевания;
8. злокачественные новообразования;
9. активный туберкулёз.

Относительные противопоказания

1. острые инфекционные заболевания и период 3–4 недель после них;
2. острые воспалительные заболевания и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов;
3. эпидемии гриппа;
4. менструация;
5. неактивный туберкулёз;
6. преходящая тромбоцитопения;
7. сахарный диабет нетяжёлого течения;
8. кариозные зубы.

Наиболее частое осложнение: кровотечение из тонзиллярной ниши во время операции или **в первые 5–7 дней**, возможно и **на 8–15-е сутки**. Поэтому первые 5–7 дней пациент находится в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике с освобождением от работы.

4.5 Послеоперационное ведение

1. в первые сутки постельный и голосовой режим; через несколько часов после операции разрешается несколько глотков воды;
2. в последующие дни щадящий режим, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная;
3. местные и системные анальгетики;
4. профилактика обострения сопутствующих заболеваний.

Для обезболивания и уменьшения воспаления используют НПВП.

После тонзиллэктомии в течение месяца рекомендуются ограничение физической нагрузки и соблюдение режима сна и отдыха.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Компенсированная форма: курсы лечения **2 раза в год**. Если **за 3 года** не было ангин и других признаков декомпенсации, пациента снимают с диспансерного учёта.

Декомпенсация в виде рецидивов ангин: курсы лечения **3–4 раза в год**. При неэффективности лечения **в течение года**, осложнённом течении ангин или появлении другого вида декомпенсации пациента направляют на хирургическое лечение.

После тонзиллэктомии диспансерное наблюдение продолжается **6 месяцев**.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск развития хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно дефицит витаминов A, B, E), переутомление, неудовлетворительные гигиенические условия жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, заболевания зубов, полости носа и околоносовых пазух, частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и их нерациональное лечение.

Лечение, как правило, осуществляет оториноларинголог в амбулаторных условиях.

Показания к госпитализации в хирургическое отделение

1. неэффективность лечения;
2. подозрение на гнойное осложнение: паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит;
3. подозрение на новообразование;
4. необходимость хирургического лечения.

Тонзиллэктомию выполняют в оториноларингологическом отделении в плановом порядке; при неосложнённом послеоперационном периоде пациента выписывают **на 5–7-е сутки**.

Переход тонзиллита в декомпенсированную форму чаще наблюдается при иммунодефиците (врождённом, на фоне приёма иммунодепрессантов и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции). Аутоиммунные осложнения более вероятны при стрептококковой этиологии тонзиллита и ревматической лихорадке у пациента или ближайших родственников.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», тогда как в карточке рубрикатора приведён J31.2 «Хронический фарингит». На сайте указан код из текста КР.